BRK™ Transseptal Needle

407200, 407201, 407205, 407206, 407207, G407208, G407209, G407210, G407211, G407212, G407215, G407216
Instructions for Use

Abbott

Proposition 65, a State of California voter initiative, requires the following notice:

WARNING: This product can expose you to chemicals including ethylene oxide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.
‡ Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.

Pat. http://www.abbott.com/patents

© 2022 Abbott. All Rights Reserved.

EN: English

BRK™ Transseptal Needle

Instructions for Use

Description

The BRK™ Transseptal Needle consists of a luminal stainless steel needle and solid stainless steel stylet. The distal section of the needle is curved to facilitate positioning within the heart when used with a transseptal sheath set from Abbott Medical. Within this curved section, there is an abrupt step down in the outer diameter of the needle to mate with the internal diameter of the dilator of a transseptal sheath set from Abbott Medical. The distal tip of the needle is beveled to facilitate the puncture process. The proximal end of the needle is configured with a pointer flange (indicating distal curve orientation) and is fitted with a 2-way stopcock to provide needle lumen access for aspiration, fluid injection/infusion, blood sampling, pressure monitoring, and stylet and/or guidewire insertion (0.014 in. maximum guidewire diameter for an 18 gauge needle; 0.012 in. maximum guidewire diameter for a 19 gauge needle). The stylet is straight and isodiametric throughout its length. The proximal end of the stylet is fitted with a curved clip to lock onto the proximal needle hub when inserted into the needle lumen. The stylet is designed to facilitate needle advancement within the dilator. The needle is available in various useable lengths and distal curve configurations.

Intended Purpose

The BRK™ Transseptal Needle is intended to be used to puncture the interatrial septum to gain left heart access.

Indications for Use

The BRK™ Transseptal Needle is used to puncture the interatrial septum during a transseptal catheterization procedure to gain left heart access.

Patient Target Group

The BRK™ Transseptal Needle is intended to be used in hemodynamically stable patients requiring left heart catheter access. Use of the BRK™ Transseptal Needle may require special consideration in patients with the following conditions:

- Rotated heart
- Enlarged aortic root
- Marked right atrial enlargement
- Scoliosis/kyphosis
- Abnormal left atrial geometry
- Congenital malformations
- Vascular malformations
- Inability to access the right atrium through the inferior vena cava

Intended User

This device should be used by only those physicians who are specially trained in transseptal procedures, in a fully-equipped operational electrophysiology laboratory.

Clinical Benefits

The intended clinical benefit of the BRK™ Transseptal Needle is to puncture the interatrial septum during a transseptal catheterization procedure to gain left heart access to enable devices requiring left-sided endocardial heart access to achieve their intended clinical benefit, such as an ablation catheter. This is measured by successful puncture of the interatrial septum.

Contraindications

- Previous interatrial septal patch or prosthetic atrial septal defect closure device.
- Any previous thromboembolic event.
- Known or suspected left atrial myxoma.
- Known or suspected myocardial infarction within the last two weeks.
- Unstable angina.
- Recent cerebral vascular accident (CVA).
- Patients who do not tolerate anticoagulation therapy.
- Patients with an active infection.

Warnings

- Do not alter this device in any way.
- This device is intended for one time use only; do not reprocess or reuse it. Note the product “Use by” date on the package. Any attempt to resterilize and reuse this system may compromise its integrity. Adverse effects of using nonsterile components may include, but are not limited to:
  - Local and systemic infection or reaction
  - Mechanical damage
  - Inaccurate functionality
- The materials identified below per product may cause allergic or hypersensitivity reactions. Persons allergic to these may suffer an allergic reaction to this product. Prior to its use on the patient, the patient should be counselled on the materials contained in the device and a thorough history of allergies must be discussed:
  - Stainless steel
  - Epoxy adhesive
  - Nickel chrome plated brass
  - Silicone high vacuum grease (Dupont)
  - Master bond
- Misuse of this device may result in serious complications.
- For both patients and laboratory staff, cardiac catheterization procedures present the potential for significant X-ray exposure, which can result in acute radiation injury as well as increased risk for somatic and genetic effects due to the X-ray beam intensity and duration of the fluoroscopic imaging. Carefully consider the use of this device in pregnant women.

Precautions

- Federal law (U.S.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- Read directions prior to use.
- Inspect the package prior to use. Do not use if the package is open or damaged.
- Inspect all components before use.
- Store in a cool, dark, dry place.
- Prior to the procedure, the patient must be hemodynamically stable. Certain conditions may require special consideration when using this product. These may include, but are not limited to:
  - Rotated heart
  - Enlarged aortic root
  - Marked right atrial enlargement

  - Scoliosis/kyphosis
  - Abnormal left atrial geometry
  - Congenital malformations
  - Vascular malformations
  - Inability to access the right atrium through the inferior vena cava
- This device should be used by only those physicians who are specially trained in transseptal procedures, in a fully-equipped operational electrophysiology (EP) laboratory.
- Catheter advancement should be performed under fluoroscopic guidance to minimize the risk of cardiac damage, perforation, or tamponade. Compatible navigation and real time visualization systems may also be considered.
- During insertion, check for excessive resistance as the tip of the needle advances through the curvature of the sheath/dilator assembly. If there is any resistance to needle advancement, retract the needle, and assess components.
- During insertion, use caution not to create excessive bends in this device. This may inhibit advancement of the needle and may result inadvertent needle puncture of the dilator/sheath assembly.
- During insertion, always use the stylet to facilitate needle passage through the dilator/sheath assembly. Failure to use the stylet may inhibit advancement of the needle and may result in inadvertent needle puncture of the dilator/sheath assembly or skiving of material from the inner surface of the dilator.
- If pericardial or aortic entry occurs, do not advance the dilator over the needle. If the needle has penetrated the pericardium or aorta, it must be withdrawn. Monitor vital signs closely.
- There is a risk of air infiltration when withdrawing objects from the hemostasis valve of the sheath. Take precautions to prevent air infiltration by withdrawing objects slowly to prevent vacuum buildup in the sheath and fluoroscopically monitor the sheath during ensuing device insertion for the presence of air.
- After use, this device, its accessories, and packaging should be appropriately classified for disposal, e.g. biohazard, sharps, non-hazardous waste etc., and carefully disposed of in compliance with facility procedures and applicable laws and regulations.
- One or more components of this device may contain the following substance defined as CMR 1B in a concentration above 0.1% weight by weight: Cobalt: Chemical Abstracts Service (CAS) No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0. Current scientific evidence supports that medical devices manufactured from cobalt alloys and stainless steel alloys containing cobalt do not cause an increased risk of cancer or adverse reproductive effects.

  One or more components of this device may contain the following substance defined as CMR 1A in a concentration above 0.1% weight by weight: Lead: Chemical Abstracts Service (CAS) No. 7439-92-1; EC No. 231-100-4. Current scientific evidence supports that medical devices manufactured from lead do not cause an increased risk of cancer or adverse reproductive effects.

Potential Adverse Events

Adverse Event Category	Adverse Event Subcategory
Bleeding	Hemorrhage/Bleeding
	Hematoma
Cerebral injury	Asymptomatic cerebral emboli
	Stroke/cerebrovascular accident
	Transient ischemic attack (TIA)
Embolism	Air embolism
	Foreign body embolism
	Pulmonary embolism
	Thromboembolism
	Thrombosis/thrombus
Cardiac perforation	Cardiac tamponade
	Pericardial effusion
Cardiovascular injury	Valvular damage
	Aortic root puncture
	Atrial perforation
Conduction system disturbance	SA node, AV node, or His-Purkinje system block
	Cardiac arrhythmias
Immunological reaction	Anaphylaxis
Infection	Pericarditis
	Endocarditis
	Pneumonia
	Sepsis
Pain/discomfort	Pain, groin, chest (general chest pain not associated with MI)
Peripheral vascular injury	Dissection
	Laceration
	Arteriovenous fistula formation
	Pseudoaneurysm formation
Hypotension	N/A
Superficial tissue injury	N/A

Directions

Prepare and Assemble Equipment

1. Remove contents from packaging.

   NOTE: Do not assemble the sheath and dilator.

2. Flush the dilator and sheath with heparinized saline.
3. Close the sheath stopcock.
4. Remove the stylet from the needle and flush the needle with heparinized saline.
5. Insert the stylet into the needle and lock it onto the hub.
6. Insert the dilator fully into the transseptal sheath.

Advance Sheath/Dilator Assembly into Superior Vena Cava

1. Obtain femoral venous access (right femoral preferred).

   OPT: A larger (≥2.5 French sizes greater than the transseptal sheath) standard length sheath may be used to obtain and maintain venous access for device exchange and hemostasis.

2. Introduce a 0.032 in., 150 - 180 cm, 3 mm "J" tip guidewire into the superior vena cava (SVC).

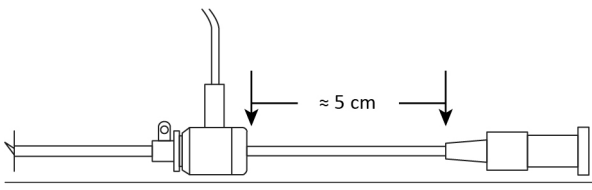
   NOTE: 0.032 in. is the maximum guidewire diameter that can be used with the dilator.

3. Insert the sheath/dilator into the vein over the guidewire until the sheath tip is in the SVC. Orient the dilator tip medially.

Position Needle/Stylet Assembly inside Sheath/ Dilator Assembly

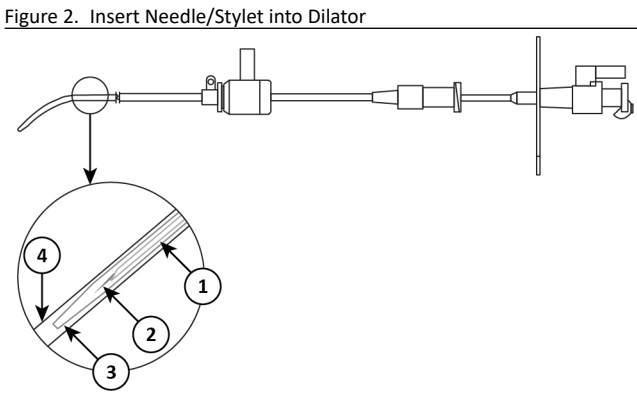
1. Remove the guidewire from the dilator.
2. Aspirate fully and then flush the dilator with heparinized saline.
3. Withdraw the dilator approximately 5 cm (see figure below) to facilitate passage of the needle curve through the rigid hubs of the dilator and sheath.

Figure 1. Withdraw Dilator



4. Lock the stylet onto the hub.
5. Insert the needle/stylet into the dilator. Advance the needle/stylet under fluoroscopy until it is approximately 2 cm from the dilator tip inside the sheath (see figure below).

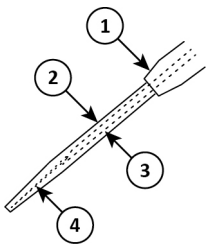
Figure 2. Insert Needle/Stylet into Dilator



1. Needle
2. Stylet
3. Dilator tip
4. Sheath

6. To reconnect the sheath and dilator, advance the dilator and needle/stylet into the sheath simultaneously under fluoroscopy. Ensure the needle's position within the dilator does not change as both components are advanced together. Maintain the sheath tip position in the SVC.
7. Under fluoroscopy, advance the needle/stylet until the stylet is positioned just proximal of the dilator tip (see figure below).

Figure 3. Advance Needle/Stylet



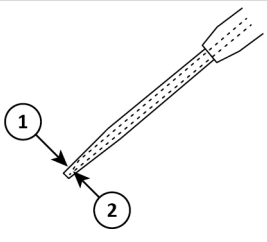
1. Sheath tip
2. Dilator
3. Needle
4. Stylet

8. Remove the stylet, do not discard it.
9. Aspirate the needle until blood return is observed. Discard the syringe.

   NOTE: The use of a slip-tip (non Luer-Lok‡) syringe may prevent aspirating air.

10. Flush the needle with heparinized saline. Close the stopcock.
11. Advance the needle under fluoroscopy until the needle tip is just proximal of the dilator tip (see figure below).

Figure 4. Advance Needle Tip



1. Dilator tip
2. Needle tip

OPT: Attach a 3-way rotating stopcock to the needle hub.

OPT: Attach a syringe with radiopaque contrast media to the stopcock. Aspirate the needle. Then load the needle with the contrast media under fluoroscopic guidance.

OPT: Connect a pressure monitoring line to the stopcock.

OPT: Use a standard 3-port manifold setup to connect contrast, pressure, and flush lines.

Engage Fossa Ovalis

1. Visualize and identify anatomic landmarks.

2. Set the fluoroscopy unit to an angle parallel to the plane of the mitral valve and orthogonal to the plane of the septum. This will typically be left anterior oblique (LAO), approximately 30 to 40 degrees.

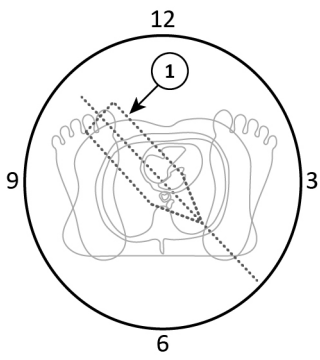
   OPT: During EP procedures, the coronary sinus and His bundle catheter positions can serve as useful anatomic landmarks. In the appropriate LAO view, the coronary sinus catheter appears in profile. In the appropriate right anterior oblique (RAO) view, the His bundle catheter appears in profile. The fossa ovalis is level, or slightly below, the His bundle catheter and superior and posterior to the coronary sinus ostium.

   OPT: Placing a pigtail angiographic/hemodynamic monitoring catheter in the non-coronary cusp of the aortic valve can serve as a useful anatomic landmark.

   OPT: Observe the pressure waveform being recorded through the BRK™ Transseptal Needle.

3. Adjust the pointer flange so that the needle is perpendicular to the fossa ovalis (between 3:00 and 5:00 o'clock typically, as viewed from the foot end of the patient). (See figure below.)

Figure 5. Needle Pointer Flange

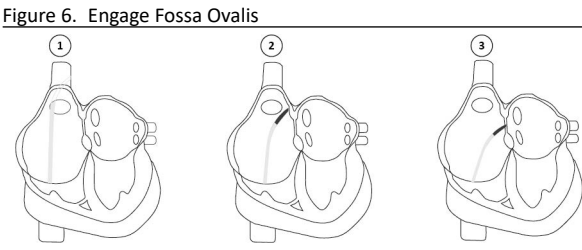


1. Needle pointer flange

4. Use fluoroscopy to confirm that the needle tip is inside the dilator.
5. After confirming that the tip of the needle is within the dilator, drag the entire sheath/dilator/needle assembly slowly. Prevent any movement of the assembly parts relative to each other. It is critical to maintain the previous orientation of the pointer flange while dragging the assembly.
6. In the LAO view (orthogonal to the interatrial septum) observe the tip of the dilator during the drag for abrupt medial (or rightward) movement, indicating the tip has engaged the fossa ovalis. (See figures below.)

   NOTE: If the fossa ovalis is probe patent, the dilator tip now moves into the left atrium with ease.

Figure 6. Engage Fossa Ovalis



1. Starting position in SVC
2. Initial medial movement in RA
3. Abrupt medial movement onto fossa ovalis

NOTE: If pressure is being monitored through the needle, the pressure through the needle is inaccurate at this point because the tip is against the fossa ovalis.

Puncture Fossa Ovalis with BRK™ Transseptal Needle

1. Confirm the correct location of the sheath/dilator/needle assembly on the fossa ovalis before advancing the needle.
2. After the correct location is confirmed, extend the needle to full engagement within the sheath/dilator assembly and advance the needle across the interatrial septum.

   OPT: Under pressure monitoring, entry into the left atrium is confirmed when the pressure tracing shows a left atrial pressure waveform.

   OPT: Left atrial access can be confirmed via fluoroscopy with contrast injections.

3. If there is any resistance to needle advancement, retract the needle and re-evaluate the anatomic landmarks.

   CAUTION: If pericardial or aortic entry occurs, do not advance the dilator over the needle. If the needle has penetrated the pericardium or aorta, it must be withdrawn. Monitor vital signs closely.

Advance Sheath/Dilator Assembly into Left Atrium

While maintaining a fixed needle position within the left atrium, advance the sheath/dilator assembly fully over the needle into the left atrial cavity.

Advance Sheath over Fixed Dilator and Needle into Left Atrium

1. Maintain the position of the needle and dilator across the septum.
2. While maintaining the dilator in a fixed location, advance the sheath fully over the dilator into the left atrial cavity.

Withdraw BRK™ Transseptal Needle and Dilator

CAUTION: There is a risk of air infiltration when withdrawing objects from the hemostasis valve of the sheath. Take precautions to prevent air infiltration by withdrawing objects slowly to prevent vacuum buildup in the sheath and fluoroscopically monitor the sheath during ensuing device insertion for the presence of air.

1. Turn the needle stopcock to the off position and disconnect any attachments to the needle hub.
2. Remove the BRK™ Transseptal Needle from the dilator. The needle may be cleaned and set aside for repeat use in this procedure. Otherwise, discard the needle as appropriate for contaminated sharp objects.
3. Immediately attach a syringe to the dilator and aspirate. Continue aspirating blood while holding the sheath in position and withdrawing the dilator. The blood should be arterial blood.
4. After the dilator is removed, aspirate blood through the side arm of the sheath. Carefully flush the sidearm of the sheath with heparinized saline to avoid air bubbles.
5. The sheath is now in place in the left atrium.

Packaging and Shelf-Life

The BRK™ Transseptal Needle is supplied sterile. The needle is packaged with a stylet inserted. The needle and stylet are placed in the primary packaging. The primary packaging is placed inside a Mylar‡ and Tyvek‡ pouch, which is heat-sealed. The pouch and this IFU are then placed in a box, which is sealed at both ends. Both the pouch and the box have a label with product information, including the expiration date. Products are labeled for a shelf life of three years.

Clinical Data Summary

For European Union countries: A summary of the safety and clinical performance (SSCP) for these devices will be published at https://ec.europa.eu/tools/eudamed by the Notified Bodies in accordance with the requirements of EU MDR 2017/745 and associated timelines. Search for the device using the UDI-DI provided on the outer packaging of the device. The UDI-DI is the 14-digit number between the first two sets of parentheses. For more information about finding and using the UDI-DI, refer to the Frequently Asked Questions document found at medical.abbott/manuals.

Incident Reporting

If, in the course of use of this device, you have reason to believe that a serious incident occurred, please report it to the manufacturer. For customers in the European Union, report the serious incident to your national authority as well as to the manufacturer.

Limited Warranty

Abbott Medical warrants that its products shall be free from defects in materials and workmanship under normal use. This warranty does not exceed the "Expiration" date stated on any product labeling. The authorized uses and approved methods of use of each of our products is set forth in the related "Instructions for Use" that accompany each product. Abbott Medical disclaims any responsibility and liability for the use of its products in a manner that has not been authorized or approved. Abbott Medical's liability under this warranty is limited to replacing its products. The foregoing warranty excludes and is in lieu of all other warranties whether expressed or implied including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Abbott Medical disclaims any liability for any incidental or consequential loss, damage, or expense directly or indirectly arising from the use of this product, other than as expressly provided by specific law. Abbott Medical neither assumes nor authorizes any other person to assume for it any other or additional liability for loss, damage, or expense in connection with this product. For more details please review complete Abbott Medical warranty policy available from Abbott Medical or on the back of an Abbott Medical invoice.

Symbols

The symbols below and harmonized symbols may be found on the product or product label. For harmonized symbols, refer to the Universal Symbols Glossary at medical.abbott/manuals.

Symbol	Definition
Series	Series
Contents	Contents
Transseptal Needle	Transseptal Needle
	Single sterile barrier system
	Length
Rx ONLY	CAUTION: Federal law (U.S.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
CE 2797	Conformité Européenne (European Conformity). Affixed in accordance with European Council Regulation 2017/745. Hereby, Abbott Medical declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of this regulation.
	Importer
UK CA 0086	United Kingdom Conformity Assessed
UKRP	Responsible person in the United Kingdom
UA.TR.101	Ukrainian mark of conformity to the technical regulations, where 101 is the assessment body.
MD	Medical Device
UDI	Unique Device Identification
medical.abbott/manuals	Follow instructions for use on this website
(7440-48-4) (7439-92-1)	Contains hazardous substances. (Cobalt CAS No. 7440-48-4) (Lead CAS No. 7439-92-1)

AR: اللغة العربية

™BRK إبرة عبر الحاجز
تعليمات الاستخدام

الوصف

تتكون الإبر العابرة للحاجز ™BRK من إبرة رفيعة ذات تجويف أُمْعي مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ ومرود مُصمت من الفولاذ الذي لا يصدأ. تم تصميم الجزء القاصي من الإبرة بشكل منحنٍ لتسهيل ضبط وضعه داخل القلب عند استخدامه مع مجموعة الغمد العابرة للحاجز المقدمة من شُركة Abbott Medical. ويوجد داخل القسم المنحني انحناء مفاجئ في القطر الخارجي من الإبرة لتوصيلها بالقطر الداخلي لموسع مجموعة الغمد العابرة للحاجز المقدمة من شركة Abbott Medical. يكون الطرف البعيد للإبرة مشطوف الحافة لتيسير عملية البزل. تم تجهيز الطرف الداني من الإبرة بشفة مؤشر (تشير إلى اتجاه المنحنى القاصي)، كما تم تزويده بمحبس يتحرك يسمح بنفاذ السوائل في اتجاهين للسماح بالدخول عبر تجويف الإبرة للقيام بالشفط وحقن/تسريب السوائل، وأخذ عينات من الدم، ومراقبة الضغط، وإدخال المرود و/أو السلك الدليلي (الحد الأقصى لقطر السلك الدليلي هو 0.014 بوصة لإبرة مقاس 18؛ فيما يبلغ الحد الأقصى لقطر السلك الدليلي 0.012 بوصة لإبرة مقاس 19). يكون طول المرود مستقيمًا ومتساوي الأقطار. تم تجهيز الطرف القريب للمرود مع مشبك منحني لقفله على محور الإبرة القريب عند إدخاله في تجويف الإبرة. تم تصميم المرود لتسهيل إدخال الإبرة داخل الموسّع. الإبرة متوافرة بأطوال متعددة للاستخدام وتصميمات متعددة للرأس البعيدة.

الغرض المقصود

تم تصميم الإبرة العابرة للحاجز ™BRK للاستخدام في بزل الحاجز الأذيني للوصول إلى الجانب الأيسر للقلب.

دواعي الاستخدام

تستخدم الإبرة العابرة للحاجز ™BRK في بزل الحاجز الأذيني أثناء إدخال القسطرة عبر الحاجز للوصول إلى الجانب الأيسر للقلب.

مجموعات المرضى المستهدفة

تم تصميم الإبرة العابرة للحاجز ™BRK للاستخدام لدى المرضى الذين تكون حالة الدم الديناميكية لديهم مستقرة ويحتاجون إلى الوصول إلى قسطرة الجانب الأيسر للقلب. قد يتطلب استخدام الإبرة العابرة للحاجز ™BRK اهتمامًا خاصًا في المرضى الذين يعانون من الحالات التالية:

- استدارة القلب
- تضخم في جذر الشريان الأورطي
- تضخم ملحوظ في الأذين الأيمن
- الجَنف/الحُداب
- شكل غير طبيعي للأذين الأيسر
- تشوهات خلقية
- تشوهات وعائية
- عدم القدرة على الوصول إلى الأذين الأيمن من خلال الوريد الأجوف السفلي

المستخدم المقصود

ينبغي أن يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأطباء المدربين تدريبًا خاصًا على الإجراءات العابرة للحاجز، في مختبر خاص بالفيزيولوجيا الكهربائية مجهز بالكامل.

الفوائد السريرية

تكمن الفائدة السريرية المقصودة من الإبرة العابرة للحاجز ™BRK في بزل الحاجز الأذيني أثناء إدخال القسطرة عبر الحاجز للوصول إلى الجانب الأيسر للقلب لتمكين الأجهزة التي تتطلب الوصول إلى شغاف القلب بالجانب الأيسر من القلب لتحقيق الفائدة السريرية المقصودة، مثل استخدام قسطرة للكي. يتم قياس ذلك من خلال إجراء بزل ناجح في الحاجز الأذيني.

موانع الاستخدام

- وجود لاصق سبق تركيبه في الحاجز الأذينيّ أو جهاز إغلاق بديلي لعلاج عيب في الحاجز الأذينيّ.
- وقوع أي حوادث سابقة للخثار الوريدي.
- العلم بوجود ورم مخاطي في الأذين الأيسر أو الاشتباه في وجوده.
- العلم بوجود احتشاء في عضلة القلب خلال آخر أسبوعين أو الاشتباه في وجوده.
- ذبحة صدرية غير مستقرة.
- حادثة وعائية دماغية حديثة (CVA).
- المرضى غير القادرين على تحمل العلاج المضاد للتجلط.
- المرضى المصابون بعدوى نشطة.

التحذيرات

- امتنع عن إدخال أي تعديلات على هذا الجهاز بأي شكلٍ كان.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام مرة واحدة فقط؛ لذلك لا تقم بإعادة معالجته أو إعادة استخدامه. لاحظ تاريخ الصلاحية الموضح بعبارة "طُ ال حل ليل ت خدام ت ى" المدون على العلبة. قد تؤدي أي محاولة لإعادة تعقيم هذا النظام وإعادة استخدامه إلى الإضرار بسلامته. يمكن أن تتضمن الآثار السلبية الناتجة عن استخدام مكونات غير معقمة على سبيل المثال لا الحصر:
  - الإصابة بعدوى أو تحسس موضعي وجهازي
  - تلف ميكانيكي
  - أداء غير دقيق للوظائف
- قد تتسبب المواد المحددة أدناه لكل منتج في تفاعلات تحسسية أو فرط تحسس. الأشخاص المصابون بحساسية من هذه المواد قد يعانون من تفاعلات حساسية تجاه هذه المنتج. قبل استخدامه على المريض، يجب تقديم المشورة للمريض بشأن المواد الموجودة في الجهاز ويجب أن تتم مناقشة التاريخ الكامل لحالات الحساسية التي يعاني منها المريض:
  - فولاذ مقاوم للصدأ
  - لاصق إيبوكسي
  - نحاس مطلي بالنيكل الكرومي
  - شحم سيليكون مخصص للاستخدامات ذات الضغط الفراغي المرتفع (Dupont)
  - Master Bond
- قد يؤدي سوء استخدام هذا الجهاز إلى حدوث مضاعفات خطيرة.
- تنطوي الإجراءات الطبية القائمة على التدخل بأجهزة القسطرة القلبية على احتمال التعرض إلى الأشعة السينية -بشكل كبير لكلّ من المريض والعاملين في المختبر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة حادة بسبب الإشعاعات، فضلاً عن زيادة خطورة التأثيرات على الخلايا الجسمانية والجينات، بسبب كثافة تدفق الأشعة السينية، ومدة التصوير الفلوروسكوبي (التألقي). ننصح بإجراء دراسة متأنية عند التفكير في استخدام هذا الجهاز للنساء الحوامل.

الاحتياطات

- تحظر القوانين الفيدرالية (في الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز إلا بواسطة طبيب أو بأمر منه.
- اقرأ الإرشادات قبل الاستخدام.
- افحص العلبة قبل الاستخدام. ولا تستخدم الجهاز إذا كانت العلبة مفتوحة أو تالفة.
- افحص جميع المكونات قبل الاستخدام.
- تُخزّن في مكان جاف ومظلم وبارد.
- يجب أن تكون حالة الدم الديناميكية للمريض مستقرة قبل الإجراء. قد تتطلب بعض الحالات مراعاة خاصة عند استخدام هذا المنتج. يمكن أن تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر:
  - استدارة القلب
  - تضخم في جذر الشريان الأورطي
  - تضخم ملحوظ في الأذين الأيمن
  - الجَنف/الحُداب
  - شكل غير طبيعي للأذين الأيسر
  - تشوهات خلقية
  - تشوهات وعائية
  - عدم القدرة على الوصول إلى الأذين الأيمن من خلال الوريد الأجوف السفلي
- ينبغي أن يقتص استخدام هذا الجهاز على الأطباء المدربين تدريبًا خاصًا على الإجراءات العابرة للحاجز، في مختبر خاص بالفيزيولوجيا الكهربائية (EP) مجهز بالكامل.

- يجب دفع القسطرة مع التوجيه بالاستعانة بتقنية الكشف الفلوري للحد من خطورة تعرض القلب للضرر، أو ثقبه، أو انضغاطه. يمكن أن تتم كذلك مراعاة أنظمة التنقل والتصوير الفوري المتوافقة.
- تحقق أثناء عملية الإدخال من وجود مقاومة مفرطة أثناء تقدم طرف الإبرة عبر منحنى مجموعة الغمد/الموسّع. إذا كان هناك أي مقاومة أثناء توجيه الإبرة إلى الأمام، فقم بسحب الإبرة وتقييم المكونات.
- أثناء الإدخال، توخ الحذر لعدم إنشاء انحناءات مفرطة في هذا الجهاز. فقد يمنع ذلك تقدم الإبرة إلى الأمام وقد يؤدي إلى بزل مجموعة الموسّع/الغمد بشكل غير مقصود بفعل الإبرة.
- أثناء عملية الإدخال، استخدم دائمًا المرود لتسهيل مرور الإبرة من خلال مجموعة الموسّع/الغمد. قد يتسبب عدم استخدام المرود في منع إدخال الإبرة وقد يؤدي إلى بزل مجموعة الموسّع/الغمد بشكل غير مقصود بواسطة الإبرة أو إزالة سطح المواد الموجودة بالسطح الداخلي للموسّع.
- في حالة الدخول إلى التأمور أو الشريان الأورطي، لا تدفع الموسّع فوق الإبرة. إذا اخترقت الإبرة التأمور أو الشريان الأورطي، فيجب سحبها. يجب مراقبة العلامات الحيوية عن قرب.
- هناك خطر لتسرب الهواء عند سحب مواد من صمام الإرقاء الموجود بالغمد. اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الهواء عن طريق سحب العناصر ببطء لمنع تراكم الفراغ في الغمد، والتزم بمتابعة الغمد بالاستعانة بالمنظار الفلوروسكوبي خلال الخطوة المتمثلة في إدخال الجهاز للكشف عن وجود الهواء.
- بعد الاستخدام، ينبغي تصنيف هذا الجهاز وملحقاته وعلبته للتخلص من تلك العناصر بالشكل الصحيح، كأن يتم تصنيفها على سبيل المثال على أنها نفايات بيولوجية خطرة، أو نفايات حادة، أو نفايات غير خطرة وما إلى ذلك، والتخلص منها بالتوافق مع الإجراءات المتبعة في المنشأة الطبية والقوانين واللوائح السارية.
- قد يحتوي مكون واحد أو أكثر من مكونات هذا الجهاز على المادة التالية المحددة كفئة CMR 1B بتركيز أعلى من 0.1% على أساس الوزن بالوزن: الكوبالت: مسجّل في Chemical Abstracts Service (CAS) برقم 4-48-7440؛ المفوضية الأوروبية (EC) رقم 0-158-231. تدعم الأدلة العلمية الحالية أن الأجهزة الطبية المصنعة من سبائك الكوبالت وسبائك الفولاذ المقاوم للصدأ التي تحتوي على الكوبالت، لا تسبب زيادة في خطر الإصابة بالسرطان أو تأثيرات ضارة بالإنجاب.

  قد يحتوي مكون واحد أو أكثر من مكونات هذا الجهاز على المادة التالية المحددة كفئة CMR 1A بتركيز أعلى من 0.1% على أساس الوزن بالوزن: الرصاص: مسجّل في Chemical Abstracts Service (CAS) برقم 1-92-7439؛ المفوضية الأوروبية (EC) رقم 4-100-231. تشير الأدلة العلمية المعروفة حاليًا إلى أن الأجهزة الطبية المصنعة من الرصاص لا تسبب زيادة خطر الإصابة بالسرطان أو الآثار الإنجابية الضارة.

الآثار الجانبية المحتملة

فئة الأثر الجانبي	الفئة الفرعية للأثر الجانبي
النزيف	النزيف الحاد/النزيف
	ورم دموي
الإصابة الدماغية	الانصمام الدماغي غير المصحوب بأعراض
	السكتة الدماغية/الحادث الوعائي الدماغي
	نوبة إقفارية عابرة (TIA)
الانصمام (الجلطة أو الانسداد الدموي)	انصمام هوائي
	انصمام بجسم غريب
	الانصمام الرئوي
	الانصمام الخثاري
	التخثر/التجلط
ثقب قلبي	اندحاس قلبي (دكاك القلب أو انهياره)
	انصباب تأموري
الإصابة الوعائية القلبية	تلف صمامي
	بزل جذر الشريان الأورطي
	انثقاب أذيني
اضطرابات جهاز التوصيل	العقدة الجيبية الأذينية أو العقدة الأذينية البطينية أو انسداد نظام هيس بيركينجي
	اضطراب النظم القلبي
رد فعل مناعي	فرط الحساسية
العدوى	التهاب التامور (غلاف القلب)
	التهاب الشغاف (التهاب بطانة القلب)
	الالتهاب الرئوي
	الإنتان
الألم/الشعور بعدم الراحة	ألم في الفخذ والصدر (ألم عام في الصدر غير مرتبط باحتشاء العضلة القلبية)
إصابة الأوعية الدموية الطرفية	التشريح
	التهتك
	تكوين الناسور الشرياني الوريدي
	تكوين تمدد الأوعية الدموية الكاذب
انخفاض ضغط الدم	غير متوفر
إصابة في الأنسجة السطحية	غير متوفر

التوجيهات

إعداد الجهاز وتجميعه

1. أخرج المحتويات من العلبة.

   ملاحظة: لا تقم بتجميع الغمد والموسّع.

2. اغسل الموسّع والغمد باستخدام محلول ملحي بالهيبارين.
3. أغلق محبس الغمد.
4. قم بإزالة المرود من الإبرة وغسل الإبرة بمحلول ملحي بالهيبارين.
5. أدخل المرود في الإبرة وقم بتثبيته داخل المحور.
6. أدخل الموسّع في الغمد العابر الحاجز بالكامل.

دفع مجموعة الغمد/الموسّع داخل الوريد الأجوف العلوي

1. قم بالوصول إلى الوريد الفخذي (يفضل الفخذ اليمنى).

   اختياري: مسموح باستخدام غمد قياسي (≥يزيد بمقدار 2.5 وحدة من المقاس الفرنسي (مقياس فرينش) عن مقاس الغمد العابر للحاجز) للحصول على إمكانية الوصول عبر الأوردة والحفاظ عليها من أجل تغيير الجهاز وإيقاف النزيف.

2. أدخل سلكًا دليليًا مقاس 0.032 بوصة و150 - 180 سم و3 ملم به رأس على شكل حرف "J" في الوريد الأجوف العلوي (SVC).

   ملاحظة: الحد الأقصى لقطر السلك الدليلي الذي يمكن استخدامه مع الموسّع عبر الحاجز هو 0.032 بوصة.

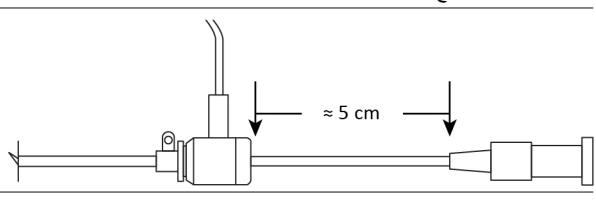
3. أدخل كلاً من مجموعة الغمد والموسّع العابر للحاجز في الوريد فوق السلك الدليلي وادفع المجموعة حتى رأس الغمد في الوريد الأجوف العلوي (SVC). قم بتوجيه رأس الموسّع في المنتصف.

ضع مجموعة الإبر/المرود عبر الحاجز داخل مجموعة الغمد/الموسّع

1. قم بإزالة السلك الدليلي من الموسّع.
2. اسحب الموسّع بالكامل ثم اغسله باستخدام محلول ملحي بالهيبارين.

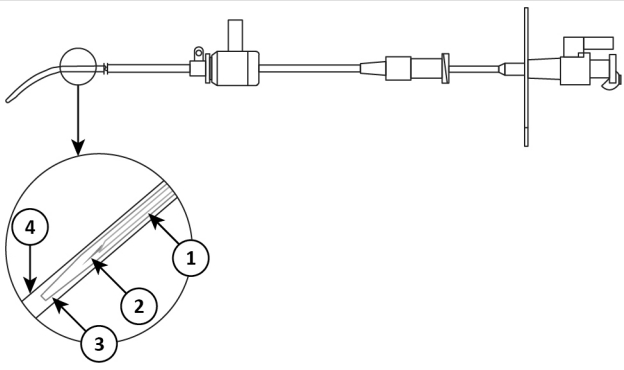
3. اسحب الموسع حوالي 5 سم (انظر الشكل أدناه) لتسهيل مرور منحنى الإبرة عبر المحاور الصلبة للموسّع والغمد.

شكل 1. سحب الموسّع



4. تأكد أن المرود مُثبّت على المحور.
5. أدخل الإبرة/المرود في الموسّع. قم بإدخال الإبرة/المرود تحت المنظار التألقي حتى يدخل حوالي 2 سم من طرف الموسّع داخل الغمد (انظر الشكل أدناه).

شكل 2. أدخل الإبرة/المرود في الموسّع

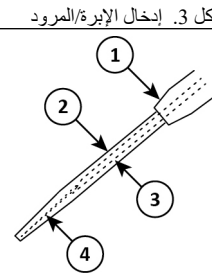


1. إبرة
2. المرود
3. طرف الموسّع
4. الغمد

6. لتوصيل الغمد والموسّع، ادفع الموسّع والإبرة/المرود في الغمد في نفس الوقت بالاستعانة بالمنظار الفلوروسكوبي. تأكد من أن موضع الإبرة داخل الموسّع لا يتغير حيث يتم توجيه كلا المكونين معًا. حافظ على موضع رأس الغمد في الوريد الأجوف العلوي.
7. ادفع الإبرة/المرود مع الاستعانة بالمنظار الفلوروسكوبي حتى يصل المرود إلى موضع دانٍ من رأس الموسّع تقريبًا (انظر الشكل أدناه).

شكل 3. إدخال الإبرة/المرود

1. طرف الغمد
2. الموسّع
3. إبرة
4. المرود



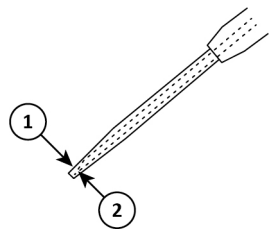
8. أزل المرود، لا تتخلص منه.
9. اسحب الإبرة حتى تلاحظ رجوع الدم. ثم تخلص من المحقنة.

ملاحظة: قد يمنع استخدام المحقنة -ذات الرأس المنزلق (وليست محقنة ‡Luer-Lok) شفط الهواء.

10. اغسل الإبرة باستخدام محلول ملحي بالهيبارين. • أغلق المحبس.
11. أدخل الإبرة تحت المنظار الفلوروسكوبي حتى يكون طرف الإبرة قريبًا من طرف الموسّع (انظر شكل أدناه).

شكل 4. إدخال طرف الإبرة

1. طرف الموسّع
2. طرف الإبرة



اختياري: قم بتوصيل المحبس الدوار ثلاثي الاتجاهات بمحور الإبرة.

اختياري: قم بتوصيل محقنة معبأة بوسيط تباين معتم للإشعاع بالمحبس. واسحب الإبرة. ثم قم بتعبئة الإبرة بوسيط التباين مسترشدًا بتوجيه المنظار التألقي.

اختياري: قم بتوصيل أنبوب لمراقبة الضغط بالمحبس.

اختياري: استخدم وحدة متشعب قياسية ذات 3 منافذ لربط أنابيب وسيط التباين والضغط والتدفق.

تعشيق الحفرة البيضوية

1. ضع تصورًا بصريًا لمواضع المعلمات التشريحية وقم بتحديدها.
2. اضبط منظار التصوير الفلوروسكوبي على زاوية موازية لمستوى الصمام التاجي ومتعامدة على سطح الحاجز. وعادةً ما يكون ذلك في وضعية تصوير أمامية يسرى (LAO) مائلة بدرجة 30 إلى 40 درجة.

اختياري: أثناء الإجراءات الخاصة بالفيزيولوجيا الكهربية، يمكن لمواضع الجيوب التاجية وقسطرة الحزمة الأذينية البطينية أن تكون بمثابة علامات تشريحية مفيدة. في عرض وضعية التصوير الأمامي اليسرى المائلة (LAO) والمناسبة، ستظهر قسطرة الجيب التاجي من منظر جانبي. في العرض الخاص بوضعية التصوير الأمامي المائلة اليمنى (RAO) المناسبة، تظهر قسطرة حزمة هيس من منظر جانبي. توجد الحفرة البيضوية على مستوى قسطرة الحزمة الأذينية البطينية أو تحتها بقليل وتكون علوية وخلفية بالنسبة لفوهة الجيب التاجي.

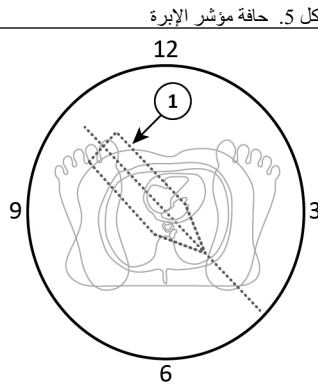
اختياري: يمكن القيام بتعشيق قسطرة للتصوير الوعائي/المراقبة الديناميكية الدموية في الشرفة غير التاجية للصمام الأبهري للاستفادة منها كمَعْلَم تشريحي مفيد.

اختياري: راقب الشكل الموجي للضغط الذي يتم تسجيله من خلال الإبرة العابرة BRK™.

3. اضبط حافة المؤشر بحيث تكون الإبرة عمودية على الحفرة البيضوية (تكون في وضع شبيه بموضع عقارب الساعة عندما تشير إلى الساعة 3:00 والساعة 5:00 ، من منظورك عند الوقوف عند طرف قدم المريض). (انظر الشكل أدناه).

شكل 5. حافة مؤشر الإبرة

1. حافة مؤشر الإبرة

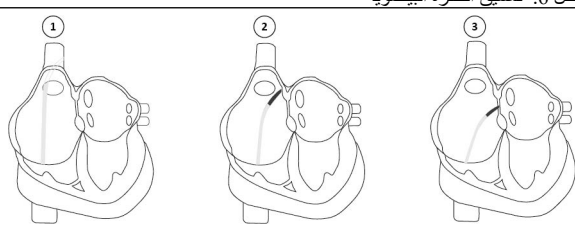


4. استعن بالمنظار الفلوروسكوبي للتأكد من أن طرف الإبرة موجود داخل الموسّع.

5. بعد التأكد من أن رأس الإبرة داخل الموسّع، اسحب مجموعة الغمد/الموسّع/الإبرة بأكملها ببطء. امنع أي حركة لأجزاء التجمّع بالنسبة لبعضها البعض. من الضروري أن تحافظ على الاتجاه السابق لحافة المؤشر أثناء سحب المجموعة.
6. من وضعية العرض الأمامي الأيسر المائل (المتعامد مع الحاجز الأذينيّ)، لاحظ رأس الموسّع أثناء السحب للتأكد من عدم تحركه المفاجئ في الوسط (أو على ناحية اليمين)، مما يشير إلى تعشيق الرأس في الحفرة البيضوية. (انظر الشكل أدناه).

ملاحظة: إذا كانت الحفرة البيضوية بها عيب يمكن كشفه بأداة الفحص، فسوف يتحرك رأس الموسّع الآن داخل الأذين الأيسر بسهولة تامة.

شكل 6. تعشيق الحفرة البيضوية



1. الموضع الأولي في الوريد الأجوف العلوي
2. الحركة الأولية في المنتصف في الأذين الأيمن
3. حركة مفاجئة في المنتصف داخل الحفرة البيضوية

ملاحظة: في حالة مراقبة الضغط من خلال الإبرة، لاحظ أن الضغط من خلال الإبرة لن يكون دقيقًا في هذه المرحلة، لأن الرأس يكون موجهًا للحفرة البيضوية.

بزل الحفرة البيضوية باستخدام الإبرة العابرة للحاجز ™BRK

1. تأكد من صحة موضع مجمّع الغمد/الموسّع/الإبرة على الحفرة البيضوية قبل إدخال الإبرة.
2. بمجرد التأكد من الموضع الصحيح، ادفع الإبرة حتى يتم تعشيقها بالكامل داخل مجمّع الغمد/الموسّع وادفعها عبر الحاجز بين الأُذَينَيْن.

اختياري: أثناء مراقبة الضغط، يتم التأكد من إدخال القسطرة داخل الأذين الأيسر عندما يُظهر تتبع الضغط شكلاً موجيًا في ضغط الأذين الأيسر.

اختياري: يمكن التأكد من دخول الأذين الأيسر تحت المنظار التألقي من خلال عمليات حقن وسائط التباين.

3. إذا كان هناك أي مقاومة أثناء توجيه الإبرة إلى الأمام، فاسحب الإبرة وأعد تقييم المعلمات التشريحية.

تنبيه: في حالة الدخول إلى التأمور أو الشريان الأورطي، لا تدفع الموسّع فوق الإبرة. إذا اخترقت الإبرة التأمور أو الشريان الأورطي، فيجب سحبها. يجب مراقبة العلامات الحيوية عن قرب.

دفع مجمّع الغمد/الموسّع داخل الأذين الأيسر

في أثناء الحفاظ على موضع الإبرة الثابت داخل الأذين الأيسر، ادفع مجموعة الغمد/المُوسّع بالكامل إلى الأمام فوق الإبرة داخل التجويف الأذيني الأيسر.

دفع الغمد فوق الموسّع الثابت والإبرة داخل الأذين الأيسر

1. حافظ على موضع الإبرة والموسّع عبر الحاجز.
2. ادفع الغمد بالكامل فوق الموسّع داخل التجويف الأذيني الأيسر، مع الحفاظ على الموسّع في موضع ثابت.

سحب الحفرة البيضوية باستخدام الإبرة العابرة للحاجز ™BRK

تنبيه: هناك خطر لتسرب الهواء عند سحب مواد من صمام الإرقاء الموجود بالغمد. اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الهواء عن طريق سحب العناصر ببطء لمنع تراكم الفراغ في الغمد، والتزم بمتابعة الغمد بالاستعانة بالمنظار الفلوروسكوبي خلال الخطوة المتمثلة في إدخال الجهاز للكشف عن وجود الهواء.

1. أدر محبس الإبرة إلى وضع إيقاف التشغيل وافصل أي ملحقات بمحور الإبرة.
2. قم بإزالة الإبرة العابرة للحاجز ™BRK من الموسّع. يمكن تنظيف الإبرة ووضعها جانبًا لاستخدامها مرة أخرى في هذا الإجراء الطبي، وفي حالة عدم النية في إعادة استخدامها، فعليك بالتخلص منها باتباع الوسائل المناسبة للتخلص من العناصر الحادة الملوثة.
3. قم بتوصيل محققة على الفور بالموسّع وقم بالشفط. استمر في شفط الدم أثناء تثبيت الغمد في الموضع وسحب الموسّع. ينبغي أن يكون الدم المسحوب من الشرايين.
4. بعد إزالة الموسّع، اسحب الدم من خلال الذراع الجانبية للغمد. اغسل بعناية الجزء الجانبي للغمد باستخدام محلول ملحي تمت معالجته بالهيبارين لتجنب تكون فقاعات الهواء.
5. الغمد الآن في موضعه في البطين الأيسر.

العبوة وفترة الصلاحية

تتوفر الإبرة العابرة للحاجز ™BRK في حالة معقمة. يتم تعبئة الإبرة في علبة تشتمل على المرود. يتم وضع الإبرة والمرود في العلبة الرئيسية. يتم وضع العلبة الرئيسية داخل مغلف ‡Mylar و ‡Tyvek محكم الإغلاق حراريًا. يتم بعد ذلك وضع المغلف وتعليمات الاستخدام هذه في صندوق محكم الإغلاق من الطرفين. يحمل كل من المغلف والمنتج ملصقًا يحتوي على معلومات المنتج، بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية. يشير الملصق الموجود على المنتجات إلى فترة صلاحيتها البالغة ثلاث سنوات.

ملخص البيانات السريرية

بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي: سيتم نشر ملخص للسلامة والأداء السريري (SSCP) لهذه الأجهزة على موقع https://ec.europa.eu/tools/eudamed من قبل الهيئات الرقابية المعنية وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي MDR 2017/745 والجداول الزمنية ذات الصلة. ابحث عن الجهاز باستخدام UDI-DI المتوفر على العبوة الخارجية للجهاز. UDI-DI هو الرقم المكون من 14 عددًا بين أول مجموعتين من الأقواس. لمزيد من المعلومات حول العثور على رقم UDI-DI واستخدامه، اطّلع على مستند الأسئلة الأكثر شيوعًا الموجود في medical.abbott/manuals.

الإبلاغ عن الحوادث

إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بحدوث أمر خطير أثناء استخدام هذا الجهاز، فيُرجى إبلاغ الجهة المُصنِّعة بذلك. بالنسبة للعملاء في الاتحاد الأوروبي، قم بالإبلاغ عن الحادث الخطير للسلطة الوطنية المختصة وكذلك الجهة المُصنِّعة.

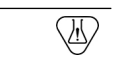
ضمان محدود

تضمن شركة Abbott Medical أن تكون منتجاتها خالية من عيوب الخامات والصناعة عند استخدامها في الظروف المعتادة. لا يتجاوز هذا الضمان تاريخ انتهاء الصلاحية" المدون على ملصق المنتج. وتم توضيح الاستخدامات المُصرَّح بها وطرق الاستخدام المعتمدة لكل منتج من منتجاتنا في تعليمات الاستخدام" ذات الصلة المرافقة لكل منتج. تخلي شركة Abbott Medical أية مسؤولية وغيرها من المسؤوليات القانونية عن استخدام منتجاتها بطريقة لم يتم التصريح بها أو اعتمادها. تقتصر مسؤولية شركة Abbott Medical وفقًا لهذا الضمان على استبدال منتجاتها. كما يستبعد الضمان المذكور آنفًا ويحل محل جميع الضمانات الأخرى سواء كانت صريحة أو ضمنية، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات ضمنية للتسويق أو الملاءمة لغرض آخر. تخلي شركة Abbott Medical أية مسؤولية قانونية مقابل أية خسارة عرضية أو غير مباشرة، أو تلف، أو مصروفات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استخدام هذا المنتج، بخلاف ما ينص عليه قانون محدد بشكل صريح. لا تتحمل شركة Abbott Medical ولا تفوّض أي شخص آخر لفرض أية مسؤولية قانونية أخرى أو إضافية مقابل أية خسارة، أو تلف، أو مصروفات فيما يتعلق بهذا المنتج. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة سياسة الضمان الكاملة لدى شركة Abbott Medical التي تتوفر من جانب شركة Abbott Medical أو الموجودة على ظهر الفاتورة المقدمة من شركة Abbott Medical.

الرموز

يمكن إيجاد الرموز الموضحة أدناه والرموز الموحدة على المنتج أو الملصق الخاص به. للتعرُّف على الرموز الموحدة، راجع مسرد الرموز العالمية في medical.abbott/manuals.

الرمز	التعريف
Series	السلسلة
Contents	المحتويات
Transseptal Needle	إبرة عبر الحاجز
⬭	نظام مانع أحادي مُعقَّم
⟷	الطول

الرمز	التعريف
	تنبيه: تحظر القوانين الفيدرالية (في الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز إلا بواسطة طبيب أو بأمر منه.
	Conformité Européenne (التوافق مع المعايير الأوروبية). ملحق بهذا الجهاز وفقًا للوائح المجلس الأوروبي 2017/745. وتشير هذه العلامة إلى إقرار شركة Abbott Medical بأن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية لهذه اللائحة والبنود الأخرى ذات الصلة.
	المستورد
	تم تقييم المطابقة للمتطلبات المعمول بها في المملكة المتحدة
	الشخص المسؤول في المملكة المتحدة
	علامة المطابقة الأوكرانية للوائح التنظيمية الفنية، حيث تكون 101 هي جهة التقييم.
	جهاز طبي
	الرقم التعريفي الفريد الخاص بالجهاز
	اتبع تعليمات الاستخدام على هذا الموقع الإلكتروني
 (7440-48-4) (7439-92-1)	يحتوي على مواد خطرة. (الكوبالت CAS رقم 4-48-7440) (رصاص مسجل في خدمة (CAS) تحت رقم 1-92-7439)

BG: Български

BRK™ Транссептална игла

Инструкции за употреба

Описание

Транссепталната игла BRK™ се състои от луминална игла от неръждаема стомана и здрав стилет от неръждаема стомана. Дисталната секция на иглата е извита, за да улесни поставянето в сърцето, когато се използва с комплект на транссептално дезиле на Abbott Medical. В рамките на тази извита секция има рязко намаление във външния диаметър на иглата, за да се съчетае с вътрешния диаметър на дилататора на комплект на транссептално дезиле на Abbott Medical. Дисталният връх на иглата е скосен, за да улесни процеса на пробиване. Проксималният край на иглата е конфигуриран с фланец на показалеца (показващ ориентацията на дисталната крива) и е снабден с двупосочен спирателен кран за осигуряване на достъп на иглата до лумена за аспирация, инжектиране/вливане на течност, вземане на кръвни проби, следене на налягането и въвеждане на стилет и/или водач (максимален диаметър на водача 0,014 in. (0,035 cm) за игла с размер 18; максимален диаметър на водача 0,012 in. (0,030 cm) за игла с размер 19). Стилетът е прав и изодиаметричен по цялата си дължина. Проксималният край на стилета е снабден с извита щипка, която се заключва върху проксималната втулка на иглата, когато се вкарва в лумена на иглата. Стилетът е проектиран да улеснява вкарването на иглата в дилататора. Иглата се предлага с различни използваеми дължини и конфигурации на дисталната крива.

Предназначение

Транссепталната игла BRK™ е предназначена за пробиване на интератриалния септум, за да се получи достъп до лявата половина на сърцето.

Показания за употреба

Транссепталната игла BRK™ се използва за пробиване на интератриалния септум по време на процедура за транссептална катетеризация, за да се получи достъп до лявата половина на сърцето.

Целева група пациенти

Транссепталната игла BRK™ е предназначена за използване при хемодинамично стабилни пациенти, нуждаещи се от катетърен достъп до лявата половина на сърцето. Използването на транссепталната игла BRK™ може да изисква специално внимание при пациенти със следните състояния:

- Ротирано сърце
- Уголемен аортен корен
- Маркирано уголемяване на дясното предсърдие
- Сколиоза/кифоза
- Абнормна геометрия на лявото предсърдие
- Вродени малформации
- Съдови малформации
- Невъзможност за достъп до дясното предсърдие през долната куха вена

Предназначен потребител

Това устройство трябва да се използва само от лекари, които са специално обучени в извършването на транссептални процедури в напълно оборудвана операционна лаборатория по електрофизиология.

Клинични ползи

Предвидената клинична полза от транссепталната игла BRK™ е да се осъществи пробив на интератриалния септум по време на транссептална процедура за катетеризация, за да се получи достъп до лявата половина на сърцето и да се даде възможност на устройства, изискващи достъп до левия ендокард на сърцето, да постигнат предвидената си клинична полза, като например аблационния катетър. Това се измерва чрез успешно пробиване на интератриалния септум.

Противопоказания

- Предишен интератриален септален пластир или устройство за затваряне на протезен предсърден септален дефект.
- Всякакво предишно тромбоемболично събитие.
- Известна или подозирана миксома на лявото предсърдие.
- Известен или подозиран инфаркт на миокарда през последните две седмици.
- Нестабилна стенокардия.
- Скорошен мозъчносъдов инцидент (CVA).
- Пациенти, които не понасят антикоагулантната терапия.
- Пациенти с активна инфекция.

Предупреждения

- Не модифицирайте изделието по никакъв начин.
- Това изделие е предназначено само за еднократна употреба; не го обработвайте и не го използвайте повторно. Вижте датата „Да се използва до“ на продукта върху опаковката. Всеки опит за повторно стерилизиране и повторно използване на тази система може да компрометира нейната цялост. Нежеланите реакции при използване на нестерилни включват, но не се ограничават до:
  - Локална и системна инфекция или реакция
  - Механична повреда
  - Неточности във функционалността
- Материалите, посочени по-долу за всеки продукт, могат да причинят алергични реакции или реакции на свръхчувствителност. Лица, които са алергични към тях, могат да получат алергична реакция към този продукт. Преди да се използва върху пациента, пациентът трябва да бъде консултиран относно материалите, съдържащи се в изделието, и трябва да се обсъди цялостна анамнеза за алергии:
  - Неръждаема стомана
  - Епоксидно лепило
  - Месинг с никел-хромово покритие
  - Силиконова смазка за висок вакуум (Dupont)
  - Master Bond
- Неправилната употреба на това изделие може да доведе до сериозни усложнения.
- Както за пациентите, така и за лабораторния персонал, процедурите на сърдечна катетеризация носят риск от значително рентгеново облъчване, което може да доведе до остро радиационно увреждане, както и увеличен риск от соматични и генетични въздействия поради интензивността на рентгеновия лъч и продължителността на флуороскопското изобразяване. Внимателно обмислете употребата на това изделие при бременни жени.

Предпазни мерки

- Федералното законодателство (САЩ) ограничава продажбата на това изделие да се извършва само от или по поръчка на лекар.
- Прочетете указанията преди употреба.
- Огледайте опаковката преди употреба. Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена.
- Прегледайте всички компоненти преди употреба.
- Да се съхранява на хладно, тъмно и сухо място.
- Преди процедурата пациентът трябва да е хемодинамично стабилен. Някои условия могат да изискват специално обмисляне при използването на този продукт. Те може да включват следните, без този списък да е изчерпателен:
  - Ротирано сърце
  - Уголемен аортен корен
  - Маркирано уголемяване на дясното предсърдие
  - Сколиоза/кифоза
  - Абнормна геометрия на лявото предсърдие
  - Вродени малформации
  - Съдови малформации
  - Невъзможност за достъп до дясното предсърдие през долната куха вена
- Това устройство трябва да се използва само от лекари, които са специално обучени в извършването на транссептални процедури в напълно оборудвана операционна лаборатория по електрофизиология (EP).
- Придвижването на катетъра напред трябва да се извършва под флуороскопско наблюдение, за да се намали рискът от нараняване, перфорация или тампонада на сърцето. Използването на съвместими системи за навигация и визуализация в реално време също може да бъде взето предвид.
- По време на поставянето проверявайте за прекомерно съпротивление, докато върхът на иглата напредва през кривината на модула на дезилето/дилататора. Ако има съпротивление срещу напредването на иглата, изтеглете иглата и преценете компонентите.
- При въвеждането внимавайте да не нагънете прекалено изделието. Това може да попречи на вкарването на иглата и може да доведе до неволно пробиване на модула на дилататора/дезилето.
- По време на поставянето винаги използвайте стилета, за да улесните преминаването на иглата през модула на дилататора/дезилето. Неизползването на стилета може да попречи на вкарването на иглата и може да доведе до неволно пробиване с иглата на модула на дилататора/дезилето или остъргване на материал от вътрешната повърхност на дилататора.
- Ако настъпи перикарден или аортен вход, не придвижвайте дилататора над иглата. Ако иглата е проникнала в перикарда или аортата, тя трябва да бъде изтеглена. Следете внимателно жизнените показатели.
- Съществува риск от проникване на въздух при изтегляне на предмети от хемостазния клапан на дезилето. Вземете предпазни мерки, за да предотвратите проникването на въздух, като бавно изтегляте предмети, за да предотвратите натрупването на вакуум в дезилето, и под флуороскопски контрол наблюдавайте дезилето по време на последващото въвеждане на изделието за наличие на въздух.
- След употреба това устройство, принадлежностите му и опаковките трябва да бъдат правилно класифицирани за изхвърляне, напр. биологично опасни отпадъци, остри предмети, неопасни отпадъци и др., и да бъдат внимателно изхвърлени в съответствие с процедурите на здравното заведение и приложимите закони и разпоредби.
- Един или повече компоненти на това изделие могат да съдържат следното вещество, определено като CMR 1B в концентрация от над 0,1% тегловно: Кобалт: Служба за химични индекси (CAS) No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0. Съвременните научни данни подкрепят тезата, че медицинските изделия, произведени от кобалтова сплав и сплав от неръждаема стомана, съдържаща кобалт, не водят до повишен риск от рак или неблагоприятно въздействие върху репродуктивната способност.

  Един или повече компоненти на това изделие могат да съдържат следното вещество, определено като CMR 1A в концентрация от над 0,1% тегловно: Олово: Служба за химични индекси (CAS) No. 7439-92-1; EC No. 231-100-4. Съвременните научни данни подкрепят тезата, че медицинските изделия, произведени от олово, не водят до повишен риск от рак или неблагоприятно въздействие върху репродуктивната способност.

Потенциални нежелани събития

Категория нежелани реакции	**Подкатегория нежелани реакции**
Кървене	Кръвоизлив/кървене
	Хематом
Мозъчна травма	Безсимптомна мозъчна емболия
	Инсулт/мозъчносъдов инцидент
	Преходен исхемичен пристъп (TIA)
Емболия	Въздушна емболия
	Емболия от чуждо тяло
	Белодробна емболия
	Тромбоемболия
	Тромбоза/тромб
Сърдечна перфорация	Сърдечна тампонада
	Перикарден излив
Сърдечносъдово нараняване	Клапно увреждане
	Пробив на корена на аортата
	Перфорация на предсърдието
Смущение в проводящата система	SA възел, AV възел или His-Purkinje системен блок
	Сърдечни аритмии
Имунологична реакция	Анафилаксия
Инфекция	Перикардит
	Ендокардит
	Пневмония
	Сепсис
Болка/дискомфорт	Болка, в слабините, в гърдите (обща болка в гърдите, която не е свързана с МИ)

Категория нежелани реакции	Подкатегория нежелани реакции
Увреждане на периферните съдове	Дисекция
	Лацерация (разкъсване)
	Образуване на артериовенозна фистула
	Образуване на псевдоаневризма
Хипотония	Не е приложимо
Нараняване на повърхностна тъкан	Не е приложимо

Указания

Подготовка и монтаж на оборудването

1. Извадете съдържанието от опаковката.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Не сглобявайте дезилето и дилататора.

2. Промийте дилататора и дезилето с хепаринизиран физиологичен разтвор.
3. Затворете спирателния кран на дезилето.
4. Извадете стилета от иглата и промийте иглата с хепаринизиран физиологичен разтвор.
5. Поставете стилета в иглата и го фиксирайте върху втулката.
6. Въведете дилататора изцяло в транссепталното дезиле.

Напредване на модула на дилататора/ дезилето в горната куха вена

1. Получете достъп до феморалната вена (за предпочитане дясната феморална вена).

   ОПЦИЯ: Дезиле с по-голяма (размери 2,5 Fr. са по-големи от транссепталното дезиле) стандартна дължина може да се използва за получаване и поддържане на венозен достъп за обмен на устройства и хемостаза.

2. Въведете телен водач с параметри: 0,032 in., 150–180 cm, 3 mm „J“ връх в горната куха вена (SVC).

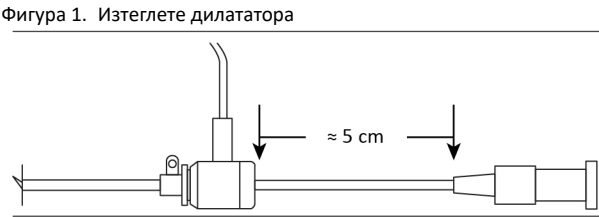
   ЗАБЕЛЕЖКА: 0,032 in. е максималният диаметър на теления водач, който може да се използва с дилататора.

3. Въведете дезилето/дилататора във вената над теления водач, докато върхът на дезилето не влезе в горната куха вена (SVC). Ориентирайте накрайника на дилататора медиално.

Позициониране на модула на иглата/стилета вътре в модула на дезилето/дилататора

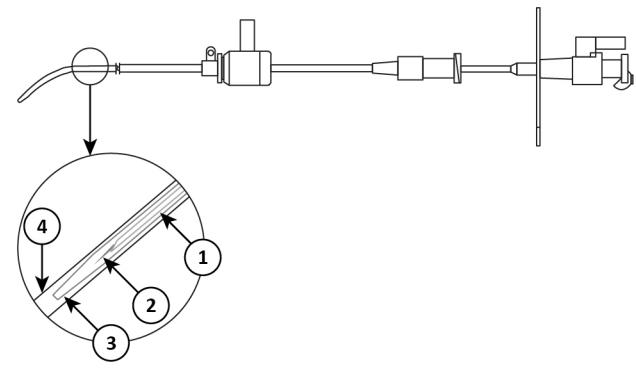
1. Отстранете теления водач от дилататора.
2. Аспирирайте напълно и след това промийте дилататора с хепаринизиран физиологичен разтвор.
3. Изтеглете дилататора на около 5 cm (вж. фигурата по-долу), за да улесните преминаването на иглата през твърдите втулки на дилататора и дезилето.

Фигура 1. Изтеглете дилататора



4. Заключете стилета върху втулката.
5. Въведете иглата/стилета в дилататора. Придвижете иглата/стилета под флуороскопски контрол, докато е приблизително на 2 cm от накрайника на дилататора вътре в дезилето (вж. фигурата по-долу).

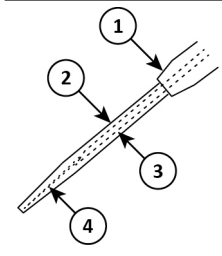
Фигура 2. Въведете иглата/стилета в дилататора



1. Игла
2. Стилет
3. Връх на дилататора
4. Маншон

6. За да свържете отново дезилето и дилататора, придвижете дилататора и иглата/стилета в дезилето едновременно под флуороскопски контрол. Уверете се, че положението на иглата в дилататора не се променя, докато и двата компонента се придвижват заедно. Поддържайте положението на върха на дезилето в горната куха вена.
7. Под флуороскопски контрол придвижете иглата/стилета, докато стилетът не бъде разположен в непосредствена близост до накрайника на дилататора (вж. фигурата по-долу).

Фигура 3. Придвижете иглата/стилета



1. Връх на дезилето
2. Дилататор
3. Игла
4. Стилет

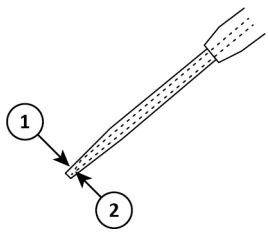
8. Отстранете стилета, но не го изхвърляйте.
9. Аспирирайте иглата, докато не се забележи връщане на кръв. Изхвърлете спринцовката.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на спринцовка с плъзгащ-връх (без Luer-Lok‡) може да предотврати всмукването на въздух.

10. Промийте иглата с хепаринизиран физиологичен разтвор. Затворете спирателния кран.

11. Придвижете иглата под флуороскопски контрол, докато върхът на иглата застане в непосредствена близост до накрайника на дилататора (вж. фигурата по-долу).

Фигура 4. Придвижете върха на иглата



1. Връх на дилататора
2. Връх на иглата

ОПЦИЯ: Прикрепете 3-пътен спирателен кран към втулката на иглата.

ОПЦИЯ: Прикрепете спринцовка с рентгеноконтрастно вещество към спирателния кран. Аспирирайте иглата. След това заредете иглата с контрастното вещество под флуороскопски контрол.

ОПЦИЯ: Свържете линия за следене на налягането към спирателния кран.

ОПЦИЯ: Използвайте стандартна настройка на 3-портовия колектор за свързване на линии за контраст, кръвно налягане и промиване.

Ангажирайте овалната ямка

1. Визуализирайте и идентифицирайте анатомични ориентири.
2. Настройте флуороскопското устройство под ъгъл, успореден на равнината на митралната клапа и ортогонален спрямо равнината на септума. Обикновено това ще бъде лява предна коса проекция (LAO), приблизително от 30 до 40 градуса.

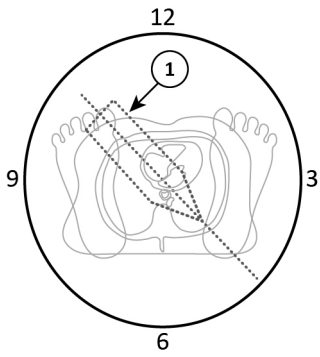
   ОПЦИЯ: По време на електрофизиологичните (EP) процедури позициите на коронарния синус и катетъра на снопа на Хис могат да послужат като полезни анатомични ориентири. В подходящ изглед на лява коса проекция (LAO) катетърът на коронарния синус се вижда в профил. В подходящ изглед на дясна предна коса проекция (RAO) катетъра на снопа на Хис се вижда в профил. Овалната ямка е разположена на или малко под нивото на катетъра на снопа на Хис и е по-горна и задна спрямо коронарния синусов остиум.

   ОПЦИЯ: Поставянето на ангиографски/хемодинамичен катетър за мониторинг тип „Pigtail“ в некоронарния връх на аортната клапа може да послужи като полезен анатомичен ориентир.

   ОПЦИЯ: Наблюдавайте кривата на вълната на кръвното налягане, която се записва, чрез транссептална игла BRK™.

3. Настройте фланеца на показалеца така, че иглата да е перпендикулярна на овалната ямка (обикновено между 3:00 и 5:00 часа, както се гледа от крака на пациента). (Вижте фигурата по-долу.)

Фигура 5. Фланец на показалеца на иглата



1. Фланец на показалеца на иглата

4. Използвайте флуороскопски контрол, за да потвърдите, че върхът на иглата е вътре в дилататора.
5. След като потвърдите, че върхът на иглата е вътре в дилататора, плъзнете бавно целия модул дезиле/дилататор/игла. Предотвратете всякакво движение на частите на модула една спрямо друга. Важно е да се поддържа предишната ориентация на фланеца на показалеца, докато плъзгате модула.
6. В изглед LAO (ортогонален на интератриалния септум) наблюдавайте върха на дилататора по време на плъзгането за рязко медиално (или дясно) движение, което показва, че върхът е захванал овалната ямка. (Вижте фигурите по-долу.)

   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако овалната ямка е проходима за сондата, накрайникът на дилататора се премества в лявото предсърдие с лекота.

Фигура 6. Ангажирайте овалната ямка



1. Начална позиция в SVC
2. Първоначално медиално движение в PRA
3. Рязко медиално движение върху овалната ямка

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако налягането се проследява през иглата, налягането през иглата в този момент ще бъде неточно, тъй като върхът е срещу овалната ямка.

Пробийте овалната ямка с транссептална игла BRK™

1. Проверете правилното местоположение на модула дезиле/дилататор/игла върху овалната ямка, преди да придвижите иглата напред.
2. След като бъде потвърдено правилното местоположение, разгънете иглата до пълно захващане в модула дезиле/дилататор и я придвижете напред през интератриалния септум.

   ОПЦИЯ: При следене на налягането влизането в лявото предсърдие се потвърждава, когато проследяването на кръвното налягане показва крива на вълна на лявото артериално налягане.

   ОПЦИЯ: Достъпът до лявото предсърдие може да бъде потвърден чрез флуороскопски контрол с контрастни инжекции.

3. Ако има съпротивление срещу напредването на иглата, приберете иглата и оценете повторно анатомичните ориентири.

   ВНИМАНИЕ: Ако настъпи перикарден или аортен вход, не придвижвайте дилататора над иглата. Ако иглата е проникнала в перикарда или аортата, тя трябва да бъде изтеглена. Следете внимателно жизнените показатели.

Придвижете модула на дезилето/дилататора в лявото предсърдие

Докато поддържате неподвижно положение на иглата в лявото предсърдие, придвижете напред модула дезиле/дилататор изцяло над иглата в лявата предсърдна кухина.

Придвижете дезилето над фиксирания дилататор и иглата в лявото предсърдие

1. Поддържайте позицията на иглата и дилататора през септума.
2. Докато поддържате дилататора на фиксирано място, придвижете напред дезилето изцяло над дилататора в лявата предсърдна кухина.

Изтеглете транссептална игла BRK™ и дилататора

ВНИМАНИЕ: Съществува риск от проникване на въздух при изтегляне на предмети от хемостазния клапан на дезилето. Вземете предпазни мерки, за да предотвратите проникването на въздух, като бавно изтегляте предмети, за да предотвратите натрупването на вакуум в дезилето, и под флуороскопски контрол наблюдавайте дезилето по време на последващото въвеждане на изделието за наличие на въздух.

1. Завъртете спирателния кран на иглата, за да го спрете, и изключете всички приставки към втулката на иглата.
2. Извадете транссептална игла BRK™ от дилататора. Иглата може да бъде почистена и оставена настрана за повторна употреба в тази процедура. В противен случай изхвърлете иглата, както е подходящо за замърсени остри предмети.
3. Незабавно прикрепете спринцовка към дилататора и аспирирайте. Продължете да аспирирате кръвта, докато държите дезилето в положение и изтегляте дилататора. Кръвта трябва да бъде артериална кръв.
4. След като отстраните дилататора, аспирирайте кръв през страничното рамо на дезилето. Внимателно промийте страничното рамо на дезилето с хепаринизиран физиологичен разтвор, за да избегнете образуването на въздушни мехурчета.
5. Дезилето вече е поставено в лявото предсърдие.

Опаковка и срок на годност

Транссептална игла BRK™ се доставя стерилна. Иглата е опакована с поставен стилет. Иглата и стилетът са поставени в основната опаковка. Основната опаковка е поставена вътре в торбичка Mylar‡ и Tyvek‡, която е термично запечатана. Торбичката и тези инструкции за употреба са поставени в кутия, която е запечатана в двата края. И торбичката, и кутията имат етикет с информация за продукта, включително срока на годност. Продуктите са етикетирани за срок на годност три години.

Обобщение на клиничните данни

За държави от Европейския съюз: Обобщение на безопасността и клиничното действие (SSCP) за тези устройства ще бъде публикувано на https://ec.europa.eu/tools/eudamed от нотифицираните органи в съответствие с изискванията на EU MDR 2017/745 и свързаните с тях срокове. Потърсете устройството чрез UDI-DI на външната опаковка на устройството. UDI-DI е 14-цифреният номер между първите две групи скоби. За повече информация относно откриването и използването на UDI-DI вижте документа „Често задавани въпроси“, който се намира на адрес medical.abbott/manuals.

Докладване на инциденти

Ако по време на използването на това изделие имате основание да смятате, че е възникнал сериозен инцидент, моля, съобщете го на производителя. За клиенти в Европейския съюз: докладвайте за сериозния инцидент на Вашия национален орган, както и на производителя.

Ограничена гаранция

Abbott Medical гарантира, че продуктите на компанията не съдържат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба. Тази гаранция не надхвърля датата на „изтичане на срока на годност“, посочена върху етикета на всеки продукт. Разрешената употреба и одобрените методи за използване на всеки от нашите продукти са дадени в съответните „Инструкции за употреба“, придружаващи всеки продукт. Abbott Medical не носи каквато и да е отговорност и задължение за използването на продуктите на компанията по начин, който не е разрешен или одобрен. Отговорността на Abbott Medical съгласно тази гаранция е ограничена до подмяна на нейните продукти. Гореупоменатата гаранция изключва и замества всички други гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но без ограничение, всякакви подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел. Abbott Medical не носи отговорност за никакви инцидентни или последващи загуби, повреди или разноски, възникнали пряко или непряко от използването на този продукт, освен изрично упоменатите от конкретния закон. Abbott Medical не поема и не упълномощава друго лице да поеме каквато и да било друга или допълнителна отговорност за загуба, повреда или разходи във връзка с този продукт. За повече подробности вижте пълната гаранционна политика на Abbott Medical, налична от Abbott Medical или на гърба на фактура от Abbott Medical.

Символи

Символът по-долу и хармонизираните символи могат да бъдат открити върху продукта или етикета. За хармонизирани символи направете справка в Универсалния речник на символите на medical.abbott/manuals.

Символ	Дефиниция
Series	Серия
Contents	Съдържание
Transseptal Needle	Транссептална игла
	Единична стерилна бариерна система
	Дължина
	ВНИМАНИЕ: Федералното законодателство (САЩ) ограничава продажбата на това изделие да се извършва само от или по поръчка на лекар.
	Conformité Européenne (Европейско съответствие). Поставена в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския съвет. С настоящото Abbott Medical декларира, че това устройство отговаря на съответните изисквания и на други съществени разпоредби на този регламент.
	Вносител

Символ	Дефиниция
UK CA 0086	Оценка на съответствието за Обединеното кралство
UKRP	Отговорно лице в Обединеното кралство
UA.TR.101	Украинска маркировка за съответствие с техническите регулации, където 101 е органът за оценка.
MD	Медицинско изделие
UDI	Уникален идентификационен номер на изделието
medical.abbott/manuals	Следвайте инструкциите за употреба на този уебсайт
(7440-48-4) (7439-92-1)	Съдържа опасни вещества. (Кобалт CAS № 7440-48-4) (Олово CAS № 7439-92-1)

CS: Čeština

BRK™ Transseptální jehla

Návod k použití

Popis

Transseptální jehla BRK™ sestává z luminální jehly z nerezové oceli a pevného styletu z nerezové oceli. Distální část jehly je zahnuta, což při použití se soupravou transseptálního pouzdra společnosti Abbott Medical usnadňuje její usazení v srdci. V této zahnuté části dochází k ostrému poklesu vnějšího průměru jehly umožňujícímu propojení s vnitřním průměrem dilatátoru soupravy transseptálního pouzdra společnosti Abbott Medical. Distální koncovka jehly je zkosena, což usnadňuje provádění punkce. Proximální konec jehly je vybaven patkou (indikující orientaci distálního zakřivení) a je osazen dvojcestným kohoutem poskytujícím přístup do průduchu jehly pro nasávání, vstřikování/infuzi kapalin, odběr vzorků krve, monitorování tlaku a zavádění styletu anebo vodicího drátu (vodicí drát o maximálním průměru 0,014 palce pro jehlu velikosti 18 nebo o maximálním průměru 0,012 palce pro jehlu velikosti 19). Stylet je rovný a má po celé délce stejné rozměry. Proximální konec styletu je vybaven zakřivenou úchytkou sloužící k upevnění k proximální hlavě jehly, když je zaveden do průchodu jehly. Stylet je konstruován tak, aby usnadnil zavádění jehly v dilatátoru. Jehla se dodává v různých použitelných délkách a konfiguracích distálního zakřivení.

Zamýšlený účel

Transseptální jehla BRK™ je určena k punkci síňového septa za účelem získání přístupu do levé části srdce.

Indikace k použití

Transseptální jehla BRK™ se používá k punkci síňového septa během transseptální katetrizace pro přístup k levé části srdce.

Cílová skupina pacientů

Transseptální jehla BRK™ je určena pro použití u hemodynamicky stabilních pacientů vyžadujících katetrový přístup do levé části srdce. Použití transseptální jehly BRK™ vyžaduje zvláštní pozornost u pacientů s následujícími stavy:

- Rotované srdce,
- Rozšířený kořen aorty,
- Významné zvětšení pravé srdeční síně,
- Skolióza/kyfóza,
- Abnormální rozměry levé síně,
- Vrozené malformace,
- Cévní malformace,
- Nemožnost přístupu do pravé síně skrz dolní dutou žílu.

Zamýšlený uživatel

Toto zařízení mohou používat pouze lékaři, kteří jsou speciálně vyškoleni v transseptálních postupech, a to v plně vybavené provozní elektrofyziologické laboratoři.

Klinický přínos

Zamýšleným klinickým přínosem transseptální jehly BRK™ je punkce síňového septa během transseptální katetrizace za účelem získání přístupu k levé části srdce, aby zařízení vyžadující levostranný endokardiální přístup k srdci mohla dosáhnout zamýšleného klinického přínosu, například ablační katétr. Toto je hodnoceno úspěšnou punkcí síňového septa.

Kontraindikace

- Předchozí záplata síňového septa nebo protetický uzávěr defektu síňového septa.
- Jakákoli předchozí tromboembolická příhoda.
- Známý nebo suspektní myxom levé síně.
- Známý nebo suspektní infarkt myokardu během posledních dvou týdnů.
- Nestabilní angina pectoris.
- Nedávná cévní mozková příhoda (CMP).
- Pacienti, kteří nesnášejí antikoagulační terapii.
- Pacienti s aktivní infekcí.

Varování

- Neprovádějte žádné úpravy tohoto zařízení.
- Toto zařízení je určeno pouze k jednorázovému použití; nezpracovávejte je ani nepoužívejte opakovaně. Sledujte datum „Použít do“ produktu uvedené na obalu. Jakýkoli pokus o resterilizaci a opětovné použití tohoto systému může ohrozit jeho integritu. Vedlejší účinky používání nesterilních součástí mohou mimo jiné zahrnovat:
  - Lokální a systémová infekce nebo reakce
  - Mechanické poškození
  - Nepřesnou funkčnost
- Níže uvedené materiály produktu mohou způsobit alergické nebo hypersenzitivní reakce. Osoby alergické na tyto materiály mohou mít na tento produkt alergickou reakci. Před použitím u pacienta je nutné pacienta poučit o materiálech obsažených v zařízení a je nutné důkladně probrat předchozí výskyt alergií na:
  - Nerezová ocel
  - Epoxidové lepidlo
  - Chromovaná niklová mosaz
  - Silikonové mazivo pro vysoké vakuum (Dupont)
  - Master Bond
- Nesprávné použití tohoto zařízení může vést k vážným komplikacím.
- Postupy srdeční katetrizace představují pro pacienty i laboratorní pracovníky riziko vystavení značnému rentgenovému záření, což může mít za následek akutní radiační poškození a také zvýšené riziko somatických a genetických účinků z důvodu intenzity a doby vystavení rentgenovému paprsku během skiaskopie. Pečlivě zvažte použití tohoto zařízení u těhotných žen.

Bezpečnostní opatření

- Federální předpisy (USA) omezují prodej a objednávání tohoto zařízení pouze na lékaře.
- Před použitím si přečtěte pokyny.
- Před použitím balení zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud je balení otevřené nebo poškozené.
- Všechny součásti před použitím zkontrolujte.
- Uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě.
- Před výkonem musí být pacient z hemodynamického hlediska stabilní. U určitých stavů je nutné důkladně zvážit, zda tento výrobek použít. Patří sem mimo jiné níže uvedené stavy:
  - Rotované srdce,
  - Rozšířený kořen aorty,
  - Významné zvětšení pravé srdeční síně,

  - Skolióza/kyfóza,
  - Abnormální rozměry levé síně,
  - Vrozené malformace,
  - Cévní malformace,
  - Nemožnost přístupu do pravé síně skrz dolní dutou žílu.
- Toto zařízení mohou používat pouze lékaři, kteří jsou speciálně vyškoleni v transseptálních postupech, a to v plně vybavené provozní elektrofyziologické (EP) laboratoři.
- Posun katétru by měl být prováděn pod skiaskopickou kontrolou, aby se minimalizovalo riziko poškození srdce, perforace nebo tamponády. Zvažte také použití kompatibilních systémů navigace a vizualizace v reálném čase.
- Během zavádění je nutné dávat pozor na nadměrný odpor, když bude hrot jehly procházet ohybem soupravy pouzdra/dilatátoru. Pokud pocítíte odpor vůči dalšímu zavádění jehly, vytáhněte ji a zkontrolujte součásti.
- Při zasouvání postupujte opatrně a dbejte na to, aby se zařízení nadbytečně neohýbalo. To by mohlo zabránit postupu jehly a vést k nechtěnému propíchnutí soupravy dilatátoru/pouzdra.
- Během zavádění vždy používejte mandrén k usnadnění posunu jehly soupravou dilatátoru/pouzdra. Pokud nepoužijete mandrén, může dojít k narušení posunu jehly, což vede k nechtěnému propíchnutí soupravy dilatátoru/pouzdra nebo oděru materiálu na vnitřním povrchu dilatátoru.
- Pokud dojde ke vstupu do perikardu nebo aorty, neposouvejte dilatátor přes jehlu. Pokud jehla propíchla perikard nebo aortu, je nutné ji vytáhnout. Pozorně sledujte životní funkce.
- Při vytahování předmětů z hemostatického ventilu pouzdra hrozí nebezpečí průniku vzduchu. Učiňte opatření, abyste průniku vzduchu zabránili, a to tak, že pomalým vytahováním předmětů zabráníte vytvoření vakua v pouzdře a současně budete skiaskopicky kontrolovat, jestli se během zavádění nedostal do zařízení vzduch.
- Toto zařízení, jeho příslušenství a obal by měly být po použití správně klasifikovány pro likvidaci, např. jako biologicky nebezpečný odpad, ostré předměty, odpad, který není nebezpečný, atd., a pečlivě zlikvidovány v souladu s postupy zařízení a příslušnými zákony a předpisy.
- Jedna nebo více součástí tohoto zařízení může obsahovat následující látku definovanou jako CMR 1B v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti: kobalt: Chemical Abstracts Service (CAS) číslo 7440-48-4; EC číslo 231-158-0. Současné vědecké poznatky potvrzují, že zdravotnické prostředky vyrobené ze slitin kobaltu a slitin nerezové oceli obsahující kobalt nezpůsobují zvýšené riziko rakoviny nebo nepříznivých účinků na reprodukci.

  Jedna nebo více součástí tohoto zařízení může obsahovat následující látku definovanou jako CMR 1A v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti: Olovo: Chemical Abstracts Service (CAS) číslo 7439-92-1; EC číslo 231-100-4. Současné vědecké poznatky potvrzují, že zdravotnická zařízení vyrobená z olova nezpůsobují zvýšené riziko rakoviny nebo nepříznivých účinků na reprodukci.

Potenciální nežádoucí příhody

Kategorie nežádoucích událostí	Podkategorie nežádoucích událostí
Krvácení	Hemoragii/krvácení
	Hematom
Poranění mozku	Asymptomatickou cerebrální embolii
	Mrtvici/cévní mozkovou příhodu
	Tranzitorní ischemická ataka
Embolie	Vzduchová embolie
	Embolie cizím tělesem
	Plicní embolie
	Trombembolie
	Trombóza/trombus
Perforace srdce	Srdeční tamponáda
	Perikardiální výpotek
Kardiovaskulární poranění	Poškození chlopně
	Punkce kořene aorty
	Perforace síně
Poruchy převodního systému srdce	Blok SA, AV uzlu nebo His-Purkyňova systému
	Srdeční arytmie
Imunologická reakce	Anafylaxe
Infekce	Perikarditida
	Endokarditida
	Pneumonie
	Sepsi
Bolest/nepříjemný pocit	Bolesti třísla/hrudníku (obecná bolest na hrudi nespojena s IM)
Poranění periferních cév	Disekce
	Lacerace
	Vytvoření arteriovenózní píštěle
	Vytvoření pseudoaneuryzmatu
Hypotenze	–
Povrchové poranění tkáně	–

Pokyny

Příprava a sestavení nástrojů

1. Obsah vyjměte z balení.

   POZNÁMKA: Nesestavujte pouzdro a dilatátor.
2. Dilatátor a pouzdro propláchněte heparinizovaným fyziologickým roztokem.
3. Zavřete uzavírací kohout pouzdra.
4. Z jehly vyjměte mandrén a propláchněte ji sterilním heparinizovaným fyziologickým roztokem.
5. Mandrén do jehly opět zasuňte a upevněte jej na hrdlo jehly.
6. Dilatátor zcela zasuňte do transseptálního pouzdra.

Zavedení soupravy pouzdra/dilatátoru do horní duté žíly

1. Získejte femorální žilní přístup (nejlépe pravý femorální).

   VOLITELNÉ: k dosažení a udržení žilního přístupu pro výměnu nástrojů a hemostázu lze použít větší (≥ o 2,5 French větší než transseptální pouzdro) pouzdro standardní délky.

2. Zaveďte vodicí drát o rozměrech 0,032 palce, 150–180 cm, s 3 mm koncovkou „J“ do horní duté žíly (SVC).

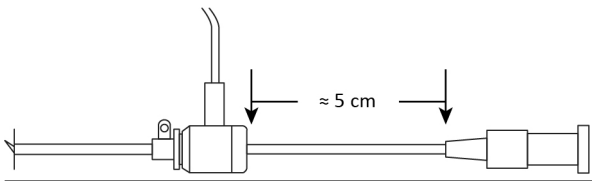
   POZNÁMKA: Maximální průměr vodicího drátu, který lze použít současně s dilatátorem, je 0,032 palce.

3. Zaveďte soupravu transseptálního pouzdra a dilatátoru do žíly přes vodicí drát a posunujte soupravu tak dlouho, až koncovka pouzdra pronikne do SVC. Koncovku dilatátoru nasměrujte do středu.

Umístěte soupravu jehly/styletu do pouzdra/dilatátoru

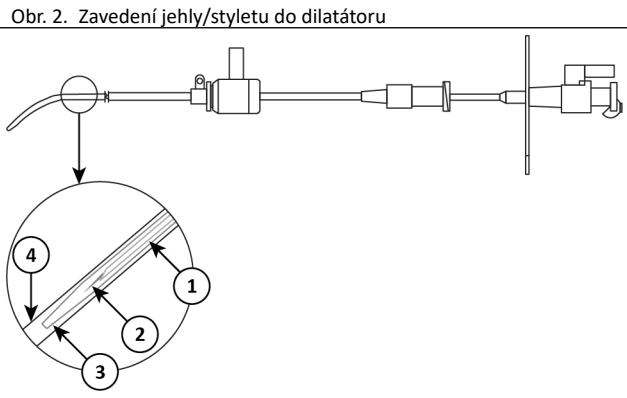
1. Vytáhněte vodicí drát z dilatátoru.
2. Zcela aspirujte a poté dilatátor propláchněte heparinizovaným fyziologickým roztokem.
3. Vytáhněte dilatátor přibližně o 5 cm (viz obrázek níže), abyste usnadnili průchod zakřivení jehly přes tuhé hlavně dilatátoru a pouzdra.

Obr. 1. Vyjmutí dilatátoru



4. Zajistěte mandrén na hlavě.
5. Zaveďte jehlu/mandrén do dilatátoru. Zasuňte jehlu/mandrén pod skiaskopickou kontrolou do hloubky, kdy bude ležet přibližně 2 cm od koncovky dilatátoru uvnitř pouzdra (viz obrázek níže).

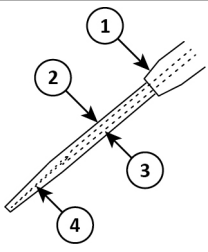
Obr. 2. Zavedení jehly/styletu do dilatátoru



1. Jehla
2. Stylet
3. Koncovka dilatátoru
4. Pouzdro

6. Pro opětovné spojení pouzdra a dilatátoru zasuňte současně dilatátor a jehlu/stylet do pouzdra za skiaskopické kontroly. Zkontrolujte, že se poloha jehly v dilatátoru nemění a obě komponenty se zavádí spolu. Udržujte koncovku pouzdra v SVC.
7. Pod skiaskopickou kontrolou zasuňte jehlu/stylet do polohy, ve které bude mandrén ležet proximálně od koncovky dilatátoru (viz obrázek níže).

Obr. 3. Zasunutí jehly/styletu



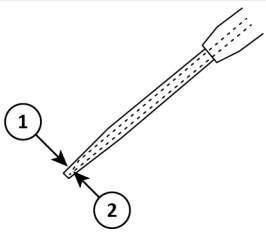
1. Koncovka pouzdra
2. Dilatátor
3. Jehla
4. Stylet

8. Stylet vyjměte, nevyhazujte jej.
9. Nasávejte jehlou, dokud nezpozorujete návrat krve. Zlikvidujte stříkačku.

   POZNÁMKA: Použitím stříkačky s nasunovacím hrotem (non Luer-Lok‡) můžete předejít nasávání vzduchu.

10. Propláchněte jehlu heparinizovaným fyziologickým roztokem. Uzavřete uzavírací ventil.
11. Zasuňte jehlu pod skiaskopickou kontrolou do polohy, ve které bude hrot jehly ležet kousek proximálně od koncovky dilatátoru (viz obrázek níže).

Obr. 4. Zasunutí hrotu jehly



1. Koncovka dilatátoru
2. Hrot jehly

VOLITELNÉ: Připojte na jehlu trojcestný rotační kohoutek.

VOLITELNÉ: Připojte stříkačku s rentgenkontrastní látkou k uzavíracímu ventilu. Nasávejte jehlou. Poté do jehly vstříkněte kontrastní látku za skiaskopického navádění.

VOLITELNÉ: K uzavíracímu ventilu napojte hadičku k monitorování tlaku.

VOLITELNÉ: K napojení hadiček pro kontrastní látku, měření tlaku a proplach použijte běžnou sadu s trojcestným ventilem.

Dosažení fossa ovalis

1. Vizualizujte a určete anatomické znaky.

2. Nastavte skiaskopickou jednotku do úhlu rovnoběžně s rovinou mitrální chlopně a kolmo na rovinu septa. Obvykle se jedná o úhel přibližně 30 až 40 stupňů levé přední šikmé projekce (LAO).

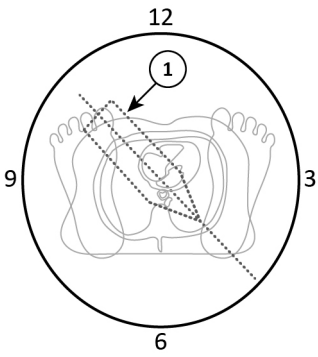
   VOLITELNÉ: Během EP měření lze jako užitečných anatomických znaků využít poloh katétru v koronárním sinu a Hisově svazku. Při správném náhledu projekce (LAO) se katétr v koronárním sinu zobrazí v profilu. Při správném náhledu pravé přední šikmé projekce (RAO) se katétr u Hisova svazku zobrazí v profilu. Fossa ovalis se nachází v úrovni katétru v oblasti Hisova svazku nebo lehce pod ním a nahoře a vzadu od ústí koronárního sinu.

   VOLITELNÉ: Jako užitečný anatomický znak může sloužit umístění angiografického/hemodynamického monitorovacího katétru pigtail k nekoronárnímu cípu aortální chlopně.

   VOLITELNÉ: Sledujte průběh tlaku snímaný skrz transseptální jehlu BRK™.

3. Upravte patku tak, aby jehla byla kolmo na fossa ovalis (obvykle mezi třetí a pátou hodinou při pohledu od nohou pacienta). (Viz obrázek níže.)

Obr. 5. Patka jehly

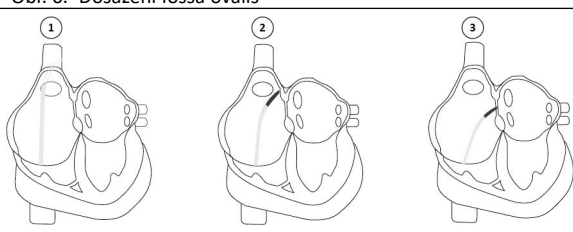


1. Patka jehly

4. Skiaskopicky zkontrolujte, že se hrot jehly skutečně nachází v dilatátoru.
5. Po potvrzení, že se hrot jehly nachází uvnitř dilatátoru, můžete pomalu táhnout za celou soupravu pouzdra/dilatátoru/jehly. Zamezte každému vzájemnému posunu jednotlivých dílů soupravy vůči sobě. Při vytahování soupravy je nezbytně nutné udržovat předchozí směr patky.
6. V náhledu LAO (kolmo k síňovému septu) sledujte koncovku dilatátoru, zda nedošlo během vytahování k náhlému pohybu mediálně (nebo doprava), což by znamenalo, že se koncovka nachází ve fossa ovalis. (Viz obrázek níže.)

   POZNÁMKA: Pokud je fossa ovalis jasně zřetelná, koncovka dilatátoru nyní snadno projde do levé síně.

Obr. 6. Dosažení fossa ovalis



1. Výchozí poloha v SVC
2. Počáteční středový pohyb v RA
3. Náhlý středový pohyb na fossa ovalis

POZNÁMKA: Při monitorování tlaku přes jehlu, je v tomto bodě tlak přes jehlu nepřesný, protože koncovka je proti fossa ovalis.

Punkce fossa ovalis transseptální jehlou BRK™

1. Před dalším posunem jehly potvrďte správnou polohu soupravy pouzdra/dilatátoru/jehly na fossa ovalis.
2. Po potvrzení správné polohy posunujte jehlu dále do úplného zasunutí v soupravě pouzdra/dilatátoru a postupujte přes síňové septum.

   VOLITELNÉ: Při monitorování tlaku je zavedení do levé síně potvrzeno tím, že tlaková křivka má tvar průběhu tlaku levé síně.

   VOLITELNÉ: Přístup do levé síně je možno potvrdit pomocí skiaskopie s injikováním kontrastní látky.

3. Pokud se v průběhu zavádění jehly projeví jakýkoliv odpor, jehlu stáhněte zpět a přehodnoťte anatomické znaky.

   UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde ke vstupu do perikardu nebo aorty, neposouvejte dilatátor přes jehlu. Pokud jehla propíchla perikard nebo aortu, je nutné ji vytáhnout. Pozorně sledujte životní funkce.

Postup soupravy zaváděcího pouzdra/dilatátoru do levé síně

Při udržování stabilizované polohy jehly v levé síni zaveďte soupravu pouzdra/dilatátoru přes jehlu plně do dutiny levé síně.

Zavedení pouzdra přes stabilizovaný dilatátor a jehlu do levé síně

1. Udržujte polohu jehly a dilatátoru napříč septem.
2. Při udržování stabilizované polohy dilatátoru posunujte celé pouzdro přes dilatátor do dutiny levé síně.

Vytažení transseptální jehly BRK™ a dilatátoru

UPOZORNĚNÍ: Při vytahování předmětů z hemostatického ventilu pouzdra hrozí nebezpečí průniku vzduchu. Učiňte opatření, abyste průniku vzduchu zabránili, a to tak, že pomalým vytahováním předmětů zabráníte vytvoření vakua v pouzdře a současně budete skiaskopicky kontrolovat, jestli se během zavádění nedostal do zařízení vzduch.

1. Nastavte uzavírací ventil jehly do uzavřené polohy a odpojte všechna připojení od hrdla jehly.
2. Vytáhněte transseptální jehlu BRK™ z dilatátoru. Jehlu lze očistit a odložit stranou, aby ji bylo možné při tomto výkonu znovu použít. V opačném případě jehlu zlikvidujte jako kontaminované ostré předměty.
3. Na dilatátor ihned nasaďte stříkačku a odsávejte. Při udržování pouzdra v dané poloze a vytahování dilatátoru neustále nasávejte krev. Krev by měla být arteriální.
4. Po vyjmutí dilatátoru odsajte krev bočním ramenem pouzdra. Opatrně propláchněte boční rameno pouzdra heparinizovaným fyziologickým roztokem, abyste zabránili vzniku vzduchových bublin.
5. Pouzdro se nyní nachází v levé síni.

Balení a skladovatelnost

Transseptální jehla BRK™ se dodává sterilní. Jehla je balena se zavedeným styletem. Jehla a stylet jsou uloženy v primárním obalu. Primární obal se nachází uvnitř zataveného pouzdra z materiálu Mylar‡ a Tyvek‡. Pouzdro a tento návod k použití jsou vloženy do krabice, která je na obou stranách zalepena. Jak pouzdro, tak krabice jsou opatřeny štítkem s informacemi

o výrobku, včetně data použitelnosti. Vyznačená doba skladování výrobku činí tři roky.

Souhrn klinických dat

Pro země Evropské unie: Souhrn bezpečnostního a klinického výkonu (SSCP) těchto zařízení zveřejní oznámené subjekty na adrese https://ec.europa.eu/tools/eudamed v souladu s požadavky nařízení EU MDR 2017/745 a souvisejícími lhůtami. Vyhledejte zařízení pomocí identifikátoru UDI-DI uvedeného na vnějším obalu zařízení. UDI-DI je 14 místné číslo mezi prvními dvěma sadami závorek. Další informace o vyhledávání a používání UDI-DI naleznete v dokumentu Často kladené otázky na adrese medical.abbott/manuals.

Hlášení událostí

Pokud se domníváte, že během používání tohoto zařízení došlo k závažné události, nahlaste to výrobci. Jste-li zákazníky v Evropské unii, nahlaste tuto závažnou událost vnitrostátnímu orgánu i výrobci.

Omezená záruka

Společnost Abbott Medical zaručuje, že její produkty budou za běžných podmínek používání bez vad materiálu a provedení. Tato záruka se vztahuje pouze na období do data „exspirace" na štítku příslušného produktu. Schválené metody a postupy použití našich jednotlivých produktů jsou uvedeny v souvisejících „Návodech k použití", které jsou přiloženy ke každému produktu. Společnost Abbott Medical odmítá odpovědnost a neručí za své produkty, jestliže byly použity způsobem, který není dovolen či schválen. Ručení společnosti Abbott Medicalv rámci této záruky se omezuje na výměnu produktů. Výše uvedená záruka vylučuje a nahrazuje všechny ostatní záruky vyjádřené či vyvozené, včetně (nikoli pouze) odvozených záruk na prodejnost nebo vhodnost pro konkrétní účel. Společnost Abbott Medical odmítá odpovědnost za jakékoli náhodné nebo následné ztráty, poškození nebo výdaje přímo nebo nepřímo vyplývající z používání tohoto produktu vyjma těch, které jsou výslovně uvedené v konkrétním zákoně. Společnost Abbott Medical nepřijímá jakoukoli další nebo dodatečnou odpovědnost v souvislosti s tímto produktem za ztrátu, poškození nebo výdaje. Další podrobnosti najdete v úplných podmínkách poskytování záruky společností Abbott Medical, které získáte od společnosti Abbott Medical a které jsou uvedeny na zadní straně faktury společnosti Abbott Medical.

Symboly

Na produktu nebo na jeho štítku se mohou nacházet níže uvedené symboly a standardizované symboly. Seznam standardizovaných symbolů naleznete v části Universal Symbols Glossary (Univerzální glosář symbolů) na adrese medical.abbott/manuals.

Symbol	Definice
Series	Řada
Contents	Obsah
Transseptal Needle	Transseptální jehla
	Systém jedné sterilní bariéry
	Délka
Rx ONLY	UPOZORNĚNÍ: Federální předpisy (USA) omezují prodej a objednávání tohoto zařízení pouze na lékaře.
CE 2797	Conformité Européenne (Soulad s evropskými směrnicemi). Označení v souladu s nařízením Evropské rady 2017/745. Společnost Abbott Medical prohlašuje, že tento prostředek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.
	Dovozce
UK CA 0086	Posouzena shoda ve Spojeném království
UKRP	Odpovědná osoba ve Spojeném království
UA.TR.101	Ukrajinská značka shody s technickými předpisy, kde 101 je subjektem posuzování.
MD	Zdravotnický prostředek
UDI	Jedinečné identifikační číslo prostředku
medical.abbott/manuals	Řiďte se návodem k použití na těchto webových stránkách
(7440-48-4) (7439-92-1)	Obsahuje nebezpečné látky. (Kobalt CAS č. 7440-48-4) (Olovo CAS č. 7439-92-1)

DA: Dansk

BRK™ Transseptal kanyle

Brugsanvisning

Beskrivelse

BRK™ transseptal kanyle består af en kanyle med lumen i rustfrit stål og en stilet i massivt rustfrit stål. Kanylen er buet distalt, så den er lettere at anbringe i hjertet, når den anvendes med et transseptalt sheathsæt fra Abbott Medical. I den buede del af kanylen er der et brat fald i den udvendige diameter, så den passer på den indvendige diameter på dilatatoren i et transseptalt sheathsæt fra Abbott Medical. Den distale spids på kanylen er affaset, så punkturen lettes. Proksimalt er kanylen forsynet med en viserflange (der angiver retningen på den distale krumning) og en 2-vejsstophane, der sikrer, at kanylens lumen bruges til aspiration, væskeinjektion/-infusion, blodprøvetagning, trykmåling samt indføring af stilet og/eller guidewire (0,014 tomme [0,36 mm] maks. guidewire-diameter til en størrelse 18 kanyle, 0,012 tomme [0,30 mm] maks. guidewirediameter til en størrelse 19 kanyle). Stiletten er lige og isodiametrisk hele vejen igennem. Proksimalt er stiletten forsynet med en buet clips, der låses fast på kanylens muffe proksimalt, når den sættes ind i kanylens lumen. Stiletten er udviklet med henblik på at gøre det lettere at føre kanylen frem i dilatatoren. Kanylen fås i forskellige længder og med forskellige distale krumninger.

Tilsigtet formål

BRK™ transseptal kanyle er beregnet til at blive brugt til at punktere det interatriale septum, så der opnås adgang til hjertet i venstre side.

Indikationer for brug

BRK™ transseptal kanyle bruges til at punktere det interatriale septum under transseptal kateterisation, så der opnås adgang til hjertet i venstre side.

Patientmålgruppe

BRK™ transseptal kanyle er beregnet til at blive brugt til hæmodynamisk stabile patienter, der kræver kateteradgang til hjertet i venstre side. Brug af BRK™ transseptal kanyle kan kræve særlig overvejelse hos patienter med følgende tilstande:

- Roteret hjerte
- Forstørret aortarod
- Markant forstørret højre atrium
- Skoliose/kyfose
- Abnorm geometri i venstre atrium
- Medfødte misdannelser
- Karmisdannelser
- Manglende mulighed for at nå det højre atrium gennem vena cava inferior (IVC)

Tilsigtet bruger

Denne enhed bør kun bruges af læger, der er specielt uddannet i transseptale procedurer, i et fuldt udstyret operationelt elektrofysiologisk laboratorium.

Kliniske fordele

Den tilsigtede kliniske fordel ved BRK™ transseptal kanyle er punktur af det interatriale septum under en transseptal kateteriseringsprocedure for at skaffe adgang til venstre side af hjertet og gøre det muligt, at enheder, der kræver venstresidet endokardial hjerteadgang, realiserer deres tilsigtede kliniske fordel, såsom et ablationskateter. Dette måles ved vellykket punktur af det interatriale septum.

Kontraindikationer

- Forudgående patch af det interatriale septum eller ASD-lukningsprotese.
- Enhver forudgående tromboembolisk hændelse.
- Påvist eller formodet venstresidigt atrialt myksom.
- Påvist eller formodet myokardieinfarkt inden for de seneste to uger.
- Ustabil angina pectoris.
- Nyligt cerebrovaskulært tilfælde (CVA).
- Patienter, der ikke tåler antikoagulationsbehandling.
- Patienter med en aktiv infektion.

Advarsler

- Der må ikke foretages ændringer af dette udstyr.
- Dette udstyr er udelukkende beregnet til engangsbrug. Det må ikke genbehandles eller genbruges. Bemærk datoen for "Anvendes inden" på produktets pakning. Eventuelle forsøg på gensterilisering og genbrug af dette system kan påvirke dets integritet. Komplikationer ved brug af ikkesterile komponenter kan omfatte, men er ikke begrænset til følgende:
  - Lokal og systemisk infektion eller reaktion
  - Mekanisk skade
  - Unøjagtig funktionalitet
- Materialerne, der er angivet nedenfor pr. produkt, kan give allergiske reaktioner eller overfølsomhedsreaktioner. Personer, der er allergiske over for disse materialer, kan få en allergisk reaktion på produktet. Inden enheden bruges til patienten, skal patienten rådgives om materialerne i enheden, og eventuel allergi i anamnesen skal drøftes grundigt:
  - Rustfrit stål
  - Epoxy-klæbemiddel
  - Forniklet forkromet messing
  - Silikone-højvakuumfedt (DuPont)
  - Master Bond
- Forkert brug af denne anordning kan medføre alvorlige komplikationer.
- Hjertekateterisation indebærer risiko for signifikant røntgeneksponering for både patienter og laboratoriepersonale, hvilket kan medføre akut strålingsskade samt øget risiko for somatiske og genetiske effekter pga. røntgenstrålens intensitet og varigheden af fluoroskopien. Overvej grundigt brugen af denne anordning til gravide kvinder.

Forholdsregler

- Ifølge amerikansk (USA) lovgivning må denne enhed kun sælges af en læge eller efter ordination af en læge.
- Læs anvisningerne før brug.
- Kontrollér emballagen før brug. Udstyret må ikke anvendes, hvis pakken er åben eller beskadiget.
- Kontrollér alle komponenter inden brug.
- Opbevares køligt, mørkt og tørt.
- Forud for indgrebet skal patienten være hæmodynamisk stabil. Visse tilstande kan kræve særlige forholdsregler ved anvendelsen af dette udstyr. Disse omfatter, men er ikke begrænset til:
  - Roteret hjerte
  - Forstørret aortarod
  - Markant forstørret højre atrium

  - Skoliose/kyfose
  - Abnorm geometri i venstre atrium
  - Medfødte misdannelser
  - Karmisdannelser
  - Manglende mulighed for at nå det højre atrium gennem vena cava inferior (IVC)
- Denne enhed bør kun bruges af læger, der er specielt uddannet i transseptale procedurer, i et fuldt udstyret operationelt elektrofysiologisk (EP) laboratorium.
- Katetret bør fremføres under fluoroskopi for at minimere risikoen for hjerteskade, -perforation eller -tamponade. Kompatible navigations- og realtidsvisualiseringssystemer kan også overvejes.
- Under indføring kontrolleres det, at modstanden ikke er for stor, når kanylespidsen føres igennem sheathen/dilatatorenhedens bøjning. Hvis kanylen møder modstand under fremføringen, skal kanylen trækkes tilbage og komponenterne vurderes.
- Under indføring skal man omhyggeligt undgå kraftig bøjning af udstyret. Dette kan hæmme fremføring af kanylen og kan resultere i, at kanylen utilsigtet punkterer dilatator-/sheathenheden.
- Under indføringen bruges stiletten hele tiden til at lette kanylens passage gennem dilatator-/sheathenheden. Hvis stiletten ikke anvendes, kan dette hæmme kanylens fremføring og resultere i, at kanylen utilsigtet punkterer dilatator-/sheathenheden eller river materiale løs fra dilatatorens indvendige overflade.
- Hvis der opstår åbning til perikardiet eller aorta, må dilatatoren ikke føres frem over kanylen. Hvis kanylen har penetreret perikardiet eller aorta, skal den trækkes ud. Overvåg vitale parametre tæt.
- Der er risiko for luftindtrængen under udtrækning af objekter fra sheathens hæmostaseventil. Tag forholdsregler for at forhindre luftindtrængen ved langsom udtrækning af objekter for at forhindre dannelse af undertryk i sheathen, og overvåg sheathen for luft ved hjælp af fluoroskopi under efterfølgende indføring af anordningen.
- Efter brug skal anordningen, tilbehøret og emballagen klassificeres korrekt til bortskaffelse, f.eks. farligt biologisk affald, skarpe genstande, ikkefarligt affald mv., og bortskaffes omhyggeligt i overensstemmelse med hospitalets procedurer samt gældende love og regler.
- Én eller flere komponenter i denne anordning kan indeholde følgende stof defineret som CMR 1B i en koncentration på over 0,1 vægtprocent: Kobolt: Chemical Abstracts Service (CAS) nr. 7440-48-4, EF-nr. 231-158-0. Aktuel videnskabelig evidens viser, at medicinsk udstyr fremstillet af koboltlegeringer og rustfri stållegeringer, der indeholder kobolt, ikke udgør en øget risiko for kræft eller har uønskede reproduktive virkninger.

  Én eller flere komponenter i denne anordning kan indeholde følgende stof defineret som CMR 1A i en koncentration på over 0,1 vægtprocent: Elektrode: Chemical Abstracts Service (CAS) nr. 7439-92-1, EF-nr. 231-100-4. Aktuel videnskabelig evidens viser, at medicinsk udstyr fremstillet af bly ikke udgør en øget risiko for kræft eller har uønskede reproduktive virkninger.

Potentielle komplikationer

Bivirkningskategori	Underkategori for bivirkning
Blødning	Blødning
	Hæmatom
Cerebral skade	Asymptomatisk cerebral emboli
	Slagtilfælde/hjerneblødning
	Transitorisk iskæmisk attak (TIA)
Emboli	Luftemboli
	Fremmedlegemeemboli
	Lungeemboli
	Tromboembolisme
	Trombose/trombe
Hjerteperforation	Hjertetamponade
	Perikardieeffusion
Kardiovaskulær skade	Beskadigelse af klap
	Punktur af aortarod
	Atrieperforation
Forstyrrelse i overledningssystemet	SA-knude, AV-knude eller His-Purkinje-systemblokade
	Hjertearytmier
Immunologisk reaktion	Anafylaksi
Infektion	Pericarditis
	Endocarditis
	Pneumoni
	Sepsis
Smerter/ubehag	Smerter, lyske, bryst (generelle brystsmerter, der ikke er forbundet med MI)
Perifer vaskulær skade	Dissektion
	Laceration
	Arteriovenøs fisteldannelse
	Pseudoaneurismedannelse
Hypotension	Ikke relevant
Overfladisk vævsskade	Ikke relevant

Anvisninger

Klargør og saml udstyret

1. Fjern indholdet fra emballagen.

   BEMÆRK: Saml ikke sheathen og dilatatoren.
2. Skyl dilatatoren og sheathen med hepariniseret saltvand.
3. Luk stophanen på sheathen.
4. Fjern stiletten fra kanylen, og skyl kanylen med hepariniseret saltvand.
5. Før stiletten ind i kanylen, og lås den fast på muffen.
6. Før dilatatoren helt ind i den transseptale sheath.

Før sheath-/dilatatorenheden ind i vena cava superior

1. Skaf femoral veneadgang (højre femur foretrækkes).

   VALG: En større (≥2,5 French større end den transseptale sheath) sheath-standardlængde kan anvendes for at opnå og fastholde veneadgang til udskiftning af anordning og hæmostase.

2. Før en 0,032 tomme (0,81 mm), 150 - 180 cm, 3 mm "J"-spids-guidewire ind i vena cava superior (SVC).

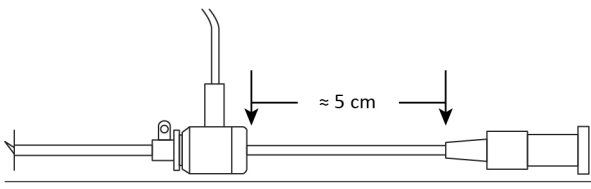
   BEMÆRK: 0,032 tomme (0,81 mm) er den maksimale guidewirediameter, som kan anvendes med dilatatoren.

3. Før sheath-/dilatatorenheden ind i venen over guidewiren, indtil sheathens spids er i SVC. Vend dilatatorspidsen medialt.

Placering af kanyle/stiletenheden inde i sheath/dilatatorenheden

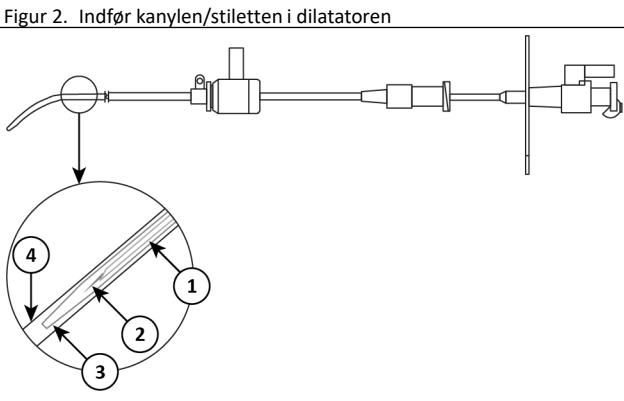
1. Fjern guidewiren fra dilatatoren.
2. Aspirer helt, og skyl derefter dilatatoren med hepariniseret saltvand.
3. Træk dilatatoren ca. 5 cm tilbage (se figuren nedenfor) for at lette passage af den buede kanyle gennem de stive muffer på dilatatoren og sheathen.

Figur 1. Træk dilatoren tilbage



4. Lås stiletten fast på muffen.
5. Indfør kanylen/stiletten i dilatatoren. Før kanylen/stiletten frem under brug af fluoroskopi, til den er ca. 2 cm fra dilatatorens spids inde i sheathen (se figuren nedenfor).

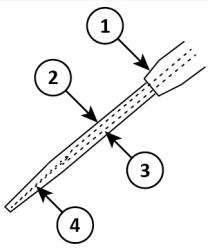
Figur 2. Indfør kanylen/stiletten i dilatatoren



1. Kanyle
2. Stilet
3. Dilatatorspids
4. Sheath

6. Forbind sheathen og dilatatoren igen ved samtidig at føre dilatatoren og kanylen/stiletten frem inde i sheathen under brug af fluoroskopi. Sørg for, at kanylens placering inde i dilatatoren ikke ændrer sig, mens begge komponenter føres frem sammen. Oprethold sheathspidsens position i SVC.
7. Før kanylen/stiletten frem under brug af fluoroskopi, indtil stiletten er placeret proksimalt i forhold til dilatatorens spids (se figuren nedenfor).

Figur 3. Før kanylen/stiletten frem



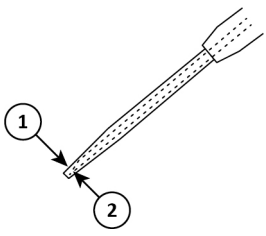
1. Sheathspids
2. Dilatator
3. Kanyle
4. Stilet

8. Fjern stiletten, smid den ikke ud.
9. Aspirér kanylen, indtil der observeres tilbageløb af blod. Kassér injektionssprøjten.

   BEMÆRK: Brug af en slip-spids (ikke-Luer-Lok‡) injektionssprøjte kan gøre det umuligt at aspirere luft.

10. Skyl kanylen med hepariniseret saltvand. Luk stophanen.
11. Før kanylen frem under brug af fluoroskopi, indtil kanylens spids er placeret proksimalt i forhold til dilatatorens spids (se figuren nedenfor).

Figur 4. Fremfør kanylespidsen



1. Dilatatorspids
2. Kanylespids

VALG: Monter en 3-vejsdrejestophane på kanylemuffen.

VALG: Monter en injektionssprøjte med røntgenfast kontrastmiddel på stophanen. Aspirer kanylen. Fyld derefter kanylen med kontrastmiddel under fluoroskopi.

VALG: Forbind en trykovervågningsslange til stophanen.

VALG: Brug en standard 3-vejsmanifold til tilslutning af kontrast-, tryk- og skylleslanger.

Lokalisering af fossa ovalis

1. Visualiser og identificer anatomiske landmærker.
2. Indstil fluoroskopiudstyret i en vinkel parallelt med planet for mitralklappen og ortogonalt med septumplanet. Dette vil typisk være LAO (left anterior oblique), ca. 30 til 40 grader.

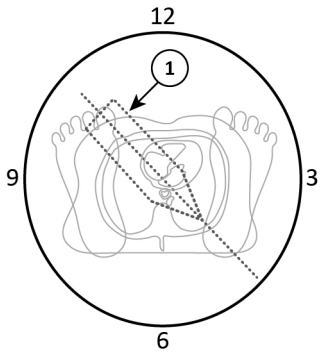
   VALG: Under EP-undersøgelser kan sinus coronarius og His-bundt kateterpositioner fungere som nyttige anatomiske landmærker. I den relevante LAO-visning ses sinus coronarius-katetret i profil. I den relevante RAO-visning (right anterior oblique) ses His-bundtkatetret i profil. Fossa ovalis befinder sig på niveau med eller en smule under His-bundtkatetret samt superiort og posteriort i forhold til sinus coronarius-ostiet.

   VALG: Placering af et angiografisk/hæmodynamisk grisehalekateter til monitorering i den ikke-koronare cuspis i aortaklappen kan fungere som et nyttigt anatomisk landmærke.

   VALG: Observér den trykkurve, der optages gennem BRK™ transseptal kanyle.

3. Juster viserflangen, så kanylen er lodret i forhold til fossa ovalis (typisk i en position svarende til mellem kl. 3.00 og kl. 5.00, set fra patientens fodende). (Se figuren nedenfor.)

Figur 5. Kanylens viserflange

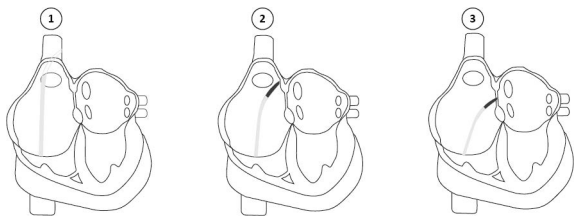


1. Kanylens viserflange

4. Anvend fluoroskopi til at bekræfte, at kanylens spids er inde i dilatatoren.
5. Når det er bekræftet, at kanylens spids er inde i dilatatoren, trækkes der langsomt i hele sheath/dilatator/kanyleenheden. Undgå, at de enkelte dele af enheden bevæger sig i forhold til hinanden. Det er meget vigtigt at fastholde retningen på viserflangen, samtidig med at der trækkes i enheden.
6. I LAO-visningen (ortogonalt med det interatriale septum) observeres spidsen af dilatatoren under trækket for brat medial (eller højrevendt) bevægelse, hvilket indikerer, at spidsen har grebet fat i fossa ovalis. Se figurerne nedenfor).

   BEMÆRK: Hvis fossa ovalis er sondeåben, bevæger dilatatorspidsen sig nu med lethed ind i venstre atrium.

Figur 6. Lokalisering af fossa ovalis



1. Startplacering i SVC
2. Initiel medial bevægelse i RA
3. Pludselig medial bevægelse på fossa ovalis

BEMÆRK: Hvis trykket overvåges gennem kanylen, er trykket gennem kanylen ikke præcist på dette tidspunkt, fordi spidsen ligger op imod fossa ovalis.

Foretag punktur af fossa ovalis med BRK™ transseptal kanyle

1. Bekræft, at sheath-/dilatator-/kanyleenheden er korrekt placeret i fossa ovalis, inden kanylen føres fremad.
2. Når korrekt placering er bekræftet, kan kanylen udstrækkes, så den griber helt fat inde i sheath-/dilatatorenheden, og føres frem gennem det interatriale septum.

   VALG: Under trykovervågning bekræftes adgangen til venstre atrium, når tryksporingen viser en trykkurve for venstre atrium.

   VALG: Adgang til venstre atrium kan bekræftes via fluoroskopi med indsprøjtning af kontrastmiddel.

3. Hvis kanylen møder modstand under fremføringen, skal kanylen trækkes tilbage og de anatomiske landmærker reevalueres.

   FORSIGTIG: Hvis der opstår åbning til perikardiet eller aorta, må dilatatoren ikke føres frem over kanylen. Hvis kanylen har penetreret perikardiet eller aorta, skal den trækkes ud. Overvåg vitale parametre tæt.

Fremføring af sheath/dilatatorenheden ind i venstre atrium

Mens kanylen holdes i en fast position inde i venstre atrium, føres sheath-/dilatatorenheden helt frem over kanylen ind i venstre atriekavitet.

Fremføring af sheathen over den fastgjorte dilatator og kanyle ind i venstre atrium

1. Fasthold kanylens og dilatatorens position igennem septum.
2. Mens dilatatoren holdes i en fast position, føres sheathen helt over dilatatoren og ind i venstre atriekavitet.

Træk BRK™ transseptal kanyle og dilatatoren tilbage

FORSIGTIG: Der er risiko for luftindtrængen under udtrækning af objekter fra sheathens hæmostaseventil. Tag forholdsregler for at forhindre luftindtrængen ved langsom udtrækning af objekter for at forhindre dannelse af undertryk i sheathen, og overvåg sheathen for luft ved hjælp af fluoroskopi under efterfølgende indføring af anordningen.

1. Drej stophanen til lukket position, og frakobl alt udstyr, der måtte være tilsluttet kanylens muffe.
2. Tag BRK™ transseptal kanyle ud af dilatatoren. Kanylen kan rengøres og lægges til side til senere brug under dette indgreb. Ellers bortskaffes kanylen i henhold til passende forholdsregler for kontaminerede skarpe genstande.
3. Montér øjeblikkeligt en injektionssprøjte på dilatatoren, og aspirér. Bliv ved med at aspirere blod, mens sheathen holdes på plads, og dilatatoren trækkes ud. Blodet skal være arterielt blod.
4. Efter at dilatatoren er fjernet, aspireres blod gennem sheathens sidearm. Skyl forsigtigt sheathens sidearm med hepariniseret saltvand for at undgå luftbobler.
5. Sheathen er nu på plads i venstre atrium.

Emballage og holdbarhed

BRK™ transseptal kanyle leveres i steril stand. Kanylen er pakket med en indført stilet. Kanylen og stiletten er anbragt i den primære emballage. Den primære emballage er anbragt i en Mylar‡ og Tyvek‡ pose, der er varmeforseglet. Posen og brugsanvisningen er derefter anbragt i en æske, der er forseglet i begge ender. Både posen og æsken er forsynet med mærker med oplysninger om produktet, herunder også produktets udløbsdato. Produkterne har en forventet holdbarhed på tre år.

Oversigt over kliniske data

For EU-lande: En oversigt over sikkerheden og den kliniske ydeevne (SSCP) for disse enheder vil blive offentliggjort på https://ec.europa.eu/tools/eudamed af de bemyndigede organer i overensstemmelse med kravene i EU MDR 2017/745 og tilhørende tidslinjer. Søg efter enheden ved hjælp af det UDI-DI-nummer, der er angivet på

enhedens ydre emballage. UDI-DI er det 14-cifrede tal mellem de første to sæt parenteser. Se dokumentet med ofte stillede spørgsmål, der findes på medical.abbott/manuals for at få flere oplysninger om, hvordan du finder og bruger UDI-DI.

Indberetning af hændelser

Hvis der under brugen af denne enhed er grund til at antage, at der er forekommet en alvorlig hændelse, bedes denne indberettet til producenten. For kunder i EU indberettes den alvorlige hændelse både til den nationale myndighed og til producenten.

Begrænset garanti

Abbott Medical garanterer, at deres produkter er uden materiale- og produktionsfejl under normal brug. Denne garanti dækker ikke ud over den "udløbsdato", der er angivet på mærkater på produktet. Autoriseret brug og godkendte metoder til brug af vores enkelte produkter fremgår af den "Brugsanvisning", der følger med hvert produkt. Abbott Medical fralægger sig ethvert ansvar og erstatningsansvar i forbindelse med brugen af deres produkter på en måde, der ikke er autoriseret eller godkendt. Abbott Medicals erstatningsansvar under denne garanti er begrænset til produkterstatning. Ovennævnte garanti udelukker og erstatter alle andre garantier, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til stiltiende garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Abbott Medical fralægger sig ethvert erstatningsansvar for noget hændeligt eller indirekte tab, erstatning eller udgift, som direkte eller indirekte hidrører fra anvendelsen af dette produkt, undtagen som udtrykkeligt bestemt ved særlig lov. Abbott Medical påtager sig ikke og bemyndiger ikke nogen anden person til på deres vegne at påtage sig andet eller yderligere ansvar for tab, erstatning eller udgift i forbindelse med dette produkt. Læs hele Abbott Medicals garantipolitik, som du kan få hos Abbott Medical, eller se på bagsiden af en faktura fra Abbott Medical.

Symboler

Symbolerne herunder og harmoniserede symboler findes på produktet eller produktets mærkat. For harmoniserede symboler henvises der til ordlisten for universalsymboler på medical.abbott/manuals.

Symbol	Definition
Series	Serie
Contents	Indhold
Transseptal Needle	Transseptal kanyle
	Enkelt sterilt barrieresystem
	Længde
Rx ONLY	FORSIGTIG: Ifølge amerikansk (USA) lovgivning må denne enhed kun sælges af en læge eller efter ordination af en læge.
CE 2797	Conformité Européenne (Europæisk overensstemmelse). Påsat i overensstemmelse med Det Europæiske Råds forordning 2017/745. Abbott Medical erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i denne forordning.
	Importør
UK CA 0086	Overensstemmelsesvurderet for Storbritannien
UKRP	Ansvarlig person i Storbritannien
UA.TR.101	Ukrainsk mærkning for overensstemmelse med de tekniske forskrifter, hvor 101 er vurderingsorganet.
MD	Medicinsk udstyr
UDI	Unik udstyrsidentifikation
medical.abbott/manuals	Følg brugsanvisningen på dette websted
(7440-48-4) (7439-92-1)	Indeholder farlige stoffer. (Kobolt CAS-nr. 7440-48-4) (Bly CAS-nr. 7439-92-1)

DE: Deutsch

BRK™ Transseptale Nadel

Bedienungsanleitung

Beschreibung

Die BRK™ Transseptale Nadel besteht aus einer Edelstahl-Hohlnadel und einem Mandrin aus massivem Edelstahl. Der distale Abschnitt der Nadel ist gebogen, um bei Verwendung eines transseptalen Schleusensets von Abbott Medical die Positionierung im Herzen zu erleichtern. Innerhalb dieses gebogenen Abschnitts wird der Außendurchmesser der Nadel abrupt kleiner, damit er dem Innendurchmesser des Dilatators eines transseptalen Schleusensets von Abbott Medical entspricht. Die distale Nadelspitze ist abgeschrägt, um das Punktieren zu erleichtern. Das proximale Ende der Nadel ist mit einem Markierungsflansch versehen (der die Richtung der distalen Kurve anzeigt) und mit einem 2-Wege-Absperrhahn ausgestattet, um für Aspiration, Injektionen/Infusionen, Blutentnahme, Drucküberwachung sowie zum Einführen von Mandrin und/oder Führungsdraht (maximaler Durchmesser des Führungsdrahtes für eine 18-Gauge-Nadel, 0,014 Zoll; für eine 19-Gauge-Nadel, 0,012 Zoll) den Zugang zum Nadellumen zu ermöglichen. Der Mandrin ist gerade und in ganzer Länge isodiametrisch. Am proximalen Ende des Mandrins befindet sich ein gebogener Clip, mit dem er sich beim Einführen in das Nadellumen am proximalen Nadelansatz befestigen lässt. Die Form des Mandrins erleichtert das Vorschieben der Nadel im Dilatator. Die Nadel ist in verschiedenen Nutzlängen und distalen Kurvenkonfigurationen erhältlich.

Verwendungszweck

Die BRK™ Transseptale Nadel ist zur Punktion des Vorhofseptums vorgesehen, um Zugang zur linken Herzhälfte zu erhalten.

Anwendungsbereiche

Die BRK™ Transseptale Nadel wird bei der transseptalen Katheterisierung zur Punktion des Vorhofseptums eingesetzt, um Zugang zur linken Herzhälfte zu erhalten.

Patientenzielgruppe

Die BRK™ Transseptale Nadel ist zur Verwendung bei hämodynamisch stabilen Patienten vorgesehen, bei denen ein Katheterzugang zur linken Herzhälfte erforderlich ist. Bei Patienten mit den nachstehenden Erkrankungen ist der Einsatz der BRK™ Transseptalen Nadel besonders abzuwägen:

- Herzrotation
- Erweiterte Aortenwurzel
- Deutliche Erweiterung des rechten Vorhofs
- Skoliose/Kyphose
- Anormale Geometrie des linken Vorhofs
- Angeborene Fehlbildungen
- Gefäßmissbildungen
- Kein Zugang zum rechten Vorhof durch die Vena cava inferior

Bestimmungsgemäßer Benutzer

Dieses Produkt darf nur von Ärzten mit spezieller Ausbildung in transseptalen Verfahren in einem vollständig ausgestatteten Elektrophysiologielabor verwendet werden.

Klinische Vorteile

Der beabsichtigte klinische Nutzen der BRK™ Transseptalen Nadel ist die Punktion des Vorhofseptums im Rahmen eines transseptalen Katheterisierungsverfahrens, um Zugang zur linken Herzhälfte zu erhalten und damit einen linksseitigen endokardialen Zugang für entsprechende Instrumente (z. B. Ablationskatheter) zu gewährleisten, sodass diese ihren beabsichtigten klinischen Nutzen erreichen können. Dies ist abhängig von der erfolgreichen Punktion des Vorhofseptums.

Gegenanzeigen

- Vorausgegangene Reparatur des Vorhofseptums oder Atriumseptumdefekt-Prothese.
- Vorausgegangene Thromboembolie.
- Bekanntes oder vermutetes Myxom im linken Vorhof.
- Bekannter oder vermuteter Myokardinfarkt innerhalb der letzten zwei Wochen.
- Instabile Angina pectoris.
- Rezenter Schlaganfall.
- Patienten, die eine Antikoagulationstherapie nicht vertragen.
- Patienten mit aktiver Infektion.

Warnhinweise

- Dieses Produkt darf nicht modifiziert werden.
- Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt; nicht wiederaufbereiten oder wiederverwenden. Das auf der Verpackung angegebene „Verwendbar bis“-Datum beachten. Jeglicher Versuch, dieses System erneut zu sterilisieren und wiederzuverwenden, kann seine Integrität beeinträchtigen. Zu den Nebenwirkungen bei der nicht sterilen Verwendung von Komponenten gehören unter anderem:
  - Lokale und systemische Infektion oder Reaktion
  - Mechanische Schäden
  - Fehlerhafte Funktion
- Die unten angegebenen Materialien des Produkts können allergische oder Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Patienten, die gegen diese Materialien allergisch sind, können auf dieses Produkt allergisch reagieren. Vor der Verwendung sollte der Patient über die im Produkt enthaltenen (nachfolgend aufgeführten) Materialien aufgeklärt werden und es sollte eine umfassende Anamnese des Patienten hinsichtlich Allergien erhoben werden:
  - Edelstahl
  - Epoxydharzklebstoff
  - Messing mit Nickel-Chrom-Beschichtung
  - Silikon-Hochvakuumfett (Dupont)
  - Master Bond
- Die missbräuchliche Verwendung dieses Geräts kann zu ernsten Komplikationen führen.
- Sowohl für den Patienten als auch für das Laborpersonal bestehen bei der Herzkatheterisierung aufgrund der Dauer und der Intensität der Röntgenstrahlung bei der fluoroskopischen Bildgebung die Gefahr einer signifikanten Strahlenbelastung mit akuten Strahlenschäden sowie ein erhöhtes Risiko für somatische und genetische Auswirkungen. Die Verwendung dieses Geräts bei schwangeren Frauen muss sorgfältig abgewogen werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Laut US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an Ärzte bzw. auf ärztliche Anordnung hin verkauft werden.
- Vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung lesen.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Produktverpackung. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Alle Komponenten vor dem Gebrauch prüfen.
- Kühl, dunkel und trocken aufbewahren.
- Der Patient muss vor dem Verfahren hämodynamisch stabil sein. Unter bestimmten Umständen ist der Einsatz dieses Produkts besonders abzuwägen. Dazu gehören u. a:
  - Herzrotation
  - Erweiterte Aortenwurzel
  - Deutliche Erweiterung des rechten Vorhofs
  - Skoliose/Kyphose
  - Anormale Geometrie des linken Vorhofs
  - Angeborene Fehlbildungen
  - Gefäßmissbildungen
  - Kein Zugang zum rechten Vorhof durch die Vena cava inferior
- Dieses Produkt darf nur von Ärzten mit spezieller Ausbildung in transseptalen Verfahren in einem vollständig ausgestatteten Elektrophysiologielabor (EP-Labor) verwendet werden.
- Das Vorschieben des Katheters muss unter fluoroskopischer Beobachtung erfolgen, um das Risiko eines Herzschadens, einer Perforation oder einer Tamponade zu minimieren. Kompatible Navigations- und Echtzeit-Visualisierungssysteme können ebenfalls in Betracht gezogen werden.
- Beim Einführen der Nadel auf übermäßigen Widerstand achten, wenn die Nadelspitze durch Biegungen der Schleusen-Dilatatoreinheit vorgeschoben wird. Bei Widerstand während des Vorschiebens der Nadel diese herausziehen und die Komponenten prüfen.
- Beim Einführen darauf achten, dass die Vorrichtung nicht zu sehr gebogen wird. Dies kann das Vorschieben der Nadel behindern und dazu führen, dass die Dilatator-Schleuseneinheit versehentlich von der Nadel punktiert wird.
- Beim Einführen stets den Mandrin verwenden, um das Vorschieben der Nadel durch die Dilatator-Schleuseneinheit zu erleichtern. Andernfalls kann das Vorschieben der Nadel behindert, die Dilatator-Schleuseneinheit versehentlich von der Nadel punktiert oder Material von der Innenfläche des Dilatators abgetragen werden.
- Schieben Sie den Dilatator bei perikardialem oder aortalem Eintritt nicht über die Nadel vor. Wenn die Nadel in das Perikard oder die Aorta eingedrungen ist, muss sie zurückgezogen werden. Überwachen Sie sorgfältig die Vitalfunktionen.
- Beim Zurückziehen von Objekten aus dem Hämostaseventil der Schleuse besteht die Gefahr, dass Luft angesaugt wird. Bezüglich des Eindringens von Luft Vorkehrungen treffen, indem die Objekte langsam zurückgezogen werden, damit sich in der Schleuse kein Vakuum bilden kann, und die Schleuse beim Einführen des Geräts fluoroskopisch auf Luftblasen überprüfen.
- Nach dem Gebrauch sollte dieses System, sein Zubehör und seine Verpackung für die Entsorgung entsprechend klassifiziert werden, z. B. Biogefährdung, scharfe Gegenstände, ungefährliche Abfälle usw., und gemäß den Einrichtungsverfahren und den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften sorgfältig entsorgt werden.
- Eine oder mehrere Komponenten dieses Geräts können den folgenden als CMR 1B definierten Stoff in einer Konzentration von über 0,1 Gewichtsprozent enthalten: Kobalt: Chemical Abstracts Service (CAS) Nr. 7440-48-4; EG-Nr. 231-158-0. Aktuelle wissenschaftliche Belege unterstützen, dass Medizinprodukte, die aus Kobaltlegierungen und Edelstahllegierungen, die Kobalt enthalten, nicht das Krebsrisiko erhöhen oder unerwünschte Wirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit haben.

  Eine oder mehrere Komponenten dieses Geräts können den folgenden als CMR 1A definierten Stoff in einer Konzentration von über 0,1 Gewichtsprozent enthalten: Blei: Chemical Abstracts Service (CAS) Nr. 7439-92-1; EG-Nr. 231-100-4. Aktuelle wissenschaftliche Belege unterstützen, dass Medizinprodukte, die aus Blei hergestellt wurden, nicht das Krebsrisiko erhöhen oder unerwünschte Wirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit haben.

Potenzielle Unerwünschte Ereignisse

Unerwünschtes Ereignis – Kategorie	Unerwünschtes Ereignis – Unterkategorie
Blutungen	Hämorrhagie/Blutung
	Hämatom
Verletzung des Gehirns	Asymptomatische zerebrale Embolie
	Schlaganfall/zerebrovaskulärer Insult
	Transitorische ischämische Attacke (TIA)
Embolie	Luftembolie
	Fremdkörperembolie
	Lungenembolie
	Thromboembolie
	Thrombose/Thrombus
Herzperforation	Herzbeuteltamponade
	Perikarderguss
Kardiovaskuläre Verletzung	Herzklappenschädigung
	Aortenwurzelpunktion
	Vorhofperforation
Störung des Reizleitungssystems	SA-Block, AV-Block oder His-Purkinje-Block
	Herzrhythmusstörungen
Immunreaktion	Anaphylaxie
Infektion	Perikarditis
	Endokarditis
	Pneumonie
	Sepsis
Schmerzen/ Beschwerden	Schmerzen in Leiste, Brust (allgemeine Brustschmerzen ohne Zusammenhang mit Myokardinfarkt)
Periphere Gefäßverletzung	Dissektion
	Lazeration
	Arteriovenöse Fistelbildung
	Pseudoaneurysma-Bildung
Hypotonie	n. v.
Oberflächliche Gewebeschädigung	n. v.

Gebrauchsanleitung

Vorbereiten und Zusammensetzen der Vorrichtung

1. Entnehmen Sie den Inhalt aus der Verpackung.

   HINWEIS: Die Schleuse und den Dilatator nicht zusammensetzen.

2. Spülen Sie den Dilatator und die Schleuse mit heparinisierter Kochsalzlösung.
3. Schließen Sie den Schleusen-Absperrhahn.
4. Entfernen Sie den Mandrin von der Nadel und spülen Sie die Nadel mit heparinisierter Kochsalzlösung.
5. Setzen Sie den Mandrin wieder in die Nadel ein und lassen Sie ihn auf dem Ansatz einrasten.
6. Führen Sie den Dilatator vollständig in die transseptale Schleuse ein.

Vorschieben der Schleusen-Dilatatoreinheit in die Vena cava superior

1. Legen Sie einen femoralvenösen Zugang (bevorzugt am rechten Oberschenkel).

   OPTIONAL: Verwenden Sie eine größere Schleuse mit einer Standardlänge (≥2,5 French größer als die transseptale Schleuse), um einen venösen Zugang zum Austausch von Instrumenten und zur Hämostase zu gewährleisten.

2. Führen Sie einen 0,032-Zoll-Führungsdraht mit einer Länge von 150–180 cm und einer 3-mm-„J"-Spitze in die Vena cava superior (SVC) ein.

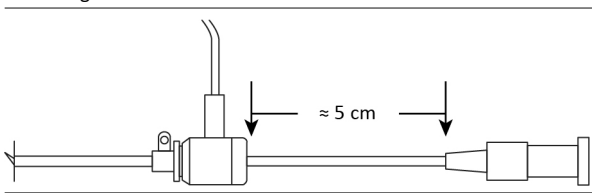
   HINWEIS: Mit dem Dilatator können Führungsdrähte mit einem Durchmesser von maximal 0,032 Zoll verwendet werden.

3. Führen Sie die Schleusen-Dilatatoreinheit über den Führungsdraht in die Vene ein, bis sich die Schleusenspitze in der Vena cava superior befindet. Die Dilatatorspitze muss medial ausgerichtet sein.

Positionieren der transseptalen Nadel-Mandrineinheit in der Schleusen-Dilatatoreinheit

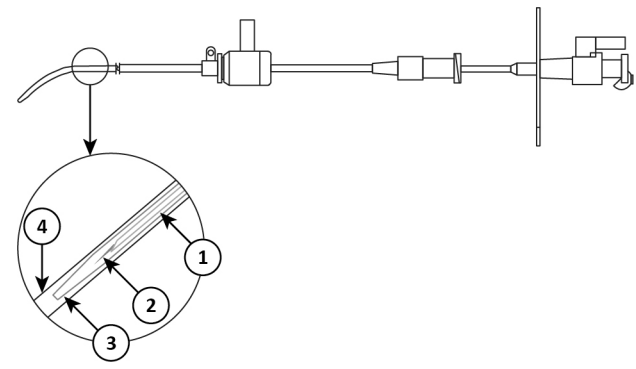
1. Entfernen Sie den Führungsdraht aus dem Dilatator.
2. Aspirieren Sie vollständig und spülen Sie den Dilatator anschließend mit heparinisierter Kochsalzlösung.
3. Ziehen Sie den Dilatator ca. 5 cm zurück (siehe nachstehende Abbildung), um das Vorschieben der Kurve der Nadel durch die starren Dilatator- und Schleusenansätze zu erleichtern.

Abbildung 1. Ziehen Sie den Dilatator zurück



4. Lassen Sie den Mandrin im Ansatz einrasten.
5. Führen Sie anschließend die Nadel/den Mandrin in den Dilatator ein. Schieben Sie die Nadel/den Mandrin unter Durchleuchtung vor, bis sie/er sich in der Schleuse ca. 2 cm von der Dilatatorspitze entfernt befindet (siehe nachstehende Abbildung).

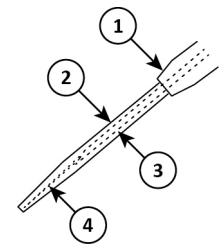
Abbildung 2. Führen Sie die Nadel/den Mandrin in den Dilatator ein



1. Nadel
2. Mandrin
3. Dilatatorspitze
4. Schleuse

6. Um die Schleuse und den Dilatator miteinander zu verbinden, schieben Sie den Dilatator und die Nadel/den Mandrin unter Durchleuchtung gleichzeitig in der Schleuse vor. Vergewissern Sie sich, dass sich die Position der Nadel im Dilatator nicht verändert, wenn beide Komponenten zusammen vorgeschoben werden. Behalten Sie die Position der Schleusenspitze in der Vena cava superior bei.
7. Schieben Sie unter Durchleuchtung die Nadel/den Mandrin vor, bis sich der Mandrin gerade proximal zur Dilatatorspitze befindet (siehe nachstehende Abbildung).

Abbildung 3. Schieben Sie die Nadel/den Mandrin vor



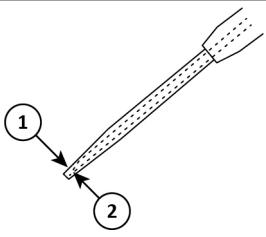
1. Schleusenspitze
2. Dilatator
3. Nadel
4. Mandrin

8. Entfernen Sie den Mandrin, entsorgen Sie ihn jedoch nicht.
9. Aspirieren Sie die Nadel, bis ein Blutrückfluss festgestellt wird. Entsorgen Sie die Spritze.

   HINWEIS: Eine Spritze mit Slip-Spitze (ohne Luer-Lok‡) kann das Aspirieren von Luft verhindern.

10. Spülen Sie die Nadel mit heparinisierter Kochsalzlösung. Dann den Absperrhahn schließen.
11. Schieben Sie unter Durchleuchtung die Nadel vor, bis sich die Nadelspitze gerade proximal zur Dilatatorspitze befindet (siehe nachstehende Abbildung).

Abbildung 4. Schieben Sie die Nadelspitze vor



1. Dilatatorspitze
2. Nadelspitze

OPTIONAL: Befestigen Sie einen drehbaren 3-Wege-Absperrhahn am Nadelansatz.

OPTIONAL: Befestigen Sie eine Spritze mit röntgenfähigem Kontrastmittel am Absperrhahn. Aspirieren Sie die Nadel. Füllen Sie die Nadel dann unter Durchleuchtung mit Kontrastmittel.

OPTIONAL: Schließen Sie eine Drucküberwachungsleitung an den Absperrhahn an.

OPTIONAL: Verwenden Sie einen standardmäßigen Verteiler mit 3 Anschlüssen, um die Kontrastmittel-, Druck- und Spülleitung anzuschließen.

Erfassen der Fossa ovalis

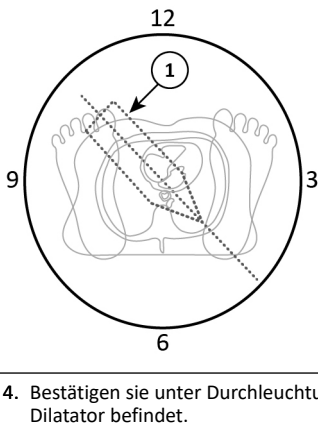
1. Visualisieren und identifizieren Sie anatomische Referenzpunkte.
2. Stellen Sie das Fluoroskopiegerät auf einen Winkel ein, der parallel zur Ebene der Mitralklappe und orthogonal zur Ebene des Septums ist. In der Regel sind das etwa 30 bis 40 Grad schräg vorn links (Left Anterior Oblique, LAO).

   OPTIONAL: Während der EP-Verfahren können am Koronarsinus und am His-Bündel liegende Katheter hilfreiche anatomische Referenzpunkte darstellen. In der entsprechenden LAO-Projektion ist das Profil des Koronarsinuskatheters sichtbar. In der entsprechenden Projektion von schräg vorn rechts (Right Anterior Oblique, RAO) ist das Profil des am His-Bündel liegenden Katheters sichtbar. Die Fossa ovalis befindet auf Höhe bzw. knapp unterhalb des am His-Bündel liegenden Katheters sowie superior und posterior zum Ostium des Koronarvenensinus.

   OPTIONAL: Anatomische Referenzpunkte können durch Platzierung eines angiographischen/hämodynamischen Pigtail-Kontrollkatheters im nichtkoronaren Cuspis der Aortenklappe identifiziert werden.

   OPTIONAL: Beobachten Sie die durch die BRK™ Transseptale Nadel aufgezeichnete Druckkurve.
3. Stellen Sie den Markierungsflansch so ein, dass die Nadel rechtwinklig zur Fossa ovalis liegt (normalerweise zwischen 3:00 und 5:00 Uhr, vom Fußende des Patienten aus gesehen). (Siehe nachstehende Abbildung.)

Abbildung 5. Markierungsflansch der Nadel

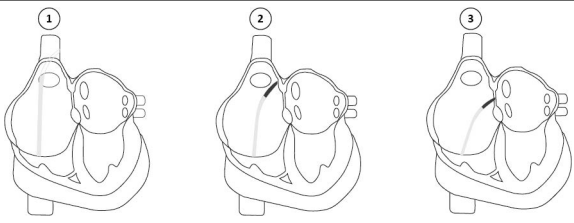


1. Markierungsflansch der Nadel

4. Bestätigen sie unter Durchleuchtung, dass sich die Nadelspitze im Dilatator befindet.
5. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich die Nadelspitze im Dilatator befindet, ziehen Sie langsam an der Einheit aus Schleuse, Dilatator und Nadel. Vermeiden Sie Bewegungen der Einzelteile der Einheit zueinander. Die vorherige Orientierung des Markierungsflanschs muss beim Ziehen der Einheit unbedingt beibehalten werden.
6. Überprüfen Sie in der LAO-Ansicht (orthogonal zum Vorhofseptum), ob die Dilatatorspitze beim Ziehen eine plötzliche Bewegung zur Mitte (oder nach rechts) erfährt, da dies ein Hinweis darauf ist, dass die Spitze die Fossa ovalis erfasst hat. (Siehe nachstehende Abbildungen.)

   HINWEIS: Wenn die Fossa ovalis für den Katheter durchgängig ist, lässt sich die Dilatatorspitze problemlos in den linken Vorhof bewegen.

Abbildung 6. Erfassen der Fossa ovalis



1. Ausgangsposition in der Vena cava superior
2. Erste mediale Bewegung im rechten Vorhof
3. Abrupte mediale Bewegung auf die Fossa ovalis

HINWEIS: Bei Drucküberwachung über die Nadel ist der Druck durch die Nadel an dieser Stelle nicht korrekt, da die Spitze an der Fossa ovalis anliegt.

Punktieren der Fossa ovalis mit der BRK™ Transseptalen Nadel

1. Überprüfen Sie vor dem Vorschieben der Nadel die korrekte Lage der Einheit aus Schleuse, Dilatator und Nadel an der Fossa ovalis.
2. Wenn Sie die korrekte Lage bestätigt haben, schieben Sie die Nadel so weit vor, bis sie sich vollständig in der Schleusen-Dilatatoreinheit befindet, und schieben Sie die Nadel dann durch das Vorhofseptum hindurch.

   OPTIONAL: Unter Drucküberwachung gilt der Eintritt in den linken Vorhof als bestätigt, wenn auf dem Druckmessgerät eine Kurvenform für Linksatrialdruck angezeigt wird.

   OPTIONAL: Der Eintritt in den linken Vorhof kann durch Kontrastmittelinjektionen fluoroskopisch bestätigt werden.
3. Wenn Sie beim Vorschieben der Nadel einen Widerstand spüren, ziehen Sie die Nadel zurück und überprüfen Sie die anatomischen Referenzpunkte erneut.

   VORSICHT: Schieben Sie den Dilatator bei perikardialem oder aortalem Eintritt nicht über die Nadel vor. Wenn die Nadel in das Perikard oder die Aorta eingedrungen ist, muss sie zurückgezogen werden. Überwachen Sie sorgfältig die Vitalfunktionen.

Vorschieben der Schleusen-Dilatatoreinheit in den linken Vorhof

Halten Sie die Nadel im linken Vorhof fest in Position und schieben Sie die Schleusen-Dilatatoreinheit über die Nadel vollständig in die linke Vorhofkammer vor.

Vorschieben der Schleuse über fixierten Dilatator und Nadel in den linken Vorhof

1. Verändern Sie die Position der Nadel und des Dilatators beim Durchqueren des Septums nicht.
2. Halten Sie den Dilatator in einer festen Position und schieben Sie dabei die Schleuse über den Dilatator vollständig in die linke Vorhofkammer vor.

Zurückziehen der BRK™ Transseptalen Nadel und des Dilatators

VORSICHT: Beim Zurückziehen von Objekten aus dem Hämostaseventil der Schleuse besteht die Gefahr, dass Luft angesaugt wird. Bezüglich des Eindringens von Luft Vorkehrungen treffen, indem die Objekte langsam zurückgezogen werden, damit sich in der Schleuse kein Vakuum bilden kann, und die Schleuse beim Einführen des Geräts fluoroskopisch auf Luftblasen überprüfen.

1. Drehen sie den Absperrhahn der Nadel zu (Position „Off“) und klemmen Sie sämtliche am Nadelansatz vorhandenen Anschlüsse ab.
2. Entfernen Sie die BRK™ Transseptale Nadel vom Dilatator. Die Nadel kann nun gesäubert und für die spätere Wiederverwendung in diesem Verfahren beiseite gelegt werden. Andernfalls entsorgen Sie die Nadel nach den für verunreinigte scharfe Gegenstände üblichen Verfahren.
3. Befestigen Sie unmittelbar eine Spritze am Dilatator und aspirieren Sie. Setzen Sie die Blutaspiration fort, während Sie die Schleuse fixieren und den Dilatator zurückziehen. Das Blut sollte arterielles Blut sein.
4. Aspirieren Sie, nachdem Sie den Dilatator entfernt haben, Blut durch den Seitenarm der Schleuse. Spülen Sie den Seitenarm der Schleuse vorsichtig mit heparinisierter Kochsalzlösung, um Luftblasen zu vermeiden.
5. Die Schleuse ist nun im linken Vorhof platziert.

Verpackung und Haltbarkeit

Die BRK™ Transseptale Nadel wird steril geliefert. Die Nadel wird mit eingesetztem Mandrin verpackt. Die Nadel und der Mandrin liegen in der Primärverpackung. Die Primärverpackung befindet sich in einem hitzeversiegelten Mylar‡- und Tyvek‡-Beutel. Der Beutel und diese Gebrauchsanleitung wiederum werden in eine Box gelegt, die an beiden Seiten versiegelt wird. Sowohl der Beutel als auch die Box sind mit einem Etikett mit Produktinformation und Verfallsdatum versehen. Auf den Produkten ist eine Haltbarkeitsdauer von drei Jahren vermerkt.

Zusammenfassung der klinischen Daten

Für Länder in der Europäischen Union: Ein Kurzbericht über die Sicherheit und klinische Leistung (SSCP) dieser Produkte wird von den benannten Stellen gemäß den Anforderungen der EU MDR 2017/745 und entsprechenden Zeitplänen auf https://ec.europa.eu/tools/eudamed veröffentlicht. Suchen Sie das Produkt anhand der UDI-DI auf der Außenverpackung des Produkts. Die UDI-DI ist die 14-stellige Zahl zwischen den ersten beiden Klammern. Weitere Informationen über das Auffinden und die Verwendung der UDI-DI finden Sie in dem Dokument „Antworten auf häufig gestellte Fragen“ unter medical.abbott/manuals.

Meldung von Vorfällen

Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Grund zu der Annahme besteht, dass ein ernster Zwischenfall eingetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller. Kunden aus der Europäischen Union melden ernste Zwischenfälle sowohl der entsprechenden nationalen Behörde als auch dem Hersteller.

Beschränkte Gewährleistung

Abbott Medical garantiert, dass alle seine Produkte bei normalem Gebrauch frei von Material- und Konstruktionsfehlern sind. Diese Gewährleistung gilt nicht über das auf dem jeweiligen Produktetikett angegebene „Verfallsdatum“ hinaus. Die zugelassenen Arten der Verwendung und die zugelassenen Methoden der Verwendung aller unserer Produkte sind in der „Bedienungsanleitung“ dargelegt, die jedem unserer Produkte beiliegt. Abbott Medical lehnt jegliche Verantwortung und Haftung für die Verwendung seiner Produkte in einer nicht genehmigten oder nicht zugelassenen Weise ab. Diese Garantiehaftung von Abbott Medical beschränkt sich auf den Ersatz der eigenen Produkte. Die vorgenannte Garantie ersetzt alle sonstigen expliziten oder impliziten Garantien einschließlich (u. a.) impliziter Garantien über die Marktgängigkeit oder Eignung zu einem bestimmten Gebrauch. Abbott Medical schließt jegliche Haftung für Begleit- oder Folgeschäden, Verluste oder Kosten aus, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des Produkts ergeben, außer in dem von spezifischen Gesetzen ausdrücklich vorgegebenen Maß. Abbott Medical übernimmt keinerlei zusätzliche Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten im Zusammenhang mit diesem Produkt und autorisiert oder veranlasst auch keine anderen Personen, eine solche Haftung stellvertretend zu übernehmen. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der bei Abbott Medical erhältlichen oder auf der Rückseite von Abbott Medical-Rechnungen bereitgestellten vollständigen Garantierichtlinie von Abbott Medical.

Symbole

Auf dem Produkt oder dem Produktetikett befinden sich die folgenden Symbole und harmonisierten Symbole. Die Bedeutung harmonisierter Symbole finden Sie unter medical.abbott/manuals im Universal Symbols Glossary (Glossar für universale Symbole).

Symbol	Definition
Series	Serien
Contents	Inhalt
Transseptal Needle	Transseptale Nadel
	Sterilbarrieren-Einzelsystem
	Länge
	VORSICHT: Laut US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an Ärzte bzw. auf ärztliche Anordnung hin verkauft werden.
	Conformité Européenne (CE-Kennzeichnung). Angebracht gemäß der Verordnung des Europäischen Rates 2017/745. Abbott Medical bescheinigt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere Vorgaben dieser Verordnung erfüllt.
	Importeur
	Konformitätsbeurteilung des Vereinigten Königreichs

Symbol	Definition
UKRP	Verantwortliche Person für das Vereinigte Königreich
UA.TR.101	Ukrainisches Konformitätszeichen mit den technischen Vorschriften, wobei 101 die Prüfstelle ist.
MD	Medizinprodukt
UDI	Eindeutige Produktidentifikationsnummer
medical.abbott/manuals	Bedienungsanleitung beachten
(7440-48-4) (7439-92-1)	Enthält gefährliche Substanzen. (Cobalt CAS-Nr. 7440-48-4) (Blei CAS-Nr. 7439-92-1)

EL: Ελληνικά

BRK™ Διαδιαφραγματική βελόνα

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή

Η διαδιαφραγματική βελόνα BRK™ αποτελείται από αυλοφόρο βελόνα ανοξείδωτου χάλυβα και στειλεό από συμπαγή ανοξείδωτο χάλυβα. Το άπω τμήμα της βελόνας είναι κυρτό για να διευκολύνει την τοποθέτησή της μέσα στην καρδιά όταν χρησιμοποιείται με το σετ διαδιαφραγματικού θηκαριού της Abbott Medical. Μέσα στο κυρτό τμήμα, υπάρχει μια απότομη κατωφερής βαθμίδα στην εξωτερική διάμετρο της βελόνας για τη συναρμογή της με την εσωτερική διάμετρο του διαστολέα του σετ διαδιαφραγματικού θηκαριού της Abbott Medical. Το άπω άκρο της βελόνας είναι λοξοτμημένο για να διευκολύνει τη διαδικασία παρακέντησης. Το εγγύς άκρο της βελόνας είναι διαμορφωμένο με φλάντζα δείκτη (για την ένδειξη προσανατολισμού της άπω καμπύλης) και εφαρμόζει με δίοδη στρόφιγγα για να παρέχει πρόσβαση στον αυλό της βελόνας για αναρρόφηση, έγχυση υγρού, δειγματοληψία αίματος, παρακολούθηση της πίεσης και εισαγωγή στειλεού ή/και οδηγού σύρματος [0,014 ίντσες (0,36 mm) μέγιστη διάμετρος οδηγού σύρματος για βελόνα No.18, 0,012 ίντσες (0,30 mm) μέγιστη διάμετρος οδηγού σύρματος για βελόνα No.19]. Ο στειλεός είναι ευθύς και ισοδιαμετρικός σε όλο του το μήκος. Το εγγύς άκρο του στειλεού εφαρμόζει με κυρτό κλιπ για να ασφαλίζει πάνω στο εγγύς συνδετικό της βελόνας όταν εισάγεται στον αυλό της βελόνας. Ο στειλεός είναι σχεδιασμένος για να διευκολύνει την προώθηση της βελόνας μέσα στον διαστολέα. Η βελόνα διατίθεται σε διάφορα ωφέλιμα μήκη και διαμορφώσεις άπω καμπύλης.

Προβλεπόμενος σκοπός

Η διαδιαφραγματική βελόνα BRK™ προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη διάτρηση του μεσοκολπικού διαφράγματος με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης στην αριστερή καρδιά.

Ενδείξεις χρήσης

Η διαδιαφραγματική βελόνα BRK™ χρησιμοποιείται για την παρακέντηση του μεσοκολπικού διαφράγματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαδιαφραγματικού καθετηριασμού με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης στην αριστερή καρδιά.

Ομάδα ασθενών-στόχος

Η διαδιαφραγματική βελόνα BRK™ προορίζεται για χρήση σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς στους οποίους απαιτείται πρόσβαση στην αριστερή καρδιά μέσω καθετήρα. Η χρήση της διαφραγματικής βελόνας BRK™ μπορεί να απαιτεί μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα σε ασθενείς με τις παρακάτω παθήσεις:

- Περιστροφή του άξονα της καρδιάς
- Διογκωμένη αορτική ρίζα
- Εκσεσημασμένη διόγκωση του δεξιού κόλπου
- Σκολίωση/κύφωση
- Μη φυσιολογική γεωμετρία αριστερού κόλπου
- Συγγενείς δυσπλασίες
- Αγγειακές δυσπλασίες
- Αδυναμία προσπέλασης στον δεξιό κόλπο διαμέσου της κάτω κοίλης φλέβας

Προβλεπόμενος χρήστης

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους στις διαδιαφραγματικές διαδικασίες, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο λειτουργικό εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας.

Κλινικά οφέλη

Το επιδιωκόμενο κλινικό όφελος της διαδιαφραγματικής βελόνας BRK™ είναι η παρακέντηση του μεσοκολπικού διαφράγματος κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διαδιαφραγματικού καθετηριασμού με σκοπό την πρόσβαση στην αριστερή καρδιά για την ενεργοποίηση συσκευών που απαιτούν αριστερόστροφη ενδοκαρδιακή καρδιακή πρόσβαση για να επιτύχουν το επιδιωκόμενο κλινικό όφελος, όπως ένας καθετήρας κατάλυσης. Αυτό μετράται με επιτυχή παρακέντηση του μεσοκολπικού διαφράγματος.

Αντενδείξεις

- Προηγούμενο εμβάλωμα μεσοκολπικού διαφράγματος ή προσθετική συσκευή σύγκλεισης μεσοκολπικού ελλείμματος.
- Προηγούμενο θρομβοεμβολικό επεισόδιο.
- Γνωστό ή πιθανολογούμενο μύξωμα του αριστερού κόλπου.
- Γνωστό ή πιθανολογούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες.
- Ασταθής στηθάγχη.
- Πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (CVA).
- Ασθενείς που δεν ανέχονται την αντιπηκτική θεραπεία.
- Ασθενείς με ενεργό λοίμωξη.

Προειδοποιήσεις

- Μην τροποποιείτε αυτήν τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για μία μόνο χρήση. Να μην επαναχρησιμοποιείται και να μην υποβάλλεται σε εκ νέου επεξεργασία. Προσέξτε την ημερομηνία «Χρήση έως» του προϊόντος πάνω στη συσκευασία. Οποιαδήποτε απόπειρα επαναποστείρωσης και επαναχρησιμοποίησης αυτού του συστήματος μπορεί να υπονομεύσει την ακεραιότητά του. Στις ανεπιθύμητες επιδράσεις της χρήσης μη αποστειρωμένων εξαρτημάτων μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
  - Τοπική και συστηματική λοίμωξη ή αντίδραση
  - Μηχανική ζημιά
  - Ανακριβής λειτουργικότητα
- Τα υλικά που προσδιορίζονται παρακάτω ανά προϊόν μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Ασθενείς αλλεργικοί σε αυτά τα υλικά ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση στο προϊόν αυτό. Πριν από τη χρήση του προϊόντος στον ασθενή, ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί για τα υλικά που περιέχονται στη συσκευή και να ληφθεί πλήρες ιστορικό αλλεργιών:
  - Ανοξείδωτος χάλυβας
  - Εποξειδική κόλλα
  - Ορείχαλκος με επίστρωση χρωμίου-νικελίου
  - Γράσο σιλικόνης υψηλής υποπίεσης (DuPont)
  - Master Bond
- Η μη ενδεδειγμένη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

- Τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό του εργαστηρίου, οι διαδικασίες καρδιακού καθετηριασμού ενέχουν κίνδυνο σημαντικής έκθεση σε ακτίνες-Χ, που μπορεί να προκαλέσει οξύ τραυματισμό από ακτινοβολία, καθώς και αυξημένο κίνδυνο σωματικών και γενετικών επιδράσεων λόγω της έντασης της δέσμης των ακτίνων-Χ και της διάρκειας της ακτινοσκοπικής απεικόνισης. Σκεφτείτε προσεκτικά εάν θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή σε έγκυες γυναίκες.

Προφυλάξεις

- Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Επιθεωρήστε τη συσκευασία πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή υποστεί ζημιά.
- Επιθεωρήστε όλα τα εξαρτήματα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό χώρο.
- Πριν από τη διαδικασία, ο ασθενής πρέπει να είναι αιμοδυναμικά σταθερός. Σε ασθενείς με ορισμένες παθήσεις μπορεί να χρειάζεται μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
  - Περιστροφή του άξονα της καρδιάς
  - Διογκωμένη αορτική ρίζα
  - Εκσεσημασμένη διόγκωση του δεξιού κόλπου
  - Σκολίωση/κύφωση
  - Μη φυσιολογική γεωμετρία αριστερού κόλπου
  - Συγγενείς δυσπλασίες
  - Αγγειακές δυσπλασίες
  - Αδυναμία προσπέλασης στον δεξιό κόλπο διαμέσου της κάτω κοίλης φλέβας
- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους στις διαδιαφραγματικές επεμβάσεις, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο λειτουργικό εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας (EP).
- Η προώθηση του καθετήρα πρέπει να εκτελείται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καρδιακής βλάβης, διάτρησης ή επιπωματισμού. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η χρήση συμβατών συστημάτων πλοήγησης και οπτικοποίησης σε πραγματικό χρόνο.
- Κατά την εισαγωγή, ελέγξτε αν υπάρχει υπερβολική αντίσταση, καθώς το άκρο της βελόνας προχωρά μέσω της καμπύλης της διάταξης θηκαριού/διαστολέα. Αν υπάρχει αντίσταση στην προώθηση της βελόνας, ανασύρετε τη βελόνα και αξιολογήστε τα εξαρτήματα.
- Κατά την εισαγωγή, προσέχετε να μη λυγίζετε υπερβολικά αυτή τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει την προώθηση της βελόνας και να έχει ως αποτέλεσμα την ακούσια διάτρηση της διάταξης διαστολέα/θηκαριού από τη βελόνα.
- Κατά την εισαγωγή, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον στειλεό για τη διευκόλυνση της διέλευσης της βελόνας διαμέσου της διάταξης διαστολέα/θηκαριού. Η μη χρήση του στειλεού ενδέχεται να δυσχεράνει την προώθηση της βελόνας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διάτρηση της διάταξης διαστολέα/θηκαριού από τη βελόνα ή την αφαίρεση υλικού από την εσωτερική επιφάνεια του διαστολέα.
- Σε περίπτωση εισαγωγής στο περικάρδιο ή στην αορτή, μην προωθήσετε τον διαστολέα πάνω από τη βελόνα. Εάν η βελόνα έχει διεισδύσει στο περικάρδιο ή στην αορτή, πρέπει να αποσυρθεί. Παρακολουθείτε με προσοχή τις ζωτικές ενδείξεις.
- Υπάρχει κίνδυνος διήθησης αέρα κατά την απόσυρση αντικειμένων από την αιμοστατική βαλβίδα του θηκαριού. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για να αποτρέψετε διήθηση αέρα αποσύροντας τα αντικείμενα αργά για την πρόληψη δημιουργίας κενού στο θηκάρι και παρακολουθείτε με ακτινοσκόπηση το θηκάρι κατά την εισαγωγή της συσκευής για παρουσία αέρα.
- Μετά τη χρήση, αυτή η συσκευή, τα εξαρτήματα και η συσκευασία της πρέπει να κατηγοριοποιηθούν κατάλληλα για την απόρριψη, π.χ. βιολογικός κίνδυνος, αιχμηρά αντικείμενα, μη επικίνδυνα απορρίμματα κ.λπ., και να απορριφθούν προσεκτικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του ιδρύματος και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
- Ένα ή περισσότερα εξαρτήματα αυτής της συσκευής μπορεί να περιέχουν την ακόλουθη ουσία που ορίζεται ως CMR 1B σε συγκέντρωση άνω του 0,1% βάρος κατά βάρος: Κοβάλτιο: Αρ. Chemical Abstracts Service (CAS) 7440-48-4. EC No. 231-158-0. Τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται από κράματα κοβαλτίου και κράματα ανοξείδωτου χάλυβα που περιέχουν κοβάλτιο δεν προκαλούν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου ή δυσμενείς αναπαραγωγικές επιπτώσεις.

  Ένα ή περισσότερα εξαρτήματα αυτής της συσκευής μπορεί να περιέχουν την ακόλουθη ουσία που ορίζεται ως CMR 1A σε συγκέντρωση άνω του 0,1% βάρος κατά βάρος: Μόλυβδος: Αρ. Chemical Abstracts Service (CAS) 7439-92-1. EC No. 231-100-4. Τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται από μόλυβδο δεν προκαλούν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου ή δυσμενείς αναπαραγωγικές επιπτώσεις.

Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα

Κατηγορία ανεπιθύμητου συμβάντος	**Υποκατηγορία ανεπιθύμητου συμβάντος**
Αιμορραγία	Αιμορραγία
	Αιμάτωμα
Εγκεφαλική βλάβη	Ασυμπτωματικά εγκεφαλικά έμβολα
	Εγκεφαλικό/αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA)
Εμβολή	Εμβολή αέρα
	Εμβολή ξένου σώματος
	Πνευμονική εμβολή
	Θρομβοεμβολή
	Θρόμβωση/θρόμβος
Καρδιακή διάτρηση	Καρδιακός επιπωματισμός
	Περικαρδιακό εξίδρωμα
Καρδιαγγειακός τραυματισμός	Βαλβιδική βλάβη
	Διάτρηση αορτικής ρίζας
	Κολπική διάτρηση
Διαταραχή συστήματος αγωγιμότητας	Φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός, κολποκοιλιακός αποκλεισμός ή αποκλεισμός συστήματος His-Purkinje
	Καρδιακές αρρυθμίες
Ανοσολογική αντίδραση	Αναφυλαξία

Κατηγορία ανεπιθύμητου συμβάντος	Υποκατηγορία ανεπιθύμητου συμβάντος
Λοίμωξη	Περικαρδίτιδα
	Ενδοκαρδίτιδα
	Πνευμονία
	Σήψη
Πόνος / δυσφορία	Πόνος, βουβωνική χώρα, στήθος (γενικός πόνος στο στήθος που δεν σχετίζεται με ΕΜ)
Περιφερική αγγειακή βλάβη	Διαχωρισμός
	Ρήξη
	Σχηματισμός αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας
	Σχηματισμός ψευδοανευρύσματος
Υπόταση	Δ/Ι
Τραυματισμός επιφανειακού ιστού	Δ/Ι

Οδηγίες

Προετοιμασία και συναρμολόγηση του εξοπλισμού

1. Αφαιρέστε τα περιεχόμενα από τη συσκευασία.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συναρμολογήσετε το θηκάρι και τον διαστολέα.

2. Εκπλύνετε τον διαστολέα και το θηκάρι με ηπαρινισμένο ορό.
3. Κλείστε τη στρόφιγγα στο θηκάρι.
4. Αφαιρέστε τον στειλεό από τη βελόνα και εκπλύνετε τη βελόνα με ηπαρινισμένο ορό.
5. Εισαγάγετε τον στειλεό στη βελόνα και ασφαλίστε τον πάνω στο συνδετικό.
6. Εισαγάγετε τον διαστολέα πλήρως μέσα στο διαδιαφραγματικό θηκάρι.

Προωθήστε τη διάταξη θηκαριού/διαστολέα στην άνω κοίλη φλέβα

1. Διενεργήστε μηριαία φλεβική προσπέλαση (προτιμάται ο δεξιός μηρός).

   ΠΡΟΑΙΡ.: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο θηκάρι τυπικού μήκους (κατά ≥2,5 μεγέθη French μεγαλύτερο από το διαδιαφραγματικό θηκάρι) για την εξασφάλιση και διατήρηση φλεβικής προσπέλασης για την εναλλαγή συσκευής και την αιμόσταση.

2. Εισαγάγετε ένα οδηγό σύρμα 0,032 ιντσών (0,81 mm), 150 - 180 cm, 3 mm, με άκρο τύπου «J» , στην άνω κοίλη φλέβα (SVC).

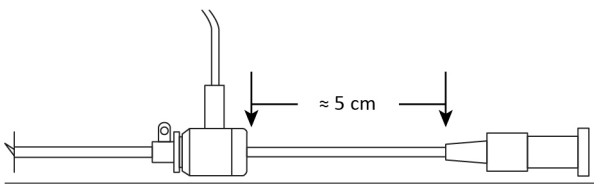
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 0,032 ίντσες (0,81 mm) είναι η μέγιστη διάμετρος οδηγού σύρματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον διαστολέα.

3. Εισαγάγετε το θηκάρι/διαστολέα στη φλέβα πάνω από το οδηγό σύρμα μέχρι το άκρο του θηκαριού να βρεθεί μέσα στην άνω κοίλη φλέβα. Προσανατολίστε το άκρο του διαστολέα στο μέσο.

Τοποθέτηση της διάταξης βελόνας/στειλεού στο εσωτερικό της διάταξης θηκαριού/διαστολέα

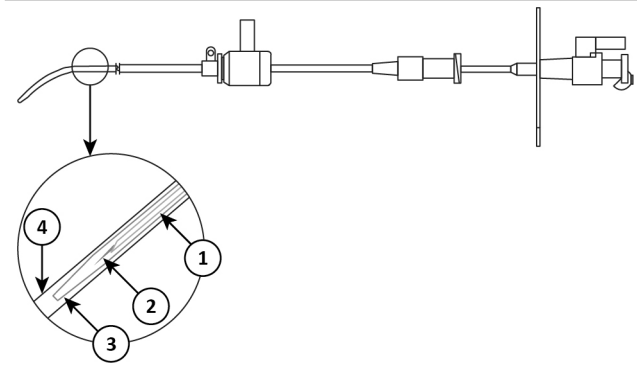
1. Αφαιρέστε το οδηγό σύρμα από τον διαστολέα.
2. Προχωρήστε σε πλήρη αναρρόφηση και στη συνέχεια εκπλύνετε τον διαστολέα με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό.
3. Αποσύρετε τον διαστολέα κατά περίπου 5 cm (δείτε την παρακάτω εικόνα) για να διευκολύνετε τη διέλευση της καμπύλης της βελόνας μέσα από τα άκαμπτα συνδετικά του διαστολέα και του θηκαριού.

Εικόνα 1. Απόσυρση διαστολέα



4. Ασφαλίστε τον στειλεό στο συνδετικό.
5. Εισαγάγετε τη βελόνα/στειλεό στον διαστολέα. Προωθήστε τη βελόνα/στειλεό υπό ακτινοσκόπηση, μέχρι να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 cm από το άκρο του διαστολέα μέσα στο θηκάρι (δείτε την παρακάτω εικόνα).

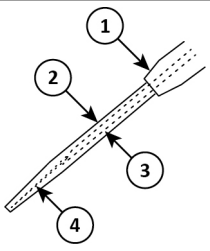
Εικόνα 2. Εισαγωγή βελόνας/στειλεού στον διαστολέα



1. Βελόνα
2. Στειλεός
3. Άκρο διαστολέα
4. Θηκάρι

6. Για να επανασυνδέσετε το θηκάρι με τον διαστολέα, προωθήστε ταυτόχρονα τον διαστολέα και τη βελόνα/στειλεό μέσα στο θηκάρι υπό ακτινοσκόπηση. Βεβαιωθείτε ότι η θέση της βελόνας στον διαστολέα δεν αλλάζει, καθώς και τα δύο εξαρτήματα προωθούνται μαζί. Διατηρήστε τη θέση της άκρης του θηκαριού στην άνω κοίλη φλέβα.
7. Υπό ακτινοσκόπηση, προωθήστε τη βελόνα/στειλεό μέχρι ο στειλεός να τοποθετηθεί στο εγγύτερο δυνατό σημείο από το άκρο του διαστολέα (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Εικόνα 3. Προώθηση βελόνας/στειλεού



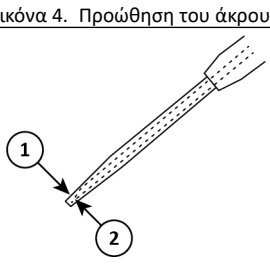
1. Άκρο θηκαριού
2. Διαστολέας
3. Βελόνα
4. Στειλεός

8. Αφαιρέστε τον στειλεό αλλά μην τον απορρίπτετε.
9. Εκτελέστε αναρρόφηση της βελόνας μέχρι να παρατηρηθεί επιστροφή αίματος. Απορρίψτε τη σύριγγα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση σύριγγας με άκρο ολίσθησης (όχι Luer-Lock‡) ενδέχεται να εμποδίσει την αναρρόφηση αέρα.

10. Κάντε έκπλυση της βελόνας με ηπαρινισμένο ορό. Κλείστε τη στρόφιγγα.
11. Προωθήστε τη βελόνα υπό ακτινοσκόπηση μέχρι το άκρο της βελόνας να βρεθεί στο εγγύτερο δυνατό σημείο από το άκρο του διαστολέα (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Εικόνα 4. Προώθηση του άκρου της βελόνας



1. Άκρο διαστολέα
2. Άκρο βελόνας

ΠΡΟΑΙΡ.: Προσαρτήστε μια τρίοδη περιστρεφόμενη στρόφιγγα στο συνδετικό της βελόνας.

ΠΡΟΑΙΡ.: Προσαρτήστε μια σύριγγα με ακτινοσκιερό σκιαγραφικό μέσο στη στρόφιγγα. Κάντε αναρρόφηση της βελόνας. Στη συνέχεια, υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, τοποθετήστε τη βελόνα με το σκιαγραφικό μέσο.

ΠΡΟΑΙΡ.: Συνδέστε μια γραμμή παρακολούθησης πίεσης στη στρόφιγγα.

ΠΡΟΑΙΡ.: Χρησιμοποιήστε μια τυπική διάταξη σωλήνων τρίοδης στρόφιγγας για τη σύνδεση γραμμών σκιαγραφικού μέσου, πίεσης και έκπλυσης.

Επαφή με το ωοειδές τρήμα

1. Οπτικοποιήστε και προσδιορίστε ανατομικά ορόσημα.
2. Ρυθμίστε τη μονάδα ακτινοσκόπησης σε κατάλληλη γωνία, παράλληλα με το επίπεδο της μιτροειδούς βαλβίδας και σε ορθή γωνία με το επίπεδο του διαφράγματος. Συνήθως, αυτή η γωνία θα είναι αριστερή πρόσθια λοξή (LAO), περίπου 30 έως 40 μοίρες.

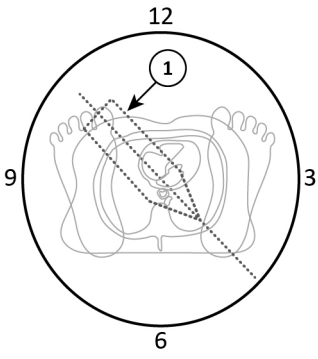
   ΠΡΟΑΙΡ.: Κατά τη διάρκεια των ηλεκτροφυσιολογικών διαδικασιών, η τοποθέτηση των καθετήρων στις θέσεις στεφανιαίου κόλπου και δεματίου του His μπορεί να διευκολύνει τον προσδιορισμό ανατομικών οροσήμων. Στην κατάλληλη αριστερά πρόσθια λοξή (LAO) προβολή, ο καθετήρας στεφανιαίου κόλπου θα εμφανίζεται σε θέση προφίλ. Στην κατάλληλη δεξιά πρόσθια λοξή (RAO) προβολή ο καθετήρας δεματίου του His θα εμφανίζεται σε θέση προφίλ. Το ωοειδές τρήμα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ή λίγο χαμηλότερα από τον καθετήρα δεματίου του His και υψηλότερα και πίσω σε σχέση με το στόμιο του στεφανιαίου κόλπου.

   ΠΡΟΑΙΡ.: Η τοποθέτηση καθετήρα pigtail αγγειογραφικής και αιμοδυναμικής παρακολούθησης στη μη στεφανιαία γλωχίνα της αορτικής βαλβίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό ανατομικών οροσήμων.

   ΠΡΟΑΙΡ.: Παρατηρήστε την κυματομορφή πίεσης που καταγράφεται μέσω της διαδιαφραγματικής βελόνας BRK™.

3. Ρυθμίστε τη φλάντζα δείκτη έτσι ώστε η βελόνα να είναι κάθετη στο ωοειδές τρήμα (συνήθως, μεταξύ των θέσεων που αντιστοιχούν στην ώρα 3:00 και 5:00 των δεικτών του ρολογιού, όπως φαίνεται από την πλευρά των πελμάτων του ασθενούς). (Δείτε την παρακάτω εικόνα.)

Εικόνα 5. Φλάντζα δείκτη βελόνας

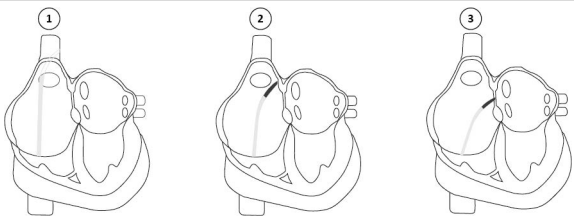


1. Φλάντζα δείκτη βελόνας

4. Επιβεβαιώστε ότι το άκρο της βελόνας βρίσκεται στο εσωτερικό του διαστολέα μέσω ακτινοσκόπησης.
5. Αφού βεβαιωθείτε ότι το άκρο της βελόνας βρίσκεται στο εσωτερικό του διαστολέα, σύρετε αργά ολόκληρη τη διάταξη θηκαριού/διαστολέα/βελόνας. Εμποδίστε οποιαδήποτε κίνηση των μερών της διάταξης, του ενός σε σχέση με το άλλο. Όσο σύρετε τη διάταξη, είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση του προηγούμενου προσανατολισμού της φλάντζας δείκτη.
6. Στην αριστερή πρόσθια λοξή προβολή (σε ορθή γωνία με το μεσοκολπικό διάφραγμα), παρατηρήστε το άκρο του διαστολέα κατά τη διάρκεια της έλξης για απότομη κίνηση με μεσαία κατεύθυνση (ή προς τα δεξιά), η οποία αποτελεί ένδειξη ότι το άκρο έχει έλθει σε επαφή με το ωοειδές τρήμα. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες.)

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ωοειδές τρήμα είναι ανοικτό, το άκρο του διαστολέα θα μετακινηθεί τώρα με ευκολία στον αριστερό κόλπο.

Εικόνα 6. Επαφή με το ωοειδές τρήμα



1. Θέση έναρξης στην άνω κοίλη φλέβα
2. Αρχική μετακίνηση στο μέσο στον δεξιό κόλπο
3. Απότομη μετακίνηση στο μέσο πάνω στο ωοειδές τρήμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πίεση παρακολουθείται μέσω της βελόνας, σημειώστε ότι η μέτρηση της πίεσης μέσω της βελόνας δεν θα είναι ακριβής σε αυτό το στάδιο, διότι το άκρο βρίσκεται επί του ωοειδούς τρήματος.

Παρακέντηση του ωοειδούς τρήματος με τη διαδιαφραγματική βελόνα BRK™

1. Επιβεβαιώστε τη σωστή θέση της διάταξης θηκαριού/διαστολέα/βελόνας στο ωοειδές τρήμα πριν από την προώθηση της βελόνας.
2. Αφού επιβεβαιωθεί η σωστή θέση της, προωθήστε τη βελόνα σε πλήρη επαφή εντός της διάταξης θηκαριού/διαστολέα και προωθήστε την κατά πλάτος του μεσοκολπικού διαφράγματος.

   ΠΡΟΑΙΡ.: Όταν η πίεση παρακολουθείται, η εισαγωγή στον αριστερό κόλπο επιβεβαιώνεται όταν κατά την ανίχνευση της πίεσης εμφανίζεται κυματομορφή πίεσης αριστερού κόλπου.

   ΠΡΟΑΙΡ.: Η προσπέλαση στον αριστερό κόλπο μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω ακτινοσκόπησης με εγχύσεις σκιαγραφικού μέσου.

3. Εάν παρουσιαστεί αντίσταση στην προώθηση της βελόνας, αποσύρετε τη βελόνα και αξιολογήστε εκ νέου τα ανατομικά ορόσημα.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση εισαγωγής στο περικάρδιο ή στην αορτή, μην προωθήσετε τον διαστολέα πάνω από τη βελόνα. Εάν η βελόνα έχει διεισδύσει στο περικάρδιο ή στην αορτή, πρέπει να αποσυρθεί. Παρακολουθείτε με προσοχή τις ζωτικές ενδείξεις.

Προώθηση της διάταξης θηκαριού/διαστολέα μέσα στον αριστερό κόλπο

Διατηρώντας τη βελόνα σε σταθερή θέση εντός του αριστερού κόλπου, προωθήστε τη διάταξη θηκαριού/διαστολέα εντελώς πάνω από τη βελόνα στην κοιλότητα του αριστερού κόλπου.

Προώθηση του θηκαριού πάνω από τον σταθερό διαστολέα και τη βελόνα μέσα στον αριστερό κόλπο

1. Διατηρήστε τη θέση της βελόνας και του διαστολέα κατά πλάτος του διαφράγματος.
2. Με τον διαστολέα σε σταθερή θέση, προωθήστε το θηκάρι εντελώς πάνω από τον διαστολέα στην κοιλότητα του αριστερού κόλπου.

Απόσυρση της διαδιαφραγματικής βελόνας BRK™ και του διαστολέα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος διήθησης αέρα κατά την απόσυρση αντικειμένων από την αιμοστατική βαλβίδα του θηκαριού. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για να αποτρέψετε διήθηση αέρα αποσύροντας τα αντικείμενα αργά για την πρόληψη δημιουργίας κενού στο θηκάρι και παρακολουθείτε με ακτινοσκόπηση το θηκάρι κατά την εισαγωγή της συσκευής για παρουσία αέρα.

1. Στρέψτε τη στρόφιγγα της βελόνας στην κλειστή θέση (off) και αποσυνδέστε κάθε προσάρτημα από το συνδετικό της βελόνας.
2. Αφαιρέστε τη διαδιαφραγματική βελόνα BRK™ από τον διαστολέα. Η βελόνα μπορεί να καθαριστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί για αυτήν τη διαδικασία. Διαφορετικά, απορρίψτε τη βελόνα με τρόπο κατάλληλο για μολυσμένα αιχμηρά αντικείμενα.
3. Προσαρτήστε αμέσως μια σύριγγα στον διαστολέα και κάντε αναρρόφηση. Συνεχίστε την αναρρόφηση αίματος κρατώντας το θηκάρι στη θέση του και αποσύροντας τον διαστολέα. Το αίμα πρέπει να είναι αρτηριακό αίμα.
4. Αφού αφαιρεθεί ο διαστολέας, αναρροφήστε αίμα μέσω του πλευρικού βραχίονα του θηκαριού. Εκπλύνετε προσεκτικά τον πλευρικό βραχίονα του θηκαριού με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα.
5. Το θηκάρι είναι τώρα τοποθετημένο στον αριστερό κόλπο.

Συσκευασία και χρόνος αποθήκευσης

Η διαδιαφραγματική βελόνα BRK™ παρέχεται αποστειρωμένη. Η βελόνα συσκευάζεται με εισηγμένο στειλεό. Η βελόνα και ο στειλεός είναι τοποθετημένα στην πρωτεύουσα συσκευασία. Η πρωτεύουσα συσκευασία είναι τοποθετημένη μέσα σε θήκη από Mylar‡ και Tyvek‡, η οποία είναι θερμοσφραγισμένη. Στη συνέχεια, η θήκη και αυτές οι οδηγίες χρήσης τοποθετούνται σε κουτί, το οποίο έχει σφραγισμένα και τα δύο άκρα. Τόσο η θήκη όσο και το κουτί φέρουν ετικέτα με τα στοιχεία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης. Τα προϊόντα επισημαίνονται για χρόνο αποθήκευσης τριών ετών.

Σύνοψη κλινικών δεδομένων

Για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μια περίληψη της ασφάλειας και της κλινικής απόδοσης (SSCP) για αυτές τις συσκευές θα δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/tools/eudamed από την κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EE MDR 2017/745 και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Αναζητήστε τη συσκευή με το UDI-DI που παρέχεται στην εξωτερική συσκευασία της συσκευής. Το UDI-DI είναι ο 14 ψήφιος αριθμός μεταξύ των δύο πρώτων ζευγών παρενθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εύρεση και χρήση του UDI-DI, ανατρέξτε στο έγγραφο Συχνές ερωτήσεις που βρίσκεται στη διεύθυνση medical.abbott/manuals.

Αναφορά περιστατικών

Εάν, στην πορεία που χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, έχετε λόγο να πιστεύετε ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Για πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρετε το σοβαρό περιστατικό στην αρμόδια αρχή της χώρας σας, καθώς και στον κατασκευαστή.

Περιορισμένη εγγύηση

Η Abbott Medical εγγυάται ότι τα προϊόντα αυτά δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά και κακοτεχνίες υπό κανονική χρήση. Η παρούσα εγγύηση δεν υπερβαίνει την ημερομηνία «Λήξης» που αναγράφεται στην επισήμανση του εκάστοτε προϊόντος. Οι εξουσιοδοτημένες χρήσεις και εγκεκριμένες μέθοδοι χρήσης κάθε προϊόντος μας περιγράφονται στις σχετικές «Οδηγίες χρήσης» που συνοδεύουν το κάθε προϊόν. Η Abbott Medical ουδεμία νομική ή αστική ευθύνη φέρει, εάν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται με μη εξουσιοδοτημένο ή εγκεκριμένο τρόπο. Η αστική ευθύνη της Abbott Medical υπό την παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των προϊόντων της. Η παραπάνω εγγύηση εξαιρεί και αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές ή εννοούμενες, μεταξύ των οποίων οποιαδήποτε εννοούμενη εγγύηση περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας του προϊόντος για συγκεκριμένο σκοπό. Η Abbott Medical ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική βλάβη, ζημιά ή δαπάνη άμεσα ή έμμεσα προκύπτουσα από τη χρήση του προϊόντος, εκτός των όσων προβλέπονται ρητά από τον συγκεκριμένο νόμο. Η Abbott Medical ούτε αναλαμβάνει ούτε και εξουσιοδοτεί τρίτους να αναλάβουν για λογαριασμό της οποιαδήποτε άλλη ή πρόσθετη αστική ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή δαπάνη σε σχέση με αυτό το προϊόν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την πλήρη πολιτική εγγύησης της Abbott Medical που διατίθεται από την Abbott Medical ή στο πίσω μέρος ενός τιμολογίου της Abbott Medical.

Σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα και τα εναρμονισμένα σύμβολα μπορεί να βρίσκονται πάνω στο προϊόν ή στην επισήμανση του προϊόντος. Για τα εναρμονισμένα σύμβολα, ανατρέξτε στο γλωσσάρι καθολικών συμβόλων στη διεύθυνση medical.abbott/manuals.

Σύμβολο	Ορισμός
Series	Σειρά
Contents	Περιεχόμενα
Transseptal Needle	Διαδιαφραγματική βελόνα
	Σύστημα μονού αποστειρωμένου φραγμού
	Μήκος
℞ ONLY	ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
CE 2797	Conformité Européenne (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση). Τοποθετείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/745 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με το παρόν, η Abbott Medical δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις αυτού του κανονισμού.
	Εισαγωγέας
UK CA 0086	Αξιολόγηση συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου
UKRP	Υπεύθυνος στο Ηνωμένο Βασίλειο
UA.TR.101	Ουκρανικό σήμα συμμόρφωσης με τους τεχνικούς κανονισμούς, όπου το 101 είναι ο φορέας αξιολόγησης.
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
UDI	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
medical.abbott/manuals	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα
(7440-48-4) (7439-92-1)	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες. (Κοβάλτιο Αρ. CAS 7440-48-4) (Μόλυβος Αρ. CAS 7439-92-1)

ES: Español

BRK™ Aguja transeptal

Instrucciones de uso

Descripción

La aguja transeptal BRK™ se compone de una aguja luminal y un estilete macizo, ambos de acero inoxidable. La sección distal de la aguja es curva para facilitar su colocación dentro del corazón cuando se utiliza con un conjunto de vaina transeptal de Abbott Medical. En esta sección curva, el diámetro exterior de la aguja presenta una disminución brusca que coincide con el diámetro interior del dilatador de un conjunto de vaina transeptal de Abbott Medical. La aguja tiene una punta distal biselada para facilitar el proceso de perforación. El extremo proximal de la aguja está configurado con una pestaña indicadora (que muestra la orientación de la curva distal) y provisto de una llave de paso de 2 vías para proporcionar acceso al lumen de la aguja para la aspiración, la inyección o la infusión de líquidos, la toma de muestras de sangre, la monitorización de la presión y la inserción de un estilete o aguja guía (el diámetro máximo de la aguja guía debe ser de 0,014 pulgadas para una aguja de calibre 18; el diámetro máximo de la aguja guía debe ser de 0,012 pulgadas para una aguja de calibre 19). El estilete es recto e isodiamétrico en toda su longitud. El extremo proximal del estilete dispone de un clip curvo para fijarlo al conector proximal de la aguja cuando se introduce en el lumen de esta. El estilete está diseñado para facilitar el avance de la aguja dentro del dilatador. La aguja está disponible en varias longitudes útiles y diferentes configuraciones de curvas distales.

Fin previsto

La aguja transeptal BRK™ está diseñada para usarse en la perforación del tabique interauricular para acceder al lado izquierdo del corazón.

Indicaciones de uso

La aguja transeptal BRK™ se emplea para perforar el tabique interauricular durante los procedimientos de cateterismo transeptal con el fin de acceder al lado izquierdo del corazón.

Grupo objetivo de pacientes

La aguja transeptal BRK™ está diseñada para usarse en pacientes hemodinámicamente estables que necesiten que el catéter llegue al lado izquierdo del corazón. Es posible que el uso de la aguja transeptal BRK™ necesite especial consideración en pacientes con los siguientes cuadros:

- Corazón rotado
- Raíz aórtica dilatada
- Dilatación marcada de la aurícula derecha
- Escoliosis/cifosis
- Geometría anómala de la aurícula izquierda
- Anomalías congénitas
- Anomalías vasculares
- Imposibilidad de acceder a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior

Usuario previsto

Este dispositivo deben usarlo únicamente médicos con formación específica en procedimientos transeptales, en un laboratorio de electrofisiología operativo y totalmente equipado.

Beneficios clínicos

El beneficio clínico previsto de la aguja transeptal BRK™ es perforar el tabique interauricular durante un procedimiento de cateterismo transeptal para acceder al lado izquierdo del corazón y permitir que los dispositivos que precisen acceso endocárdico al lado izquierdo del corazón logren el beneficio clínico previsto, como un catéter de ablación. Esto se mide por la perforación correcta del tabique interauricular.

Contraindicaciones

- Parche septal interauricular o dispositivo protésico para el cierre de una comunicación interauricular anteriores.
- Cualquier episodio tromboembólico anterior.
- Presencia o sospecha de mixoma auricular izquierdo.
- Presencia o sospecha de un infarto de miocardio en las últimas dos semanas.
- Angina inestable.
- Accidente cerebrovascular (ACV) reciente.
- Pacientes con intolerancia al tratamiento con anticoagulantes.
- Pacientes con una infección activa.

Advertencias

- No modifique este dispositivo de ningún modo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para un solo uso; no lo reprocese ni reutilice. Fíjese en la fecha de "caducidad" del envase. Todo intento de volver a esterilizar y reutilizar este sistema puede poner en peligro su integridad. Los efectos adversos derivados del uso de componentes sin esterilizar incluyen, entre otros:
  - Reacción e infección sistémica o local
  - Daños mecánicos
  - Funcionalidad imprecisa
- Los materiales abajo identificados por producto pueden causar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Las personas alérgicas a ellos pueden sufrir una reacción alérgica a este producto. Antes de su uso en el paciente, se le debe informar sobre los materiales que contiene el dispositivo y ha de analizarse un historial pormenorizado de alergias:
  - Acero inoxidable
  - Adhesivo epoxi
  - Latón niquelado cromado
  - Grasa de silicona para alto vacío (Dupont)
  - Master Bond
- El mal uso de este dispositivo puede provocar complicaciones graves.
- Tanto para los pacientes como para el personal del laboratorio, los procedimientos de cateterización cardíaca constituyen un potencial importante de exposición a rayos X, que puede derivar en la aparición de lesiones agudas por radiación y el aumento del riesgo de sufrir efectos somáticos y genéticos, debido a la intensidad del haz de rayos X y a la duración del proceso de obtención de imágenes fluoroscópicas. Considere detenidamente el uso de este dispositivo en mujeres embarazadas.

Precauciones

- Las leyes federales de EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
- Lea las instrucciones antes del uso.
- Inspeccione el envase antes del uso. No lo utilice si el envase está abierto o dañado.
- Inspeccione todos los componentes antes del uso.

- Almacénelo en un lugar fresco, oscuro y seco.
- El paciente deberá estar hemodinámicamente estable antes de la intervención. Es posible que en algunos casos haya que tomar especial precaución al utilizar este producto. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
  - Corazón rotado
  - Raíz aórtica dilatada
  - Dilatación marcada de la aurícula derecha
  - Escoliosis/cifosis
  - Geometría anómala de la aurícula izquierda
  - Anomalías congénitas
  - Anomalías vasculares
  - Imposibilidad de acceder a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior
- Este dispositivo deben usarlo únicamente médicos con formación específica en procedimientos transeptales, en un laboratorio de electrofisiología (EF) operativo y totalmente equipado.
- El avance del catéter debe realizarse bajo control fluoroscópico para minimizar los riesgos de daños, perforación o taponamiento cardíacos. También se puede considerar el uso de sistemas compatibles de navegación y visualización en tiempo real.
- Durante la introducción, compruebe si existe demasiada resistencia a medida que la punta de la aguja avanza a través de la curvatura del conjunto de vaina y dilatador. Si existe algún tipo de resistencia durante el avance de la aguja, retráigala y evalúe los componentes.
- Durante la introducción, deberá tomar las precauciones necesarias para que no se formen demasiadas curvas en el dispositivo. Esto podría impedir el avance de la aguja y provocar una perforación accidental con la aguja del conjunto de dilatador y vaina.
- Utilice siempre el estilete durante la introducción para facilitar el paso de la aguja a través del conjunto de dilatador y vaina. Si no se utiliza el estilete, se podría impedir el avance de la aguja, lo cual podría provocar una perforación accidental con la aguja del conjunto de dilatador y vaina o que se levanten virutas del material de la superficie interior del dilatador.
- Si se produce una penetración pericárdica o aórtica, no haga avanzar el dilatador sobre la aguja. Si la aguja ha penetrado en el pericardio o la aorta, será necesario retirarla. Controle rigurosamente las constantes vitales.
- Existe un riesgo de infiltración gaseosa al extraer objetos de la válvula hemostática de la vaina. Tome las precauciones necesarias para evitar que esto ocurra: extraiga los objetos lentamente para evitar la acumulación de vacío en la vaina y controle mediante fluoroscopia la vaina durante la posterior introducción del dispositivo para poder detectar la presencia de aire.
- Después del uso, este dispositivo, sus accesorios y el envase deben clasificarse de forma adecuada para su eliminación (p. ej., peligro biológico, objetos afilados, desechos no peligrosos, etc.), y eliminarse cuidadosamente observando los procedimientos del centro y las leyes y normativas vigentes.
- Uno o más componentes de este producto pueden contener la sustancia siguiente, definida como CMR 1B, en una concentración superior al 0,1 % del peso por peso: cobalto: n.º de Chemical Abstracts Service (CAS) 7440-48-4; n.º CE 231-158-0. Los hallazgos científicos actuales indican que los productos sanitarios fabricados a partir de aleaciones de cobalto y aleaciones de acero inoxidable que contengan cobalto no aumentan el riesgo de padecer cáncer o efectos reproductivos adversos.

  Uno o más componentes de este producto pueden contener la sustancia siguiente, definida como CMR 1A, en una concentración superior al 0,1 % del peso por peso: plomo: n.º de Chemical Abstracts Service (CAS) 7439-92-1; n.º CE 231-100-4. Los hallazgos científicos actuales indican que los productos sanitarios fabricados de plomo no aumentan el riesgo de padecer cáncer o efectos reproductivos adversos.

Posibles acontecimientos adversos

Categoría del evento adverso	Subcategoría del evento adverso
Hemorragia	Hemorragia/sangrado
	Hematoma
Lesión cerebral	Embolias cerebrales asintomáticas
	Ictus/accidente cerebrovascular
	Ataque isquémico transitorio (AIT)
Embolia	Embolia gaseosa
	Embolia por cuerpos extraños
	Embolia pulmonar
	Tromboembolia
	Trombosis/trombo
Perforación cardíaca	Taponamiento cardíaco
	Derrame pericárdico
Lesión cardiovascular	Daño valvular
	Perforación de la raíz aórtica
	Perforación auricular
Alteración del sistema de conducción	Bloqueo del nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular o sistema His-Purkinje
	Arritmias cardíacas
Reacción inmunológica	Anafilaxia
Infección	Pericarditis
	Endocarditis
	Neumonía
	Septicemia
Dolor/molestias	Dolor, ingle, tórax (dolor torácico general no asociado con IM)
Lesión vascular periférica	Disección
	Laceración
	Formación de fístulas arteriovenosas
	Formación de pseudoaneurisma
Hipotensión	N/D
Lesión tisular superficial	N/D

Instrucciones

Preparar y ensamblar el equipo

1. Saque todo el contenido del envase.

   NOTA: No ensamble la vaina y el dilatador.

2. Irrigue el dilatador y la vaina con solución salina heparinizada.
3. Cierre la llave de paso de la vaina.
4. Extraiga el estilete de la aguja e irrigue la aguja con solución salina heparinizada.
5. Introduzca el estilete en la aguja y fíjelo en el conector.
6. Introduzca el dilatador por completo en la vaina transeptal.

Hacer avanzar el conjunto de vaina y dilatador hacia la vena cava superior

1. Obtenga un acceso venoso femoral (preferentemente, el femoral derecho).

   OPCIONAL: para obtener y mantener el acceso venoso para el intercambio de dispositivos y la hemostasia, puede utilizarse una vaina de longitud estándar más grande (≥2,5 tamaños en French más grande que la vaina transeptal).

2. Introduzca una guía de 0,032 pulgadas y 150–180 cm de longitud con punta en "J" de 3 mm en la vena cava superior (VCS).

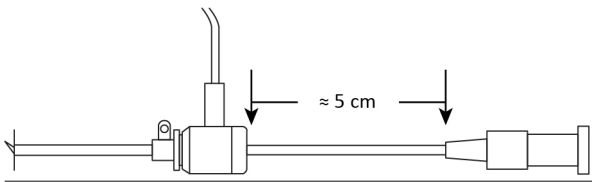
   NOTA: El diámetro máximo de la aguja guía que se puede utilizar con el dilatador es de 0,032 pulgadas.

3. Introduzca la vaina y el dilatador en la vena sobre la aguja guía hasta que la punta de la vaina esté en la VCS. Oriente la punta del dilatador en dirección medial.

Colocar el conjunto de aguja y estilete dentro del conjunto de vaina y dilatador

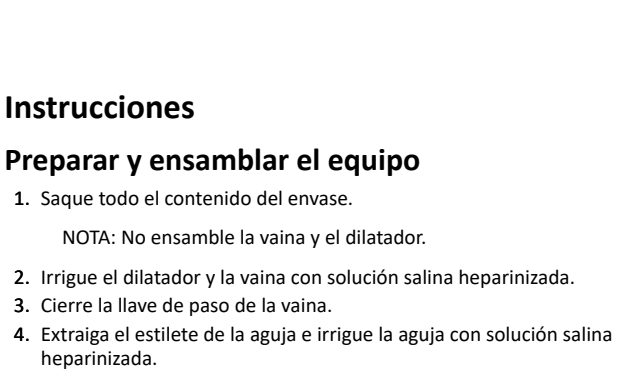
1. Extraiga la guía del dilatador.
2. Aspire totalmente y luego irrigue el dilatador con solución salina heparinizada.
3. Extraiga el dilatador aproximadamente 5 cm (vea la figura siguiente) para facilitar el paso de la curva de la aguja a través de los conectores rígidos del dilatador y de la vaina.

Figura 1. Retirar el dilatador



4. Fije el estilete al conector.
5. Introduzca la aguja y el estilete en el dilatador. Haga avanzar la aguja y el estilete bajo fluoroscopia hasta que estén aproximadamente a 2 cm de la punta del dilatador dentro de la vaina (véase la figura de abajo).

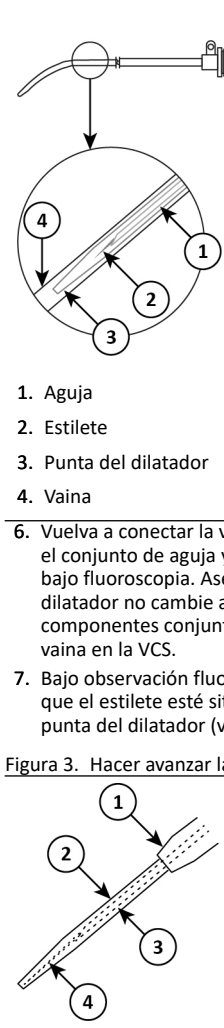
Figura 2. Introducir la aguja y el estilete en el dilatador



1. Aguja
2. Estilete
3. Punta del dilatador
4. Vaina

6. Vuelva a conectar la vaina y el dilatador haciendo avanzar el dilatador y el conjunto de aguja y estilete dentro de la vaina de forma simultánea bajo fluoroscopia. Asegúrese de que la posición de la aguja dentro del dilatador no cambie a medida que se hagan avanzar ambos componentes conjuntamente. Mantenga la posición de la punta de la vaina en la VCS.
7. Bajo observación fluoroscópica, haga avanzar la aguja y el estilete hasta que el estilete esté situado justo en posición proximal respecto a la punta del dilatador (véase la figura de abajo).

Figura 3. Hacer avanzar la aguja y el estilete



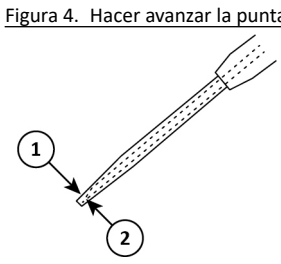
1. Punta de la vaina
2. Dilatador
3. Aguja
4. Estilete

8. Saque el estilete, pero no lo deseche.
9. Aspire la aguja hasta observar que la sangre regresa. Deseche la jeringa.

   NOTA: El uso de una jeringa de punta deslizante (no Luer-Lok‡) puede evitar la aspiración de aire.

10. Irrigue la aguja con solución salina heparinizada. Cierre la llave de paso.
11. Haga avanzar la aguja bajo fluoroscopia hasta que su punta esté situada justo en posición proximal respecto a la punta del dilatador (véase la figura de abajo).

Figura 4. Hacer avanzar la punta de la aguja



1. Punta del dilatador
2. Punta de la aguja

OPCIONAL: acople una llave de paso giratoria de 3 vías al conector de la aguja.

OPCIONAL: acople una jeringa con medio de contraste radiopaco a la llave de paso. Aspire la aguja. A continuación, cargue la aguja con medio de contraste bajo orientación fluoroscópica.

OPCIONAL: conecte una línea de monitorización de la presión a la llave de paso.

OPCIONAL: utilice un sistema de distribuidor de 3 puertos estándar para conectar las líneas de contraste, presión y lavado.

Acceso a la fosa oval

1. Visualice e identifique los puntos de referencia anatómicos.
2. Coloque la unidad fluoroscópica en un ángulo paralelo al plano de la válvula mitral y perpendicular al plano del tabique. Normalmente se situará a aproximadamente 30 a 40 grados en posición oblicua anterior izquierda (OAI).

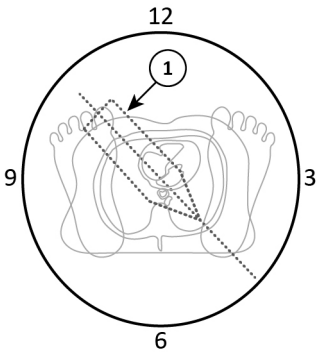
   OPCIONAL: durante los procedimientos de EF, las posiciones de los catéteres del seno coronario y del haz de His pueden ser útiles como puntos de referencia anatómicos. En la vista OAI adecuada, el catéter del seno coronario aparece de perfil. En la vista oblicua anterior derecha (OAD), el catéter del haz de His aparece de perfil. La fosa oval está a la altura del catéter del haz de His o ligeramente por debajo, y por encima y por detrás del orificio del seno coronario.

   OPCIONAL: la colocación de un catéter de monitorización hemodinámica/angiográfica en J en la valva no coronaria de la válvula aórtica puede ser útil como punto de referencia anatómico.

   OPCIONAL: observe la forma de onda de presión que se registra a través de la aguja transeptal BRK™.

3. Ajuste la pestaña indicadora de modo que la aguja quede perpendicular a la fosa oval (normalmente entre las posiciones de las 3:00 y las 5:00 en punto, visto desde los pies del paciente). (Véase la figura de abajo.)

Figura 5. Pestaña indicadora de la aguja

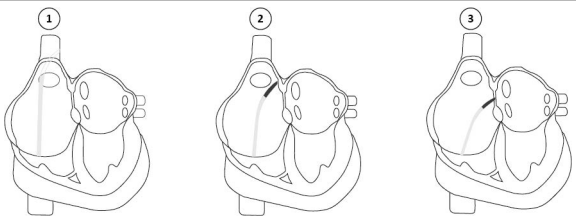


1. Pestaña indicadora de la aguja

4. Utilice fluoroscopia para confirmar que la punta de la aguja se encuentra dentro del dilatador.
5. Después de confirmar que la punta de la aguja está dentro del dilatador, arrastre todo el conjunto de vaina, dilatador y aguja lentamente. Evite cualquier movimiento relativo entre las piezas del conjunto. Es fundamental mantener la orientación anterior de la pestaña indicadora al arrastrar el conjunto.
6. En la vista OAI (perpendicular al tabique interauricular), observe la punta del dilatador durante el arrastre para comprobar si existe algún movimiento medial (o hacia la derecha) brusco, lo cual indicaría que la punta se ha enganchado en la fosa oval. (Véanse las figuras de abajo.)

   NOTA: Si la fosa oval es permeable a una sonda, la punta del dilatador se introduce ahora en la aurícula izquierda con facilidad.

Figura 6. Acceso a la fosa oval



1. Posición de partida en la VCS
2. Movimiento medial inicial en la AD
3. Movimiento medial brusco sobre la fosa oval

NOTA: Si se está monitorizando la presión a través de la aguja, la presión a través de esta no es exacta en este punto, ya que la punta está situada contra la fosa oval.

Perforación de la fosa oval con la aguja transeptal BRK™

1. Confirme que el conjunto de vaina, dilatador y aguja está correctamente colocado en la fosa oval antes de hacer avanzar la aguja.
2. Una vez confirme que la colocación es correcta, extienda la aguja dentro del conjunto de vaina y dilatador hasta que se acople completamente y hágala avanzar a través del tabique interauricular.

   OPCIONAL: durante la monitorización de la presión, la penetración en la aurícula izquierda se confirma cuando el trazado de presión muestra una forma de onda de presión para la aurícula izquierda.

   OPCIONAL: el acceso a la aurícula izquierda puede confirmarse mediante fluoroscopia con inyecciones de contraste.

3. Si existe algún tipo de resistencia durante el avance de la aguja, retráigala y vuelva a analizar los puntos de referencia anatómicos.

   PRECAUCIÓN: Si se produce una penetración pericárdica o aórtica, no haga avanzar el dilatador sobre la aguja. Si la aguja ha penetrado en el pericardio o la aorta, será necesario retirarla. Controle rigurosamente las constantes vitales.

Hacer avanzar el conjunto de vaina y dilatador hacia la aurícula izquierda

Mientras la aguja se mantiene en una posición fija dentro de la aurícula izquierda, haga avanzar completamente el conjunto de vaina y dilatador sobre la aguja hacia el interior de la cavidad auricular izquierda.

Hacer avanzar la vaina sobre el dilatador y la aguja inmóviles hacia la aurícula izquierda

1. Mantenga la posición de la aguja y el dilatador con respecto al tabique.
2. Mientras el dilatador se mantiene en una posición fija, haga avanzar la vaina completamente sobre el dilatador hacia el interior de la cavidad auricular izquierda.

Retirar la aguja transeptal BRK™ y el dilatador

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de infiltración gaseosa al extraer objetos de la válvula hemostática de la vaina. Tome las precauciones necesarias para evitar que esto ocurra: extraiga los objetos lentamente para evitar la acumulación de vacío en la vaina y controle mediante fluoroscopia la

vaina durante la posterior introducción del dispositivo para poder detectar la presencia de aire.

1. Gire la llave de paso de la aguja a la posición de cierre y desconecte los accesorios del conector de la aguja.
2. Retire la aguja transeptal BRK™ del dilatador. La aguja se puede limpiar y dejar a un lado para utilizarla nuevamente en esa misma intervención. De lo contrario, deseche la aguja según los procedimientos correspondientes a objetos cortantes contaminados.
3. Acople inmediatamente una jeringa al dilatador y aspire. Continúe aspirando sangre mientras mantiene la vaina en su posición y retira el dilatador. La sangre deberá ser arterial.
4. Una vez retirado el dilatador, aspire sangre a través del brazo lateral de la vaina. Con cuidado, irrigue el brazo lateral de la vaina con solución salina heparinizada para evitar burbujas de aire.
5. La vaina estará entonces en su sitio en la aurícula izquierda.

Envase y caducidad

La aguja transeptal BRK™ se suministra estéril. Cada aguja viene envasada con un estilete introducido. La aguja y el estilete se colocan en un envase principal. El envase principal se coloca dentro de una bolsa de Mylar‡ y Tyvek‡ termosellada. A continuación, la bolsa y estas instrucciones de uso se colocan en una caja que está precintada en ambos extremos. Tanto la bolsa como la caja incluyen una etiqueta con información sobre el producto, incluida la fecha de caducidad. En la etiqueta de los productos se indica un período de validez de tres años.

Resumen de datos clínicos

Para países de la Unión Europea: los organismos notificados, de conformidad con los requisitos del Reglamento 2017/745 de la UE sobre productos sanitarios y los plazos asociados, publicarán un resumen de seguridad y rendimiento clínico (SSCP) para estos dispositivos en https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Busque el dispositivo mediante el UDI-DI proporcionado en el envase exterior del dispositivo. El UDI-DI es el número de 14 dígitos entre los dos primeros conjuntos de paréntesis. Si desea más información sobre la localización y uso del UDI-DI, consulte el documento de preguntas frecuentes que se encuentra en medical.abbott/manuals.

Notificación de incidentes

Si, mientras utiliza este dispositivo, tiene motivos para creer que se ha producido un incidente grave, notifíqueselo al fabricante. En el caso de clientes de la Unión Europea, notifique los incidentes graves tanto a la autoridad nacional como al fabricante.

Garantía limitada

Abbott Medical garantiza que sus productos no presentan defectos en sus materiales ni en su fabricación en condiciones normales de uso. Esta garantía no superará la fecha de "caducidad" que figura en el etiquetado de los productos. Los usos autorizados y los métodos de uso aprobados para cada uno de nuestros productos se establecen en las correspondientes "Instrucciones de uso" que acompañan a cada producto. Abbott Medical declina cualquier responsabilidad por el uso de sus productos de manera no autorizada o aprobada. La responsabilidad de Abbott Medical según esta garantía se limita a la sustitución de sus productos. La presente garantía excluye y anula todas las demás garantías, ya sean expresas o implícitas incluyendo, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un uso concreto. Abbott Medical declina cualquier responsabilidad por las pérdidas, daños o gastos imprevistos o consecuentes derivados directa o indirectamente del uso de este producto, salvo lo expresamente dispuesto en la legislación aplicable. Abbott Medical no asume, ni autoriza a ninguna otra persona a asumir, ninguna otra responsabilidad por la pérdida, daños o gastos relacionados con este producto. Para más información, consulte la política de garantía completa de Abbott Medical disponible en Abbott Medical o en el reverso de una factura de Abbott Medical.

Símbolos

En el producto o la etiqueta del producto se pueden encontrar los siguientes símbolos y los símbolos armonizados. Para conocer los símbolos armonizados, consulte el Glosario de símbolos universales en medical.abbott/manuals.

Símbolo	Definición
Series	Serie
Contents	Contenido
Transseptal Needle	Aguja transeptal
	Sistema de barrera estéril sencilla
	Longitud
	PRECAUCIÓN: Las leyes federales de EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
	Conformité Européenne (conformidad europea). Colocado de conformidad con el Reglamento del Consejo Europeo 2017/745. Por la presente, Abbott Medical declara que este dispositivo cumple los requisitos fundamentales y demás disposiciones pertinentes de este reglamento.
	Importador
	Evaluación de conformidad en el Reino Unido
UKRP	Responsable en el Reino Unido
	Marca ucraniana de conformidad con las regulaciones técnicas, donde 101 es el organismo de evaluación.
MD	Producto sanitario
UDI	Identificación única del dispositivo
	Siga las instrucciones de uso de este sitio web
 (7440-48-4) (7439-92-1)	Contiene sustancias peligrosas. (Cobalto, n.º CAS 7440-48-4) (Plomo, n.º CAS 7439-92-1)

ET: Eesti keel

BRK™ Transseptaalne nõel

Kasutusjuhend

Kirjeldus

BRK™ transseptaalne nõel koosneb valendikuga roostevabast terasest nõelast ja kõvast roostevabast terasest stiletist. Nõela distaalne osa on kõver, et seda saaks ettevõtte Abbott Medical transseptaalse sisestushülsi komplekti abil südamesse paigutada. Kõveras osas muutub nõela välisläbimõõt väiksemaks, et see sobiks ettevõtte Abbott Medical transseptaalse sisestushülsi komplekti dilataatori siseläbimõõduga. Nõela distaalne ots on nurga all lihvitud, et punkteerimine hõlpsam oleks. Nõela proksimaalne ots on konfigureeritud nõela äärikuga (mis näitab distaalse kõveruse suunda) ja sellel on 2-suunaline korkkraan, mis annab nõela valendikule juurdepääsu aspireerimiseks, vedeliku süstimiseks/infundeerimiseks, vereproovide võtmiseks, rõhku jälgimiseks ning stileti ja/või juhtetraadi sisestamiseks (kuni 0,014-tollise läbimõõduga juhtetraat 18 F nõela puhul; kuni 0,012-tollise läbimõõduga juhtetraat 19 F nõela puhul). Stilett on kogu pikkuses sirge ja ühesuguse diameetriga. Stileti proksimaalses otsas on kõver klamber, et nõela proksimaalset jaoturit nõela valendikku sisestamise ajal lukustada. Stilett on mõeldud nõela edasiliikumise hõlbustamiseks dilataatoris. Nõel on saadaval mitmesuguse pikkuse ja distaalse kõverusega.

Sihtotstarve

BRK™ transseptaalne nõel on mõeldud kasutamiseks kodadevahelise vaheseina punkteerimiseks, et vasakusse südamepoolde siseneda.

Kasutusnäidustused

BRK™ transseptaalset nõela kasutatakse kodadevahelise vaheseina punkteerimiseks transseptaalse kateeterdamise käigus vasakusse südamepoolde sisenemise ajal.

Patsientide sihtrühm

BRK™ transseptaalne nõel on mõeldud kasutamiseks hemodünaamiliselt stabiilsetel patsientidel, kelle puhul on vajalik kateeterdatud juurdepääs vasakusse südamepoolde. BRK™ nõela kasutamine võib nõuda erilist tähelepanu järgmiste seisunditega patsientidel:

- Südame telje pöördumine;
- Laienenud aordi algusosa;
- Märgatav parema koja laienemine;
- Skolioos/küfoos;
- Ebatavaline vasaku koja geomeetria;
- Kaasasündinud väärarendid;
- Vaskulaarsed väärarendid;
- Võimatu läheneda paremale kojale läbi alumise õõnesveeni.

Kavandatud kasutaja

Seda seadet tohivad täielikult varustatud toimivas elektrofüsioloogia laboris kasutada ainult arstid, kes on transseptaalsete protseduuride alal spetsiaalse väljaõppe saanud.

Kliiniline kasu

BRK™ transseptaalse nõela kavandatud kliiniline kasu seisneb kodadevahelise vaheseina punktsioonis transseptaalse kateeterdamisprotseduuri ajal, et saada juurdepääs vasakule südamepoolele, et võimaldada saavutada kavandatud kliiniline kasu seadmetel, mis vajavad juurdepääsu vasaku südamepoole endokardile, näiteks ablatsioonikateetril. Seda mõõdetakse kodadevahelise vaheseina eduka punktsiooniga.

Vastunäidustused

- Varem tehtud kodade vaheseina operatsioon või kodade vaheseina defekti sulguri protees.
- Mis tahes varasem tromboemboolia olukord.
- Teadaolev vasaku südamekoja müksoom või selle kahtlus.
- Teadaolev müokardiinfarkt viimase kahe nädala jooksul või selle kahtlus.
- Ebastabiilne stenokardia.
- Hiljutine ajuveresoonte haigusjuhtum (CVA).
- Patsiendid, kes ei talu hüübimisvastast ravi.
- Aktiivse infektsiooniga patsiendid.

Hoiatused

- Seda seadet ei tohi mingil moel muuta.
- See seade on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks, ärge töödelge ümber ega kasutage korduvalt. Pöörake tähelepanu pakendile märgitud toote „aegumiskuupäevale“. Iga katse seda süsteemi uuesti steriliseerida ja korduskasutada võib kahjustada selle terviklikkust. Ebasteriilsete komponentide kasutamise kõrvaltoimed hõlmavad järgmisi (loend pole lõplik):
  - Lokaalne ja süsteemne infektsioon või reaktsioon;
  - Mehaanilised kahjustused;
  - Ebatäpne töö.
- Toote kohta allpool loetletud materjalid võivad põhjustada allergilisi või ülitundlikkusreaktsioone. Nende materjalide suhtes allergilistel isikutel võib tekkida allergiline reaktsioon. Enne kasutamist patsiendil tuleb patsienti nõustada seadmes sisalduvate materjalide asjus ja arutada põhjalikult varasemaid allergiaid.
  - Roostevaba teras
  - Epoksüliim
  - Nikli-kroomiga kaetud messing
  - Kõrgvaakum silikoonmääre (Dupont)
  - Master Bond
- Selle seadme väärkasutamine võib põhjustada raskeid tüsistusi.
- Südame kateeterdamise protseduuril võib esineda märkimisväärne kokkupuude röntgenikiirgusega, mis võib röntgenikiirguse intensiivsuse ja fluoroskoopia kestuse tõttu põhjustada ägedaid kiirituskahjustusi ning somaatiliste toimete ja geenikahjustuste suurenenud ohtu nii patsientidele kui ka laboripersonalile. Kaaluge hoolikalt selle seadme kasutamist rasedatel naistel.

Ettevaatusabinõud

- USA föderaalseaduse järgi võib seda seadet müüa ainult arst või arsti ettekirjutusel.
- Enne kasutamist lugege juhendit.
- Enne kasutamist kontrollige pakendit. Ärge kasutage, kui pakend on avatud või kahjustatud.
- Enne kasutamist kontrollige kõiki komponente.
- Hoida jahedas, pimedas ja kuivas kohas.
- Enne protseduuri alustamist peab patsient olema hemodünaamiliselt stabiilne. Mõnede seisundite korral on selle toote kasutamisel vaja

tavalisest suuremat ettevaatust. Nende hulka kuuluvad muu hulgas järgmised:
  - Südame telje pöördumine;
  - Laienenud aordi algusosa;
  - Märgatav parema koja laienemine;
  - Skolioos/küfoos;
  - Ebatavaline vasaku koja geomeetria;
  - Kaasasündinud väärarendid;
  - Vaskulaarsed väärarendid;
  - Võimatu läheneda paremale kojale läbi alumise õõnesveeni.
- Seda seadet tohivad kasutada arstid, kes on saanud transseptaalsete protseduuride alal spetsiaalse väljaõppe, täielikult varustatud töötavas elektrofüsioloogia (EF) laboris.
- Kateetrit tuleb südame kahjustamise, mulgustuse või tamponaadi tekkeohu vähendamiseks liigutada edasi fluoroskoopilise kontrolli all. Kaaluda võib ka ühilduvaid visualiseerimis- ja reaalajas navigeerimissüsteeme.
- Sisestamise ajal kontrollige, et nõela otsa liikumisel läbi sisestushülsi ja dilataatori koostu kõveruste ei esineks liigset takistust. Kui nõela edasiliikumine on takistatud, tõmmake nõel tagasi ja kontrollige komponente.
- Olge sisestamise käigus ettevaatlik ja veenduge, et te ei painutaks seadet üleliia. See võib vähendada nõela edasiliikumist ning põhjustada tahtmatu dilataatori/sisestushülsi koostu punktsiooni.
- Sisestamise ajal tuleb alati kasutada stiletti, et lihtsustada nõela dilataatori/sisestushülsi koostust läbiminekut. Stileti mittekasutamine võib takistada nõela läbiminekut ja võib põhjustada tahtmatu dilataatori/sisestushülsi koostu punktsiooni nõelaga või dilataatori sisepinna materjali kriipimist.
- Kui ilmneb perikardiaalne või aorti sisenemine, ärge edastage dilataatorit üle nõela. Kui nõel on tunginud läbi perikardi või aordi, tuleb see tagasi tõmmata. Jälgige hoolikalt elulisi näitajaid.
- Sisestushülsi hemostaasiklapist objekte eemaldades on õhu sisseimbumise oht. Võtke kasutusele ettevaatusabinõud õhu sisseimbumise vältimiseks, eemaldades objekte aeglaselt, vältimaks sisestushülsis vaakumi tekkimist, ning jälgige fluoroskoobi abil sisestushülssi, tagades õhu sissetungimise korral seadme sisestamise.
- Pärast kasutamist tuleb seade, selle tarvikud ja pakendid kõrvaldamiseks nõuetekohaselt sorteerida (näiteks bioloogilised, teravad ja ohtlikud jäätmed) ning kõrvaldada hoolikalt asutuse protseduuride ja kohaldatavate seaduste ning eeskirjade kohaselt.
- Seadme üks või mitu osa võivad sisaldada järgmist ainet, mis on määratletud kui CMR 1B, kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. Koobalt: Chemical Abstracts Service'i (CAS) nr 7440-48-4; EÜ nr 231-158-0. Praeguste teaduslike faktide kohaselt ei põhjusta koobalti sulamitest ja roostevaba terase sulamitest valmistatud seadmed vähi suurenenud tekkeriski või kahjulikke mõjusid reproduktiivsüsteemile.

  Seadme üks või mitu osa võivad sisaldada järgmist ainet, mis on määratud kui CMR 1A, kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. Elektroodjuhe: Chemical Abstracts Service'i (CAS) nr 7439-92-1; EÜ nr 231-100-4. Praeguste teaduslike teadmiste kohaselt ei suurenda pliist valmistatud seadmed vähi ega reproduktiivsüsteemi kahjustuste riski.

Võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoime kategooria	Kõrvaltoime alamkategooria
Veritsus	Hemorraagia/verejooks
	Hematoom
Ajukahjustus	Asümptomaatiline ajuemboolia
	Rabandus / ajuveresoonkonna tüsistus
	Transitoorne isheemiline atakk (TIA)
Emboolia	Õhkemboolia
	Võõrkeha emboolia
	Kopsuemboolia
	Tromboemboolia
	Tromboos/tromb
Südame perforatsioon	Kardiaalne tamponaad
	Perikardi efusioon
Kardiovaskulaarne vigastus	Klapikahjustus
	Aordi algusosa punkteerimine
	Arteri perforatsioon
Juhtimissüsteemi häire	SA-sõlm, AV-sõlm või His-Purkinje süsteemiplokk
	Südame rütmihäired
Immunoloogiline reaktsioon	Anafülaksia
Infektsioon	Perikardiit
	Endokardiit
	Kopsupõletik
	Sepsis
Valu/ ebamugavustunne	Valu kubemes, rinnus (üldine valu rinnus, mis ei ole seotud müokardiinfarktiga)
Perifeer-vaskulaarne kahjustus	Dissektsioon
	Latseratsioon
	Arteriovenoosse fistuli moodustumine
	Pseudoaneurüsmi moodustumine
Hüpotensioon	Ei kohaldu
Pindmine koekahjustus	Ei kohaldu

Suunised

Valmistage seade ette ja pange kokku

1. Eemaldage sisu pakendist.

   TÄHELEPANU. Ärge ühendage sisestushülssi ja dilataatorit.
2. Loputage dilataator ja sisestushülss hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.
3. Sulgege sisestushülsi sulgurkraan.
4. Eemaldage stilett nõelalt ja loputage nõela hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.
5. Pange stilett nõela sisse ja lukustage see jaoturile.

6. Sisestage dilataator täielikult transseptaalsesse sisestushülssi.

Sisestage sisestushülsi/dilataatori koost ülemisse õõnesveeni

1. Sisestage läbi reieveeni (eelistatavalt parempoolne).

   VALIKULINE. Tagamaks veeniteed seadme vahetuseks ja hemostaasiks, võib kasutada suurema standardpikkusega sisestushülssi (≥ 2,5 prantsuse suurust suurem kui transseptaalne sisestushülss).

2. Sisestage 0,032-tolline, 150–180 cm, 3 mm „J"-otsaga juhtetraat ülemisse õõnesveeni (SVC).

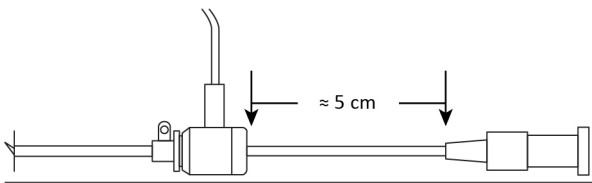
   TÄHELEPANU. 0,032 tolli on maksimaalne dilataatoriga kasutatava juhtetraadi läbimõõt.

3. Sisestage sisestushülsi ja dilataatori kost veeni juhtetraadi abil kuni sisestushülsi otsak on SVC-s. Orienteerige dilataatori otsa mediaalselt.

Asetage nõela/stileti koost sisestushülsi/ dilataatori koostu sisse

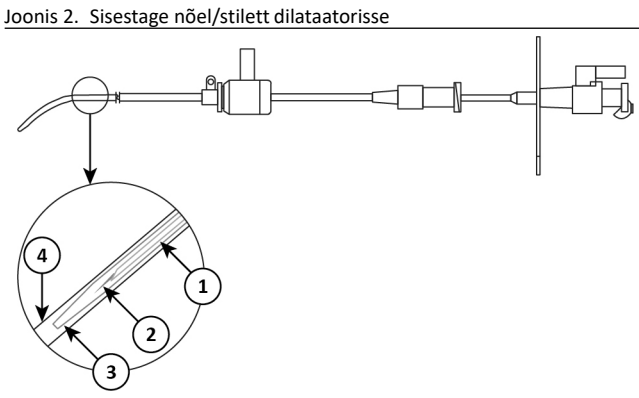
1. Eemaldage juhtetraat dilataatorist.
2. Aspireerige täielikult ja loputage seejärel dilataatorit heepariniseeritud soolalahusega.
3. Tõmmake dilataator umbes 5 cm tagasi (vt joonist allpool), et hõlbustada nõela kõveruse läbiminekut dilataatori ja sisestushülsi jäikadest jaoturitest.

Joonis 1. Tõmmake dilataator tagasi



4. Lukustage stilett jaoturi külge.
5. Sisestage nõela/stileti koost dilataatorisse. Viige nõela/stileti koost fluoroskoopia abil edasi, kuni see on sisestushülsi sees oleva dilataatori otsast umbes 2 cm kaugusel (vt allolevat joonist).

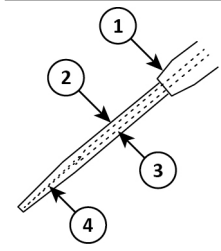
Joonis 2. Sisestage nõel/stilett dilataatorisse



1. Nõel
2. Stilett
3. Dilataatori ots
4. Sisestushülss

6. Ühendage sisestushülss ja dilataator uuesti, viies dilataatorit ja nõela/ stileti koostu samal ajal fluoroskoopia abil sisestushülssi. Veenduge, et nõela asukoht dilataatoris ei muutuks, kui mõlemad komponendid koos edasi liiguvad. Hoidke sisestushülsi otsa SVC-s.
7. Edastage fluoroskoopia abil nõela/stileti koost, kuni stilett asetseb dilataatori otsa lähedal (vt allolevat joonist).

Joonis 3. Nõela/stileti edasiviimine



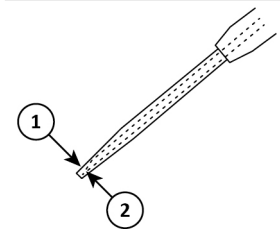
1. Sisestushülsi ots
2. Dilataator
3. Nõel
4. Stilett

8. Eemaldage stilett, ärge visake seda ära.
9. Aspireerige nõela, kuni ilmub veri. Visake süstal ära.

   TÄHELEPANU! Slip-tüüpi (mitte-Luer-Lok‡) süstla kasutamine võib aidata vältida õhu aspireerimist.

10. Loputage nõel puhta heepariniseeritud füsioloogilise lahusega. Sulgege kraan.
11. Lükake nõela fluoroskoopia abil edasi, kuni nõela ots on dilataatori otsa lähedal (vt allolevat joonist).

Joonis 4. Nõela otsa edasiviimine



1. Dilataatori ots
2. Nõela ots

VALIKULINE. Kinnitage nõela jaoturile 3-suunaline pöörlev sulgurkraan.

VALIKULINE. Kinnitage kraani külge radioaktiivse kontrastainega süstal. Aspireerige nõel. Seejärel laadige fluoroskoopia abil nõel kontrastainega.

VALIKULINE. Ühendage rõhu jälgimisliin sulgurkraaniga.

VALIKULINE. Kasutage kontrastaine, rõhu jälgimisseadme ja loputusliinide ühendamiseks standardset 3-avalist kollektorit.

Hõlmake ovaalmulk

1. Muutke anatoomilised tähised nähtavateks ja identifitseerige need.

2. Paigaldage korrektse nurga alla, paralleelseks mitraalklapi plaaniga ja ortogonaalseks vaheseina plaaniga. See on tavaliselt vasak anterioorne põikiprojektsioon (LAO), ligikaudu 30 kuni 40 kraadi.

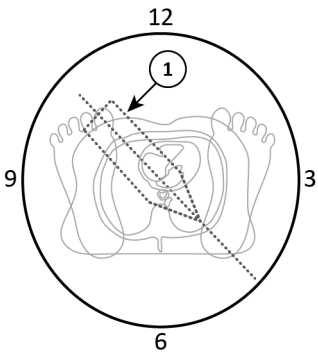
   VALIKULINE. Elektrofüsioloogiliste protseduuride ajal võivad koronaarne siinus ja His-kateetri positsioonid olla väga kasulikeks anatoomilisteks märgisteks. Korrektse LAO-vaate korral on koronaarse siinuse kateeter külgvaates. Korrektse parema anterioorse põikiprojektsiooni (RAO) korral on nähtaval His-kateetri külgvaade. Ovaalmulk asub His-kateetri kohal või natuke allpool ning koronaarsiinuse avause ülal ja taga.

   VALIKULINE. Angiograafilise/hemodünaamilise seasaba-jälgimiskateetri asetamine aordiklapi mittekoronaarsesse tippu võib olla kasulikuks anatoomiliseks tähiseks.

   VALIKULINE. Jälgige BRK™ transseptaalse nõela kaudu registreeritavat rõhu kõver.

3. Reguleerige nõela äärikut selliselt, et nõel oleks ovaalmulgu suhtes perpendikulaarne (tavaliselt kellaosutite 3 ja 5 vahel vaadatuna patsiendi jalgade juurest). (Vt allolevat joonist.)

Joonis 5. Nõela äärik

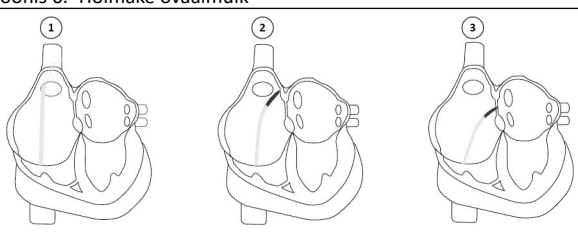


1. Nõela äärik

4. Veenduge fluoroskoopia abil, et nõela ots oleks dilataatori sees.
5. Pärast veendumist, et nõela ots asub dilataatori sees, tõmmake kogu sisestushülsi/dilataatori/nõela koostu aeglaselt. Vältige kõigi koostu osade nihkumist üksteise suhtes. Väga oluline on koostu tõmbamise vältel hoida nõela ääriku esialgset orientatsiooni.
6. LAO-vaates (kodadevahelise vaheseinaga ortogonaalselt) jälgige tõmbamise ajal dilataatori otsa äkilise mediaalse (või parempoolse) liikumise suhtes, mis osutab, et ots on hõlmanud ovaalmulgu. (Vt allolevaid jooniseid.)

   TÄHELEPANU! Kui ovaalmulk on hõlmatud, liigub dilataatori ots kerge vaevaga vasakusse südamekotta.

Joonis 6. Hõlmake ovaalmulk



1. Lähteasend SVC-s
2. Esialgne mediaalne liikumine RA-s
3. Järsk mediaalne liikumine ovaalmulgule

TÄHELEPANU! Kui rõhku jälgitakse läbi nõela, pidage meeles, et selles punktis ei oleks nõela rõhk täpne, sest nõela ots asub vastu ovaalmulku.

Punkteerige ovaalmulk BRK™ transseptaalse nõelaga

1. Enne nõela edasiliikumist veenduge, et sisestushülsi/dilataatori/nõela koostu asukoht ovaalmulgul oleks õige.
2. Pärast õige asukoha kinnitamist pikendage nõela täielikult sisestushülsi/dilataatori koostu ning edastage läbi kodadevahelise vaheseina.

   VALIKULINE. Rõhu jälgimise korral on vasakusse kotta sisenemine kinnitatud, kui rõhujälgimissüsteem näitab vasaku südamekoja rõhu kõverat.

   VALIKULINE. Vasakusse südamekotta sisenemist saab kinnitada ka kontrastainete ja fluoroskoobi abil.

3. Kui nõela edasiliikumisel on takistusi, tõmmake nõel tagasi ja määrake anatoomiliste märgistuste abil uuesti õige asukoht.

   ETTEVAATUST! Kui ilmneb perikardiaalne või aorti sisenemine, ärge edastage dilataatorit üle nõela. Kui nõel on tunginud läbi perikardi või aordi, tuleb see tagasi tõmmata. Jälgige hoolikalt elulisi näitajaid.

Edastage sisestushülsi/dilataatori koost vasakusse kotta

Hoides nõela asendit vasakus südamekojas, lükake sisestushülsi/dilataatori koost täielikult üle nõela vasaku südamekoja õõnsusesse.

Sisestage sisestushülss üle fikseeritud dilataatori ja nõela vasakusse südamekotta

1. Hoidke nõela ja dilataatori asendit läbi vaheseina.
2. Hoides dilataatorit fikseeritud asendis, lükake sisestushülss täielikult üle dilataatori vasakusse südamekotta.

Tõmmake BRK™ transseptaalne nõel ja dilataator tagasi

ETTEVAATUST! Sisestushülsi hemostaasiklapist objekte eemaldades on õhu sisseimbumise oht. Võtke kasutusele ettevaatusabinõud õhu sisseimbumise vältimiseks, eemaldades objekte aeglaselt, vältimaks sisestushülsis vaakumi tekkimist, ning jälgige fluoroskoobi abil sisestushülssi, tagades õhu sissetungimise korral seadme sisestamise.

1. Keerake nõela sulgurkraan väljalülitatud asendisse ja ühendage lahti kõik nõela jaoturi kinnitused.
2. Eemaldage BRK™ transseptaalne nõel dilataatorist. Nõela võib puhastada ja sellel protseduuril uuesti kasutada. Muidu kõrvaldage nõel kasutusest saastatud teravate esemete kõrvaldamise korra kohaselt.
3. Kinnitage süstal kohe dilataatorile ja aspireerige. Jätkake vere aspireerimist, samal ajal sisestushülssi õiges asendis hoides ja dilataatorit tagasi tõmmates. Ilmuv veri peaks olema arteriaalne veri.
4. Pärast dilataatori eemaldamist aspireerige veri läbi sisestushülsi külgharu. Õhumullide vältimiseks loputage sisestushülsi külgharu ettevaatlikult hepariniseeritud soolalahusega.
5. Sisestushülss asub nüüd vasakus südamekojas.

Pakend ja kõlblikkusaeg

BRK™ transseptaalne nõel tarnitakse steriilsena. Nõel on pakitud sisestatud stiletiga. Nõel ja stilett on pakitud esmasesse pakendisse. Algpakend on pandud Mylar‡ ja Tyvek‡ kotti, mis on kuumsuletud. Seejärel on pakend ja kasutusjuhend pandud karpi, mis on mõlemast otsast suletud. Nii taskul kui ka karbil on etikett tooteteabega, sh ka kõlblikkusajaga. Toodete kõlblikkusaeg on kolm aastat.

Kliiniliste andmete kokkuvõte

Euroopa Liidu riikidele. Teavitatud asutused avaldavad nende seadmete ohutuse ja kliinilise toimivuse (SSCP) kokkuvõtte aadressil https://ec.europa.eu/tools/eudamed EL MDR 2017/745 nõuete ja seotud ajakavade kohaselt. Otsige seadet seadme välispakendil oleva UDI-DI abil. UDI-DI on 14-kohaline arv kahe esimese sulgude komplekti vahel. Lisateavet UDI-DI leidmise ja kasutamise kohta leiate korduma kippuvate küsimuste dokumendist aadressilt medical.abbott/manuals.

Juhtumitest teatamine

Kui arvate, et selle seadme kasutamisel on juhtunud tõsine intsident, teatage sellest tootjale. Kui olete Euroopa Liidus asuv klient, siis teavitage tõsisest vahejuhtumist nii oma riigi vastavat pädevat ametiasutust kui ka tootjat.

Piiratud garantii

Abbott Medical garanteerib, et tavapärasel kasutamisel ei ole toodetel materjalide või valmistamisega seotud defekte. See garantii ei kehti pärast mis tahes tootesildil toodud „kõlblikkusaja“ kuupäeva möödumist. Iga meie toote lubatud kasutus ja heakskiidetud kasutusmeetodid on kirjas tootega kaasasolevas „kasutusjuhendis“. Abbott Medical ütleb lahti igasugusest vastutusest ja kohustusest, mis on seotud toodete lubamatu või heakskiitmata kasutusega. Ettevõtte Abbott Medical vastutus piirdub selle garantii korral oma toodete asendamisega. See garantii välistab ja asendab kõik otsesed või kaudsed garantiid, sh (loend pole lõplik) kaudsed garantiid turustatavuse või konkreetseks eesmärgiks sobivuse kohta. Kui seadusega pole sõnaselgelt teisiti sätestatud, ei vastuta Abbott Medical ühegi ettenägematu või kaudse kahjumi, kahju või kulu eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt selle toote kasutamisest. Abbott Medical ei võta endale ega volita ühtegi teist isikut võtma ettevõttele mingit muud või lisavastutust selle tootega seotud kahjumite, kahjude või kulude korral. Lisateabe saamiseks tutvuge ettevõtte Abbott Medical täieliku garantii põhimõtetega, mille saate ettevõtte Abbott Medical käest ja mis on saadaval ettevõtte Abbott Medical arve tagaküljel.

Sümbolid

Tootel või toote märgistusel võivad esineda allolevad ja harmoneeritud sümbolid. Ühtlustatud sümbolid leiate universaalsete sümbolite sõnastikust aadressil medical.abbott/manuals.

Tingmärk	Määratlus
Series	Seeriad
Contents	Sisukord
Transseptal Needle	Transseptaalne nõel
	Ühekordne steriilne barjäärisüsteem
	Pikkus
Rx ONLY	ETTEVAATUST! USA föderaalseaduse järgi võib seda seadet müüa ainult arst või arsti ettekirjutusel.
CE 2797	Conformité Européenne (vastab Euroopa nõuetele). Kinnitatud Euroopa Nõukogu määruse 2017/745 kohaselt. Abbott Medical deklareerib, et seade on kooskõlas selle määruse oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega.
	Maaletooja
UK CA 0086	Ühendkuningriigi vastavust on hinnatud
UKRP	Vastutav isik Ühendkuningriigis
UA.TR.101	Ukraina tehniliste eeskirjade vastavusmärgis, kus 101 on hindamisasutus.
MD	Meditsiiniseade
UDI	Seadme kordumatu tunnusnumber
medical.abbott/manuals	Järgige sellel veebisaidil olevat kasutusjuhendit
(7440-48-4) (7439-92-1)	Sisaldab ohtlikke aineid. (Koobalt, CAS nr 7440-48-4) (Elektroodjuhe, CAS nr 7439-92-1)

FI: Suomi

BRK™ Transseptaalinen neula

Käyttöohjeet

Kuvaus

Transseptaalinen BRK™-neula koostuu ruostumattomasta teräksestä valmistetusta luminaalisesta neulasta ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta tukevasta mandriinista. Neulan distaaliosa on kaareva, mikä helpottaa sijoittamista sydämeen, kun neulaa käytetään yhdessä Abbott Medicalin transseptaalisen holkkisarjan kanssa. Tässä kaarevassa osassa on kohta, jossa neulan ulkohalkaisija kapenee äkillisesti sopiakseen yhteen Abbott Medicalin transseptaalisen holkkisarjan laajentimen sisähalkaisijan kanssa. Neulan distaalipää on viistottu punktion helpottamiseksi. Neulan proksimaalipäässä on osoitinreunus (joka ilmaisee distaalisen kaaren suunnan) ja 2-suuntainen sulkuhana, jonka kautta voi aspiroida neulan luumenin, ruiskuttaa/infusoida nestettä, ottaa verinäytteitä, seurata verenpainetta ja viedä sisään mandriinin ja/tai ohjainlangan (ohjainlangan enimmäishalkaisija 18 gaugen neulalle on 0,014 tuumaa; ohjainlangan enimmäishalkaisija 19 gaugen neulalle on 0,012 tuumaa). Mandriini on suora ja sen halkaisija on sama koko pituudelta. Mandriinin proksimaalipäässä on kaareva kiinnitin, joka kiinnittyy proksimaaliseen neulan kantaan, kun mandriini työnnetään neulan luumeniin. Mandriini on suunniteltu helpottamaan neulan eteenpäin viemistä laajentimessa. Neulaa on saatavana useina eri pituuksina ja distaalikaaren kokoonpanoina.

Käyttötarkoitus

Transseptaalinen BRK™-neula on tarkoitettu käytettäväksi eteisten välisen väliseinän punktointiin, jotta saavutetaan pääsy sydämen vasemmalle puolelle.

Käyttöindikaatiot

Transseptaalista BRK™-neulaa käytetään eteisten välisen väliseinän punktointiin transseptaalisen katetrisaation yhteydessä, jotta saavutetaan pääsy sydämen vasemmalle puolelle.

Potilaskohderyhmä

Transseptaalinen BRK™-neula on tarkoitettu käytettäväksi hemodynaamisesti vakailla potilailla, joille on vietävä katetri sydämen vasemmalle puolelle. Transseptaalisen BRK™-neulan käyttö saattaa edellyttää erityistä harkintaa potilailla, joilla on seuraavia terveydellisiä tiloja:

- Sydämen kiertymä
- Laajentunut aortan tyvi
- Selvä oikean eteisen laajentuma
- Skolioosi/kyfoosi
- Poikkeava vasemman eteisen geometria
- Synnynnäiset epämuodostumat
- Verisuonten epämuodostumat
- Rakenne, joka estää oikeaan eteiseen pääsyn alaonttolaskimon kautta

Tarkoitettu käyttäjä

Tätä laitetta saavat käyttää vain transseptaalisiin toimenpiteisiin koulutuksen saaneet lääkärit täysin varustellussa ja toiminnassa olevassa elektrofysiologian laboratoriossa.

Kliiniset edut

Transseptaalisen BRK™-neulan tavoiteltu kliininen etu on eteisten välisen väliseinän punktointi transseptaalisen katetrisaation yhteydessä, jotta saavutetaan pääsy sydämen vasemmalle puolelle. Tämä on tarpeen, jotta laitteet, joiden käyttö edellyttää endokardiaalista pääsyä sydämen vasemmalle puolelle, kuten ablaatiokatetri, saavuttaisivat tarkoitetun kliinisen hyödyn. Hyödyn arviointi perustuu eteisten välisen väliseinän onnistuneeseen punktointiin.

Kontraindikaatiot

- Aiempi eteisten välinen septaalinen korjaus tai proteettinen eteisväliseinäaukon sulkulaite.
- Mikä tahansa aiempi tromboembolinen tapahtuma.
- Tiedossa oleva tai epäilty vasemman eteisen myksooma.
- Tiedossa oleva tai epäilty sydäninfarkti edeltävien kahden viikon aikana.
- Epästabiili angina pectoris.
- Viimeaikainen aivoverenkiertohäiriö.
- Potilaan kykenemättömyys sietää antikoagulaatiohoitoa.
- Potilaalla oleva aktiivinen infektio.

Varoitukset

- Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
- Laite on kertakäyttöinen. Sitä ei saa käsitellä tai käyttää uudelleen. Tarkista tuotteen “viimeinen käyttöpäivä” pakkauksesta. Tämän järjestelmän uudelleensterilointi ja uudelleenkäyttö voi heikentää sen eheyttä. Epästeriilien osien käytön aiheuttamia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi:
  - Paikallinen ja systeeminen infektio tai reaktio
  - Mekaaninen vaurio
  - Laitteen virheellinen toiminta.
- Alla tuotekohtaisesti luetellut materiaalit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita tai yliherkkyysreaktioita. Tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion henkilöille, jotka ovat allergisia näille materiaaleille. Ennen kuin laitetta käytetään potilaalle, potilaalle tulee kertoa laitteen sisältämistä materiaaleista ja potilaan allergiahistoria tulee selvittää perusteellisesti:
  - Ruostumaton teräs
  - Epoksiliima
  - Nikkeli-kromipinnoitettu messinki
  - Alipaineen kestävä silikonirasva (DuPont)
  - Master Bond
- Tämän laitteen väärinkäyttö voi johtaa vakaviin komplikaatioihin.
- Sydämen katetrointitoimenpiteet saattavat altistaa sekä potilaat että laboratoriohenkilöstön merkittävälle määrälle röntgensäteilyä. Tämä voi aiheuttaa akuutin säteilyvamman ja lisätä somaattisten ja geneettisten haittavaikutusten riskiä, joka määräytyy röntgensäteen voimakkuuden ja läpivalaisujaksojen keston mukaan. Harkitse huolellisesti tämän laitteen käyttöä raskaana oleville naisille.

Varotoimet

- Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän tuotteen saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Tarkasta pakkaus ennen käyttöä. Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on auennut tai vahingoittunut.
- Tarkasta kaikki osat ennen käyttöä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa valolta suojattuna.

- Ennen toimenpidettä potilaan on oltava hemodynaamisesti vakaa. Tietyissä tilanteissa tämän tuotteen käyttö saattaa edellyttää erityistä harkintaa. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
  - Sydämen kiertymä
  - Laajentunut aortan tyvi
  - Selvä oikean eteisen laajentuma
  - Skolioosi/kyfoosi
  - Poikkeava vasemman eteisen geometria
  - Synnynnäiset epämuodostumat
  - Verisuonten epämuodostumat
  - Rakenne, joka estää oikeaan eteiseen pääsyn alaonttolaskimon kautta
- Tätä laitetta saavat käyttää vain transseptaalisiin toimenpiteisiin koulutuksen saaneet lääkärit täysin varustellussa ja toiminnassa olevassa elektrofysiologian (EP) laboratoriossa.
- Katetrin eteenpäin vieminen tulee tehdä läpivalaisuohjauksessa sydämen vaurioitumis-, perforaatio- ja tamponaatioriskien minimoimiseksi. Lisäksi voidaan harkita yhteensopivia navigointijärjestelmiä ja reaaliaikaisia visualisointijärjestelmiä.
- Tarkista, tuntuuko sisäänviennin aikana liiallista vastusta, kun neulan kärki liikkuu holkki/laajenninkokoonpanon kaaren läpi. Jos neulan edetessä tuntuu vastusta, vedä neula ulos ja arvioi komponenttien kunto.
- Vältä laitteen liiallista taivuttamista sisäänviennin aikana. Se voi estää neulan etenemisen ja neula saattaa tahattomasti puhkaista laajennin/holkkiyhdistelmän.
- Käytä aina asennuksen aikana mandriinia helpottamaan neulan etenemistä laajennin/holkkiyhdistelmän läpi. Jos mandriinia ei käytetä, neulan eteneminen voi estyä ja neula saattaa tahattomasti puhkaista laajennin/holkkiyhdistelmän tai kaapia materiaalia laajentimen sisäpinnasta.
- Jos neula päätyy sydänpussiin tai aorttaan, älä vie laajenninta eteenpäin neulaa pitkin. Jos neula on päätynyt sydänpussiin tai aorttaan, se on vedettävä pois. Seuraa tarkasti elintoimintoja.
- Välineiden vetäminen pois holkin hemostaasiventtiilin kautta aiheuttaa ilman sisään tunkeutumisen riskin. Ehkäise ilman sisään tunkeutuminen vetämällä välineet hitaasti, jolloin holkkiin ei muodostu alipainetta, ja tarkkaile holkkia läpivalaisun avulla seuraavan laitteen sisäänviennin aikana havaitaksesi mahdolliset ilmakuplat.
- Käytön jälkeen tämä laite, sen lisävarusteet ja pakkaus tulee luokitella asianmukaisesti hävittämistä varten, esimerkiksi biovaaralliseksi, teräviä esineitä sisältäväksi tai vaarattomaksi jätteeksi, ja ne tulee hävittää huolellisesti laitoksen käytäntöjen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.
- Yksi tai useampi tämän laitteen komponentti saattaa sisältää seuraavaa CMR 1B -luokiteltua ainetta yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena: Kobolti: Chemical Abstracts Service (CAS) -nro 7440-48-4; EY-nro 231-158-0. Tämänhetkinen tieteellinen aineisto tukee oletusta, että kobolttiseoksista tai kobolttia sisältävistä ruostumattoman teräksen seoksista valmistetut lääketieteelliset laitteet eivät lisää syöpäriskiä tai lisääntymiseen liittyviä riskejä.

  Yksi tai useampi tämän laitteen komponentti saattaa sisältää seuraavaa CMR 1A -luokiteltua ainetta yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena: Lyijy: Chemical Abstracts Service (CAS) -nro 7439-92-1; EY-nro 231-100-4. Tämänhetkinen tieteellinen aineisto tukee oletusta, että lyijystä valmistetut lääketieteelliset laitteet eivät lisää syöpäriskiä tai lisääntymiseen liittyviä riskejä.

Mahdolliset haittavaikutukset

Haittavaikutuksen luokka	Haittavaikutusluokan alaluokka
Verenvuoto	Verenvuoto
	Hematooma
Aivovamma	Oireeton aivojen embolia
	Aivohalvaus/aivoverenkiertohäiriö
	Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA)
Embolia	Ilmaembolia
	Vierasesine-embolia
	Keuhkoembolia
	Tromboembolia
	Tromboosi/trombi
Sydämen perforaatio	Sydämen tamponaatio
	Sydänpussin nestepurkauma
Sydän- ja verisuonivauriot	Läppävaurio
	Aortan tyven punktio
	Eteisen perforaatio
Johtoratajärjestelmän häiriö	Sinussolmukkeen, eteis-kammiosolmukkeen tai His-Purkinje-järjestelmän katkos
	Sydämen rytmihäiriöt
Immunologinen reaktio	Anafylaksia
Infektio	Sydänpussitulehdus
	Endokardiitti
	Keuhkokuume
	Sepsis
Kipu/epämukavuus	Kipu, nivus, rintakehä (yleinen rintakipu, joka ei liity sydäninfarktiin)
Perifeerinen verisuonivaurio	Dissektio
	Laseraatio
	Valtimo-laskimofistelin muodostuminen
	Pseudoaneurysman muodostuminen
Hypotensio	–
Pinnallinen kudosvaurio	–

Ohjeet

Laitteen valmistelu ja asennus

1. Poista sisältö pakkauksesta.

   HUOMAUTUS: Älä asenna holkkia ja laajenninta.

2. Huuhtele laajennin ja holkki heparinisoidulla keittosuolaliuoksella.
3. Sulje holkin sulkuhana.

4. Irrota mandriini neulasta ja huuhtele neula heparinisoidulla keittosuolaliuoksella.
5. Työnnä mandriini neulaan ja lukitse se kantaan.
6. Työnnä laajennin kokonaan transseptaalisen holkin sisään.

Holkki-/laajenninkokoonpanon vienti yläonttolaskimoon

1. Muodosta sisäänvientikohta reisilaskimoon (on suositeltavaa käyttää oikean puolen reisilaskimoa).

   VAIHTOEHTO: Voit käyttää suurempaa (≥2,5 French-kokoa suurempaa kuin transseptaalinen holkki) vakiopituista holkkia sisäänvientikohdan luontiin ja ylläpitoon laitteen vaihtoa ja hemostaasia varten.

2. Vie 0,032 tuuman, 150–180 cm:n, 3 mm:n "J"-kärkinen ohjainlanka yläonttolaskimoon (SVC).

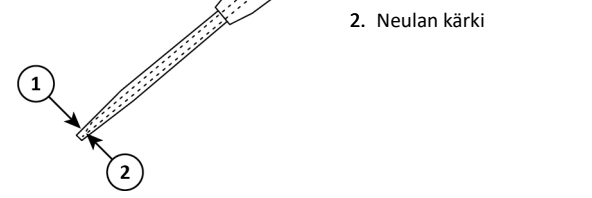
   HUOMAUTUS: 0,032 tuumaa on laajentimen kanssa käytettävän ohjainlangan enimmäishalkaisija.

3. Työnnä holkkia/laajenninta ohjainlankaa pitkin, kunnes holkin kärki on yläonttolaskimossa. Suuntaa laajentimen kärki mediaalisesti.

Neula/mandriinikokoonpanon sijoittaminen holkki/laajenninkokoonpanon sisään

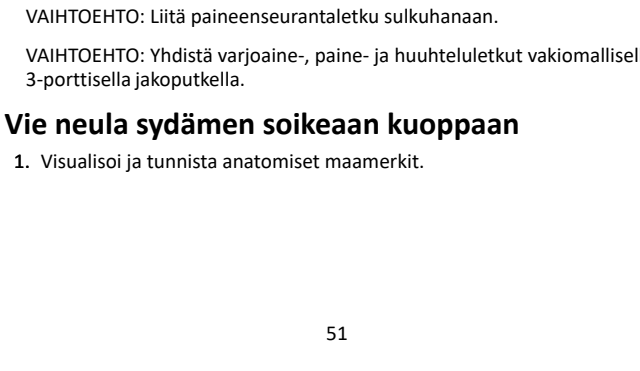
1. Poista ohjainlanka laajentimesta.
2. Aspiroi laajennin kokonaan ja huuhtele se sitten heparinisoidulla keittosuolaliuoksella.
3. Vedä laajenninta noin 5 cm (katso seuraava kuva) helpottaaksesi neulan kaaren etenemistä laajentimen ja holkin jäykkien kantojen läpi.

Kuva 1. Vedä laajennin ulos



4. Lukitse mandriini kantaan.
5. Työnnä neula/mandriini laajentimen sisään. Työnnä neulaa/mandriinia sisään läpivalaisussa, kunnes se on noin 2 cm:n päässä laajentimen kärjestä holkin sisällä (katso seuraava kuva).

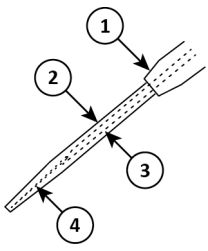
Kuva 2. Työnnä neula/mandriini laajentimen sisään



1. Neula
2. Mandriini
3. Laajentimen kärki
4. Holkki

6. Liitä holkki ja laajennin uudelleen toisiinsa työntämällä laajenninta ja neulaa/mandriinia samanaikaisesti holkkiin läpivalaisussa. Varmista, ettei neulan sijainti suhteessa laajentimeen muutu, kun molempia komponentteja työnnetään yhdessä eteenpäin. Säilytä holkin kärjen asento yläonttolaskimossa.
7. Työnnä neulaa/mandriinia sisään läpivalaisussa, kunnes mandriini on aivan laajentimen kärjen proksimaalisella puolella (katso seuraava kuva).

Kuva 3. Työnnä neulaa/mandriinia eteenpäin



1. Holkin kärki
2. Laajennin
3. Neula
4. Mandriini

8. Irrota mandriini, älä heitä sitä pois.
9. Aspiroi neulaa, kunnes näet veren palaavan. Hävitä ruisku.

   HUOMAUTUS: Slip-kärkisen ruiskun käyttö (Luer-Lok‡-ruiskun asemesta) saattaa estää ilman aspiroimisen.

10. Huuhtele neula heparinisoidulla keittosuolaliuoksella. Sulje sulkuhana.
11. Työnnä neulaa sisään läpivalaisussa, kunnes neulan kärki on aivan laajentimen kärjen proksimaalisella puolella (katso seuraava kuva).

Kuva 4. Vie neulan kärkeä eteenpäin

1. Laajentimen kärki
2. Neulan kärki

VAIHTOEHTO: Liitä kiertyvä kolmitiehana neulan kantaan.

VAIHTOEHTO: Liitä röntgenpositiivisella varjoaineella täytetty ruisku sulkuhanaan. Aspiroi neula. Täytä sitten neula varjoaineella valvoen toimenpidettä läpivalaisussa.

VAIHTOEHTO: Liitä paineenseurantaletku sulkuhanaan.

VAIHTOEHTO: Yhdistä varjoaine-, paine- ja huuhteluletkut vakiomallisella 3-porttisella jakoputkella.

Vie neula sydämen soikeaan kuoppaan

1. Visualisoi ja tunnista anatomiset maamerkit.

2. Aseta läpivalaisulaite hiippaläpän tason suuntaiseen kulmaan ja kohtisuoraan väliseinän tasoon nähden. Tämä on tavallisesti noin 30–40 astetta viistoon vasemmalle anteriorisesti (LAO).

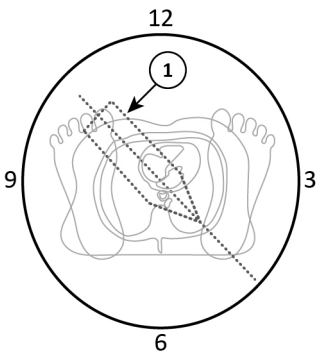
   VAIHTOEHTO: Elektrofysiologisten toimenpiteiden aikana katetrien paikat sepelpoukamassa ja eteis-kammiokimpussa voivat toimia hyödyllisinä anatomisina maamerkkeinä. Asianmukaisessa LAO-näkymässä sepelpoukaman katetri näkyy profiilissa. Asianmukaisessa RAO-näkymässä (viistoon oikealle anteriorisesti) eteis-kammiokimpun katetri näkyy profiilissa. Sydämen soikea kuoppa on eteis-kammiokimpun katetrin tasolla tai hiukan sen alapuolella, superiorisesti ja posteriorisesti sepelpoukaman aukkoon nähden.

   VAIHTOEHTO: Aorttaläpän ei-koronaariseen liuskaan asetettu angiografinen/hemodynaaminen siansaparo-seurantakatetri voi toimia hyödyllisenä anatomisena maamerkkinä.

   VAIHTOEHTO: Tarkkaile transseptaalisen BRK™-neulan kautta tallennettavaa painekäyrää.

3. Säädä osoitinreunusta niin, että neula on kohtisuorassa sydämen soikeaan kuoppaan nähden (tyypillisesti kello 3:n ja 5:n välillä potilaan jalkojen suunnasta katsottuna). (Katso seuraava kuva.)

Kuva 5. Neulan osoitinreunus



1. Neulan osoitinreunus

4. Varmista läpivalaisulla, että neulan kärki on laajentimen sisällä.
5. Kun olet varmistanut, että neulan kärki on laajentimen sisällä, vedä koko holkki/laajennin/neulakokoonpanoa hitaasti. Estä kokoonpanon osia liikkumasta suhteessa toisiinsa. On tärkeää säilyttää osoitinreunuksen aiempi suunta kokoonpanoa vedettäessä.
6. Tarkkaile laajentimen kärkeä LAO-näkymässä (kohtisuorassa eteisten väliseen väliseinään nähden) vetämisen aikana äkillisen mediaalisen (tai oikealle suuntautuvan) liikkeen varalta, koska tämä osoittaa kärjen olevan sydämen soikeassa kuopassa. (Katso seuraavat kuvat.)

   HUOMAUTUS: Jos sydämen soikea kuoppa on koettimella avattavissa, laajentimen kärki siirtyy nyt helposti vasempaan eteiseen.

Kuva 6. Vie neula sydämen soikeaan kuoppaan



1. Aloitusasento yläonttolaskimossa
2. Alkuvaiheen mediaalinen liike oikeassa eteisessä
3. Äkillinen mediaalinen liike sydämen soikeaan kuoppaan

HUOMAUTUS: Jos painetta seurataan neulan kautta, on huomattava, että neulan kautta mitattu painelukema on tässä vaiheessa epätarkka, koska kärki on sydämen soikeaa kuoppaa vasten.

Sydämen soikean kuopan punktointi transseptaalisella BRK™-neulalla

1. Varmista holkki/laajennin/neulakokoonpanon oikea sijainti sydämen soikeassa kuopassa ennen neulan työntämistä eteenpäin.
2. Kun oikea sijainti on varmistettu, työnnä neulaa eteenpäin holkki/laajennin/neulakokoonpanon sisällä ja jatka neulan työntämistä eteisten välisen väliseinän läpi.

   VAIHTOEHTO: Paineenseurannan avulla pääsy vasempaan eteiseen voidaan varmistaa siitä, että paineenseurannan käyrä vastaa vasemman eteisen painetta.

   VAIHTOEHTO: Pääsy vasempaan eteiseen voidaan varmistaa läpivalaisun ja varjoaineinjektion avulla.

3. Jos neulan edetessä tuntuu vastusta, vedä neula takaisin ja arvioi uudelleen anatomiset maamerkit.

   HUOMIO: Jos neula päätyy sydänpussiin tai aorttaan, älä vie laajenninta eteenpäin neulaa pitkin. Jos neula on päätynyt sydänpussiin tai aorttaan, se on vedettävä pois. Seuraa tarkasti elintoimintoja.

Holkki/laajenninkokoonpanon vienti vasempaan eteiseen

Pidä neula paikallaan vasemmassa eteisessä ja vie holkki/laajenninkokoonpano neulaa pitkin vasemman eteisen onteloon asti.

Holkin vienti paikallaan olevaa laajenninta ja neulaa pitkin vasempaan eteiseen

1. Pidä neula ja laajennin paikoillaan väliseinän kohdalla.
2. Pidä laajenninta paikoillaan ja vie holkki laajenninta pitkin kokonaan vasemman eteisen onteloon.

Vedä transseptaalinen BRK™-neula ja laajennin ulos

HUOMIO: Välineiden vetäminen pois holkin hemostaasiventtiilin kautta aiheuttaa ilman sisään tunkeutumisen riskin. Ehkäise ilman sisään tunkeutuminen vetämällä välineet hitaasti, jolloin holkkiin ei muodostu alipainetta, ja tarkkaile holkkia läpivalaisun avulla seuraavan laitteen sisäänviennin aikana havaitaksesi mahdolliset ilmakuplat.

1. Käännä neulan sulkuhana Off-asentoon ja irrota kaikki neulan kantaan liitetyt laitteet.
2. Poista transseptaalinen BRK™-neula laajentimesta. Neula voidaan puhdistaa ja asettaa syrjään käytettäväksi uudelleen saman toimenpiteen aikana. Muussa tapauksessa neula on hävitettävä tartuntavaarallisten terävien esineiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
3. Liitä laajentimeen välittömästi ruisku ja aspiroi. Jatka veren aspiroimista samalla, kun pidät holkkia paikoillaan ja vedät laajentimen pois. Veren tulee olla valtimoverta.
4. Kun laajennin on poistettu, aspiroi verta holkin sivuvarren kautta. Huuhtele holkin sivuvarsi huolellisesti heparinisoidulla keittosuolaliuoksella, että vältät ilmakuplien muodostumisen.
5. Holkki on nyt paikoillaan vasemmassa eteisessä.

Pakkaus ja varastointiaika

Transseptaalinen BRK™-neula toimitetaan steriilinä. Neula on pakkauksessa mandriiniin kiinnitettynä. Neula ja mandriini on suljettu ensisijaiseen pakkaukseen. Ensisijainen pakkaus on suljettu kuumasaumattuun Mylar‡- ja Tyvek‡-pussiin. Pussi ja nämä käyttöohjeet on sitten pakattu molemmista päistään suljettuun laatikkoon. Sekä pussissa että laatikossa on tuotetiedot sisältävä etiketti, josta ilmenee myös viimeinen käyttöpäivä. Tuotteiden ilmoitettu varastointiaika on kolme vuotta.

Kliinisten tietojen yhteenveto

Euroopan unionin maat: Ilmoitetut laitokset julkaisevat näiden laitteiden turvallisuuden ja kliinisen toimivuuden yhteenvedon (SSCP) osoitteessa https://ec.europa.eu/tools/eudamed EU:n MDR-asetuksen 2017/745 vaatimusten ja niihin liittyvien aikataulujen mukaisesti. Hae laitetta käyttämällä ulkopakkauksessa olevaa UDI-DI-tunnusta. UDI-DI-tunnus on 14 merkin pituinen numerosarja kahden ensimmäisen sulkuihin merkityn merkkijonon välissä. Lisätietoja UDI-DI-tunnuksen löytämisestä ja käyttämisestä on Usein esitettyjä kysymyksiä -asiakirjassa osoitteessa medical.abbott/manuals.

Ongelmista ilmoittaminen

Jos sinulla on tätä laitetta käyttäessäsi syytä epäillä, että on ilmennyt vakava ongelma, ilmoita siitä valmistajalle. Euroopan unionissa toimivien asiakkaiden tulee ilmoittaa ongelmasta valmistajan lisäksi kansallisille viranomaisille.

Rajoitettu takuu

Abbott Medical takaa, ettei sen tuotteissa esiinny normaalikäytössä materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu ei ole voimassa tuotteeseen merkityn “Eräpäivän” jälkeen. Kunkin tuotteemme käyttötarkoitus ja hyväksytyt käyttötavat on kuvattu vastaavissa “Käyttöohjeissa”, jotka toimitetaan jokaisen tuotteen mukana. Abbott Medical sanoutuu irti kaikesta vastuusta, jos sen tuotteita käytetään tavalla, jota ei ole sallittu tai hyväksytty. Abbott Medicalin vastuu rajoittuu tämän takuun nojalla sen tuotteiden vaihtamiseen. Edellä kuvattu takuu poissulkee ja korvaa kaikki muut takuut, sekä nimenomaiset että hiljaiset, mukaan lukien muun muassa kaikki epäsuorat takuut kaupallisesta käytöstä tai soveltuvuudesta erityiseen käyttötarkoitukseen. Abbott Medical sanoutuu irti kaikesta vastuusta liittyen kaikkiin satunnaisiin tai välillisiin menetyksiin, vahinkoihin tai kustannuksiin, jotka suoraan tai välillisesti johtuvat tämän tuotteen käytöstä, muutoin kuin mitä nimenomaisesti on erityisessä laissa määrätty. Abbott Medical ei ota eikä valtuuta ketään toista henkilöä ottamaan mitään muuta vastuuta tai lisävastuuta tähän tuotteeseen liittyvästä menetyksestä, vahingosta tai kulusta. Lisätietoja on Abbott Medicalin täydellisissä takuuehdoissa, jotka voi pyytää Abbott Medicalilta tai jotka ovat nähtävissä Abbott Medicalin laskun kääntöpuolella.

Symbolit

Tuotteessa ja tuote-etiketissä saattaa olla seuraavia symboleita sekä yhdenmukaistettuja symboleita. Tietoja yhdenmukaistetuista symboleista on sivuston medical.abbott/manuals kohdassa Universal Symbols Glossary (yleinen symbolisanasto).

Symboli	Kuvaus
Series	Sarja
Contents	Sisältö
Transseptal Needle	Transseptaalinen neula
	Yksi steriili sulkujärjestelmä
	Pituus
℞ ONLY	HUOMIO: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän tuotteen saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
CE 2797	Conformité Européenne (eurooppalainen yhdenmukaisuus). Merkitty Euroopan unionin asetuksen 2017/745 mukaisesti. Abbott Medical ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa tämän asetuksen olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.
	Maahantuoja
UK CA 0086	Ison-Britannian vaatimustenmukaisuus arvioitu
UKRP	Vastaava henkilö Isossa-Britanniassa
UA.TR.101	Ukrainan teknisten määräysten vaatimustenmukaisuusmerkintä, jossa 101 on arviointilaitos.
MD	Lääkintälaite
UDI	Yksilöllinen laitteen tunniste
medical.abbott/manuals	Lue käyttöohjeet tältä verkkosivustolta
(7440-48-4) (7439-92-1)	Sisältää vaarallisia aineita. (Cobalt CAS-nro 7440-48-4) (Lyijy CAS-nro 7439-92-1)

FR: Français

BRK™ Aiguille transseptale

Mode d'emploi

Description

L'aiguille transseptale BRK™ se compose d'une aiguille intracavitaire en acier inoxydable et d'un stylet en acier inoxydable massif. La partie distale de l'aiguille est recourbée pour faciliter sa mise en place à l'intérieur du cœur lorsqu'elle est utilisée avec un ensemble de gaine transseptale d'Abbott Medical. La partie recourbée présente une réduction abrupte du diamètre externe de l'aiguille de façon à correspondre au diamètre interne du dilatateur fourni dans un ensemble de gaine transseptale d'Abbott Medical. L'extrémité distale de l'aiguille est biseautée pour faciliter la ponction. L'extrémité proximale de l'aiguille est configurée avec une collerette du pointeur (indiquant l'orientation de la courbe distale) et est munie d'un robinet à 2 voies pour assurer l'accès à la lumière de l'aiguille en vue de l'aspiration, de l'injection/perfusion de liquide, des prélèvements sanguins, du monitorage de la pression et de l'insertion du stylet et/ou d'un guide (0,014 pouce [0,36 mm] de diamètre maximum pour une aiguille de calibre 18 ; guide d'un diamètre maximum de 0,012 pouce [0,30 mm] pour une aiguille de calibre 19). Le stylet est droit et isodiamétrique sur toute sa longueur. L'extrémité proximale du stylet est dotée d'une attache recourbée qui s'enclenche dans l'embase proximale de l'aiguille lors de l'insertion dans la lumière de l'aiguille. Le stylet est conçu de façon à faciliter l'avancement de l'aiguille à l'intérieur du dilatateur. L'aiguille existe en plusieurs longueurs utiles avec différentes configurations de la courbure distale.

Usage prévu

L'aiguille transseptale BRK™ est destinée à être utilisée pour percer le septum interauriculaire afin d'accéder au cœur gauche.

Indications d'utilisation

L'aiguille transseptale BRK™ s'utilise pour effectuer la ponction du septum interauriculaire lors d'une intervention de cathétérisme transseptal visant à assurer l'accès au cœur gauche.

Groupe ciblé de patients

L'aiguille transseptale BRK™ est destinée à être utilisée chez des patients hémodynamiquement stables nécessitant un accès au cathéter cardiaque gauche. L'utilisation de l'aiguille transseptale BRK™ peut nécessiter une attention particulière chez les patients présentant les conditions suivantes :

- Rotation du cœur
- Hypertrophie de la racine aortique
- Hypertrophie importante de l'oreillette droite
- Scoliose/cyphose
- Configuration anormale de l'oreillette gauche
- Malformations congénitales
- Malformations vasculaires
- Impossibilité d'accéder à l'oreillette droite par la veine cave inférieure

Utilisateurs visés

Ce dispositif doit être utilisé uniquement par des médecins spécialement formés aux procédures transseptales, dans un laboratoire d'électrophysiologie opérationnel entièrement équipé.

Avantages cliniques

L'avantage clinique prévu de l'aiguille transseptale BRK™ est de percer le septum interauriculaire pendant une procédure de cathétérisme transseptal pour obtenir un accès au cœur gauche afin de permettre aux dispositifs nécessitant un accès cardiaque endocardique du côté gauche d'atteindre l'avantage clinique prévu, comme un cathéter d'ablation. Ceci est mesuré par une ponction réussie du septum interauriculaire.

Contre-indications

- Antécédents de plaque septale interauriculaire ou de système prothétique de fermeture de la communication auriculaire.
- Antécédents de thrombo-embolie.
- Myxome auriculaire connu ou soupçonné.
- Infarctus du myocarde connu ou soupçonné au cours des deux dernières semaines.
- Angor instable.
- Accident vasculaire cérébral (AVC) récent.
- Patients ne supportant pas les traitements anticoagulants.
- Les patients présentant une infection active.

Avertissements

- Ne pas modifier ce dispositif.
- Ce dispositif est destiné à un usage unique seulement ; ne pas le retraiter ou le réutiliser. Noter la date « À utiliser avant » du produit sur l'emballage. Toute tentative de restérilisation et de réutilisation de ce système peut en compromettre l'intégrité. Les effets indésirables peuvent notamment comprendre les effets suivants :
  - Infection et réaction locale ou systémique
  - Dommages mécaniques
  - Fonctionnement imprécis
- Les matériaux identifiés ci-dessous par produit peuvent provoquer des réactions allergiques ou d'hypersensibilité. Les personnes allergiques à ces matériaux peuvent développer une réaction allergique à ce produit. Avant son utilisation sur le patient, celui-ci doit être informé des matériaux contenus dans le dispositif et un historique complet des allergies doit faire l'objet d'une discussion :
  - Acier inoxydable
  - Adhésif époxy
  - Laiton nickelé chromé
  - Graisse silicone pour vide poussé (Dupont)
  - Master Bond
- Un mauvais usage de ce dispositif peut entraîner des complications graves.
- Tant pour les patients que pour le personnel du laboratoire, les procédures de cathétérisme cardiaque sont susceptibles d'entraîner une exposition importante aux rayons-X, ce qui peut provoquer un syndrome d'irradiation aiguë, ainsi qu'un risque accru d'effets somatiques et génétiques, cela en raison de l'intensité du faisceau des rayons-X et de la durée de l'imagerie fluoroscopique. Réfléchir attentivement l'utilisation de ce dispositif chez les femmes enceintes.

Précautions

- Conformément à la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.
- Lire les instructions avant d'utiliser le câble.
- Avant toute utilisation, inspecter l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

- Inspecter tous les composants avant utilisation.
- Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
- Avant l'intervention, le patient doit être stable sur le plan hémodynamique. Lors de l'utilisation du produit, certaines affections nécessitent une attention particulière. Celles-ci comprennent, entre autres :
  - Rotation du cœur
  - Hypertrophie de la racine aortique
  - Hypertrophie importante de l'oreillette droite
  - Scoliose/cyphose
  - Configuration anormale de l'oreillette gauche
  - Malformations congénitales
  - Malformations vasculaires
  - Impossibilité d'accéder à l'oreillette droite par la veine cave inférieure
- Ce dispositif doit être utilisé uniquement par des médecins spécialement formés aux procédures transseptales, dans un laboratoire d'électrophysiologie (EP) opérationnel entièrement équipé.
- La progression du cathéter dans le corps du patient doit s'effectuer sous guidage radioscopique afin de limiter le risque de lésion, perforation ou tamponnade cardiaque. Des systèmes de navigation et de visualisation en temps réel compatibles peuvent également être envisagés.
- Pendant l'introduction, vérifier si une résistance excessive se fait sentir lors de l'avancement de l'aiguille dans la courbure de l'ensemble gaine/dilatateur. En cas de résistance lors de l'avancement de l'aiguille, retirer l'aiguille et évaluer les composants.
- Pendant l'introduction, prendre soin de ne pas plier le dispositif de manière excessive. Cela risquerait d'empêcher la progression de l'aiguille et de provoquer une ponction accidentelle de l'ensemble dilatateur/gaine.
- Pendant l'introduction, toujours utiliser le mandrin pour faciliter le passage de l'aiguille dans l'ensemble dilatateur/gaine. L'absence de mandrin risque d'empêcher la progression de l'aiguille et de provoquer une ponction accidentelle de l'ensemble dilatateur/gaine ou d'éroder la surface interne du dilatateur.
- En cas de pénétration dans le péricarde ou l'aorte, ne pas faire avancer le dilatateur par-dessus l'aiguille. Si l'aiguille se trouve dans le péricarde ou l'aorte, il faudra la retirer. Surveiller attentivement les signes vitaux.
- Un risque d'infiltration d'air est présent lorsque des objets sont retirés de la valve hémostatique de la gaine. Prendre les précautions nécessaires pour éviter une infiltration d'air en retirant lentement les objets de manière à éviter la création d'une dépression dans la gaine et surveiller la gaine par radioscopie pendant l'insertion consécutive du dispositif pour une éventuelle présence d'air.
- Après utilisation, ce dispositif, ses accessoires et son emballage doivent être classés en vue de leur élimination, par exemple, déchets à risques infectieux, tranchants, non dangereux, etc. et soigneusement mis au rebut conformément aux procédures mises en place dans l'établissement et aux lois et aux réglementations en vigueur.
- Un ou plusieurs composants de ce dispositif pourraient contenir la substance suivante définie comme CMR 1B dans une concentration supérieure à 0,1 % poids par poids : Cobalt : No 7440-48-4 du Chemical Abstracts Service (CAS) ; No EC 231-158-0. Les preuves scientifiques actuelles montrent que les dispositifs médicaux fabriqués à partir d'alliages de cobalt et d'alliages d'acier inoxydable contenant du cobalt n'entraînent pas de risque accru de cancer ou d'effets indésirables sur la reproduction.

  Un ou plusieurs composants de ce dispositif pourraient contenir la substance suivante définie comme CMR 1A dans une concentration supérieure à 0,1 % poids par poids : Plomb : No 7439-92-1 du Chemical Abstracts Service (CAS) ; No EC 231-100-4. Les preuves scientifiques actuelles montrent que les dispositifs médicaux fabriqués à partir de plomb n'entraînent pas de risque accru de cancer ou d'effets indésirables sur la reproduction.

Événements indésirables potentiels

Catégorie d'événements indésirables	**Sous-catégorie d'événements indésirables**
Hémorragie	Hémorragie/saignement
	Hématome
Lésion cérébrale	Embolie cérébrale asymptomatique
	Arrêt cardiaque/accident vasculaire cérébral
	Accident ischémique transitoire (AIT)
Embolie	Embolie gazeuse
	Embolie de corps étranger
	Embolie pulmonaire
	Thrombo-embolie
	Thrombose/thrombus
Perforation cardiaque	Tamponnade cardiaque
	Épanchement péricardique
Lésion cardiovasculaire	Lésion valvulaire
	Ponction de la racine aortique
	Perforation auriculaire
Lésion du système de conduction	Nœud sinoauriculaire, nœud auriculo-ventriculaire ou bloc dans le système His-Purkinje
	Arythmies cardiaques
Réaction immunologique	Anaphylaxie
Infection	Péricardite
	Endocardite
	Pneumonie
	Septicémie
Douleur/gêne	Douleur, aine, poitrine (douleur thoracique générale non associée à l'infarctus du myocarde)
Lésion vasculaire périphérique	Dissection
	Lacération
	Formation de la fistule artérioveineuse
	Formation de pseudo-anévrisme
Hypotension	S.O.
Lésion tissulaire superficielle	S.O.

Instructions

Préparation et assemblage de l'équipement

1. Sortir le contenu de l'emballage.

   REMARQUE : ne pas assembler la gaine et le dilatateur.

2. Rincer le dilatateur et la gaine transseptale avec du sérum physiologique hépariné stérile.
3. Mettre le robinet de la gaine en position fermée.
4. Retirer le mandrin de l'aiguille et rincer celle-ci avec du sérum physiologique hépariné stérile.
5. Insérer le mandrin dans l'aiguille et l'enclencher dans l'embase.
6. Insérer le dilatateur à fond dans la gaine transseptale.

Avancement de l'ensemble gaine/dilatateur dans la veine cave supérieure

1. Procéder à une ponction de la veine fémorale (fémorale droite de préférence).

   OPTION : une gaine de longueur standard plus grande (≥tailles 2,5 F supérieures à la gaine transseptale) peut être employée pour obtenir et maintenir l'accès veineux pour l'échange de dispositifs et l'hémostase.

2. Introduire un guide de 0,032 pouce de diamètre et 150 à 180 cm de long, avec une extrémité de 3 mm en « J » dans la veine cave supérieure.

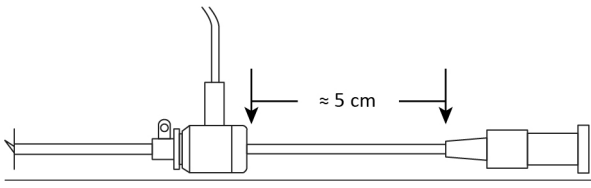
   REMARQUE : le diamètre maximum du guide pouvant être utilisé avec le dilatateur transseptal est de 0,032 pouce.

3. Insérer l'ensemble gaine/dilatateur dans la veine sur le guide et le faire avancer jusqu'à ce que l'extrémité de la gaine se trouve dans la veine cave supérieure. Orienter l'extrémité du dilatateur en direction médiale.

Introduction de l'ensemble aiguille/stylet dans l'ensemble gaine/dilatateur

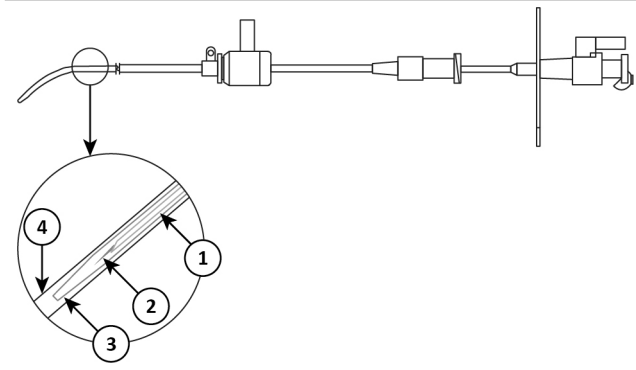
1. Retirer le guide du dilatateur.
2. Aspirer complètement puis rincer le dilatateur avec une solution saline héparinée.
3. Retirer le dilatateur d'environ 5 cm (voir figure ci-dessous) pour faciliter le passage de la courbe de l'aiguille à travers les embases rigides du dilatateur et de la gaine.

Figure 1. Retirer le dilatateur



4. Fixer le mandrin sur l'embase.
5. Insérer l'ensemble aiguille/mandrin dans le dilatateur. Sous radioscopie, faire avancer l'ensemble aiguille/stylet jusqu'à ce qu'il se trouve à environ 2 cm de l'extrémité du dilatateur dans la gaine (voir figure ci-dessous).

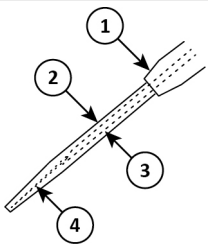
Figure 2. Insertion de l'aiguille/du mandrin dans le dilatateur



1. Aiguille
2. Mandrin
3. Extrémité du dilatateur
4. Gaine

6. Sous radioscopie, pour raccorder la gaine et le dilatateur, faire avancer simultanément le dilatateur et l'ensemble aiguille/stylet dans la gaine. S'assurer que la position de l'aiguille dans le dilatateur ne change pas, car les deux composants sont avancés ensemble. Maintenir la position de l'extrémité de la gaine dans la veine cave supérieure.
7. Sous radioscopie, faire avancer l'ensemble aiguille/stylet jusqu'à ce que le stylet soit proche de l'extrémité du dilatateur (voir figure ci-dessous).

Figure 3. Avancement de l'aiguille/le mandrin



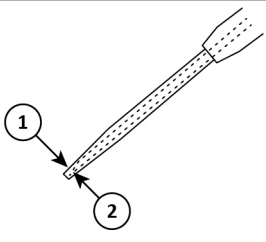
1. Extrémité de la gaine
2. dilatateur
3. Aiguille
4. Mandrin

8. Retirer le stylet, ne pas le jeter.
9. Aspirer jusqu'à ce que le sang s'écoule à nouveau. Jeter la seringue.

   REMARQUE : l'utilisation d'une seringue à embout-coulissant (non Luer-Lok‡) peut empêcher l'aspiration d'air.

10. Rincer l'aiguille avec du sérum physiologique hépariné stérile. Mettre le robinet en position fermée.
11. Avancer l'aiguille sous fluoroscopie jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille soit juste à proximité de la pointe du dilatateur (voir la figure ci-dessous).

Figure 4. Avancement de la pointe de l'aiguille



1. Extrémité du dilatateur
2. Pointe de l'aiguille

OPTION : fixer un robinet d'arrêt rotatif à 3 voies à l'embase de l'aiguille.

OPTION : attacher une seringue avec un produit de contraste radio-opaque au robinet d'arrêt. Aspirer l'aiguille. Charger ensuite l'aiguille avec le produit de contraste sous guidage fluoroscopique.

OPTION : connecter une ligne de surveillance de la pression au robinet d'arrêt.

OPTION : utiliser une configuration de collecteur standard à 3 ports pour connecter les lignes de contraste, de pression et de rinçage.

Engager la fosse ovale

1. Visualiser et identifier les repères anatomiques.
2. Régler l'unité de fluoroscopie à un angle parallèle au plan de la valve mitrale et orthogonal au plan du septum. Il s'agira généralement de l'oblique antérieur gauche (LAO), d'environ 30 à 40 degrés.

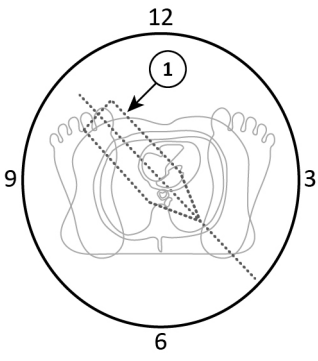
   OPTION : au cours des procédures d'EP, les positions du sinus coronaire et du cathéter du faisceau de His peuvent servir de repères anatomiques utiles. Dans la vue LAO appropriée, le cathéter du sinus coronaire apparaît de profil. Dans la vue oblique antérieure droite (RAO) appropriée, le cathéter du faisceau de His apparaît de profil. La fosse ovale est au niveau ou légèrement en dessous du cathéter du faisceau de His et supérieure et postérieure à l'ostium du sinus coronaire.

   OPTION : placer un cathéter de surveillance angiographique/hémodynamique en queue de cochon dans la cuspide non coronaire de la valve aortique peut servir de repère anatomique utile.

   OPTION : observer la forme d'onde de pression enregistrée à travers l'aiguille transseptale BRK™.

3. Ajuster la collerette du pointeur de manière à ce que l'aiguille soit perpendiculaire à la fosse ovale (entre 3h00 et 5h00 généralement, vue depuis le pied du patient). (Voir figure ci-dessous.)

Figure 5. Bride de pointeur d'aiguille

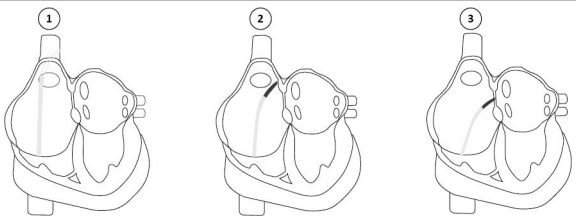


1. Bride de pointeur d'aiguille

4. Utiliser la fluoroscopie pour confirmer que la pointe de l'aiguille est à l'intérieur du dilatateur.
5. Après avoir confirmé que la pointe de l'aiguille se trouve dans le dilatateur, faire glisser lentement l'ensemble gaine/dilatateur/aiguille. Empêcher tout mouvement des pièces d'assemblage les unes par rapport aux autres. Il est essentiel de conserver l'orientation précédente de la bride du pointeur lors du déplacement de l'assemblage.
6. Dans la vue LAO (orthogonale au septum interauriculaire), observer la pointe du dilatateur pendant la traînée pour constater un mouvement brusque médian (ou vers la droite), indiquant que la pointe a engagé la fosse ovale. (Voir figures ci-dessous.)

   REMARQUE : si la fosse ovale est perméable à la sonde, la pointe du dilatateur se déplace maintenant facilement dans l'oreillette gauche.

Figure 6. Engager la fosse ovale



1. Position de départ dans la veine cave supérieure
2. Mouvement médian initial dans la RA
3. Mouvement médian brusque sur la fosse ovale

REMARQUE : si la pression est surveillée à travers l'aiguille, la pression à travers l'aiguille est imprécise à ce stade parce que la pointe est contre la fosse ovale.

Ponction de la fosse ovale avec l'aiguille transseptale BRK™

1. Confirmer l'emplacement correct de l'ensemble gaine/dilatateur/aiguille sur la fosse ovale avant d'avancer l'aiguille.
2. Une fois l'emplacement correct confirmé, étendre l'aiguille jusqu'à ce qu'elle s'engage complètement dans l'ensemble gaine/dilatateur et faire avancer l'aiguille à travers le septum interauriculaire.

   OPTION : sous surveillance de la pression, l'entrée dans l'oreillette gauche est confirmée lorsque le tracé de pression montre une forme d'onde de pression auriculaire gauche.

   OPTION : l'accès auriculaire gauche peut être confirmé par fluoroscopie avec des injections de contraste.

3. En cas de résistance lors de l'avancement de l'aiguille, rétracter l'aiguille et réévaluer les repères anatomiques.

   MISE EN GARDE : en cas de pénétration dans le péricarde ou l'aorte, ne pas faire avancer le dilatateur par-dessus l'aiguille. Si l'aiguille se trouve dans le péricarde ou l'aorte, il faudra la retirer. Surveiller attentivement les signes vitaux.

Avancer l'ensemble gaine/dilatateur dans l'oreillette gauche

Tout en maintenant la position fixe de l'aiguille dans l'oreillette gauche, faire avancer l'ensemble gaine/dilatateur entièrement par-dessus l'aiguille dans la cavité de l'oreillette gauche.

Avancer la gaine sur le dilatateur fixe et l'aiguille dans l'oreillette gauche

1. Maintenir la position de l'aiguille et du dilatateur à travers le septum.
2. Tout en maintenant le dilatateur dans un emplacement fixe, faire avancer complètement la gaine sur le dilatateur dans la cavité auriculaire gauche.

Retirer l'aiguille transseptale et le dilatateur BRK™

MISE EN GARDE : un risque d'infiltration d'air est présent lorsque des objets sont retirés de la valve hémostatique de la gaine. Prendre les précautions nécessaires pour éviter une infiltration d'air en retirant

lentement les objets de manière à éviter la création d'une dépression dans la gaine et surveiller la gaine par radioscopie pendant l'insertion consécutive du dispositif pour une éventuelle présence d'air.

1. Tourner le robinet d'arrêt de l'aiguille en position d'arrêt et déconnecter tous les accessoires de l'embase de l'aiguille.
2. Retirer l'aiguille transseptale BRK™ du dilatateur. L'aiguille peut être nettoyée et mise de côté pour une utilisation répétée dans cette procédure. Sinon, jeter l'aiguille de façon appropriée en tant qu'objet tranchant contaminé.
3. Attacher immédiatement une seringue au dilatateur et aspirer. Continuer à aspirer le sang tout en maintenant la gaine en position et en retirant le dilatateur. Le sang doit être du sang artériel.
4. Une fois le dilatateur retiré, aspirer le sang par le bras latéral de la gaine. Rincer soigneusement le bras de la gaine avec une solution saline héparinée pour éviter les bulles d'air.
5. La gaine est maintenant en place dans l'oreillette gauche.

Emballage et péremption

L'aiguille transseptale BRK™ est fournie stérile. L'aiguille est emballée avec un stylet inséré. L'aiguille et le stylet sont placés dans l'emballage primaire. L'emballage primaire est placé à l'intérieur d'une pochette Mylar‡ et Tyvek‡, qui est thermosoudée. La pochette et ce mode d'emploi sont ensuite placés dans une boîte scellée aux deux extrémités. La pochette et la boîte ont une étiquette avec des informations sur le produit, y compris la date de péremption. Les produits sont étiquetés pour une durée de conservation de trois ans.

Récapitulatif des données cliniques

Pour les pays de l'Union européenne : Un résumé de la sécurité et des performances cliniques (SSCP) de ces dispositifs sera publié sur https://ec.europa.eu/tools/eudamed par les organismes notifiés conformément aux exigences de l'UE MDR 2017/745 et aux délais associés. Rechercher le dispositif à l'aide de l'UDI-DI fourni sur l'emballage extérieur du dispositif. L'UDI-DI est le nombre à 14 chiffres entre les deux premières séries de parenthèses. Pour plus d'informations sur la recherche et l'utilisation de l'UDI-DI, reportez-vous au document Foire aux questions disponible sur medical.abbott/manuals.

Rapports d'incidents

Si, au cours de l'utilisation de cet appareil, des raisons vous laissent croire qu'un incident grave s'est produit, le signaler au fabricant. Pour les clients de l'Union européenne, signaler l'incident grave à votre autorité nationale ainsi qu'au fabricant.

Garantie limitée

Abbott Medical garantit que ses produits sont exempts de défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales. Cette garantie ne s'applique pas au-delà de la date de « péremption » indiquée sur l'étiquette des produits. Les usages autorisés et les méthodes d'utilisation approuvées pour chacun de nos produits sont définis dans le « mode d'emploi » qui accompagne chaque produit. Abbott Medical décline toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de ses produits d'une manière non autorisée ou non approuvée. La responsabilité d'Abbott Medical dans le cadre de la présente garantie se limite au remplacement de ses produits. La présente garantie exclut et remplace toute autre garantie expresse ou tacite, notamment, mais sans s'y limiter, toute garantie tacite de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier. Abbott Medical ne pourra pas être tenu responsable de toute perte indirecte ou accidentelle, de tout dommage ou débours découlant directement ou indirectement de l'utilisation du présent produit, dans des cas autres que ceux prévus par la loi applicable. Abbott Medical n'accepte et n'autorise aucune tierce personne à accepter, en son nom, aucune responsabilité ou obligation supplémentaire concernant toute perte, dommage ou débours en rapport avec ce produit. Pour plus de détails, consulter la politique de garantie complète d' Abbott Medical disponible auprès d'Abbott Medical ou au dos de la facture d' Abbott Medical.

Symboles

Les symboles ci-dessous et les symboles harmonisés figurent sur le produit ou sur l'étiquette du produit. Pour consulter les symboles harmonisés, se référer au glossaire des symboles universels à l'adresse medical.abbott/manuals.

Symbole	Définition
Series	Série
Contents	Contenu
Transseptal Needle	Aiguille transseptale
	Système de barrière stérile simple
	Longueur
	MISE EN GARDE : Conformément à la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.
	Conformité européenne. Symbole apposé en accord avec la réglementation 2017/745 du Conseil européen. Abbott Medical déclare par la présente que ce dispositif répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de cette réglementation.
	Importateur
	Conformité au Royaume-Uni évaluée
UKRP	Personne responsable au Royaume-Uni
	Marque de conformité ukrainienne aux réglementations techniques, où 101 est l'organisme d'évaluation.
MD	Dispositif médical
UDI	Identification unique du dispositif
	Respecter le mode d'emploi sur ce site Web
 (7440-48-4) (7439-92-1)	Contient des substances dangereuses. (Cobalt N° CAS 7440-48-4) (Plomb N° CAS 7439-92-1)

HR: Hrvatski

BRK™ Transseptalna igla

Upute za uporabu

Opis

Transseptalnu iglu BRK™ čine šuplja igla od nehrđajućeg čelika i puni stilet od nehrđajućeg čelika. Distalni dio igle zakrivljen je kako bi se olakšalo postavljanje unutar srca pri uporabi s kompletom transseptalne uvodnice tvrtke Abbott Medical. Unutar tog zakrivljenog dijela postoji naglo smanjenje vanjskog promjera igle koje je u skladu s unutarnjim promjerom dilatatora kompleta transseptalne uvodnice tvrtke Abbott Medical. Distalni vrh igle ukošen je radi lakšeg postupka punkcije. Proksimalni kraj igle konfiguriran je s prirubnicom s pokazivačem (pokazuje orijentaciju distalnog zakrivljenja) i opremljen dvosmjernim zapornim ventilom koji omogućava pristup lumenu igle u svrhu aspiracije, ubrizgavanja/infuzije tekućine, uzimanja uzorka krvi, praćenja tlaka te umetanje stileta i/ili žice vodilice (maksimalni promjer žice vodilice od 0,014 inča za iglu veličine 18 G, maksimalni promjer žice vodilice od 0,012 inča za iglu veličine 19 G). Stilet je ravan i izodijametričan cijelom svojom duljinom. Na proksimalnom dijelu stileta nalazi se zakrivljena kopča za blokiranje na proksimalnu glavinu igle nakon umetanja u lumen igle. Stilet je osmišljen tako da omogućava uvođenje igle u dilatator. Dostupne su različite iskoristive duljine i konfiguracije distalnog zakrivljenja igle.

Namjena

Transseptalna igla BRK™ namijenjena je za punkciju interatrijske pregrade u svrhu pristupa lijevoj strani srca.

Indikacije za upotrebu

Transseptalna igla BRK™ upotrebljava se za punkciju interatrijske pregrade tijekom postupka transseptalne kateterizacije u svrhu pristupa lijevoj strani srca.

Ciljna skupina pacijenata

Transseptalna igla BRK™ namijenjena je za uporabu na hemodinamski stabilnim pacijentima u kojih postoji potreba za kateterskim pristupom lijevoj strani srca. Možda će biti potrebno posebno razmotriti uporabu transseptalne igle BRK™ u pacijenata sa sljedećim stanjima:

- Zakrenuto srce
- Povećan korijen aorte
- Zabilježeno proširenje desne pretklijetke
- Skolioza/kifoza
- Abnormalnost geometrije lijeve pretklijetke
- Urođene deformacije
- Deformacije krvnih žila
- Nemogućnost pristupa desnoj pretklijetki kroz donju šuplju venu.

Ciljani korisnik

Ovaj uređaj smiju upotrebljavati samo liječnici koji su posebno obučeni za transseptalne postupke u potpuno opremljenom laboratoriju za elektrofiziologiju.

Kliničke koristi

Predviđena klinička korist transseptalne igle BRK™ jest punkcija interatrijske pregrade za vrijeme postupka transseptalne kateterizacije u svrhu pristupa lijevoj strani srca kako bi se uređajima za koje je potreban endokardijalni pristup s lijeve strane srca omogućilo postizanje njihove predviđene kliničke koristi, kao što je ablacijski kateter. To se mjeri uspješnom punkcijom interatrijske pregrade.

Kontraindikacije

- Prethodno postavljena zakrpa interatrijske pregrade ili protetski uređaj za zatvaranje atrijskog septalnog defekta.
- Prethodna tromboembolija.
- Poznati ili suspektni miksom lijeve pretklijetke.
- Poznati ili suspektni infarkt miokarda u posljednja dva tjedna.
- Nestabilna angina.
- Nedavni cerebrovaskularni inzult (CVA).
- Pacijenti koji ne podnose terapiju antikoagulansima.
- Pacijenti s aktivnom infekcijom.

Upozorenja

- Nemojte mijenjati ovaj uređaj ni na koji način.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za jednokratnu uporabu. Nemojte ga ponovno obrađivati niti ponovno upotrebljavati. Vodite računa o datumu označenom kao „Rok valjanosti" proizvoda na pakiranju. Svaki pokušaj ponovne sterilizacije i ponovne uporabe ovog sustava mogao bi umanjiti njegovu ispravnost. Štetni učinci uporabe nesterilnih komponenti, uz ostalo, mogu uključivati sljedeće:
  - Lokalnu i sustavnu infekciju ili reakciju
  - Mehaničko oštećenje
  - Neispravan rad.
- Materijali navedeni u nastavku po proizvodu mogu uzrokovati alergijske reakcije ili reakcije preosjetljivosti. Osobe koje su alergične na njih mogu dobiti alergijsku reakciju na ovaj proizvod. Prije upotrebe uređaja na pacijentu pacijenta bi trebalo informirati o materijalima koje uređaj sadržava te je potrebno s njim detaljno raspraviti o njegovoj povijesti alergija:
  - Nehrđajući čelik
  - Epoksidno ljepilo
  - Mjed presvučen slitinom nikal-krom
  - Silikonska mast za jaki vakuum (Dupont)
  - Master Bond
- Nepravilna uporaba ovog uređaja može dovesti do ozbiljnih komplikacija.
- Tijekom postupaka kateterizacije srca u pacijenata i u laboratorijskog osoblja postoji mogućnost značajnog izlaganja rendgenskom zračenju, koje može rezultirati akutnom radijacijskom ozljedom i povećanim rizikom od somatskih i genetskih efekata zbog intenziteta rendgenskog zračenja i trajanja fluoroskopskog snimanja. Pažljivo razmotrite uporabu ovog uređaja za trudnice.

Mjere opreza

- Prema američkom saveznom zakonu ovaj se uređaj može kupiti samo od liječnika ili na njihov recept.
- Prije uporabe pročitajte upute.
- Prije upotrebe pregledajte pakiranje. Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno.
- Prije uporabe pregledajte sve komponente.
- Čuvajte na hladnom, tamnom i suhom mjestu.
- Prije postupka pacijent mora biti hemodinamski stabilan. Pri uporabi ovog proizvoda za određena će stanja možda biti potrebna posebna razmatranja. To, između ostalog, mogu biti sljedeća stanja:

  - Zakrenuto srce
  - Povećan korijen aorte
  - Zabilježeno proširenje desne pretklijetke
  - Skolioza/kifoza
  - Abnormalnost geometrije lijeve pretklijetke
  - Urođene deformacije
  - Deformacije krvnih žila
  - Nemogućnost pristupa desnoj pretklijetki kroz donju šuplju venu.
- Ovaj uređaj smiju upotrebljavati samo liječnici koji su posebno obučeni za transseptalne postupke u potpuno opremljenom laboratoriju za elektrofiziologiju (EP).
- Pomicanje katetera mora se izvršavati uz fluoroskopsko navođenje kako bi se umanjila opasnost od oštećenja, perforacije ili tamponade srca. Također se mogu razmotriti kompatibilni sustavi za navigaciju i vizualizaciju u stvarnom vremenu.
- Tijekom umetanja provjerite nema li prekomjernog otpora dok vrh igle prolazi kroz zakrivljeni dio sklopa uvodnice/dilatatora. Ako pri uvođenju igle postoji otpor, uvucite iglu i provjerite komponente.
- Tijekom umetanja budite oprezni kako ne biste previše savijali uređaj. To može onemogućiti uvođenje igle i dovesti do slučajnog probijanja sklopa dilatatora/uvodnice iglom.
- Tijekom umetanja uvijek upotrebljavajte stilet kako biste olakšali prolazak igle kroz sklop dilatatora/uvodnice. Ako ne upotrebljavate stilet, možda iglu nećete moći uvesti, a to može dovesti do slučajnog probijanja sklopa dilatatora/uvodnice iglom ili ljuštenja materijala na unutarnjoj površini dilatatora.
- Dođe li do ulaska u perikard ili aortu, dilatator nemojte uvoditi preko igle. Ako je igla ušla u perikard ili aortu, morate je izvući. Pažljivo pratite vitalne znakove.
- Pri izvlačenju predmeta iz hemostatskog ventila na uvodnici postoji rizik od infiltracije zraka. Poduzmite mjere opreza za sprječavanje infiltracije zraka tako da predmete izvlačite polako da biste spriječili nastanak vakuuma u uvodnici te s pomoću fluoroskopije pratite uvodnicu tijekom umetanja uređaja kako biste utvrdili ima li zraka.
- Nakon upotrebe ovaj uređaj, pripadajući pribor i pakiranje treba propisno klasificirati radi odlaganja, npr. na biološki opasne materijale, oštre predmete, neopasni otpad itd. te ih pažljivo odložiti u skladu s postupcima određenima u ustanovi te važećim zakonima i propisima.
- Jedna komponenta ovog uređaja ili više njih mogu sadržavati sljedeću tvar definiranu kao CMR 1B u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela: kobalt: Chemical Abstracts Service (CAS) br. 7440-48-4; EZ br. 231-158-0. Trenutačni znanstveni dokazi potvrđuju da medicinski proizvodi proizvedeni od slitina kobalta i legura nehrđajućeg čelika koje sadržavaju kobalt ne uzrokuju povećani rizik od raka ni štetnih učinaka na reprodukciju.

  Jedna komponenta ovog uređaja ili više njih mogu sadržavati sljedeću tvar definiranu kao CMR 1A u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela: olovo: Chemical Abstracts Service (CAS) br. 7439-92-1; EZ br. 231-100-4. Trenutačni znanstveni dokazi potvrđuju da medicinski proizvodi proizvedeni od olova ne uzrokuju povećani rizik od raka ni štetnih učinaka na reprodukciju.

Moguće nuspojave

Kategorija nuspojave	Potkategorija nuspojave
Krvarenje	Hemoragija/krvarenje
	Hematom
Ozljeda mozga	Asimptomatska embolija mozga
	Moždani udar / moždana kap
	Tranzitorna ishemijska ataka (TIA)
Embolija	Zračna embolija
	Embolija radi stranog tijela
	Plućna embolija
	Tromboembolija
	Tromboza/tromb
Perforacija srca	Tamponada srca
	Perikardni izljev
Kardiovaskularna ozljeda	Oštećenje zalistaka
	Probijanje korijena aorte
	Perforacija pretklijetke
Smetnja u sustavu provodljivosti	Blokada SA čvora, AV čvora ili sustava His-Purkinje
	Srčana aritmija
Imunološka reakcija	Anafilaksija
Infekcija	Perikarditis
	Endokarditis
	Upala pluća
	Sepsa
Bol/nelagoda	Bol, prepone, prsa (generalna bol u prsima koja nije povezana s infarktom miokarda)
Ozljeda perifernih žila	Disekcija
	Razderotina
	Formiranje arteriovenske fistule
	Formiranje pseudoaneurizme
Hipotenzija	n. p.
Ozljeda površinskog tkiva	n. p.

Upute

Priprema i sastavljanje opreme

1. Izvadite sadržaj iz pakiranja.

   NAPOMENA: nemojte sastavljati uvodnicu i dilatator.
2. Isperite dilatator i uvodnicu heparinziranom fiziološkom otopinom.
3. Zatvorite zaporni ventil uvodnice.
4. Uklonite stilet iz igle i isperite iglu heparinziranom fiziološkom otopinom.
5. Umetnite stilet u iglu i blokirajte ga na glavinu.
6. Do kraja umetnite dilatator u transseptalnu uvodnicu.

Uvođenje sklopa uvodnice/dilatatora u gornju šuplju venu

1. Uspostavite venski pristup kroz bedrenu venu (po mogućnosti na desnom bedru).

   OPCIONALNO: za uspostavu i održavanje venskog pristupa u svrhu zamjene uređaja i hemostaze možete upotrijebiti veću uvodnicu (za ≥ 2,5 francuske mjere veću u odnosu na transseptalnu uvodnicu) standardne duljine.

2. Uvedite žicu vodilicu promjera 0,032 inča, duljine 150 – 180 cm i vrhom u obliku slova „J" od 3 mm u gornju šuplju venu (GŠV).

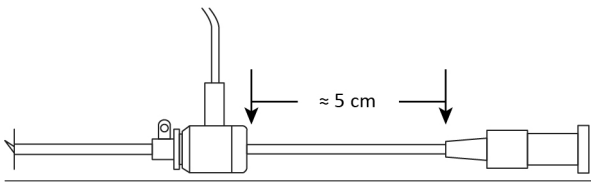
   NAPOMENA: vrijednost od 0,032 inča je maksimalan promjer žice vodilice koji se može upotrijebiti s dilatatorom.

3. Umećite uvodnicu/dilatator u venu po žici vodilici sve dok vrh uvodnice ne dođe u GŠV. Usmjerite vrh dilatatora prema sredini.

Pozicioniranje sklopa igle/stileta unutar sklopa uvodnice/dilatatora

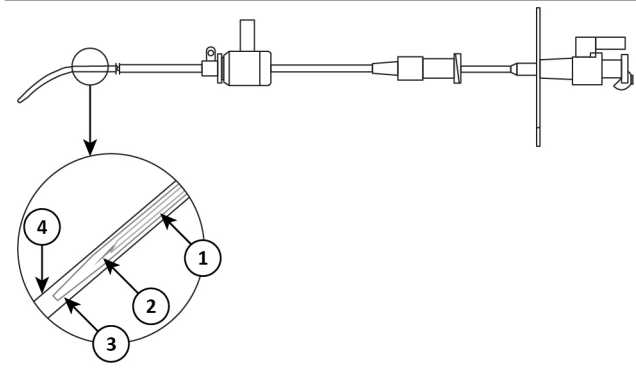
1. Izvadite žicu vodilicu iz dilatatora.
2. Do kraja aspirirajte i zatim isperite dilatator heparinizirano fiziološkom otopinom.
3. Izvucite dilatator otprilike 5 cm (pogledajte sliku u nastavku) kako biste olakšali prolazak zakrivljenja igle kroz nesavitljive glavine dilatatora i uvodnice.

Slika 1. Vađenje dilatatora



4. Blokirajte stilet na glavinu.
5. Umetnite iglu/stilet u dilatator. Fluoroskopskim navođenjem uvedite iglu/stilet na otprilike 2 cm od vrha dilatatora unutar uvodnice (pogledajte sliku u nastavku).

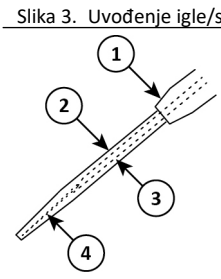
Slika 2. Umetanje igle/stileta u dilatator



1. Igla
2. Stilet
3. Vrh dilatatora
4. Uvodnica

6. Ponovno spojite uvodnicu i dilatator tako da dilatator i iglu/stilet istovremeno uvedete u uvodnicu fluoroskopskim navođenjem. Pripazite da se položaj igle unutar dilatatora ne promijeni dok istovremeno uvodite obje komponente. Zadržite položaj vrha uvodnice u GŠV-u.
7. Fluoroskopskim navođenjem iglu/stilet uvedite tako da bude u proksimalnom položaju u odnosu na vrh dilatatora (pogledajte sliku u nastavku).

Slika 3. Uvođenje igle/stileta



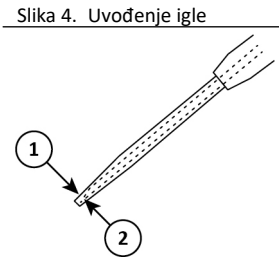
1. Vrh uvodnice
2. Dilatator
3. Igla
4. Stilet

8. Izvadite stilet, nemojte ga odložiti u otpad.
9. Aspirirajte iglu dok ne uočite povrat krvi. Štrcaljku odložite u otpad.

   NAPOMENA: uporaba štrcaljke s Luer slip vrhom (bez Luer-Lok‡ mehanizma) može spriječiti aspiraciju zraka.

10. Isperite iglu heparinoziranom fiziološkom otopinom. Zatvorite zaporni ventil.
11. Fluoroskopskim navođenjem iglu uvedite tako da njezin vrh bude u proksimalnom položaju u odnosu na vrh dilatatora (pogledajte sliku u nastavku).

Slika 4. Uvođenje igle



1. Vrh dilatatora
2. Vrh igle

OPCIONALNO: priključite trosmjerni rotirajući zaporni ventil na glavinu igle.

OPCIONALNO: pričvrstite štrcaljku s radionepropusnim kontrastnim sredstvom na zaporni ventil. Aspirirajte iglu. Zatim fluoroskopskim navođenjem napunite iglu kontrastnim sredstvom.

OPCIONALNO: na zaporni ventil priključite vod za praćenje tlaka.

OPCIONALNO: upotrijebite standardnu konfiguraciju s trima priključcima za priključivanje vodova za kontrastno sredstvo, tlak i ispiranje.

Uvođenje u ovalnu jamu

1. Vizualizirajte i identificirajte anatomske orijentire.

2. Postavite jedinicu za fluoroskopiju pod kutom, paralelno s ravninom mitralnog zaliska i ortogonalno na ravninu pregrade. Obično je to lijeva anteriorna kosa projekcija (LAO), otprilike 30 do 40 stupnjeva.

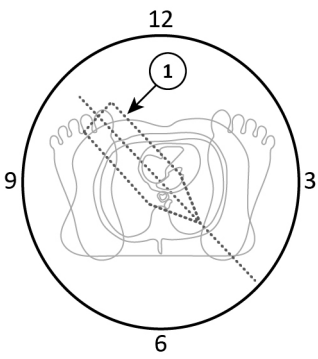
   OPCIONALNO: tijekom EP postupaka položaji katetera na koronarnom sinusu i His snopu mogu poslužiti kao korisni anatomski orijentiri. U odgovarajućoj projekciji LAO kateter koronarnog sinusa vidjet će se na profilu. U odgovarajućoj desnoj anteriornoj kosoj projekciji (RAO) vidjet će se profil katetera na Hisovu snopu. Ovalna jama nalazi se na razini katetera na Hisovu snopu ili malo ispod nje, a superiorno i posteriorno u odnosu na otvor koronarnog sinusa.

   OPCIONALNO: postavljanje katetera tipa Pigtail za angiografsko/hemodinamsko praćenje u nekoronarni kuspis aortnog zaliska može poslužiti kao koristan anatomski orijentir.

   OPCIONALNO: promatrajte oblik vala tlaka koji se bilježi preko transseptalne igle BRK™.

3. Namjestite prirubnicu s pokazivačem tako da igla bude okomita na ovalnu jamu (obično između 3:00 i 5:00 sati, gledano od nogu pacijenta). (Pogledajte sliku u nastavku.)

Slika 5. Prirubnica s pokazivačem na igli



1. Prirubnica s pokazivačem na igli

4. Fluoroskopijom potvrdite da se vrh igle nalazi unutar dilatatora.
5. Nakon što potvrdite da se vrh igle nalazi unutar dilatatora, polako vucite cijeli sklop uvodnice/dilatatora/igle. Pazite da ne dođe do međusobnog relativnog pomicanja dijelova sklopa. Iznimno je važno održati prethodnu orijentaciju prirubnice s pokazivačem tijekom povlačenja sklopa.
6. U projekciji LAO (ortogonalno na interatrijsku pregradu) promatrajte je li se tijekom povlačenja vrh dilatatora naglo pomaknuo prema sredini (ili udesno) jer je to znak da je vrh došao do ovalne jame. (Pogledajte slike u nastavku.)

   NAPOMENA: ako je ovalna jama prohodna za sondu, vrh dilatatora sada će se bez poteškoća pomaknuti u lijevu pretklijetku.

Slika 6. Uvođenje u ovalnu jamu



1. Početni položaj u GŠV-u
2. Prvo pomicanje prema sredini u desnoj pretklijetki
3. Naglo pomicanje prema sredini na ovalnu jamu

NAPOMENA: ako pratite tlak kroz iglu, u ovom trenutku tlak kroz iglu neće biti točan jer se vrh nalazi na ovalnoj jami.

Punkcija ovalne jame transseptalnom iglom BRK™

1. Potvrdite pravilnu lokaciju sklopa uvodnice/dilatatora/igle na ovalnoj jami prije daljnjeg uvođenja igle.
2. Nakon što potvrdite pravilnu lokaciju, do kraja izvucite iglu unutar sklopa uvodnice/dilatatora i gurnite iglu kroz interatrijsku pregradu.

   OPCIONALNO: uz praćenje tlaka, ulazak u lijevu pretklijetku potvrđen je kad se na zapisu tlaka pokaže oblik vala za tlak lijeve pretklijetke.

   OPCIONALNO: pristup lijevoj pretklijetki može se potvrditi putem fluoroskopije ubrizgavanjima kontrastnog sredstva.

3. Ako pri uvođenju igle osjetite otpor, iglu uvucite i ponovno procijenite anatomske orijentire.

   OPREZ: dođe li do ulaska u perikard ili aortu, dilatator nemojte uvoditi preko igle. Ako je igla ušla u perikard ili aortu, morate je izvući. Pažljivo pratite vitalne znakove.

Uvođenje sklopa uvodnice/dilatatora u lijevu pretklijektu

Održavajući fiksni položaj igle unutar lijeve pretklijetke, preko igle do kraja pomaknite sklop uvodnice/dilatatora prema naprijed u šupljinu lijeve pretklijetke.

Uvođenje uvodnice preko fiksnog dilatatora i igle u lijevu pretklijetku

1. Nemojte mijenjati položaj igle i dilatatora dok prelazite pregradu.
2. Dok se dilatator nalazi u fiksnom položaju, uvodnicu gurnite do kraja preko dilatatora u šupljinu lijeve pretklijetke.

Izvlačenje transseptalne igle BRK™ i dilatatora

OPREZ: pri izvlačenju predmeta iz hemostatskog ventila na uvodnici postoji rizik od infiltracije zraka. Poduzmite mjere opreza za sprječavanje infiltracije zraka tako da predmete izvlačite polako da biste spriječili nastanak vakuuma u uvodnici te s pomoću fluoroskopije pratite uvodnicu tijekom umetanja uređaja kako biste utvrdili ima li zraka.

1. Zatvorite zaporni ventil igle i odvojite sve eventualne priključke s glavine igle.
2. Izvadite transseptalnu iglu BRK™ iz dilatatora. Iglu možete očistiti i staviti sa strane za ponovnu uporabu u ovom postupku. U protivnom, odložite iglu u otpad na način prikladan za kontaminirane oštre predmete.
3. Odmah pričvrstite štrcaljku na dilatator i aspirirajte. Nastavite aspirirati krv dok uvodnicu držite na mjestu i izvlačite dilatator. Krv bi trebala biti arterijska.
4. Nakon uklanjanja dilatatora aspirirajte krv kroz bočni krak uvodnice. Pažljivo isperite bočni krak uvodnice heparinizirano fiziološkom otopinom da biste izbjegli mjehuriće zraka.
5. Uvodnica je sada postavljena u lijevu pretklijetku.

Pakiranje i rok trajanja

Transseptalna igla BRK™ isporučuje se sterilna. Igla je zapakirana s umetnutim stiletom. Igla i stilet postavljeni su u primarno pakiranje. Primarno pakiranje postavljeno je u zavarenu vrećicu Mylar‡ i Tyvek‡. Vrećica i ove upute za uporabu zatim su stavljene u kutiju zapečaćenu na

obama krajevima. I na vrećici i na kutiji nalazi se naljepnica s informacijama o proizvodu, uključujući datum isteka roka valjanosti. Rok trajanja naveden na proizvodima je tri godine.

Sažetak kliničkih podataka

Za zemlje Europske unije: sažetak o sigurnosti i kliničkoj učinkovitosti (SSCP) za te uređaje prijavljena tijela objavit će na web-mjestu https://ec.europa.eu/tools/eudamed u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i povezanim vremenskim rasporedima. Uređaj potražite s pomoću jedinstvenog identifikacijskog broja proizvoda (UDI-DI) koji se nalazi na vanjskom pakiranju proizvoda. UDI-DI jest 14-znamenkasti broj između prva dva skupa zagrada. Za više informacija o traženju i uporabi broja UDI-DI pogledajte dokument Frequently Asked Questions (Najčešća pitanja) na web-mjestu medical.abbott/manuals.

Prijavljivanje štetnih događaja

Ako vjerujete da je tijekom upotrebe ovog uređaja došlo do ozbiljnog štetnog događaja, prijavite ga proizvođaču. Kupci iz Europske unije ozbiljan štetni događaj prijavljuju nacionalnom nadležnom tijelu i proizvođaču.

Ograničeno jamstvo

Tvrtka Abbott Medical jamči da njezini proizvodi prilikom normalne upotrebe nemaju nedostataka povezanih s materijalom ili izradom. Ovo jamstvo ne vrijedi nakon datuma „roka valjanosti" koji je naznačen na oznakama svih proizvoda. Propisane namjene i odobrene metode upotrebe za svaki naš proizvod definirane su u odgovarajućim „uputama za uporabu" koje su priložene uz svaki pojedini proizvod. Tvrtka Abbott Medical odriče se svake odgovornosti za upotrebu proizvoda na način koji nije ovlašten ili odobren. Odgovornost tvrtke Abbott Medical prema ovom jamstvu ograničena je na zamjenu njezinih proizvoda. Gore navedeno jamstvo zamjenjuje i poništava sva ostala jamstva, bilo da su ona izdana izrijekom ili prešutno, uključujući uz ostalo sva prešutna jamstva koja se tiču stavljanja proizvoda u promet ili njegove prikladnosti za neku određenu namjenu. Tvrtka Abbott Medical odriče se svake odgovornosti za sve slučajne ili posljedične gubitke, štete ili troškove koji su izravno ili neizravno uzrokovani upotrebom ovog proizvoda, osim kako je izričito određeno relevantnim zakonom. Tvrtka Abbott Medical ne preuzima ni ne ovlašćuje nijednu drugu osobu da u njezino ime preuzme nikakvu drugu ili dodatnu odgovornost za gubitak, štetu ili trošak povezan s ovim proizvodom. Više informacija potražite u cjelovitom tekstu jamstva tvrtke Abbott Medical koji možete dobiti od tvrtke Abbott Medical ili pronaći na poleđini računa koji je izdala tvrtka Abbott Medical.

Simboli

Simboli u nastavku i usklađeni simboli mogu se pronaći na proizvodu ili na naljepnici proizvoda. Usklađene simbole potražite u univerzalnom glosaru simbola na stranici medical.abbott/manuals.

Simbol	Definicija
Series	Serija
Contents	Sadržaj
Transseptal Needle	Transseptalna igla
	Sustav jedne sterilne barijere
	Duljina
Rx ONLY	OPREZ: prema američkom saveznom zakonu ovaj se uređaj može kupiti samo od liječnika ili na njihov recept.
CE 2797	Conformité Européenne (Europska sukladnost). Označeno u skladu s Uredbom Europskog vijeća 2017/745. Ovime tvrtka Abbott Medical izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama te uredbe.
	Uvoznik
UK CA 0086	Ocjena sukladnosti za Ujedinjenu Kraljevinu
UKRP	Odgovorna osoba u Ujedinjenoj Kraljevini
UA.TR.101	Ukrajinska oznaka usklađenosti s tehničkim propisima, u kojoj 101 označava tijelo za ocjenjivanje.
MD	Medicinski proizvod
UDI	Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda
medical.abbott/manuals	Slijedite upute za uporabu s ovih internetskih stranica
(7440-48-4) (7439-92-1)	Sadrži opasne tvari (kobalt: CAS br. 7440-48-4) (olovo: CAS br. 7439-92-1)

HU: Magyar

BRK™ Transzszeptális tű

Használati utasítás

Leírás

A BRK™ transzszeptális tű egy luminál rozsdamentes acél tűből és egy tömör rozsdamentes acél szondából áll. A tű disztális része ívelt, hogy megkönnyítse a szívben való elhelyezést, ha az Abbott Medical transzszeptális hüvelykészletével együtt használják. Ezen az íves szakaszon belül a tű külső átmérője hirtelen csökken, hogy illeszkedjen az Abbott Medical transzszeptális hüvelykészlete tágítójának belső átmérőjéhez. A tű disztális hegye a szúrás megkönnyítése érdekében le van ferdítve. A tű proximális vége (a disztális görbe irányultságát jelző) mutatós karimával és kétutas elzárócsappal van ellátva, amely biztosítja a tű lumenéhez való hozzáférést az aspirációhoz, folyadékinjekcióhoz/infúzióhoz, vérvételhez, nyomásfigyeléshez és szonda és/vagy vezetődrót behelyezéséhez (0,014 hüv. maximális vezetődrót átmérő 18-as tűnél; 0,012 hüv. maximális vezetődrót átmérő 19-es tűnél). A szonda egyenes és teljes hosszában izodiametrikus. A szonda proximális vége egy ívelt kapoccsal van ellátva, amely a tű lumenébe történő behelyezéskor a proximális tűfejre rögzül. Kialakítása révén a szonda megkönnyíti a tű előrehaladását a tágítóban. A tű többféle használható hosszúságban és disztális ívben kapható.

Rendeltetés

A BRK™ transzszeptális tűt az interatrialis sövény átszúrására használják a bal szívfélhez való hozzáférés érdekében.

Felhasználási javallatok

A BRK™ transzszeptális tűt az interatrialis sövény átszúrására használják a transzszeptális katéterezési eljárás során a bal szívfélhez való hozzáférés érdekében.

Célzott betegcsoport

A BRK™ transzszeptális tűt bal szívkatéteres hozzáférést igénylő, hemodinamikailag stabil betegeknél kell használni. A BRK™ transzszeptális tű használata különös figyelmet igényelhet a következő állapotokkal élő betegeknél:

- Dextrocardia
- Megnagyobbodott aortagyök
- Jelentős jobb pitvari megnagyobbodás
- Scoliosis/kyphosis
- Kóros bal pitvari geometria
- Veleszületett rendellenességek
- Rendellenes éralakzat
- A jobb pitvarba való bejutás képtelensége az alsó üres visszéren keresztül

Felhasználói célközönség

Az eszközt csak olyan orvosok használhatják, akik speciálisan képzettek a transzszeptális eljárásokra, egy teljesen felszerelt, működő elektrofiziológiai laboratóriumban.

Klinikai előny

A BRK™ transzszeptális tű célzott klinikai előnye az interatrialis sövény átszúrása a transzszeptális katéterezési eljárás során, hogy a bal szívfélhez hozzáférést biztosítson, hogy a szív bal oldali endocardialis határához való hozzáférést igénylő eszközök, például az ablációs katéter, elérhessék a célzott klinikai előnyüket. Ezt az interatrialis sövény sikeres szúrásával mérik.

Ellenjavallatok

- Korábbi interatrialis sövényfoltot vagy pitvari sövényhiányt lezáró eszköz.
- Bármilyen korábbi thromboemboliás esemény.
- Ismert vagy feltételezett bal pitvari myxoma.
- Ismert vagy feltételezett szívinfarktus az elmúlt két hétben.
- Instabil angina.
- Közelmúltban lezajlott agyi érkatasztrófa (CVA).
- Az antikoagulációs kezelést nem toleráló betegek.
- Aktív fertőzésben szenvedő betegek.

Figyelmeztetések

- Semmilyen módon ne módosítsa az eszközt.
- Az eszköz csak egyszeri használatra készült; ne dolgozza fel vagy használja újra. Vegye figyelembe a termék csomagolásán feltüntetett „lejárati dátumot”. A rendszer újrasterilizálására és újrafelhasználására tett kísérletek veszélyeztethetik annak integritását. A nem steril komponensek használatából adódó nemkívánatos hatások többek között az alábbiak lehetnek:
  - Helyi és szisztémás fertőzés vagy reakció
  - Mechanikus sérülés
  - Pontatlan működés
- A termék alább meghatározott anyagai allergiás vagy túlérzékenységi reakciókat válthatnak ki. Az ezen anyagokra allergiás személyeknél a termék allergiás reakciót válthat ki. Alkalmazása előtt a beteget tájékoztatni kell az eszközben található anyagokról, és alaposan át kell beszélni az allergiás anamnézist:
  - Rozsdamentes acél
  - Epoxi ragasztóanyag
  - Nikkel-króm ötvözettel bevont sárgaréz
  - Szilikon kenőanyag nagy vákuumos használatra (Dupont)
  - Master Bond
- Az eszköz helytelen használata súlyos szövődményekhez vezethet.
- A szívkatéterezési eljárások mind a betegek, mind a labormunkatársak számára jelentős röntgenexpozíciót jelentenek, ami akut-sugárkárosodást, valamint a röntgensugár intenzitása és a fluoroszkópiás képalkotás időtartama miatt a szomatikus és genetikai-hatások fokozott kockázatát eredményezheti. Gondosan mérlegelje az eszköz használatát terhes nőknél.

Óvintézkedések

- Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre forgalmazható.
- Használat előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat előtt vizsgálja meg a csomagolást. Ne használja fel, ha a csomagolás fel van nyitva vagy megsérült.
- Használat előtt vizsgálja át az összes alkotóelemet.
- Hűvös, sötét, száraz helyen tárolandó.
- Az eljárás előtt a betegnek hemodinamikailag stabilnak kell lennie. Bizonyos állapotok esetén speciális megfontolásra lehet szükség a termék használatakor. Ezek a specifikus kockázatok többek között az alábbiak lehetnek:
  - Dextrocardia

  - Megnagyobbodott aortagyök
  - Jelentős jobb pitvari megnagyobbodás
  - Scoliosis/kyphosis
  - Kóros bal pitvari geometria
  - Veleszületett rendellenességek
  - Rendellenes éralakzat
  - A jobb pitvarba való bejutás képtelensége az alsó üres visszéren keresztül
- Az eszközt csak olyan orvosok használhatják, akik speciálisan képzettek a transzszeptális eljárásokra, egy teljesen felszerelt, működő elektrofiziológiai (EP) laboratóriumban.
- A katéter bevezetését fluoroszkópiás irányítás mellett kell végezni, így csökkentve minimálisra a szívsérülés, -perforáció és -tamponád kockázatát. Meg kell továbbá fontolni kompatibilis navigációs és valós idejű vizualizációs rendszerek használatát.
- A behelyezés során ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e túlzott ellenállást, amikor a tű hegye áthalad a hüvely/tágító görbületén. Ha a tű előrehaladásával szemben ellenállást tapasztal, húzza vissza a tűt, és vizsgálja meg a komponenseket.
- A behelyezés során óvatosan járjon el, nehogy túlzottan meghajlítsa az eszközt. Ez gátolhatja a tű előrehaladását, és a tágító/hüvely véletlen megszúrásához vezethet.
- A behelyezés során mindig használja a szondát, hogy megkönnyítse a tű áthaladását a tágítón/hüvelyen. Ha nem használja a szondát, azzal gátolhatja a tű előrehaladását, és a tágító/hüvely véletlen megszúrásához vagy a tágító belső felületéről származó anyag lekopásához vezethet.
- Ha perikardiális vagy aortába történő behatolás történik, ne tolja a tágítót a tű fölé. Ha a tű behatolt a szívburokba vagy az aortába, vissza kell húzni. Kövesse figyelemmel az életjeleket.
- Fennáll a levegő beszivárgásának veszélye, amikor objektumokat távolít el a hüvely vérzéscsillapító szelepéből. Tegyen óvintézkedéseket a levegő beszivárgásának megelőzésére azáltal, hogy az objektumokat lassan visszahúzza, hogy megakadályozza a vákuum felhalmozódását a hüvelyben, és a következő eszköz behelyezése során fluoroszkópiásan ellenőrizze a levegő jelenlétét a hüvelyben.
- Használat után az eszközt, tartozékait és csomagolását megfelelően kell osztályozni az ártalmatlanításhoz, pl. biológiailag veszélyes, éles vagy nem veszélyes hulladék stb., és gondosan, a létesítmény eljárásainak és a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Az eszköz egy vagy több komponense tartalmazhatja a következő, CMR 1B-ként meghatározott anyagot 0,1%-ot meghaladó koncentrációban: Kobalt: Chemical Abstracts Service (CAS-szám): 7440-48-4; EC-szám: No. 231-158-0. A jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján a kobaltötvözetből és a kobaltot tartalmazó rozsdamentesacél-ötvözetekből gyártott orvostechnikai eszközök nem okoznak megnövekedett daganatkockázatot vagy nemkívánatos reproduktív hatásokat.

  Az eszköz egy vagy több komponense tartalmazhatja a következő, CMR 1A-ként meghatározott anyagot 0,1%-ot meghaladó koncentrációban: Ólom: Chemical Abstracts Service (CAS-szám): 7439-92-1; EC-szám: No. 231-100-4. A jelenlegi tudományos bizonyítékok alátámasztják, hogy az ólomból készült orvostechnikai eszközök nem fokozzák a rák kialakulásának kockázatát vagy nemkívánatos reprodukciós hatásokat.

Lehetséges nemkívánatos események

Nemkívánatos események	Nemkívánatos események alkategóriája
Vérzés	Vérzés
	Hematóma
Agykárosodás	Aszimptomatikus agyi embóliák
	Sztrók/cerebrovaszkuláris történés
	Tranziens iszkémiás roham (TIA)
Embólia	Légembólia
	Idegentest-embólia
	Tüdőembólia
	Tromboembólia
	Trombózis/trombus
Szívperforáció	Szívtamponád
	Perikardiális folyadékgyülem
Kardiovaszkuláris sérülés	Billentyűkárosodás
	Aortagyök megszúrása
	Pitvari perforáció
Ingerületet vezető rendszer zavara	Az SA-csomó, az AV-csomó vagy a His-Purkinje rendszer blokkja
	Aritmiák
Immunreakció	Anafilaxia
Fertőzés	Szívburokgyulladás
	Endokarditisz
	Tüdőgyulladás
	Szepszis
Fájdalom/diszkomfort	Ágyéki, mellkasi fájdalom (általános mellkasi fájdalom, amely nem kapcsolódik az MI-hez)
Perifériás érrendszer sérülése	Disszekció
	Felszakadás
	Arteriovenózus fisztula kialakulása
	Álaneurysma kialakulása
Hipotónia	n. a.
Felszíni szövetsérülés	n. a.

Használati utasítás

A berendezések előkészítése és összeszerelése

1. Vegye ki a csomagolás tartalmát.

   MEGJEGYZÉS: Ne szerelje össze a hüvelyt és a tágítót.

2. Öblítse át a tágítót és a hüvelyt heparinizált sóoldattal.
3. Zárja le a hüvely elzárócsapját.
4. Távolítsa el a szondát a tűből, és öblítse át a tűt heparinizált sóoldattal.
5. Helyezze be a szondát a tűbe, és rögzítse azt a tűfejre.

6. Helyezze be a tágítót teljesen a transzszeptális hüvelybe.

A hüvely/tágító bevezetése a felső üres visszérbe

1. Férjen hozzá a femorális vénához (lehetőleg a jobb oldalihoz).

   Opcionális: Egy nagyobb (≥2,5 French mérettel nagyobb, mint a transzszeptális hüvely) standard hosszúságú hüvely használható a vénás hozzáférés megszerzéséhez és fenntartásához az eszközcsere és a vérzéscsillapítás céljából.

2. Vezessen be egy 0,032 hüv., 150–180 cm, 3 mm méretekkel rendelkező „J"-hegyű vezetődrótot a felső üres visszér (SVC) belsejébe.

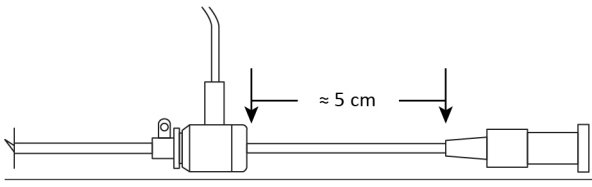
   MEGJEGYZÉS: A tágítóval használható maximális vezetődrót átmérő 0,032 hüv.

3. Helyezze be a hüvelyt/tágítót a vénába a vezetődrót fölé, amíg a hüvely hegye az SVC-be nem kerül. A tágító hegyét mediálisan igazítsa el.

Tű/szonda behelyezése a hüvely/tágító belsejébe

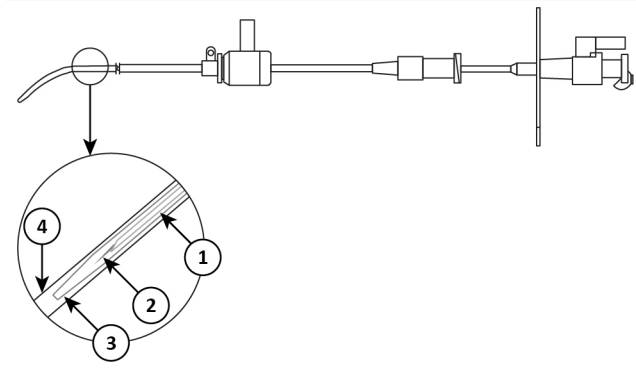
1. Távolítsa el a vezetődrótot a tágítóról.
2. Teljesen szívja le, majd öblítse át a tágítót heparinizált sóoldattal.
3. Húzza vissza a tágítót körülbelül 5 cm-re (lásd az alábbi ábrát), hogy megkönnyítse a tű áthaladását a tágító és a hüvely merev csücskén.

ábra. 1. A tágító visszahúzása



4. Rögzítse a szondát a fejre.
5. Helyezze a tűt/szondát a tágítóba. Tolja előre a tűt/szondát fluoroszkópia alatt, amíg a tágító hegyétől kb. 2 cm-re nem kerül a hüvely belsejébe (lásd az alábbi ábrát).

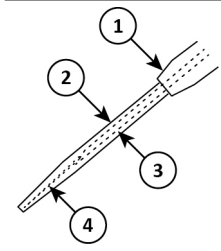
ábra. 2. A tű/szonda behelyezése a tágítóba



1. Tű
2. Szonda
3. Tágító hegye
4. Hüvely

6. A hüvely és a tágító újracsatlakoztatásához a tágítót és a tűt/szondát egyszerre tolja be a hüvelybe fluoroszkópia alatt. Győződjön meg arról, hogy a tű helyzete a tágítóban nem változik, miközben a két komponens együtt halad előre. Tartsa a hüvely hegyének helyzetét az SVC-ben.
7. Fluoroszkópia alatt tolja előre a tűt/szondát, amíg a tű a tágító hegyéhez közel nem kerül (lásd az alábbi ábrát).

ábra. 3. A tű/szonda előretolása



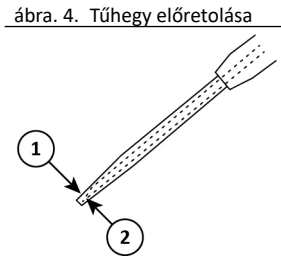
1. Hüvely hegye
2. Tágító
3. Tű
4. Szonda

8. Távolítsa el a szondát, de ne dobja ki.
9. Végezzen tűaspirációt, amíg vér visszatérése nem figyelhető meg. Dobja ki a fecskendőt.

   MEGJEGYZÉS: A csúsztatható-hegyű fecskendő (nem Luer-Lok‡) használatával megakadályozható a levegő beszívása.

10. Öblítse át a tűt heparinizált sóoldattal. Zárja el az elzárócsapot.
11. Tolja előre a tűt fluoroszkópia alatt, amíg a tű hegye éppen a tágító hegyéhez közelít (lásd az alábbi ábrát).

ábra. 4. Tűhegy előretolása



1. Tágító hegye
2. Tűhegy

Opcionális: Csatlakoztasson egy háromutas forgó elzárócsapot a tűfejhez.

Opcionális: Csatlakoztasson egy sugárfogó kontrasztanyaggal megtöltött fecskendőt az elzárócsaphoz. Végezzen tűaspirációt. Ezután fluoroszkópiás irányítás mellett töltse meg a tűt a kontrasztanyaggal.

Opcionális: Csatlakoztasson egy nyomásfigyelő vezetéket az elzárócsaphoz.

Opcionális: A kontraszt-, a nyomás- és az öblítővezetékek csatlakoztatásához használjon szabványos, 3 portos elosztócsonkot.

Az ovális terület bevonása

1. Vizualizálja és azonosítsa az anatómiai tájékozódási pontokat.

2. Állítsa a fluoroszkópiás egységet a kétcsúcsú billentyű síkjával párhuzamos és a sövény síkjára merőleges szögbe. Ez általában a bal elülső ferde (LAO) szög, amely körülbelül 30–40 fokos.

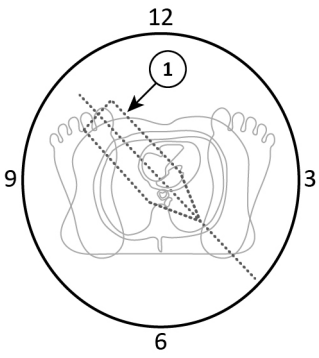
   Opcionális: Az EP-eljárások során a szívkoszorúér-öböl és a His-köteg katéter pozíciója hasznos anatómiai tájékozódási pontként szolgálhat. A megfelelő LAO nézetben a szívkoszorúér-öböl katéter profilban jelenik meg. A megfelelő jobb elülső ferde nézetben (RAO) a His-köteg katéter profilnézetben jelenik meg. Az ovális terület a HIS-köteg katéter szintjén vagy kissé alatta, valamint a szívkoszorúér-öböl bemenetéhez képest feljebb és hátrébb helyezkedik el.

   Opcionális: A fonalvezető angiográfiás/hemodinamikai megfigyelő katéter elhelyezése az aortabillentyű nem koronáriás csücskében hasznos anatómiai tájékozódási pontként szolgálhat.

   Opcionális: Figyelje meg a BRK™ transzszeptális tűn keresztül rögzített görbét.

3. Állítsa be a mutatós karimát úgy, hogy a tű merőlegesen álljon az ovális területre (jellemzően 3 és 5 óra között, a beteg lábfejéről nézve). (Lásd az alábbi ábrát.)

ábra. 5. Tű jelzőkarimája

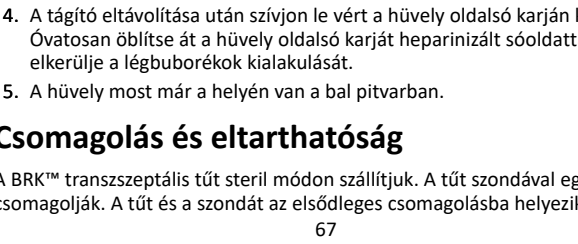


1. Tű jelzőkarimája

4. Fluoroszkópiával erősítse meg, hogy a tű hegye a tágítóban van.
5. Miután meggyőződött arról, hogy a tű hegye a tágítóban van, lassan húzza ki a teljes hüvelyt/tágítót/tűt. Akadályozza meg a szerelvényrészek egymáshoz viszonyított mozgását. Nagyon fontos, hogy a szerelvény húzása közben a mutatós karima korábbi tájolása megmaradjon.
6. A LAO nézetben (az interatrialis sövényre merőlegesen) figyelje meg a tágító hegyét a húzás során, hogy nem mozdul-e el hirtelen mediálisan (vagy jobbra), ami azt jelzi, hogy a hegy az ovális területre került. (Lásd az alábbi ábrákat.)

   MEGJEGYZÉS: Ha az ovális terület átjárható a szonda által, a tágító hegye most könnyedén behatol a bal pitvarba.

ábra. 6. Az ovális terület bevonása



1. Kiindulási helyzet az SVC-ben
2. Kezdeti mediális mozgás az RA-ban
3. Hirtelen mediális mozgás az ovális területre

MEGJEGYZÉS: Ha a nyomást a tűn keresztül figyeli, a tűn keresztül mért nyomás ezen a ponton pontatlan, mivel a hegye az ovális területtel szemben van.

Az ovális terület punkciója a BRK™ transzszeptális tűvel

1. Ellenőrizze a hüvely/tágító/tű helyes elhelyezkedését az ovális területen, mielőtt a tűt előretolná.
2. A helyes elhelyezkedés megerősítése után húzza ki a tűt a hüvelybe/tágítóba való teljes behatolásig, és tolja előre a tűt az interatrialis sövényen keresztül.

   Opcionális: A nyomásfigyelés során a bal pitvarba való belépés akkor megerősített, ha a nyomáskövetés bal pitvari görbét jelenít meg.

   Opcionális: A bal pitvari hozzáférést kontrasztanyag-injekcióval végzett átvilágítással lehet megerősíteni.

3. Ha a tű előrehaladásával szemben ellenállást tapasztal, húzza vissza a tűt, és vizsgálja meg újra az anatómiai tájékozódási pontokat.

   FIGYELEM! Ha perikardiális vagy aortába történő behatolás történik, ne tolja a tágítót a tű fölé. Ha a tű behatolt a szívburokba vagy az aortába, vissza kell húzni. Kövesse figyelemmel az életjeleket.

A hüvely/tágító bevezetése a bal pitvarba

Teljesen vezesse át a hüvely/tágító szerelvényt a tűn a bal pitvar üregébe, miközben a tűt rögzített helyzetben tartja a bal pitvarban.

A hüvely előretolása a rögzített tágító és a tű fölött a bal pitvarba

1. Tartsa meg a tű és a tágító pozícióját a sövényen keresztül.
2. Miközben a tágítót rögzített helyen tartja, tolja be a hüvelyt teljesen a tágító fölé a bal pitvari üregbe.

A BRK™ transzszeptális tű és a tágító kivonása

FIGYELEM! Fennáll a levegő beszivárgásának veszélye, amikor objektumokat távolít el a hüvely vérzéscsillapító szelepéből. Tegyen óvintézkedéseket a levegő beszivárgásának megelőzésére azáltal, hogy az objektumokat lassan visszahúzza, hogy megakadályozza a vákuum felhalmozódását a hüvelyben, és a következő eszköz behelyezése során fluoroszkópiásan ellenőrizze a levegő jelenlétét a hüvelyben.

1. Fordítsa a tű elzárócsapját kikapcsolt állásba, és válassza le a tűfejhez való csatlakoztatásokat.
2. Távolítsa el a BRK™ transzszeptális tűt a tágítóból. A tűt meg lehet tisztítani és félre lehet tenni az eljárás során történő ismételt használatra. Ellenkező esetben a tűt a szennyezett éles tárgyak esetében követendő eljárásnak megfelelően dobja ki.
3. Azonnal csatlakoztasson egy fecskendőt a tágítóhoz, és szívja le. Folytassa a vér leszívását, miközben a hüvelyt a helyén tartja, és visszahúzza a tágítót. A vérnek artériás vérnek kell lennie.
4. A tágító eltávolítása után szívjon le vért a hüvely oldalsó karján keresztül. Óvatosan öblítse át a hüvely oldalsó karját heparinizált sóoldattal, hogy elkerülje a légbuborékok kialakulását.
5. A hüvely most már a helyén van a bal pitvarban.

Csomagolás és eltarthatóság

A BRK™ transzszeptális tűt steril módon szállítjuk. A tűt szondával együtt csomagolják. A tűt és a szondát az elsődleges csomagolásba helyezik. Az

elsődleges csomagolást egy Mylar‡ és Tyvek‡ tasakba helyezik, amelyeket hőbiztosítanak. A tasakot és a jelen használati útmutatót ezután egy dobozba helyezik, amelyet mindkét végén lezárnak. Mind a tasak, mind a doboz címkéje tartalmazza a termékinformációkat, beleértve a lejárati dátumot is. A termékek hároméves eltarthatósági időre vannak címkézve.

Klinikai adatok összefoglalása

Az Európai Unió országai esetében: A bejelentett szervezetek az EU MDR 2017/745 követelményeinek és a kapcsolódó határidőknek megfelelően a https://ec.europa.eu/tools/eudamed weboldalon közzéteszik az ezen eszközökre vonatkozó biztonságosságról és a klinikai teljesítőképességről szóló összefoglalót (SSCP). Az eszköz külső csomagolásán levő UDI-DI segítségével keressen rá a készülékre. Az UDI-DI az első két zárójel közötti 14 jegyű szám. Az UDI-DI megtalálásával és használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a medical.abbott/manuals weboldalon található Gyakran ismételt kérdések című dokumentumot.

Események jelentése

Ha oka van azt gondolni, hogy a jelen készülék használata közben súlyos esemény következett be, kérjük, hogy jelentse a gyártónak. Az Európai Unióban tartózkodó ügyfeleknek a gyártó, valamint a belföldi hatóságok felé is jelenteniük kell a súlyos eseményt.

Korlátozott jótállás

Az Abbott Medical jótállást vállal azért, hogy rendeltetésszerű használat mellett termékei mentesek maradnak az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ez a jótállás nem terjed ki a termékcímkéken feltüntetett „Lejárati dátumon" túlra. A termékeinkre vonatkozó engedélyezett használatot és jóváhagyott használati módszereket az egyes termékekhez mellékelt „Használati utasítás" ismerteti. Az Abbott Medical elutasít minden felelősséget és kötelezettséget abban az esetben, ha termékeit olyan módon használják fel, amelyet nem engedélyezett vagy nem hagyott jóvá. Az Abbott Medical kötelezettsége ezen jótállás keretében csak a termék cseréjére terjed ki. A fent említett jótállás kizár és helyettesít minden más garanciát, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, beleértve, de nem kizárólagosan minden, az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást. A speciális jogszabályokban kifejezetteken kívül az Abbott Medical semmilyen kötelezettséget nem vállal véletlen vagy következményes veszteség, kár vagy költség vonatkozásában, amely akár közvetve, akár közvetlenül a jelen eszköz használatából származik. Az Abbott Medical nem vállal magára, és mást sem hatalmaz fel arra, hogy magára vállaljon bármilyen más vagy kiegészítő kötelezettséget a termékkel kapcsolatos veszteség, kár vagy költség esetében. További részletekért tekintse át az Abbott Medical teljes jótállási szabályzatát, amelyet beszerezhet az Abbott Medical vállalattól, illetve amely az Abbott Medical által kiállított számla hátoldalán is megtalálható.

Szimbólumok

A terméken, illetve a termékcímkén az alábbiakban felsorolt szimbólumok és harmonizált szimbólumok szerepelhetnek. A harmonizált szimbólumokat lásd a medical.abbott/manuals weboldalon található Általános szimbólumgyűjteményben.

Szimbólum	Magyarázat
Series	Sorozat
Contents	Tartalom
Transseptal Needle	Transzszeptális tű
	Egyetlen steril védőrendszer
	Hosszúság
℞ ONLY	FIGYELEM! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre forgalmazható.
CE 2797	Conformité Européenne (európai megfelelőség). Az Európai Tanács 2017/745 rendeletével összhangban. Az Abbott Medical kijelenti, hogy az eszköz megfelel ezen rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
	Importőr
UK CA 0086	Az Egyesült Királyság előírásainak való megfelelőség kiértékelése
UKRP	Felelős személy az Egyesült Királyságban
UA.TR.101	Ukrán megfelelőségi jelölés a műszaki rendelkezésekre vonatkozóan, ahol a 101 az értékelő testület.
MD	Orvostechnikai eszköz
UDI	Egyedi eszközazonosító
medical.abbott/manuals	Kövesse a weboldalon található használati utasítást
(7440-48-4) (7439-92-1)	Veszélyes anyagokat tartalmaz. (Kobalt, CAS-szám: 7440-48-4) (Ólom, CAS-szám: 7439-92-1)

IT: Italiano

BRK™ Ago transettale

Istruzioni per l'uso

Descrizione

L'ago transettale BRK™ consiste in un ago in acciaio inossidabile con lume e in uno stiletto pieno in acciaio inossidabile. La sezione distale dell'ago è curva per facilitare il posizionamento all'interno del cuore quando viene utilizzato con set di guaina transettale di Abbott Medical. All'interno di questa sezione curva, è presente un netto abbassamento del diametro esterno dell'ago per consentire l'accoppiamento con il diametro interno del dilatatore di un set di guaina transettale di Abbott Medical. La punta distale dell'ago è smussata per facilitare il processo di foratura. L'estremità prossimale dell'ago è configurata con una flangia dell'indicatore (che indica l'orientamento della curva distale) ed è dotata di un rubinetto a 2 vie per garantire l'accesso al lume dell'ago per aspirazione, iniezione/infusione di liquidi, prelievo di sangue, monitoraggio della pressione e inserimento dello stiletto e/o del filo guida (diametro massimo del filo guida di 0,014 pollici per un ago calibro di 18; diametro massimo del filo guida di 0,012 pollici per un ago calibro 19). Lo stiletto è dritto e isodiametrico per tutta la lunghezza. L'estremità prossimale dello stiletto è dotata di una clip curva per bloccarsi sul mozzo prossimale dell'ago durante l'inserimento nel lume dell'ago. Lo stiletto è progettato per facilitare l'avanzamento dell'ago all'interno del dilatatore. L'ago è disponibile in varie lunghezze e configurazioni della curva distale utilizzabili.

Uso previsto

L'ago transettale BRK™ è destinato a essere utilizzato per forare il setto interatriale e accedere alla parte sinistra del cuore.

Indicazioni per l'uso

L'ago transettale BRK™ viene utilizzato per forare il setto interatriale durante una procedura di cateterismo transettale e accedere alla parte sinistra del cuore.

Pazienti destinatari

L'ago transettale BRK™ è destinato all'uso in pazienti emodinamicamente stabili che necessitano dell'accesso con catetere alla parte sinistra del cuore. Potrebbe essere necessario prestare particolare attenzione se l'ago transettale BRK™ viene utilizzato in pazienti con le seguenti condizioni:

- Rotazione cardiaca
- Dilatazione della radice aortica
- Marcata dilatazione dell'atrio destro
- Scoliosi/Cifosi
- Configurazione anomala dell'atrio sinistro
- Malformazioni congenite
- Malformazioni vascolari
- Impossibilità di accedere all'atrio destro attraverso la vena cava inferiore

Destinatari

Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente dai medici che sono stati specificamente formati per le procedure transettali, in un laboratorio di elettrofisiologia operativo completamente attrezzato.

Benefici clinici

Il beneficio clinico previsto dell'ago transettale BRK™ consiste nel forare il setto interatriale durante una procedura di cateterismo transettale al fine di accedere alla parte sinistra del cuore per consentire ai dispositivi che necessitano dell'accesso endocardico alla parte sinistra del cuore di ottenere il beneficio clinico previsto (ad esempio, un catetere per ablazione). L'ottenimento del beneficio clinico viene confermato dalla corretta foratura del setto interatriale.

Controindicazioni

- Precedente patch del setto interatriale o dispositivo protesico per la chiusura del difetto del setto interatriale
- Qualsiasi evento tromboembolico pregresso
- Mixoma atriale sinistro accertato o sospetto
- Infarto del miocardio accertato o sospetto nelle ultime due settimane
- Angina instabile
- Accidente cerebrovascolare (CVA) recente
- Pazienti che non tollerano la terapia anticoagulante
- Pazienti con un'infezione attiva

Avvertenze

- Non alterare questo dispositivo in alcun modo.
- Questo dispositivo è destinato a essere utilizzato una sola volta: non deve essere ritrattato o riutilizzato. Annotare la "Data di scadenza" indicata sulla confezione. Qualsiasi tentativo di risterilizzazione e riutilizzo di questo sistema potrebbe comprometterne l'integrità. Gli effetti avversi dell'utilizzo di componenti non sterili possono includere, ma non sono limitati a:
  - Infezione o reazione locale e sistemica
  - Danni meccanici
  - Funzionalità non accurata
- I materiali indicati di seguito per prodotto possono causare reazioni allergiche o di ipersensibilità. Le persone allergiche a tali materiali potrebbero manifestare una reazione allergica a questo prodotto. Prima dell'utilizzo sul paziente, quest'ultimo deve essere informato sui materiali contenuti nel dispositivo e devono essere analizzate attentamente eventuali allergie:
  - Acciaio inossidabile
  - Adesivo epossidico
  - Ottone cromato e nichelato
  - Grasso al silicone per alto vuoto (Dupont)
  - Master Bond
- L'uso improprio di questo dispositivo può provocare gravi complicanze.
- Nelle procedure di cateterismo cardiaco, sia i pazienti sia il personale di laboratorio potrebbero essere esposti a una quantità significativa di raggi X. Tale esposizione potrebbe provocare lesioni acute da radiazioni e aumentare il rischio di effetti somatici e genetici dovuti all'intensità del fascio di raggi X e alla durata dell'imaging fluoroscopico. Valutare attentamente l'uso di questo dispositivo nelle donne in gravidanza.

Precauzioni

- La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a medici o su prescrizione medica.
- Leggere le istruzioni prima dell'uso.
- Ispezionare la confezione prima dell'uso. Non usare se la confezione è aperta o danneggiata.
- Ispezionare tutti i componenti prima dell'uso.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

- Prima della procedura, è necessario che il paziente sia emodinamicamente stabile. Nell'impiego del prodotto, potrebbe essere necessaria un'attenzione speciale qualora il paziente presenti specifiche condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo:
  - Rotazione cardiaca
  - Dilatazione della radice aortica
  - Marcata dilatazione dell'atrio destro
  - Scoliosi/Cifosi
  - Configurazione anomala dell'atrio sinistro
  - Malformazioni congenite
  - Malformazioni vascolari
  - Impossibilità di accedere all'atrio destro attraverso la vena cava inferiore
- Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente dai medici che sono stati specificamente formati per le procedure transettali, in un laboratorio di elettrofisiologia (EP) operativo completamente attrezzato.
- L'avanzamento del catetere deve essere eseguito sotto guida fluoroscopica per ridurre al minimo il rischio di danno, perforazione o tamponamento cardiaco. Possono essere valutati anche sistemi di navigazione e visualizzazione in tempo reale compatibili.
- Durante l'inserimento, verificare che non sia presente una resistenza eccessiva durante l'avanzamento della punta dell'ago attraverso la curvatura del gruppo guaina/dilatatore. In caso di resistenza all'avanzamento dell'ago, ritrarre l'ago e valutare i componenti.
- Durante l'inserimento, fare attenzione a non creare piegature eccessive in questo dispositivo. Infatti, ciò potrebbe bloccare l'avanzamento dell'ago e provocare forature involontarie del gruppo dilatatore/guaina da parte dell'ago.
- Durante l'inserimento, utilizzare sempre lo stiletto per facilitare il passaggio dell'ago attraverso il gruppo dilatatore/guaina. Il mancato utilizzo dello stiletto potrebbe bloccare l'avanzamento dell'ago e provocare forature involontarie del gruppo dilatatore/guaina da parte dell'ago o il distacco di materiale dalla superficie interna del dilatatore.
- In caso di ingresso nel pericardio o nell'aorta, non far avanzare il dilatatore sopra l'ago. Se l'ago è penetrato nel pericardio o nell'aorta, è necessario ritrarlo. Monitorare attentamente i parametri vitali.
- Esiste il rischio di infiltrazioni d'aria in caso di ritrazione di oggetti dalla valvola emostatica della guaina. Adottare delle precauzioni per evitare infiltrazioni d'aria ritraendo lentamente gli oggetti in modo da impedire la formazione di vuoto nella guaina e monitorare fluoroscopicamente la guaina durante il successivo inserimento del dispositivo per escludere la presenza di aria.
- Dopo l'uso, questo dispositivo, i suoi accessori e la confezione devono essere opportunamente classificati per lo smaltimento, ad es. rischio biologico, oggetti appuntiti o taglienti, rifiuti non pericolosi ecc., e smaltiti attentamente in conformità alle procedure della struttura, alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- Uno o più componenti di questo dispositivo potrebbero contenere la seguente sostanza definita CMR 1B in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p: cobalto: Chemical Abstracts Service (CAS) n. 7440-48-4; CE n. 231-158-0. Le attuali evidenze scientifiche rivelano che i dispositivi medici fabbricati con leghe di cobalto e leghe di acciaio inossidabile contenenti cobalto non causano un aumento del rischio di cancro o effetti avversi sulla riproduzione.

  Uno o più componenti di questo dispositivo potrebbero contenere la seguente sostanza definita CMR 1A in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p: piombo: Chemical Abstracts Service (CAS) n. 7439-92-1; CE n. 231-100-4. Le attuali evidenze scientifiche indicano che i dispositivi medici fabbricati con piombo non causano un aumento del rischio di cancro o effetti avversi sulla riproduzione.

Potenziali eventi avversi

Categoria di evento avverso	Sottocategoria di evento avverso
Emorragia	Emorragia/Sanguinamento
	Ematoma
Lesione cerebrale	Emboli cerebrali asintomatici
	Ictus/accidente cerebrovascolare
	Attacco ischemico transitorio (TIA)
Embolia	Embolia gassosa
	Embolia da corpo estraneo
	Embolia polmonare
	Tromboembolia
	Trombosi/Trombo
Perforazione cardiaca	Tamponamento cardiaco
	Versamento pericardico
Lesione cardiovascolare	Danno valvolare
	Foratura della radice aortica
	Perforazione atriale
Disturbo del sistema di conduzione	Blocco del nodo SA, del nodo AV o del sistema His-Purkinje
	Aritmie cardiache
Reazione immunologica	Anafilassi
Infezione	Pericardite
	Endocardite
	Polmonite
	Sepsi
Dolore/Fastidio	Dolore, inguine, torace (dolore toracico generale non associato a IM)
Lesione vascolare periferica	Dissezione
	Lacerazione
	Formazione di fistole artero-venose
	Formazione di pseudoaneurismi
Ipotensione	N/D
Lesione tissutale superficiale	N/D

Indicazioni

Preparazione e montaggio dell'apparecchiatura

1. Rimuovere il contenuto dalla confezione.

   NOTA: non montare la guaina e il dilatatore.

2. Irrigare il dilatatore e la guaina con soluzione fisiologica eparinizzata.
3. Chiudere il rubinetto della guaina.
4. Rimuovere lo stiletto dall'ago e sciacquare l'ago con soluzione salina eparinizzata.
5. Inserire lo stiletto nell'ago e bloccarlo sul mozzo.
6. Inserire completamente il dilatatore nella guaina transettale.

Avanzamento del gruppo guaina/dilatatore nella vena cava superiore

1. Ottenere l'accesso venoso femorale (preferibilmente femorale destro).

   FACOLTATIVO: è possibile utilizzare una guaina di lunghezza standard maggiore (misura maggiore di ≥2,5 French rispetto a quella della guaina transettale) per ottenere e mantenere l'accesso venoso per la sostituzione del dispositivo e l'emostasi.

2. Introdurre un filo guida di 0,032 pollici, 150 - 180 centimetri, con punta "J" di 3 mm nella vena cava superiore (VCS).

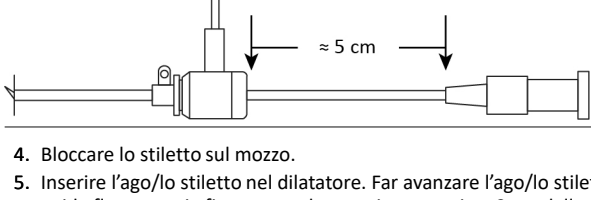
   NOTA: 0,032 pollici corrisponde al diametro massimo del filo guida utilizzabile con il dilatatore.

3. Inserire la guaina/il dilatatore nella vena sopra il filo guida fino a quando la punta della guaina non si trova nella VCS. Orientare la punta del dilatatore in direzione mediale.

Posizionamento del gruppo ago/stiletto all'interno del gruppo guaina/dilatatore

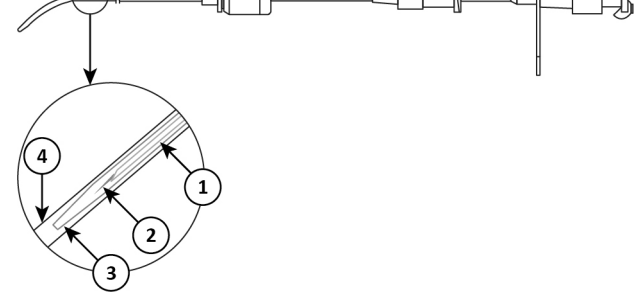
1. Rimuovere il filo guida dal dilatatore.
2. Aspirare completamente e in seguito irrigare il dilatatore con soluzione salina eparinizzata.
3. Ritrarre il dilatatore di circa 5 cm (vedere la figura di seguito) per facilitare il passaggio della curva dell'ago attraverso i mozzi rigidi del dilatatore e della guaina.

Figura 1. Ritrazione del dilatatore



4. Bloccare lo stiletto sul mozzo.
5. Inserire l'ago/lo stiletto nel dilatatore. Far avanzare l'ago/lo stiletto sotto guida fluoroscopia fino a quando non si trova a circa 2 cm dalla punta del dilatatore all'interno della guaina (vedere la figura di seguito).

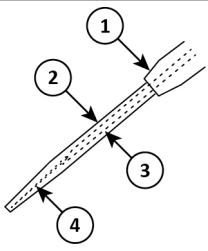
Figura 2. Inserimento dell'ago/dello stiletto nel dilatatore



1. Ago
2. Stiletto
3. Punta del dilatatore
4. Guaina

6. Per ricollegare la guaina e il dilatatore, far avanzare contemporaneamente il dilatatore e l'ago/lo stiletto nella guaina sotto guida fluoroscopica. Assicurarsi che la posizione dell'ago all'interno del dilatatore non cambi quando entrambi i componenti vengono fatti avanzare insieme. Mantenere la posizione della punta della guaina nella VCS.
7. Sotto guida fluoroscopica, far avanzare l'ago/lo stiletto fino a quando lo stiletto non si trova in posizione appena prossimale rispetto alla punta del dilatatore (vedere la figura di seguito).

Figura 3. Avanzamento dell'ago/dello stiletto



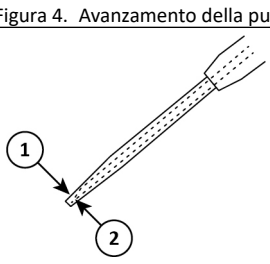
1. Punta della guaina
2. Dilatatore
3. Ago
4. Stiletto

8. Rimuovere lo stiletto e non gettarlo.
9. Aspirare l'ago fino a quando non si osserva il ritorno del sangue. Gettare la siringa.

   NOTA: l'uso di una siringa a punta scorrevole (non Luer-Lok‡) potrebbe impedire l'aspirazione dell'aria.

10. Sciacquare l'ago con soluzione fisiologica eparinizzata. Chiudere il rubinetto.
11. Far avanzare l'ago sotto guida fluoroscopica fino a quando la punta dell'ago è in posizione appena prossimale rispetto alla punta del dilatatore (vedere la figura di seguito).

Figura 4. Avanzamento della punta dell'ago



1. Punta del dilatatore
2. Punta dell'ago

FACOLTATIVO: collegare un rubinetto rotante a 3 vie al mozzo dell'ago.

FACOLTATIVO: collegare una siringa con mezzo di contrasto radiopaco al rubinetto. Aspirare l'ago. In seguito caricare l'ago con il mezzo di contrasto sotto guida fluoroscopica.

FACOLTATIVO: collegare una linea di monitoraggio della pressione al rubinetto.

FACOLTATIVO: utilizzare una configurazione del collettore a 3 porte standard per collegare le linee di mezzo di contrasto, pressione e irrigazione.

Raggiungimento della fossa ovale

1. Visualizzare e individuare i punti di riferimento anatomici.
2. Impostare l'unità fluoroscopica su un angolo parallelo al piano della valvola mitrale e ortogonale al piano del setto. Questo sarà generalmente obliquo anteriore sinistro (LAO), approssimativamente da 30 a 40 gradi.

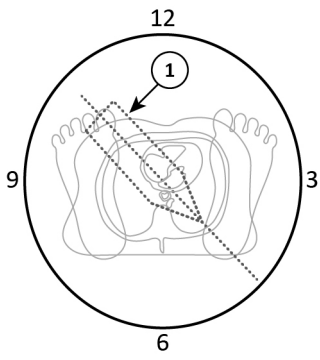
   FACOLTATIVO: durante le procedure EP, le posizioni del seno coronarico e del catetere sul fascio di His possono fungere da utili punti di riferimento anatomici. Nella vista LAO adeguata, il catetere del seno coronarico viene visualizzato di profilo. Nella vista obliqua anteriore destra (RAO) adeguata, il catetere sul fascio di His viene visualizzato di profilo. La fossa ovale è allo stesso livello, o leggermente al di sotto, del catetere sul fascio di His e in posizione superiore e posteriore rispetto all'ostio del seno coronarico.

   FACOLTATIVO: il posizionamento di un catetere di monitoraggio angiografico/emodinamico pigtail nella cuspide non coronarica della valvola aortica può fungere da utile punto di riferimento anatomico.

   FACOLTATIVO: osservare la forma d'onda della pressione registrata attraverso l'ago transettale BRK™.

3. Regolare la flangia dell'indicatore in modo tale che l'ago sia perpendicolare alla fossa ovale (in genere tra la posizione a ore 3:00 e quella a ore 5:00, osservata dall'estremità dei piedi del paziente). (Vedere la figura di seguito.)

Figura 5. Flangia dell'indicatore dell'ago

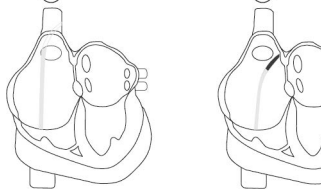


1. Flangia dell'indicatore dell'ago

4. Utilizzare la fluoroscopia per confermare che la punta dell'ago sia all'interno del dilatatore.
5. Dopo tale conferma, trascinare lentamente l'intero gruppo guaina/dilatatore/ago. Impedire qualsiasi movimento di ciascuna parte del gruppo rispetto alle altre. È fondamentale mantenere l'orientamento precedente della flangia dell'indicatore durante il trascinamento del gruppo.
6. Nella vista LAO (ortogonale rispetto al setto interatriale) osservare la punta del dilatatore durante il trascinamento per individuare un netto movimento mediale (o verso destra), che indica che la punta ha raggiunto la fossa ovale. (Vedere le figure di seguito.)

   NOTA: se la fossa ovale è pervia alla sonda, la punta del dilatatore ora si sposta facilmente nell'atrio sinistro.

Figura 6. Raggiungimento della fossa ovale



1. Posizione iniziale nella VCS
2. Movimento mediale iniziale nell'AD
3. Brusco movimento mediale sulla fossa ovale

NOTA: se la pressione viene monitorata attraverso l'ago, risulta imprecisa a questo punto perché la punta è posizionata contro la fossa ovale.

Perforazione della fossa ovale con l'ago transettale BRK™

1. Confermare la posizione corretta del gruppo guaina/dilatatore/ago sulla fossa ovale prima di far avanzare l'ago.
2. Dopo aver confermato la posizione corretta, estendere l'ago fino all'innesto completo all'interno del gruppo guaina/dilatatore e farlo avanzare attraverso il setto interatriale.

   FACOLTATIVO: sotto monitoraggio della pressione, l'ingresso nell'atrio sinistro viene confermato quando il tracciato della pressione mostra una forma d'onda della pressione atriale sinistra.

   FACOLTATIVO: l'accesso atriale sinistro può essere confermato tramite fluoroscopia con iniezioni del mezzo di contrasto.

3. In caso di resistenza all'avanzamento dell'ago, ritrarre quest'ultimo e valutare nuovamente i punti di riferimento anatomici.

   ATTENZIONE: in caso di ingresso nel pericardio o nell'aorta, non far avanzare il dilatatore sopra l'ago. Se l'ago è penetrato nel pericardio o nell'aorta, è necessario ritrarlo. Monitorare attentamente i parametri vitali.

Avanzamento del gruppo guaina/dilatatore nell'atrio sinistro

Mantenendo l'ago in posizione fissa nell'atrio sinistro, far avanzare completamente sopra l'ago il gruppo guaina-dilatatore nella cavità atriale sinistra.

Avanzamento della guaina sopra il dilatatore fisso e l'ago nell'atrio sinistro

1. Mantenere la posizione dell'ago e del dilatatore attraverso il setto.
2. Mantenendo il dilatatore in una posizione fissa, far avanzare completamente la guaina sopra il dilatatore nella cavità atriale sinistra.

Ritrazione dell'ago transettale BRK™ e del dilatatore

ATTENZIONE: esiste il rischio di infiltrazioni d'aria in caso di rimozione degli oggetti dalla valvola emostatica della guaina. Adottare delle precauzioni per evitare infiltrazioni d'aria ritraendo lentamente gli oggetti in modo da impedire la formazione di vuoto nella guaina e monitorare fluoroscopicamente la guaina durante il successivo inserimento del dispositivo per escludere la presenza di aria.

1. Ruotare il rubinetto dell'ago in posizione di chiusura e scollegare eventuali elementi collegati al mozzo dell'ago.

2. Rimuovere l'ago transettale BRK™ dal dilatatore. L'ago può essere pulito e messo da parte per essere riutilizzato durante questa procedura. In alternativa, gettare l'ago come richiesto per gli oggetti appuntiti o taglienti contaminati.
3. Collegare immediatamente una siringa al dilatatore e aspirare. Continuare ad aspirare il sangue mantenendo la guaina in posizione e ritraendo il dilatatore. Il sangue deve essere arterioso.
4. Dopo la rimozione del dilatatore, aspirare il sangue attraverso il braccio laterale della guaina. Irrigare attentamente il braccio laterale della guaina con soluzione fisiologica eparinizzata per evitare la formazione di bolle d'aria.
5. Ora la guaina è in posizione nell'atrio sinistro.

Confezione e conservazione

L'ago transettale BRK™ viene fornito sterile. L'ago è confezionato con uno stiletto inserito. L'ago e lo stiletto sono inseriti nella confezione primaria. La confezione primaria è posta all'interno di un sacchetto Mylar‡ e Tyvek‡ termosaldato. Il sacchetto e le presenti istruzioni per l'uso vengono quindi inseriti in una scatola, sigillata a entrambe le estremità. Sia il sacchetto sia la scatola hanno un'etichetta recante le informazioni sul prodotto, inclusa la data di scadenza. Sull'etichetta dei prodotti è indicata una durata di conservazione di tre anni.

Riepilogo dei dati clinici

Per i Paesi dell'Unione europea: una sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica (SSCP) per questi dispositivi sarà pubblicata all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed dagli Organismi notificati in conformità ai requisiti del regolamento MDR 2017/745 dell'UE e alle relative tempistiche. Cercare il dispositivo mediante l'UDI-DI indicato sulla confezione esterna del dispositivo. L'UDI-DI è il numero di 14 cifre tra le prime due serie di parentesi. Per maggiori informazioni su come trovare e utilizzare l'UDI-DI, fare riferimento al documento relativo alle domande frequenti disponibile all'indirizzo medical.abbott/manuals.

Segnalazione degli incidenti

Se, durante l'utilizzo di questo dispositivo, si ha motivo di credere che si sia verificato un incidente grave, informare il produttore. Per i clienti residenti nell'Unione europea, eventuali incidenti gravi devono essere segnalati sia al produttore sia alle autorità statali.

Garanzia limitata

Abbott Medical garantisce che i propri prodotti, in normali condizioni di utilizzo, sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione. La presente garanzia non è valida oltre la data di "Scadenza" indicata sull'etichetta di ogni prodotto. Gli usi autorizzati e i metodi approvati per l'uso di ogni prodotto sono indicati nelle relative "Istruzioni per l'uso" allegate a ogni prodotto. Abbott Medical declina ogni responsabilità per l'uso dei propri prodotti in modi non autorizzati o approvati. La responsabilità di Abbott Medical prevista dalla presente garanzia è limitata alla sostituzione dei propri prodotti. La precedente garanzia esclude e sostituisce ogni altra garanzia espressa o implicita incluse, ma non in via limitativa, eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Abbott Medical non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita incidentale o consequenziale, danno o spesa risultante direttamente o indirettamente dall'uso di questo prodotto, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto da leggi specifiche. Abbott Medical non si assume né autorizza altre persone ad assumersi in sua vece alcuna altra o ulteriore responsabilità per perdita, danno o spesa in relazione a questo prodotto. Per maggiori dettagli, consultare la politica di garanzia completa di Abbott Medical disponibile presso Abbott Medical o riportata sul retro di una fattura Abbott Medical.

Simboli

I seguenti simboli e i simboli armonizzati sono disponibili sul prodotto o sulla sua etichetta. Per i simboli armonizzati, consultare il Glossario dei simboli universali all'indirizzo medical.abbott/manuals.

Simbolo	Definizione
Series	Serie
Contents	Contenuto
Transseptal Needle	Ago transettale
	Sistema a barriera sterile singola
	Lunghezza
℞ ONLY	ATTENZIONE: La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a medici o su prescrizione medica.
CE 2797	Conformité Européenne (Conformità europea). Apposto in conformità al Regolamento del Consiglio europeo 2017/745. Con la presente, Abbott Medical dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento.
	Importatore
UK CA 0086	Sottoposto a valutazione della conformità per il Regno Unito
UKRP	Persona responsabile nel Regno Unito
UA.TR.101	Marchio ucraino di conformità ai regolamenti tecnici; il numero 101 corrisponde all'organismo di valutazione.
MD	Dispositivo medico
UDI	Identificazione unica del dispositivo
medical.abbott/manuals	Seguire le istruzioni per l'uso riportate su questo sito web
(7440-48-4) (7439-92-1)	Contiene sostanze pericolose. (Cobalto CAS n. 7440-48-4) (Piombo CAS n. 7439-92-1)

KO: 한국어

BRK™ 경중격 바늘
사용 설명서

설명

BRK™ 경중격 바늘은 루미날 스테인리스 스틸 바늘과 솔리드 스테인리스 스틸 스타일렛으로 구성됩니다. 바늘의 말단부는 Abbott Medical의 경중격 삽입관 세트와 함께 사용할 때 심장 내부에 쉽게 배치할 수 있도록 곡선형으로 제조되었습니다. 이 곡선형 부분 안에는 Abbott Medical의 경중격 삽입관 세트의 확장기 내경과 연결할 수 있도록 바늘 외경이 계단형으로 급격하게 감소합니다. 바늘의 말단부 팁은 천자 과정을 쉽게 수행할 수 있도록 비스듬한 모양입니다. 바늘의 근접위 끝은 포인터 플랜지(말단부 곡선 방향을 표시함)로 구성되며 바늘에서 흡인, 액체 주입, 혈액 검사, 압력 모니터링, 스타일렛 및/또는 가이드 와이어 삽입 등을 위한 공동에 접근할 수 있는 2방향 콕 마개가 달려 있습니다(18게이지 바늘의 경우 최대 가이드 와이어 직경 0.014", 19게이지 바늘의 경우 최대 가이드 와이어 직경 0.012"). 스타일렛은 길이 전체에 걸쳐 직선이고 동측입니다. 스타일렛의 근접위 끝에는 바늘 공동에 삽입할 때 근접위 바늘 중심부에 잠그기 위한 곡선 클립이 달려 있습니다. 스타일렛은 확장기 내에서 바늘이 쉽게 진행할 수 있도록 설계되었습니다. 바늘은 다양한 가용 길이와 말단부 곡선 구성으로 사용할 수 있습니다.

용도

BRK™ 경중격 바늘은 왼쪽 심장에 접근하기 위한 심방간 중격 천자에 사용합니다.

적응증

BRK™ 경중격 바늘은 왼쪽 심장에 접근하기 위한 경중격 카테터 삽입 시술 중 심방간 중격 천자에 사용합니다.

환자 대상 그룹

BRK™ 경중격 바늘은 왼쪽 심장 카테터에 접근해야 하는 혈류역학적으로 안정적인 환자에게 사용합니다. BRK™ 경중격 바늘을 사용하려면 다음 조건의 환자를 특별히 고려해야 할 수 있습니다.

- 심장 회전
- 대동맥 근부 비대
- 우심방 비대 표시
- 척추 측만증/척추 후만증
- 비정상적인 좌심방 구조
- 선천성 기형
- 혈관 기형
- 하대정맥을 통해 우심방에 접근할 수 없음

의도된 사용자

설비가 완전하게 갖추어진 전기생리학 실험실에서 경중격 시술에 대한 특별한 교육을 받은 의사만 이 기기를 사용해야 합니다.

임상 이점

BRK™ 경중격 바늘의 임상적 이익은 좌심 내막에 접근해야 하는 기기가 절제 카테터와 같은 임상적 이익을 달성할 수 있도록 왼쪽 심장에 접근하는 경중격 카테터 삽입 시술 중 심방간 중격을 천자하는 것입니다. 이는 심방간 중격의 천자에 의해 측정됩니다.

금기사항

- 이전에 심방간 중격 패치 또는 인공 심방 중격 결손 폐쇄 기기 사용.
- 이전에 혈전색전성 사례 발생.
- 좌심방 점액종이 알려지거나 의심됨.
- 지난 2주 이내에 심근 경색이 알려지거나 의심됨.
- 불안정 협심증.
- 최근 뇌졸중 발생(CVA).
- 항응고 치료를 견디지 못하는 환자.
- 활성 감염 환자.

경고

- 본 기기를 어떠한 방식으로든 개조하지 마십시오.
- 이 기기는 일회용입니다. 재처리하거나 재사용하지 마십시오. 패키지의 제품 "사용 기한" 날짜를 확인하십시오. 재멸균 및 재사용할 경우, 이 시스템의 무결성이 손상될 수 있습니다. 비멸균 구성품을 사용할 경우 다음을 포함한 여러 부작용이 발생할 수 있습니다.
  - 국소 및 전신 감염 또는 반응
  - 기계적 손상
  - 부정확한 기능
- 제품별로 아래에 명시된 재질은 알레르기 또는 과민 반응을 일으킬 수 있습니다. 이러한 재질에 대하여 알레르기가 있는 사람은 본 제품에 대해 알레르기 반응을 보일 수 있습니다. 기기를 환자에게 사용하기 전에 기기에 포함된 재질에 대해 환자와 상담해야 하며 자세한 알레르기 병력을 논의해야 합니다.
  - 스테인리스 스틸
  - 에폭시 접착제
  - 니켈 크롬이 도금된 황동
  - 실리콘 고진공 그리스(DuPont)
  - Master Bond
- 이 기기를 잘못 사용하면 심각한 합병증이 발생할 수 있습니다.
- 심장 카테터 삽입 시술은 환자와 실험실 직원 모두에게 상당한 X-레이 노출의 가능성이 있으며, X-레이 광선 강도와 형광 투시 영상 촬영 중 노출 시간으로 인해 급성 방사선 손상을 야기하고 신체적 및 유전적 영향의 위험을 높일 수 있습니다. 임산부에 대한 기기 사용은 신중하게 고려해야 합니다.

주의 사항

- 미국 연방법에 따라 본 기기는 의사가 직접 판매하거나 의사의 지시에 따라서만 판매할 수 있습니다.
- 사용하기 전에 지침을 읽어 보십시오.
- 사용 전에 패키지를 검사합니다. 포장이 개봉되거나 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에 모든 구성품을 점검하십시오.
- 서늘하고 어둡고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 시술 전에 환자는 혈류역학적으로 안정적이어야 합니다. 특정 조건에서 이 제품을 사용할 때 특별한 고려 사항이 필요할 수 있습니다. 이러한 조건에는 다음 항목이 제한 없이 포함될 수 있습니다.
  - 심장 회전
  - 대동맥 근부 비대
  - 우심방 비대 표시
  - 척추 측만증/척추 후만증
  - 비정상적인 좌심방 구조
  - 선천성 기형
  - 혈관 기형
  - 하대정맥을 통해 우심방에 접근할 수 없음

- 설비가 완전하게 갖추어진 전기생리학(EP) 실험실에서 경중격 시술에 대한 특별한 교육을 받은 의사만 이 기기를 사용해야 합니다.
- 카테터 삽입은 심장 손상, 천공 또는 심낭 압전증의 위험을 최소화하기 위해 형광 투시 검사하에 수행되어야 합니다. 호환 가능한 탐색 및 실시간 시각화 시스템도 고려할 수 있습니다.
- 삽입 중에 삽입관/확장기 어셈블리 굴곡을 통해 바늘 끝이 진행할 때 과도한 저항이 있는지 확인하십시오. 바늘 진행에 저항이 있는 경우, 바늘을 뒤로 빼고 구성품을 평가하십시오.
- 삽입 중에 본 기기가 과도하게 구부러지지 않도록 주의하십시오. 기기가 과도하게 구부러지면 바늘이 진행하지 못할 수 있으며, 확장기/삽입관 어셈블리에 우발적으로 바늘 구멍이 생길 수 있습니다.
- 삽입 중에는 항상 스타일렛을 사용하여 확장기/삽입관 어셈블리로 바늘이 잘 통과하도록 하십시오. 스타일렛을 사용하지 않으면 바늘이 진행하지 못할 수 있으며, 확장기/삽입관 어셈블리에 우발적으로 바늘 구멍이 생기거나 확장기 내부 표면의 소재가 벗겨질 수 있습니다.
- 심낭강 또는 대동맥 진입이 발생하면 바늘을 통해 확장기를 진행시키지 마십시오. 바늘이 심낭이나 대동맥을 관통한 경우 바늘을 빼야 합니다. 활력 징후를 긴밀하게 모니터링하십시오.
- 삽입관의 지혈 밸브에서 물체를 빼낼 때 공기가 침입할 위험이 있습니다. 삽입관 안에 진공이 형성되지 않도록 물체를 천천히 빼내어 공기가 침입하지 않도록 주의하고 형광 투시 검사를 통해 삽입관을 모니터링하면서 기기 삽입으로 인한 공기가 있는지 확인하십시오.
- 사용 후 본 기기, 부속품 및 포장은 폐기를 위해 적합하게 분류되어야 하며(예: 생물학적 위험물, 날카로운 물건, 비위험 폐기물 등), 시설 절차와 해당 법률 및 규정에 따라 신중하게 폐기되어야 합니다.
- 이 기기의 하나 이상의 구성품에는 중량 기준 0.1%가 넘는 농도로 CMR 1B로 정의된 다음과 같은 물질이 포함될 수 있습니다. 납: Chemical Abstracts Service(CAS) No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0. 현재의 과학적 증거는 코발트 합금 및 코발트를 함유한 스테인리스 합금으로 제조된 의료 기기가 암 위험 증가 또는 생식 기능 저하를 일으키지 않는다는 것을 뒷받침합니다.

  이 기기의 하나 이상의 구성품에는 중량 기준 0.1%가 넘는 농도로 CMR 1A로 정의된 다음과 같은 물질이 포함될 수 있습니다. 전극선: Chemical Abstracts Service(CAS) No. 7439-92-1; EC No. 231-100-4. 현재의 과학적 증거는 납으로 제조된 의료 기기가 암 발생 위험의 증가나 생식 기능 저하를 유발하지 않는다는 것을 뒷받침합니다.

발생 가능한 부작용 사례

부작용 사례 범주	부작용 사례 하위 범주
출혈	출혈
	혈종
뇌 손상	무증상 뇌색전증
	뇌졸중/뇌혈관 사고
	일과성 허혈 발작(TIA)
색전증	공기 색전증
	이물질 색전증
	폐색전증
	혈전 색전증
	혈전증/혈전
심장 천공	심낭 압전증
	심낭 삼출
심혈관 손상	판막 손상
	대동맥 근부 천자
	심방 천공
흉분 전도계 장애	SA 노드, AV 노드 또는 히스푸르킨예계 차단
	심장 부정맥
면역 반응	과민증
감염	심장막염
	심장내막염
	폐렴
	패혈증
통증/불편감	통증, 서혜부, 가슴(MI와 무관한 일반적인 흉통)
말초 혈관 손상	박리
	열상
	동정맥루 형성
	가성동맥류 형성
저혈압	해당 없음
표피 조직 손상	해당 없음

지침

장치를 준비하고 조립합니다

1. 포장에서 내용물을 꺼냅니다.

   참고: 삽입관과 확장기를 조립하지 마십시오.

2. 헤파린 첨가 생리 식염수로 확장기와 삽입관을 세척합니다.
3. 삽입관 콕 마개를 닫습니다.
4. 바늘에서 스타일렛을 분리하고 헤파린 첨가 생리 식염수로 바늘을 세척합니다.
5. 스타일렛을 바늘에 삽입하고 중심부에 잠급니다.
6. 확장기를 경중격 삽입관에 완전히 삽입합니다.

삽입관/확장기 어셈블리를 상대정맥 안으로 진행시킵니다

1. 대퇴정맥 접근로를 확보합니다(오른쪽 대퇴 추천).

   OPT: 더 큰(경중격 삽입관보다 더 큰 ≥2.5 French 크기) 표준 길이 삽입관을 사용하여 기기 교환 및 지혈을 위한 정맥 접근로를 확보하고 유지할 수 있습니다.

2. 0.032인치, 150~180cm, 3mm “J” 팁 가이드 와이어를 SVC(상대정맥)에 삽입합니다.

   참고: 0.032"는 확장기에 사용할 수 있는 최대 가이드 와이어 직경입니다.

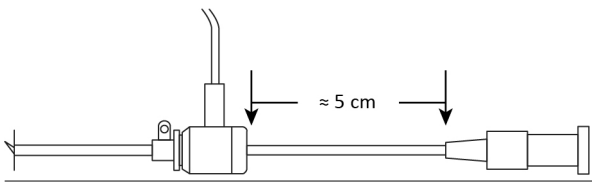
3. 삽입관 탭이 SVC에 도달할 때까지 가이드 와이어를 통해 삽입관/확장기를 정맥에 삽입합니다. 확장기 팁을 내측으로 향하게 합니다.

바늘/스타일렛 어셈블리를 삽입관/확장기 어셈블리 내부에 배치

1. 확장기에서 가이드 와이어를 제거합니다.
2. 완전히 흡인한 다음 확장기를 헤파린 첨가 식염수로 세척합니다.

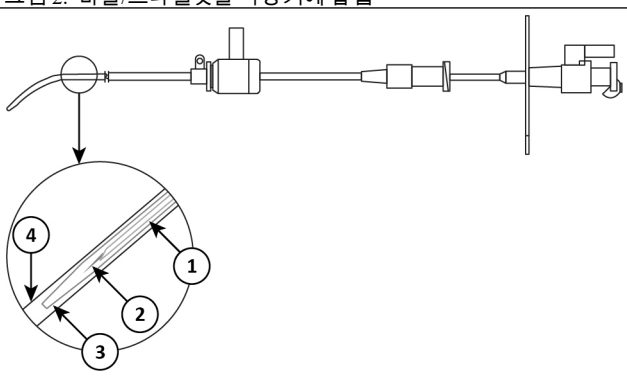
3. 확장기를 약 5cm(아래 그림 참조) 빼내어 바늘 곡선이 확장기와 삽입관의 단단한 중심부를 쉽게 통과할 수 있도록 합니다.

그림 1. 확장기 빼내기



4. 스타일렛을 중심부에 잠급니다.
5. 바늘/스타일렛을 확장기에 삽입합니다. 삽입관 내부의 확장기 팁에서 약 2cm 거리에 도달할 때까지 형광 투시 검사를 확인하면서 바늘/스타일렛을 진행시킵니다(아래 그림 참조).

그림 2. 바늘/스타일렛을 확장기에 삽입



1. 바늘
2. 스타일렛
3. 확장기 팁
4. 삽입관

6. 삽입관과 확장기를 다시 연결하려면 형광 투시 검사를 통해 확장기 및 바늘/스타일렛을 동시에 삽입관에 넣습니다. 두 구성품을 함께 진행시킬 때 확장기 내에서 바늘 위치가 바뀌지 않도록 해야 합니다. SVC에서 안에서 삽입관 팁 위치를 유지합니다.
7. 형광 투시 검사를 확인하면서 스타일렛이 확장기 팁의 바로 근접위에 배치될 때까지 바늘/스타일렛을 진행시킵니다(아래 그림 참조).

그림 3. 바늘/스타일렛 밀어 넣기

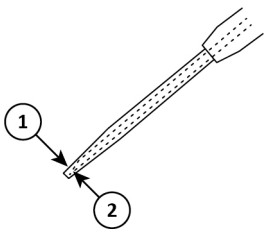
1. 삽입관 팁
2. 확장기
3. 바늘
4. 스타일렛

8. 스타일렛을 제거하고 폐기하지 마십시오.
9. 혈액이 돌아오는 것이 관찰될 때까지 바늘을 흡인합니다. 주사기를 폐기합니다.

   참고: 슬립-팁(Luer-Lok‡이 아닌) 주사기를 사용하면 공기를 흡인하지 못할 수 있습니다.

10. 헤파린 첨가 생리 식염수로 바늘을 세척합니다. 콕 마개를 닫습니다.
11. 바늘 팁이 확장기 팁의 바로 근접위에 도달할 때까지 형광 투시 검사를 확인하면서 바늘을 진행시킵니다(아래 그림 참조).

그림 4. 바늘 팁 밀어 넣기



1. 확장기 팁
2. 바늘 팁

OPT: 3방향 회전 콕 마개를 바늘 중심부에 부착합니다.

OPT: 방사선 비투과성 조영제가 들어 있는 주사기를 콕 마개에 부착합니다. 바늘을 흡인합니다. 그런 다음 형광 투시 안내를 통해 조영제가 들어 있는 바늘을 장착합니다.

OPT: 압력 모니터링 라인을 콕 마개에 연결합니다.

OPT: 표준 3포트 매니폴드 설정을 사용하여 조영제 라인, 압력 라인, 세척 라인을 연결합니다.

난원와에 맞물림

1. 해부학적 랜드마크를 시각화하고 식별합니다.
2. 승모판 평면과 평행하고 중격 평면과 직각이 되는 각도에 형광 투시 검사 장치를 설치합니다. 이 각도는 일반적으로 약 30 ~ 40도 LAO(좌전사위)입니다.

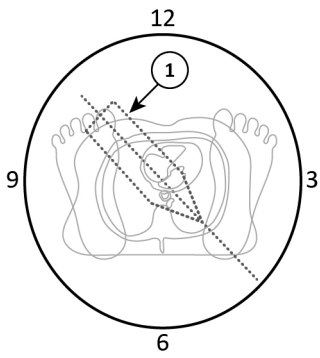
   OPT: EP 시술 중에 심장정맥굴 및 히스속 카테터 위치를 유용한 해부학적 랜드마크로 사용할 수 있습니다. 적절한 LAO 보기에서 심장정맥굴 카테터가 프로필에 표시됩니다. 적절한 RAO(우전사위) 보기에서 히스속 카테터가 프로필에 나타납니다. 난원와는 히스속 카테터와 동일한 수준 또는 약간 아래 수준과 심장정맥굴 입구의 상위 및 후위에 배치됩니다.

   OPT: 돼지꼬리형 혈류 조영/혈류 역학 모니터링 카테터를 대동맥판막의 무관상동맥 첨판에 배치하여 유용한 해부학적 랜드마크로 사용할 수 있습니다.

   OPT: BRK™ 경중격 바늘을 통해 기록되는 압력 파형을 관찰합니다.

3. 바늘이 난원와에 수직(일반적으로 환자의 발 끝에서 볼 때 3시 방향과 5시 방향 사이)이 되도록 포인터 플랜지를 조정합니다. (아래 그림 참조)

그림 5. 바늘 포인터 플랜지



1. 바늘 포인터 플랜지

4. 형광 투시 검사를 사용하여 확장기 내부에 바늘 팁이 있는지 확인합니다.
5. 바늘 끝이 확장기 내부에 있는지 확인한 후, 전체 삽입관/확장기/바늘 어셈블리를 천천히 끌어옵니다. 어셈블리 부분이 서로에 대해 움직이지 않도록 합니다. 어셈블리를 끌어오는 동안 포인터 플랜지의 이전 방향을 유지하는 것이 중요합니다.
6. LAO 보기에서(심방간 중격에 직각), 끌어오는 중에 확장기 팁을 관찰하여 팁이 난원와에 맞물렸음을 나타내는 갑작스러운 내측(또는 오른쪽 방향) 이동을 확인합니다. (아래 그림 참조)

   참고: 난원와가 탐침으로 개방된 경우, 확장기 팁이 좌심방에 쉽게 들어갑니다.

그림 6. 난원와에 맞물림



1. SVC에서 시작 위치
2. RA에서 초기 내측 이동
3. 난원와로 갑작스러운 내측 이동

참고: 바늘을 통해 압력을 모니터링하는 경우, 팁이 난원와에 맞닿아 있기 때문에 이 시점에서는 바늘을 통한 압력이 정확하지 않다는 점에 주의하십시오.

BRK™ 경중격 바늘로 난원와 천자

1. 바늘을 진행시키기 전에 난원와에서 삽입관/확장기/바늘 어셈블리의 올바른 위치를 확인합니다.
2. 올바른 위치가 확인되면, 바늘을 밀어 삽입관/확장기 어셈블리 내에 완전히 맞물리게 하고 심방간 중격을 가로질러 진행시킵니다.

   OPT: 압력을 모니터링하여 압력 추적에 좌심방 압력 파형이 표시되면 좌심방 진입이 확인됩니다.

   OPT: 조영제 주입 상태에서 형광 투시 검사를 통해 좌심방 접근을 확인할 수 있습니다.

3. 바늘 진행에 저항이 있으면 바늘을 뒤로 빼고 해부학적 랜드마크를 다시 평가합니다.

   주의: 심낭강 또는 대동맥 진입이 발생하면 바늘을 통해 확장기를 진행시키지 마십시오. 바늘이 심낭이나 대동맥을 관통한 경우 바늘을 빼야 합니다. 활력 징후를 긴밀하게 모니터링하십시오.

좌심방 안으로 삽입관/확장기 어셈블리 진행시킴

좌심방 내에서 고정된 바늘 위치를 유지하면서, 바늘을 통해 좌심방 공동 안으로 삽입관/확장기 어셈블리를 완전히 진행시킵니다.

고정된 확장기와 바늘을 통해 삽입관을 좌심방 안으로 밀어 넣음

1. 중격 전체에서 바늘 및 확장기의 위치를 유지합니다.
2. 고정된 위치에서 확장기를 유지하면서 확장기를 통해 좌심방 공동 안으로 삽입관을 완전히 진행시킵니다.

BRK™ 경중격 바늘 및 확장기를 빼냄

주의: 삽입관의 지혈 밸브에서 물체를 빼낼 때 공기가 침입할 위험이 있습니다. 삽입관 안에 진공이 형성되지 않도록 물체를 천천히 빼내어 공기가 침입하지 않도록 주의하고 형광 투시 검사를 통해 삽입관을 모니터링하면서 기기 삽입으로 인한 공기가 있는지 확인하십시오.

1. 바늘 콕 마개를 끄기 위치로 돌리고 바늘 중심부의 부착물을 모두 분리합니다.
2. 확장기에서 BRK™ 경중격 바늘을 제거합니다. 바늘을 세척하고 이 시술에서 반복 사용할 수 있도록 따로 둡니다. 그렇지 않으면 오염된 날카로운 물체에 적합한 방법으로 바늘을 폐기합니다.
3. 주사기를 확장기에 즉시 부착하고 흡인합니다. 삽입관을 제자리에 유지하고 확장기를 빼내면서 혈액을 계속 흡인합니다. 혈액은 동맥혈이어야 합니다.
4. 확장기를 제거하면 삽입관의 사이드 암을 통해 혈액을 흡인합니다. 기포가 생기지 않도록 주의하면서 헤파린 첨가 생리 식염수로 삽입관의 사이드 암을 조심스럽게 세척합니다.
5. 이제 삽입관이 좌심방에 배치됩니다.

패키지 및 보존 기간

BRK™ 경중격 바늘은 멸균 상태로 공급됩니다. 바늘은 스타일렛이 삽입된 상태로 포장됩니다. 바늘과 스타일렛은 기본 포장 안에 들어 있습니다. 기본 포장은 열 밀봉된 Mylar‡ 및 Tyvek‡ 파우치 안에 들어 있습니다. 그런 다음 파우치와 이 IFU는 상자 안에 들어 있으며 상자의 양쪽 끝은 모두 밀봉되어 있습니다. 파우치와 상자에는 모두 만료 날짜를 포함한 제품 정보가 표시된 라벨이 있습니다. 제품에는 보존 기간 3년이 표시된 라벨이 붙어 있습니다.

임상 데이터 요약

유럽 연합 국가의 경우: EU MDR 2017/745 및 관련 타임라인의 요건에 따라 인증 기관에서 이 기기의 안전 및 임상 성과(SSCP) 요약을 https://ec.europa.eu/tools/eudamed에 게시합니다. 기기의 외부 패키지에 있는 UDI-DI를 사용하여 기기를 검색하십시오. UDI-DI는 처음 두 괄호 세트 사이에 있는 14자리 숫자입니다. UDI-DI를 찾고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 medical.abbott/manuals의 자주 묻는 질문(FAQ) 문서를 참조하십시오.

사고 보고

이 기기를 사용하는 과정에서 심각한 사고가 발생했다고 판단할 근거가 있는 경우 제조업체에 보고하십시오. 유럽연합 내 고객의 경우 심각한 사고가 발생하면 제조업체뿐 아니라 국가 당국에도 보고하십시오.

제한적 보증

Abbott Medical은 제품을 정상적으로 사용한다는 전제하에 재료와 완성도에 결함이 없음을 보증합니다. 이 보증은 제품 레이블에 표시된 사용

"기한"이 지나면 적용되지 않습니다. 본 제품에 대한 인가된 사용 및 승인된 사용 방법은 본 제품과 함께 제공되는 "사용 설명서"에 명시되어 있습니다. Abbott Medical은 인가되거나 승인되지 않은 방법으로 제품을 사용하는 것에 대한 어떠한 의무 또는 책임을 부인합니다. 본 보증에 따른 Abbott Medical의 책임은 해당 제품의 교환으로 제한됩니다. 위에서 언급한 보증은 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증(이로만 국한되는 것은 아님)을 비롯한 모든 명시적 또는 묵시적 보증의 다른 모든 보증을 배제하며 대신합니다. Abbott Medical은 특별 법에 따라 명시될 경우를 제외하고, 본 제품의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 부수적 손해 또는 간접 손실, 손해, 직접적/간접적 비용에 대해 책임이 없습니다. Abbott Medical은 본 제품과 관련된 손실, 손해 또는 비용에 대해 다른 책임 또는 추가 책임이 없으며 제3자가 그러한 손실, 손해 또는 비용에 대해 책임을 지도록 허가하지도 않습니다. 자세한 내용은 Abbott Medical에서 제공하거나 Abbott Medical 송장 뒤에 나와 있는 Abbott Medical 보증 정책 전문을 참조하시기 바랍니다.

기호

제품이나 제품 라벨에서는 아래에 나와 있는 기호와 범용 기호를 볼 수 있습니다. 범용 기호에 대해서는 medical.abbott/manuals의 Universal Symbols Glossary(범용 기호 용어 설명)를 참조하십시오.

기호	정의
Series	시리즈
Contents	내용
Transseptal Needle	경중격 바늘
	일회용 멸균막 시스템
	길이
Rx ONLY	주의: 미국 연방법에 따라 본 기기는 의사가 직접 판매하거나 의사의 지시에 따라서만 판매할 수 있습니다.
CE 2797	유럽 규격(Conformité Européenne). 유럽 의회 규제 2017/745에 따라 부착됨. 이에 의거하여 Abbott Medical은 본 기기가 본 지침의 필수 요구 사항 및 기타 관련 규정을 준수함을 선언합니다.
	수입업체
UK CA 0086	영국 적합성 평가 완료
UKRP	영국의 책임자
UA.TR.101	기술 규정에 대한 우크라이나 적합성 마크(101은 평가 기관).
MD	의료 기기
UDI	고유한 기기 식별
medical.abbott/manuals	이 웹 사이트의 사용 지침에 따르십시오
(7440-48-4) (7439-92-1)	유해 물질이 포함되어 있습니다. (코발트 CAS No. 7440-48-4) (납 CAS No. 7439-92-1)

LT: Lietuvių

BRK™ Transeptalinė adata

Naudojimo instrukcijos

Aprašymas

BRK™ transseptalinę adatą sudaro barbitūratų nerūdijančiojo plieno adata ir standus nerūdijančiojo plieno zondas. Adatos distalinė dalis yra išlenkta taip, kad ją būtų galima lengviau įstumti į širdį, naudojant su Abbott Medical transseptaliniu movos rinkiniu. Šioje lenktoje dalyje adatos išorinis skersmuo staigiai sumažėja, kad atitiktų Abbott Medical transseptalinio movos rinkinio vidinį plėtiklio skersmenį. Distalinis adatos galiukas yra įkypas, kad juo būtų lengviau pradurti. Proksimalinis adatos galas sukonfigūruotas su adatos junge (nurodančia distalinės kreivės padėtį) ir jame įtaisytas dviejų padėčių kranelis, kurio dėka adatos kanalą galima naudoti aspiravimui, skysčių injekcijai ar infuzijai atlikti, kraujo mėginiams imti, kraujospūdžiui stebėti, taip pat galima įstatyti zondą ir (arba) kreipiamąją vielą (18 dydžio adatos maksimalus kreipiamosios vielos skersmuo – 0,014 col. (0,36 mm); 19 dydžio adatos maksimalus kreipiamosios vielos skersmuo – 0,012 col. (0,30 mm)). Zondas yra tiesus ir vienodo diametro per visą savo ilgį. Proksimaliniame zondo gale įtaisytas lenktas spaustukas, užsifiksuojantis ant proksimalinės adatos įvorės, jį įstačius į adatos kanalą. Zondas skirtas tam, kad būtų lengviau adatą prakišti per plėtiklį. Galima įsigyti įvairių naudojamos dalies ilgių ir distalinės kreivės konfigūracijų adatą.

Numatytoji paskirtis

BRK™ transseptalinė adata yra skirta pradurti prieširdžių pertvarą, kad būtų galima pasiekti kairiąją širdies dalį.

Naudojimo indikacijos

BRK™ transseptalinė adata naudojama pradurti prieširdžių pertvarą per transseptalinę kateterizacijos procedūrą, kad būtų galima pasiekti kairiąją širdies dalį.

Tikslinė pacientų grupė

BRK™ transseptalinė adata yra skirta naudoti hemodinamiškai stabilios būklės pacientams, kurių kairiąją širdies dalį reikia pasiekti. Reikia gerai apsvarstyti, norint BRK™ transseptalinę adatą naudoti pacientams, kuriems nustatyta:

- Širdies rotacija;
- Padidėjusi aortos šaknis;
- Žymus dešiniojo prieširdžio padidėjimas;
- Skoliozė / kifozė;
- Nenormali kairiojo prieširdžio geometrija;
- Įgimtos ydos;
- Kraujagyslių įgimtos ydos;
- Priėjimo prie dešiniojo prieširdžio per apatinę tuščiąją veną nebuvimas.

Tikslinis naudotojas

Šį įtaisą turi naudoti tik tokie sertifikuoti gydytojai, kurie yra konkrečiai išmokyti atlikti transseptalines procedūras, ir tai turi daryti visiškai įrengtoje veikiančioje elektrofiziologijos laboratorijoje.

Klinikinė nauda

Klinikinė BRK™ transseptalinės adatos paskirtis yra pradurti prieširdžių pertvarą per transseptalinę kateterizacijos procedūrą, kad būtų galima pasiekti kairiąją širdies dalį tais prietaisais, kuriais tai padarius gaunama klinikinė nauda, pvz., abliacijos kateteriu. Tik sėkmingas prieširdžių pertvaros pradūrimas suteiks tokią galimybę.

Kontraindikacijos

- Ankstesnis tarp prieširdžių pertvaros skyriaus ar protezinis prieširdžio pertvaros defekto uždarymo prietaisas.
- Ankstesni tromboemboliniai sutrikimai.
- Diagnozuota ar įtariama kairiojo prieširdžio miksoma.
- Diagnozuotas ar įtariamas miokardo infarktas, patirtas per pastarąsias dvi savaites.
- Nestabili angina.
- Neseniai patirtas smegenų kraujotakos sutrikimas (CVA).
- Pacientai, netoleruojantys gydymo koaguliacijos inhibitoriais.
- Pacientai, kuriems nustatyta aktyvi infekcija.

Įspėjimai

- Niekaip neperdarykite šio prietaiso.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik vieną kartą; neperdarykite jo ir nenaudokite pakartotinai. Atkreipkite dėmesį į ant pakuotės nurodytą datą „Naudoti iki“. Bet koks bandymas iš naujo sterilizuoti ir pakartotinai naudoti šią sistemą gali pakenkti jos vientisumui. Nesterilių komponentų naudojimo nepageidaujami poveikiai gali apimti nurodytus toliau, tačiau jais neapsiribojama:
  - Vietinė ir sisteminė infekcija arba reakcija;
  - Mechaninis pažeidimas;
  - Netikslus veikimas.
- Toliau nurodytos gaminio medžiagos gali sukelti alergines arba padidėjusio jautrumo reakcijas. Asmenys, alergiški šioms medžiagoms, gali patirti alerginę reakciją į šį gaminį. Prieš naudojant prietaisą su pacientu reikia aptarti prietaise esančias medžiagas ir išsamią alergijos anamnezę:
  - Nerūdijantysis plienas
  - Epoksidiniai klijai
  - Nikelio chromu padengtas žalvaris
  - Silikono tepalas, skirtas naudoti dideliame vakuume („Dupont“)
  - Master Bond
- Netinkamai naudojant šį prietaisą gali kilti sunkių komplikacijų.
- Pacientams ir laboratorijos darbuotojams: širdies kateterizavimo procedūros kelia potencialų apšvitinimo rentgeno spinduliais pavojų, kuris gali sukelti ūminių radiacinių pažeidimų bei padidinti somatinio ir genetinio poveikio riziką, atsižvelgiant į rentgeno spindulių intensyvumą ir rentgenoskopinio tyrimo trukmę. Atidžiai apsvarstykite šio įtaiso naudojimą nėščioms moterims.

Atsargumo priemonės

- Pagal federalinius įstatymus (JAV) šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.
- Prieš naudodami perskaitykite nurodymus.
- Prieš naudodami patikrinkite pakuotę. Nenaudokite, jei pakuotė atidaryta ar pažeista.
- Prieš naudodami patikrinkite visus komponentus.
- Laikykite vėsioje, tamsioje, sausoje vietoje.
- Prieš atliekant šią procedūrą, paciento būklė turi būti hemodinamiškai stabili. Naudojant šį gaminį reikia atkreipti dėmesį į tam tikras būkles. Galimos komplikacijos (jomis neapsiribojant):

  - Širdies rotacija;
  - Padidėjusi aortos šaknis;
  - Žymus dešiniojo prieširdžio padidėjimas;
  - Skoliozė / kifozė;
  - Nenormali kairiojo prieširdžio geometrija;
  - Įgimtos ydos;
  - Kraujagyslių įgimtos ydos;
  - Priėjimo prie dešiniojo prieširdžio per apatinę tuščiąją veną nebuvimas.
- Šį įtaisą turi naudoti tik tokie sertifikuoti gydytojai, kurie yra konkrečiai išmokyti atlikti transseptalines procedūras, ir tai turi daryti visiškai įrengtoje veikiančioje elektrofiziologijos (EP) laboratorijoje.
- Kateterį reikia kišti stebint rentgenoskopu, kad sumažėtų širdies pažeidimo, pradūrimo ar tamponados rizika. Taip pat galima apsvarstyti naudoti suderinamas navigacijos ir tikralaikio vizualizavimo sistemas.
- Įvesdami patikrinkite, ar nėra didelio pasipriešinimo, kai adatos galiukas lenda per movos / plėtiklio mazgo kreivę. Jei yra pasipriešinimas adatos judėjimui, atitraukite adatą ir įvertinkite komponentus.
- Įvesdami būkite atsargūs, kad pernelyg nesulenktumėte šio prietaiso. Priešingu atveju gali sutrikti adatos slinkimas ir adata gali netyčia pradurti plėtiklio / movos rinkinį.
- Įvesdami visada naudokite zondą, kad būtų lengviau prakišti adatą per plėtiklio / movos mazgą. Nenaudojant tokio zondo, gali sutrikti adatos slinkimas ir adata gali netyčia pradurti plėtiklio ir movos rinkinį arba suraižyti plėtiklio vidinį paviršių.
- Adatai patekus į perikardą ar aortą, nestumkite plėtiklio virš adatos. Jei adata kerta perikardą ar aortą, ją reikia ištraukti. Atidžiai stebėkite pagrindinius organizmo būklės rodiklius.
- Ištraukiant objektus iš movos hemostazinio vožtuvo, kyla oro infiltracijos pavojus. Imkitės priemonių oro infiltracijai išvengti, objektus traukdami lėtai, kad nesusidarytų vakuumas movoje. Taip pat fluoroskopu stebėkite, ar movoje nėra oro, kai vėliau dėsite prietaisą.
- Panaudotą įtaisą, jo priedus ir pakuotę būtina atitinkamai klasifikuoti kaip biologinį pavojų keliančias, aštrias, nekenksmingas ar kitas atliekas ir atsargiai išmesti vadovaujantis įstaigoje taikomomis procedūromis ir galiojančiais įstatymais bei reglamentais.
- Viename ar keliuose šio prietaiso komponentuose gali būti toliau nurodytos medžiagos, apibrėžiamos kaip CMR 1B, kurios koncentracija didesnė nei 0,1% masės: kobaltas: „Chemical Abstracts Service“ (CAS) Nr. 7440-48-4; EB Nr. 231-158-0. Dabartiniai moksliniai įrodymai patvirtina, kad medicinos priemonės, pagamintos iš kobalto lydinių ir nerūdijančiojo plieno lydinių, kurių sudėtyje yra kobalto, nesukelia didesnės vėžio ar nepageidaujamo poveikio reprodukcijai rizikos.

  Viename ar keliuose šio prietaiso komponentuose gali būti toliau nurodytos medžiagos, apibrėžiamos kaip CMR 1A, kurios koncentracija didesnė nei 0,1% masės: švinas: „Chemical Abstracts Service“ (CAS) Nr. 7439-92-1; EB Nr. 231-100-4. Dabartiniai moksliniai įrodymai patvirtina, kad medicinos priemonės, pagamintos iš švino, nesukelia didesnės vėžio ar nepageidaujamo poveikio reprodukcijai rizikos.

Galimi nepageidaujami reiškiniai

Nepageidaujamo reiškinio kategorija	Nepageidaujamo reiškinio subkategorija
Kraujavimas	Hemoragija / kraujavimas
	Hematoma
Smegenų trauma	Besimptomė smegenų embolija
	Insultas / smegenų kraujotakos sutrikimas
	Trumpalaikis kraujotakos sutrikimas (TKS)
Embolija	Oro embolija
	Svetimkūnių embolija
	Plaučių embolija
	Tromboembolija
	Trombozė / trombas
Širdies perforacija	Širdies tamponada
	Perikardo efuzija
Širdies ir kraujagyslių pažeidimas	Vožtuvo pažeidimas
	Aortos šaknies pradūrimas
	Prieširdžio perforacija
Laidumo sistemos sutrikimas	SA mazgo, AV mazgo ar His-Purkinje sistemos blokada
	Širdies aritmijos
Imuninė reakcija	Anafilaksija
Infekcija	Perikarditas
	Endokarditas
	Pneumonija
	Sepsis
Skausmas / nemalonus pojūtis	Skausmas, kirkšnis, krūtinė (skausmas krūtinėje, nesusijęs su MI)
Periferinių kraujagyslių trauma	Disekcija
	Įplyšimas
	Arterioveninės fistulės susidarymas
	Pseudoaneurizmos susidarymas
Hipotenzija	Netaikoma
Paviršinių audinių trauma	Netaikoma

Nurodymai

Paruoškite ir surinkite įrangą

1. Išimkite pakuotės turinį.

   PASTABA. Nerinkite movos ir plėtiklio.
2. Praplaukite plėtiklį ir movą heparinizuotu fiziologiniu tirpalu.
3. Uždarykite movos čiaupą.
4. Ištraukite zondą iš adatos ir praplaukite adatą heparinizuotu fiziologiniu tirpalu.
5. Įkiškite zondą į adatą ir užfiksuokite jį ant įvorės.
6. Į transeptalinę movą iki galo įkiškite plėtiklį.

Stumkite movos / plėtiklio mazgą į viršutinę tuščiąją veną

1. Pasiekite šlaunies veną (rekomenduojama dešiniosios šlaunies veną).

   PASIRENKAMA. Norint užtikrinti ir išlaikyti priėjimą prie venos, kai keičiami prietaisai ir atliekama hemostazė, galima naudoti didesnę standartinio ilgio movą (≥ 2,5 prancūziško dydžio didesnę už transseptalinę movą).

2. Įterpkite 0,032 colio, 150–180 cm, 3 mm kreipiamąją vielą su „J“ tipo galiuku į viršutinę tuščiąją veną (SVC).

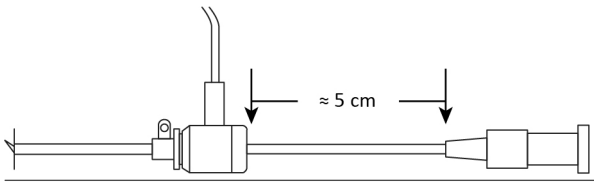
   PASTABA. 0,032 col. – tai maksimalus kreipiamosios vielos, naudotinos su transeptaliniu plėtikliu, skersmuo.

3. Įveskite movą / plėtiklį į veną per kreipiamąją vielą, kol movos galiukas atsidurs SVC. Nukreipkite plėtiklio galiuką ties viduriu.

Įstatykite adatos / zondo rinkinį į movos / plėtiklio rinkinį

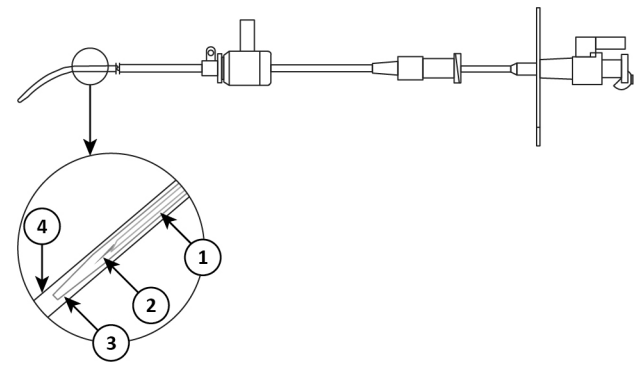
1. Ištraukite kreipiamąją vielą iš plėtiklio.
2. Iki galo išsiurbkite ir tada praplaukite plėtiklį heparinizuotu fiziologiniu tirpalu.
3. Patraukite plėtikilį maždaug 5 cm (žr. toliau esantį paveikslėlį), kad adatos linkiui būtų lengviau praeiti pro plėtiklio ir movos standžiąsias stebules.

1 pav. Plėtiklio ištraukimas



4. Užfiksuokite zondą ant įvorės.
5. Įstatykite adatą / zondą į plėtiklį. Stebėdami fluoroskopu stumkite adatą / zondą, kol jie bus maždaug 2 cm atstumu nuo plėtiklio galiuko movos viduje (žr. toliau esantį paveikslėlį).

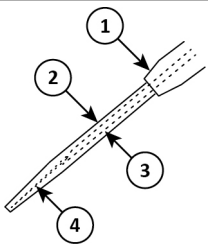
2 pav. Adatos / zondo įkišimas į plėtiklį



1. Adata
2. Zondas
3. Plėtiklio galiukas
4. Mova

6. Stebėdami fluoroskopu sujunkite movą ir plėtiklį, vienu metu į movą pastumdami plėtiklį ir adatą / zondą. Užtikrinkite, kad adatos padėtis plėtiklyje nesikeičia, kai abu komponentai stumiami kartu. Išlaikykite movos galiuko padėtį viršutinėje tuščiojoje venoje.
7. Stebėdami fluoroskopu stumkite adatą / zondą, kol zondas bus proksimaliai su plėtiklio galiuku (žr. toliau esantį paveikslėlį).

3 pav. Adatos / zondo stūmimas



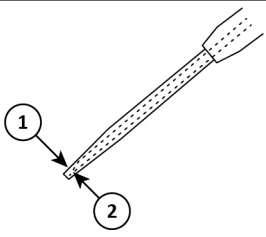
1. Movos galiukas
2. Plėtiklis
3. Adata
4. Zondas

8. Ištraukite zondą, neišmeskite jo.
9. Siurbkite orą iš adatos, kol pastebėsite kraują. Išmeskite švirkštą.

   PASTABA. Naudojant slidaus antgalio (ne Luer-Lok‡) švirkštą gali nepavykti išsiurbti oro.

10. Praplaukite adatą heparinizuotu fiziologiniu tirpalu. Uždarykite čiaupą.
11. Stumkite adatą stebėdami fluoroskopu, kol adatos galiukas bus proksimaliai su plėtiklio galiuku (žr. toliau esantį paveikslėlį).

4 pav. Adatos galiuko stūmimas



1. Plėtiklio galiukas
2. Adatos galiukas

PASIRENKAMA. pritvirtinkite 3 padėčių rotacinį vožtuvą prie adatos įvorės.

PASIRENKAMA. Pritvirtinkite švirkštą su rentgenokontrastine medžiaga prie vožtuvo. Išsiurbkite orą iš adatos. Tada įdėkite adatą su kontrastine medžiaga, naudodamiesi fluoroskopu.

PASIRENKAMA. Prijunkite slėgio stebėjimo liniją prie čiaupo.

PASIRENKAMA. naudokite standartinę 3 jungčių struktūrą kontrasto, slėgio ir praplovimo linijoms prijungti.

Įvedimas į ovaliąją angą

1. Vizualizuokite ir suraskite anatominius orientyrus.

2. Nustatykite fluoroskopą kampu lygiagrečiai su mitralinio vožtuvo plokštuma ir ortogonalia pertvaros plokštuma. Paprastai tai kairioji priešakinė plokštuma (maždaug 30–40 laipsnių).

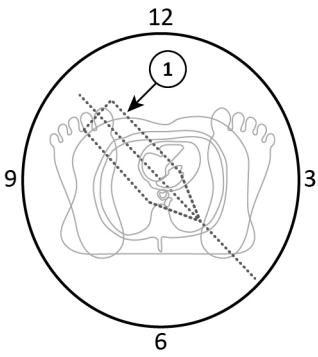
   PASIRENKAMA. Elektrofiziologinių (EF) procedūrų metu kateterių padėtys koronariniame sinuse ir Hiso pluošte gali praversti kaip naudingi anatominiai orientyrai. Atitinkamame LAO vaizde profilyje rodomas koronarinio sinuso kateteris. Atitinkamoje dešiniojoje priešakinėje plokštumoje (RAO), profilyje matosi Hiso pluošto kateteris. Ovalioji anga yra ties (ar šiek tiek žemiau) Hiso pluošto kateteriu bei prieš koronarinio sinuso angą ir už jos.

   PASIRENKAMA. Į aortos vožtuvo nekoronarinę viršūnę įvestas angiografinis / hemodinaminis stebėjimo kateteris gali praversti kaip naudingas anatominis orientyras.

   PASIRENKAMA. Stebėkite slėgio kreivę, registruojamą per BRK™ transseptalinę adatą.

3. Sureguliuokite adatos rodyklės jungę taip, kad adata būtų statmena ovaliajai angai (maždaug tarp 3:00 val. ir 5:00 val., žiūrint iš paciento kojūgalio). (Žiūrėkite toliau esantį paveikslėlį.)

5 pav. Adatos rodyklės jungė



1. Adatos rodyklės jungė

4. Naudodami fluoroskopą įsitikinkite, kad adatos galiukas yra plėtiklyje.
5. Nustatę, kad adatos galiukas yra plėtiklyje, lėtai traukite visą movos / plėtiklio / adatos mazgą. Neleiskite rinkinio dalims judėti viena kitos atžvilgiu. Rinkinio traukimo metu būtina išlaikyti ankstesnę adatos rodyklės jungės orientaciją.
6. LAO vaizde (plokštuma statmena prieširdžių pertvarai) stebėkite plėtiklio galiuką traukimo metu, ar nėra šiurkščių vidurio (ar dešininių) judesių, parodančių, kad galiukas sukibo su ovaliąja anga. (Žiūrėkite toliau esantį paveikslėlį.)

   PASTABA. Jei ovalioji anga yra prieinama zondui, tada plėtiklio galiukas laisvai juda į kairįjį prieširdį.

6 pav. Įvedimas į ovaliąją angą



1. Pradinė padėtis venoje SVC
2. Pradinis vidurinis judesys RA
3. Staigus vidurinis judesys ovaliojoje angoje

PASTABA. Stebint slėgį per adatą, slėgis adatoje šiuo momentu yra netikslus, nes galiukas yra priešais ovaliąją angą.

Ovaliosios angos pradūrimas su BRK™ transseptaline adata

1. Prieš stumdami adatą patikrinkite, ar movos / plėtiklio / adatos mazgas yra reikiamoje vietoje ovaliojoje angoje.
2. Nustatę, kad mazgas yra reikiamoje vietoje, išleiskite adatą iki visiško sukibimo su movos / plėtiklio mazgu ir stumkite skersai prieširdžių pertvaros.

   PASIRENKAMA. Kai stebimas slėgis rodo kairiojo prieširdžio slėgio bangos formą, galima tvirtinti, kad adata pateko į kairįjį prieširdį.

   PASIRENKAMA. Ar pasiektas kairysis prieširdis, galima patikrinti naudojant fluoroskopą su kontrastinės medžiagos injekcijomis.

3. Jei yra pasipriešinimas adatos judėjimui, atitraukite adatą ir iš naujo įvertinkite anatominius orientyrus.

   DĖMESIO. Adatai patekus į perikardą ar aortą, nestumkite plėtiklio virš adatos. Jei adata kerta perikardą ar aortą, ją reikia ištraukti. Atidžiai stebėkite pagrindinius organizmo būklės rodiklius.

Movos / plėtiklio rinkinio įvedimas į kairįjį prieširdį

Laikydami adatą fiksuotoje padėtyje kairiajame prieširdyje, stumkite movos / plėtiklio mazgą virš adatos iki galo į kairiojo prieširdžio ertmę.

Į kairįjį prieširdį per fiksuotą plėtiklį ir adatą stumkite movą

1. Išlaikykite adatos ir plėtiklio padėtį skersai pertvaros.
2. Laikydami plėtiklį fiksuotoje padėtyje, stumkite movą virš plėtiklio iki galo į kairiojo prieširdžio ertmę.

BRK™ transeptalinės adatos ir plėtiklio ištraukimas

DĖMESIO. Ištraukiant objektus iš movos hemostazinio vožtuvo, kyla oro infiltracijos pavojus. Imkitės priemonių oro infiltracijai išvengti, objektus traukdami lėtai, kad nesusidarytų vakuumas movoje. Taip pat fluoroskopu stebėkite, ar movoje nėra oro, kai vėliau dėsite prietaisą.

1. Pasukite adatos čiaupą į uždarymo padėtį ir atjunkite visus prijungimus, esančius prie adatos įvorės.
2. Ištraukite BRK™ transeptalinę adatą iš plėtiklio. Adatą reikia išvalyti ir padėti į šalį, kad būtų galima naudoti pakartotinai šioje procedūroje. Priešingu atveju išmeskite adatą kaip užterštą aštrų objektą.
3. Nedelsdami prijunkite švirkštą prie plėtiklio ir siurbkite. Toliau siurbkite kraują laikydami movą nejudamoje padėtyje ir traukdami plėtiklį. Kraujas turėtų būti arterinis.
4. Išėmę plėtiklį siurbkite kraują per movos šoninę atšaką. Kruopščiai praplaukite movos šoninę atšaką heparinizuotu fiziologiniu tirpalu, kad neliktų oro burbuliukų.
5. Mova dabar yra vietoje kairiajame prieširdyje.

Pakuotė ir laikymo laikas

BRK™ transseptalinė adata tiekiama sterili. Adata supakuota su įstatytu zondu. Adata ir zondas yra įdėti į pirminę pakuotę. Pirminė pakuotė yra įdėta į Mylar‡ ir Tyvek‡ krepšelį, kuris yra termoizoliuotas. Krepšelis ir ši

naudojimo instrukcija yra įdėti į dėžutę, sandarią abiejuose galuose. Ir ant krepšelio, ir ant dėžutės yra etiketė su informacija apie gaminį, įskaitant galiojimo datą. Pažymėta, kad neišpakuoti gaminiai tinkami naudoti tris metus.

Klinikinių duomenų suvestinė

Informacija Europos Sąjungos šalims. Šių prietaisų saugos ir klinikinio veikimo apžvalgą notifikuotosios įstaigos skelbia https://ec.europa.eu/tools/eudamed pagal ES MDR 2017/745 ir susijusių grafikų reikalavimus. Ieškokite prietaiso naudodami UDI-DI, pateiktą ant išorinės prietaiso pakuotės. UDI-DI yra 14 skaitmenų numeris tarp pirmųjų dviejų skliaustų rinkinių. Daugiau informacijos apie tai, kaip rasti ir naudoti UDI-DI, pateikiama dažnai užduodamų klausimų dokumente, skelbiamame adresu medical.abbott/manuals.

Pranešimas apie įvykius

Jei, naudodamiesi šiuo prietaisu, turite pagrindo manyti, kad įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui. Jei naudojate priemonę Europos Sąjungoje, apie rimtą incidentą praneškite savo nacionalinei institucijai ir gamintojui.

Ribotoji garantija

„Abbott Medical“ garantuoja, kad įprastai naudojant jos produktai bus be medžiagų ir gamybos defektų. Ši garantija galioja iki datos „Tinka iki“, nurodytos produkto etiketėje. Leidžiamas naudojimas ir patvirtinti kiekvieno produkto naudojimo metodai yra nustatyti susijusioje „Naudojimo instrukcijoje“, kuri pridedama prie kiekvieno produkto. „Abbott Medical“ neprisiima jokios atsakomybės už savo produktus, jei jie buvo naudojami tokiu būdu, kuris nebuvo leidžiamas ar patvirtintas. Pagal šią garantiją „Abbott Medical“ atsako tik pakeisdama produktus. Pirmiau minėta garantija atmetamos ir pakeičiamos visos kitos išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurias numanomas tinkamumo parduoti ar tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. „Abbott Medical“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius patirtus atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, padarytą žalą ar patirtas išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusius dėl šio produkto naudojimo, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus konkrečiuose teisės aktuose. „Abbott Medical“ neprisiima ir neleidžia jokiam kitam asmeniui prisiimti jokios kitos ar papildomos atsakomybės už nuostolius, žalą ar išlaidas, susijusius su šiuo produktu. Norėdami rasti daugiau informacijos, peržiūrėkite visą „Abbott Medical“ garantijos politiką, kurią galite gauti iš „Abbott Medical“ arba rasti galinėje „Abbott Medical“ sąskaitos pusėje.

Simboliai

Toliau esančius simbolius ir suderintus simbolius galite rasti ant gaminio ar jo etiketės. Dėl suderintų simbolių reikšmių žr. universalų simbolių žodyną adresu medical.abbott/manuals.

Simbolis	Paaiškinimas
Series	Serija
Contents	Turinys
Transseptal Needle	Transeptalinė adata
	Vieno sterilaus barjero sistema
	Ilgis
Rx ONLY	ĮSPĖJIMAI. Pagal federalinius įstatymus (JAV) šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.
CE 2797	Conformité Européenne (Europos atitiktis). Pridedama vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2017/745. Hereby, Abbott Medical declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of this regulation.
	Importuotojas
UK CA 0086	Jungtinės Karalystės atitikties įvertinimas
UKRP	Atsakingasis asmuo Jungtinėje Karalystėje
UA.TR.101	Ukrainoje naudojamas atitikties techniniams reglamentams ženklas; „101“ yra vertinimo įstaiga.
MD	Medicinos prietaisas
UDI	Unikalusis priemonės identifikavimo numeris
medical.abbott/manuals	Laikykitės šioje svetainėje pateiktos naudojimo instrukcijos
(7440-48-4) (7439-92-1)	Sudėtyje yra pavojingų medžiagų. (Kobaltas CAS Nr. 7440-48-4) (Švino CAS Nr. 7439-92-1)

LV: Latviski

BRK™ Transseptāla adata

Lietošanas instrukcija

Apraksts

BRK™ transseptālā adata sastāv no dobas nerūsējošā tērauda adatas un cieta nerūsējošā tērauda stileta. Adatas distālā sekcija ir izliekta, lai atvieglotu novietošanu sirdī, lietojot kopā ar Abbott Medical transseptālā apvalka komplektu. Šajā izliektajā sekcijā adatas ārējais diametrs pēkšņi samazinās, lai atbilstu Abbott Medical transseptālā apvalka komplekta dilatatora iekšējam diametram. Adatas distālais gals ir nošķelts, lai atvieglotu punkcijas veikšanu. Adatas proksimālais gals ir konfigurēts ar rādītāja atloku (norādot distālās līknes orientāciju) un ir aprīkots ar divvirzienu noslēgkrānu, lai nodrošinātu piekļuvi adatas lūmenam nolūkā veikt aspirēšanu, šķidruma injicēšanu/infuzēšanu, asins paraugu ņemšanu, spiediena kontroli, kā arī stileta un/vai vadstīgas ievietošanu (maks. 0,36 mm (0,014 collu) vadstīgas diametrs 18. izmēra adatai; maks. 0,30 mm (0,012 collu) vadstīgas diametrs 19. izmēra adatai). Stilets ir taisns un izodiametrisks visā garumā. Stileta proksimālais gals ir aprīkots ar izliektu skavu, lai varētu piestiprināt proksimālajai adatas pieslēgvietai, kad tas ir ievietots adatas lūmenā. Stilets ir izveidots tā, lai atvieglotu adatas virzību dilatatorā. Ir pieejamas dažādu darba garumu un distālās līknes konfigurāciju adatas.

Paredzētais mērķis

BRK™ transseptālā adata ir paredzēta interatriālās starpsienas punkcijas veikšanai, lai nodrošinātu kreisās puses sirds piekļuvi.

Lietošanas indikācijas

BRK™ transseptālā adata tiek izmantota, lai transseptālās katetrizācijas procedūras laikā veiktu interatriālās starpsienas punkciju, iegūstot kreiso sirds piekļuvi.

Mērķa pacientu grupa

BRK™ transseptālā adata ir paredzēta hemodinamiski stabiliem pacientiem, kuriem ir nepieciešama kreisās puses sirds katetra piekļuve. Uz BRK™ transseptālās adatas lietošanu var attiekties īpaši apsvērumi pacientiem, kuriem ir šādi stāvokļi:

- Pagriezta sirds;
- Palielināta aortas sakne;
- Ievērojams labā priekškambara palielinājums;
- Skolioze/kifoze;
- Anormāla kreisā priekškambara ģeometrija;
- Iedzimtas anomālijas;
- Asinsvadu anomālijas;
- Nespēja piekļūt labajam priekškambarim caur apakšējo dobo vēnu.

Paredzētais lietotājs

Šo ierīci var izmantot tikai ārsti, kuri ir īpaši apmācīti transseptālu procedūru veikšanā, pilnībā aprīkotā un darbam gatavā elektrofizioloģijas laboratorijā.

Klīniskie ieguvumi

BRK™ transseptālās adatas paredzētais klīniskais ieguvums ir interatriālās starpsienas punkcija transseptālās katetrizācijas procedūras laikā, lai nodrošinātu kreisās puses sirds piekļuvi un tādējādi ļautu ierīcēm, piemēram, ablācijas katetram, kam nepieciešama kreisās puses endokardiāla piekļuve, pildīt paredzēto klīnisko funkciju. To mēra pēc interatriālās starpsienas punkcijas sekmīguma.

Kontrindikācijas

- Iepriekšējs interatriālās starpsienas plāksteris vai priekškambaru starpsienas defekta noslēgšanas protēzes ierīce
- Jebkāds iepriekšējs trombembolijas notikums
- Zināma kreisā priekškambara miksoma vai aizdomas par tādu
- Zināms miokarda infarkts vai aizdomas par tādu pēdējo divu nedēļu laikā
- Nestabila stenokardija
- Neseni galvas smadzeņu asinsrites traucējumi (Cerebral Vascular Accident — CVA)
- Pacienti, kuri nepanes antikoagulācijas terapiju
- Pacienti ar aktīvu infekciju

Brīdinājumi

- Šo ierīci nedrīkst modificēt nekādā veidā.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai; nepārstrādājiet un neizmantojiet to atkārtoti. Ņemiet vērā uz iepakojuma norādīto "Izlietot līdz" datumu. Jebkurš mēģinājums atkārtoti sterilizēt un izmantot šo sistēmu var ietekmēt tās integritāti. Lietojot nesterilus komponentus, var rasties, piemēram, bet ne tikai, šādas nevēlamas blakusparādības:
  - Vietēja un sistēmiska infekcija vai reakcija;
  - Mehānisku bojājumu;
  - Nepareizu darbību.
- Tālāk norādītie izstrādājumos izmantotie materiāli var izraisīt alerģiskas vai paaugstinātas jutības reakcijas. Personām, kurām ir alerģija pret šiem materiāliem, konkrētais izstrādājums var izraisīt alerģisku reakciju. Pirms ierīces lietošanas pacients ir jāinformē par ierīcē izmantotajiem materiāliem, kā arī ir jānoskaidro visa šī pacienta alerģiju vēsture.
  - Nerūsējošais tērauds
  - Epoksīda līme
  - Misiņš ar niķeļa–hroma pārklājumu
  - Silikona ziede izmantošanai lielā vakuumā (Dupont)
  - Master Bond
- Nepareiza šīs ierīces lietošana var radīt nopietnas komplikācijas.
- Sirds katetrizācijas procedūru laikā gan laboratorijas personāls, gan pacienti rentgenstaru intensitātes un fluoroskopiskās attēldiagnostikas ilguma dēļ var tikt pakļauti ievērojamai rentgenstarojuma devai, kas var izraisīt akūtu apstarojuma traumu, kā arī paaugstinātu somatiskās un ģenētiskās iedarbības risku. Rūpīgi pārdomājiet šīs ierīces lietošanu grūtniecēm.

Piesardzības pasākumi

- Federālais likums (ASV) nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta norīkojuma.
- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus.
- Pirms lietošanas pārbaudiet iepakojumu. Nelietot, ja iesaiņojums ir atvērts vai bojāts.
- Pirms lietošanas pārbaudiet visus komponentus.
- Uzglabāt vēsā, tumšā un sausā vietā.
- Pirms procedūras pacientam ir jābūt hemodinamiski stabilam. Lietojot šo izstrādājumu, noteiktiem apstākļiem var būt jāpievērš īpaša uzmanība. Tie var ietvert tostarp tālāk norādītos:
  - Pagriezta sirds;
  - Palielināta aortas sakne;

  - Ievērojams labā priekškambara palielinājums;
  - Skolioze/kifoze;
  - Anormāla kreisā priekškambara ģeometrija;
  - Iedzimtas anomālijas;
  - Asinsvadu anomālijas;
  - Nespēja piekļūt labajam priekškambarim caur apakšējo dobo vēnu.
- Šo ierīci var izmantot tikai ārsti, kuri ir īpaši apmācīti transseptālu procedūru veikšanā, pilnībā aprīkotā un darbam gatavā elektrofizioloģijas laboratorijā.
- Katetra virzīšana ir jāveic fluoroskopijas kontrolē, lai līdz minimumam samazinātu sirds bojājuma, perforācijas vai tamponādes risku. Var apsvērt arī saderīgu navigācijas un reāllaika vizualizācijas sistēmu lietošanu.
- Ievietošanas laikā ir jāpārbauda, vai nav pārmērīgas pretestības, kad adatas gals virzās caur apvalka/dilatatora bloka izliekumu. Ja adatas virzībai ir jebkāda pretestība, atvelciet adatu un novērtējiet komponentus.
- Ievadīšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai ierīce netiktu pārmērīgi saliekta. Tas var kavēt adatas virzību, un tādēļ adata var netīši caurdurt dilatatora/apvalka bloku.
- Ievietošanas laikā vienmēr ir jāizmanto stilets, lai atvieglotu adatas izvadīšanu caur dilatatora/apvalka bloku. Stileta nelietošana var kavēt adatas virzību, un tādēļ adata var netīši caurdurt dilatatora/apvalka bloku vai nogriezt materiālu no dilatatora iekšējās virsmas.
- Ja notiek ievadīšana perikardā vai aortā, dilatatoru nedrīkst virzīt pār adatu. Ja adata ir caurdūrusi perikardu vai aortu, tā ir jāatvelk. Rūpīgi uzraugiet dzīvībai svarīgās funkcijas.
- Atvelkot objektus no apvalka hemostāzes vārsta, pastāv gaisa infiltrēšanas risks. Veiciet piesardzības pasākumus, lai nepieļautu gaisa infiltrēšanu, atvelkot objektus lēni, lai nepieļautu vakuuma uzkrāšanos apvalkā, un ierīces ievietošanas laikā uzraugiet apvalku ar fluoroskopiskiem līdzekļiem, lai pārliecinātos, ka tajā nav gaisa.
- Pēc lietošanas šī ierīce, tās piederumi un iepakojums ir pienācīgi jāsašķiro utilizācijai, piemēram, kā bioloģiski bīstami atkritumi, asi priekšmeti, nebīstami atkritumi u.c., un uzmanīgi jāutilizē saskaņā ar medicīnas iestādes procedūrām, kā arī piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.
- Viens vai vairāki šīs ierīces komponenti var saturēt šo vielu, kas definēta kā CMR 1B, koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% no masas: kobalts: Chemical Abstracts Service (CAS) Nr. 7440-48-4; EK Nr. 231-158-0. Pašreizējie zinātniskie pierādījumi apstiprina, ka medicīniskās ierīces, kas izgatavotas no kobalta sakausējumiem un kobaltu saturošiem nerūsējošā tērauda sakausējumiem, nerada paaugstinātu vēža risku vai nelabvēlīgu ietekmi uz reproduktīvo funkciju.

  Viens vai vairāki šīs ierīces komponenti var saturēt šo vielu, kas definēta kā CMR 1A, koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% no masas: svins: Chemical Abstracts Service (CAS) Nr. 7439-92-1; EK Nr. 231-100-4. Pašreizējie zinātniskie pierādījumi apstiprina, ka medicīniskās ierīces, kas izgatavotas no svina, nerada paaugstinātu vēža risku vai nelabvēlīgu ietekmi uz reproduktīvo funkciju.

Iespējamie nevēlamie notikumi

Nevēlamā notikuma kategorija	Nevēlamā notikuma apakškategorija
Asiņošana	Hemorāģija/asiņošana
	Asins izplūdums
Cerebrālā trauma	Bezsimptomu cerebrāli emboli
	Insults/trieka
	Pārejoša išēmiska lēkme (PIL)
Embolija	Gaisa embolija
	Svešķermeņu embolija
	Plaušu embolija
	Trombembolija
	Tromboze/trombs
Sirds perforācija	Sirds tamponāde
	Perikarda izsvīdums
Sirds un asinsvadu traumas	Vārstuļu bojājumi
	Aortas saknes punkcija
	Priekškambara perforācija
Vadītājsistēmas traucējumi	SA mezgla, AV mezgla vai Hisa-Purkinjē sistēmas blokāde
	Sirds aritmija
Imunoloģiska reakcija;	Anafilakse
Infekcija	Perikardīts
	Endokardīts
	Pneimonija
	Sepse
Sāpes/diskomforts	Sāpes cirksnī, krūškurvī (vispārīgas sāpes krūškurvī, kas nav saistītas ar MI)
Perifēro asinsvadu bojājums	Disekcija
	Plīsums
	Arteriovenozas fistulas veidošanās
	Pseidoaneirismas veidošanās
Hipotensija;	N/A
Virspusēji audu bojājumi;	N/A

Norādījumi

Aprīkojuma sagatavošana un salikšana

1. Izņemiet saturu no iepakojuma.

   PIEZĪME. Apvalku un dilatatoru nedrīkst samontēt.
2. Izskalojiet dilatatoru un apvalku ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.
3. Aizveriet apvalka noslēgkrānu.
4. Izņemiet stiletu no adatas un izskalojiet adatu ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.
5. Ievietojiet stiletu adatā un fiksējiet to uz pieslēgvietas.
6. Ievietojiet dilatatoru transseptālajā apvalkā līdz galam.

Apvalka/dilatatora bloka ievirzīšana augšējā dobajā vēnā

1. Iegūstiet femorālu venozo piekļuvi (vēlams, labajā augšstilbā).

   PĒC IZVĒLES. Lai iegūtu un uzturētu venozo piekļuvi ierīces nomaiņai un hemostāzei, var izmantot lielāku (par ≥2,5 izmēriem frenčos lielāku nekā transseptālais apvalks) standarta garuma apvalku.

2. Ievadiet 0,81 mm (0,032 collu), 150–180 cm, 3 mm "J" gala vadstīgu augšējā dobajā vēnā jeb (Superior Vena Cava — SVC).

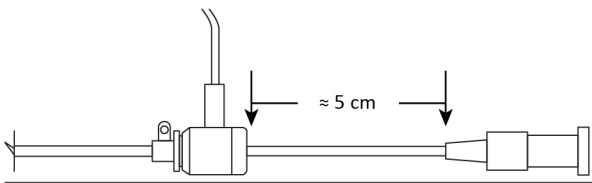
   PIEZĪME. 0,81 cm (0,032 collas) ir maksimālais vadstīgas diametrs, ko var izmantot ar dilatatoru.

3. Ievietojiet apvalku/dilatatoru vēnā pāri vadstīgai, līdz apvalka gals atrodas SVC. Orientējiet dilatatora galu mediāli.

Adatas/stileta bloka novietošana apvalka/dilatatora blokā

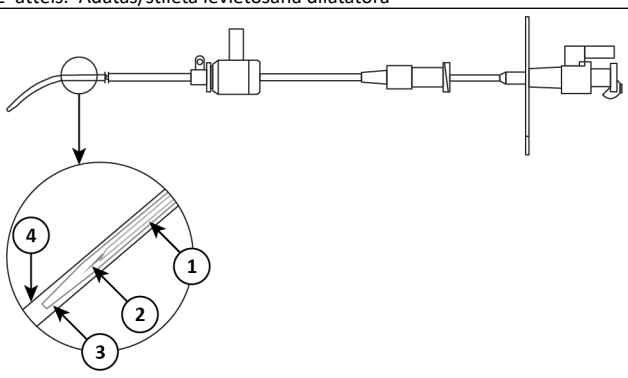
1. Izņemiet vadstīgu no dilatatora.
2. Pilnībā aspirējiet un pēc tam skalojiet dilatatoru ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.
3. Atvelciet dilatatoru par aptuveni 5 cm (skatiet attēlu tālāk), lai atvieglotu adatas izliekšanos caur dilatatora un apvalka cietajām pieslēgvietām.

1 attēls. Dilatatora atvilkšana



4. Fiksējiet stiletu pie pieslēgvietas.
5. Ievietojiet adatu/stiletu dilatatorā. Fluoroskopijas uzraudzībā virziet adatu/stiletu, līdz tas atrodas aptuveni 2 cm no dilatatora gala apvalka iekšpusē (skatiet attēlu tālāk).

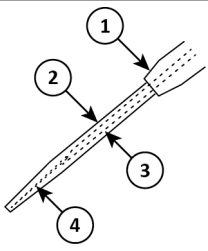
2 attēls. Adatas/stileta ievietošana dilatatorā



1. Adata
2. Stilets
3. Dilatatora gals
4. Apvalks

6. Lai savienotu apvalku un dilatatoru atkal, fluoroskopijas uzraudzībā dilatatoru un adatu/stiletu ievirziet apvalkā vienlaikus. Nodrošiniet, lai adatas pozīcija dilatatorā nemainītos, kamēr abi komponenti tiek virzīti kopā. Gādājiet, lai apvalka gals saglabātu savu pozīciju SVC.
7. Fluoroskopijas uzraudzībā virziet adatu/stiletu, līdz stilets atrodas tieši proksimāli dilatatora galam (skatiet attēlu tālāk).

3 attēls. Adatas/stileta virzīšana



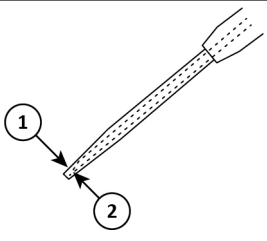
1. Apvalka gals
2. Dilatators
3. Adata
4. Stilets

8. Izņemiet stiletu, neizmetiet to.
9. Aspirējiet adatu, līdz asiņu atplūšana vairs nav novērojama. Izmetiet šļirci.

   PIEZĪME. Izmantojot šļirci ar slīdošo-gala savienojumu (nevis Luer-Lok‡), var novērst gaisa aspirēšanu.

10. Izskalojiet adatu ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu. Aizveriet noslēgkrānu.
11. Fluoroskopijas uzraudzībā virziet adatu, līdz adatas gals atrodas tieši proksimāli dilatatora galam (skatiet attēlu tālāk).

4 attēls. Adatas gala virzīšana



1. Dilatatora gals
2. Adatas gals

PĒC IZVĒLES. Pievienojiet adatas pieslēgvietai trīsvirzienu grozāmo noslēgkrānu.

PĒC IZVĒLES. Pievienojiet noslēgkrānam šļirci ar rentgenkontrastējošu kontrastvielu. Aspirējiet adatu. Pēc tam fluoroskopijas uzraudzībā uzpildiet adatu ar kontrastvielu.

PĒC IZVĒLES. Pievienojiet noslēgkrānam spiediena kontroles līniju.

PĒC IZVĒLES. Izmantojiet standarta 3 pieslēgvietu kolektora sistēmu, lai pievienotu kontrastvielas, spiediena un skalošanas līnijas.

Saslēgšana ar ovālo atveri

1. Vizualizējiet un identificējiet anatomiskos orientierus.

2. Iestatiet fluoroskopijas iekārtu leņķī paralēli mitrālā vārstuļa plaknei un ortogonāli starpsienas plaknei. Parasti tā ir kreisā priekšējā slīpā pozīcija (Left Anterior Oblique — LAO), aptuveni 30 līdz 40 grādu.

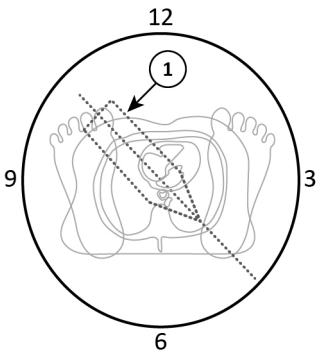
   PĒC IZVĒLES. Elektrofizioloģijas procedūru laikā koronārā sinusa un Hisa kūlīša katetra pozīcijas var izmantot kā noderīgus anatomiskos orientierus. Atbilstošajā LAO skatā koronārā sinusa katetrs ir redzams profilā. Atbilstošajā labās priekšējās slīpās pozīcijas (Right Anterior Oblique — RAO) skatā Hisa kūlīša katetrs ir redzams profilā. Ovālā atvere ir Hisa kūlīša katetra līmenī vai mazliet zem tā, un virs un aiz koronārā sinusa atveres.

   PĒC IZVĒLES. Spirālveida (pigtail) angiogrāfijas/hemodinamiskās uzraudzības katetru ievietojot aortas vārstuļa nekoronārajā virā, to var izmantot kā noderīgu anatomisko orientieri.

   PĒC IZVĒLES. Vērojiet spiediena līkni, kura tiek ierakstīta caur BRK™ transseptālo adatu.

3. Noregulējiet rādītāja atloku tā, lai adata atrastos perpendikulāri ovālajai atverei (parasti tas atbilst pozīcijai plkst. 3.00 un plkst. 5.00 uz pulksteņa ciparnīcas, skatoties no pacienta kājgaļa). (Skatiet attēlu tālāk.)

5 attēls. Adatas rādītāja atloks

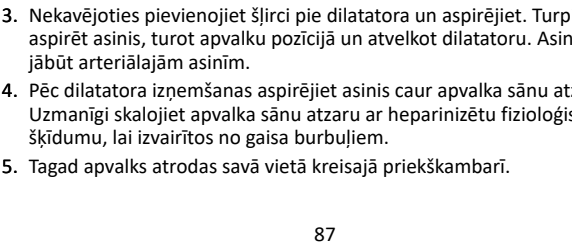


1. Adatas rādītāja atloks

4. Izmantojiet fluoroskopiju, lai pārliecinātos, ka adatas gals atrodas dilatatorā.
5. Kad ir apstiprināts, ka adatas gals atrodas dilatatorā, lēni velciet visu apvalka/dilatatora/adatas bloku. Nedrīkst pieļaut, ka bloka daļas izkustas attiecībā cita pret citu. Velkot bloku, ir ļoti svarīgi saglabāt iepriekšējo rādītāja atloka orientāciju.
6. Vilkšanas laikā vērojiet dilatatora galu LAO skatā (ortogonāli pret interatriālo starpsienu), vai tam nav mediālu (vai pa labi vērstu) kustību, kuras norādītu, ka gals ir saslēdzies ar ovālo atveri. (Skatiet attēlus tālāk.)

   PIEZĪME. Ja ovālā atvere nav noslēgusies, dilatatora gals tagad viegli iebīdās kreisajā priekškambarī.

6 attēls. Saslēgšana ar ovālo atveri



1. Sākuma pozīcija augšējā dobajā vēnā (SVC)
2. Sākotnējā mediālā kustība labajā priekškambarī (RA)
3. Pēkšņa mediāla kustība uz ovālo atveri

PIEZĪME. Ja spiediens tiek kontrolēts caur adatu, šajā brīdī spiediens caur adatu ir neprecīzs, jo gals atduras pret ovālo atveri.

Ovālās atveres punkcija ar BRK™ transseptālo adatu

1. Pirms adatas virzīšanas uz priekšu ir jāpārliecinās, ka apvalka/dilatatora/adatas bloks atrodas nepieciešamajā pozīcijā.
2. Kad pareizā atrašanās vieta ir apstiprināta, izbīdiet adatu līdz pilnai saķerei apvalka/dilatatora blokā un virziet adatu uz priekšu pāri interatriālajai starpsienai.

   PĒC IZVĒLES. Kontrolējot spiedienu, ievadīšana kreisajā priekškambarī tiek apstiprināta, kad spiediena trajektorija rāda kreisā priekškambara spiediena līkni.

   PĒC IZVĒLES. Kreisā priekškambara piekļuvi var apstiprināt, izmantojot fluoroskopiju ar kontrastvielas injekcijām.

3. Ja adatas virzībai uz priekšu ir jebkāda pretestība, atvelciet adatu un vēlreiz novērtējiet anatomiskos orientierus.

   UZMANĪBU! Ja notiek ievadīšana perikardā vai aortā, dilatatoru nedrīkst virzīt pār adatu. Ja adata ir caurdūrusi perikardu vai aortu, tā ir jāatvelk. Rūpīgi uzraugiet dzīvībai svarīgās funkcijas.

Apvalka/dilatatora bloka virzīšana kreisajā priekškambarī

Saglabājot fiksētu adatas pozīciju kreisajā priekškambarī, virziet apvalka/dilatatora bloku līdz galam uz priekšu pāri adatai un ievirziet to kreisā priekškambara dobumā.

Virziet apvalku pāri fiksētajam dilatatoram un adatai un ievirziet kreisajā priekškambarī

1. Saglabājiet adatas un dilatatora pozīciju cauri starpsienai.
2. Saglabājot dilatatoru fiksētā pozīcijā, virziet apvalku līdz galam uz priekšu, pāri dilatatoram, un ievirziet to kreisā priekškambara dobumā.

BRK™ transseptālās adatas un dilatatora atvilkšana

UZMANĪBU! Atvelkot objektus no apvalka hemostāzes vārsta, pastāv gaisa infiltrēšanas risks. Veiciet piesardzības pasākumus, lai nepieļautu gaisa infiltrēšanu, atvelkot objektus lēni, lai nepieļautu vakuuma uzkrāšanos apvalkā, un ierīces ievietošanas laikā uzraugiet apvalku ar fluoroskopiskiem līdzekļiem, lai pārliecinātos, ka tajā nav gaisa.

1. Pagrieziet adatas noslēgkrānu izslēgtā pozīcijā un atvienojiet visus savienojumus, kas ir izveidoti ar adatas pieslēgvietu.
2. Noņemiet BRK™ transseptālo adatu no dilatatora. Adatu var notīrīt un atlikt malā atkārtotai izmantošanai šajā procedūrā. Pretējā gadījumā izmetiet adatu atbilstoši piesārņoto aso priekšmetu izmešanas nosacījumiem.
3. Nekavējoties pievienojiet šļirci pie dilatatora un aspirējiet. Turpiniet aspirēt asinis, turot apvalku pozīcijā un atvelkot dilatatoru. Asinīm ir jābūt arteriālajām asinīm.
4. Pēc dilatatora izņemšanas aspirējiet asinis caur apvalka sānu atzaru. Uzmanīgi skalojiet apvalka sānu atzaru ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu, lai izvairītos no gaisa burbuļiem.
5. Tagad apvalks atrodas savā vietā kreisajā priekškambarī.

Iepakojums un uzglabāšanas ilgums

BRK™ transseptālā adata tiek piegādāta sterila. Iepakotajā adatā ir ievietots stilets. Adata ar stiletu ir ievietota primārajā iepakojumā. Primārais iepakojums ir ievietots termiski noslēgtā Mylar‡ un Tyvek‡ maisiņā. Pēc tam maisiņš un šī lietošanas instrukcija ir ievietota no abiem galiem noslēgtā kārbā. Gan maisiņam, gan kārbai ir etiķete ar informāciju par izstrādājumu, tostarp arī derīguma termiņa beigu datumu. Izstrādājumu etiķetē ir norādīts trīs gadu glabāšanas laiks.

Klīnisko datu kopsavilkums

Eiropas Savienības valstīm: Kopsavilkumu par šo ierīču drošumu un klīnisko veiktspēju (SSCP) publicēs pilnvarotās iestādes vietnē https://ec.europa.eu/tools/eudamed saskaņā ar ES MDR 2017/745 prasībām un atbilstoši saistītajiem termiņiem. Meklējiet ierīci, izmantojot UDI-DI, kas norādīts uz ierīces ārējā iepakojuma. UDI-DI ir 14 ciparu numurs starp pirmajām divām iekavām. Papildinformāciju par UDI-DI atrašanu un izmantošanu skatiet bieži uzdoto jautājumu dokumentā vietnē medical.abbott/manuals.

Ziņošana par incidentiem

Ja šīs ierīces lietošanas laikā jums ir pamats uzskatīt, ka noticis nopietns incidents, ziņojiet par to ražotājam. Klientiem Eiropas Savienībā jāziņo par nopietniem negadījumiem savas valsts pilnvarotajai iestādei, kā arī ražotājam.

Ierobežotā garantija

Abbott Medical garantē, ka normālas lietošanas apstākļos tā izstrādājumiem neradīsies materiālu vai ražošanas defekti. Šīs garantijas termiņš nav ilgāks par "derīguma termiņu", kas norādīts izstrādājuma etiķetē. Mūsu izstrādājumu atļautais lietojums un apstiprinātās lietošanas metodes ir norādītas katra izstrādājuma komplektācijā iekļautajā "lietošanas instrukcijā". Abbott Medical neuzņemas nekādu atbildību un saistības par tā izstrādājumu izmantošanu neatbilstoši atļautajam vai apstiprinātajam lietojuma veidam. Saskaņā ar šo garantiju uzņēmuma Abbott Medical atbildība tiek ierobežota tikai ar tā izstrādājumu nomaiņu. Iepriekš minētā garantija neietver un aizstāj visas citas gan tieši, gan netieši izteiktās garantijas, piemēram, ikvienu netiešu garantiju par atbilstību pārdošanai vai piemērotību noteiktam mērķim. Abbott Medical neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, ko tieši vai netieši ir izraisījusi šī izstrādājuma lietošana, ja vien tas nav skaidri norādīts spēkā esošajos tiesību aktos. Abbott Medical neuzņemas un nepilnvaro nevienu citu personu uzņemties nekādu citu vai papildu atbildību par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem saistībā ar šo izstrādājumu. Plašāku informāciju skatiet pilnajā Abbott Medical garantijas politikas dokumentā, ko var saņemt no uzņēmuma Abbott Medical vai kas ir pieejams Abbott Medical rēķina aizmugurē.

Simboli

Uz izstrādājuma vai tā marķējuma var būt redzami tālāk norādītie un saskaņotie simboli. Saskaņotos simbolus skatiet Universal Symbols Glossary (Universālais simbolu glosārijs) vietnē medical.abbott/manuals.

Simbols	Definīcija
Series	Sērija
Contents	Saturs
Transseptal Needle	Transseptāla adata
	Vienas sterilās barjeras sistēma
	Garums
℞ ONLY	UZMANĪBU! Federālais likums (ASV) nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta norīkojuma.
CE 2797	Confirmite Europeenne (Atbilstība Eiropas standartiem). Pievienots atbilstoši Eiropas Padomes Regulai 2017/745. Ar šo uzņēmums Abbott Medical paziņo, ka šī ierīce atbilst minētās regulas pamatprasībām un citiem regulā sniegtajiem noteikumiem, kas attiecas uz šo ierīci.
	Importētājs
UK CA 0086	Atbilstības izvērtējums Apvienotajā Karalistē
UKRP	Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē
UA.TR.101	Ukrainas tehnisko noteikumu atbilstības zīme, kur 101 ir novērtēšanas institūcija.
MD	Medicīnas ierīce
UDI	Ierīces unikālais identifikators
medical.abbott/manuals	Ievērojiet tīmekļa vietnē pieejamo lietošanas instrukciju
(7440-48-4) (7439-92-1)	Satur bīstamas vielas. (Kobalts CAS Nr. 7440-48-4) (Svins CAS Nr. 7439-92-1)

МК: Македонски јазик

BRK™ Транссептална игла

Упатство за употреба

Опис

Транссепталната игла BRK™ се состои од луминална игла од не'рѓосувачки челик и исполнета сонда од не'рѓосувачки челик. Дисталниот дел на иглата е свиткан за да се олесни поставувањето во срцето кога се користи со транссептален комплет обвивки од Abbott Medical. Во свитканиот дел, има нагло намалување на надворешниот дијаметар на иглата за да се вклопи во внатрешниот дијаметар на дилататорот од транссептални комплет обвивки од Abbott Medical. Дисталниот врв на иглата е закосен за да се олесни процесот на боцкање. Проксималниот крај на иглата е конфигуриран со прирабница со индикатор (којшто ја покажува ориентацијата на дисталната крива) и е опремен со 2-насочен вентил за да овозможи пристап до луменот на иглата за аспирација, инјектирање/инфузија на течности, земање крв, следење на притисокот и вметнување на сондата и/или водилката (0,014 инчи максимален дијаметар на водилката за иглата од калибар 18; 0,012 инчи максимален дијаметар на водилката за иглата од калибар 19). Сондата е права и изодијаметрична во текот на целата должина. Проксималниот крај на сондата е опремен со свиткан клип за заклучување во проксималната оска на иглата кога ќе се вметне во луменот на иглата. Сондата е дизајнирана за да го олесни движењето на иглата во внатрешноста на дилататорот. Иглата е достапна во повеќе должини и конфигурации на дисталната крива.

Наменета употреба

Транссепталната игла BRK™ е наменета да се користи за пробивање на интератријалниот септум за да се добие пристап до левата страна на срцето.

Индикации за употреба

Транссепталната игла BRK™ се користи за пробивање на интератријалниот септум за време на постапката за транссептална катетеризација за да се добие пристап до левата страна на срцето.

Целна група на пациенти

Транссепталната игла BRK™ е наменета да се користи кај хемодинамски стабилни пациенти кај коишто треба да се пристапи до левата страна на срцето со катетер. Треба особени внимателно да се размисли пред употреба на транссепталната игла BRK™ кај пациенти со следниве состојби:

- Ротирано срце
- Проширен корен на аортата
- Значително проширување на десната преткомора
- Сколиоза/кифоза
- Абнормална геометрија на левата преткомора
- Вродени деформитети
- Васкуларни деформитети
- Неможност да се влезе во десната преткомора преку долната шуплива вена

Наменет корисник

Овој уред треба да го користат само лекари коишто се специјално обучени за транссептални постапки во целосно опремена, операциона електрофизиолошка лабораторија.

Клинички придобивки

Планираната клиничка придобивка од транссепталната игла BRK™ е да се пробие интератријалниот септум за време на постапката за транссептална катетеризација за добивање пристап до левата страна на срцето, за да им се овозможи на уредите на коишто им треба ендокардијален срцев пристап од левата страна да ја постигнат нивната планирана клиничка придобивка, како што е катетерот за аблација. Ова се мери со успешното пробивање на интератријалниот септум.

Контраиндикации

- Претходна интератријална, септална лепенка или протетички уред за затворање на атријалниот септален дефект.
- Претходна појава на тромбоемболија.
- Познат или сомнителен лев атријален миксом.
- Познат или сомнителен миокарден инфаркт во текот на последните две недели.
- Нестабилна ангина.
- Неодамнешен цереброваскуларен инцидент (CVA).
- Пациенти коишто не толерираат антикоагулантна терапија.
- Пациенти со активна инфекција.

Предупредувања

- Не менувајте го овој уред на кој било начин.
- Овој уред е наменет само за еднократна употреба. Не обработувајте го и не користете го повторно. Внимавајте на датумот за „Рок на употреба“ на производот што се наоѓа на пакетот. Со секој обид за рестерилизација и реупотреба на системот може да се компромитира неговиот интегритет. Во несакани реакции од употребата на нестерилни компоненти може да спаѓаат, но не се ограничени на:
  - Локална и системска инфекција или реакција
  - Механичко оштетување
  - Непрецизна функционалност
- Материјалите по производ коишто се идентификувани подолу може да предизвикаат алергиски или хиперсензитивни реакции. Лицата коишто се алергични на нив може да претрпат алергиска реакција на овој производ. Пред да го употребите производот врз пациентот, треба да се консултирате со пациентот за материјалите што ги содржи уредот и мора да извршите темелна анамнеза на алергиите:
  - Не'рѓосувачки челик
  - Епоксидно лепило
  - Никел хромиран месинг
  - Силиконска, високовакуумска маст (Dupont)
  - Master Bond
- Погрешната употреба на овој уред може да доведе до сериозни компликации.
- И за пациентите и за лабораторискиот персонал, постапките за срцева катетеризација претставуваат потенцијал за значително изложување на рендгенски зраци, што може да доведе до акутна радијациона повреда, како и зголемен ризик за соматски и генетички ефекти поради интензитетот на рендгенските зраци и времетраењето на флуороскопското снимање. Внимателно размислете дали да го употребите овој уред кај бремени жени.

Мерки за заштита

- Федералниот закон (Соединетите Американски Држави) ја ограничува продажбата на овој уред само од страна или по налог на лекар.
- Прочитајте ги упатствата пред употреба.
- Проверете го пакувањето пред употреба. Да не се употребува доколку пакувањето е отворено или оштетено.
- Проверете ги сите компоненти пред употреба.
- Да се чува на ладно, темно и суво место.
- Пред постапката, пациентот мора да биде хемодинамски стабилен. За некои состојби може да е потребно посебно внимание при користењето на овој производ. Тие може да вклучуваат, но не се ограничени на:
  - Ротирано срце
  - Проширен корен на аортата
  - Значително проширување на десната преткомора
  - Сколиоза/кифоза
  - Абнормална геометрија на левата преткомора
  - Вродени деформитети
  - Васкуларни деформитети
  - Неможност да се влезе во десната преткомора преку долната шуплива вена
- Овој уред треба да го користат само лекари коишто се специјално обучени за транссептални постапки во целосно опремена, операциона електрофизиолошка (EP) лабораторија.
- Напредувањето на катетерот треба да се изврши со флуороскопско насочување за да се минимизира ризикот од срцево оштетување, перфорација или тампонада. Може да се земат предвид и компатибилни системи за навигација и визуелизација во реално време.
- За време на вметнувањето, проверете дали има зголемен отпор како што врвот на иглата се движи низ свиткувањето на склопот од обвивка/дилататор. Ако има отпор на движењето на иглата, повлечете ја иглата и проценети ги компонентите.
- За време на вметнувањето, бидете внимателни дополнително да не го свиткате уредот. Ова може да го спречи движењето на иглата и да доведе до ненамерно пробивање на склопот од обвивка/дилататор со иглата.
- За време на вметнувањето, секогаш користете ја сондата за да го олесните минувањето на иглата низ склопот од обвивка/дилататор. Ако не ја користите сондата, може да го спречите движењето на иглата и да дојде до ненамерно пробивање на склопот од обвивка/дилататор со иглата или кинење на материјалот од внатрешната површина на дилататорот.
- Ако влезете во перикардот или аортата, не придвижувајте го дилататорот врз иглата. Ако иглата навлезе во перикардот или аортата, мора да ја повлечете. Внимателно следете ги виталните знаци.
- Постои ризик од инфилтрација на воздух при повлекување предмети од хемостатскиот вентил на обвивката. Бидете претпазливи за да спречите инфилтрација на воздухот со бавно повлекување на предметите за да спречите да се насобере вакуум во обвивката и флуороскопски следете ја обвивката во текот на вметнувањето на уредот за следење за присуство на воздух.
- По употреба, овој уред, додатоците и пакетот треба соодветно да ги класифицирате за отстранување, на пр. биолошки опасен отпад, игли, безопасен отпад итн. и внимателно да ги отстраните во согласност со постапките на институцијата и важечките закони и регулативи.
- Една или повеќе компоненти на уредот може да ја содржат следнава супстанца дефинирана како CMR 1B во концентрација над 0,1% тежина по тежина: Кобалт: Chemical Abstracts Service (CAS) бр. 7440-48-4; EC бр. 231-158-0. Тековните научни сознанија потврдуваат дека медицинските уреди произведени од легури на кобалт и легури на не'рѓосувачки челик коишто содржат кобалт не предизвикуваат зголемен ризик од канцер или негативни репродуктивни ефекти.

  Една или повеќе компоненти на уредот може да ја содржат следнава супстанца дефинирана како CMR 1A во концентрација над 0,1% тежина по тежина: Олово: Chemical Abstracts Service (CAS) бр. 7439-92-1; EC бр. 231-100-4. Тековните научни сознанија потврдуваат дека медицинските уреди произведени од олово не предизвикуваат зголемен ризик од канцер или негативни репродуктивни ефекти.

Потенцијални несакани ефекти

Категорија на несакани реакции	**Поткатегорија на несакани реакции**
Крвавење	Хеморагија/крвавење
	Хематом
Мозочна повреда	Асимптоматска церебрална емболија
	Мозочен удар/цереброваскуларна несреќа
	Минлив исхемичен напад (TIA)
Емболија	Воздушна емболија
	Емболија од туѓо тело
	Белодробна емболија
	Тромбоемболија
	Тромбоза/тромб
Перфорација на срцето	Тампонада на срце
	Перикардијален излив
Кардиоваскуларна повреда	Валвуларно оштетување
	Пробивање на коренот на аортата
	Перфорација на преткомората
Нарушување на системот за спроводливост	Блок на SA-јазолот, AV-јазолот или системот His-Purkinje
	Срцеви аритмии
Имунолошка реакција	Анафилакса
Инфекција	Перикардитис
	Ендокардитис
	Пневмонија
	Сепса
Болка/неудобност	Болка во слабини/гради (општа градна болка што не е поврзана со MI)

Категорија на несакани реакции	Поткатегорија на несакани реакции
Периферна васкуларна повреда	Дисекција
	Лацерација
	Формирање на артериовенозна фистула
	Формирање на псевдоаневризма
Хипотензија	НЕ Е ПРИМЕНЛИВО
Површинска повреда на ткиво	НЕ Е ПРИМЕНЛИВО

Инструкции

Подготовка и склопување на опремата

1. Извадете ја содржината од амбалажата.

   ЗАБЕЛЕШКА: Не склопувајте ги обвивката и дилататорот.

2. Исплакнете ги дилататорот и обвивката со хепаринизиран физиолошки раствор.
3. Затворете го вентилот на обвивката.
4. Отстранете ја сондата од иглата и исплакнете ја иглата со хепаринизиран физиолошки раствор.
5. Вметнете ја сондата во иглата и заклучете ја во оската.
6. Целосно вметнете го дилататорот во транссептталната обвивка.

Придвижете го склопот од обвивка/дилататор во горната шуплива вена

1. Овозможете феморален венски пристап (најдобро десен феморален пристап).

   ИЗБОРНО: Поголема (≥2,5 француски димензии поголеми од транссептталната обвивка) обвивка со стандардна должина може да се користи за да се овозможи и одржува венски пристап за размена на уредот и хемостаза.

2. Воведете водилка со врв „J“ со димензии 0,032 инчи, 150 – 180 cm, 3 mm во горната шуплива вена (SVC).

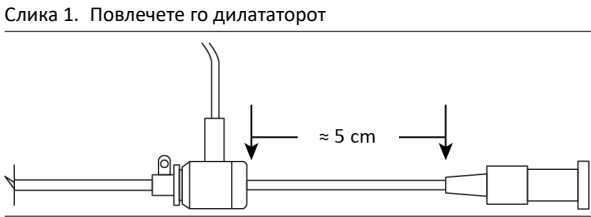
   ЗАБЕЛЕШКА: 0,032 инчи е максималниот дијаметар на водилката што може да се користи со дилататорот.

3. Вметнувајте ја обвивката/дилататорот во вената преку водилката додека врвот на обвивката не влезе во SVC. Свртете го врвот на дилататорот медијално.

Поставување на склопот од игла/сонда во склопот од обвивка/дилататор

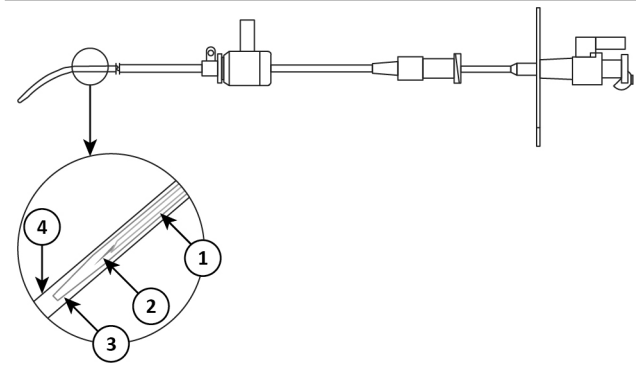
1. Отстранете ја водилката од дилататорот.
2. Целосно аспирирајте го и потоа исплакнете го дилататорот со хепаринизиран физиолошки раствор.
3. Повлечете го дилататорот околу 5 cm (видете ја долната слика) за да го олесните минувањето на кривината од иглата низ крутите оски на дилататорот и обвивката.

Слика 1. Повлечете го дилататорот



4. Заклучете ја сондата во оската.
5. Вметнете ја игла/сондата во дилататорот. Движете ја иглата/сондата под флуороскопија додека не се најде приближно на 2 cm од врвот на дилататорот внатре во обвивката (видете ја следнава слика).

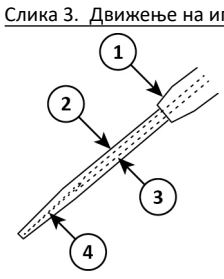
Слика 2. Вметнување на иглата/сондата во дилататорот



1. Игла
2. Сонда
3. Врв на дилататорот
4. Обвивка

6. За повторно поврзување на обвивката и дилататорот, движете ги дилататорот и иглата/сондата во обвивката истовремено под флуороскопија. Внимавајте положбата на иглата во дилататорот да не се смени како што ги движите двете компоненти заедно. Одржувајте ја положбата на врвот од обвивката во SVC.
7. Под флуороскопија, движете ја игла/сондата додека сондата не се намести проксимално од врвот на дилататорот (видете ја следнава слика).

Слика 3. Движење на иглата/сондата



1. Врв на обвивката
2. Дилататор
3. Игла
4. Сонда

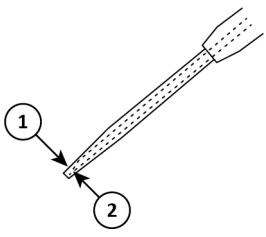
8. Отстранете ја сондата, не фрлајте ја.
9. Аспирирајте ја иглата додека не забележите дека излегува крв. Фрлете го шприцот.

   ЗАБЕЛЕШКА: Употребата на шприц со лизгачки врв (што не е Luer-Lok‡) може да ја попречи аспирацијата на воздухот.

10. Исплакнете ја иглата со хепаринизиран физиолошки раствор. Затворете го вентилот.

11. Под флуороскопија, движете ја иглата додека нејзиниот врв не се намести проксимално од врвот на дилататорот (видете ја следнава слика).

Слика 4. Движење на врвот на иглата



1. Врв на дилататорот
2. Врв на иглата

ИЗБОРНО: Прикачете ротирачки вентил во 3 правци за оската на иглата.

ИЗБОРНО: Прикачете шприц со радиоотпорен, контрастен медиум за вентилот. Аспирирајте ја иглата. Потоа, поставете ја иглата со контрастен медиум со помош на флуороскопија.

ИЗБОРНО: Поврзете линија за следење на притисокот во вентилот.

ИЗБОРНО: Користете колектор со 3 порти за поврзување линии за контраст, притисок и за плакнење.

Зафаќање на овалната фоса

1. Визуелизирајте ги и идентификувајте ги анатомските обележја.
2. Поставете ја флуороскопската единица под агол којшто е паралелен со рамнината на митралната валвула и ортогонален со рамнината на септумот. Ова типично ќе биде левата антериорна косина (LAO), приближно од 30 до 40 степени.

   ИЗБОРНО: Во текот на EP-постапките, положбите на коронарниот синус и катетерот на His-снопот може да служат како корисни анатомски обележја. Во соодветниот LAO-приказ, коронарниот синусен катетер се појавува во профил. Во соодветниот приказ на десната антериорна косина (RAO), катетерот на His-снопот се појавува во профил. Овалната фоса е рамна или малку под катетерот на His-снопот и супериорна и постериорна на коронарниот синусен остиум.

   ИЗБОРНО: Ако поставите ангиографски/хемодинамски катетер за следење во форма на опавче во некоронарниот сегмент на аортната валвула, тој може да послужи како корисно анатомско обележје.

   ИЗБОРНО: Забележете ја брановата форма на притисокот снимена преку транссепталната игла BRK™.

3. Приспособете ја прирабницата со индикатор, така што иглата да биде вертикална на овалната фоса (помеѓу 3:00 и 5:00 часот типично, гледајќи од крајот на стапалата на пациентот). (Видете ја следнава слика.)

Слика 5. Прирабница со индикатор на иглата



1. Прирабница со индикатор на иглата

4. Користете флуороскопија за да потврдите дека врвот на иглата е во дилататорот.
5. Откако ќе потврдите дека врвот на иглата е во дилататорот, бавно влечете го целиот склоп од обвивка/дилататор/игла. Спречете движење на деловите од склопот помеѓу себе. Важно е да се задржи претходната ориентација на прирабницата со индикатор додека го влечете склопот.
6. Во LAO-приказот (ортогонално на интератријалниот септум), следете го врвот на дилататорот додека влечете за нагло медијално (или надесно) движење, што укажува дека врвот ја зафатил овалната фоса. (Видете ги следниве слики.)

   ЗАБЕЛЕШКА: Ако овалната фоса е проодна за сондата, сега врвот на дилататорот лесно влегува во левата преткомора.

Слика 6. Зафаќање на овалната фоса



1. Почетна положба во SVC
2. Почетно медијално движење во RA
3. Нагло медијално движење врз овалната фоса

ЗАБЕЛЕШКА: Ако го следите притисокот преку иглата, тој не е точен бидејќи во тој момент врвот е спроти овалната фоса.

Пробијте ја овалната фоса со транссептална игла BRK™

1. Потврдете ја точната локација на склопот од обвивка/дилататор/игла на овалната фоса пред да ја придвижите иглата.
2. Откако ќе ја потврдите точната локација, продолжете ја иглата за целосно ангажирање во склопот од обвивка/дилататор и придвижете ја иглата преку интератријалниот септум.

   ИЗБОРНО: Со следење на притисокот, влезот во левата преткомора се потврдува кога следењето на притисокот ќе покаже бранова форма на притисокот од левата преткомора.

   ИЗБОРНО: Пристапот до левата преткомора може да се потврди преку флуороскопија, со инјектирање контраст.

3. Ако има отпор на движењето на иглата, повлечете ја иглата и повторно проценете ги анатомските обележја.

   ВНИМАНИЕ: Ако влезете во перикардот или аортата, не придвижувајте го дилататорот врз иглата. Ако иглата навлезе во перикардот или аортата, мора да ја повлечете. Внимателно следете ги виталните знаци.

Придвижување на склопот од обвивка/ дилататор во левата преткомора

Додека одржувате фиксирана положба на иглата во левата преткомора, движете го напред склопот на обвивката/дилататорот целосно преку иглата во празнината на левата преткомора.

Придвижување на обвивката преку фиксен дилататор и игла во левата преткомора

1. Одржувајте ја положбата на иглата и дилататорот преку септумот.
2. Додека го одржувате дилататорот на фиксна локација, целосно придвижете ја обвивката преку дилататорот во левата преткоморна празнина.

Повлечете ја транссептална игла BRK™ и дилататорот

ВНИМАНИЕ: Постои ризик од инфилтрација на воздух при повлекување предмети од хемостатскиот вентил на обвивката. Бидете претпазливи за да спречите инфилтрација на воздухот со бавно повлекување на предметите за да спречите да се насобере вакуум во обвивката и флуороскопски следете ја обвивката во текот на вметнувањето на уредот за следење за присуство на воздух.

1. Свртете го вентилот на иглата во исклучена положба и откачете ги додатоците од оската на иглата.
2. Отстранете ја транссептална игла BRK™ од дилататорот. Исчистете ја иглата и оставете ја настрана за повторна употреба во текот на постапката. Во спротивно, фрлете ја иглата според упатствата за контаминирани остри предмети.
3. Веднаш прикачете шприц за дилататорот и аспирирајте. Продолжете да аспирирате крв држејќи ја обвивката в место и повлекувајќи го дилататорот. Крвта треба да биде артериска.
4. Откако ќе го отстраните дилататорот, аспирирајте крв преку страничниот ракав на обвивката. Внимателно исплакнете го страничниот ракав на обвивката со хепаринизиран физиолошки раствор за да избегнете воздушни меурчиња.
5. Обвивката сега се наоѓа во левата преткомора.

Амбалажа и рок на употреба

Транссептална игла BRK™ се испорачува стерилна. Иглата е спакувана со вметната сонда. Игла и сондата се ставени во примарната амбалажа. Примарната амбалажа е ставена во торбичка на Mylar‡ и Tyvek‡, којашто е термички запечатена. Потоа, торбичката и ова упатство за употреба се стават во кутија којашто се запечатува на двата краја. И на торбичката, и на кутијата има етикета со информации за производот, вклучувајќи и рок на траење. Производите се означени со рок на употреба од три години.

Резиме на клиничките податоци

За државите од Европската Унија: Надлежните органи ќе објават резиме на безбедносните и клиничките перформанси (SSCP) за овие уреди на https://ec.europa.eu/tools/eudamed во согласност со барањата на EU MDR 2017/745 и поврзаните временски линии. Пребарајте го уредот со помош на даденият UDI-DI даден на надворешната амбалажа од уредот. UDI-DI е 14-цифреният број помеѓу првите два сета загради. Информации за наоѓањето и користењето на UDI-DI ќе најдете во документот Чести прашања на medical.abbott/manuals.

Пријавување инциденти

Доколку сметате дека во текот на употребата на овој уред настанал сериозен инцидент, пријавете го кај производителот. Клиентите од Европската Унија треба да го пријават сериозниот инцидент кај државниот орган, како и кај производителот.

Ограничена гаранција

Abbott Medical гарантира дека нејзините производи се без дефекти во однос на материјалите и изработката кога се употребуваат во нормални услови. Оваа гаранција не го пречекорува рокот на „траење“ назначен на која било етикета на производот. Овластените употреби и одобрените методи на употреба на кој било производ се објаснети во соодветното „Упатство за употреба“ коешто се испорачува со секој производ. Abbott Medical се оградува од каква било обврска или одговорност за употребата на нејзините производи на неовластен или неодобрен начин. Одговорноста на Abbott Medical според оваа гаранција се ограничува на замена на производите. Претходно споменатата гаранција ги исклучува и се користи наместо сите други искажани и имплицитни гаранции вклучувајќи, но не ограничувајќи се, на која било имплицитна гаранција за квалитет или погодност за одредена цел. Abbott Medical се оградува од секаква одговорност за каква било случајна или последователна загуба, оштетување или трошок настанати директно или индиректно од употребата на производот поинаку од наведеното во конкретниот закон. Abbott Medical не презема, ниту овластува друго лице да преземе во нејзино име, друга или дополнителна обврска за загуба, оштетување или трошок во однос на овој производ. За повеќе детали, разгледајте ја целосната политиката за гаранции на Abbott Medical добиена од Abbott Medical или на задната страна на фактурата од Abbott Medical.

Симболи

На производот или на етикетата на производот може да се најдат следниве симболи и усогласени симболи. Стандардизираните симболи може да ги најдете во Универзалниот речник на симболи на medical.abbott/manuals.

Симбол	Дефиниција
Series	Серија
Contents	Содржина
Transseptal Needle	Транссептална игла
	Систем со една стерилна бариера
	Должина
Rx ONLY	ВНИМАНИЕ: Федералниот закон (САД) ја ограничува продажбата на овој уред само од страна на или по налог на лекар.
CE 2797	Conformité Européenne (европска усогласеност). Додадена согласно со релевантните одредби од регулативата 2017/745 на Европскиот совет. Со ова, Abbott Medical изјавува дека овој уред е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од оваа регулатива.
	Увозник
UK CA 0086	Направена е проценка на сообразноста за Обединетото Кралство
UKRP	Одговорно лице во Обединетото Кралство

Симбол	Дефиниција
 UA.TR.101	Украинска марка на сообразност со техничките прописи, каде 101 е орган за проценка.
	Медицински уред
	Единствена идентификација на уредот
 medical.abbott/manuals	Следете го упатството за употреба на оваа веб-локација
 (7440-48-4) (7439-92-1)	Содржи опасни супстанции. (Кобалт CAS бр. 7440-48-4) (Олово CAS бр. 7439-92-1)

NL: Nederlands

BRK™ Transseptale naald

Gebruiksaanwijzing

Beschrijving

De BRK™ transseptale naald bestaat uit een luminale roestvrijstalen naald en een solide roestvrijstalen stilet. Het distale deel van de naald is gebogen om het positioneren binnen het hart te vergemakkelijken bij gebruik met een transseptale schachtset van Abbott Medical. Binnen dit gebogen deel wordt de buitendiameter van de naald abrupt kleiner om aan te sluiten op de binnendiameter van de dilatator van een transseptale schachtset van Abbott Medical. De distale tip van de naald is afgeschuind om de punctie te vergemakkelijken. Het proximale uiteinde van de naald is geconfigureerd met een aanwijsflens (die de richting van de distale kromming aangeeft) en is voorzien van een tweewegafsluitkraan om toegang tot het naaldlumen te bieden voor aspiratie, injectie/infusie van vloeistoffen, bloedafname, drukbewaking en voor het inbrengen van een stilet en/of voerdraad (maximale voerdraaddiameter van 0,014 inch voor een naald van 18 gauge; maximale voerdraaddiameter 0,012 inch voor een naald van 19 gauge). Het stilet is over de gehele lengte recht en isodiametrisch. Het proximale uiteinde van het stilet is voorzien van een gebogen clip die op de proximale naaldhub vastklikt wanneer deze in het naaldlumen wordt ingebracht. Het stilet is ontworpen om het opvoeren van de naald in de dilatator te vergemakkelijken. De naald is verkrijgbaar in diverse bruikbare lengtes en distale gebogen configuraties.

Beoogd doel

De BRK™ transseptale naald is bedoeld om te worden gebruikt bij de punctie van het interatriale septum om toegang te verkrijgen tot de linkerharthelft.

Indicaties voor gebruik

De BRK™ transseptale naald wordt gebruikt bij de punctie van het interatriale septum tijdens een transseptale katheterisatie om toegang te verkrijgen tot de linkerharthelft.

Patiëntendoelgroep

De BRK™ transseptale naald is bedoeld om te worden gebruikt bij hemodynamisch stabiele patiënten waarbij kathetertoegang tot de linkerharthelft wordt vereist. Bij het gebruik van de BRK™ transseptale naald dient er speciale aandacht te worden besteed aan patiënten met de volgende aandoeningen:

- Een afwijkende hartas;
- Een vergrote aortawortel;
- Een duidelijke vergroting van het rechteratrium;
- Scoliose/kyfose;
- Abnormale geometrie van het linkeratrium;
- Aangeboren afwijkingen;
- Vaatafwijkingen;
- Problemen om toegang te krijgen tot het rechter atrium via de vena cava inferior.

Beoogde gebruiker

Dit hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door artsen die speciaal zijn opgeleid in transseptale procedures, in een volledig uitgerust operationeel elektrofysiologisch laboratorium.

Klinische voordelen

Het beoogd klinisch voordeel van de BRK™ transseptale naald is de punctie van het interatriale septum tijdens een transseptale katheterisatie om toegang te verkrijgen tot de linkerharthelft om hulpmiddelen die toegang vereisen tot het endocardiale hart aan de linkerzijde in staat te stellen hun beoogde klinische voordeel te bereiken, zoals een ablatiekatheter. Dit wordt gemeten door een succesvolle punctie van het interatriale septum.

Contra-indicaties

- Een eerdere interatriale septumpatch of atriumseptumdefectsluitingsprothese.
- Eerdere trombo-embolische complicaties.
- Een vastgesteld myxoom in het linkeratrium, of een vermoeden ervan.
- Vastgesteld myocardinfarct in de afgelopen twee weken, of een vermoeden ervan.
- Onstabiele angina pectoris.
- Recent cerebrovasculair accident (CVA).
- Patiënten die geen antistollingstherapie kunnen verdragen.
- Patiënten met een actieve infectie.

Waarschuwingen

- Voer geen aanpassingen aan het hulpmiddel uit.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. U dient het niet opnieuw te verwerken of opnieuw te gebruiken. Let op de “Uiterste gebruiksdatum” op de verpakking. Elke poging voor het opnieuw steriliseren en opnieuw gebruiken van het systeem kan de integriteit ervan in gevaar brengen. Tot de bijwerkingen van het gebruik van niet-steriele onderdelen behoren onder meer:
  - Een lokale en systemische infectie of reactie
  - Mechanische beschadiging
  - Onjuiste werking
- De hieronder per product vermelde materialen kunnen een allergische of overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Patiënten met een allergie kunnen een allergische reactie op dit product vertonen. Voordat u dit hulpmiddel op de patiënt gaat gebruiken, moet hij/zij worden geïnformeerd over de materialen in dit hulpmiddel en moet de geschiedenis van allergieën grondig worden besproken:
  - Roestvrij staal
  - Epoxylijm
  - Vernikkeld verchroomd messing
  - Siliconen hoogvacuümvet (Dupont)
  - Master Bond
- Verkeerd gebruik van dit hulpmiddel kan leiden tot ernstige complicaties.
- Voor zowel patiënten als laboratoriumpersoneel kunnen hartkatheterisatieprocedures aanzienlijke blootstelling aan röntgenstralen met zich meebrengen, wat kan leiden tot acuut stralingsletsel en een verhoogd risico op somatische en genetische gevolgen vanwege de intensiteit van de röntgenstraling en de duur van de beeldvorming onder fluoroscopie. Overweeg het gebruik van dit hulpmiddel bij zwangere vrouwen zorgvuldig.

Voorzorgsmaatregelen

- Volgens de federale wetgeving in de VS mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.
- Lees de aanwijzingen voorafgaand aan het gebruik.

- Controleer de verpakking voorafgaand aan het gebruik. Niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is.
- Inspecteer alle onderdelen vóór gebruik.
- Bewaren op een koele, donkere, droge plaats.
- Voorafgaand aan de procedure moet de patiënt hemodynamisch stabiel zijn. Bij bepaalde aandoeningen kunnen speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij gebruik van dit product. Voorbeelden hiervan zijn:
  - Een afwijkende hartas;
  - Een vergrote aortawortel;
  - Een duidelijke vergroting van het rechteratrium;
  - Scoliose/kyfose;
  - Abnormale geometrie van het linkeratrium;
  - Aangeboren afwijkingen;
  - Vaatafwijkingen;
  - Problemen om toegang te krijgen tot het rechter atrium via de vena cava inferior.
- Dit hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door artsen die speciaal zijn opgeleid in transseptale procedures, in een volledig uitgerust operationeel elektrofysiologisch (EP) laboratorium.
- Het opvoeren van de katheter moet onder fluoroscopische begeleiding worden uitgevoerd om het risico op hartbeschadiging, -perforatie of -tamponade te minimaliseren. Ook compatibele navigatie- en real-time visualisatiesystemen kunnen worden overwogen.
- Controleer op overmatige weerstand tijdens het inbrengen wanneer de tip van de naald door de kromming van de schacht/dilatatorconstructie beweegt. Als er weerstand is bij het opvoeren van de naald, trekt u de naald terug en beoordeelt u de onderdelen.
- Wees tijdens het inbrengen voorzichtig dat u het hulpmiddel niet te veel buigt. Dit kan het opvoeren van de naald belemmeren en kan resulteren in een onbedoelde naaldpunctie van de dilatator/schachtconstructie.
- Gebruik tijdens het inbrengen altijd het stilet om de doorvoer van de naald door de dilatator/schachtconstructie te vergemakkelijken. Het niet gebruiken van het stilet kan het opvoeren van de naald belemmeren en kan resulteren in een onbedoelde naaldpunctie van de dilatator/schachtconstructie of het afschrapen van materiaal van het binnenoppervlak van de dilatator.
- Wanneer de naald het pericard of de aorta binnendringt, voer de dilatator dan niet over de naald op. Als de naald het pericard of de aorta is binnengedrongen, moet deze worden teruggetrokken. Bewaak de vitale functies nauwkeurig.
- Er bestaat een risico op luchtinfiltratie bij het terugtrekken van voorwerpen uit de hemostaseklep van de schacht. Neem voorzorgsmaatregelen om luchtinfiltratie te voorkomen door voorwerpen langzaam terug te trekken om het opbouwen van vacuüm in de schacht te voorkomen en de schacht onder fluoroscopie te controleren op de aanwezigheid van lucht tijdens het daaropvolgende inbrengen van het hulpmiddel.
- Na gebruik moeten dit hulpmiddel, de accessoires en de verpakking op de juiste wijze worden geclassificeerd voor de afvoer, zoals biologisch gevaarlijk afval, scherpe voorwerpen, niet-gevaarlijk afval enz., en zorgvuldig worden afgevoerd in overeenstemming met de procedures van de faciliteit en de toepasselijke wet- en regelgeving.
- Een of meer onderdelen van dit hulpmiddel kunnen de volgende stof bevatten, gedefinieerd als CMR 1B, in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent: Kobalt: CAS-nr. (Chemical Abstracts Service) 7440-48-4; EC nr. 231-158-0. Op basis van huidig wetenschappelijk bewijs leiden medische hulpmiddelen die vervaardigd zijn van kobaltlegeringen en roestvrijstalen kobaltbevattende legeringen niet tot een verhoogd risico op kanker of schadelijke effecten op de voortplanting.

  Een of meer onderdelen van dit hulpmiddel kunnen de volgende stof bevatten, gedefinieerd als CMR 1A, in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent: Lood: CAS-nr. (Chemical Abstracts Service) 7439-92-1; EC nr. 231-100-4. Huidig wetenschappelijk bewijs ondersteunt dat medische hulpmiddelen vervaardigd uit lood geen verhoogd risico op kanker of nadelige effecten op de voortplanting veroorzaken.

Mogelijke bijwerkingen

Categorie ongewenste gebeurtenissen	Subcategorie ongewenste gebeurtenissen
Bloeding	Hemorragie/bloeding
	Hematoom
Cerebraal letsel	Asymptomatische hersenembolie
	Beroerte/cerebrovasculair accident
	Transient ischemic attack (TIA)
Embolie	Luchtembolie
	Embolie vreemd lichaam
	Longembolie
	Trombo-embolie
	Trombose/trombus
Hartperforatie	Harttamponnade
	Pericardeffusie
Cardiovasculair letsel	Hartklepbeschadiging
	Punctie van aortawortel
	Atriumperforatie
Verstoring van het geleidingssysteem	Blokkade in de SA-knoop, AV-knoop of His-Purkinje-systeem
	Hartaritmieën
Immunologische reactie	Anafylaxie
Infectie	Pericarditis
	Endocarditis
	Longontsteking
	Sepsis
Pijn/ongemak	Pijn, lies, borst (algemene pijn op de borst niet geassocieerd met MI)
Perifeer vasculair letsel	Dissectie
	Laceratie
	Vorming van arterioveneuze fistels
	Vorming van pseudo-aneurysma
Hypotensie	N.v.t.

Categorie ongewenste gebeurtenissen	Subcategorie ongewenste gebeurtenissen
Oppervlakkig weefselletsel	N.v.t.

Aanwijzingen

Uitrusting voorbereiden en monteren

1. Verwijder de inhoud uit de verpakking.

   OPMERKING: Monteer de schacht en dilatator niet.

2. Spoel de dilatator en schacht met geheparinieerde zoutoplossing.
3. Sluit de afsluitkraan van de schacht.
4. Verwijder het stilet van de naald en spoel de naald met geheparinieerde zoutoplossing.
5. Steek de stilet in de naald en sluit deze aan op de hub.
6. Steek de dilatator volledig in de transseptale schacht.

De schacht/dilatatorconstructie opvoeren in de vena cava superior

1. Verkrijg femorale veneuze toegang (bij voorkeur rechter arteria femoralis).

   OPTIONEEL: Er kan een grotere (≥2,5 French-maat groter dan de transseptale schacht) schacht van standaardlengte worden gebruikt om veneuze toegang te verkrijgen en te behouden voor het verwisselen van hulpmiddelen en hemostase.

2. Voer een 0,032 inch, 150 - 180 cm, 3 mm “J”-tip voerdraad op in de vena cava superior (SVC).

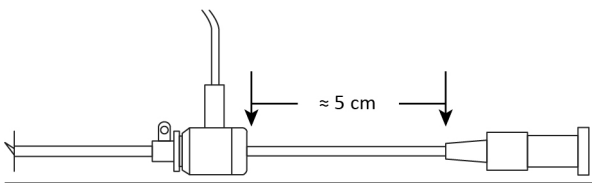
   OPMERKING: 0,032 inch is de maximale diameter van de voerdraad die kan worden gebruikt met de dilatator.

3. Voer de schacht/dilatator in de ader over de voerdraad op totdat de tip van de schacht zich in de SVC bevindt. Richt de dilatatortip mediaal.

De naald/stiletconstructie in de schacht/ dilatatorconstructie plaatsen

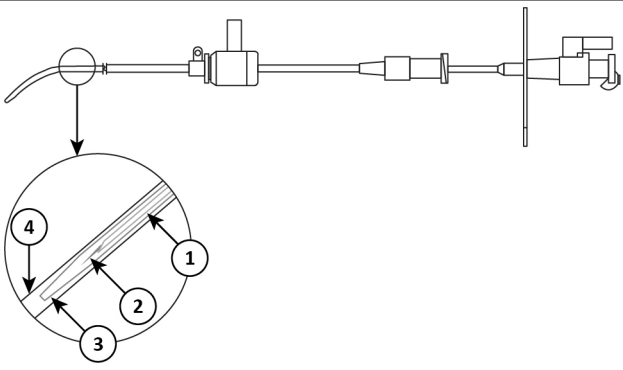
1. Verwijder de voerdraad uit de dilatator.
2. Aspireer volledig en spoel de dilatator vervolgens met geheparinieerde zoutoplossing.
3. Trek de dilatator ongeveer 5 cm terug (zie onderstaande afbeelding) om de doorgang van de naaldbocht door de stijve hubs van de dilatator en de schacht te vergemakkelijken.

Figuur 1. Dilatator terugtrekken



4. Sluit het stilet aan op de hub.
5. Steek de naald/stiletconstructie in de dilatator. Voer de naald/ stiletconstructie onder fluoroscopie op totdat deze zich ongeveer 2 cm van de dilatatortip in de schacht bevindt (zie onderstaande afbeelding).

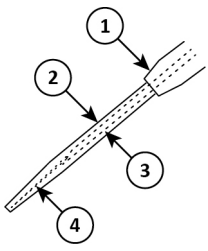
Figuur 2. Naald/stiletconstructie in de dilatator opvoeren



1. Naald
2. Stilet
3. Dilatatortip
4. Schacht

6. Om de schacht en de dilatator opnieuw aan te sluiten, voert u de dilatator en de naald/stiletconstructie gelijktijdig onder fluoroscopie op in de schacht. Zorg ervoor dat de positie van de naald in de dilatator niet verandert omdat beide componenten gelijktijdig worden opgevoerd. Behoud de positie van de tip van de schacht in de SVC.
7. Voer onder fluoroscopie de naald/stiletconstructie op totdat het stilet zich net proximaal van de dilatatortip bevindt (zie onderstaande afbeelding).

Figuur 3. Naald/stilet opvoeren



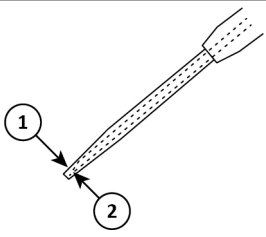
1. Tip van de schacht
2. Dilatator
3. Naald
4. Stilet

8. Verwijder de stilet, gooi deze niet weg.
9. Aspireer de naald tot het terugvloeien van bloed wordt waargenomen. Gooi de spuit weg.

   OPMERKING: Het gebruik van een spuit met slip-tip (geen Luer-Lok‡) kan het aspireren van lucht voorkomen.

10. Spoel de naald met geheparinieerde zoutoplossing. Sluit de afsluitkraan.
11. Voer de naald op onder fluoroscopie totdat de tip van de naald zich net proximaal van de dilatatortip bevindt (zie onderstaande afbeelding).

Figuur 4. Tip van de naald opvoeren



1. Dilatatortip
2. Tip van de naald

OPTIONEEL: Bevestig een roterende driewegkraan op de naaldhub.

OPTIONEEL: Bevestig een spuit met een radiopaak contrastmiddel op de afsluitkraan. Aspireer de naald. Laad vervolgens de naald met het contrastmiddel onder fluoroscopische begeleiding.

OPTIONEEL: Sluit een drukbewakingslijn aan op de afsluitkraan.

OPTIONEEL: Gebruik een standaard verdeelstuk met 3 poorten om contrast-, druk- en spoellijnen aan te sluiten.

Fossa ovalis binnengaan

1. Visualiseer en identificeer anatomische oriëntatiepunten.
2. Stel de fluoroscopie-unit in op een hoek die evenwijdig is aan het vlak van de mitralisklep en orthogonaal is aan het vlak van het septum. Dit is meestal links anterieur oblique (LAO), ongeveer 30 tot 40 graden.

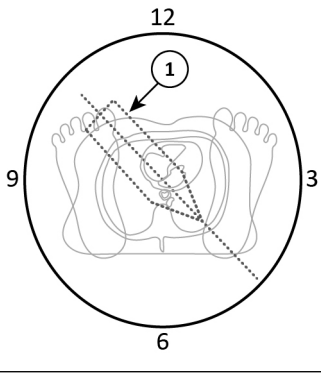
   OPTIONEEL: Tijdens EP-procedures kunnen de posities van de katheter in de sinus coronarius en in de bundel van His dienen als nuttige anatomische oriëntatiepunten. In de juiste LAO-weergave verschijnt de katheter in de sinus coronarius als zijaanzicht. In de juiste RAO-weergave (rechts anterieur oblique) verschijnt de katheter in de bundel van His als zijaanzicht. De fossa ovalis bevindt zich ter hoogte van of iets onder de katheter in de bundel van His en superieur en posterieur aan het ostium van de sinus coronarius.

   OPTIONEEL: Het plaatsen van een angiografische/hemodynamische pigtail-bewakingskatheter in de niet-coronaire knobbel van de aortaklep kan dienen als een nuttig anatomisch oriëntatiepunt.

   OPTIONEEL: Observeer de drukgolfvorm die wordt geregistreerd door de BRK™ transseptale naald.

3. Pas de aanwijsflens zo aan dat de naald zich loodrecht van de fossa ovalis bevindt (meestal tussen 3:00 en 5:00 uur, gezien vanaf het voeteneinde van de patiënt). (Zie onderstaande afbeelding.)

Figuur 5. Aanwijsflens van de naald

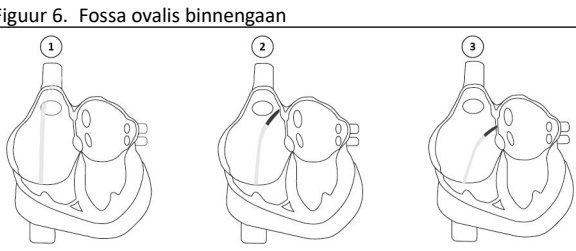


1. Aanwijsflens van de naald

4. Gebruik fluoroscopie om te bevestigen dat de tip van de naald zich in de dilatator bevindt.
5. Controleer of de tip van de naald zich in de dilatator bevindt en trek langzaam aan de gehele schacht/dilatator/naaldconstructie. Voorkom dat delen van de constructie ten opzichte van elkaar bewegen. Het is van essentieel belang om de eerdere richting van de aanwijsflens te behouden tijdens het aantrekken van de constructie.
6. Controleer tijdens het trekken in de LAO-weergave (orthogonaal op het interatriale septum) of de dilatatortip abrupte mediale (of rechtswaartse) bewegingen maakt, wat aangeeft dat de tip zich in de fossa ovalis heeft gegrepen. (Zie onderstaande afbeeldingen.)

   OPMERKING: Als de fossa ovalis eenvoudig geperforeerd kan worden, beweegt de dilatatortip nu gemakkelijk naar het linker atrium.

Figuur 6. Fossa ovalis binnengaan



1. Startpositie in SVC
2. Eerste mediale beweging in RA
3. Abrupte mediale beweging naar fossa ovalis

OPMERKING: Als de druk door de naald wordt gecontroleerd, is de druk door de naald op dit punt onnauwkeurig omdat de tip tegen de fossa ovalis drukt.

Puncteer de fossa ovalis met BRK™ transseptale naald

1. Bevestig de juiste locatie van de schacht/dilatator/naaldconstructie bij de fossa ovalis voordat de naald wordt opgevoerd.
2. Nadat de juiste locatie is bevestigd, schuift u de naald uit tot deze volledig in de schacht/dilatatorconstructie zit en voert u de naald door het interatriale septum op.

   OPTIONEEL: Onder drukbewaking wordt het binnengaan van het linkeratrium bevestigd wanneer de drukregistratie een drukgolfvorm van het linkeratrium weergeeft.

   OPTIONEEL: Toegang tot het linkeratrium kan worden bevestigd via fluoroscopie met contrastinjecties.

3. Als er weerstand is bij het opvoeren van de naald, trekt u de naald terug en beoordeelt u de anatomische oriëntatiepunten opnieuw.

   LET OP: Wanneer de naald het pericard of de aorta binnendringt, voer de dilatator dan niet over de naald op. Als de naald het pericard of de aorta is binnengedrongen, moet deze worden teruggetrokken. Bewaak de vitale functies nauwkeurig.

De schacht/dilatatorconstructie opvoeren in het linkeratium

Voer de schacht/dilatatoreenheid volledig over de naald op in de linkeratriale holte terwijl u de naald in een vaste positie in het linkeratrium houdt.

De schacht over de vaste dilatator en naald in het linkeratrium opvoeren

1. Behoud de positie van de naald en dilatator over het septum.
2. Terwijl u de dilatator op een vaste plek houdt, voert u de schacht volledig op over de dilatator in de linkeratrium.

BRK™ transseptale naald en dilatator terugtrekken

LET OP: Er bestaat een risico op luchtinfiltratie bij het terugtrekken van voorwerpen uit de hemostaseklep van de schacht. Neem voorzorgsmaatregelen om luchtinfiltratie te voorkomen door voorwerpen langzaam terug te trekken om het opbouwen van vacuüm in de schacht te voorkomen en de schacht onder fluoroscopie te controleren op de aanwezigheid van lucht tijdens het daaropvolgende inbrengen van het hulpmiddel.

1. Draai de afsluitkraan van de naald dicht en koppel alle hulpstukken van de naaldhub los.
2. Verwijder de BRK™ transseptale naald van de dilatator. De naald kan worden gereinigd en bewaard om deze opnieuw te gebruiken tijdens deze procedure. Voer de naald anders af volgens de procedures voor verontreinigde scherpe voorwerpen.
3. Bevestig onmiddellijk een spuit op de dilatator en aspireer. Ga door met het aspireren van bloed terwijl u de schacht op zijn plaats houdt en de dilatator terugtrekt. Het bloed moet arterieel bloed zijn.
4. Nadat de dilatator is verwijderd, aspireert u bloed via de zijarm van de schacht. Spoel de zijarm van de schacht zorgvuldig met gehepariniseerde zoutoplossing om luchtbellen te voorkomen.
5. De schacht zit nu op zijn plaats in het linkeratrium.

Verpakking en houdbaarheid

De BRK™ transseptale naald wordt steriel geleverd. De naald is verpakt met een stilet erin geplaatst. De naald en het stilet worden in de hoofdverpakking geplaatst. De hoofdverpakking wordt in een Mylar‡- en Tyvek‡-zakje geplaatst, dat door middel van warmte is verzegeld. Het zakje en deze gebruiksaanwijzing worden vervolgens in een doos geplaatst, die aan beide kanten is verzegeld. Zowel het zakje als de doos zijn voorzien van een etiket met productinformatie, inclusief de Uiterste gebruiksdatum. Het etiket van de producten geeft een houdbaarheid van drie jaar.

Overzicht van klinische gegevens

Voor landen binnen de Europese Unie: Een samenvatting van de veiligheids- en klinische prestaties (SSCP) voor deze hulpmiddelen zal worden gepubliceerd op https://ec.europa.eu/tools/eudamed door de aangemelde instanties overeenkomstig de vereisten van EU MDR 2017/745 en bijbehorende tijdlijnen. U kunt het hulpmiddel zoeken met behulp van de UDI-DI op de buitenzijde van de verpakking. De UDI-DI is het 14-cijferige nummer tussen de eerste twee sets met haakjes. Raadpleeg voor meer informatie over het vinden en toepassen van de UDI-DI het document met veelgestelde vragen op medical.abbott/manuals.

Melden van incidenten

Als u tijdens de gebruiksduur van dit hulpmiddel vermoedt dat er een ernstig incident is opgetreden, dient u dit bij de fabrikant te melden. Voor klanten in de Europese Unie geldt dat ernstige incidenten zowel bij de nationale instantie als bij de fabrikant moeten worden gemeld.

Beperkte garantie

Abbott Medical garandeert dat de producten van Abbott Medical bij normaal gebruik vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking. Deze garantie geldt niet meer na de “uiterste gebruiksdatum” die op de etikettering van alle producten staat vermeld. Het geautoriseerde gebruik en de goedgekeurde gebruiksmethoden van elk van onze producten is uiteengezet in de “gebruiksaanwijzing” die met elk product wordt geleverd. Abbott Medical wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor het gebruik van de producten van Abbott Medical op een manier die niet is geautoriseerd of goedgekeurd. De aansprakelijkheid van Abbott Medical onder deze garantie is beperkt tot het vervangen van de producten van Abbott Medical. De bovenstaande garantie sluit alle andere garanties uit en vervangt alle andere garanties, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Abbott Medical wijst alle aansprakelijkheid af voor incidentele of gevolgschade, verlies of kosten die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van dit product, anders dan welke uitdrukkelijk door specifieke wetgeving wordt voorgeschreven. Abbott Medical aanvaardt geen enkele andere of aanvullende aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten in verband met dit product, noch autoriseert Abbott Medical enig ander persoon om namens Abbott Medical dergelijke aansprakelijkheid te aanvaarden. Raadpleeg voor meer informatie het volledige garantiebeleid van Abbott Medical dat bij Abbott Medical kan worden opgevraagd en op de achterzijde van facturen van Abbott Medical is afgedrukt.

Symbolen

Op het product of het productetiket kunnen de volgende symbolen en geharmoniseerde symbolen zijn aangebracht. Raadpleeg de Universal Symbols Glossary (verklaring van universele symbolen) op medical.abbott/manuals voor informatie over de betekenis van geharmoniseerde symbolen.

Symbool	Definitie
Series	Serie
Contents	Inhoud
Transseptal Needle	Transseptale naald
	Systeem met enkelvoudige steriele barrière
	Lengte
	LET OP: Volgens de federale wetgeving in de VS mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.
	Conformité Européenne (Europese conformiteit). Aangebracht in overeenstemming met Verordening 2017/745 van de Europese Raad. Hierbij verklaart Abbott Medical dat dit hulpmiddel voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van deze verordening.
	Importeur
	Conformiteit voor Verenigd Koninkrijk beoordeeld
UKRP	Verantwoordelijke persoon in het Verenigd Koninkrijk
	Oekraïense markering van conformiteit met de technische voorschriften, waarbij 101 de beoordelende instantie is.

Symbool	Definitie
MD	Medisch hulpmiddel
UDI	Unieke hulpmiddelenidentificatie
medical.abbott/manuals	Volg de gebruiksaanwijzing op deze website
(7440-48-4) (7439-92-1)	Bevat schadelijke stoffen. (Kobalt CAS-nr. 7440-48-4) (Lood CAS-nr. 7439-92-1)

NO: Norsk

BRK™ Transseptal nål

Bruksanvisning

Beskrivelse

Den transseptale BRK™-nålen består av en luminal nål i rustfritt stål og en massiv sonde i rustfritt stål. Den distale delen av nålen er buet for å lette posisjonering i hjertet når den brukes sammen med et transseptalt hylsesett fra Abbott Medical. I denne buede delen er det et skarpt trinn nedover i den ytre diameteren av nålen slik at den passer overens med den indre diameteren av dilatatoren i et transseptalt hylsesett fra Abbott Medical. Den distale nålespissen er avskrådd for å lette punksjonsprosessen. Den proksimale enden av nålen er konfigurert med en pekerflens (som indikerer distal bueorientering) og er utstyrt med en 2-veis stoppekran for å gi tilgang til nålens lumen for aspirasjon, væskeinnsprøytning/-infusjon, blodprøvetaking, trykkovervåkning og innsetting av sonde og/eller mandreng (0,014 tommers maksimal mandrengdiameter for en 18 G-nål; 0,012 tommers maksimal mandrengdiameter for en 19 G-nål). Sonden er rett og isodiametrisk i hele lengden. Den proksimale enden av sonden er utstyrt med et buet klips som skal låses fast til det proksimale nålefestet når det settes inn i nålens lumen. Sonden er designet for å gjøre det lettere å føre frem nålen i dilatatoren. Nålen fås i ulike anvendelige lengder og distale buekonfigurasjoner.

Tiltenkt formål

Den transseptale BRK™-nålen er beregnet på å punktere septum mellom atriene for å få tilgang til venstre hjertekammer.

Indikasjoner for bruk

Den transseptale BRK™-nålen brukes til å punktere septum mellom atriene under en transseptal kateteriseringsprosedyre for å få tilgang til venstre hjertekammer.

Pasientmålgruppe

Den transseptale BRK™-nålen er beregnet for bruk på hemodynamisk stabile pasienter som trenger katetertilgang til venstre hjertekammer. Bruk av den transseptale BRK™-nålen kan kreve spesielle hensyn hos pasienter med følgende forhold:

- Rotert hjerte
- Forstørret aortarot
- Markert forstørrelse av høyre atrium
- Skoliose/kyfose
- Unormal geometri i venstre atrium
- Medfødte misdannelser
- Vaskulære misdannelser
- Manglende mulighet til å få tilgang til høyre atrium gjennom vena cava inferior

Tiltenkt bruker

Denne enheten skal kun brukes av leger som er spesialutdannet i transseptale prosedyrer, i et fullt utstyrt operativt elektrofysiologisk laboratorium.

Klinisk nytteverdi

Den tiltenkte kliniske nytteverdien av den transseptale BRK™-nålen er å punktere septum mellom atriene under en transseptal kateteriseringsprosedyre for å få tilgang til venstre hjertekammer slik at enheter som krever endokardial tilgang til venstre side av hjertet kan oppnå den tiltenkte kliniske nytteverdien, som for eksempel et ablasjonskateter. Dette måles ved vellykket punksjon av septum mellom atriene.

Kontraindikasjoner

- Tidligere interatriell septal patch eller protetisk lukkeinnretning for atrieseptumdefekt.
- En tidligere tromboembolisk episode.
- Kjent eller mistenkt venstre atrielt myksom.
- Kjent eller mistenkt myokardinfarkt i løpet av de to siste ukene.
- Ustabil angina.
- Nyere cerebrovaskulær hendelse (CVA).
- Pasienter som ikke tåler antikoagulasjonsbehandling.
- Pasienter med aktiv infeksjon.

Advarsler

- Denne enheten skal ikke modifiseres på noen måte.
- Denne enheten skal bare brukes én gang. Den må ikke reprosesseres eller gjenbrukes. Legg merke til «Brukes innen»-datoen på pakningen. Forsøk på resterilisering og gjenbruk av dette systemet kan forringe integriteten. Bivirkninger av å bruke ikke-sterile komponenter kan omfatte, men er ikke begrenset til:
  - Lokal og systemisk infeksjon eller reaksjon
  - Mekanisk skade
  - Unøyaktig funksjonalitet
- Materialene identifisert nedenfor per produkt kan forårsake allergiske reaksjoner eller overfølsomhetsreaksjoner. Personer med allergi mot disse kan reagere allergisk på dette produktet. Før det brukes på pasienten, bør pasienten få beskjed om materialene i enheten, og en eventuell allergihistorikk må diskuteres grundig:
  - Rustfritt stål
  - Epoksylim
  - Nikkelforkrommet messing
  - Høyvakuum silikonfett (DuPont)
  - Master Bond
- Feil bruk av denne enheten kan føre til alvorlige komplikasjoner.
- Prosedyrer for hjertekateterisering øker faren for betydelig røntgeneksponering for både pasienter og laboratoriepersonell, noe som kan resultere i akutt stråleskade samt økt risiko for somatiske og genetiske effekter pga. røntgenstråleintensiteten til og varigheten av den fluoroskopiske avbildningen. Bruken av denne enheten hos gravide kvinner må overveies nøye.

Forholdsregler

- Ifølge føderal lovgivning (USA) kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege.
- Les anvisningene før bruk.
- Kontroller pakningen før bruk. Må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet.
- Kontroller alle komponentene før bruk.
- Oppbevares på et kjølig, mørkt, tørt sted.
- Før prosedyren må pasienten være hemodynamisk stabil. Enkelte tilstander kan kreve spesielle hensyn ved bruk av dette produktet. Disse omfatter blant annet:

  - Rotert hjerte
  - Forstørret aortarot
  - Markert forstørrelse av høyre atrium
  - Skoliose/kyfose
  - Unormal geometri i venstre atrium
  - Medfødte misdannelser
  - Vaskulære misdannelser
  - Manglende mulighet til å få tilgang til høyre atrium gjennom vena cava inferior
- Denne enheten skal kun brukes av leger som er spesialutdannet i transseptale prosedyrer, i et fullt utstyrt operativt elektrofysiologisk (EP) laboratorium.
- Fremføring av kateteret skal utføres under fluoroskopisk veiledning for å minimere risikoen for hjerteskade, -perforasjon eller -tamponade. Kompatible navigasjons- og sanntidsvisualiseringssystemer kan også vurderes.
- Under innsetting må det kontrolleres at det ikke er sterk motstand når nålespissen beveger seg gjennom kurvaturen på hylse-/dilatatorenheten. Hvis det merkes motstand ved fremføring av nålen, skal nålen trekkes tilbake og komponentene undersøkes.
- Under innsetting må du være forsiktig så du ikke lager for store bøyninger i enheten. Dette kan hindre fremføringen av nålen og kan føre til utilsiktet punksjon av dilatator-/hylseenheten.
- Under innsetting må du alltid bruke sonden for å lette nålens gjennomgang gjennom dilatator-/hylseenheten. Hvis det ikke brukes sonde, kan det hindre fremføringen av nålen og føre til utilsiktet punksjon av dilatator-/hylseenheten eller avstikking av materiale fra den indre overflaten av dilatatoren.
- Hvis det oppstår inntrenging i perikardiet eller aorta, må du ikke føre dilatatoren over nålen. Hvis nålen har trengt gjennom perikardiet eller aorta, må den tas ut. Overvåk vitale tegn nøye.
- Det er fare for luftinfiltrasjon når du trekker ut gjenstander fra hylsens hemostaseventil. Ta forholdsregler for å forhindre luftinfiltrasjon ved å trekke ut gjenstandene langsomt for å forhindre oppbygging av vakuum i hylsen. Overvåk hylsen fluoroskopisk under påfølgende innsetting av enheten med tanke på luft.
- Etter bruk skal enheten, tilbehøret og emballasjen klassifiseres for riktig deponering, f.eks. biologisk farlig avfall, spisse gjenstander, ikke-farlig avfall osv., og deponeres i samsvar med institusjonens prosedyrer og gjeldende lover og bestemmelser.
- Én eller flere komponenter i denne enheten kan inneholde følgende stoff definert som CMR 1B i en konsentrasjon over 0,1% vekt/vekt: kobolt: CAS-nr. (Chemical Abstracts Services) 7440-48-4; EF-nr. 231-158-0. Gjeldende vitenskapelige holdepunkter støtter at medisinske enheter som produseres av koboltlegeringer og legeringer av rustfritt stål som inneholder kobolt, ikke medfører økt risiko for kreft eller negative reproduksjonseffekter.

  Én eller flere komponenter i denne enheten kan inneholde følgende stoff definert som CMR 1A i en konsentrasjon over 0,1% vekt/vekt: bly: CAS-nr. (Chemical Abstracts Services) 7439-92-1; EF-nr. 231-100-4. Gjeldende vitenskapelige holdepunkter støtter at medisinske enheter som produseres av bly, ikke medfører økt risiko for kreft eller negative reproduksjonseffekter.

Mulige bivirkninger

Bivirkningskategori	Underkategori av bivirkninger
Blødning	Hemoragi/blødning
	Hematom
Cerebral skade	Asymptomatisk hjerneemboli
	Slag / cerebrovaskulær hendelse
	Transitorisk iskemisk anfall (TIA)
Embolisme	Luftemboli
	Fremmedlegemeemboli
	Lungeemboli
	Tromboembolisme
	Trombose/trombe
Hjerteperforasjon	Hjertetamponade
	Perikardial effusjon
Kardiovaskulær skade	Valvulær skade
	Punksjon av aortarot
	Perforasjon av atrium
Forstyrrelse i ledningssystemet	Blokkering av SA-node, AV-node eller His-Purkinje-system
	Hjertearytmier
Immunologisk reaksjon	Anafylaksi
Infeksjon	Perikarditt
	Endokarditt
	Lungebetennelse
	Sepsis
Smerter/ubehag	Smerter, lyske, bryst (generelle brystsmerter som ikke er forbundet med MI)
Perifer vaskulær skade	Disseksjon
	Laserasjon
	Arteriovenøs fisteldannelse
	Dannelse av pseudoaneurisme
Hypotensjon	I/A
Overfladisk vevsskade	I/A

Anvisninger

Klargjør og monter utstyret

1. Ta innholdet ut av emballasjen.

   MERK: Ikke monter hylsen og dilatatoren.
2. Skyll dilatatoren og hylsen med heparinisert saltvann.
3. Lukk hylsens stoppekran.
4. Fjern sonden fra nålen og skyll nålen med heparinisert saltvann.
5. Sett sonden inn i nålen og lås den fast i nålefestet.
6. Sett dilatatoren helt inn i den transseptale hylsen.

Før hylse-/dilatatorenheten inn i vena cava superior

1. Skaff tilgang via vena femoralis (høyre femoralis er foretrukket).

   ALTERNATIVT: En større standardhylse (≥ 2,5 French (Fr.)-størrelser større enn den transseptale hylsen) kan brukes for å oppnå og opprettholde venøs tilgang for utskifting av enheter og hemostase.

2. Før en 0,032 tommer, 150–180 cm, 3 mm mandreng med «J»-spiss inn i vena cava superior (SVC).

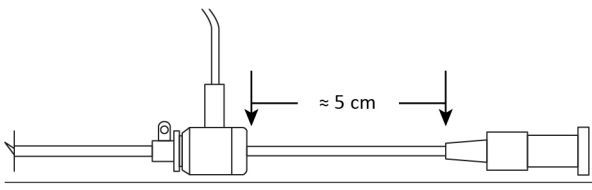
   MERK: 0,032 tommer er den maksimale mandrengdiameteren som kan brukes med dilatatoren.

3. Sett hylsen/dilatatoren inn i venen over mandrengen inntil hylsespissen er i SVC. Rett inn dilatatorspissen medialt.

Plasser nål-/sondeenheten inne i hylse-/diltatatorenheten

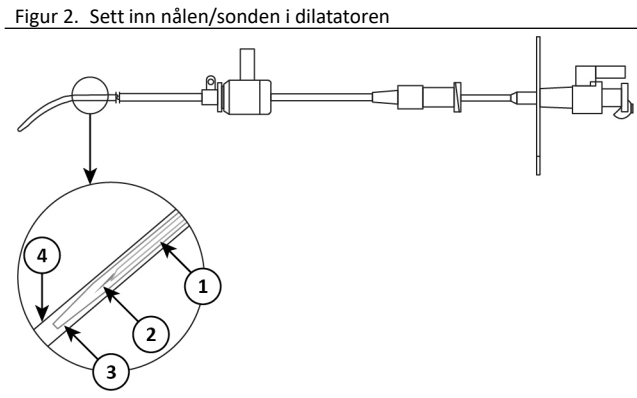
1. Fjern mandrengen fra dilatatoren.
2. Aspirer helt og skyll deretter dilatatoren med heparinisert saltvann.
3. Trekk ut dilatatoren ca. 5 cm (se figuren nedenfor) for å lette passeringen av nålebuen gjennom de stive nålefestene i dilatatoren og hylsen.

Figur 1. Trekk ut dilatatoren



4. Lås sonden i nålefestet.
5. Sett inn nålen/sonden i dilatatoren. Før frem nålen/sonden under fluoroskopi til den er omtrent 2 cm fra dilatatorspissen inne i hylsen (se figuren nedenfor).

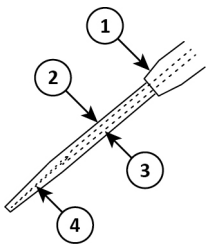
Figur 2. Sett inn nålen/sonden i dilatatoren



1. Nål
2. Sonde
3. Dilatatorspiss
4. Hylse

6. Koble til hylsen og dilatatoren igjen ved å føre dilatatoren og nålen/sonden inn i hylsen samtidig under fluoroskopi. Forsikre deg om at nålens plassering i dilatatoren ikke endres, ettersom begge komponentene føres frem sammen. Opprettholde hylsespissposisjonen i SVC.
7. Før frem nålen/sonden under fluoroskopi til sonden er rett proksimal for dilatatorspissen (se figuren nedenfor).

Figur 3. Før frem nålen/sonden



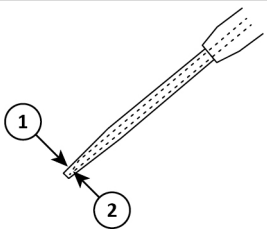
1. Hylsespiss
2. Dilatator
3. Nål
4. Sonde

8. Fjern sonden, men ikke kast den.
9. Aspirer nålen til blod observeres. Kast sprøyten.

   MERK: Bruk av en sprøyte med glidespiss (ikke Luer-Lok‡) kan forhindre luftaspirasjon.

10. Skyll nålen med heparinisert saltvann. Lukk stoppekranen.
11. Før frem nålen under fluoroskopi til nålespissen er rett proksimal for dilatatorspissen (se figuren nedenfor).

Figur 4. Før frem nålespissen



1. Dilatatorspiss
2. Nålespiss

ALTERNATIVT: Fest en 3-veis roterende stoppekran til nålefestet.

ALTERNATIVT: Fest en sprøyte med røntgentett kontrastmiddel til stoppekranen. Aspirer nålen. Last deretter nålen med kontrastmiddelet under fluoroskopisk veiledning.

ALTERNATIVT: Koble en trykkovervåkningslinje til stoppekranen.

ALTERNATIVT: Bruk et standard 3-ports manifoldoppsett for å koble til kontrast-, trykk- og skyllelinjer.

Oppnå kontakt med fossa ovalis

1. Visualiser og identifiser anatomiske landemerker.

2. Sett fluoroskopienheten i en vinkel parallelt med mitralklaffens plan og ortogonalt for septumplanet. Dette vil vanligvis være venstre anterior skråstilt (LAO), omtrent 30 til 40 grader.

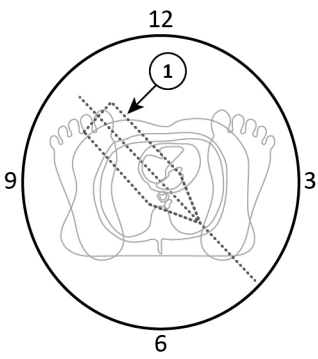
   ALTERNATIVT: Under EP-prosedyrer kan koronarsinus og His-kateterbuntposisjoner fungere som nyttige anatomiske landemerker. I riktig LAO-visning vises koronarsinuskateteret i profil. I riktig RAO-visning (høyre anterior skråstilt) vises His-kateterbunten i profil. Fossa ovalis er på samme nivå som eller litt under His-kateterbunten og superiort og posteriort for ostium av sinus coronarius.

   ALTERNATIVT: Plassering av et angiografisk/hemodynamisk overvåkningskateter med pigtail i den ikke-koronare forhøyningen på aortaklaffen kan fungere som et nyttig anatomisk landemerke.

   ALTERNATIVT: Følg med på trykkurven som registreres gjennom den transseptale BRK™-nålen.

3. Juster pekerflensen slik at nålen står vinkelrett på fossa ovalis (vanligvis mellom kl. 3- og kl. 5-posisjon sett fra pasientens fotende). (Se figuren nedenfor.)

Figur 5. Nålepekerflens

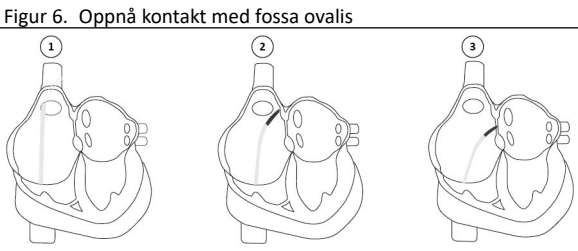


1. Nålepekerflens

4. Bruk fluoroskopi for å bekrefte at nålespissen er inne i dilatatoren.
5. Etter at du har kontrollert at spissen av nålen er inni dilatatoren, dras hele hylse-/dilatator-/nåleenheten langsomt. Hindre at de monterte delene beveger seg i forhold til hverandre. Det er helt avgjørende å opprettholde den foregående orienteringen til pekerflensen mens du drar i enheten.
6. I LAO-visning (ortogonalt for septum mellom atriene) må du følge med på spissen på dilatatoren under trekkingen med tanke på abrupte mediale bevegelser (mot høyre), noe som indikerer at spissen har kontakt med fossa ovalis. (Se figurene nedenfor.)

   MERK: Hvis fossa ovalis er probepatent, føres dilatatorspissen nå enkelt inn i venstre atrium.

Figur 6. Oppnå kontakt med fossa ovalis



1. Startposisjon i vena cava superior
2. Innledende medial bevegelse i RA
3. Abrupt medial bevegelse mot fossa ovalis

MERK: Hvis trykket overvåkes gjennom nålen, er trykket gjennom nålen unøyaktig på dette tidspunktet siden spissen hviler mot fossa ovalis.

Punkter fossa ovalis med den transseptale BRK™-nålen

1. Kontroller riktig plassering av hylse-/dilatator-/nåleenheten på fossa ovalis før fremføring av nålen.
2. Etter at riktig plassering er bekreftet, trekkes nålen ut til det oppnås fullt inngrep i hylse-/dilatatorenheten. Før frem nålen over septum mellom atriene.

   ALTERNATIVT: Under trykkovervåkning bekreftes inngang i venstre atrium når trykksporingen viser en trykkbølgeform for venstre atrium.

   ALTERNATIVT: Tilgang til venstre atrium kan bekreftes via fluoroskopi med kontrastinjeksjoner.

3. Hvis det merkes motstand mot fremføring av nålen, trekkes nålen tilbake og de anatomiske landemerkene vurderes på nytt.

   FORSIKTIG: Hvis det oppstår inntrenging i perikardiet eller aorta, må du ikke føre dilatatoren over nålen. Hvis nålen har trengt gjennom perikardiet eller aorta, må den tas ut. Overvåk vitale tegn nøye.

Før hylse-/dilatatorenheten inn i venstre atrium

Oppretthold en fast nåleposisjon i venstre atrium og før hylse-/dilatatorenheten helt over nålen og inn i venstre atriekavitet.

Før hylsen over den fikserte dilatatoren og nålen inn i venstre atrium

1. Oppretthold nålens og dilatatorens posisjon over septum.
2. Hold dilatatoren i en fast posisjon, og før hylsen helt over dilatatoren og inn i venstre atriekavitet.

Trekk tilbake den transseptale BRK™-nålen og dilatatoren

FORSIKTIG: Det er fare for luftinfiltrasjon når du trekker ut gjenstander fra hylsens hemostaseventil. Ta forholdsregler for å forhindre luftinfiltrasjon ved å trekke ut gjenstandene langsomt for å forhindre oppbygging av vakuum i hylsen. Overvåk hylsen fluoroskopisk under påfølgende innsetting av enheten med tanke på luft.

1. Vri nålens stoppekran til av-stillingen, og koble fra eventuelt tilbehør til nålefestet.
2. Fjern den transseptale BRK™-nålen fra dilatatoren. Nålen kan rengjøres og settes til side for gjentatt bruk i denne prosedyren. Ellers må nålen kastes på riktig måte for kontaminerte skarpe gjenstander.
3. Fest straks en sprøyte til dilatatoren og aspirer. Fortsett å aspirere blod mens du holder hylsen på plass og trekker ut dilatatoren. Blodet skal være arterielt blod.
4. Etter at dilatatoren er fjernet, aspirerer du blod gjennom hylsens sidearm. Skyll sidearmen på hylsen forsiktig med heparinisert saltvann for å unngå luftbobler.
5. Hylsen er nå på plass i venstre atrium.

Emballasje og holdbarhet

Den transseptale BRK™-nålen leveres steril. Nålen er emballert med innsatt sonde. Nålen og sonden er lagt i den primære emballasjen.

Primæremballasjen er lagt i en Mylar‡- og Tyvek‡-pose som er varmeforseglet. Posen og denne bruksanvisningen er deretter lagt i en eske som er forseglet i begge ender. Både posen og esken har en etikett med produktinformasjon, inkludert utløpsdato. Produktene er merket med en holdbarhet på tre år.

Sammendrag av kliniske data

For EU-land: Et sammendrag av sikkerhet og klinisk ytelse (SSCP) for disse enhetene vil bli publisert på https://ec.europa.eu/tools/eudamed av de tekniske kontrollorganene i samsvar med kravene i EU MDR 2017/745 og tilhørende tidslinjer. Søk etter enheten ved å bruke UDI-DI som angitt på enhetens ytre emballasje. UDI-DI er det 14-sifrede tallet mellom de to første settene med parenteser. Du finner mer informasjon om å finne og bruke UDI-DI-en i dokumentet Frequently Asked Questions (Vanlige spørsmål) på medical.abbott/manuals.

Rapportering av hendelse

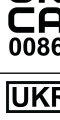
Hvis du under bruk av denne enheten har grunn til å tro at det har skjedd en alvorlig hendelse, må du rapportere dette til produsenten. For kunder i EU må den alvorlige hendelsen rapporteres til den nasjonale tilsynsmyndigheten og produsenten.

Begrenset garanti

Abbott Medical garanterer at produktene skal være uten defekter i materialer og håndverksmessig utførelse ved normal bruk. Denne garantien gjelder ikke etter «utløpsdatoen» oppgitt på produktetiketter. Autoriserte bruksområder og godkjente bruksmetoder for hvert av produktene våre er fremsatt i den aktuelle bruksanvisningen som følger med hvert produkt. Abbott Medical fraskriver seg ethvert ansvar for bruken av selskapets produkter på en måte som ikke er autorisert eller godkjent. Abbott Medicals erstatningsansvar i henhold til denne garantien er begrenset til å erstatte produktene. Den foregående garantien ekskluderer og er i stedet for alle andre garantier, enten uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier for salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Abbott Medical fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldig eller følgemessig tap, skade eller kostnad som oppstår direkte eller indirekte fra bruken av dette produktet, bortsett fra det som er uttrykkelig dekket av en spesiell lov. Abbott Medical verken påtar seg eller autoriserer noen annen person til å påta seg på sine vegne noe annet eller ekstra ansvar for tap, skade eller kostnad i forbindelse med dette produktet. For mer informasjon, se Abbott Medicals fullstendige garantivilkår som kan fås fra Abbott Medical eller som er angitt på baksiden av fakturaer fra Abbott Medical.

Symboler

Symbolene nedenfor og harmoniserte symboler kan finnes på produktet eller produktets etikett. Du finner harmoniserte symboler i den universelle ordlisten for symboler på medical.abbott/manuals.

Symbol	Forklaring
Series	Serie
Contents	Innhold
Transseptal Needle	Transseptal nål
	Enkelt sterilt barrieresystem
	Lengde
	FORSIKTIG: Ifølge føderal lovgivning (USA) kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege.
	Conformité Européenne (europeisk samsvar). Merket i samsvar med Det europeiske råds forordning 2017/745. Abbott Medical erklærer herved at denne enheten overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i denne forordningen.
	Importør
	Samsvar evaluert for Storbritannia
UKRP	Ansvarlig person i Storbritannia
	Ukrainsk merking av samsvar med tekniske forskrifter, der 101 er vurderingsorganet.
MD	Medisinsk utstyr
UDI	Unik enhetsidentifikasjon
	Se bruksanvisningen på disse nettsidene
 (7440-48-4) (7439-92-1)	Inneholder farlige stoffer. (kobolt CAS-nr. 7440-48-4) (bly CAS-nr. 7439-92-1)

PL: Polski

BRK™ Igła przezprzegrodowa

Instrukcja użycia

Opis

Igła przezprzegrodowa BRK™ składa się z igły oraz mandrynu wykonanych ze stali nierdzewnej. Dystalna część igły jest zakrzywiona, aby ułatwić ułożenie w sercu podczas stosowania z zestawem koszulki przezgrodowej firmy Abbott Medical. W obszarze zakrzywionym średnica zewnętrzna igły zmniejsza się w celu dopasowania do wewnętrznej średnicy rozszerzacza z zestawu koszulki przezgrodowej firmy Abbott Medical. Końcówka dystalna igły jest stożkowata, celem ułatwienia nakłucia. Proksymalna końcówka igły jest skonfigurowana z kołnierzem wskaźnika (wskazując kierunek zakrzywienia dystalnego) oraz jest wyposażona w 2-drożny kurek odcinający, aby zapewnić dostęp do światła do aspiracji, wstrzykiwania / infuzji płynów, pobierania próbek krwi, monitorowania ciśnienia oraz umieszczania mandrynu i/lub prowadnicy (maksymalna średnica prowadnika 0,014 cala [0,36 mm] dla igły o rozmiarze 18 G; maksymalna średnica prowadnika 0,012 cala [0,30 mm] dla igły o rozmiarze 19 G). Mandryn jest prosty i ma jednakową średnicę na całej długości. Proksymalna końcówka mandrynu wyposażona jest w zakrzywiony zacisk zamykający gniazdo proksymalne igły podczas wkładania do światła igły. Mandryn zaprojektowany jest do ułatwienia wsuwania igły w rozszerzaczu. Igła dostępna jest w różnych długościach użytkowych i konfiguracjach zakrzywienia dystalnego.

Przeznaczenie

Igła przezprzegrodowa BRK™ służy do punkcji przegrody międzyprzedsionkowej w celu uzyskania dostępu do lewej części serca.

Wskazania do stosowania

Igła przezprzegrodowa BRK™ stosowana jest do punkcji przegrody międzyprzedsionkowej podczas zabiegu cewnikowania przezprzegrodowego, w celu uzyskania dostępu do lewej części serca.

Grupa docelowa pacjentów

Igła przezprzegrodowa BRK™ może być stosowana u pacjentów stabilnych hemodynamicznie, u których wymagane jest uzyskanie dostępu do lewej części serca w celu wprowadzenia cewnika. Stosowanie igły przezprzegrodowej BRK™ u pacjentów może wymagać szczególnego rozważenia w następujących sytuacjach:

- Odwrócona pozycja serca,
- Powiększenie ujścia aorty,
- Znaczne powiększenie prawego przedsionka,
- Skolioza / kifoza,
- Nietypowa geometria lewego przedsionka,
- Wady wrodzone;
- Wady naczyniowe,
- Brak możliwości dostępu do prawego przedsionka przez żyłę główną dolną.

Docelowy użytkownik

Urządzenie powinno być używane przez lekarzy wykwalifikowanych w zakresie procedur przezprzegrodowych we w pełni wyposażonej pracowni elektrofizjologicznej.

Korzyści kliniczne

Zamierzonym zastosowaniem klinicznym igły przezprzegrodowej BRK™ jest punkcja przegrody międzyprzedsionkowej podczas zabiegu cewnikowania przezprzegrodowego, która ma na celu uzyskanie dostępu do lewej części serca, tak aby umożliwić zgodne z zamierzonym zastosowaniem klinicznym użycie urządzeń wymagających dostępu endokardialnego do lewej strony serca, takich jak cewnik ablacyjny. Decyduje o tym skuteczność punkcji przegrody międzyprzedsionkowej.

Przeciwwskazania

- Wcześniejsze leczenie łatą w przegrodzie międzyprzedsionkowej lub protetyczne urządzenie do zamykania wady w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
- Jakiekolwiek wcześniejsze powikłania zakrzepowo-zatorowe.
- Rozpoznany lub potwierdzony śluzak lewego przedsionka.
- Zawał mięśnia sercowego lub podejrzenie zawału serca w okresie dwóch tygodni poprzedzających zabieg.
- Niestabilna dusznica bolesna.
- Niedawno przebyty epizod naczyniowo-mózgowy (CVA).
- Pacjenci nietolerujący leczenia przeciwzakrzepowego.
- Pacjenci z aktywną infekcją.

Ostrzeżenia

- Nie należy w żaden sposób modyfikować tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie należy używać go ponownie ani poddawać dekontaminacji. Przestrzegać daty ważności („Use by") podanej na opakowaniu. Wszelkie próby ponownej sterylizacji lub ponownego używania tego systemu mogą negatywnie wpłynąć na jego integralność. Niekorzystne skutki użycia komponentów niejałowych to m.in.:
  - Miejscowa i ogólnoustrojowa infekcja lub reakcja
  - Uszkodzenie mechaniczne
  - Nieprecyzyjne działanie
- Materiały wskazane poniżej dla każdego produktu mogą powodować reakcje alergiczne lub nadwrażliwości. U osób na nie uczulonych może wystąpić reakcja alergiczna na ten produkt. Przed zastosowaniem wyrobu u pacjenta należy udzielić mu porady na temat materiałów wchodzących w skład wyrobu i omówić szczegółowo przebyte alergie na następujące materiały:
  - Stal nierdzewna
  - Klej epoksydowy
  - Niklowany i chromowany mosiądz
  - Smar silikonowy do próżni (Dupont)
  - Master Bond
- Niewłaściwe użytkowanie tego urządzenia może spowodować poważne powikłania.
- Procedury cewnikowania serca pociągają za sobą ryzyko narażenia pacjentów i personelu laboratorium na działanie znacznej ilości promieniowania rentgenowskiego, co może prowadzić do ostrych urazów radiacyjnych lub zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia skutków somatycznych i genetycznych spowodowanych natężeniem wiązki promieniowania rentgenowskiego i czasem trwania obrazowania fluoroskopowego. Należy dokładnie rozważyć zastosowanie tego urządzenia u kobiet w ciąży.

Środki ostrożności

- Prawo federalne (USA) dopuszcza sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie.

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami.
- Przed użyciem sprawdzić opakowanie. Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Wszystkie elementy systemu należy przed użyciem sprawdzić.
- Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
- Procedurę należy stosować wyłącznie u pacjentów stabilnych hemodynamicznie. W niektórych sytuacjach użycie tego urządzenia może wymagać szczególnego rozważenia. Może to obejmować między innymi następujące sytuacje:
  - Odwrócona pozycja serca,
  - Powiększenie ujścia aorty,
  - Znaczne powiększenie prawego przedsionka,
  - Skolioza / kifoza,
  - Nietypowa geometria lewego przedsionka,
  - Wady wrodzone,
  - Wady naczyniowe,
  - Brak możliwości dostępu do prawego przedsionka przez żyłę główną dolną.
- Urządzenie powinno być używane przez lekarzy wykwalifikowanych w zakresie procedur przezprzegrodowych we w pełni wyposażonej pracowni elektrofizjologicznej (EP).
- Cewnik należy wprowadzać pod kontrolą fluoroskopową, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, perforacji lub tamponady serca. Można również rozważyć zastosowanie zgodnych systemów nawigacji i wizualizacji w czasie rzeczywistym.
- Podczas wprowadzania należy sprawdzić, czy w trakcie przechodzenia końcówki igły przez zakrzywioną część zestawu koszulka/rozszerzacz nie występuje nadmierny opór. W przypadku wystąpienia oporu podczas wprowadzania igły, należy wycofać igłę i sprawdzić jej elementy.
- Podczas wprowadzania należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do nadmiernego wygięcia urządzenia. Może to blokować przesuwanie igły i doprowadzić do niezamierzonego przekłucia igłą zestawu rozszerzacz / koszulka.
- Podczas wkładania zawsze korzystać z mandrynu, aby ułatwić przechodzenie igły przez zestaw rozszerzacz / koszulka. Niekorzystanie z mandrynu może blokować przesuwanie igły i doprowadzić do niezamierzonego przekłucia igłą zestawu rozszerzacz / koszulka lub rozdwojenia materiału wewnętrznej powierzchni rozszerzacza.
- Jeśli nastąpi wejście do osierdzia lub aorty, nie przesuwać rozszerzacza po igle. Jeśli igła przebiła się do osierdzia lub aorty, musi zostać wyciągnięta. Uważnie monitorować funkcje życiowe.
- Podczas wyciągania przedmiotów z zaworu hemostatycznego koszulki istnieje ryzyko infiltracji powietrza. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wnikaniu powietrza: wyciągać przedmioty powoli, aby nie dopuścić do narastania próżni w koszulce i fluoroskopowo monitorować obecność powietrza w koszulce w trakcie późniejszego wkładania urządzenia.
- Po użyciu urządzenie, jego akcesoria i opakowanie powinny zostać odpowiednio sklasyfikowane pod kątem utylizacji, np.: odpady stwarzające zagrożenie biologiczne, odpady ostre, odpady inne niż niebezpieczne itp., i zutylizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce oraz właściwymi przepisami prawa.
- Jeden lub więcej składników tego wyrobu może zawierać następującą substancję określoną jako CMR 1B w stężeniu powyżej 0,1% wagowo: Kobalt: nr CAS (Chemical Abstracts Service) 7440-48-4; nr WE 231-158-0. Obecne dowody naukowe potwierdzają, że wyroby medyczne wyprodukowane ze stopów kobaltu i stopów stali nierdzewnej zawierających kobalt nie powodują zwiększonego ryzyka zachorowania na raka ani niekorzystnych skutków reprodukcyjnych.

  Jeden lub więcej składników tego wyrobu może zawierać następującą substancję określoną jako CMR 1A w stężeniu powyżej 0,1% wagowo: Ołów: nr CAS (Chemical Abstracts Service) 7439-92-1; nr WE 231-100-4. Obecne dowody naukowe potwierdzają, że wyroby medyczne wyprodukowane z ołowiu nie powodują zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory ani niekorzystnych skutków reprodukcyjnych.

Potencjalne zdarzenia niepożądane

Kategoria zdarzenia niepożądanego	**Kategoria podrzędna zdarzenia niepożądanego**
Krwawienie	Krwotok/krwawienie
	Krwiak
Uszkodzenie mózgu	Bezobjawowe zatory mózgowe
	Udar naczyniowy mózgu
	Przemijający napad niedokrwienny (TIA)
Zator	Zator powietrzny
	Zator wywołany przez ciało obce
	Zator płucny
	Powikłania zakrzepowo-zatorowe
	Zakrzepica/zakrzep
Perforacja serca	Tamponada serca
	Wysięk do worka osierdziowego
Uraz sercowo-naczyniowy	Uszkodzenie zastawki
	Przekłucie ujścia aorty
	Perforacja przedsionka
Zakłócenia układu przewodzącego	Blok węzła zatokowego, węzła przedsionkowo-komorowego lub układu His-Purkinje
	Arytmie serca
Odpowiedź immunologiczna	Wstrząs anafilaktyczny
Zakażenie	Zapalenie osierdzia
	Zapalenie wsierdzia
	Zapalenie płuc
	Posocznica
Ból/dyskomfort	Ból w pachwinie lub klatce piersiowej (ogólny ból w klatce piersiowej niezwiązany z MI)
Uszkodzenie naczyń obwodowych	Rozwarstwienie
	Rana szarpana
	Powstanie przetoki tętniczo-żylnej
	Powstanie tętniaka rzekomego
Hipotensja	Nie dotyczy
Powierzchniowe uszkodzenie tkanek	Nie dotyczy

Wskazówki

Przygotowanie i montaż urządzenia

1. Wyjąć zawartość z opakowania.

   UWAGA: Nie składać koszulki i rozszerzacza.

2. Przepłukać rozszerzacz i koszulkę heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
3. Zamknąć kurek odcinający koszulki.
4. Wyjąć mandryn z igły i przepłukać igłę heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
5. Włożyć mandryn do igły i zablokować ją na gnieździe.
6. Całkowicie wprowadzić rozszerzacz do koszulki przezprzegrodowej.

Wsunąć zestaw koszulka/rozszerzacz do żyły głównej górnej

1. Uzyskać dostęp żylny do żyły udowej (preferowana prawa udowa).

   OPC: w celu uzyskania i utrzymania dostępu żylnego na potrzeby wymiany urządzeń oraz hemostazy można użyć koszulki o większej długości standardowej (≥ 2,5 rozmiaru w skali French większej niż koszulka przezprzegrodowa).

2. Włożyć prowadnik 0,032 cala, 150–180 cm z końcówką typu „J" 3 mm do żyły głównej górnej.

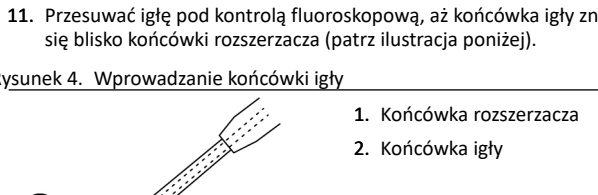
   UWAGA: 0,032 cala oznacza maksymalną średnicę zewnętrzną prowadnika, jaki może być użyty z rozszerzaczem.

3. Wprowadzić koszulkę/rozszerzacz do żyły po prowadniku i przesuwać zespół, aż końcówka koszulki znajdzie się w żyle głównej górnej. Ustawić końcówkę rozszerzacza w pozycji środkowej.

Ustawianie zespołu igły przezprzegrodowej i mandrynu wewnątrz zespołu koszulka / rozszerzacz

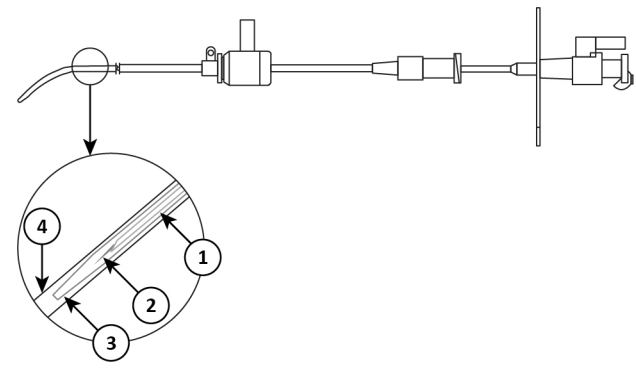
1. Wyjąć prowadnik z rozszerzacza.
2. Zaaspirować do końca, a następnie przepłukać rozszerzacz roztworem soli fizjologicznej.
3. Wyciągnąć rozszerzacz na około 5 cm (patrz ilustracja poniżej), aby ułatwić przechodzenie krzywizny igły przez sztywne gniazda rozszerzacza i koszulki.

Rysunek 1. Wyciąganie rozszerzacza



4. Zablokować mandryn w gnieździe.
5. Wprowadzić igłę/mandryn do rozszerzacza. Przesuwać igłę / mandryn pod kontrolą fluoroskopową, aż znajdzie się około 2 cm od końcówki rozszerzacza wewnątrz koszulki (patrz ilustracja poniżej).

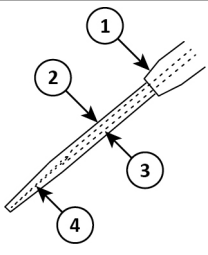
Rysunek 2. Wprowadzanie igły/mandrynu do rozszerzacza



1. Igła
2. Mandryn
3. Końcówka rozszerzacza
4. Koszulka

6. Aby ponownie połączyć koszulkę i rozszerzacz, jednocześnie wsunąć rozszerzacz i igłę / mandryn do koszulki pod kontrolą fluoroskopową. Upewnić się, że położenie igły w rozszerzaczu nie zmienia się, ponieważ oba elementy są przesuwane razem. Utrzymywać końcówkę koszulki w żyle głównej górnej.
7. Pod kontrolą fluoroskopową wprowadzać igłę/mandryn do momentu, aż mandryn znajdzie się blisko końcówki rozszerzacza (patrz ilustracja poniżej).

Rysunek 3. Wprowadzanie igły/mandrynu



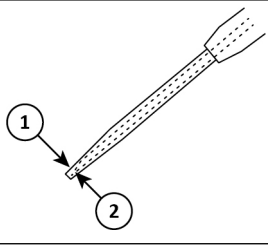
1. Końcówka koszulki
2. Rozszerzacz
3. Igła
4. Mandryn

8. Wyjąć mandryn i nie wyrzucać go.
9. Zaaspirować igłę do momentu zaobserwowania pojawienia się krwi. Wyrzucić strzykawkę.

   UWAGA: Użycie strzykawki z końcówką ślizgową (innej niż Luer-Lok‡) może uniemożliwić aspirację powietrza.

10. Przepłukać igłę heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej. Zamknąć kurek odcinający.
11. Przesuwać igłę pod kontrolą fluoroskopową, aż końcówka igły znajdzie się blisko końcówki rozszerzacza (patrz ilustracja poniżej).

Rysunek 4. Wprowadzanie końcówki igły



1. Końcówka rozszerzacza
2. Końcówka igły

OPC: Podłączyć trójdrożny kurek odcinający do gniazda igły.

OPC: Podłączyć do kurka odcinającego strzykawkę z kontrastem nieprzepuszczającym promieniowania. Zaaspirować igłę. Następnie wprowadzić igłę z kontrastem pod kontrolą fluoroskopową.

OPC: Podłączyć do kurka odcinającego linię monitorowania ciśnienia.

OPC: Użyć standardowego 3-portowego kolektora, aby podłączyć linie kontrastu, ciśnienia i roztworu soli fizjologicznej.

Uchwycenie dołu owalnego

1. Zwizualizować i zidentyfikować charakterystyczne punkty anatomiczne.
2. Ustawić fluoroskop pod kątem równolegle do płaszczyzny zastawki mitralnej i prostopadle do płaszczyzny przegrody. Zwykle będzie to rzut z lewego przedniego skosu (LAO), od około 30 do 40 stopni.

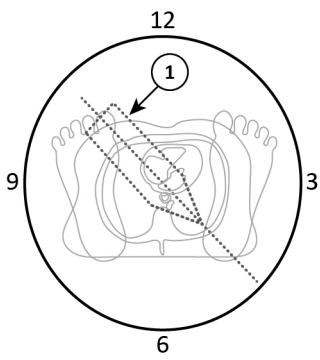
   OPC: Podczas procedur elektrofizjologicznych przydatnym charakterystycznym punktem anatomii może być położenie cewnika zatoki wieńcowej i pęczka Hisa. W odpowiednim rzucie LAO cewnik zatoki wieńcowej jest widoczny z profilu. W odpowiednim rzucie z prawego przedniego skosu (RAO) cewnik pęczka Hisa jest widoczny z profilu. Dół owalny znajduje się na poziomie cewnika pęczka Hisa lub trochę poniżej oraz powyżej i za ujściem zatoki wieńcowej.

   OPC: Umieszczenie przewodu elastycznego cewnika monitorującego angiograficzno / hemodynamicznego w niewieńcowym wierzchołku zastawki aortalnej może służyć jako przydatny charakterystyczny punkt anatomii.

   OPC: Obserwować krzywą ciśnienia rejestrowaną przez igłę przezprzegrodową BRK™.

3. Wyregulować kołnierz wskaźnika tak, aby igła leżała prostopadle do dołu owalnego (zazwyczaj między godziną 3:00 a 5:00, patrząc od stóp pacjenta). (Patrz ilustracja poniżej.)

Rysunek 5. Kołnierz wskaźnika igły

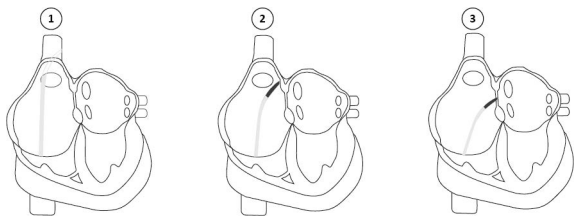


1. Kołnierz wskaźnika igły

4. Przy użyciu fluoroskopii sprawdzić, czy końcówka igły znajduje się wewnątrz rozszerzacza.
5. Po sprawdzeniu, czy końcówka igły znajduje się wewnątrz rozszerzacza, powoli wyciągnąć cały zespół koszulka / rozszerzacz / igła. Uważać, aby części zespołu nie poruszyły się względem siebie. Podczas wyciągania zespołu niezbędne jest utrzymanie poprzedniego ustawienia kołnierza wskaźnika.
6. W rzucie LAO (prostopadłym do przegrody międzyprzedsionkowej) obserwować, czy w trakcie wysuwania końcówka rozszerzacza nie wykona gwałtownego ruchu do środka (lub w prawo), który sygnalizuje uchwycenie dołu owalnego. (Patrz ilustracja poniżej.)

   UWAGA: jeśli dół owalny jest drożny, końcówka rozszerzacza z łatwością wsuwa się do lewego przedsionka.

Rysunek 6. Uchwycenie dołu owalnego



1. Położenie początkowe w żyle głównej górnej
2. Początkowy ruch do środka w rzucie prawym przednim
3. Gwałtowny ruch do środka w dole owalnym

UWAGA: Jeśli ciśnienie jest monitorowane przez igłę, pomiar jest w tym momencie nieprecyzyjny, ponieważ końcówka znajduje się na dole owalnym.

Punkcja dołu owalnego przy użyciu igły przezprzegrodowej BRK™

1. Przed przesunięciem igły potwierdzić prawidłowe położenie zespołu koszulka/rozszerzacz/igła w dole owalnym.
2. Po potwierdzeniu, że położenie jest prawidłowe, całkowicie rozciągnąć igłę w zespole koszulka / rozszerzacz i przesunąć igłę przez przegrodę międzyprzedsionkową.

   OPC: Jeśli ciśnienie jest monitorowane, przejście do lewej komory jest potwierdzone przez krzywą ciśnienia lewej komory.

   OPC: Dostęp do lewej komory można potwierdzić fluoroskopią z wstrzyknięciem kontrastu.

3. Jeśli przesuwanie igły napotyka opór, wyciągnąć igłę i ponownie ocenić charakterystyczne punkty anatomii.

   PRZESTROGA: Jeśli nastąpi wejście do osierdzia lub aorty, nie przesuwać rozszerzacza po igle. Jeśli igła przebiła się do osierdzia lub aorty, musi zostać wyciągnięta. Uważnie monitorować funkcje życiowe.

Wsuwanie zespołu koszulka / rozszerzacz do lewego przedsionka

Utrzymując igłę w stałym położeniu w lewym przedsionku, przesunąć cały zestaw koszulka/rozszerzacz po igle do jamy lewego przedsionka.

Wsuwanie koszulki po unieruchomionym rozszerzaczu i igle do lewego przedsionka

1. Utrzymywać położenie igły i rozszerzacza w trakcie przechodzenia przez przegrodę.
2. Utrzymując rozszerzacz w stałym położeniu, przesunąć całą koszulkę po rozszerzaczu do jamy lewego przedsionka.

Wyciąganie igły przezprzegrodowej BRK™ i rozszerzacza

PRZESTROGA: Podczas wyciągania przedmiotów z zaworu hemostatycznego koszulki istnieje ryzyko infiltracji powietrza. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wnikaniu powietrza: wyciągać przedmioty powoli, aby nie dopuścić do narastania próżni w koszulce i fluoroskopowo monitorować obecność powietrza w koszulce w trakcie późniejszego wkładania urządzenia.

1. Zakręcić kurek odcinający igły i odłączyć wszystko od gniazda igły.
2. Wyciągnąć igłę przezprzegrodową BRK™ z rozszerzacza. Igła może zostać oczyszczona i odłożona na bok, aby mogła zostać ponownie wykorzystana w tym zabiegu. W innym wypadku wyrzucić igłę w sposób odpowiedni dla zanieczyszczonych ostrych przedmiotów.
3. Natychmiast podłączyć strzykawkę do rozszerzacza i aspirować. Kontynuować aspirowanie krwi, utrzymując położenie koszulki i wyciągając rozszerzacz. Krew powinna być tętnicza.
4. Po wyciągnięciu rozszerzacza aspirować krew przez boczne ramię koszulki. Ostrożnie przepłukać boczne ramię koszulki roztworem soli fizjologicznej, aby zapobiec powstaniu pęcherzyków powietrza.
5. Koszulka została umieszczona we właściwym miejscu w lewym przedsionku.

Opakowanie i okres trwałości

Igła przezprzegrodowa BRK™ jest dostarczana w formie sterylnej. Igła zapakowana jest wraz z dołączonym mandrynem. Igła i mandryn znajdują się w opakowaniu podstawowym. Opakowanie podstawowe znajduje się w worku z materiałów Mylar‡ i Tyvek‡, zgrzanym na gorąco. Worek i niniejsza instrukcja są następnie umieszczone w pudełku, zapieczętowanym z obu stron. Worek oraz pudełko zaopatrzone są w etykietę z informacjami o produkcie wraz z datą przydatności. Produkty są oznaczone etykietą z terminem przydatności wynoszącym trzy lata.

Streszczenie danych klinicznych

W przypadku krajów Unii Europejskiej: Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej tych wyrobów zostanie opublikowane na stronie https://ec.europa.eu/tools/eudamed przez jednostki notyfikowane zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745 w przewidzianych na to terminach. Należy wyszukać urządzenie przy użyciu identyfikatora UDI-DI podanego na jego opakowaniu zewnętrznym. Identyfikator UDI-DI to 14-cyfrowy numer znajdujący się między dwoma pierwszymi nawiasami. Więcej informacji o tym, jak znaleźć i użyć identyfikatora UDI-DI, można uzyskać z dokumentu Frequently Asked Questions (Często zadawane pytania) dostępnego na stronie medical.abbott/manuals.

Zgłaszanie wypadków

Jeśli w trakcie użytkowania tego urządzenia wystąpi zdarzenie, które można uznać za poważne, należy zgłosić je producentowi. W przypadku klientów z Unii Europejskiej poważne zdarzenia należy zgłosić właściwemu organowi krajowemu oraz producentowi.

Ograniczona gwarancja

Firma Abbott Medical gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie dotyczy okresu po upływie daty ważności („Expiration") podanej na jakichkolwiek etykietach dołączonych do produktu. Uprawnione zastosowania i zatwierdzone metody użytkowania każdego z produktów firmy określono w odpowiedniej „Instrukcji użycia" dołączonej do każdego produktu. Firma Abbott Medical nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem jej produktów w sposób, który nie jest uprawniony lub nie został zatwierdzony. Odpowiedzialność firmy Abbott Medical wynikająca z niniejszej gwarancji ogranicza się do wymiany jej produktów. Niniejsza gwarancja wyklucza i zastępuje wszelkie inne gwarancje domniemane lub wyrażone wprost, w tym domniemaną gwarancję pokupności lub przydatności do określonego celu. Firma Abbott Medical nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody ani koszty, przypadkowe lub wtórne, wynikające pośrednio lub bezpośrednio z zastosowania niniejszego produktu, inne niż wyraźnie podane przez określony przepis prawny. Firma Abbott Medical nie przyjmuje ani nie upoważnia innych stron do przyjmowania w jej imieniu innej lub dodatkowej odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty w związku z niniejszym produktem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z kompletną polityką dotyczącą gwarancji firmy Abbott Medical dostępną w firmie Abbott Medical lub na odwrocie faktury wystawionej przez firmę Abbott Medical.

Symbole

Na wyrobie lub jego etykiecie można znaleźć następujące symbole lub symbole ustandaryzowane. Symbole ustandaryzowane można znaleźć w uniwersalnym słowniczku symboli na stronie medical.abbott/manuals.

Symbol	Definicja
Series	Seria
Contents	Spis treści
Transseptal Needle	Igła przezprzegrodowa
	System pojedynczej bariery sterylnej
	Długość
℞ ONLY	PRZESTROGA: Prawo federalne (USA) dopuszcza sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie.
CE 2797	Conformité Européenne (zgodność europejska). Oznaczono zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej 2017/745. Firma Abbott Medical niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami powyższej dyrektywy.
	Importer
UK CA 0086	Oceniono zgodność z przepisami w Wielkiej Brytanii
UKRP	Podmiot odpowiedzialny w Wielkiej Brytanii
UA.TR.101	Ukraiński znak zgodności z przepisami technicznymi, gdzie 101 oznacza jednostkę oceniającą.
MD	Wyrób medyczny
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
medical.abbott/manuals	Przestrzegać instrukcji użycia zamieszczonej na tej stronie internetowej
(7440-48-4) (7439-92-1)	Zawiera substancje stwarzające zagrożenie. (Kobalt, nr CAS 7440-48-4) (Ołów nr CAS 7439-92-1)

PT: Português

BRK™ Agulha Transeptal

Instruções de utilização

Descrição

A Agulha Transeptal BRK™ consiste numa agulha luminal em aço inoxidável e um estilete sólido em aço inoxidável. A secção distal da agulha é curva para facilitar o posicionamento dentro do coração quando utilizada com o conjunto de bainha transeptal da Abbott Medical. Dentro desta secção curva, existe uma quebra abrupta no diâmetro exterior da agulha para acoplação com o diâmetro interno do dilatador de um conjunto de bainha transeptal Abbott Medical. A ponta distal da agulha é oblíqua para facilitar o processo de punção. A extremidade proximal da agulha está configurada com uma aba indicadora (que indica a orientação da curva distal) e contém uma torneira de 2 vias que proporciona acesso ao lúmen da agulha para aspiração, injecção/perfusão de fluidos, colheita de amostras de sangue, monitorização da pressão e inserção do estilete e/ou fio-guia (fio-guia com diâmetro máximo de 0,014 pol. para uma agulha de calibre 18; fio-guia de diâmetro máximo de 0,012 pol. para uma agulha de calibre 19). O estilete é recto e isodiamétrico ao longo do seu comprimento. A extremidade proximal do estilete possui uma porção curva para se fixar ao conector da agulha proximal quando inserido no lúmen da agulha. O estilete foi concebido para facilitar o avanço da agulha dentro do dilatador. A agulha está disponível em vários comprimentos úteis e configurações de curva distal.

Utilização prevista

A Agulha Transeptal BRK™ destina-se a ser utilizada para puncionar o septo interauricular para obter acesso ao lado esquerdo do coração.

Indicações de utilização

A Agulha Transeptal BRK™ é utilizada para puncionar o septo interauricular durante um procedimento de cateterismo transeptal para obter acesso ao lado esquerdo do coração.

Grupo de pacientes alvo

A Agulha Transeptal BRK™ destina-se a ser utilizada em pacientes hemodinamicamente estáveis que requerem acesso por cateter ao lado esquerdo do coração. A utilização da Agulha Transeptal BRK™ pode exigir consideração especial em pacientes com as seguintes condições:

- Rotação cardíaca
- Dilatação da raiz aórtica
- Dilatação acentuada da aurícula direita
- Escoliose/cifose
- Geometria auricular esquerda anormal
- Malformações congénitas
- Malformações vasculares
- Incapacidade de acesso à aurícula direita através da veia cava inferior

Utilizador previsto

Este dispositivo deve ser utilizado apenas por médicos com formação específica em procedimentos transeptais, num laboratório electrofisiológico operacional e totalmente equipado.

Benefícios clínicos

O benefício clínico previsto da Agulha Transeptal BRK™ consiste na punção do septo interauricular durante um procedimento de cateterismo transeptal para obter acesso ao lado esquerdo do coração de modo a permitir o benefício clínico previsto de dispositivos que exigem acesso endocárdico ao lado esquerdo do coração, como um cateter de ablação. Isto é avaliado pela punção bem-sucedida do septo interauricular.

Contra-indicações

- Placa septal interauricular prévia ou dispositivo protético para encerramento de defeito do septo auricular.
- Qualquer acidente tromboembólico anterior.
- Mixoma auricular esquerdo confirmado ou suspeito.
- Enfarte do miocárdio confirmado ou suspeito nas duas últimas semanas.
- Angina instável.
- Acidente vascular cerebral (AVC) recente.
- Pacientes intolerantes a terapêutica anticoagulante.
- Pacientes com infecção activa.

Avisos

- Não altere este dispositivo de modo algum.
- Este dispositivo destina-se apenas a uma única utilização; não reprocesse nem reutilize o dispositivo. Tenha em atenção a data «Utilizar até» do produto indicada na embalagem. Qualquer tentativa de reesterilização e reutilização deste sistema pode comprometer a respectiva integridade. Os efeitos adversos da utilização de componentes não estéreis podem incluir, entre outros:
  - Infecção ou reacção local e sistémica
  - Danos mecânicos
  - Funcionalidade imprecisa
- Os materiais identificados abaixo por produto podem causar reacções alérgicas ou de hipersensibilidade. Os indivíduos alérgicos a estes materiais podem sofrer reacções alérgicas a este produto. Antes da utilização no paciente, o paciente deve ser aconselhado sobre os materiais contidos no dispositivo e é necessário avaliar todos os antecedentes alérgicos do paciente:
  - Aço inoxidável
  - Adesivo epóxi
  - Latão tratado com níquel-cromo
  - Graxa de silicone para alto vácuo (DuPont)
  - Master Bond
- O uso indevido deste dispositivo pode resultar em complicações graves.
- Tanto para os pacientes como para o pessoal de laboratório, os procedimentos de cateterismo cardíaco apresentam a possibilidade de exposição significativa a raios X, podendo resultar em lesões agudas por radiação, assim como um maior risco de efeitos somáticos e genéticos, devido à intensidade do feixe de raios X e à duração da imagiologia fluoroscópica. A utilização deste dispositivo em mulheres grávidas deve ser ponderada com cautela.

Precauções

- A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou por indicação de um médico.
- Leia as instruções antes da utilização.
- Inspeccione a embalagem antes da utilização. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Inspeccione todos os componentes antes de os utilizar.
- Guarde num local fresco, escuro e seco.

- Antes do procedimento, o paciente tem de apresentar-se hemodinamicamente estável. Algumas situações podem exigir considerações especiais ao utilizar este produto. Estas podem incluir, entre outras:
  - Rotação cardíaca
  - Dilatação da raiz aórtica
  - Dilatação acentuada da aurícula direita
  - Escoliose/cifose
  - Geometria auricular esquerda anormal
  - Malformações congénitas
  - Malformações vasculares
  - Incapacidade de acesso à aurícula direita através da veia cava inferior
- Este dispositivo deve ser utilizado apenas por médicos com formação específica em procedimentos transeptais, num laboratório electrofisiológico (EF) operacional e totalmente equipado.
- O avanço do cateter deverá ser realizado sob orientação fluoroscópica para minimizar o risco de danos cardíacos, perfuração ou tamponamento. Também podem ser considerados sistemas de navegação e visualização em tempo real compatíveis.
- Durante a introdução, verifique se existe resistência excessiva à medida que a ponta da agulha avança através da curvatura do conjunto bainha/dilatador. Se detectar qualquer resistência ao avanço da agulha, retraia a agulha e avalie os componentes.
- Durante a introdução, tenha cuidado para não criar curvaturas excessivas neste dispositivo. Isto poderá dificultar o avanço da agulha e pode resultar na punção acidental do conjunto dilatador/bainha pela agulha.
- Durante a introdução, utilize sempre o estilete para facilitar a passagem da agulha através do conjunto dilatador/bainha. A não utilização do estilete poderá inibir o avanço da agulha e provocar uma punção acidental do conjunto dilatador/bainha pela agulha ou a raspagem de material da superfície interna do dilatador.
- Se ocorrer entrada pericárdica ou aórtica, não avance o dilatador sobre a agulha. Se a agulha tiver penetrado no pericárdio ou na aorta, esta tem de ser retirada. Monitorize os sinais vitais atentamente.
- Existe um risco de infiltração de ar ao retirar objectos da válvula hemostática da bainha. Tome precauções para prevenir a infiltração de ar, retirando os objectos lentamente para impedir a acumulação de vácuo na bainha, e proceda à monitorização fluoroscópica da bainha durante a introdução do dispositivo relativamente à presença de ar.
- Após a utilização, este dispositivo, os respectivos acessórios e a embalagem deverão ser classificados adequadamente para a eliminação (p. ex., risco biológico, material afiado, resíduos não perigosos, etc.) e eliminados cuidadosamente em conformidade com os procedimentos da instituição e a legislação e regulamentos aplicáveis.
- Um ou mais componentes deste dispositivo podem conter a seguinte substância definida como CMR 1B com uma concentração acima de 0,1% (p/p): Cobalto: Chemical Abstracts Service (CAS) N.º 7440-48-4; CE N.º 231-158-0. As evidências científicas actuais indicam que os dispositivos médicos fabricados com ligas de cobalto e ligas de aço inoxidável que contêm cobalto não causam um aumento do risco de cancro nem efeitos adversos na reprodução.

  Um ou mais componentes deste dispositivo podem conter a seguinte substância definida como CMR 1A com uma concentração acima de 0,1% (p/p): Chumbo: Chemical Abstracts Service (CAS) N.º 7439-92-1; CE N.º 231-100-4. As evidências científicas actuais indicam que os dispositivos médicos fabricados com chumbo não causam um aumento do risco de cancro nem efeitos adversos na reprodução.

Possíveis acontecimentos adversos

Categoria de evento adverso	Subcategoria de evento adverso
Hemorragia	Hemorragia/Sangramento
	Hematoma
Lesão cerebral	Êmbolos cerebrais assintomáticos
	Acidente vascular cerebral (AVC)
	Acidente isquémico transitório (AIT)
Embolia	Embolia gasosa
	Embolia de corpo estranho
	Embolia pulmonar
	Tromboembolismo
	Trombose/trombo
Perfuração cardíaca	Tamponamento cardíaco
	Derrame pericárdico
Lesão cardiovascular	Lesão valvular
	Punção da raiz aórtica
	Perfuração auricular
Perturbação do sistema de condução	Bloqueio do nó SA, do nó AV ou do sistema de His-Purkinje
	Arritmias cardíacas
Reacção imunológica	Anafilaxia
Infecção	Pericardite
	Endocardite
	Pneumonia
	Sépsis
Dor/desconforto	Dor na virilha, peito (dor geral no peito não associada a EM)
Lesão vascular periférica	Dissecção
	Laceração
	Formação de fístula arteriovenosa
	Formação de pseudoaneurisma
Hipotensão	N/A
Lesão tecidular superficial	N/A

Instruções

Preparar e montar o equipamento

1. Retire o conteúdo da embalagem.

   NOTA: Não monte a bainha e o dilatador.

2. Irrigue o dilatador e a bainha com soro fisiológico heparinizado.
3. Feche a torneira da bainha.

4. Remova o estilete da agulha e irrigue a agulha com soro fisiológico heparinizado.
5. Introduza o estilete na agulha e bloqueie-o no conector.
6. Introduza o dilatador completamente na bainha transeptal.

Introduzir o conjunto bainha/dilatador na veia cava superior

1. Obtenha acesso venoso femoral (femoral direita preferencialmente).

   OPCIONAL: É possível utilizar uma bainha de comprimento padrão maior (≥2,5 tamanhos French acima da bainha transeptal) para obter e manter o acesso venoso para troca do dispositivo e hemostase.

2. Introduza um fio-guia de 0,032 pol., com 150 – 180 cm e uma ponta em «J» de 3 mm, na veia cava superior (VCS).

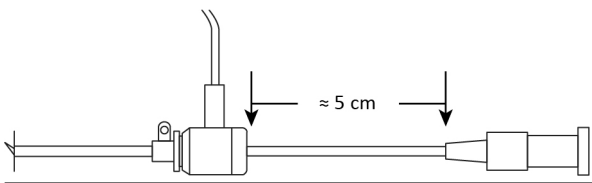
   NOTA: 0,032 pol. é o diâmetro máximo do fio-guia que pode ser utilizado com o dilatador.

3. Introduza o conjunto bainha/dilatador na veia sobre o fio-guia até que a ponta da bainha esteja na VCS. Oriente a ponta do dilatador medialmente.

Posicionar o conjunto agulha/estilete dentro do conjunto bainha/dilatador

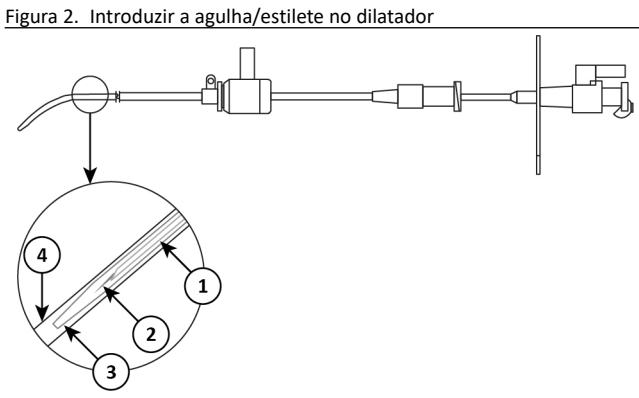
1. Retire o fio-guia do dilatador.
2. Aspire totalmente e, em seguida, irrigue o dilatador com soro fisiológico heparinizado.
3. Retire o dilatador aproximadamente 5 cm (consulte a figura abaixo) para facilitar a passagem da curvatura da agulha através dos conectores rígidos do dilatador e da bainha.

Figura 1. Retirar o dilatador



4. Bloqueie o estilete no conector.
5. Introduza a agulha/estilete no dilatador. Avance a agulha/estilete sob fluoroscopia até o conjunto estar aproximadamente a 2 cm da ponta do dilatador no interior da bainha (consulte a figura abaixo).

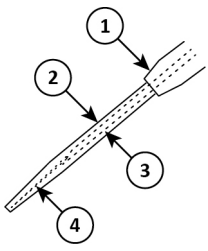
Figura 2. Introduzir a agulha/estilete no dilatador



1. Agulha
2. Estilete
3. Ponta do dilatador
4. Bainha

6. Para ligar a bainha e o dilatador novamente, avance o dilatador e a agulha/estilete em simultâneo para o interior da bainha sob fluoroscopia. Certifique-se de que a posição da agulha no interior do dilatador não muda à medida que os dois componentes são avançados em conjunto. Mantenha a posição da ponta da bainha na VCS.
7. Sob fluoroscopia, avance a agulha/estilete até o estilete estar posicionado quase proximamente em relação à ponta do dilatador (consulte a figura abaixo).

Figura 3. Avançar a agulha/estilete



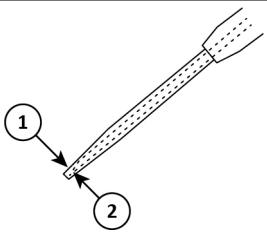
1. Ponta da bainha
2. Dilatador
3. Agulha
4. Estilete

8. Retire o estilete, sem o descartar.
9. Aspire a agulha até observar retorno de sangue. Elimine a seringa.

   NOTA: A utilização de uma seringa de ponta slip (não Luer-Lok‡) pode impedir a aspiração de ar.

10. Irrigue a agulha com soro fisiológico heparinizado. Feche a torneira.
11. Avance a agulha sob fluoroscopia até a ponta da agulha estar posicionada quase proximamente em relação à ponta do dilatador (consulte a figura abaixo).

Figura 4. Avançar a ponta da agulha



1. Ponta do dilatador
2. Ponta da agulha

OPCIONAL: Ligue uma torneira rotativa de 3 vias ao conector da agulha.

OPCIONAL: Fixe uma seringa com meio de contraste radiopaco à torneira. Aspire a agulha. Em seguida, sob orientação fluoroscópica, carregue a agulha com o meio de contraste.

OPCIONAL: Ligue uma linha de monitorização da pressão à torneira.

OPCIONAL: Utilize uma configuração padrão com colector de 3 portas para ligar as linhas de contraste, pressão e irrigação.

Abordar a fossa oval

1. Visualize e identifique as referências anatómicas.

2. Coloque a unidade de fluoroscopia num ângulo paralelo ao plano da válvula mitral e perpendicular ao plano do septo. Este será tipicamente um ângulo oblíquo anterior esquerdo (LAO), aproximadamente de 30 a 40 graus.

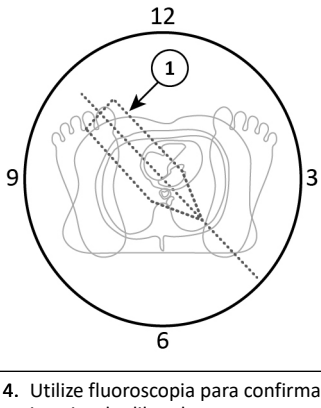
   OPCIONAL: Durante os procedimentos EF, as posições dos cateteres no seio coronário e feixe de His podem actuar como referências anatómicas úteis. Na visualização LAO apropriada, o cateter do seio coronário é apresentado de perfil. Na visualização oblíqua anterior direita (RAO) apropriada, o cateter do feixe de His é apresentado de perfil. A fossa oval encontra-se ao nível, ou ligeiramente abaixo, do cateter do feixe de His e superior e posterior ao óstio do seio coronário.

   OPCIONAL: A colocação de um cateter de monitorização hemodinâmica/angiográfica de ponta enrolada na cúspide não coronária da válvula aórtica pode actuar como uma referência anatómica útil.

   OPCIONAL: Observe a forma de onda de pressão que está a ser registada através da Agulha Transeptal BRK™.

3. Ajuste a aba indicadora de modo a que a agulha fique perpendicular à fossa oval (tipicamente entre os ponteiros das 3:00 e as 5:00 horas, visto a partir da extremidade dos pés do paciente). (Consulte a figura abaixo.)

Figura 5. Aba indicadora da agulha

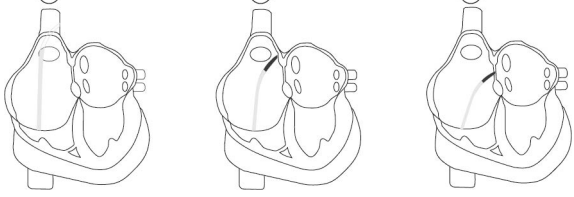


1. Aba indicadora da agulha

4. Utilize fluoroscopia para confirmar que a ponta da agulha está no interior do dilatador.
5. Depois de confirmar que a ponta da agulha se encontra no interior do dilatador, arraste todo o conjunto bainha/dilatador/agulha lentamente. Evite qualquer movimento das partes do conjunto relativamente umas às outras. Enquanto se arrasta o conjunto, é essencial manter a orientação prévia da aba indicadora.
6. Na visualização LAO (perpendicular ao septo interauricular), observe a ponta do dilatador durante o arrastamento, verificando se ocorreu qualquer movimento abrupto medial (ou para a direita), indicando que a ponta atingiu a fossa oval. (Consulte as figuras abaixo.)

   NOTA: Se a fossa oval estiver desobstruída, a ponta do dilatador desloca-se agora para a aurícula esquerda com facilidade.

Figura 6. Abordar a fossa oval



1. Posição inicial na VCS
2. Deslocação medial inicial na AD
3. Deslocação medial abrupta para a fossa oval

NOTA: Se a pressão estiver a ser monitorizada através da agulha, a pressão através da agulha será imprecisa, uma vez que a ponta se encontra a pressionar a fossa oval.

Perfurar a fossa oval com a Agulha Transeptal BRK™

1. Confirme a localização correcta do conjunto bainha/dilatador/agulha na fossa oval antes de introduzir a agulha.
2. Depois de confirmar a localização correcta, estenda a agulha para obter um encaixe completo dentro do conjunto bainha/dilatador e avance a agulha através do septo interauricular.

   OPCIONAL: Sob monitorização da pressão, a entrada na aurícula esquerda é confirmada quando o traçado da pressão mostra uma forma de onda de pressão auricular esquerda.

   OPCIONAL: O acesso à aurícula esquerda pode ser confirmado por fluoroscopia com injecções de contraste.

3. Se existir qualquer resistência ao avanço da agulha, recue a agulha e reavalie as referências anatómicas.

   CUIDADO: Se ocorrer entrada pericárdica ou aórtica, não avance o dilatador sobre a agulha. Se a agulha tiver penetrado no pericárdio ou na aorta, esta tem de ser retirada. Monitorize os sinais vitais atentamente.

Introduzir o conjunto bainha/dilatador na aurícula esquerda

Mantendo uma posição fixa da agulha na aurícula esquerda, introduza o conjunto bainha/dilatador totalmente sobre a agulha, em direcção à cavidade auricular esquerda.

Avançar a bainha sobre o dilatador fixado e a agulha na aurícula esquerda

1. Mantenha a posição da agulha e do dilatador ao longo do septo.
2. Enquanto mantém o dilatador numa posição fixa, introduza a bainha totalmente sobre o dilatador, em direcção à cavidade auricular esquerda.

Retirar a Agulha Transeptal BRK™ e o dilatador

CUIDADO: Existe um risco de infiltração de ar ao retirar objectos da válvula hemostática da bainha. Tome precauções para prevenir a infiltração de ar, retirando os objectos lentamente para impedir a acumulação de vácuo na bainha, e proceda à monitorização fluoroscópica da bainha durante a introdução do dispositivo relativamente à presença de ar.

1. Vire a torneira da agulha para a posição desligada e desligue todos os elementos ligados ao conector da agulha.
2. Retire a agulha transeptal BRK™ do dilatador. A agulha pode ser limpa e colocada de parte para nova utilização neste procedimento. Caso contrário, elimine a agulha conforme adequado para objectos afiados contaminados.

3. Fixe imediatamente uma seringa ao dilatador e aspire. Continue a aspirar o sangue enquanto mantém a posição da bainha e retira o dilatador. O sangue deve ser arterial.
4. Depois de retirar o dilatador, aspire o sangue através do braço lateral da bainha. Irrigue cuidadosamente o braço lateral da bainha com soro fisiológico heparinizado para evitar bolhas de ar.
5. A bainha encontra-se agora posicionada na aurícula esquerda.

Embalagem e prazo de validade

A Agulha Transeptal BRK™ é fornecida estéril. A agulha é embalada com um estilete inserido. A agulha e o estilete são colocados na embalagem principal. A embalagem principal é colocada dentro de uma bolsa Mylar‡ e Tyvek‡ selada a quente. A bolsa e estas instruções de utilização são em seguida colocadas numa caixa, selada em ambas extremidades. Tanto a bolsa como a caixa possuem um rótulo com as informações do produto, incluindo o prazo de validade. Os produtos são rotulados com um prazo de validade de três anos.

Resumo dos dados clínicos

Para países da União Europeia: Um resumo da segurança e desempenho clínico (SSCP) destes dispositivos será publicado em https://ec.europa.eu/tools/eudamed pelos organismos notificados, em conformidade com os requisitos do regulamento UE MDR 2017/745 e prazos associados. Procure o dispositivo utilizando o UDI-DI fornecido na embalagem exterior do dispositivo. O UDI-DI é o número de 14 dígitos entre os dois primeiros conjuntos de parênteses. Para obter mais informações sobre como encontrar e utilizar o UDI-DI, consulte o documento Frequently Asked Questions (Perguntas frequentes) em medical.abbott/manuals.

Comunicação de incidentes

Se, durante a utilização deste dispositivo, tiver razões para pensar que ocorreu um incidente grave, informe o fabricante. Os clientes na União Europeia deverão comunicar o incidente grave à respectiva autoridade nacional, assim como ao fabricante.

Garantia limitada

A Abbott Medical garante que os seus produtos estarão isentos de defeitos de material e de fabrico em condições normais de utilização. Esta garantia não excede o prazo de «validade» indicado na etiquetagem de qualquer produto. As utilizações autorizadas e os métodos aprovados de utilização de todos os nossos produtos estão definidos nas respectivas «Instruções de utilização» que acompanham cada produto. A Abbott Medical declina toda e qualquer responsabilidade pela utilização dos seus produtos de uma forma que não tenha sido autorizada ou aprovada. A responsabilidade da Abbott Medical ao abrigo desta garantia está limitada à substituição dos seus produtos. A garantia anterior exclui e substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, quaisquer garantias implícitas de comercialização ou de adequação a fins específicos. A Abbott Medical declina qualquer responsabilidade por perdas acidentais ou consequenciais, danos ou despesas resultantes directa ou indirectamente da utilização deste produto, além do expressamente determinado pela legislação específica. A Abbott Medical não assume, nem autoriza qualquer outra pessoa a assumir em seu nome, qualquer responsabilidade adicional por perdas, danos ou despesas relacionados com este produto. Para obter mais detalhes, consulte a política de garantia completa da Abbott Medical, disponibilizada pela Abbott Medical ou no verso de uma factura da Abbott Medical.

Símbolos

Os símbolos seguintes e os símbolos harmonizados podem ser apresentados no produto ou na respectiva etiqueta. Para obter informações acerca dos símbolos harmonizados, consulte o Universal Symbols Glossary (glossário universal de símbolos) em medical.abbott/manuals.

Símbolo	Definição
Series	Série
Contents	Conteúdo
Transseptal Needle	Agulha Transeptal
	Sistema de barreira estéril única
	Comprimento
Rx ONLY	CUIDADO: A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou por indicação de um médico.
CE 2797	Conformité Européenne (Conformidade Europeia). Afixado em conformidade com o Regulamento do Conselho Europeu 2017/745. Por este meio, a Abbott Medical declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras cláusulas relevantes deste regulamento.
	Importador
UK CA 0086	Avaliação da Conformidade no Reino Unido
UKRP	Responsável no Reino Unido
UA.TR.101	Marcação ucraniana de conformidade com os regulamentos técnicos, sendo 101 o organismo de avaliação.
MD	Dispositivo médico
UDI	Identificação exclusiva do dispositivo
medical.abbott/manuals	Seguir as instruções de utilização neste website
(7440-48-4) (7439-92-1)	Contém substâncias perigosas. (Cobalto CAS N.º 7440-48-4) (Chumbo: CAS Nº 7439-92-1)

RO: Română

BRK™ Ac transseptal

Instrucțiuni de utilizare

Descriere

Acul transseptal BRK™ este compus dintr-un ac luminal din oțel inoxidabil și un stilet solid din oțel inoxidabil. Secțiunea distală a acului este curbată pentru a facilita poziționarea în interiorul inimii atunci când este utilizat cu un set de teacă transseptală de la Abbott Medical. În cadrul acestei secțiuni curbate, are loc o scădere abruptă a diametrului exterior al acului pentru a se potrivi cu diametrul intern al dilatatorului de la un set de teacă transseptală de la Abbott Medical. Vârful distal al acului este bizotat pentru a facilita procedura de puncție. Capătul proximal al acului este configurat cu o flanșă indicatoare (care indică orientarea curbei distale) și este prevăzut cu un robinet de închidere cu două căi pentru a oferi acces la lumenul acului pentru aspirație, injectare/infuzie de lichid, prelevare de sânge, monitorizare a presiunii și inserție de stilet și/sau fir de ghidare (diametru maxim al firului de ghidare de 0,014 inci pentru un ac de calibru 18; diametru maxim al firului de ghidare de 0,012 inci pentru un ac de calibru 19). Stiletul este drept și izodiametric pe toată lungimea sa. Capătul proximal al stiletului este prevăzut cu o clemă curbată pentru a se bloca pe tija proximală a acului atunci când este introdusă în lumenul acului. Stiletul este conceput pentru a facilita avansarea acului în interiorul dilatatorului. Acul este disponibil în diverse lungimi utilizabile și configurații ale curbei distale.

Destinația utilizării

Acul transseptal BRK™ este destinat a fi utilizat pentru a perfora septul interatrial cu scopul de a avea acces la cordul stâng.

Indicații de utilizare

Acul transseptal BRK™ este utilizat pentru a perfora septul interatrial în timpul unei proceduri de cateterizare transseptală pentru a obține acces la cordul stâng.

Grupul țintă de pacienți

Acul transseptal BRK™ este destinat a fi utilizat la pacienții stabili din punct de vedere hemodinamic care necesită acces la cateterul cordului stâng. Utilizarea acului transseptal BRK™ poate necesita o atenție specială la pacienții cu următoarele afecțiuni:

- Dextrocardie
- Rădăcină aortică mărită
- Hipertrofie atrială dreaptă evidențiată
- Scolioză/cifoză
- Geometrie anormală a atriului stâng
- Malformații congenitale
- Malformații vasculare
- Incapacitatea accesării atriului drept prin vena cavă inferioară

Utilizatori vizați

Acest dispozitiv trebuie să fie utilizat numai de către acei medici care sunt special instruiți în proceduri transseptale, într-un laborator de electrofiziologie operațional, complet echipat.

Beneficii clinice

Beneficiul clinic preconizat al acului transseptal BRK™ este acela de a perfora septul interatrial în timpul unei proceduri de cateterizare transseptală pentru a obține acces la cordul stâng, cu scopul de a permite dispozitivelor care necesită acces la endocardul cordului stâng să își atingă beneficiul clinic preconizat, precum cateterul de ablație. Aceasta se determină prin puncția corectă a septului interatrial.

Contraindicații

- Dispozitiv anterior de închidere a defectului septal interatrial sau dispozitiv de închidere a defectului septal atrial protetic.
- Orice eveniment tromboembolic anterior.
- Mixom atrial stâng cunoscut sau suspectat.
- Infarct miocardic cunoscut sau suspectat în ultimele două săptămâni.
- Angină instabilă.
- Accident vascular cerebral (AVC) recent.
- Pacienți care nu tolerează terapia anticoagulantă.
- Pacienți cu o infecție activă.

Avertismente

- Nu modificați în niciun fel acest dispozitiv.
- Acest dispozitiv este destinat unei singure utilizări; nu îl reprocesați sau reutilizați. Rețineți „Data de expirare” a produsului de pe ambalaj. Orice încercare de resterilizare și reutilizare a acestui sistem poate compromite integritatea sa. Efectele adverse ale utilizării unor componente nesterile pot include, fără a se limita la:
  - Infecție sau reacție locală și sistemică
  - Deteriorări mecanice
  - Funcționare incorectă
- Materialele identificate mai jos pentru fiecare produs pot provoca reacții alergice sau de hipersensibilitate. Persoanele cu alergie la aceste materiale pot avea o reacție alergică la acest produs. Înainte de utilizarea produsului pe pacient, pacientul trebuie înștiințat cu privire la materialele conținute în dispozitiv și trebuie discutat în detaliu istoricul privind alergiile:
  - Oțel inoxidabil
  - Adeziv epoxidic
  - Alamă placată de nichel-crom
  - Vaselină siliconică de vid înalt (Dupont)
  - Master Bond
- Utilizarea necorespunzătoare a acestui dispozitiv poate duce la complicații grave.
- Atât pentru pacienți, cât și pentru personalul de laborator, procedurile de cateterizare cardiacă prezintă posibilitatea unei expuneri semnificative la raze-X, care poate duce la leziuni acute cauzate de radiații, precum și la un risc crescut de efecte somatice și genetice din cauza intensității fasciculului de raze-X și a duratei imagisticii fluoroscopice. Evaluați cu atenție utilizarea acestui dispozitiv la femeile însărcinate.

Precauții

- Legislația federală (S.U.A.) permite vânzarea acestui dispozitiv numai de către un medic sau pe baza prescripției unui medic.
- Citiți instrucțiunile înaintea utilizării.
- Înainte de utilizare, inspectați ambalajul. Nu utilizați dispozitivul dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
- Inspectați toate componentele înainte de utilizare.
- A se păstra într-un loc uscat și răcoros, la întuneric.

- Înainte de efectuarea procedurii, pacientul trebuie să fie stabil din punct de vedere hemodinamic. Anumite condiții impun o atenție specială atunci când este utilizat acest produs. Acestea includ, dar nu se limitează la:
  - Dextrocardie
  - Rădăcină aortică mărită
  - Hipertrofie atrială dreaptă evidențiată
  - Scolioză/cifoză
  - Geometrie anormală a atriului stâng
  - Malformații congenitale
  - Malformații vasculare
  - Incapacitatea accesării atriului drept prin vena cavă inferioară
- Acest dispozitiv trebuie să fie utilizat numai de către acei medici care sunt special instruiți în proceduri transseptale, într-un laborator de electrofiziologie (EF) operațional, complet echipat.
- Avansarea cateterului trebuie efectuată sub control fluoroscopic pentru a se minimiza riscul de lezare sau perforare a inimii ori de tamponadă cardiacă. Sistemele compatibile de navigare și vizualizare în timp real pot fi, de asemenea, luate în considerare.
- În timpul inserției, verificați dacă există o rezistență excesivă pe măsură ce vârful acului avansează prin curbura ansamblului teacă/dilatator. Dacă există o rezistență la avansarea acului, retrageți acul și evaluați componentele.
- În timpul inserției, aveți grijă să nu creați curburi excesive asupra acestui dispozitiv. Acest lucru poate împiedica avansarea acului și poate duce la perforarea accidentală a ansamblului dilatator/teacă.
- În timpul inserției, utilizați întotdeauna stiletul pentru a facilita trecerea acului prin ansamblul dilatator/teacă. Neutilizarea stiletului poate împiedica avansarea acului și poate duce la perforarea accidentală a ansamblului dilatator/teacă sau la îndepărtarea materialului de pe suprafața interioară a dilatatorului.
- Dacă se produce o intrare în pericard sau aortă, nu avansați dilatatorul peste ac. În cazul în care acul a penetrat pericardul sau aorta, acesta trebuie să fie retras. Monitorizați cu atenție semnele vitale.
- Există un risc de infiltrare a aerului atunci când se retrag obiecte din valva pentru hemostază a tecii. Luați măsuri de precauție pentru a preveni infiltrarea aerului prin retragerea lentă a obiectelor pentru a preveni acumularea de vid în teacă și monitorizați fluoroscopic teaca în timpul inserției ulterioare a dispozitivului pentru detectarea prezenței aerului.
- După utilizare, acest dispozitiv, accesoriile sale și ambalajul trebuie să fie clasificate în mod corespunzător în scopul eliminării, de exemplu, ca deșeuri cu risc biologic, deșeuri ascuțite, deșeuri nepericuloase etc., și eliminate cu grijă în conformitate cu procedurile instituției și cu legile și reglementările aplicabile.
- Una sau mai multe componente ale acestui dispozitiv pot conține următoarea substanță definită ca CMR 1B într-o concentrație mai mare de 0,1% din greutate: Cobalt: Chemical Abstracts Service (CAS) nr. 7440-48-4; EC nr. 231-158-0. Datele științifice actuale susțin faptul că dispozitivele medicale fabricate din aliaje de cobalt și oțel inoxidabil cu conținut de cobalt nu prezintă risc crescut de cancer sau efecte negative la nivelul aparatului reproducător.

  Una sau mai multe componente ale acestui dispozitiv pot conține următoarea substanță definită ca CMR 1A într-o concentrație mai mare de 0,1% din greutate: Plumb: Chemical Abstracts Service (CAS) nr. 7439-92-1; EC nr. 231-100-4. Dovezile științifice actuale susțin că dispozitivele medicale fabricate din plumb nu provoacă un risc crescut de cancer sau efecte adverse asupra reproducerii.

Reacții adverse posibile

Categoria de reacții adverse	Subcategoria de reacții adverse
Sângerare	Hemoragie/sângerare
	Hematom
Leziune cerebrală	Embolie cerebrală asimptomatică
	Atac cerebral/accident vascular cerebral
	Accident ischemic tranzitoriu (AIT)
Embolie	Embolie gazoasă
	Embolie provocată de un corp străin
	Embolie pulmonară
	Tromboembolie
	Tromboză/tromb
Perforație cardiacă	Tamponadă cardiacă
	Efuziune pericardică
Leziuni cardiovasculare	Leziuni valvulare
	Puncția rădăcinii aortice
	Perforație atrială
Tulburări ale sistemului de conducere	Nod SA, nod AV sau blocarea sistemului His-Purkinje
	Aritmii cardiace
Reacție imunologică	Anafilaxie
Infecție	Pericardită
	Endocardită
	Pneumonie
	Septicemie
Durere/disconfort	Durere, inghinală, toracică (durere toracică generală neasociată cu IM)
Leziuni vasculare periferice	Disecție
	Lacerație
	Formarea fistulei arteriovenoase
	Formarea pseudoanevrismului
Hipotensiune	Neaplicabil
Leziune tisulară superficială	Neaplicabil

Instrucțiuni

Pregătirea și asamblarea echipamentului

1. Scoateți conținutul din ambalaj.

   NOTĂ: Nu asamblați teaca și dilatatorul.

2. Clătiți dilatatorul și teaca cu soluție salină heparinizată.
3. Închideți robinetul de închidere al tecii.
4. Îndepărtați stiletul din ac și clătiți acul cu soluție salină heparinizată.

5. Introduceți stiletul în ac și blocați-l pe tijă.
6. Introduceți dilatatorul în întregime în teaca transseptală.

Înaintați ansamblul teacă/dilatator în vena cavă superioară

1. Obțineți acces venos femural (de preferință în partea dreaptă a femurului).

   OPȚIONAL: Se poate utiliza o teacă de lungime standard mai mare (cu ≥2,5 dimensiuni la scala French peste cea a tecii transseptale) pentru a obține și menține accesul venos pentru schimbul de dispozitive și hemostază.

2. Introduceți în vena cavă superioară (VCS) un fir de ghidare cu vârful în „J" de 0,032 inci., 150 - 180 cm, 3 mm.

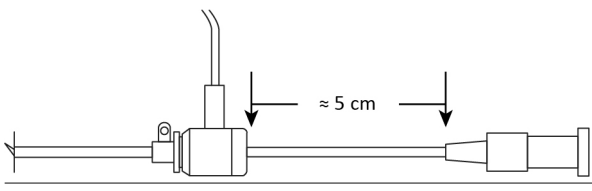
   NOTĂ: 0,032 inci este diametrul maxim al firului de ghidare ce poate fi utilizat cu dilatatorul.

3. Introduceți teaca/dilatatorul în venă peste firul de ghidare până când vârful tecii se află în VCS. Orientați vârful dilatatorului spre centru.

Poziționați ansamblul ac/stilet în interiorul ansamblului teacă/dilatator

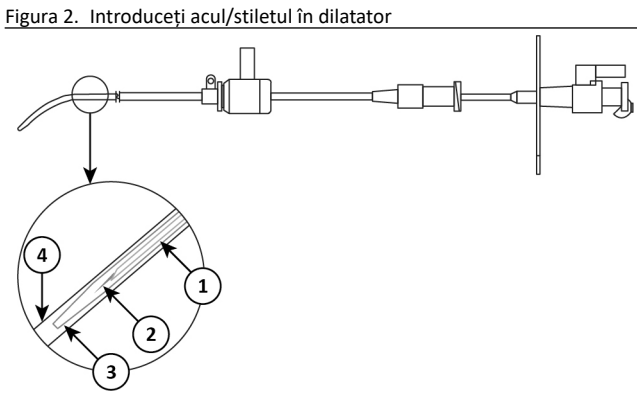
1. Scoateți firul de ghidare din dilatator.
2. Aspirați în întregime și apoi clătiți dilatatorul cu soluție salină heparinizată.
3. Retrageți dilatatorul aproximativ 5 cm (a se vedea figura de mai jos) pentru a facilita trecerea curbei acului prin tijele rigide ale dilatatorului și tecii.

Figura 1. Retrageți dilatatorul



4. Blocați stiletul pe tijă.
5. Introduceți acul/stiletul în dilatator. Avansați acul/stiletul sub supraveghere fluoroscopică până când se află la aproximativ 2 cm de vârful dilatatorului din interiorul tecii (a se vedea figura de mai jos).

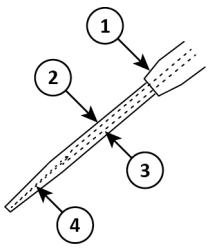
Figura 2. Introduceți acul/stiletul în dilatator



1. Ac
2. Stilet
3. Vârf dilatator
4. Teacă

6. Pentru a reconecta teaca și dilatatorul, avansați simultan dilatatorul și acul/stiletul în teacă sub supraveghere fluoroscopică. Asigurați-vă că poziția acului în interiorul dilatatorului nu se schimbă pe măsură ce ambele componente înaintează împreună. Mențineți poziția vârfului tecii în VCS.
7. Sub supraveghere fluoroscopică, avansați acul/stiletul până când stiletul este poziționat proximal față de vârful dilatatorului (a se vedea figura de mai jos).

Figura 3. Avansul acului/stiletului



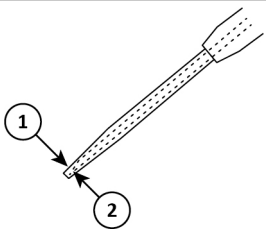
1. Vârful tecii
2. Dilatator
3. Ac
4. Stilet

8. Îndepărtați stiletul, dar nu-l aruncați.
9. Aspirați acul până când se observă că revine sângele. Aruncați seringa.

   NOTĂ: Utilizarea unei seringi cu vârf-curbat (non Luer-Lok‡) poate împiedica aspirarea aerului.

10. Clătiți acul cu soluție salină heparinizată. Închideți robinetul de închidere.
11. Avansați cu acul sub supraveghere fluoroscopică până când vârful acului se află chiar la proximitatea vârfului dilatatorului (a se vedea figura de mai jos).

Figura 4. Avansul vârfului acului



1. Vârf dilatator
2. Vârf ac

OPȚIONAL: Atașați un robinet rotativ cu 3 căi la tija acului.

OPȚIONAL: Atașați o seringă cu substanță de contrast radioopacă la robinetul de închidere. Aspirați acul. Apoi, încărcați acul cu substanța de contrast sub supraveghere fluoroscopică.

OPȚIONAL: Conectați un tub de monitorizare a presiunii la robinetul de închidere.

OPȚIONAL: Utilizați o configurație standard de colector cu 3 porturi pentru a conecta liniile de contrast, presiune și clătire.

Conectarea fosei ovale

1. Vizualizați și identificați reperele anatomice.

2. Setați unitatea de fluoroscopie la un unghi paralel cu planul valvei mitrale și ortogonal cu planul septului. Acesta va fi de regulă oblic, în partea anterioară stângă (LAO), la aproximativ 30-40 de grade.

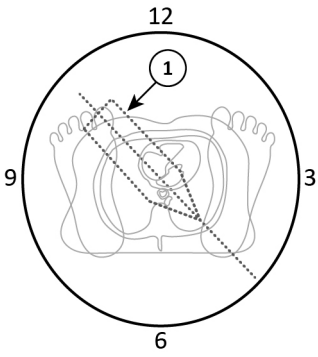
   OPȚIONAL: În timpul procedurilor EF, pozițiile cateterului sinusului coronarian și a fasciculului His pot servi ca repere anatomice importante. Pe imaginea corespunzătoare LAO, apare, în profil, cateterul sinusului coronarian. Pe imaginea oblică anterioară dreaptă (RAO) corespunzătoare, apare, în profil, cateterul fasciculului His. Fosa ovală se află la același nivel sau puțin mai jos de cateterul fasciculului His și este superioară și posterioară ostiei sinusului coronarian.

   OPȚIONAL: Plasarea unui cateter de monitorizare angiografică/ hemodinamică de tip pigtail în cuspida necoronară a valvei aortice, poate servi ca reper anatomic important.

   OPȚIONAL: Observați forma de undă a presiunii care se înregistrează prin intermediul acului transseptal BRK™.

3. Reglați flanșa indicatoare astfel încât acul să fie perpendicular pe fosa ovală (între orele 3:00 și 5:00, de regulă, după cum este văzut de la capătul piciorului pacientului). (A se vedea figura de mai jos.)

Figura 5. Flanșă indicatoare ac



1. Flanșă indicatoare ac

4. Utilizați tehnica fluoroscopică pentru a confirma că vârful acului se află în interiorul dilatatorului.
5. După ce ați confirmat că vârful acului se află în interiorul dilatatorului, trageți încet întregul ansamblu teacă/dilatator/ac. Împiedicați orice mișcare a pieselor de asamblare una față de cealaltă. Este esențial să se mențină orientarea anterioară a flanșei indicatoare în timpul tragerii ansamblului.
6. În imaginea LAO (ortogonală față de septul interatrial), observați vârful dilatatorului în timpul procedurii de glisare pentru a observa dacă există o deplasare bruscă spre median (sau spre dreapta), ceea ce indică faptul că vârful a intrat în contact cu fosa ovală. (A se vedea figurile de mai jos.)

   NOTĂ: Dacă fosa ovală este permeabilă, vârful dilatatorului se deplasează cu ușurință în atriul stâng.

Figura 6. Conectarea fosei ovale



1. Poziția de pornire în VCS
2. Deplasare mediană inițială în AD
3. Deplasare mediană bruscă pe fosa ovală

NOTĂ: Dacă presiunea este monitorizată prin intermediul acului, atunci aceasta va fi inexactă în acest punct, deoarece vârful este în contact cu fosa ovală.

Puncția fosei ovale cu ajutorul acului transseptal BRK™

1. Confirmați amplasarea corectă a ansamblului teacă/dilatator/ac pe fosa ovală înainte de a avansa acul.
2. După ce se confirmă locația corectă, extindeți acul până la intrarea completă în ansamblul teacă/dilatator și avansați acul peste septul interatrial.

   OPȚIONAL: În cadrul monitorizării presiunii, intrarea în atriul stâng este confirmată atunci când urmărirea presiunii arată o formă de undă a presiunii atriale stângi.

   OPȚIONAL: Accesul atrial stâng poate fi confirmat prin intermediul tehnicii fluoroscopice cu injecții de contrast.

3. Dacă există o rezistență la avansarea acului, retrageți acul și reevaluați reperele anatomice.

   ATENȚIE: Dacă se produce o intrare în pericard sau aortă, nu avansați dilatatorul peste ac. În cazul în care acul a penetrat pericardul sau aorta, acesta trebuie să fie retras. Monitorizați cu atenție semnele vitale.

Înaintarea ansamblului teacă/dilatator în atriul stâng

Menținând fixă poziția acului în atriul stâng, avansați ansamblul teacă/ dilatator complet peste ac, în cavitatea atrială stângă.

Înaintați teaca peste dilatatorul fix și acul în atriul stâng

1. Mențineți poziția acului și a dilatatorului peste sept.
2. În timp ce mențineți dilatatorul într-o poziție fixă, avansați teaca complet peste dilatator în cavitatea atrială stângă.

Retrageți acul și dilatatorul transseptal BRK™

ATENȚIE: Există un risc de infiltrare a aerului atunci când se retrag obiecte din valva pentru hemostază a tecii. Luați măsuri de precauție pentru a preveni infiltrarea aerului prin retragerea lentă a obiectelor pentru a preveni acumularea de vid în teacă și monitorizați fluoroscopic teaca în timpul inserției ulterioare a dispozitivului pentru detectarea prezenței aerului.

1. Rotiți robinetul de oprire a acului în poziția oprit și deconectați orice accesoriu de la tija acului.
2. Îndepărtați acul transseptal BRK™ din dilatator. Acul poate fi curățat și pus deoparte pentru a fi utilizat ulterior în această procedură. În caz contrar, aruncați acul în mod corespunzător pentru obiectele ascuțite contaminate.
3. Atașați imediat o seringă la dilatator și aspirați. Continuați să aspirați sângele în timp ce mențineți teaca în poziție și retrageți dilatatorul. Sângele trebuie să fie sânge arterial.
4. După ce dilatatorul este îndepărtat, aspirați sângele prin brațul lateral al tecii. Clătiți cu grijă brațul lateral al tecii cu soluție salină heparinizată pentru a evita bulele de aer.

5. Teaca este plasată acum în atriul stâng.

Ambalajul și perioada de valabilitate

Acul transseptal BRK™ este furnizat steril. Acul este ambalat cu un stilet inclus. Acul și stiletul sunt așezate în ambalajul primar. Ambalajul primar este așezat în interiorul unei pungi Mylar‡ și Tyvek‡, care este sigilată la cald. Punga și aceste instrucțiuni de utilizare sunt apoi introduse într-o cutie, care este sigilată la ambele capete. Atât punga, cât și cutia au o etichetă cu informații referitoare la produs, inclusiv data de expirare. Produsele sunt etichetate pentru o perioadă de valabilitate de trei ani.

Rezumatul datelor clinice

Pentru țările din Uniunea Europeană: Un rezumat al caracteristicilor de siguranță și performanță clinică (SSCP) pentru aceste dispozitive va fi publicat la adresa https://ec.europa.eu/tools/eudamed de către organismele notificate, în conformitate cu cerințele din EU MDR 2017/745 și cu termenele asociate. Căutați dispozitivul folosind marcajul UDI-DI indicat pe ambalajul exterior al dispozitivului. Marcajul UDI-DI este un număr format din 14 cifre situat între primele două seturi de paranteze. Pentru mai multe informații privind găsirea și utilizarea marcajului UDI-DI, consultați documentul Întrebări frecvente care se găsește la medical.abbott/manuals.

Raportarea incidentelor

Dacă, pe parcursul utilizării acestui dispozitiv, suspectați că a avut loc un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului. În cazul clienților din Uniunea Europeană, raportați incidentul grav autorităților dumneavoastră naționale, precum și producătorului.

Garanție limitată

Abbott Medical garantează faptul că produsele sale nu prezintă defecte de material și de manoperă în condițiile unei utilizări normale. Această garanție nu depășește data de „expirare” indicată pe eticheta produsului. Utilizările autorizate și metodele de utilizare aprobate ale fiecăruia dintre produsele noastre sunt prevăzute în „Instrucțiunile de utilizare” aferente care însoțesc fiecare produs. Abbott Medical își declină orice responsabilitate pentru utilizarea produselor sale în moduri care nu au fost autorizate sau aprobate. Responsabilitatea Abbott Medical în temeiul acestei garanții este limitată la înlocuirea produselor sale. Prezenta garanție exclude și înlocuiește orice alte garanții, explicite sau implicite, inclusiv, însă fără limitare la orice garanții implicite de vandabilitate sau de aplicabilitate cu un scop anume. Abbott Medical își declină responsabilitatea pentru orice pierderi, daune sau cheltuieli neprevăzute sau pe cale de consecință rezultate, direct sau indirect, din utilizarea acestui produs, altele decât cele prevăzute în mod explicit de legislația specifică. Abbott Medical nu își asumă și nu autorizează nicio terță parte să își asume în numele său orice alte responsabilități suplimentare pentru pierderi, daune sau cheltuieli în legătură cu acest produs. Pentru mai multe detalii, citiți textul complet al politicii Abbott Medical privind garanțiile, care este disponibilă la Abbott Medical sau pe spatele unei facturi Abbott Medical.

Simboluri

Simbolurile de mai jos și simbolurile armonizate pot fi găsite pe produs sau pe eticheta produsului. Pentru simbolurile armonizate, consultați Glosarul de simboluri universale la adresa medical.abbott/manuals.

Simbol	Definiție
Series	Seria
Contents	Conținut
Transseptal Needle	Ac transseptal
	Sistem unic de barieră sterilă
	Lungime
Rx ONLY	ATENȚIE: Legislația federală (S.U.A.) permite vânzarea acestui dispozitiv numai de către un medic sau pe baza prescripției unui medic.
CE 2797	Conformité Européenne (Conformitate europeană). Aplicat în conformitate cu Regulamentul Consiliului European 2017/745. Prin prezenta, Abbott Medical declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale acestui regulament.
	Importator
UK CA 0086	Conformitatea în Marea Britanie evaluată
UKRP	Persoană responsabilă în Marea Britanie
UA.TR.101	Marca ucraineană de conformitate cu reglementările tehnice, unde 101 este organismul de evaluare.
MD	Dispozitiv medical
UDI	Identificare unică a dispozitivelor
medical.abbott/manuals	Urmați instrucțiunile de utilizare de pe acest site web
(7440-48-4) (7439-92-1)	Conține substanțe periculoase. (Cobalt CAS nr. 7440-48-4) (Plumb CAS nr. 7439-92-1)

RU: Русский

BRK™ Транссептальная игла

Инструкция по эксплуатации

Описание

Транссептальная игла BRK™ состоит из просветной иглы и тонкого цельного зонда (стилета). Оба компонента изготовлены из нержавеющей стали. Дистальная часть иглы изогнута, чтобы облегчить ее размещение в камере сердца при использовании набора транссептальной оболочки Abbott Medical. В пределах изогнутой части иглы ее внешний диаметр резко уменьшается для обеспечения соответствия внутреннему диаметру расширителя набора транссептальной оболочки Abbott Medical. Дистальный конец иглы срезан на конус для облегчения пункции перегородки. Проксимальный конец иглы снабжен выступающим указателем (показывает направление изгиба дистальной части) и имеет двухходовый запорный кран для обеспечения доступа для просвета иглы с целью аспирации, инъекций/инфузий, забора крови и мониторинга давления, а также для введения стилета и/или проволочного направителя (максимальный диаметр проволочного направителя составляет 0,014 дюйма для иглы 18 калибра; максимальный диаметр проволочного направителя составляет 0,012 дюйма для иглы 19 калибра). Стилет прямой и имеет одинаковый диаметр по всей длине. Проксимальный конец стилета снабжен изогнутым зажимом, который фиксируется в проксимальной втулке иглы при введении стилета в просвет иглы. Стилет облегчает продвижение иглы внутри расширителя. Имеются иглы различной рабочей длины и различной конфигурации дистальной части.

Предусмотренное назначение

Транссептальная игла BRK™ предназначена для пункции межпредсердной перегородки с целью доступа в левую половину сердца.

Показания к применению

Транссептальная игла BRK™ предназначена для пункции межпредсердной перегородки во время транссептальной катетеризации с целью доступа в левую половину сердца.

Целевая группа пациентов

Транссептальная игла BRK™ предназначена для использования у пациентов со стабильной гемодинамикой с целью доступа в левую половину сердца для введения катетера. При использовании транссептальной иглы BRK™ следует уделить особое внимание пациентам со следующими состояниями:

- Поворот сердца;
- Расширенное устье аорты;
- Выраженное увеличение правого предсердия;
- Сколиоз/кифоз;
- Аномалии формы левого предсердия;
- Врожденные пороки развития;
- Пороки развития сосудов;
- Невозможность пройти в правое предсердие через нижнюю полую вену.

Предполагаемый пользователь

Это устройство предназначено для использования только врачами, специально обученными транссептальным процедурам, в полностью оборудованной электрофизиологической операционной лаборатории.

Клиническая польза

Предполагаемая клиническая польза транссептальной иглы BRK™ заключается в пункции межпредсердной перегородки во время транссептальной катетеризации с целью доступа в левую половину сердца для достижения предполагаемой клинической пользы устройств, требующих эндокардиального доступа в левую половину сердца, например абляционного катетера. Показателем достижения предполагаемой клинической пользы является успешное завершение процедуры пункции межпредсердной перегородки.

Противопоказания

- Пластика межпредсердной перегородки заплатой или закрытие дефекта межпредсердной перегородки искусственным протезом в анамнезе.
- Явления тромбоэмболии в анамнезе.
- Подтвержденная или предполагаемая миксома левого предсердия.
- Подтвержденный или предполагаемый инфаркт миокарда, перенесенный в течение двух последних недель.
- Нестабильная стенокардия.
- Недавнее нарушение кровообращения головного мозга (инсульт).
- Пациенты с непереносимостью антикоагулянтной терапии.
- Пациенты с активной инфекцией.

Предупреждения

- Внесение любых изменений в конструкцию устройства запрещено.
- Это устройство предназначено только для одноразового использования; не обрабатывайте и не используйте его повторно. Обратите внимание на дату «окончания срока годности» на упаковке изделия. Любая попытка повторной стерилизации и повторного использования этой системы может нарушить ее целостность. Возможные неблагоприятные явления, связанные с использованием нестерильных компонентов, включают (помимо прочего) следующие:
  - Местную и системную инфекцию или реакцию;
  - Механическое повреждение;
  - Неточную работу.
- Содержащиеся в изделии указанные ниже вещества могут вызывать аллергические реакции или реакции гиперчувствительности. У пациентов с аллергией на эти вещества может наблюдаться аллергическая реакция на это изделие. Прежде чем применять это изделие у пациента, необходимо подробно обсудить с пациентом его состав и тщательно изучить аллергологический анамнез:
  - Нержавеющая сталь;
  - Эпоксидный клей;
  - Латунь с хромоникелевым покрытием;
  - Силиконовая высоковакуумная смазка (Dupont);
  - Master Bond.
- Неправильное использование этого устройства может привести к серьезным осложнениям.

- Процедуры сердечной катетеризации представляют потенциальную опасность получения значительной дозы рентгеновского излучения, что может привести к острому радиационному поражению, а также повышению вероятности соматических и генетических последствий как для пациента, так и для сотрудников лаборатории вследствие интенсивности рентгеновского пучка и длительности рентгеноскопии. Тщательно оцените целесообразность применения этого устройства у беременных женщин.

Меры предосторожности

- Федеральным законодательством США разрешается продавать это устройство только врачам или по предписанию врачей.
- Перед использованием ознакомьтесь с указаниями.
- Перед использованием проверьте упаковку. Не используйте, если упаковка вскрыта или повреждена.
- Перед использованием осмотрите и проверьте все компоненты.
- Хранить в прохладном, темном, сухом месте.
- Перед началом процедуры следует стабилизировать гемодинамику пациента. При использовании этого устройства следует учесть наличие у пациента некоторых заболеваний. К ним относятся, помимо прочего, следующие состояния:
  - Поворот сердца;
  - Расширенное устье аорты;
  - Выраженное увеличение правого предсердия;
  - Сколиоз/кифоз;
  - Аномалии формы левого предсердия;
  - Врожденные пороки развития;
  - Пороки развития сосудов;
  - Невозможность пройти в правое предсердие через нижнюю полую вену.
- Это устройство предназначено для использования только врачами, специально обученными транссептальным процедурам, в полностью оборудованной электрофизиологической (ЭФ) операционной лаборатории.
- Продвижение катетера должно осуществляться под рентгеноскопическим контролем, чтобы минимизировать риск повреждения, перфорации или тампонады сердца. Также возможно использование совместимых систем навигации и визуализации в режиме реального времени.
- Во время введения проверьте, нет ли излишнего сопротивления, когда кончик иглы проходит по изгибам оболочки в сборе с расширителем. Если продвижению иглы препятствует сопротивление, отведите иглу и проверьте компоненты.
- В процессе введения не следует слишком сильно сгибать устройство. Это может помешать продвижению иглы и привести к случайному проколу иглой расширителя/оболочки в сборе.
- В процессе введения обязательно используйте стилет для облегчения прохождения иглы через собранный модуль расширителя/оболочки. Если не использовать стилет, продвижение иглы затрудняется, и это может привести к случайному проколу иглой собранного модуля расширителя/оболочки или к повреждению внутренней поверхности расширителя.
- Если игла прошла в полость перикарда или в аорту, не следует продвигать расширитель по игле. В случае пенетрации иглой перикарда или аорты, ее следует извлечь. Внимательно следите за основными показателями жизнедеятельности.
- Во время извлечения оборудования из гемостатического клапана оболочки существует риск проникновения воздуха. Во избежание этого извлекайте все оборудование медленно, чтобы в оболочке не образовался вакуум, а при последующем введении устройства контролируйте посредством рентгеноскопии отсутствие воздуха в оболочке.
- После использования данное устройство, дополнительные принадлежности к нему и его упаковку необходимо осторожно утилизировать в соответствии с принятыми в медицинском учреждении процедурами, а также действующими законами и нормативно-правовыми актами, предварительно надлежащим образом их отсортировав, например, биологически опасные отходы, острые отходы, безвредные отходы и т. д.
- В составе одного или нескольких компонентов данного устройства может содержаться нижеуказанное вещество, определенное как вещество типа CMR 1B, в концентрации выше 0,1 % массовой доли (масс./масс.): кобальт: № 7440-48-4 Chemical Abstracts Service (CAS); № 231-158-0 по EC. Современные научные доказательные данные подтверждают, что медицинские изделия, изготовленные из кобальтовых сплавов и сплавов из нержавеющей стали, содержащих кобальт, не вызывают повышенного риска возникновения рака или неблагоприятных для репродуктивности эффектов.

  В составе одного или нескольких компонентов данного устройства может содержаться нижеуказанное вещество, определенное как вещество типа CMR 1A, в концентрации выше 0,1 % массовой доли (масс./масс.): электрод: № 7439-92-1 Chemical Abstracts Service (CAS); № 231-100-4 по EC. Современные научные доказательные данные подтверждают, что медицинские изделия, изготовленные из свинца, не вызывают повышенного риска возникновения рака или нежелательного воздействия на репродуктивную систему.

Возможные нежелательные явления

Категория нежелательных явлений	**Подкатегория нежелательных явлений**
Кровотечение	Кровоизлияние/кровотечение
	Гематома
Черепно-мозговая травма	Бессимптомная эмболия головного мозга
	Инсульт/нарушение мозгового кровообращения
	Транзиторная ишемическая атака (ТИА)
Эмболия	Воздушная эмболия
	Эмболия инородным телом
	Легочная эмболия
	Тромбоэмболия
	Тромбоз/тромб
Перфорация сердца	Тампонада сердца
	Перикардиальный выпот
Сердечно-сосудистые травмы	Повреждение клапанов сердца
	Пункция корня аорты
	Перфорация предсердия
Расстройство со стороны проводящей системы	Блокада синусно-предсердного узла, атриовентрикулярного узла или системы Гиса-Пуркинье

Категория нежелательных явлений	Подкатегория нежелательных явлений
	Сердечные аритмии
Иммунологическая реакция	Анафилаксия
Инфекция	Перикардит
	Эндокардит
	Пневмония
	Сепсис
Боль/дискомфорт	Боль в паховой области или груди (боль в груди общего характера, не связанная с инфарктом миокарда)
Травма периферических сосудов	Рассечение
	Разрыв
	Формирование артериовенозной фистулы
	Формирование псевдоаневризмы
Гипотензия	Не применимо
Поверхностная травма тканей	Не применимо

Указания

Подготовка и сборка оборудования

1. Извлеките содержимое из упаковки.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Не выполняйте сборку оболочки и расширителя.

2. Промойте расширитель и оболочку гепаринизированным солевым раствором.
3. Перекройте запорный кран оболочки.
4. Извлеките из иглы стилет и промойте ее гепаринизированным солевым раствором.
5. Установите в иглу стилет и зафиксируйте его на втулке.
6. Полностью вставьте расширитель в транссептальную оболочку.

Введение собранного модуля оболочки/ расширителя в верхнюю полую вену

1. Обеспечьте доступ в бедренную вену (предпочтительно правую).

   ВАРИАНТ: можно использовать оболочку стандартной длины большего размера (≥ 2,5 размера по шкале Шарьера, чем размер транссептальной оболочки) для обеспечения и поддержания венозного доступа в целях замены устройства и обеспечения гемостаза.

2. Введите проволочный проводник диаметром 0,032 дюйма и длиной 150–180 см с «J»-образным концом длиной 3 мм в верхнюю полую вену (ВПВ).

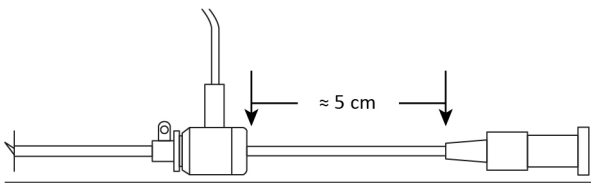
   ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальный диаметр проволочного проводника, который может использоваться с расширителем, составляет 0,032 дюйма.

3. Вводите оболочку/расширитель по проволочному проводнику, пока кончик оболочки не пройдет в верхнюю полую вену. Сориентируйте кончик расширителя в медиальном направлении.

Установите иглу со стилетом в сборе внутри оболочки с расширителем в сборе

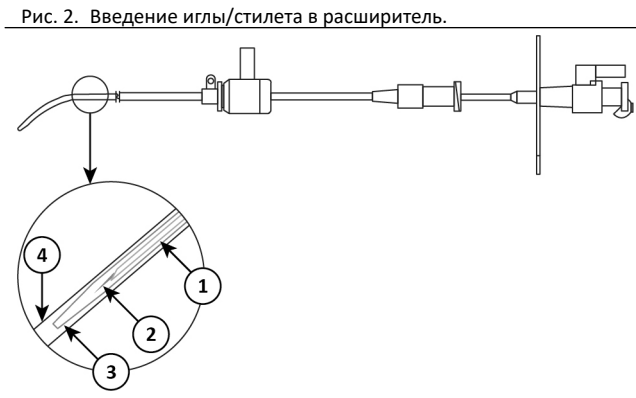
1. Извлеките из расширителя проволочный проводник.
2. Аспирируйте весь объем, затем промойте расширитель гепаринизированным физиологическим раствором.
3. Извлеките расширитель примерно на 5 см (см. рисунок ниже), чтобы облегчить прохождение изогнутой части иглы через жесткие втулки расширителя и оболочки.

Рис. 1. Извлечение расширителя.



4. Зафиксируйте стилет на втулке.
5. Введите иглу/стилет в расширитель. Продвигайте иглу/стилет под рентгеноскопическим контролем до тех пор, пока они не окажутся приблизительно на расстоянии 2 см от кончика расширителя внутри оболочки (см. рис. ниже).

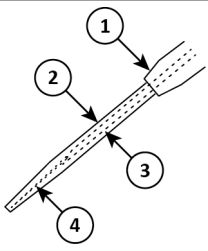
Рис. 2. Введение иглы/стилета в расширитель.



1. Игла
2. Стилет
3. Кончик расширителя
4. Оболочка

6. Для повторного присоединения оболочки к расширителю одновременно продвиньте в оболочку расширитель и иглу/стилет под рентгеноскопическим контролем. Убедитесь, что по мере продвижения обоих компонентов вместе положение иглы внутри расширителя не меняется. Не меняйте положения кончика оболочки в верхней полой вене.
7. Под рентгеноскопическим контролем продвигайте иглу/стилет до тех пор, пока стилет не будет расположен непосредственно в проксимальном направлении от кончика расширителя (см. рис. ниже).

Рис. 3. Продвижение иглы/стилета.



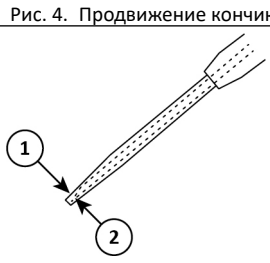
1. Кончик оболочки
2. расширитель
3. Игла
4. Стилет

8. Извлеките стилет, но не выбрасывайте его.
9. Аспирируйте содержимое иглы до появления крови из обратного кровотока. Выбросьте шприц.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Для предотвращения аспирации воздуха можно использовать шприц со скользящим наконечником (не Luer-Lok‡).

10. Промойте иглу гепаринизированным солевым раствором. Перекройте запорный кран.
11. Продвигайте иглу под флюороскопическим контролем до тех пор, пока кончик иглы не будет расположен непосредственно в проксимальном направлении от кончика расширителя (см. рис. ниже).

Рис. 4. Продвижение кончика иглы.



1. Кончик расширителя
2. Кончик иглы

ВАРИАНТ: присоедините трехходовый вращающийся запорный кран к втулке иглы.

ВАРИАНТ: подсоедините к запорному крану шприц с рентгеноконтрастным препаратом. Аспирируйте содержимое иглы. Затем заполните иглу контрастным препаратом под рентгеноскопическим контролем.

ВАРИАНТ: подсоедините к запорному крану линию мониторинга давления.

ВАРИАНТ: используйте стандартную схему подсоединения на три порта для подключения линии подачи контрастного раствора, линии датчика давления и линии подачи промывочного раствора.

Вход в овальную ямку

1. Визуально найдите и идентифицируйте анатомические ориентиры.
2. Установите флюороскопический аппарат под углом параллельно плоскости митрального клапана и перпендикулярно плоскости перегородки. Как правило, это левая передняя косая проекция (LAO) под углом приблизительно от 30 до 40 градусов.

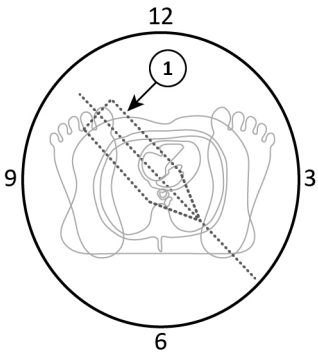
   ВАРИАНТ: во время ЭФ-процедур в качестве полезных анатомических ориентиров можно использовать положения катетеров в коронарном синусе и пучке Гиса. В соответствующей левой передней косой проекции катетер в коронарном синусе отображается в профиль. В соответствующей правой передней косой проекции (RAO) катетер в пучке Гиса отображается в профиль. Овальная ямка находится на уровне катетера в пучке Гиса или несколько ниже, а также сверху и позади устья коронарного синуса.

   ВАРИАНТ: для облегчения идентификации анатомических ориентиров можно установить катетер типа «пигтейл» (pigtail, с завитком на конце) для ангиографии или гемодинамического мониторинга в некоронарной створке аортального клапана.

   ВАРИАНТ: наблюдайте за кривой давления, регистрируемой через транссептальную иглу BRK™.

3. Поверните выступающий указатель так, чтобы игла была расположена перпендикулярно овальной ямке (обычно между стрелками часов, показывающими 3:00 и 5:00 часов, если смотреть со стороны ног пациента). (См. рис. ниже.)

Рис. 5. Выступающий указатель иглы.

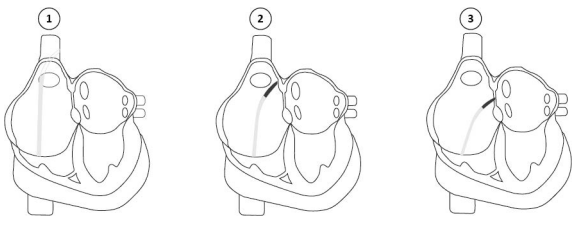


1. Выступающий указатель иглы

4. При помощи рентгеноскопии убедитесь, что кончик иглы находится в расширителе.
5. Убедившись, что кончик иглы находится в расширителе, начинайте медленно вести собранный модуль оболочки/расширителя/иглы по перегородке. Части модуля не должны смещаться относительно друг друга. Принципиально важно при проведении собранного модуля не менять ориентацию выступающего указателя.
6. Резкое смещение кончика расширителя в медиальном направлении (или вправо), обнаруженное в левой передней косой проекции (перпендикулярно межпредсердной перегородке), указывает на то, что кончик вошел в овальную ямку. (См. рисунки ниже.)

   ПРИМЕЧАНИЕ. Если овальная ямка проходима для зонда, кончик расширителя с легкостью пройдет в левое предсердие.

Рис. 6. Вход в овальную ямку



1. Первоначальное положение в верхней полой вене
2. Первоначальное медиальное смещение в правом предсердии
3. Резкое медиальное смещение в овальную ямку

ПРИМЕЧАНИЕ. Если мониторинг давления осуществляется через иглу, в этой точке давление будет определено неточно, поскольку кончик иглы уперся в овальную ямку.

Прокол овальной ямки транссептальной иглой BRK™

1. Перед продвижением иглы убедитесь, что собранный модуль оболочки/расширителя/иглы правильно размещен в овальной ямке.
2. Убедившись в правильном размещении иглы, до конца введите ее в оболочку в сборе с расширителем и проведите через межпредсердную перегородку.

   ВАРИАНТ: если выполняется мониторинг давления, вход в левое предсердие можно заметить по появлению на мониторе кривой сигнала давления, характерного для левого предсердия.

   ВАРИАНТ: вход в левое предсердие можно подтвердить посредством рентгеноскопии, введя контрастный раствор.

3. Если продвижению иглы препятствует сопротивление, отведите иглу и еще раз проверьте анатомические ориентиры.

   ВНИМАНИЕ! Если игла прошла в полость перикарда или в аорту, не следует продвигать расширитель по игле. В случае пенетрации иглой перикарда или аорты, ее следует извлечь. Внимательно следите за основными показателями жизнедеятельности.

Продвижение оболочки в сборе с расширителем в левое предсердие

Не меняя положение иглы в левом предсердии, проведите по ней устройство расширитель в сборке с оболочкой вперед в полость левого предсердия.

Продвижение оболочки по зафиксированному расширителю и игле в левое предсердие

1. Не меняйте положение иглы и расширителя относительно перегородки.
2. Не меняя положение расширителя, проведите оболочку по нему вперед в полость левого предсердия.

Извлечение транссептальной иглы BRK™ и расширителя

ВНИМАНИЕ! Во время извлечения оборудования из гемостатического клапана оболочки существует риск проникновения воздуха. Во избежание этого извлекайте все оборудование медленно, чтобы в оболочке не образовался вакуум, а при последующем введении устройства контролируйте посредством рентгеноскопии отсутствие воздуха в оболочке.

1. Поверните запорный кран иглы в положение «off» (закрыт) и отсоедините оборудование, подсоединенное к втулке иглы.
2. Извлеките транссептальную иглу BRK™ из расширителя. Иглу можно очистить и отложить для дальнейшего использования в ходе этой процедуры. В противном случае утилизируйте иглу в соответствии в требованиями по утилизации зараженных острых предметов.
3. Немедленно подсоедините к расширителю шприц и аспирируйте содержимое. Продолжайте аспирировать кровь и, не меняя положение оболочки, извлеките расширитель. Полученная кровь должна быть артериальной.
4. После извлечения расширителя аспирируйте кровь через боковой порт оболочки. Тщательно промойте боковой порт оболочки гепаринизированным физиологическим раствором, чтобы удалить пузырьки воздуха.
5. Оболочка установлена в левом предсердии.

Упаковка и срок годности

Транссептальная игла BRK™ поставляется в стерильном виде. В иглу в упаковке вставлен стилет. Игла и стилет помещены в первичную упаковку. Первичная упаковка помещена в запаянный пакет Mylar‡ и Tyvek‡. Пакет и данная инструкция находятся в запечатанной с обеих сторон коробке. На коробке и на пакете имеются этикетки с информацией об изделии, включая срок годности. Срок хранения продукции составляет три года.

Сводные клинические данные

Для стран Европейского Союза: сводная информация о безопасности и клинической эффективности (SSCP) этих устройств будет опубликована нотифицированными органами по адресу https://ec.europa.eu/tools/eudamed в соответствии с требованиями Регламента ЕС по медицинским изделиям 2017/745 и в указанные сроки. Найдите соответствующее устройство, используя уникальный идентификатор изделия (UDI-DI), указанный на внешней упаковке устройства. UDI-DI — это 14-значный номер, указанный между двумя первыми парами скобок. Более подробную информацию касательно поиска и использования UDI-DI см. в разделе «Часто задаваемые вопросы» по адресу medical.abbott/manuals.

Отчетность об инцидентах

Если в процессе использования этого устройства у вас возникли основания полагать, что произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю. Заказчикам из стран ЕС следует сообщать о серьезных инцидентах компетентному государственному органу, а также производителю.

Ограниченная гарантия

Компания Abbott Medical гарантирует отсутствие в ее изделиях дефектов материалов и производственного брака при условии нормальной эксплуатации. Данная гарантия не распространяется на период после даты «окончания срока годности», указанной на маркировке любого изделия. Санкционированные и утвержденные методы использования всех изделий компании изложены в соответствующей «инструкции по эксплуатации», которая прилагается к каждому изделию отдельно. Компания Abbott Medical не несет ответственности за использование ее изделий неразрешенными или несанкционированными методами. Ответственность компании Abbott Medical по данной гарантии ограничивается заменой изделий. Указанная гарантия исключает и заменяет все другие гарантии, как явные, так и подразумеваемые, в том числе любые подразумеваемые гарантии коммерческой ценности или пригодности для какой-либо цели. Компания Abbott Medical не несет никакой ответственности за любые случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием настоящего изделия, кроме случаев, прямо предусмотренных определенным законом. Компания Abbott Medical не допускает и не уполномочивает любое другое лицо принимать на себя любую другую или дополнительную ответственность за убытки, ущерб или расходы в связи с этим изделием. Подробную информацию см. в полной версии гарантийной политики компании Abbott Medical, которую можно получить у компании Abbott Medical или прочитать на обороте счета-фактуры компании Abbott Medical.

Условные обозначения

На изделие или его этикетку могут быть нанесены следующие условные обозначения и стандартизированные условные обозначения. Значения стандартизированных условных обозначений см. в глоссарии универсальных условных обозначений по адресу medical.abbott/manuals.

Символ	Определение
Series	Серия
Contents	Содержание
Transseptal Needle	Транссептальная игла
	Система одинарного стерильного барьера
	Длина
	ВНИМАНИЕ! Федеральным законодательством США разрешается продавать это устройство только врачам или по предписанию врачей.
	Conformité Européenne (Европейское соответствие). Присвоено данному устройству в соответствии с регламентом Европейского совета 2017/745. Настоящим компания Abbott Medical заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям вышеуказанного регламента.
	Импортер
	Знак соответствия стандартам Великобритании
UKRP	Ответственное лицо в Великобритании
	Украинский знак соответствия техническим регламентам, где 101 — орган по оценке.
MD	Медицинское устройство
UDI	Уникальный идентификационный номер устройства
	Следуйте инструкции по эксплуатации на этом веб-сайте
 (7440-48-4) (7439-92-1)	Содержит опасные вещества. (Кобальт CAS № 7440-48-4) (Свинец CAS № 7439-92-1)

SK: Slovenčina

BRK™ Transseptálna ihla

Návod na použitie

Opis

Transseptálna ihla BRK™ pozostáva z luminálnej ihly z nehrdzavejúcej ocele a pevného styletu z nehrdzavejúcej ocele. Distálna časť ihly je zakrivená, čo umožňuje ľahšie polohovanie v srdci, keď sa ihla používa spolu so súpravou transseptálneho puzdra od spoločnosti Abbott Medical. V rámci tejto zakrivenej časti dochádza k prudkému zostupu vonkajšieho priemeru ihly, aby bolo možné tesné spojenie s vnútorným priemerom dilatátora, ktorý je súčasťou súpravy transseptálneho puzdra od spoločnosti Abbott Medical. Distálny hrot ihly je skosený na uľahčenie procesu punkcie. Proximálny koniec ihly je konfigurovaný s prírubou ukazovateľa (označujúceho orientáciu distálneho zakrivenia) a je vybavený 2-cestným kohútikom, ktorý zabezpečuje prístup do lúmenu ihly na účely odsávania, vstrekovania alebo infúzie tekutín, odoberania vzoriek krvi, monitorovania tlaku a vsunutia styletu alebo vodiaceho drôtu (pre ihlu veľkosti 18 G je maximálny priemer vodiaceho drôtu 0,014 palca, pre ihlu veľkosti 19 G je maximálny priemer vodiaceho drôtu 0,012 palca). Stylet je rovný a po celej dĺžke má rovnaký priemer. Proximálny koniec styletu je vybavený zakrivenou sponou, ktorá umožňuje upevniť stylet na proximálne hrdlo ihly, keď je stylet vsunutý do lúmenu ihly. Stylet je určený na uľahčenie posúvania ihly v rámci dilatátora. Ihla sa dodáva v rôznych použiteľných dĺžkach a konfiguráciách distálneho zakrivenia.

Určený účel

Transseptálna ihla BRK™ je určená na punkciu medzipredsieňového septa na vytvorenie prístupu do ľavého srdca.

Indikácie na použitie

Transseptálna ihla BRK™ sa používa na punkciu medzipredsieňového septa počas procesu transseptálnej katetrizácie na vytvorenie prístupu do ľavého srdca.

Cieľová skupina pacientov

Transseptálna ihla BRK™ je určená na použitie u hemodynamicky stabilných pacientov, u ktorých sa vyžaduje katétrový prístup do ľavého srdca. Použitie transseptálnej ihly BRK™ môže vyžadovať osobitnú pozornosť u pacientov s nasledujúcimi zdravotnými stavmi:

- Pootočené srdce,
- Zväčšený aortálny koreň,
- Výrazné zväčšenie pravej predsiene,
- Skolióza/kyfóza,
- Abnormálna geometria ľavej predsiene,
- Vrodené malformácie,
- Vaskulárne malformácie,
- Nemožnosť prístupu do pravej predsiene cez vena cava inferior.

Cieľový používateľ

Túto pomôcku smú používať len lekári, ktorí sú špeciálne vyškolení na transseptálne zákroky, v plne vybavenom funkčnom elektrofyziologickom laboratóriu.

Klinický prínos

Zamýšľaným klinickým prínosom transseptálnej ihly BRK™ je punkcia medzipredsieňového septa počas transseptálnej katetrizácie na vytvorenie prístupu do ľavého srdca, aby sa umožnilo dosiahnuť zamýšľaný klinický prínos pri pomôckach, pri ktorých sa vyžaduje prístup do ľavej časti endokardu srdca, ako napr. pri ablačnom katétri. To sa meria úspešnou punkciou medzipredsieňového septa.

Kontraindikácie

- Predchádzajúca záplata na medzipredsieňovom septe alebo protetická pomôcka na uzavretie defektu predsieňového septa.
- Akákoľvek predchádzajúca tromboembolická udalosť.
- Potvrdený myxóm ľavej predsiene alebo podozrenie na jeho existenciu.
- Potvrdený infarkt myokardu alebo podozrenie na infarkt myokardu v posledných dvoch týždňoch.
- Nestabilná angína pectoris.
- Nedávna cievna mozgová príhoda (CVA).
- Pacienti s intoleranciou voči antikoagulačnej terapii.
- Pacienti s aktívnou infekciou.

Varovania

- Pomôcku žiadnym spôsobom neupravujte.
- Táto pomôcka je určená len na jednorazové použitie; nepripravujte ju na opakované použitie, ani ju nepoužívajte opakovane. Skontrolujte dátum „Použiť do“ na obale. Akýkoľvek pokus o resterilizáciu a opakované použitie tohto systému môže narušiť jeho integritu. Nežiaduce účinky pri používaní nesterilných súčastí môžu okrem iného zahŕňať tieto:
  - Lokálna a systémová infekcia alebo reakcia,
  - Mechanické poškodenie,
  - Nepresné fungovanie.
- Materiály jednotlivých výrobkov identifikované nižšie môžu spôsobovať alergické reakcie alebo reakcie z precitlivenosti. U osôb alergických na tieto materiály môže vzniknúť’ alergická reakcia na tento výrobok. Pred použitím u pacienta musí byť pacient poučený o materiáloch obsiahnutých v pomôcke a musí byť prediskutovaná podrobná anamnéza alergií:
  - Nehrdzavejúca oceľ
  - Epoxidové lepidlo
  - Poniklovaná chrómovaná mosadz
  - Silikónové vysokovákuové mazivo (Dupont)
  - Master Bond
- Nesprávne použitie tejto pomôcky môže spôsobiť závažné komplikácie.
- U pacientov aj personálu laboratória môžu zákroky katetrizácie srdca viesť k značnej radiačnej expozícii, čo môže viesť k akútnemu poraneniu z ožiarenia, ako aj k zvýšenému riziku somatických a genetických účinkov z dôvodu intenzity röntgenového žiarenia a trvania skiaskopického zobrazovania. Použitie tejto pomôcky u tehotných žien dôkladne zvážte.

Bezpečnostné opatrenia

- Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj tejto pomôcky na lekára alebo jeho objednávku.
- Pred použitím si prečítajte pokyny.
- Pred použitím balenie skontrolujte. Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený.
- Pred použitím skontrolujte všetky súčasti.
- Skladujte na chladnom, tmavom a suchom mieste.

- Pred zákrokom musí byť pacient hemodynamicky stabilný. Pri používaní tohto výrobku si určité podmienky môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Medzi ne môžu okrem iných patriť:
  - Pootočené srdce,
  - Zväčšený aortálny koreň,
  - Výrazné zväčšenie pravej predsiene,
  - Skolióza/kyfóza,
  - Abnormálna geometria ľavej predsiene,
  - Vrodené malformácie,
  - Vaskulárne malformácie,
  - Nemožnosť prístupu do pravej predsiene cez vena cava inferior.
- Túto pomôcku smú používať len lekári, ktorí sú špeciálne vyškolení na transseptálne zákroky, v plne vybavenom funkčnom elektrofyziologickom (EP) laboratóriu.
- Zavádzanie katétra sa musí vykonávať pod skiaskopickým dohľadom, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, perforácie alebo tamponády srdca. Je možné zvážiť aj kompatibilné navigačné systémy a systémy vizualizácie v reálnom čase.
- Pri zavádzaní kontrolujte, či hrot ihly postupujúci cez zakrivenie zostavy puzdra/dilatátora nekladie nadmerný odpor. Ak pri posúvaní ihly ucítite odpor, vytiahnite ju a skontrolujte súčasti.
- Počas zavádzania dbajte na to, aby ste v tejto pomôcke nevytvorili nadmerné ohyby. Tieto ohyby môžu obmedziť postup ihly, čo môže mať za následok neúmyselné prepichnutie zostavy dilatátora/puzdra ihlou.
- Pri vsúvaní vždy používajte stylet, aby sa uľahčil priechod ihly cez zostavu dilatátora/puzdra. Ak sa nepoužije stylet, môže dôjsť k obmedzeniu postupu ihly, čo môže mať za následok neúmyselné prepichnutie zostavy dilatátora/puzdra ihlou alebo odlupovanie materiálu z vnútorného povrchu dilatátora.
- Ak by došlo k perikardiálnemu alebo aortálnemu vstupu, dilatátor neposúvajte cez ihlu. Ak ihla prenikne do perikardu alebo aorty, musí sa vytiahnuť. Pozorne monitorujte vitálne funkcie.
- Pri vyťahovaní predmetov z hemostatického ventilu puzdra vzniká nebezpečenstvo nasatia vzduchu. Urobte potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo nasatiu vzduchu: predmety vyťahujte pomaly, aby v puzdre nevznikol podtlak a počas nasledujúceho zavádzania pomôcky skiaskopicky monitorujte, či puzdro neobsahuje vzduch.
- Po použití je potrebné túto pomôcku, jej príslušenstvo a balenie náležite klasifikovať na likvidáciu, napr. ako biologicky nebezpečný odpad, ostré nástroje, neškodný odpad atď., a opatrne zlikvidovať v súlade s postupmi zdravotníckeho zariadenia a platnými zákonmi a predpismi.
- Jedna alebo viac súčastí tejto pomôcky môžu obsahovať nasledujúcu látku definovanú ako CMR 1B v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti: Kobalt: č. CAS (Chemical Abstracts Service) 7440-48-4; č. EK 231-158-0. Súčasné vedecké dôkazy potvrdzujú, že zdravotnícke pomôcky vyrobené zo zliatin kobaltu a zliatin nehrdzavejúcej ocele s obsahom kobaltu nespôsobujú zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia alebo nepriaznivých účinkov na reprodukciu.

  Jedna alebo viac súčastí tejto pomôcky môžu obsahovať nasledujúcu látku definovanú ako CMR 1A v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti: Olovo: č. CAS (Chemical Abstracts Service) 7439-92-1; č. EK 231-100-4. Súčasné vedecké dôkazy potvrdzujú, že zdravotnícke pomôcky vyrobené z olova nespôsobujú zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia alebo nepriaznivých účinkov na reprodukciu.

Možné nežiaduce udalosti

Kategória nežiaducich udalostí	Podkategória nežiaducich udalostí
Krvácanie	Hemorágia/krvácanie
	Hematóm
Poranenie mozgu	Asymptomatická mozgová embólia
	Mŕtvica/cievna mozgová príhoda
	Prechodná ischemická príhoda (TIA)
Embólia	Vzduchová embólia
	Embólia spôsobená cudzím telesom
	Pľúcna embólia
	Tromboembólia
	Trombóza/trombus
Perforácia srdca	Tamponáda srdca
	Perikardiálny výpotok
Poškodenie srdcového tkaniva a ciev	Poškodenie chlopne
	Punkcia koreňa aorty
	Perforácia predsiene
Porucha prevodového systému srdca	Zablokovanie sinoatriálneho uzla, atrioventrikulárneho uzla alebo systému His-Purkinje
	Srdcové arytmie
Imunologická reakcia	Anafylaxia
Infekcia	Perikarditída
	Endokarditída
	Pneumónia
	Sepsa
Bolesť/nepríjemné pocity	Bolesť, slabiny, hrudník (všeobecná bolesť na hrudníku nesúvisiaca s infarktom myokardu)
Periférne poranenie cievy	Disekcia
	Lacerácia
	Vznik artériovenóznej fistuly
	Vznik pseudoaneuryzmy
Hypotenzia	Nevzťahuje sa
Poškodenie povrchového tkaniva	Nevzťahuje sa

Pokyny

Príprava a zostavenie pomôcok

1. Vyberte obsah z balenia.

   POZNÁMKA: Puzdro a dilatátor nezostavujte.
2. Dilatátor a puzdro prepláchnite heparinizovaným fyziologickým roztokom.
3. Zavrite kohútik puzdra.
4. Stylet vytiahnite z ihly a ihlu vypláchnite heparinizovaným fyziologickým roztokom.

5. Stylet zasuňte do ihly a uzamknite ho na hrdle.
6. Dilatátor úplne zasuňte do transseptálneho puzdra.

Zasunutie zostavy puzdra/dilatátora do vena cava superior

1. Vytvorte femorálny žilový prístup (prednostne pravá femorálna žila).

   VOLITEĽNÉ: Na vytvorenie a udržiavanie žilového prístupu na výmenu pomôcky a zabezpečenie hemostázy je možné použiť väčšie (veľkosti puzdra o ≥ 2,5 jednotky French väčšie ako transseptálne puzdro) puzdro štandardnej dĺžky.

2. Vodiaci drôt s priemerom 0,032 palca, dĺžkou 150 – 180 cm a 3 mm hrotom tvaru „J“ zaveďte do vena cava superior (VCS).

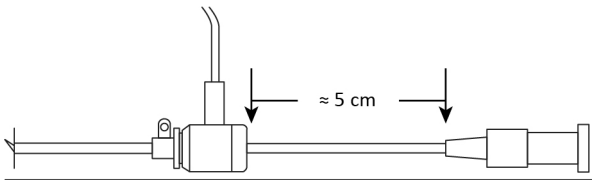
   POZNÁMKA: Maximálny priemer vodiaceho drôtu, ktorý sa môže používať s dilatátorom, je 0,032 palca.

3. Puzdro/dilatátor vsuňte do žily po vodiacom drôte a posúvajte ich dovtedy, kým sa hrot puzdra nebude nachádzať vo VCS. Hrot dilatátora nasmerujte mediálne.

Umiestnenie zostavy ihly/styletu vo vnútri zostavy puzdra/dilatátora

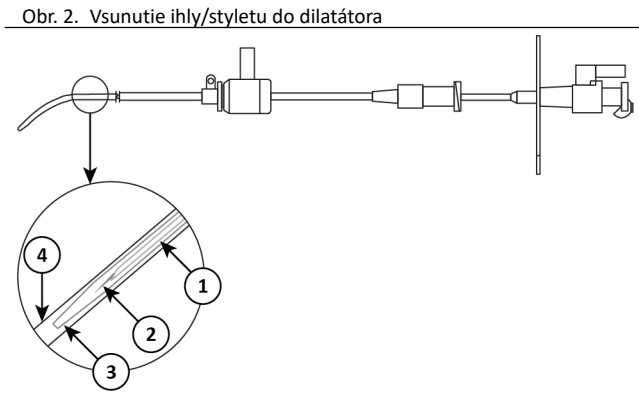
1. Vodiaci drôt vytiahnite z dilatátora.
2. Vykonajte úplnú aspiráciu a potom prepláchnite dilatátor heparinizovaným fyziologickým roztokom.
3. Vytiahnite dilatátor približne o 5 cm (pozrite si obrázok nižšie), aby sa uľahčil priechod zakrivenia ihly cez pevné hrdlá dilatátora a puzdra.

Obr. 1. Vytiahnutie dilatátora



4. Upevnite stylet na hrdlo.
5. Vsuňte ihlu/stylet do dilatátora. Pod skiaskopickou kontrolou posúvajte ihlu/stylet, kým sa nebude nachádzať približne 2 cm od hrotu dilatátora vnútri puzdra (pozrite si obrázok nižšie).

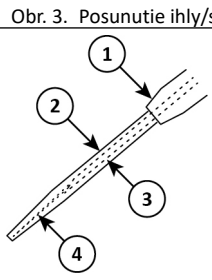
Obr. 2. Vsunutie ihly/styletu do dilatátora



1. Ihla
2. Stylet
3. Hrot dilatátora
4. Puzdro

6. Na opätovné spojenie puzdra s dilatátorom posúvajte súčasne dilatátor a ihlu/stylet do puzdra pod skiaskopickou kontrolou. Pri vzájomnom posúvaní súčastí dbajte na to, aby nedošlo k zmene pozície ihly v dilatátore. Udržiavajte polohu hrotu puzdra vo VCS.
7. Pod skiaskopickou kontrolou posúvajte ihlu/stylet, kým nebude stylet umiestnený proximálne pri hrote dilatátora (pozrite si obrázok nižšie).

Obr. 3. Posunutie ihly/styletu



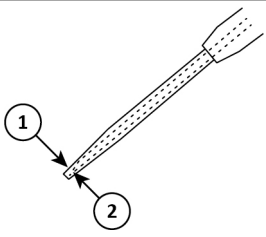
1. Hrot puzdra
2. Dilatátor
3. Ihla
4. Stylet

8. Vytiahnite stylet, nelikvidujte ho.
9. Odsávajte ihlu, dokým nespozorujete návrat krvi. Striekačku zlikvidujte.

   POZNÁMKA: Použitie striekačky s klzným hrotom (nie typu Luer-Lok‡) môže zabrániť nasatiu vzduchu.

10. Prepláchnite ihlu heparinizovaným fyziologickým roztokom. Zavrite kohútik.
11. Pod skiaskopickou kontrolou posúvajte ihlu, kým nebude hrot ihly umiestnený proximálne pri hrote dilatátora (pozrite si obrázok nižšie).

Obr. 4. Posunutie hrotu ihly



1. Hrot dilatátora
2. Hrot ihly

VOLITEĽNÉ: Na hrdlo ihly pripevnite 3-cestný otočný kohútik.

VOLITEĽNÉ: Na kohútik pripevnite striekačku s kontrastným médiom nepriepustným pre žiarenie. Ihlu odsajte. Potom ju pod skiaskopickou kontrolou naplňte kontrastnou látkou.

VOLITEĽNÉ: Ku kohútiku pripojte vodič na monitorovanie tlaku.

VOLITEĽNÉ: Na pripojenie vodičov pre kontrast, vyplachovanie a sledovanie tlaku použite štandardnú 3-portovú zostavu rozvodu.

Dosiahnutie fossa ovalis

1. Vizualizujte a identifikujte anatomické orientačné body.

2. Nastavte skiaskopickú jednotku do uhla rovnobežného s rovinou mitrálnej chlopne a kolmého na rovinu septa. Tento uhol je zvyčajne približne 30 až 40 stupňov ľavej prednej šikmej projekcie (LAO).

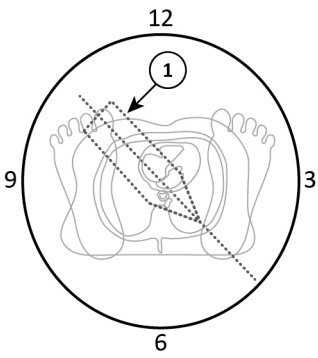
   VOLITEĽNÉ: Počas elektrofyziologických (EP) zákrokov môžu polohy katétra na úrovni sinus coronarius a Hisovho zväzku slúžiť ako užitočné anatomické orientačné body. Pri vhodnom pohľade ľavej prednej šikmej projekcie (LAO) sa na monitore objaví profil katétra na úrovni sinus coronarius. Pri vhodnom pohľade pravej prednej šikmej projekcie (RAO) sa na monitore objaví profil katétra na úrovni Hisovho zväzku. Fossa ovalis je na úrovni alebo mierne pod úrovňou katétra lokalizovaného v mieste Hisovho zväzku a nad a vzadu za ústím sinus coronarius.

   VOLITEĽNÉ: Umiestnenie monitorovacieho angiografického/hemodynamického špirálového katétra do nekoronárneho cípu aortálnej chlopne môže poslúžiť ako užitočný anatomický orientačný bod.

   VOLITEĽNÉ: Pozorujte krivku signálu tlaku, ktorá sa zaznamenáva cez transseptálnu ihlu BRK™.

3. Prírubu ukazovateľa nastavte tak, aby ihla smerovala kolmo na fossa ovalis (zvyčajne medzi 3. a 5. hodinou z pohľadu od nôh pacienta). (Pozrite si obrázok nižšie.)

Obr. 5. Príruba ukazovateľa ihly

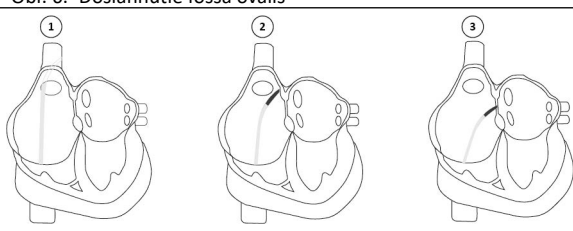


1. Príruba ukazovateľa ihly

4. Pomocou skiaskopie overte, že hrot ihly je vnútri dilatátora.
5. Po potvrdení, že sa hrot ihly nachádza vnútri dilatátora, začnite pomaly vyťahovať celú zostavu puzdra/dilatátora/ihly. Zabráňte akémukoľvek vzájomnému pohybu súčastí zostavy. Pri vyťahovaní zostavy je veľmi dôležité udržiavať predchádzajúcu orientáciu príruby ukazovateľa.
6. Počas vyťahovania v pohľade LAO (kolmo na medzipredsieňové septum) pozorujte hrot dilatátora, či nedôjde k náhlemu mediálnemu pohybu (alebo pohybu doprava), čo by naznačovalo, že hrot dosiahol fossa ovalis. (Pozrite si obrázky nižšie.)

   POZNÁMKA: Ak je fossa ovalis pre sondu priechodná, hrot dilatátora teraz ľahko vnikne do ľavej predsiene.

Obr. 6. Dosiahnutie fossa ovalis



1. Východisková poloha vo VCS
2. Počiatočný mediálny pohyb v pravej predsieni
3. Náhly mediálny pohyb do fossa ovalis

POZNÁMKA: Ak sa cez ihlu monitoruje tlak, tlak nameraný cez ihlu je v tomto bode nepresný, pretože hrot sa nachádza oproti fossa ovalis.

Punkcia fossa ovalis pomocou transseptálnej ihly BRK™

1. Skôr než pristúpite k posúvaniu ihly, skontrolujte, či je zostava puzdra, dilatátora a ihly správne umiestnená na úrovni fossa ovalis.
2. Po potvrdení správnosti umiestnenia zostavy ihlu vysuňte tak, aby zaberala celý rozsah v rámci zostavy puzdra/dilatátora, a posúvajte ihlu cez medzipredsieňové septum.

   VOLITEĽNÉ: Pri monitorovaní tlaku je vstup do ľavej predsiene potvrdený vtedy, keď sledovanie tlaku ukazuje charakteristickú krivku signálu tlaku nameraného v ľavej predsieni.

   VOLITEĽNÉ: Dosiahnutie ľavej predsiene je možné potvrdiť pomocou skiaskopie so vstreknutím kontrastnej látky.

3. Ak sa pri postupe ihly objaví akýkoľvek odpor, ihlu povytiahnite a znova vyhodnoťte anatomické orientačné body.

   UPOZORNENIE: Ak by došlo k perikardiálnemu alebo aortálnemu vstupu, dilatátor neposúvajte cez ihlu. Ak ihla prenikne do perikardu alebo aorty, musí sa vytiahnuť. Pozorne monitorujte vitálne funkcie.

Posunutie zostavy puzdra/dilatátora do ľavej predsiene

Zatiaľ čo ihlu udržiavate vo fixnej polohe v ľavej predsieni, zostavu puzdra/dilatátora úplne posuňte cez ihlu do dutiny ľavej predsiene.

Posunutie puzdra cez upevnený dilatátor a ihlu do ľavej predsiene

1. Udržiavajte polohu ihly a dilatátora v septe.
2. Zatiaľ čo dilatátor udržiavate vo fixnej polohe, puzdro úplne posuňte cez dilatátor do dutiny ľavej predsiene.

Vytiahnutie transseptálnej ihly BRK™ a dilatátora

UPOZORNENIE: Pri vyťahovaní predmetov z hemostatického ventilu puzdra vzniká nebezpečenstvo nasatia vzduchu. Urobte potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo nasatiu vzduchu: predmety vyťahujte pomaly, aby v puzdre nevznikol podtlak a počas nasledujúceho zavádzania pomôcky skiaskopicky monitorujte, či puzdro neobsahuje vzduch.

1. Kohútik ihly otočte do zatvorenej polohy a odpojte všetky prípojky na hrdle ihly.
2. Transseptálnu ihlu BRK™ vytiahnite z dilatátora. Ihlu je možné vyčistiť a odložiť na opakované použitie v rámci tohto zákroku. V opačnom prípade ihlu zlikvidujte spôsobom vhodným pre kontaminované ostré predmety.
3. Na dilatátor okamžite pripojte striekačku a odsávajte. Pokračujte v odsávaní krvi, zatiaľ čo puzdro držíte na mieste a vyťahujete dilatátor. Krv by mala byť arteriálna.
4. Po vytiahnutí dilatátora odsajte krv cez bočné rameno puzdra. Opatrne prepláchnite bočné rameno puzdra heparinizovaným fyziologickým roztokom a dbajte na to, aby sa netvorili vzduchové bubliny.
5. Puzdro je teraz na mieste v ľavej predsieni.

Balenie a doba použiteľnosti

Transseptálna ihla BRK™ sa dodáva sterilná. Ihla je zabalená s vloženým styletom. Ihla a stylet sú umiestnené v hlavnom obale. Hlavný obal je vložený vo vrecku Mylar‡ a Tyvek‡, ktoré je zvarené. Vrecko a tento návod na použitie sú vložené v škatuli, ktorá je na oboch koncoch zapečatená. Vrecko aj škatuľa sú opatrené štítkom s informáciami o výrobku vrátane dátumu exspirácie. Výrobky sú opatrené štítkom s označením životnosti výrobku, ktorá je tri roky.

Súhrn klinických údajov

V prípade krajín Európskej únie: Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) pre tieto pomôcky zverejnia notifikované osoby na adrese https://ec.europa.eu/tools/eudamed v súlade s požiadavkami nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach (MDR) 2017/745 a súvisiacimi časovými harmonogramami. Príslušnú pomôcku vyhľadajte podľa identifikátora UDI-DI uvedeného na vonkajšom obale pomôcky. Identifikátor UDI-DI je 14-miestne číslo medzi prvými dvoma skupinami zátvoriek. Ďalšie informácie o vyhľadávaní a používaní identifikátorov UDI-DI nájdete v dokumente Často kladené otázky na adrese medical.abbott/manuals.

Hlásenie udalostí

Ak sa pri používaní tejto pomôcky vyskytne závažná udalosť, nahláste ju výrobcovi. Zákazníci v Európskej únii nahlasujú závažné udalosti národnému úradu aj výrobcovi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Abbott Medical zaručuje, že výrobok je za normálneho použitia bez poškodenia materiálu a spracovania. Táto záruka sa nevzťahuje na „Dátum exspirácie“ uvedený na akomkoľvek štítku výrobku. Schválené použitie a povolené metódy použitia pre každý náš výrobok sú stanovené v príslušnom „Návode na použitie“, ktorý sa dodáva s každým výrobkom. Spoločnosť Abbott Medical sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti a záruk týkajúcich sa použitia tohto výrobku spôsobom, ktorý nebol schválený či povolený. Zodpovednosť spoločnosti Abbott Medical v tejto záruke je obmedzená na výmenu výrobku. Predošlá záruka vylučuje a nahrádza všetky ostatné záruky, či výslovné alebo implicitné, vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek implikovaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť Abbott Medical odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek náhodné alebo následné straty, škody alebo náklady priamo alebo nepriamo vyplývajúce z používania tohto výrobku, iné než ktoré sú výslovne uvedené konkrétnymi právnymi predpismi. Spoločnosť Abbott Medical neprijíma ani neoprávňuje žiadnu inú osobu prevziať akúkoľvek inú alebo dodatočnú zodpovednosť za stratu, poškodenie či náklady spojené s týmto výrobkom. Ďalšie informácie nájdete v úplnom znení záručných podmienok spoločnosti Abbott Medical, ktoré je k dispozícii od spoločnosti Abbott Medical, alebo na zadnej strane faktúr spoločnosti Abbott Medical.

Symboly

Na výrobku alebo na označení výrobku môžete nájsť nižšie uvedené symboly a harmonizované symboly. Harmonizované symboly nájdete v univerzálnom glosári symbolov na adrese medical.abbott/manuals.

Symbol	Definícia
Series	Séria
Contents	Obsah
Transseptal Needle	Transseptálna ihla
	Systém jednoduchej sterilnej bariéry
	Dĺžka
℞ ONLY	UPOZORNENIE: Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj tejto pomôcky na lekára alebo jeho objednávku.
CE 2797	Conformité Européenne (Európska zhoda). Označenie v súlade s nariadením Rady Európskej únie 2017/745. Spoločnosť Abbott Medical týmto vyhlasuje, že táto pomôcka spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia tohto nariadenia.
	Dovozca
UK CA 0086	Posúdenie zhody v Spojenom kráľovstve
UKRP	Zodpovedná osoba v Spojenom kráľovstve
UA.TR.101	Ukrajinská značka zhody s technickými nariadeniami, kde 101 označuje hodnotiaci orgán.
MD	Zdravotnícka pomôcka
UDI	Unikátna identifikácia pomôcky
medical.abbott/manuals	Postupujte podľa pokynov na použitie uvedených na tejto webovej lokalite
(7440-48-4) (7439-92-1)	Obsahuje nebezpečné látky. (kobalt, č. CAS 7440-48-4) (olovo, č. CAS 7439-92-1)

SL: Slovenščina

BRK™ Transseptalna igla

Navodila za uporabo

Opis

Transseptalna igla BRK™ je sestavljena iz votle igle iz nerjavnega jekla in mandrena iz trdnega nerjavnega jekla. Distalni del igle je ukrivljen, da omogoča namestitev v srcu, kadar se igla uporablja s kompletom transseptalnega tulca družbe Abbott Medical. Na tem ukrivljenem delu je zunanji premer hitro zmanjšan, da se ujema z notranjim premerom dilatatorja pri kompletu transseptalnega tulca družbe Abbott Medical. Distalna konica igle ima posnet rob, da poenostavi postopek punkcije. Proksimalni konec igle ima označevalno prirobnico (ki označuje usmerjenost distalne ukrivljenosti) in je opremljen z 2-potnim ventilom, ki omogoča dostop do svetline igle za aspiracijo, injiciranje/infuzijo tekočine, jemanje vzorca krvi, spremljanje tlaka in vstavitev mandrena in/ali vodilne žice (za iglo s premerom 18 G je največji premer vodilne žice 0,014 palca; za iglo s premerom 19 G pa je največji premer vodilne žice 0,012 palca). Mandren je raven in izodiametričen po celotni dolžini. Proksimalni konec mandrena ima ukrivljeno sponko za pritrditev na proksimalni nastavek igle, ko je vstavljen v svetlino igle. Mandren je zasnovan za pomoč pri pomikanju igle v dilatatorju. Igla je na voljo v različnih uporabnih dolžinah in z različnimi konfiguracijami distalne ukrivljenosti.

Predvidena uporaba

Transseptalna igla BRK™ je namenjena prebadanju interatrijskega septuma za dostop do leve strani srca.

Indikacije za uporabo

Transseptalna igla BRK™ se uporablja za prebadanje interatrijskega septuma med postopkom transseptalne katetrizacije za dostop do leve strani srca.

Ciljna skupina bolnikov

Transseptalna igla BRK™ je namenjena uporabi pri hemodinamično stabilnih bolnikih, pri katerih je potreben katetrski dostop do leve strani srca. Uporaba transseptalne igle BRK™ lahko zahteva poseben razmislek pri bolnikih z naslednjimi stanji:

- Rotacijo srca,
- Povečanim korenom aorte,
- Pomembnim povečanjem desnega atrija,
- Skoliozo/kifozo,
- Neobičajno geometrijo levega atrija,
- Prirojene malformacije,
- Vaskularne malformacije,
- Onemogočen dostop do desnega atrija skozi spodnjo votlo veno.

Predvideni uporabnik

Pripomoček smejo uporabljati samo zdravniki, ustrezno usposobljeni za transseptalne posege, v ustrezno opremljenem in delujočem elektrofiziološkem laboratoriju.

Klinične koristi

Predvidena klinična korist transseptalne igle BRK™ je punkcija interatrijskega septuma med postopkom transseptalne katetrizacije, da se pridobi dostop do levega dela srca, s čimer se zagotovi klinična korist pripomočkov, ki potrebujejo dostop do endokarda na levi strani srca, na primer ablacijskega katetra. Ta se meri po uspešnosti punkcije interatrijskega septuma.

Kontraindikacije

- Predhodno popravilo interatrijskega septuma ali protetični pripomoček za zapiranje atrijskega septalnega defekta.
- Kakršen koli predhoden trombembolični dogodek.
- Diagnosticiran ali domneven miksom v levem atriju.
- Diagnosticiran ali domneven miokardni infarkt v preteklih dveh tednih.
- Nestabilna angina.
- Nedaven cerebrovaskularni incident (CVA).
- Bolniki, ki ne prenašajo antikoagulacijskega zdravljenja.
- Bolniki z aktivno okužbo.

Opozorila

- Tega pripomočka ne spreminjajte na noben način.
- Ta pripomoček je predviden le za enkratno uporabo, ne izvajajte obdelave za ponovno uporabo in ga ne uporabite ponovno. Upoštevajte „rok uporabnosti“ na ovojnini. Vsak poskus ponovne sterilizacije in ponovne uporabe tega sistema lahko ogrozi njegovo celovitost. Neželeni učinki uporabe nesterilnih sestavnih delov so med drugim lahko:
  - Lokalne ali sistemske okužbe ali reakcije,
  - Mehanska poškodba,
  - Nenatančno delovanje.
- Materiali, ki so navedeni spodaj za posamezne izdelke, lahko povzročijo alergijske ali preobčutljivostne reakcije. Pri osebah, ki so nanje alergične, lahko pride do alergijske reakcije na ta izdelek. Pred uporabo pri bolniku je treba bolnika poučiti o materialih, ki jih vsebuje pripomoček, in se z njim pogovoriti o alergijskih reakcijah:
  - Nerjavno jeklo,
  - Epoksidno lepilo,
  - Kromirana medenina, prevlečena z nikljem,
  - Silikonsko mazivo za visoki vakuum (Dupont),
  - Master Bond
- Nepravilna uporaba tega pripomočka lahko povzroči resne zaplete.
- Med postopki katetrizacije srca lahko pride do znatne izpostavljenosti bolnikov in laboratorijskega osebja rentgenskim žarkom, zaradi česar lahko pride do akutnih radiacijskih poškodb in povečanega tveganja za somatske in genetske učinke odvisno od intenzivnosti rentgenskih žarkov in trajanja fluoroskopskega slikanja. Temeljito razmislite o uporabi tega pripomočka pri nosečnicah.

Previdnostni ukrepi

- Zvezni zakon (ZDA) omejuje prodajo tega pripomočka samo na zdravnika ali po njegovem naročilu.
- Pred uporabo preberite navodila.
- Pred uporabo preglejte paket. Ne uporabite, če je ovojnina odprta ali poškodovana.
- Pred uporabo preglejte vse sestavne dele.
- Shranjujte na hladnem, temnem in suhem mestu.
- Pred posegom mora biti bolnik hemodinamično stabilen. Določeni pogoji lahko zahtevajo poseben premislek o uporabi izdelka. To lahko med drugim vključuje naslednje:
  - Rotacijo srca,
  - Povečan koren aorte,
  - Pomembno povečanje desnega atrija,

  - Skoliozo/kifozo,
  - Neobičajno geometrijo levega atrija,
  - Prirojene malformacije,
  - Vaskularne malformacije,
  - Onemogočen dostop do desnega atrija skozi spodnjo votlo veno.
- Pripomoček smejo uporabljati samo zdravniki, ustrezno usposobljeni za transseptalne posege, v ustrezno opremljenem in delujočem elektrofiziološkem (EF) laboratoriju.
- Pomikanje katetra naprej je treba izvajati pod vodenjem s fluoroskopijo, da se minimizira tveganje poškodb, perforacij ali tamponade srca. Razmislite lahko tudi o uporabi združljivih sistemov za navigacijo in vizualizacijo v realnem času.
- Med vstavljanjem bodite pozorni na prevelik upor, ko se konica igle pomika skozi ukrivljeni del sklopa tulca/dilatatorja. Če začutite upor med pomikanjem igle, iglo povlecite nazaj in preverite sestavne dele.
- Med vstavljanjem pazite, da tega pripomočka ne ukrivite preveč. To lahko onemogoči pomikanje igle in povzroči nenamerno punkcijo sklopa dilatatorja/tulca z iglo.
- Med vstavljanjem vedno uporabite mandren za lažje pomikanje igle skozi sklop dilatatorja/tulca. Neuporaba mandrena lahko onemogoči pomikanje igle in povzroči nenamerno punkcijo sklopa dilatatorja/tulca z iglo ali odstopanje materiala od notranje površine dilatatorja.
- Če pride do vstopa v perikardij ali aorto, ne pomaknite dilatatorja prek igle. Če je igla prodrla v perikardij ali aorto, jo morate izvleči. Pozorno spremljajte vitalne znake.
- Pri vlečenju predmetov iz hemostatskega ventila tulca obstaja tveganje za vdor zraka. Vdor zraka preprečite tako, da predmete izvlečete počasi, da preprečite nastajanje vakuuma v tulcu; med uvajanjem pripomočkov fluoroskopsko nadzorujte tulec glede prisotnosti zraka.
- Po uporabi je treba ta pripomoček, njegove dodatke in ovojnino ustrezno razvrstiti za odlaganje med odpadke, npr. kot biološko nevarne odpadke, ostre odpadke, nenevarne odpadke itd., ter jih varno zavreči v skladu s postopki ustanove ter veljavnimi zakoni in predpisi.
- Ena ali več komponent tega pripomočka lahko vsebuje naslednjo snov, ki je opredeljena kot CMR 1B v koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža: Kobalt: Št. Chemical Abstracts Service (CAS) 7440-48-4; št. ES 231-158-0. Trenutni znanstveni dokazi potrjujejo, da medicinski pripomočki, izdelani iz kobaltnih zlitin in zlitin nerjavnega jekla, ki vsebujejo kobalt, ne povzročajo povečanega tveganja za nastanek raka ali škodljivih učinkov na razmnoževanje.

  Ena ali več komponent tega pripomočka lahko vsebuje naslednjo snov, ki je opredeljena kot CMR 1A v koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža: Svinec: Št. Chemical Abstracts Service (CAS) 7439-92-1; št. ES 231-100-4. Trenutni znanstveni dokazi potrjujejo, da medicinski pripomočki, izdelani iz svinca, ne povzročajo povečanega tveganja za nastanek raka ali škodljivih učinkov na razmnoževanje.

Možni neželeni dogodki

Kategorija neželenega dogodka	Podkategorija neželenega dogodka
Krvavitev	Krvavitev
	Hematom
Možganska poškodba	Asimptomatska možganska embolija
	Kap/cerebrovaskularna nesreča
	Tranzitorna ishemična ataka (TIA)
Embolija	Zračna embolija
	Embolija zaradi tujka
	Pljučna embolija
	Trombembolija
	Tromboza/trombus
Perforacija srca	Tamponada srca
	Perikardialni izliv
Kardiovaskularna poškodba	Poškodbe zaklopk
	Punkcija aortne korenine
	Perforacija atrija
Poškodbe prevodnega sistema	Blokada SA-nodusa, AV-nodusa ali sistema His-Purkinje
	Srčna aritmija
Imunološka reakcija	Anafilaksa
Okužba	Perikarditis
	Endokarditis
	Pljučnica
	Sepsa
Bolečina/nelagodje	Bolečina – dimlje, prsni koš (splošna bolečina v prsih, ki ni povezana z MI)
Poškodbe perifernih žil	Disekcija
	Laceracija
	Nastanek AV-fistule
	Nastanek psevdoanevrizme
Hipotenzija	N/V
Poškodbe površinskega tkiva	N/V

Navodila

Pripravite in sestavite opremo

1. Sestavne dele vzemite iz ovojnine.

   OPOMBA: Ne sestavite tulca in dilatatorja.

2. Dilatator in tulec izperite s heparinizirano fiziološko raztopino.
3. Zaprite petelinček tulca.
4. Mandren odstranite z igle in iglo izperite s heparinizirano fiziološko raztopino.
5. Mandren vstavite v iglo in ga pritrdite na nastavek.
6. Dilatator v celoti vstavite v transseptalni tulec.

Sklop tulca/dilatatorja vstavite v zgornjo votlo veno

1. Zagotovite femoralni venski dostop (desna femoralna vena, če je možno).

   MOŽNOST: Uporabite lahko večjo (≥2,5-krat večjo velikost v Frenchih kot pri transseptalnem tulcu) standardno dolžino tulca, da zagotovite in ohranite venski dostop za zamenjavo pripomočka in hemostazo.

2. Vstavite vodilno žico premera 0,032 palca, z dolžino 150–180 cm, s 3-milimetrsko konico „J“ v zgornjo votlo veno (SVC).

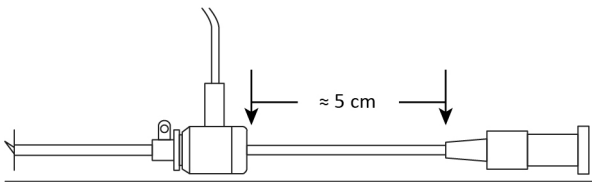
   OPOMBA: Največji premer vodilne žice, ki ga lahko uporabite z dilatatorjem, je 0,032 palca.

3. Tulec/dilatator vstavite v veno prek vodilne žice, dokler ni konica tulca v zgornji votli veni. Konico dilatatorja usmerite medialno.

Sklop igle/mandrena namestite v sklop tulca/dilatatorja

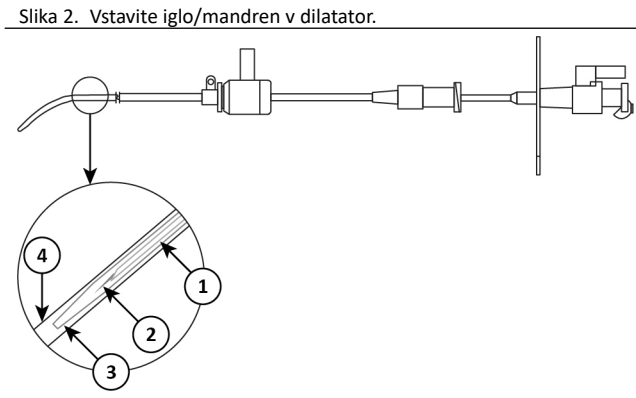
1. Vodilno žico odstranite iz dilatatorja.
2. Dilatator popolnoma aspirirajte in nato izperite s heparinizirano fiziološko raztopino.
3. Umaknite dilatator za približno 5 cm (glejte spodnjo sliko), da omogočite prehod ukrivljenega dela igle skozi toge nastavke pesta dilatatorja in tulca.

Slika 1. Umaknite dilatator



4. Mandren pritrdite na nastavek.
5. Iglo/mandren vstavite v dilatator. Iglo/mandren pomikajte naprej pod fluoroskopijo, dokler ni približno 2 cm od konice dilatatorja v tulcu (glejte spodnjo sliko).

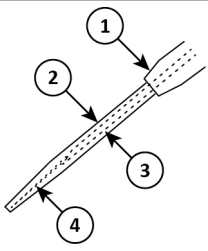
Slika 2. Vstavite iglo/mandren v dilatator.



1. Igla
2. Mandren
3. Konica dilatatorja
4. tulec

6. Ponovno spojite tulec in dilatator, tako da pod fluoroskopijo dilatator in iglo/mandren istočasno potisnete v tulec. Prepričajte se, da se položaj igle v dilatatorju ne spremeni, ko oba sestavna dela istočasno pomaknete naprej. Konico tulca držite na mestu v zgornji votli veni.
7. Pod fluoroskopijo pomikajte iglo/mandren naprej, dokler mandren ni nameščen proksimalno na konico dilatatorja (glejte spodnjo sliko).

Slika 3. Vstavite iglo/mandren



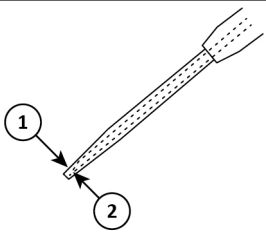
1. Konica tulca
2. Dilatator
3. Igla
4. Mandren

8. Odstranite mandren, vendar ga ne zavrzite.
9. Aspirirajte iglo, dokler ne opazite povratka krvi v brizgo. Zavrzite brizgo.

   OPOMBA: Uporaba brizge z drsno konico (ne Luer-Lok‡) lahko prepreči aspiriranje zraka.

10. Iglo izperite s heparinizirano fiziološko raztopino. Zaprite ventil.
11. Pod fluoroskopijo pomikajte iglo naprej, dokler ni konica igle proksimalno na konico dilatatorja (glejte spodnjo sliko).

Slika 4. Vstavite konico igle.



1. Konica dilatatorja
2. Konica igle

MOŽNOST: Namestite 3-potni vrtljivi petelinček na nastavek igle.

MOŽNOST: Na ventil namestite brizgo z radioneprepustnim kontrastnim sredstvom. Aspirirajte iglo. Nato pod fluoroskopskim nadzorom napolnite iglo s kontrastnim sredstvom.

MOŽNOST: Na ventil priključite cevko za spremljanje tlaka.

MOŽNOST: Uporabite standardni 3-potni razdelilnik za priključitev cevk za kontrastno sredstvo, tlak in izpiranje.

Uvedite v ovalno jamico

1. Vizualizirajte in identificirajte anatomske referenčne točke.

2. Fluoroskopsko enoto postavite pod kotom vzporedno z ravnino mitralne zaklopke in pravokotno na ravnino septuma. To običajno pomeni približno 30 do 40 stopinj levo anteriorno poševno.

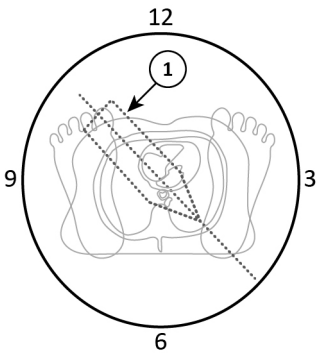
   MOŽNOST: Med elektrofizioloških postopki so lahko položaji katetra v koronarnem sinusu in Hisovem snopu koristne anatomske referenčne točke. V ustreznem levem anteriornem prečnem pogledu bo viden profil katetra v koronarnem sinusu. V ustreznem pogledu desno anteriorno poševno bo viden profil katetra v Hisovem snopu. Ovalna jamica je v ravnini ali tik pod ravnino katetra v Hisovem snopu ter je superiorno in posteriorno na ostij koronarnega sinusa.

   MOŽNOST: Namestitev zavitega angiografskega/hemodinamičnega kontrolnega katetra v nekoronarni listič aortne zaklopke je lahko koristna anatomska referenčna točka.

   MOŽNOST: Opazujte krivuljo tlaka, ki se beleži prek transseptalne igle BRK™.

3. Označevalno prirobnico namestite tako, da je igla pravokotno na ovalno jamico (običajno na položaju urnih kazalcev med 3. in 5. uro, gledano s strani stopal bolnika). (Glejte spodnjo sliko.)

Slika 5. Označevalna prirobnica igle

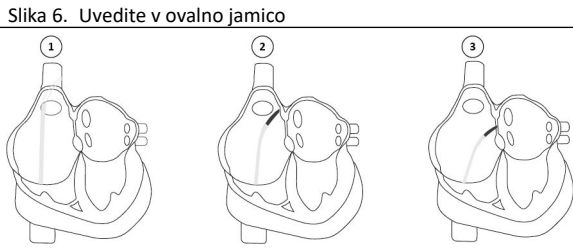


1. Označevalna prirobnica igle

4. S fluoroskopijo potrdite, da je konica igle v dilatatorju.
5. Ko potrdite, da je konica igle v dilatatorju, počasi povlecite celoten sklop tulca/dilatatorja/igle. Preprečite vsakršno medsebojno premikanje delov sklopa. Obvezno ohranite prejšnjo usmerjenost označevalne prirobnice, ko vlečete sklop.
6. V pogledu levo anteriorno poševno (pravokotno na interatrijski septum) opazujte, ali se konica dilatatorja med vlečenjem nenadoma premakne medialno (ali v desno), saj to pomeni, da je konica zašla v ovalno jamico. (Glejte spodnje slike.)

   OPOMBA: Če je ovalna jamica prehodna za sondo, se bo konica dilatatorja zlahka pomaknila v levi atrij.

Slika 6. Uvedite v ovalno jamico



1. Začetni položaj v zgornji votli veni
2. Začetni medialni premik v desni atrij
3. Nenaden medialni premik na ovalno jamico

OPOMBA: Če tlak spremljate prek igle, tlak prek igle na tej točki ni pravilno prikazan, saj je konica ob ovalni jamici.

Punktirajte ovalno jamico s transseptalno iglo BRK™

1. Pred pomikanjem igle potrdite pravilen položaj sklopa tulca/dilatatorja/igle na ovalni jamici.
2. Ko potrdite pravilni položaj, iglo v celoti potisnite v sklop tulca/dilatatorja in jo pomaknite prek interatrijskega septuma.

   MOŽNOST: Pri spremljanju tlaka je vstop v levi atrij potrjen, ko merilnik tlaka pokaže krivuljo tlaka levega atrija.

   MOŽNOST: Vstop v levi atrij lahko potrdite fluoroskopsko z injiciranjem kontrastnega sredstva.

3. Če začutite upor med pomikanjem igle, iglo povlecite nazaj in ponovno ocenite anatomske referenčne točke.

   SVARILO: Če pride do vstopa v perikardij ali aorto, ne pomaknite dilatatorja prek igle. Če je igla prodrla v perikardij ali aorto, jo morate izvleči. Pozorno spremljajte vitalne znake.

Pomaknite sklop tulca/dilatatorja v levi atrij

Ohranjajte fiksen položaj igle v levem preddvoru in celoten sklop tulca/dilatatorja pomaknite prek igle v votlino levega preddvora.

Potisnite tulec prek fiksiranega dilatatorja in igle v levi atrij

1. Ohranite položaj igle in dilatatorja nad septumom.
2. Dilatator zadržite na fiksnem mestu in tulec v celoti pomaknite prek dilatatorja v votlino levega atrija.

Izvlecite transseptalno iglo BRK™ in dilatator

SVARILO: Pri vlečenju predmetov iz hemostatskega ventila tulca obstaja tveganje za vdor zraka. Vdor zraka preprečite tako, da predmete izvlečete počasi, da preprečite nastajanje vakuuma v tulcu; med uvajanjem pripomočkov fluoroskopsko nadzorujte tulec glede prisotnosti zraka.

1. Zaprite petelinček igle in izklopite vse priključke iz nastavka igle.
2. Izvlecite transseptalno iglo BRK™ in dilatator. Iglo lahko očistite in shranite za ponovno uporabo pri tem posegu. V nasprotnem primeru iglo zavrzite v skladu z ustreznim postopkom za kontaminirane ostre predmete.
3. Takoj pritrdite brizgo na dilatator in aspirirajte. Nadaljujte z aspiriranjem krvi, obenem pa držite tulec na mestu in izvlecite dilatator. Kri mora biti arterijska.
4. Po odstranitvi dilatatorja aspirirajte kri skozi stranski del tulca. Previdno sperite stranski del tulca s heparinizirano fiziološko raztopino, da odstranite zračne mehurčke.
5. Tulec je zdaj nameščen v levem atriju.

Embalaža in življenjska doba

Transseptalne igle BRK™ so dobavljene sterilne. Igla je pakirana z vstavljenim mandrenom. Igla in mandren sta v primarni ovojnini. Primarna ovojnina je spravljena v vrečki Mylar‡ in Tyvek‡, ki je toplotno zatesnjena. Vrečka in ta navodila za uporabo so vstavljena v škatlo, ki je zatesnjena na obeh straneh. Vrečka in škatla sta opremljeni z oznako s podatki o izdelku, vključno z

datumom izteka roka uporabnosti. Izdelki so označeni z rokom uporabnosti tri leta.

Povzetek kliničnih podatkov

Za države Evropske unije: Priglašeni organi bodo v skladu z zahtevami EU MDR 2017/745 in povezanimi roki objavili povzetek varnostnega in kliničnega delovanja (SSCP) za te pripomočke na spletni strani https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Poiščite pripomoček prek navedenega UDI-DI na zunanji ovojnini tega pripomočka. UDI-DI je štirinajstmestna številka med prvima dvema nizoma oklepajev. Podrobnejše informacije o iskanju in uporabi UDI-DI najdete v dokumentu s pogosto zastavljenimi vprašanji na naslovu medical.abbott/manuals.

Poročanje o pomembnih dogodkih

Če med uporabo pripomočka pride do dogodka, za katerega utemeljeno menite, da je pomemben, o tem obvestite proizvajalca. Stranke v Evropski uniji morajo o resnih dogodkih poleg proizvajalca obvestiti tudi pristojni nacionalni organ.

Omejena garancija

Družba Abbott Medical jamči, da izdelek nima napak v materialu in izdelavi, ki bi se pokazale pri normalni uporabi. Ta garancija ne velja po datumu „poteka roka uporabnosti“, ki je naveden na oznaki izdelka. Dovoljena uporaba in odobreni načini uporabe za vsak naš izdelek sta navedena v ustreznih „navodilih za uporabo“, ki so priložena posameznemu izdelku. Družba Abbott Medical zavrača kakršno koli odgovornost in jamstvo za svoje izdelke, če se ne uporabljajo na dovoljen oziroma odobren način. Odgovornost družbe Abbott Medical je v okviru te garancije omejena na zamenjavo izdelka. Ta garancija izključuje in nadomešča vsa ostala jamstva, izrecna ali posredna, kar vključuje, vendar ni omejeno na morebitna posredna jamstva glede primernosti za prodajo ali ustreznosti za določen namen. Družba Abbott Medical zavrača kakršno koli odgovornost za kakršno koli nenamerno ali posledično škodo, poškodbo ali stroške, ki so neposredna ali posredna posledica uporabe tega izdelka, razen kot je izrecno določeno z ustreznim zakonom. Družba Abbott Medical ne prevzema druge ali dodatne odgovornosti za izgubo, škodo ali stroške v povezavi s tem izdelkom, prav tako za to ne pooblašča nobene tretje osebe. Več informacij najdete v celotni garancijski izjavi družbe Abbott Medical, ki je na voljo pri družbi Abbott Medical ali na hrbtni strani računa družbe Abbott Medical.

Simboli

Na izdelku ali nalepki izdelka so lahko naslednji simboli in usklajeni simboli. V zvezi z usklajenimi simboli glejte Universal Symbols Glossary (Glosar univerzalnih simbolov) na naslovu medical.abbott/manuals.

Simbol	Opredelitev
Series	Serija
Contents	Kazalo vsebine
Transseptal Needle	Transseptalna igla
	Sistem z enojno sterilno pregrado
	Dolžina
	SVARILO: Zvezni zakon (ZDA) omejuje prodajo tega pripomočka samo na zdravnika ali po njegovem naročilu.
CE 2797	Conformité Européenne (evropska skladnost). Dodano v skladu z Uredbo Evropskega sveta št. 2017/745. Družba Abbott Medical s tem izjavlja, da je ta pripomoček skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami te uredbe.
	Uvoznik
UK CA 0086	Ocena skladnosti za Združeno kraljestvo
UKRP	Odgovorna oseba v Združenem kraljestvu
UA.TR.101	Ukrajinska oznaka skladnosti s tehničnimi predpisi, kjer številka 101 predstavlja organ za ugotavljanje skladnosti.
MD	Medicinski pripomoček
UDI	Enolična identifikacija pripomočka
medical.abbott/manuals	Upoštevajte navodila za uporabo na tem spletnem mestu
(7440-48-4) (7439-92-1)	Vsebuje nevarne snovi. (Kobalt, št. CAS 7440-48-4) (Svinec, št. CAS 7439-92-1)

SR: Srpski

BRK™ Transseptalna igla

Uputstvo za upotrebu

Opis

BRK™ transseptalna igla se sastoji od šuplje igle od nerđajućeg čelika i čvrstog stileta od nerđajućeg čelika. Distalni vrh igle je savijen kako bi se olakšalo njeno postavljanje u srce kada se koristi sa kompletom transseptalnih uvodnika kompanije Abbott Medical. Na savijenom delu postoji jedan strmi ispust na spoljašnjem prečniku igle koji se uklapa sa unutrašnjim prečnikom dilatatora kompleta transseptalnih uvodnika kompanije Abbott Medical. Distalni vrh igle je zakošen kako bi se olakšao postupak punkcije. Proksimalni vrh igle se konfiguriše obrubnicom pokazivača igle (koja pokazuje usmerenje distalnog zavoja) i na njemu se nalazi dvostrani ventil koji obezbeđuje pristup lumenu igle radi aspiracije, ubrizgavanja/infuzije tečnosti, uzimanja uzoraka krvi, nadzora pritiska i umetanja stileta i/ili žice vodilice (za iglu broj 18 maksimalni prečnik žice vodilice je 0,014 inča, a za iglu broj 19 maksimalni prečnik žice vodilice je 0,012 inča). Stilet je ravan i izodijametričan po svojoj dužini. Na proksimalnom kraju stileta nalazi se savijena spojnica za zaključavanje stileta na proksimalno čvorište igle po umetanju u lumen igle. Stilet je projektovan tako da olakša uvođenje igle kroz dilatator. Na raspolaganju su igle sa različitim korisnim dužinama i različitim konfiguracijama distalnog zavoja.

Namena

BRK™ transseptalna igla se koristi za punkciju međupretkomorskog septuma kako bi se omogućio pristup levoj strani srca.

Indikacije za upotrebu

BRK™ transseptalna igla se koristi za punkciju međupretkomorskog septuma tokom procedure transseptalne kateterizacije kako bi se omogućio pristup levoj strani srca.

Ciljna grupa pacijenata

BRK™ transseptalna igla je namenjena za upotrebu kod hemodinamički stabilnih pacijenata kojima je potreban pristup levom srčanom kateteru. Upotreba BRK™ transseptalne igle može zahtevati posebna razmatranja kod pacijenata sa sledećim stanjima:

- Rotirano srce,
- Uvećan koren aorte,
- Označeno uvećanje desne pretkomore,
- Skolioza/skifoza,
- Abnormalna geometrija leve pretkomore,
- Urođene mane,
- Vaskularne mane,
- Nemogućnost pristupa desnoj pretkomori kroz donju šuplju venu.

Predviđeni korisnik

Ovo sredstvo treba da koriste isključivo lekari koji su posebno obučeni za transseptalne procedure, u kompletno opremljenoj operativnoj elektrofiziološkoj laboratoriji.

Kliničke koristi

Predviđena klinička korist BRK™ transseptalne igle je punkcija međupretkomorskog septuma tokom procedure transseptalne kateterizacije kako bi se omogućio pristup levoj strani srca da bi se omogućilo sredstvima koja zahtevaju endokardijalni levi srčani pristup da postignu predviđenu kliničku korist, kao što je kateter za ablaciju. Ovo se meri uspešnom punkcijom međupretkomorskog septuma.

Kontraindikacije

- Prethodno postavljena međupretkomorska septalna zakrpa ili protetički uređaj za zatvaranje atrijalnog septalnog defekta.
- Svi prethodni tromboembolijski događaji.
- Poznati ili suspektni miksom leve pretkomore.
- Poznati ili suspektni infarkt miokarda tokom prethodne dve nedelje.
- Nestabilna angina.
- Nedavni cerebrovaskularni akcident (CVA).
- Pacijenti koji ne tolerišu antikoagulacionu terapiju.
- Pacijenti sa aktivnom infekcijom.

Upozorenja

- Nemojte praviti nikakve izmene na ovom medicinskom sredstvu.
- Ovo medicinsko sredstvo je predviđeno samo za jednokratnu upotrebu; nemojte ga ponovo obrađivati ili ponovo koristiti. Uzmite u obzir datum na pakovanju „Use by" (Rok upotrebe). Svaki pokušaj ponovne sterilizacije i ponovne upotrebe ovog sistema može ugroziti njegovu celovitost. Neželjena dejstva usled korišćenja nesterilnih komponenti mogu da obuhvataju, ali nisu ograničena na sledeće:
  - Lokalna i sistemska infekcija ili reakcija,
  - Mehaničko oštećenje,
  - Neprecizno funkcionisanje.
- Materijali proizvoda navedeni u nastavku mogu izazvati alergijsku reakciju ili reakciju hiperosetljivosti. Osobe alergične na te materijale mogu imati alergijsku reakciju na proizvod. Pre upotrebe na pacijentu pacijenta treba uputiti na materijale sadržane u medicinskom sredstvu i mora se uzeti temeljna anamneza o alergijama:
  - Nerđajući čelik,
  - Epoksi adheziv,
  - Niklovani hromirani mesing,
  - Visoka vakuum silikonska mast (Dupont),
  - Master Bond.
- Pogrešna upotreba ovog medicinskog sredstva može da dovede do ozbiljnih komplikacija.
- Kod pacijenata i laboratorijskog osoblja, usled intenziteta snopa rendgenskog zračenja tokom trajanja fluoroskopskog snimanja, pri postupcima srčane kateterizacije postoji velika mogućnost od značajnog izlaganja rendgenskim zracima, koji mogu da izazovu akutnu povredu izazvanu zračenjem, kao i povećan rizik od somatskih i genetskih dejstava. Pažljivo razmotrite upotrebu ovog medicinskog sredstva kod trudnica.

Mere opreza

- Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog medicinskog sredstva na prodaju od strane ili po nalogu lekara.
- Pre korišćenja pročitajte uputstvo.
- Proverite pakovanje pre upotrebe. Ne koristite ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno.
- Pre upotrebe vizuelno proverite sve komponente.
- Čuvajte na hladnom, tamnom i suvom mestu.

- Pre procedure, pacijent mora da bude hemodinamički stabilan. Izvesna stanja pacijenta mogu da zahtevaju posebna razmatranja pre korišćenja ovog proizvoda. To može da obuhvata, ali nije ograničeno na sledeće:
  - Rotirano srce,
  - Uvećan koren aorte,
  - Označeno uvećanje desne pretkomore,
  - Skolioza/skifoza,
  - Abnormalna geometrija leve pretkomore,
  - Urođene mane,
  - Vaskularne mane,
  - Nemogućnost pristupa desnoj pretkomori kroz donju šuplju venu
- Ovo sredstvo treba da koriste isključivo lekari koji su posebno obučeni za transseptalne procedure, u kompletno opremljenoj operativnoj elektrofiziološkoj (EP) laboratoriji.
- Uvođenje katetera mora da se izvede uz fluoroskopsko navođenje da bi se rizik od oštećenja, perforacije ili tamponade srca sveo na minimum. Kompatibilni sistemi za navigaciju i vizuelizaciju u realnom vremenu takođe se mogu razmotriti.
- Tokom umetanja obratite pažnju da ne dođe do preteranog otpora dok se vrh igle uvlači kroz krivinu sklopa obloge i dilatatora. Ako postoji bilo kakav otpor prilikom uvođenja igle, izvucite iglu i proverite komponente.
- Tokom umetanja vodite računa da ne savijate medicinsko sredstvo prekomerno. To može da onemogući napredovanje igle i može da dovede do neželjenog probijanja sklopa dilatatora i obloge.
- Tokom uvođenja uvek koristite stilet za olakšavanje prolaza igle kroz sklop dilatatora i obloge. Nekorišćenje stileta može da onemogući napredovanje igle i da dovede do neželjenog probijanja sklopa dilatatora i obloge iglom ili do ljuštenja materijala sa unutrašnje površine dilatatora.
- Ukoliko dođe do ulaska u perikard ili aortu, ne uvodite dilatator preko igle. Ukoliko je igla prodrla u perikard ili aortu, morate je izvući. Pažljivo pratite vitalne znake.
- Postoji rizik od prodora vazduha prilikom vađenja predmeta iz hemostatskog ventila obloge. Preduzmite mere predostrožnosti za sprečavanje prodora vazduha laganim izvlačenjem predmeta kako bi se sprečilo stvaranje vakuuma u oblozi i fluoroskopski pratite oblogu tokom narednog umetanja medicinskog sredstva radi utvrđivanja prisustva vazduha.
- Ovo sredstvo, njegova prateća oprema i pakovanje nakon upotrebe moraju da se klasifikuju za otpad na odgovarajući način, npr. kao biološki opasni, oštri ili bezopasni otpad, kao i da se pažljivo odlože u otpad u skladu sa procedurama ustanove i važećim zakonima i propisima.
- Neke komponente ovog medicinskog sredstva mogu da sadrže sledeću supstancu koja je definisana kao CMR 1B u koncentraciji od 0,1% težinskog procenta: Kobalt: Služba hemijskih apstrakata (eng. Chemical Abstracts Service, CAS) br. 7440-48-4; EC br. 231-158-0. Postojeći naučni dokazi podržavaju teoriju da medicinski uređaji napravljeni od legura kobalta i legura nerđajućeg čelika koje sadrže kobalt ne dovode do povećanog rizika od raka ili neželjenih dejstava po reproduktivni sistem.

  Neke komponente ovog medicinskog sredstva mogu da sadrže sledeću supstancu koja je definisana kao CMR 1A u koncentraciji od 0,1% težinskog procenta: Olovo: Služba hemijskih apstrakata (eng. Chemical Abstracts Service, CAS) br. 7439-92-1; EC br. 231-100-4. Trenutni naučni dokazi podržavaju teoriju da medicinska sredstva proizvedena od olova ne dovode do povećanog rizika od raka ili neželjenih dejstava po reproduktivni sistem.

Potencijalni neželjeni događaji

Kategorija neželjenih događaja	Potkategorija neželjenih događaja
Krvarenje	Hemoragija/krvarenje
	Hematom
Cerebralna povreda	Asimptomatska cerebralna embolija
	Moždani udar/cerebrovaskularni insult
	Prolazni ishemijski napad (TIA)
Embolija	Vazdušna embolija
	Embolija stranog tela
	Plućna embolija
	Tromboembolija
	Tromboza/tromb
Perforacija srca	Tamponada srca
	Perikardni izliv
Kardiovaskularna povreda	Oštećenje zalistaka
	Punkcija korena aorte
	Perforacija pretkomore
Smetnja provodnog sistema	Blokiranje SA čvora, AV čvora ili sistema Hisovog snopa i Purkinjeovih vlakana
	Srčana aritmija
Imunološka reakcija	Anafilaksa
Infekcija	Perikarditis
	Endokarditis
	Upala pluća
	Sepsa
Bol/nelagodnost	Bol u preponama i grudima (opšti bol u grudima koji nije povezan sa MI)
Periferna vaskularna povreda	Disekcija
	Cepanje
	Formiranje arteriovenske fistule
	Formiranje pseudoaneurizme
Hipotenzija	Nije primenljivo
Površinska povreda tkiva	Nije primenljivo

Uputstvo

Priprema i sklapanje opreme

1. Izvadite sadržaj iz pakovanja.

   NAPOMENA: Nemojte sklapati oblogu i dilatator.

2. Isperite dilatator i oblogu heparinizovanim fiziološkim rastvorom.
3. Zatvorite sigurnosni ventil obloge.
4. Skinite stilet sa igle i isperite iglu heparinizovanim fiziološkim rastvorom.
5. Umetnite stilet u iglu i zaključajte ga na čvorištu.

6. Uvedite dilatator u celosti u transseptalnu oblogu.

Uvođenje sklopa obloge i dilatatora u gornju šuplju venu

1. Ostvarite pristup preko femoralne vene (po mogućnosti desne femoralne vene).

   Opcija: Obloga veće dužine od standardne (≥2,5 francuske veličine veće od transseptalne obloge) može da se koristi za ostvarivanje i održavanje venskog pristupa za izmenu medicinskog sredstva i hemostazu.

2. Uvedite žicu vodilicu od 0,032 inča, 150 – 180 cm, 3 mm sa „J" vrhom u gornju šuplju venu (SVC).

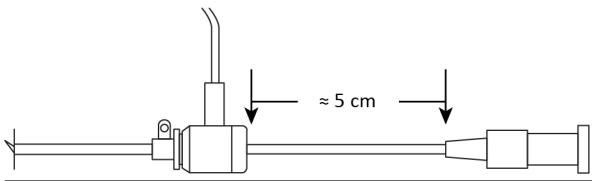
   NAPOMENA: 0,032 inča je maksimalan prečnik žice vodilice koji može da se koristi uz ovaj dilatator.

3. Uvedite sklop obloge i dilatatora u venu preko žice vodilice i uvodite ga sve dok vrh obloge ne dospe u SVC. Vrh dilatatora usmerite medijalno.

Postavljanje sklopa igle i stileta unutar sklopa obloge i dilatatora

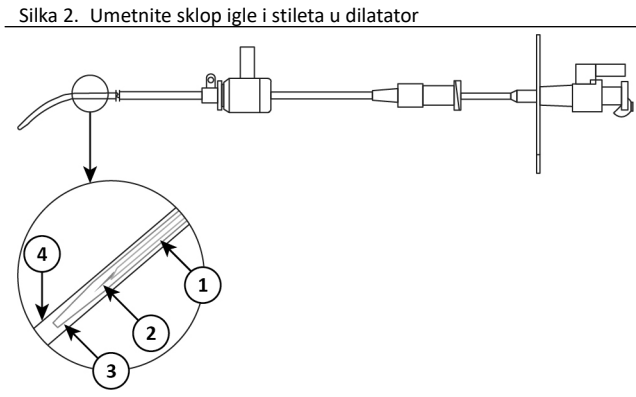
1. Izvadite žicu vodilicu iz dilatatora.
2. Aspirirajte u potpunosti i zatim isperite dilatator heparinizovanim fiziološkim rastvorom.
3. Izvucite dilatator oko 5 cm (videti sliku u nastavku) da biste olakšali prolaz krive igle kroz kruta čvorišta dilatatora i obloge.

Silka 1. Izvlačenje dilatatora



4. Zaključajte stilet na čvorište.
5. Umetnite sklop igle i stileta u dilatator. Uvodite sklop igle i stileta pod fluoroskopijom dok se vrh dilatatora ne nađe oko 2 cm unutar obloge (videti sliku u nastavku).

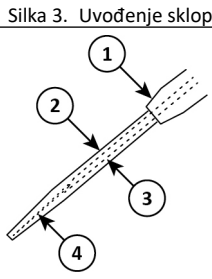
Silka 2. Umetnite sklop igle i stileta u dilatator



1. Igla
2. Sonda
3. Vrh dilatatora
4. Omotač

6. Da biste ponovo povezali oblogu i dilatator uvucite dilatator i sklop igle i stileta istovremeno u oblogu pod fluoroskopijom. Osigurajte da se položaj igle unutar dilatatora ne menja jer se obe komponente uvlače zajedno. Održavajte položaj vrha obloge u SVC.
7. Pod fluoroskopijom, uvodite sklop igle i stileta dok se stilet ne nađe proksimalno od vrha dilatatora (videti sliku u nastavku).

Silka 3. Uvođenje sklopa igle i stileta



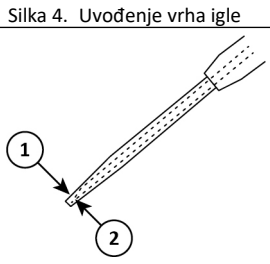
1. Vrh obloge
2. Dilatator
3. Igla
4. Sonda

8. Uklonite stilet ali ga nemojte odlagati u otpad.
9. Aspirirajte iglu dok se ne uoči povratni tok krvi. Bacite špric.

   NAPOMENA: Upotreba šprica sa kliznim vrhom (koji nije Luer-Lok‡) može da spreči aspiraciju vazduha.

10. Isperite iglu heparinizovanim fiziološkim rastvorom. Zatvorite ventil.
11. Uvodite iglu pod fluoroskopijom dok se vrh igle ne nađe proksimalno od dilatatora (videti sliku u nastavku).

Silka 4. Uvođenje vrha igle



1. Vrh dilatatora
2. Vrh igle

Opcija: Pričvrstite trostrani obrtni ventil na čvorište igle.

Opcija: Priključite špric sa radionepropusnim kontrastnim sredstvom na ventil. Aspirirajte iglu. Zatim napunite iglu kontrastnim sredstvom pod fluoroskopskim navođenjem.

Opcija: Priključite vod za nadzor pritiska na ventil.

Opcija: Koristite standardnu granu sa tri priključka za priključenje vodova za kontrast, pritisak i ispiranje.

Uvođenje u ovalnu jamu

1. Uočite i identifikujte anatomske orijentire.

2. Postavite uređaj za fluoroskopiju pod uglom, paralelno sa ravni mitralnog zaliska i pod pravim uglom u odnosu na ravan septuma. To je obično pod uglom od 30 do 40 stepeni u odnosu na levi prednji bočni (LAO) prikaz.

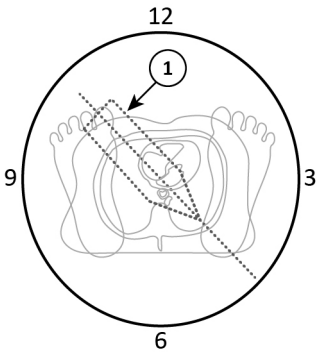
   Opcija: Tokom elektrofizioloških (EP) procedura, položaji katetera u koronarnom sinusu i u His sistemu mogu da služe kao korisni anatomski orijentiri. Na odgovarajućem LAO prikazu kateter u koronarnom sinusu će biti prikazan iz profila. Na odgovarajućem desnom prednjem bočnom (RAO) prikazu kateter u His sistemu će biti prikazan iz profila. Ovalna jama se nalazi u ravni ili malo ispod katetera u His sistemu i iznad i iza ušća koronarnog sinusa.

   Opcija: Postavljanjem zavijenog angiografskog/hemodinamičkog katetera za praćenje u nekoronarni vrh aortnog zaliska može da se dobije koristan anatomski orijentir.

   Opcija: Pratite talasni oblik pritiska koji se beleži preko BRK™ transseptalne igle.

3. Prilagodite obrubnicu pokazivača tako da igla bude u upravnom položaju u odnosu na ovalnu jamu (obično u položaju između 3 i 5 sati na časovniku, kada se posmatra od strane stopala pacijenta). (Videti sliku u nastavku.)

Silka 5. Obrubnica pokazivača igle



1. Obrubnica pokazivača igle

4. Fluoroskopijom se uverite da je vrh igle unutar dilatatora.
5. Nakon potvrde da se vrh igle nalazi u dilatatoru, polako povucite ceo sklop obloge, dilatatora i igle. Sprečite svako međusobno pomeranje delova sklopa. Od presudne je važnosti da se održi prethodna orijentacija obrubnice pokazivača tokom povlačenja sklopa.
6. Na LAO prikazu (pod pravim uglom u odnosu na međupretkomorski septum) pratite vrh dilatatora tokom povlačenja kako biste uočili bilo kakvo naglo pomeranje medijalno (ili udesno), jer ono ukazuje na to da je vrh ušao u ovalnu jamu. (Videti slike u nastavku.)

   NAPOMENA: Ako je ovalna jama prohodna za sondu, vrh dilatatora će sada lako preći u levu pretkomoru.

Silka 6. Uvođenje u ovalnu jamu



1. Početni položaj u gornjoj šupljoj veni
2. Prvo medijalno pomeranje u desnoj pretkomori
3. Naglo medijalno pomeranje u ovalnu jamu

NAPOMENA: Ako se pritisak prati preko igle, pritisak preko igle u ovom trenutku nije tačan jer se vrh nalazi u ovalnoj jami.

Obavite punkciju ovalne jame BRK™ transseptalnom iglom

1. Proverite pravilnost položaja sklopa obloge, dilatatora i igle na ovalnoj jami pre uvođenja igle.
2. Nakon što se ispravnost položaja potvrdi, uvedite iglu do kraja kroz sklop obloge i dilatatora i dalje kroz međupretkomorski septum.

   Opcija: Kada se obavlja nadzor pritiska, ulazak u levu pretkomoru je potvrđen kada praćenje pritiska pokaže talasni oblik pritiska leve pretkomore.

   Opcija: Pristup levoj pretkomori može da se potvrdi pod fluoroskopijom uz ubrizgavanje kontrastnog sredstva.

3. Ako postoji bilo kakav otpor prilikom uvođenja igle, izvucite iglu i ponovo procenite anatomske orijentire.

   OPREZ: Ukoliko dođe do ulaska u perikard ili aortu, ne uvodite dilatator preko igle. Ukoliko je igla prodrla u perikard ili aortu, morate je izvući. Pažljivo pratite vitalne znake.

Uvođenje sklopa obloge i dilatatora u levu pretkomoru

Uz zadržavanje nepomičnog položaja igle u levoj pretkomori, uvedite sklop obloge i dilatatora do kraja preko igle u šupljinu leve pretkomore.

Uvedite oblogu preko nepomičnog dilatatora i igle u levu pretkomoru

1. Zadržite položaj igle i dilatatora iznad septuma.
2. Uz zadržavanje dilatatora u nepomičnom položaju, uvedite oblogu do kraja preko dilatatora u šupljinu leve pretkomore.

Izvlačenje BRK™ transseptalne igle i dilatatora

OPREZ: Postoji rizik od prodora vazduha prilikom vađenja predmeta iz hemostatskog ventila obloge. Preduzmite mere predostrožnosti za sprečavanje prodora vazduha laganim izvlačenjem predmeta kako bi se sprečilo stvaranje vakuuma u oblozi i fluoroskopski pratite oblogu tokom narednog umetanja medicinskog sredstva radi utvrđivanja prisustva vazduha.

1. Okrenite ventil na igli u zatvoren položaj i odvojte sve priključke sa čvorišta igle.
2. Izvadite BRK™ transseptalnu iglu iz dilatatora. Igla može da se očisti i odloži za ponovnu upotrebu u okviru ove procedure. U suprotnom, bacite iglu na način koji je predviđen za kontaminirane oštre predmete.
3. Odmah priključite špric na dilatator i aspirirajte. Nastavite sa aspiriranjem krvi uz držanje obloge na mestu i izvlačenje dilatatora. Krv treba da bude arterijska.
4. Nakon što se dilatator ukloni, aspirirajte krv kroz bočni krak obloge. Pažljivo isperite bočni deo obloge heparinizovanim fiziološkim rastvorom da biste izbegli mehuriće vazduha.
5. Obloga se sada nalazi na svom mestu u levoj pretkomori.

Pakovanje i rok upotrebe

BRK™ transseptalna igla se isporučuje u sterilnom stanju. Uz iglu je zapakovan stilet. Igla i stilet su postavljeni u glavno pakovanje. Glavno pakovanje je postavljeno u vrećicu Mylar‡ i Tyvek‡ koja je termički zaptivena. Vrećica i ovo uputstvo za upotrebu su zatim postavljeni u kutiju, koja je zaptivena sa oba kraja. Na vrećici i kutiji se nalazi nalepnica sa informacijama o proizvodu, uključujući i rok upotrebe. Proizvodi imaju rok trajanja od tri godine.

Sažetak kliničkih podataka

Za zemlje u Evropskoj uniji: Sažetak bezbednosnih i kliničkih performansi (eng. Summary of the safety and clinical performance, SSCP) za ova medicinska sredstva biće objavljena na adresi https://ec.europa.eu/tools/eudamed od strane prijavljenih tela u skladu sa zahtevima odredbe EU MDR 2017/745 i povezanim rokovima. Medicinsko sredstvo potražite pomoću broja UDI-DI koji je naveden na spoljnom pakovanju medicinskog sredstva. Broj UDI-DI je 14-cifreni broj između prva dva skupa zagrada. Pogledajte dokument o najčešće postavljanim pitanjima koji se može pronaći na adresi medical.abbott/manuals za više informacija o tome kako da pronađete UDI-DI broj.

Prijavljivanje incidenata

Ako tokom korišćenja ovog medicinskog sredstva imate razloga da verujete da je došlo do ozbiljnog incidenta, prijavite to proizvođaču. Kupci u Evropskoj uniji ozbiljan incident treba da prijave nacionalnom organu i proizvođaču.

Ograničena garancija

Abbott Medical garantuje da proizvod neće imati oštećenja u materijalu i izradu uz normalno korišćenje. Ova garancija važi do datuma „Expiration" (Rok trajanja) navedenog na nalepnici proizvoda. Ovlašćene upotrebe i odobrene metode korišćenja svakog našeg proizvoda navedene su u odgovarajućem „Uputstvu za upotrebu" koje se dobija uz svaki proizvod. Abbott Medical se odriče svih odgovornosti i obaveza ako se proizvodi koriste na način koji nije ovlašćen ili odobren. Obaveza kompanije Abbott Medical ovom garancijom je ograničena na zamenu proizvoda. Gorenavedena garancija isključuje sve druge garancije, bilo izričite ili podrazumevane, koje obuhvataju, između ostalog, sve podrazumevane garancije komercijalnosti ili podesnosti za određenu namenu. Abbott Medical se odriče svake odgovornosti za slučajne ili posledične gubitke, oštećenja ili trošak do kojih je došlo direktno ili indirektno zbog korišćenja ovog proizvoda, ako nije drugačije određeno odgovarajućim zakonom. Kompanija Abbott Medical ne prihvata niti ovlašćuje neku drugu osobu da prihvati umesto nje bilo koju drugu dodatnu obavezu za gubitak, oštećenje ili trošak u vezi sa ovim medicinskim sredstvom. Više detalja potražite u kompletnoj Abbott Medical garanciji koju možete da dobijete od kompanije Abbott Medical ili na poleđini Abbott Medical fakture.

Simboli

Simboli u nastavku i harmonizovani simboli se mogu naći na proizvodu ili na nalepnici proizvoda. Kada su u pitanju harmonizovani simboli, pogledajte rečnik univerzalnih simbola na medical.abbott/manuals.

Simbol	Definicija
Series	Serije
Contents	Sadržaj
Transseptal Needle	Transseptalna igla
	Sistem jednostruke sterilne barijere
	Dužina
Rx ONLY	OPREZ: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog medicinskog sredstva na prodaju od strane ili po nalogu lekara.
CE 2797	Conformité Européenne (Evropska saobraznost). Dodato u skladu sa Uredbom Evropskog saveta 2017/745. Kompanija Abbott Medical ovim izjavljuje da je ovo medicinsko sredstvo usklađeno sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama ove uredbe.
	Uvoznik
UK CA 0086	Ocenjena usaglašenost za Ujedinjeno Kraljevstvo
UKRP	Odgovorna osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu
UA.TR.101	Ukrajinski znak za usaglašenost sa tehničkim propisima, pri čemu 101 predstavlja telo koje vrši procenu.
MD	Medicinsko sredstvo
UDI	Jedinstveni identifikacioni broj medicinskog sredstva
medical.abbott/manuals	Pridržavajte se uputstva za upotrebu koje je navedeno na ovom veb-sajtu
(7440-48-4) (7439-92-1)	Sadrži opasne supstance. (Kobalt CAS br. 7440-48-4) (Olovo CAS br. 7439-92-1)

SV: Svenska

BRK™ Transseptal nål

Bruksanvisning

Beskrivning

BRK™ transseptal nål består av en luminalnål i rostfritt stål och en mandräng i rostfritt stål. Nålens distala del är böjd för att underlätta positioneringen i hjärtat när den används med ett set med transseptala hylsor från Abbott Medical. På den böjda delen finns det en tvär avsmalning i nålens ytterdiameter för att den ska passa in i innerdiametern på en dilatator från ett set med transseptala hylsor från Abbott Medical. Nålens distala spets är avfasad för att underlätta punktionsprocessen. Nålens proximala ände är konfigurerad med en pekfläns (som visar den distala böjningens riktning) och är utrustad med en tvåvägskran för att ge åtkomst till nålens lumen för aspiration, injektion/infusion av vätska, blodprovstagning, övervakning av tryck och införing av mandräng och/eller ledare (ledarens diameter får högst vara 0,35 mm för en 18 gauge-nål och högst 0,30 mm för en 19 gauge-nål). Mandrängen är rak och har samma diameter genom hela dess längd. Mandrängens proximala ände är utrustad med en böjd klämma så att den kan fästas i det proximala nålnavet när den förs in i nålens lumen. Mandrängen är utformad för att underlätta framförandet av nålen inuti dilatatorn. Nålen finns tillgänglig i olika längder och konfigurationer av den distala böjningen.

Avsett ändamål

BRK™ transseptal nål är avsedd att användas för att punktera förmaksseptumet för att få åtkomst till hjärtats vänstra del.

Indikationer för användning

BRK™ transseptal nål används för att punktera förmaksseptumet under en transseptal kateteriseringsprocedur i syfte att få åtkomst till hjärtats vänstra del.

Patientmålgrupp

BRK™ transseptal nål är avsedd att användas på hemodynamiskt stabila patienter för vilka åtkomst till vänstersidig hjärtkateter krävs. Hos patienter med följande tillstånd kan särskilda överväganden krävas för användning av BRK™ transseptal nål:

- Vridet hjärta
- Förstorad aortarot
- Märkbar förstoring av höger förmak
- Skolios/kyfos
- Ovanlig form på vänster förmak
- Medfödda missbildningar
- Kärlmissbildningar
- Oåtkomligt höger förmak genom vena cava inferior.

Avsedd användare

Denna enhet ska endast användas av läkare som är speciellt utbildade i transseptala procedurer, i ett fullt utrustat och fungerande elektrofysiologiskt laboratorium.

Klinisk nytta

Den avsedda kliniska fördelen med BRK™ transseptal nål är att punktera förmaksseptumet under en transseptal kateteriseringsprocedur för att få åtkomst till hjärtats vänstra del i syfte att göra det möjligt att uppnå de avsedda kliniska fördelarna med enheter som kräver vänstersidig endokardiell åtkomst till hjärtat, till exempel en ablationskateter. Detta mäts genom framgångsrik punktering av förmaksseptumet.

Kontraindikationer

- Enhet för föregående patch i förmaksseptum eller protetisk tillslutning av förmaksseptumdefekt.
- Eventuella tidigare tromboemboliska händelser.
- Känt eller misstänkt vänster förmaksmyxom.
- Känd eller misstänkt hjärtinfarkt under de senaste två veckorna.
- Instabil angina.
- Nyligen inträffad cerebrovaskulär händelse (stroke/TIA).
- Patienter som inte tolererar antikoagulationsbehandling.
- Patienter med en pågående infektion.

Varningar

- Enheten får inte ändras på något sätt.
- Denna enhet är endast avsedd för engångsbruk, den får inte omsteriliseras eller återanvändas. Observera produktens utgångsdatum (”Use by”) på förpackningen. Eventuella försök till omsterilisering och återanvändning av detta system kan skada det. Biverkningar från användning av icke-sterila komponenter kan innefatta, men är inte begränsade till
  - Lokal och systemisk infektion eller reaktion
  - Mekanisk skada
  - Felaktig funktionalitet.
- Materialen som anges nedan för produkten kan orsaka allergiska reaktioner eller överkänslighetsreaktioner. Personer med allergi mot dessa material kan få en allergisk reaktion av produkten. Innan enheten används på en patient ska materialen i enheten diskuteras med patienten, och en grundlig genomgång av patientens allergihistorik måste göras:
  - Rostfritt stål
  - Epoxilim
  - Nickelförkromad mässing
  - Silikonbaserat högvakuumfett (DuPont)
  - Master Bond
- Felaktig användning av denna enhet kan resultera i allvarliga komplikationer.
- Hjärtkateteriseringsprocedurer utgör en risk för betydande röntgenexponering för både patienter och laboratoriepersonal, vilket kan leda till akut strålningsskada samt ökad risk för somatiska och genetiska effekter på grund av röntgenstrålningens intensitet och fluoroskopins varaktighet. Överväg noga användningen av denna enhet hos gravida kvinnor.

Försiktighetsåtgärder

- Enligt federal lag (i USA) får denna enhet endast säljas av läkare eller på ordination av läkare.
- Läs anvisningarna före användning.
- Inspektera förpackningen före användning. Enheten får inte användas om förpackningen är öppnad eller skadad.
- Inspektera alla komponenter före användning.
- Förvara enheten på en sval, mörk och torr plats.

- Patienten måste vara hemodynamiskt stabil före proceduren. Vissa omständigheter kan kräva extra uppmärksamhet vid bruk av produkten. Dessa kan innefatta, men är inte begränsade till
  - Vridet hjärta
  - Förstorad aortarot
  - Märkbar förstoring av höger förmak
  - Skolios/kyfos
  - Ovanlig form på vänster förmak
  - Medfödda missbildningar
  - Kärlmissbildningar
  - Oåtkomligt höger förmak genom vena cava inferior.
- Denna enhet ska endast användas av läkare som är speciellt utbildade i transseptala procedurer, i ett fullt utrustat och fungerande elektrofysiologiskt (EP) laboratorium.
- Införande av katetern ska utföras under fluoroskopisk vägledning för att minimera risken för hjärtskada, perforation eller tamponad. Kompatibla navigations- och realtidsvisualiseringssystem kan också övervägas.
- Kontrollera under införandet om motståndet är för stort när nålens spets går igenom hyls-/dilatatoranordningens böjning. Dra ut nålen och undersök komponenterna om det förekommer motstånd när nålen ska föras fram.
- Under införing ska du vara försiktig och undvika att skapa alltför kraftiga böjar i enheten. Detta kan hindra nålens införing och resultera i oavsiktliga nålpunkteringar i dilatator-/hylsanordningen.
- Använd alltid mandrängen under införingen för att underlätta nålens införing genom dilatator-/hylsanordningen. Om du inte använder mandrängen kan det hindra nålens införing, vilket kan resultera i oavsiktliga nålpunkteringar i dilatator-/hylsanordningen eller avrivning av materialet på dilatatorns insida.
- För inte dilatatorn över nålen om ingång i perikardium eller aorta sker. Om nålen har punkterat perikardium eller aortan måste den dras tillbaka. Övervaka vitala tecken noggrant.
- Det finns en risk för ingång av luft när objekt dras tillbaka från hylsans hemostasventil. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra ingång av luft genom att långsamt dra tillbaka objekt för att förhindra att det bildas vakuum i hylsan. Övervaka även om det finns luft i hylsan med fluoroskopi under efterföljande införing av enheter.
- Efter användningen ska enheten, dess tillbehör och förpackning klassificeras för korrekt kassering, t.ex. biologiskt riskavfall, vassa föremål, ofarligt avfall osv., och kasseras i enlighet med lokala rutiner och gällande lagar och bestämmelser.
- En eller flera komponenter i denna enhet kan innehålla följande ämne definierat som CMR 1B med en koncentration över 0,1 viktprocent: Kobolt: Chemical Abstracts Service (CAS)-nr 7440-48-4, EG-nr 231-158-0. Aktuellt vetenskapligt underlag ger stöd för att medicintekniska produkter som tillverkas av koboltlegeringar och legeringar av rostfritt stål som innehåller kobolt inte ökar risken för cancer eller negativa reproduktiva effekter.

  En eller flera komponenter i denna enhet kan innehålla följande ämne definierat som CMR 1A med en koncentration över 0,1 viktprocent: Bly: Chemical Abstracts Service (CAS)-nr 7439-92-1, EG-nr 231-100-4. Aktuellt vetenskapligt underlag ger stöd för att medicintekniska produkter som tillverkas av bly inte ökar risken för cancer eller negativa reproduktiva effekter.

Möjliga biverkningar

Biverkningskategori	Underkategori för biverkningar
Blödning	Blödning
	Hematom
Cerebral skada	Asymptomatisk hjärnemboli
	Stroke/cerebrovaskulär händelse
	Transitorisk ischemisk attack (TIA)
Emboli	Luftemboli
	Emboli orsakad av främmande kropp
	Lungemboli
	Tromboemboli
	Trombos/tromb
Hjärtperforation	Hjärttamponad
	Perikardiell utgjutning
Kardiovaskulär skada	Klaffskada
	Punktering av aortarot
	Förmaksperforation
Störning i överledningssystemet	SA-knutor, AV-knutor eller blockeringar i His-Purkinje-systemet
	Hjärtarytmier
Immunologisk reaktion	Anafylaxi
Infektion	Perikardit
	Endokardit
	Pneumoni
	Sepsis
Smärta/obehag	Smärta i ljumskar, bröst (allmän bröstsmärta som inte är förknippad med hjärtinfarkt)
Perifer kärlskada	Dissektion
	Laceration
	Arteriovenös fistelbildning
	Pseudoaneurysmbildning
Hypotoni	Ej tillämpligt
Ytlig vävnadsskada	Ej tillämpligt

Anvisningar

Förbered och montera utrustningen

1. Ta ut innehållet ur förpackningen.

   OBS! Sätt inte ihop hylsan och dilatatorn.
2. Spola dilatatorn och hylsan med hepariniserad saltlösning.
3. Stäng hylsans kran.
4. Ta bort mandrängen från nålen och spola nålen med hepariniserad saltlösning.
5. För in mandrängen i nålen och fäst den i navet.
6. För in dilatatorn helt i den transseptala hylsan.

För in hyls-/dilatatoranordningen i vena cava superior

1. Skapa åtkomst till femoralvenen (höger femoralis är att föredra).

   ALTERNATIVT: En större standardhylsa (≥2,5 French-storlekar större än den transseptala hylsan) kan användas för att skapa och bibehålla åtkomst till venen för enhetsbyte och hemostas.

2. För in en ledare på 0,81 mm, 150–180 cm lång, med en ”J”-spets på 3 mm, i vena cava superior (SVC).

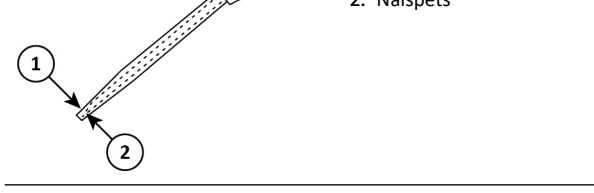
   OBS! Ledaren kan ha en diameter på högst 0,81 mm om den ska användas med dilatatorn.

3. För in hylsan/dilatatorn i venen över ledaren tills hylsans spets är i SVC. Placera dilatatorns spets medialt.

Sätt in nål-/mandränganordningen i hyls-/dilatatoranordningen

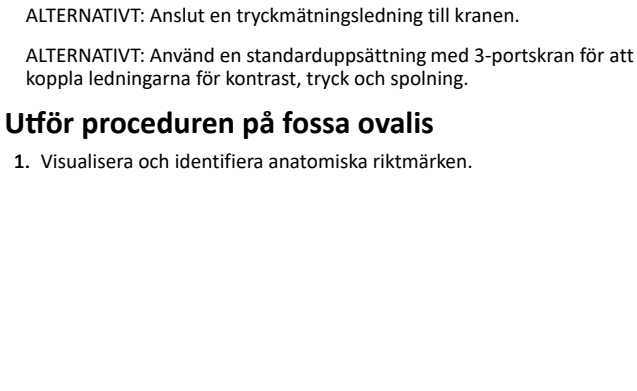
1. Avlägsna ledaren från dilatatorn.
2. Aspirera helt och spola sedan dilatatorn med hepariniserad saltlösning.
3. Dra ut dilatatorn cirka 5 cm (se bilden nedan) för att underlätta framförandet av nålens böjning genom de stela naven i dilatatorn och hylsan.

Bild 1. Dra ut dilatatorn



4. Sätt fast mandrängen i navet.
5. För in nålen/mandrängen i dilatatorn. För in nålen/mandrängen under fluoroskopi tills den är ungefär 2 cm från dilatatorns spets inuti hylsan (se bilden nedan).

Bild 2. För in nålen/mandrängen i dilatatorn



1. Nål
2. Mandräng
3. Dilatatorns spets
4. Hylsa

6. Du kan återansluta hylsan och dilatatorn genom att föra in dilatatorn och nålen/mandrängen i hylsan samtidigt med fluoroskopi. Säkerställ att nålens position inuti dilatatorn inte förändras när båda komponenterna förs in tillsammans. Bibehåll hylsspetsens position i SVC.
7. För in nålen/mandrängen under fluoroskopi tills mandrängen är precis proximalt om dilatatorns spets (se bilden nedan).

Bild 3. För fram nål/mandräng

1. Hylsans spets
2. Dilatator
3. Nål
4. Mandräng

8. Avlägsna mandrängen, men kassera den inte.
9. Aspirera nålen tills det går att se blodet återgå. Kassera sprutan.

   OBS! Användning av sprutor med slip-tip (inte Luer-Lok‡) kan hindra aspiration av luft.

10. Spola nålen med hepariniserad saltlösning. Stäng kranen.
11. För in nålen under fluoroskopi tills nålspetsen är precis proximalt om dilatatorns spets (se bilden nedan).

Bild 4. För fram nålspetsen

1. Dilatatorns spets
2. Nålspets

ALTERNATIVT: Fäst en roterande 3-vägskran vid nålnavet.

ALTERNATIVT: Fäst en spruta med röntgentätt kontrastmedel vid kranen. Aspirera nålen. Fyll sedan nålen med kontrastmedel under fluoroskopisk vägledning.

ALTERNATIVT: Anslut en tryckmätningsledning till kranen.

ALTERNATIVT: Använd en standarduppsättning med 3-portskran för att koppla ledningarna för kontrast, tryck och spolning.

Utför proceduren på fossa ovalis

1. Visualisera och identifiera anatomiska riktmärken.

2. Ställ in fluoroskopienheten till en vinkel parallellt med mitralisklaffens yta och ortagonalt med septumets yta. Detta är vanligtvis LAO (vänster anterior snedställd), ungefär mellan 30 och 40 grader.

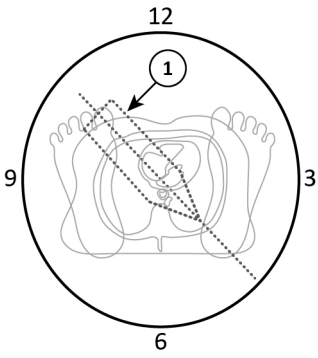
   ALTERNATIVT: Under EP-procedurer kan sinus coronarius och His-kateterns positioner vara användbara anatomiska riktmärken. I lämplig LAO-vy kommer katetern i sinus coronarius synas från sidan. I lämplig RAO-vy (höger anterior snedställd) kommer His-katetern synas från sidan. Fossa ovalis ligger på samma nivå som eller strax under His-katetern och över och bakom ostium i sinus coronarius.

   ALTERNATIVT: Att placera en angiografisk/hemodynamisk övervakningskateter av pigtail-typ i de icke-koronara kusparna i aortaklaffen kan ge ett användbart anatomiskt riktmärke.

   ALTERNATIVT: Se tryckvågformen som registreras genom BRK™ transseptal nål.

3. Justera pekflänsen så att nålen är vinkelrät mot fossa ovalis (vanligtvis mellan klockan 3:00 och 5:00 sett från patientens fötter). (Se bilden nedan.)

Bild 5. Nålens pekfläns

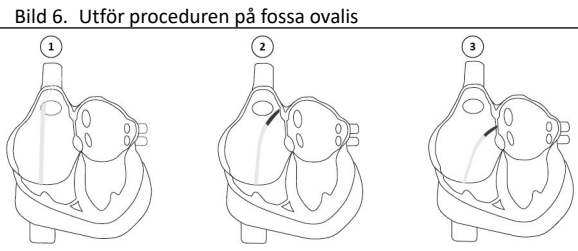


1. Nålens pekfläns

4. Bekräfta att nålspetsen är inuti dilatatorn med hjälp av fluoroskopi.
5. När du har bekräftat att nålens spets är inuti dilatatorn ska du dra hela hyls-/dilatator-/nålanordningen långsamt. Se till att anordningens delar inte rör sig mot varandra. Det är viktigt att bibehålla pekflänsens föregående riktning när anordningen dras.
6. Övervaka dilatatorns spets i LAO-vyn (ortogonalt gentemot förmaksseptumet) under dragningen med avseende på plötsliga rörelser medialt (eller åt höger) som indikerar att spetsen har stött emot fossa ovalis. (Se bilderna nedan.)

   OBS! Om fossa ovalis är öppetstående åker dilatatorns spets nu in i vänster förmak utan motstånd.

Bild 6. Utför proceduren på fossa ovalis



1. Startposition inuti SVC
2. Första rörelse medialt inuti RA
3. Plötslig medial rörelse mot fossa ovalis

OBS! Om trycket övervakas genom nålen kommer trycket genom nålen att vara felaktigt vid denna punkt eftersom spetsen ligger mot fossa ovalis.

Punktera fossa ovalis med BRK™ transseptal nål

1. Bekräfta att hyls-/dilatator-/nålanordningen har rätt position på fossa ovalis innan nålen förs in längre.
2. När rätt placering har bekräftats för du fram nålen till fullkomlig kontakt inuti hyls-/dilatatoranordningen. För sedan nålen fram genom förmaksseptumet.

   ALTERNATIVT: Vid tryckmätning kan ingång i vänster förmak bekräftas när tryckmätningen visar en tryckvågform för vänster förmak.

   ALTERNATIVT: Åtkomst till vänster förmak kan bekräftas med fluoroskopi i kombination med injektioner av kontrastmedel.

3. Vid motstånd när nålen förs in drar du ut nålen och utvärderar de anatomiska riktmärkena på nytt.

   VIKTIGT! För inte dilatatorn över nålen om ingång i perikardium eller aorta sker. Om nålen har punkterat perikardium eller aortan måste den dras tillbaka. Övervaka vitala tecken noggrant.

För in hyls-/dilatatoranordningen i vänster förmak

Samtidigt som nålens position bibehålls inom vänster förmak, för du fram hyls-/dilatatoranordningen helt över nålen in i vänstra förmakets hålrum.

För fram hylsan över den fastsatta dilatatorn och nålen in i vänster förmak

1. Bibehåll nålens och dilatatorns position genom septumet.
2. Samtidigt som dilatatorns position bibehålls, för du fram hylsan helt över dilatatorn in i vänstra förmakets hålrum.

Dra tillbaka BRK™ transseptal nål och dilatatorn

VIKTIGT! Det finns en risk för ingång av luft när objekt dras tillbaka från hylsans hemostasventil. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra ingång av luft genom att långsamt dra tillbaka objekt för att förhindra att det bildas vakuum i hylsan. Övervaka även om det finns luft i hylsan med fluoroskopi under efterföljande införing av enheter.

1. Vrid nålens kran till stängd position och koppla bort alla påkopplade enheter från nålnavet.
2. Avlägsna BRK™ transseptal nål från dilatatorn. Nålen kan rengöras och sparas för upprepad användning i denna procedur. Annars kasseras nålen på lämpligt sätt för hantering av smittbärande och vassa föremål.
3. Fäst genast en spruta vid dilatatorn och aspirera. Fortsätt aspirera blod medan hylsan hålls på plats och dilatatorn dras tillbaka. Blodet ska vara artärblod.
4. När dilatatorn har tagits bort aspirerar du blod genom hylsans sidoarm. Spola hylsans sidoarm försiktigt med hepariniserad saltlösning för att undvika luftbubblor.
5. Hylsan är nu på plats inuti vänster förmak.

Förpackning och hållbarhet

BRK™ transseptal nål levereras steril. Nålen är paketerad med en redan införd mandräng. Nålen och mandrängen är placerade i den primära förpackningen. Den primära förpackningen är placerad inuti en påse av typ Mylar‡ och Tyvek‡ som är värmeförseglad. Påsen och denna bruksanvisning är sedan placerade i en låda som är förseglad i båda ändarna. Både påsen och lådan har en etikett med produktinformation, inklusive utgångsdatum. Produkterna är märkta med en hållbarhetstid på tre år.

Sammanfattning av kliniska data

För EU-länder: En sammanfattning av säkerhet och kliniska prestanda (SSCP) för dessa enheter kommer att publiceras på https://ec.europa.eu/tools/eudamed av de anmälda organen i enlighet med kraven i EU MDR 2017/745 och associerade tidsplaner. Sök efter enheten med hjälp av UDI-DI-numret som står på enhetens ytterförpackning. UDI-DI är det 14-siffriga numret mellan de två första parentesuppsättningarna. Mer information om hur du hittar och använder UDI-DI-numret finns i dokumentet Vanliga frågor på medical.abbott/manuals.

Rapportering av incidenter

Om det under användningen av produkten finns anledning att misstänka att en allvarlig incident har inträffat ska incidenten rapporteras till tillverkaren. Kunder inom EU ska rapportera den allvarliga incidenten till både ansvarig nationell myndighet och tillverkaren.

Begränsad garanti

Abbott Medical garanterar att dess produkter är fria från fel i material och utförande vid normal användning. Denna garanti överskrider inte "Utgångsdatumet" som anges i produktmärkningen. De godkända användningarna och godkända metoderna för användning av var och en av våra produkter anges i den tillhörande "Bruksanvisning" som medföljer varje produkt. Abbott Medical frånsäger sig allt ansvar och alla skyldigheter vid användning av dess produkter på ett sätt som inte har auktoriserats eller godkänts. Abbott Medical skadeståndsskyldighet under garantiperioden inskränker sig till ersättning av dess produkter. Ovannämnda garanti exkluderar och används i stället för alla andra garantier, oavsett om dessa är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för något visst ändamål. Abbott Medical frånsäger sig allt ansvar för eventuella följdskador, skador eller kostnader som direkt eller indirekt uppkommer vid användning av denna produkt, annat än vad som uttryckligen anges i särskild lag. Abbott Medical åtar sig inte heller och ger inte någon annan person rätt att på dess vägnar åta sig något eller ytterligare ansvar för förlust, skada eller kostnader i samband med denna produkt. För mer information, läs igenom hela Abbott Medicals garantipolicy som kan beställas från Abbott Medical eller som finns på baksidan av en Abbott Medical-faktura.

Symboler

Symbolerna nedan och harmoniserade symboler kan förekomma på produkten eller produktetiketten. Information om harmoniserade symboler finns i listan över symboler på medical.abbott/manuals.

Symbol	Definition
Series	Serie
Contents	Innehåll
Transseptal Needle	Transseptal nål
	Enskilt sterilt barriärsystem
	Längd
Rx ONLY	VIKTIGT! Enligt federal lag (i USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på ordination av läkare.
CE 2797	Conformité Européenne (europeisk överensstämmelse). Uppfyller kraven enligt EU-förordning 2017/745. Härmed försäkrar Abbott Medical att denna enhet uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i denna förordning.
	Importör
UK CA 0086	United Kingdom Conformity Assessed (bedömd överensstämmelse i Storbritannien)
UKRP	Ansvarig person i Storbritannien
UA.TR.101	Ukrainsk märkning om överensstämmelse med de tekniska föreskrifterna, där 101 är bedömningsorganet.
MD	Medicinteknisk produkt
UDI	Unik produktidentifiering
medical.abbott/manuals	Följ bruksanvisningen på denna webbplats
(7440-48-4) (7439-92-1)	Innehåller farliga ämnen. (Kobolt, CAS-nr 7440-48-4) (Bly, CAS-nr 7439-92-1)

TR: Türkçe

BRK™ Transseptal İğne

Kullanım Talimatları

Açıklama

BRK™ Transseptal İğne, lüminal paslanmaz çelik iğneden ve yekpare paslanmaz çelik stileden oluşur. İğnenin distal bölümü, Abbott Medical'ın transseptal kılıf setiyle birlikte kullanıldığında kalp içinde konumlandırmayı kolaylaştırmak için kavislidir. Bu kavisli bölüm içinde, Abbott Medical'ın transseptal kılıf setinin dilatörünün iç çapıyla eşleşmek için iğnenin dış çapında ani bir düşüş vardır. İğnenin distal ucu ponksiyon işlemini kolaylaştırmak üzere eğimlidir. İğnenin proksimal ucu bir ibreli flanşla yapılandırılmıştır (distal kavis yönünü işaret eder) ve aspirasyon, sıvı enjeksiyonu/infüzyonu, kan örneği alma, basınç izleme ve stile ve/veya kılavuz tel (18 Ga iğne için 0,014 inç maksimum kılavuz tel çapı; 19 Ga iğne için 0,012 inç maksimum kılavuz tel çapı) girişi için iğne lümenine erişim sağlamak üzere 2 yollu bir vana takılıdır. Stile, uzunluğu boyunca düz ve izodiyametriktir. Stilenin proksimal ucunda, iğne lümenine takıldığında proksimal iğne göbeğinin kilitlenmesi için kavisli bir klips takılıdır. Stile, dilatör içinde iğne ilerlemesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. İğne çeşitli kullanılabilir uzunluklarda ve distal kavis yapılandırmalarında sunulur.

Kullanım Amacı

BRK™ Transseptal İğne, sol kalbe erişim sağlamak üzere interatriyal septum ponksiyonu için kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.

Kullanım Endikasyonları

BRK™ Transseptal İğne, transseptal kateterizasyon prosedürü sırasında sol kalbe erişim sağlamak üzere interatriyal septum ponksiyonu için kullanılır.

Hedef Hasta Grubu

BRK™ Transseptal İğne, sol kalp kateter erişimi gerektiren hemodinamik olarak stabil hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. BRK™ Transseptal İğnenin kullanımı, aşağıdaki durumların görüldüğü hastalarda özel dikkat gerektirebilir:

- Dönmüş kalp
- Genişlemiş aort kökü
- Belirgin sağ atriyal genişleme
- Skolyoz/kifoz
- Anormal sol atriyal geometri
- Konjenital malformasyonlar
- Vasküler malformasyonlar
- Sağ atriyuma inferior vena kava içinden erişememe

Hedef Kullanıcı

Bu cihaz sadece transseptal prosedürler konusunda özel eğitim almış doktorlar tarafından, tam donanımlı operasyonel bir elektrofizyoloji laboratuvarında kullanılmalıdır.

Klinik Faydalar

BRK™ Transseptal İğnenin amaçlanan klinik faydası, ablasyon kateteri gibi amaçlanan klinik faydasını sağlamak üzere sol taraflı endokardiyal kalp erişimi gerektiren cihazlar için sol kalp erişimi sağlamak amacıyla transseptal kateterizasyon prosedürü sırasında interatriyal septumu delmektir. Bu, interatriyal septumun başarılı ponksiyonu ile ölçülür.

Kontrendikasyonlar

- Önceki interatriyal septal yama ya da prostetik atriyal septal kusur kapatma cihazı.
- Önceki bir tromboembolik olay.
- Bilinen veya şüphelenilen sol atriyal miksoma.
- Son iki hafta içinde bilinen ya da şüphelenilen miyokard enfarktüsü.
- Stabil olmayan angina.
- Yakın zamanda yaşanan serebrovasküler olay (CVA).
- Antikoagülasyon tedavisini tolere etmeyen hastalar.
- Aktif enfeksiyonu olan hastalar.

Uyarılar

- Bu cihazda herhangi bir şekilde değişiklik yapmayın.
- Bu cihaz sadece bir defa kullanım içindir; yeniden işlemden geçirmeyin ya da yeniden kullanmayın. Ambalaj üzerindeki “Son Kullanma Tarihine” dikkat edin. Bu sistemin yeniden sterilize edilmeye veya yeniden kullanılmaya çalışılması halinde, sistem bütünlüğü bozulabilir. Steril olmayan bileşenler kullanılmasına ilişkin advers etkiler, aşağıdakileri içerebilmekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:
  - Lokal ve sistemik enfeksiyon veya reaksiyon
  - Mekanik hasar
  - Hatalı işlev
- Aşağıda ürüne göre belirtilen malzemeler, alerjik reaksiyonlara ya da aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Bunlara alerjisi olan kişilerde bu ürün nedeniyle alerjik reaksiyon gelişebilir. Hastada kullanılmadan önce, cihazda bulunan malzemelerle ilgili olarak hastaya danışılmalıdır ve kapsamlı alerji öyküsü alınmalıdır:
  - Paslanmaz çelik
  - Epoksi yapıştırıcı
  - Nikel krom kaplamalı pirinç
  - Silikon yüksek vakumlu gres (Dupont)
  - Master Bond
- Bu cihazın yanlış kullanımı, ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
- Hem hastalar hem de laboratuvar çalışanları için, kardiyak kateterizasyon prosedürlerinin, önemli ölçüde röntgen ışını maruziyetine yol açma potansiyeli vardır ve bu, röntgen ışınının yoğunluğu ile floroskopik görüntülemenin süresi nedeniyle akut radyasyon yaralanmasının yanı sıra somatik ve genetik etkilere ilişkin riskte artışa yol açabilir. Hamile kadınlarda bu cihazın kullanımını dikkatlice değerlendirin.

Önlemler

- Federal Yasalara (ABD) göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya doktorun siparişi üzerine satılabilir.
- Kullanmadan önce talimatları okuyun.
- Kullanmadan önce ambalajı inceleyin. Ambalaj açılmış veya zarar görmüşse kullanmayın.
- Kullanmadan önce tüm bileşenleri inceleyin.
- Serin, karanlık, kuru yerde saklayın.
- Prosedürden önce hasta hemodinamik olarak stabil durumda olmalıdır. Bu ürünü kullanırken, bazı koşullarda özel dikkat gerekebilir. Bu durumlar şunları içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
  - Dönmüş kalp
  - Genişlemiş aort kökü
  - Belirgin sağ atriyal genişleme
  - Skolyoz/kifoz

  - Anormal sol atriyal geometri
  - Konjenital malformasyonlar
  - Vasküler malformasyonlar
  - Sağ atriyuma inferior vena kava içinden erişememe
- Bu cihaz sadece transseptal prosedürler konusunda özel eğitim almış doktorlar tarafından, tam donanımlı operasyonel bir elektrofizyoloji (EP) laboratuvarında kullanılmalıdır.
- Kardiyak hasar, perforasyon veya tamponad riskini en aza indirmek için kateter floroskopik görüntüleme altında ilerletilmelidir. Uyumlu navigasyon ve gerçek zamanlı görselleştirme sistemleri de düşünülebilir.
- Yerleştirme esnasında, iğne ucu kılıf/dilatör düzeneğinin kavisli kısmında ilerlerken aşırı direnç kontrolü yapın. İğnenin ilerlemesine karşı direnç varsa, iğneyi geri çekin ve bileşenleri değerlendirin.
- Yerleştirme sırasında bu cihazda aşırı kıvrımlar oluşturmamak için dikkatli olun. Aksi takdirde iğnenin ilerlemesi engellenebilir ve dilatör/kılıf düzeneğinde istenmeyen iğne ponksiyonu meydana gelebilir.
- Yerleştirme esnasında, dilatör/kılıf düzeneğinden iğne geçişini kolaylaştırmak üzere daima stileyi kullanın. Stilenin kullanılmaması halinde, iğnenin ilerlemesi engellenebilir ve dilatör/kılıf düzeneğinde istenmeyen iğne ponksiyonu ya da dilatör iç yüzeyinde materyal sıyrılması meydana gelebilir.
- Perikarda veya aorta giriş meydana gelirse, dilatörü iğnenin üzerinden ilerletmeyin. İğne perikarda veya aorta girmişse geri çekilmelidir. Yaşamsal bulguları yakından izleyin.
- Kılıfın hemostaz valfinden nesneleri geri çekerken hava infiltrasyonu riski vardır. Hava infiltrasyonunu önlemek için nesneleri yavaşça geri çekerek kılıfın içinde vakum oluşmasını engelleyin ve sonraki cihaz girişi sırasında kılıfta hava olup olmadığını floroskopik olarak izleyin.
- Kullanım sonrasında bu cihaz, aksesuarları ve ambalajı, bertaraf edilmek üzere biyolojik tehlike, kesici/delici madde, tehlikeli olmayan atık vb. şeklinde uygun biçimde tasnif edilmelidir ve tesis prosedürleri ile geçerli yasalar ve düzenlemelere uygun olarak dikkatlice bertaraf edilmelidir.
- Bu cihazın bir veya daha fazla bileşeni, ağırlıkça %0,1'in üzerindeki bir konsantrasyonda CMR 1B olarak tanımlanan şu maddeyi içerebilir: Kobalt: Chemical Abstracts Service (CAS) No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0. Mevcut bilimsel kanıtlar, kobalt alaşımlarından ve kobalt içeren paslanmaz çelik alaşımlarından üretilen tıbbi cihazların kanser veya olumsuz üreme etkileri riskinde artışa neden olmadığını desteklemektedir.

  Bu cihazın bir veya daha fazla bileşeni, ağırlıkça %0,1'in üzerindeki bir konsantrasyonda CMR 1A olarak tanımlanan şu maddeyi içerebilir: Kurşun: Chemical Abstracts Service (CAS) No. 7439-92-1; EC No. 231-100-4. Mevcut bilimsel kanıtlar, kurşundan üretilen tıbbi cihazların kanser veya olumsuz üreme etkileri riskinde artışa neden olmadığını desteklemektedir.

Potansiyel Advers Olaylar

Advers Olay Kategorisi	Advers Olay Alt Kategorisi
Kanama	Hemoraji/Kanama
	Hematom
Serebral hasar	Asemptomatik serebral embolizm
	İnme/serebrovasküler olay
	Geçici iskemik atak (TIA)
Embolizm	Hava embolizmi
	Yabancı cisim embolisi
	Pulmoner embolizm
	Tromboembolizm
	Tromboz/trombüs
Kardiyak perforasyon	Kardiyak tamponad
	Perikardiyal efüzyon
Kardiyovasküler hasar	Valvüler hasar
	Aort kökü ponksiyonu
	Atriyal perforasyon
İletim sisteminde bozulma	SA düğüm, AV düğüm ya da His-Purkinje sistem blokajı
	Kardiyak aritmiler
İmmünolojik reaksiyon	Anafilaksi
Enfeksiyon	Perikardit
	Endokardit
	Pnömoni
	Sepsis
Ağrı/rahatsızlık	Ağrı, kasık, göğüs (miyokard enfarktüsü ile ilişkili olmayan genel göğüs ağrısı)
Periferik vasküler hasar	Diseksiyon
	Laserasyon
	Arteriyovenöz fistül oluşumu
	Psödoanevrizma oluşumu
Hipotansiyon	Mevcut değil
Yüzeysel doku zedelenmesi	Mevcut değil

Talimatlar

Ekipmanı Hazırlama ve Monte Etme

1. İçeriği paketten çıkarın.

   NOT: Kılıfı ve dilatörü monte etmeyin.
2. Dilatörü ve kılıfı heparinize salinle yıkayın.
3. Kılıfın vanasını kapatın.
4. Stileyi iğneden çıkarın ve iğneyi heparinize salinle yıkayın.
5. Stileyi iğneye takın ve göbek üzerine kilitleyin.
6. Dilatörü transseptal kılıfa tamamen yerleştirin.

Kılıf/Dilatör Düzeneğini Superior Vena Kavaya İlerletme

1. Femoral venöz erişim sağlayın (sağ femoral tercih edilir).

   Opsiyonel: Cihaz değişimi ve hemostaz için venöz erişim elde etmek ve bunu korumak üzere daha büyük bir (transseptal kılıftan ≥2,5 Fr daha büyük) standart uzunlukta kılıf kullanılabilir.

2. 0,032 inç, 150-180 cm, 3 mm “J” uçlu kılavuz teli superior vena kava (SVC) içine yerleştirin.

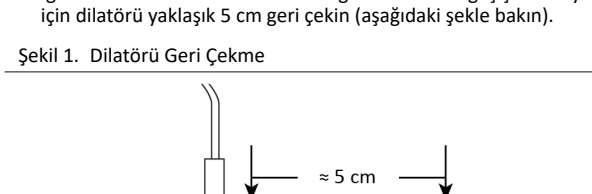
   NOT: Dilatörle kullanılabilecek maksimum kılavuz tel çapı 0,032 inçtir.

3. Kılıfı/dilatörü kılavuz tel üzerinden vene yerleştirin ve kılıf ucu SVC'nin içinde oluncaya kadar ilerletin. Dilatör ucunu, medial olarak yönlendirin.

İğne/Stile Düzeneğini, Kılıf/Dilatör Düzeneği içinde konumlandırma

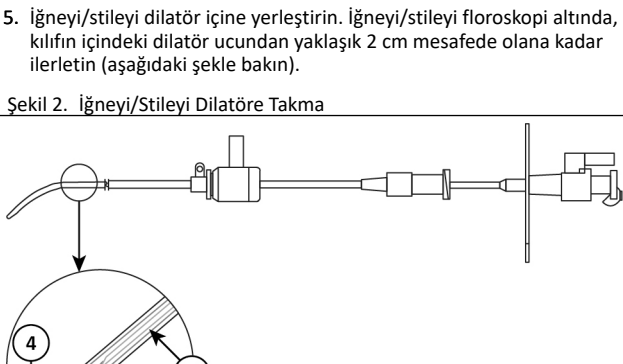
1. Kılavuz teli dilatörden çıkarın.
2. Tamamen aspire edin ve ardından dilatörü heparinize salin ile yıkayın.
3. İğne kavisinin dilatör ve kılıfın sert göbeklerinden geçişini kolaylaştırmak için dilatörü yaklaşık 5 cm geri çekin (aşağıdaki şekle bakın).

Şekil 1. Dilatörü Geri Çekme



4. Stileyi göbek üzerine kilitleyin.
5. İğneyi/stileyi dilatör içine yerleştirin. İğneyi/stileyi floroskopi altında, kılıfın içindeki dilatör ucundan yaklaşık 2 cm mesafede olana kadar ilerletin (aşağıdaki şekle bakın).

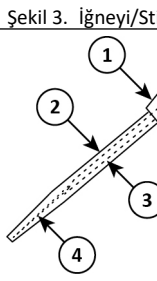
Şekil 2. İğneyi/Stileyi Dilatöre Takma



1. İğne
2. Stile
3. Dilatör ucu
4. Kılıf

6. Kılıfı ve dilatörü tekrar bağlamak için dilatörü ve iğneyi/stileyi floroskopi altında eş zamanlı olarak kılıfın içine ilerletin. Her iki bileşen birlikte ilerletilirken dilatör içinde iğne konumunun değişmediğinden emin olun. SVC'de kılıf ucu pozisyonunu koruyun.
7. Floroskopi altında, stile dilatör ucunun hemen proksimalinde konumlanana kadar iğneyi/stileyi ilerletin (aşağıdaki şekle bakın).

Şekil 3. İğneyi/Stileyi İlerletme



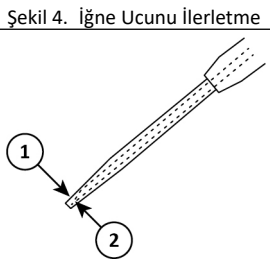
1. Kılıf ucu
2. Dilatör
3. İğne
4. Stile

8. Stileyi çıkarın, atmayın.
9. Kan dönüşü gözlenene kadar iğneyi aspire edin. Şırıngayı atın.

   NOT: Kaydırma uçlu (Luer-Lok‡ olmayan) bir şırınga kullanılması, hava aspirasyonunu önleyebilir.

10. İğneyi heparinize salinle yıkayın. Vanayı kapatın.
11. İğne ucu dilatör ucunun hemen proksimalinde olana kadar iğneyi floroskopi altında ilerletin (aşağıdaki şekle bakın).

Şekil 4. İğne Ucunu İlerletme



1. Dilatör ucu
2. İğne ucu

Opsiyonel: İğne göbeğine 3 yönlü bir döner vana takın.

Opsiyonel: Vanaya, radyopak kontrast madde içeren bir şırınga takın. İğneyi aspire edin. Daha sonra iğneyi, floroskopik görüntüleme altında kontrast maddeyle doldurun.

Opsiyonel: Vanaya bir basınç izleme hattı bağlayın.

Opsiyonel: Kontrast, basınç ve yıkama hatlarını bağlamak için standart bir 3 portlu manifold kurulumu kullanın.

Fossa Ovalise Girme

1. Anatomik işaretleri görüntüleyin ve belirleyin.
2. Floroskopi birimini, mitral kapak düzlemine paralel ve septum düzlemine dik bir açıya ayarlayın. Bu tipik olarak sol anterior oblik (LAO), yaklaşık 30 ila 40 derece olacaktır.

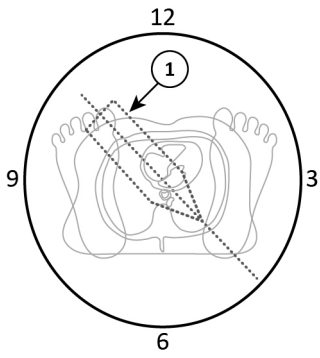
   Opsiyonel: EP prosedürleri sırasında, koroner sinüs ve His demeti kateter konumları faydalı anatomik işaretler olarak kullanılabilir. Uygun LAO görünümünde, koroner sinüs kateteri profilden görünür. Uygun sağ ön oblik (RAO) görünümde His demeti kateteri profilden görünür. Fossa ovalis, His demeti kateteri seviyesinde veya biraz altındadır ve koroner sinüs ostiyumunun üst ve arka kısmında yer alır.

   Opsiyonel: Aort kapağının koroner olmayan çıkıntısına bir pigtail anjiyografik/hemodinamik izleme kateteri yerleştirmek faydalı bir anatomik işaret sağlayabilir.

   Opsiyonel: BRK™ Transseptal İğneden kaydedilen basınç dalgaformunu gözlemleyin.

3. İbreli flanşı, iğne, fossa ovalise dik olacak şekilde (hastanın ayakucundan bakıldığında tipik olarak saat 3:00 ila 5:00 konumları arasında) ayarlayın. (Aşağıdaki şekle bakın.)

Şekil 5. İğne İbreli Flanşı

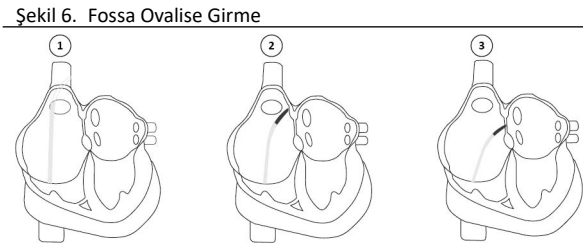


1. İğne ibreli flanşı

4. İğne ucunun dilatörün içinde olduğunu doğrulamak için floroskopi kullanın.
5. İğne ucunun dilatörün içinde olduğunu onayladıktan sonra, kılıf/dilatör/iğne düzeneğini bütün olarak yavaşça çekin. Düzenek parçalarının birbirlerine göre hareket etmesini önleyin. Düzeneği çekerken, ibreli flanşın önceki yönelimini korumak çok önemlidir.
6. LAO görünümünde (interatriyal septuma dik) çekme sırasında ucun fossa ovalise girdiğini belirten ani medial (veya sağa doğru) hareket açısından dilatörün ucunu gözlemleyin. (Aşağıdaki şekillere bakın.)

   NOT: Fossa ovalis sondaya açıksa, dilatör ucu sol atriyuma kolaylıkla girer.

Şekil 6. Fossa Ovalise Girme



1. SVC'de başlangıç konumu
2. RA'da ilk medial hareket
3. Fossa ovalis üzerine ani medial hareket

NOT: Basınç iğne ile izleniyorsa, uç fossa ovalise dayandığı için iğne yoluyla alınan basınç bu noktada yanlış olur.

BRK™ Transseptal İğne ile Fossa Ovalis Ponksiyonu

1. İğneyi ilerletmeden önce, kılıf/dilatör/iğne düzeneğinin fossa ovaliste doğru konumda olduğunu onaylayın.
2. Doğru konumda olduklarını onayladıktan sonra, iğneyi kılıf/dilatör düzeneği içinde tam geçme konumuna uzatın ve iğneyi interatriyal septumdan geçerek ilerletin.

   Opsiyonel: Basınç izleme altında, basınç takibi sol atriyal basınç dalgaformu gösterdiğinde, sol atriyuma giriş onaylanır.

   Opsiyonel: Sol atriyal erişim, kontrast madde enjeksiyonları ile floroskopi kullanılarak onaylanabilir.

3. İğnenin ilerlemesine karşı bir direnç varsa, iğneyi geri çekin ve anatomik işaretleri tekrar değerlendirin.

   DİKKAT: Perikarda veya aorta giriş meydana gelirse, dilatörü iğnenin üzerinden ilerletmeyin. İğne perikarda veya aorta girmişse geri çekilmelidir. Yaşamsal bulguları yakından izleyin.

Kılıf/Dilatör Düzeneğini Sol Atriyuma İlerletme

Sol atriyum içinde iğne konumunu sabit tutarken, kılıf/dilatör düzeneğini iğnenin üzerinden sol atriyal kaviteye tamamen ilerletin.

Kılıfı Sabit Dilatör ve İğne Üzerinden Sol Atriyuma İlerletme

1. Septum boyunca iğnenin ve dilatörün konumunu koruyun.
2. Dilatörü sabit bir konumda tutarken, kılıfı dilatörün üzerinden sol atriyal kaviteye tamamen ilerletin.

BRK™ Transseptal İğneyi ve Dilatörü Geri Çekme

DİKKAT: Kılıfın hemostaz valfinden nesneleri geri çekerken hava infiltrasyonu riski vardır. Hava infiltrasyonunu önlemek için nesneleri yavaşça geri çekerek kılıfın içinde vakum oluşmasını engelleyin ve sonraki cihaz girişi sırasında kılıfta hava olup olmadığını floroskopik olarak izleyin.

1. İğne vanasını kapalı konuma getirin ve iğne göbeğindeki tüm bağlantıları çıkarın.
2. BRK™ Transseptal İğneyi dilatörden çıkarın. İğne temizlenip bu prosedürde daha sonra tekrar kullanılmak üzere saklanabilir. Aksi takdirde, iğneyi kontamine kesici/delici nesneler için uygun şekilde bertaraf edin.
3. Derhal dilatöre bir şırınga takın ve aspire edin. Kılıfı yerinde tutarak dilatörü geri çekerken kanı aspire etmeye devam edin. Kan, arteriyel kan olmalıdır.
4. Dilatör çıkarıldıktan sonra, kanı kılıfın yan kolundan aspire edin. Hava kabarcıklarını önlemek için kılıfın yan kolunu dikkatlice heparinize salin ile yıkayın.
5. Kılıf artık sol atriyumda yerine oturmuştur.

Ambalaj ve Raf Ömrü

BRK™ Transseptal İğne steril biçimde tedarik edilir. İğne, stile yerleştirilmiş olarak ambalajlanır. İğne ve stile, primer ambalaja konur. Primer ambalaj Mylar‡ ve Tyvek‡ torba içine konur ve bu torba ısıyla kapatılır. Ardından torba ve bu Kullanım Talimatları bir kutu içerisine konur, bu kutunun iki ucu kapatılır. Torbada ve kutuda, son kullanma tarihini de içerecek şekilde ürün bilgilerinin yer aldığı bir etiket vardır. Ürünler, üç yıllık raf ömrü için etiketlenmiştir.

Klinik Veri Özeti

Avrupa Birliği ülkeleri için: Bu cihazlar için güvenlik ve klinik performansın (SSCP) bir özeti, AB MDR 2017/745 gereksinimlerine ve ilgili zaman çizelgelerine uygun olarak Onaylanmış Kuruluşlar tarafından https://ec.europa.eu/tools/eudamed adresinde yayınlanacaktır. Cihazın dış paketinde sağlanan UDI-DI'yı kullanarak cihaz için arama yapın. UDI-DI, ilk iki parantez grubu arasındaki 14 basamaklı sayıdır. UDI-DI'yi bulma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için medical.abbott/manuals adresinde bulunan Sıkça Sorulan Sorular belgesine bakın.

Olay Raporlama

Bu cihazı kullandığınız sırada ciddi bir olayın meydana geldiğini düşünüyorsanız lütfen bunu üreticiye bildirin. Avrupa Birliği içinde yer alan müşteriler, ciddi olayları hem ulusal makama hem de üreticiye bildirmelidir.

Sınırlı Garanti

Abbott Medical, ürünlerinin normal kullanım şartları altında malzeme ve işçilik kusuru içermeyeceğini garanti eder. Bu garanti, herhangi bir ürün etiketi üzerinde belirtilen "Son Kullanma" tarihinden sonrasını kapsamaz. Her ürünün izin verilen kullanımı ve onaylanmış kullanım yöntemleri, her ürünle birlikte verilen ilgili "Kullanım Talimatları" içinde belirtilmiştir. Abbott Medical, ürünlerinin izin verilmeyen veya onaylanmayan şekilde kullanılmasıyla ilgili olarak her türlü sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. Abbott Medical'ın bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü, ürünlerini değiştirmekle sınırlıdır. Belirtilen garanti, her türlü ticari olarak satılabilirlik ya da belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık ya da zımni tüm diğer garantileri reddetmekte ve bunların yerini almaktadır. Abbott Medical, bu ürünün kullanımı nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan tüm arızi veya netice kabili kayıplar, zararlar veya masraflarla ilgili olarak, ilgili kanunda açıkça belirtilen yükümlülük dışında tüm yükümlülüğü reddeder. Abbott Medical, bu ürünle bağlantılı olan kayıplar, zararlar ya da masraflar için bunun dışında veya ilave hiçbir yükümlülük üstlenmez veya üstlenmesi için başka hiç kimseye yetki vermez. Ayrıntılı bilgi için lütfen Abbott Medical'dan veya bir Abbott Medical faturasının arka yüzünden erişebileceğiniz tam Abbott Medical garanti politikasını inceleyin.

Semboller

Ürün üzerinde veya ürün etiketinde aşağıdaki semboller ve uyumlaştırılmış semboller bulunabilir. Uyumlaştırılmış semboller için, medical.abbott/manuals adresindeki Universal Symbols Glossary'ye (Evrensel Semboller Sözlüğü) bakın.

Sembol	Tanım
Series	Seri
Contents	İçindekiler
Transseptal Needle	Transseptal İğne
	Tek steril bariyerli sistem
	Uzunluk
Rx ONLY	DİKKAT: Federal Yasalara (ABD) göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya doktorun siparişi üzerine satılabilir.
CE 2797	Conformité Européenne (Avrupa Uyumluluğu). 2017/745 sayılı Avrupa Konseyi Yönetmeliği'ne uygun olarak eklenmiştir. İşbu belgede Abbott Medical, bu cihazın, bu yönetmeliğin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder.
	İthalatçı
UK CA 0086	Birleşik Krallık Uyumluluğu Değerlendirmesi
UKRP	Birleşik Krallık'taki sorumlu kişi
UA.TR.101	Bu işaret Ukrayna'da teknik düzenlemelere uygunluğu belirtir, 101 değerlendirme kuruluşudur.
MD	Tıbbi Cihaz
UDI	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı
medical.abbott/manuals	Bu web sitesindeki kullanım talimatlarını uygulayın
(7440-48-4) (7439-92-1)	Tehlikeli maddeler içerir. (Kobalt CAS No. 7440-48-4) (Kurşun CAS No. 7439-92-1)

UK: Українська

BRK™ Транссептальна голка

Інструкція з використання

Опис

Транссептальна голка BRK™ складається з голки з нержавіючої сталі з просвітом просвіту та суцільного стилета з нержавіючої сталі. Дистальна частина голки вигнута, щоб полегшити позиціонування всередині серця під час використання з набором транссептальної оболонки від Abbott Medical. На цій вигнутій частині є різке звуження в зовнішньому діаметрі голки для з'єднання з внутрішнім діаметром розширювача з набору транссептальної оболонки від Abbott Medical. Дистальний наконечник голки скошений, щоб полегшити процес пункції. Проксимальний кінець голки налаштований із виступом вказівника (що вказує на орієнтацію дистальної кривої) й оснащений 2-ходовим запірним краном, щоб забезпечити доступ до просвіту голки для аспірації, введення/інфузії рідини, відбору крові, моніторингу тиску та введення стилета та/або провідника (0,014 дюйма — максимальний діаметр провідника для голки 18 калібру; 0,012 дюйма — максимальний діаметр провідника для голки 19 калібру). Стилет прямий і рівнодіаметровий по всій довжині. Проксимальний кінець стилета оснащений вигнутим затискачем для фіксації на проксимальній втулці голки під час введення в просвіт голки. Стилет призначений для полегшення просування голки всередині розширювача. Голка доступна в різних робочих довжинах і конфігураціях дистальної кривої.

Цільове призначення

Транссептальна голка BRK™ призначена для пункції міжпередсердної перегородки, щоб отримати доступ до лівих камер серця.

Показання до застосування

Транссептальна голка BRK™ використовується для пункції міжпередсердної перегородки під час процедури транссептальної катетеризації, щоб отримати доступ до лівих камер серця.

Цільова група пацієнтів

Транссептальна голка BRK™ призначена для використання в пацієнтів зі стабільним гемодинамічним станом, до катетера лівих камер серця яких потрібен доступ. Під час використання транссептальної голки BRK™, можливо, особливої уваги потребуватимуть пацієнти з такими захворюваннями:

- Повернуте положення серця;
- Розширений корінь аорти;
- Виражене збільшення правого передсердя;
- Сколіоз/кіфоз;
- Аномальна геометрія лівого передсердя;
- Вади розвитку серця;
- Судинні мальформації;
- Неможливість доступу до правого передсердя через нижню порожнисту вену.

Цільовий користувач

Цей пристрій має використовуватися лише лікарями, які пройшли спеціальну підготовку щодо виконання транссептальних процедур, у повністю обладнаній операційній електрофізіологічній лабораторії.

Клінічна користь

Передбачувана клінічна користь транссептальної голки BRK™ полягає в пункції міжпередсердної перегородки під час процедури транссептальної катетеризації, щоб відкрити доступ до лівих камер серця для пристроїв, які потребують доступу до ендокардіальної частини серця з лівого боку з метою досягти їхньої передбачуваної клінічної користі, наприклад при застосуванні катетера для абляції. Вона залежить від того, наскільки пункція міжпередсердної перегородки успішна.

Протипоказання

- Попередня латка на міжпередсердній перегородці або штучний пристрій, що закриває дефект міжпередсердньої перегородки.
- Будь-яка попередня тромбоемболічна подія.
- Відома або підозрювана міксома лівого передсердя.
- Відомий або підозрюваний інфаркт міокарда протягом останніх двох тижнів.
- Нестабільна стенокардія.
- Недавня цереброваскулярна подія (CVA).
- Пацієнти, які погано переносять антикоагулянтну терапію.
- Пацієнти з активними інфекціями.

Попередження

- Не модифікуйте цей пристрій жодним чином.
- Цей пристрій призначений виключно для одноразового використання; не піддавайте його повторній обробці й не використовуйте повторно. Зверніть увагу на дату «Термін придатності» на упаковці. Будь-яка спроба повторної стерилізації та повторного використання цієї системи може порушити її цілісність. Небажані ефекти використання нестерильних компонентів з-поміж іншого можуть включати:
  - Місцеву й системну інфекцію або реакцію;
  - Механічні пошкодження;
  - Неточну функціональність.
- Матеріали, зазначені нижче для кожного виробу, можуть викликати алергічні реакції або реакції гіперчутливості. В осіб з алергією на ці матеріали може виникнути алергічна реакція на цей виріб. Перед його застосуванням пацієнта потрібно проконсультувати щодо матеріалів, які входять до складу пристрою, і ретельно обговорити випадки алергії в анамнезі:
  - Нержавіюча сталь;
  - Епоксидний клей;
  - Хромонікельована латунь;
  - Силіконове високовакуумне мастило (Dupont);
  - Клей Master bond.
- Неправильне чи неналежне використання цього пристрою може призвести до серйозних ускладнень.
- Як для пацієнтів, так і для лабораторного персоналу процедури серцевої катетеризації є потенційним-джерелом значного рентгенівського опромінення, що може призвести до гострого радіаційного ураження, а також -підвищеного ризику соматичних і генетичних наслідків у результаті інтенсивності рентгенівського випромінення та тривалості рентгеноскопічної візуалізації. Особливо ретельно слід оцінювати доцільність застосування цього пристрою у вагітних жінок.

Запобіжні заходи

- Відповідно до федерального законодавства США продаж цього пристрою дозволено лише лікарям або за їхнім призначенням.
- Перед застосуванням прочитайте вказівки з використання.
- Перед використанням перевірте упаковку. Якщо упаковка відкрита або пошкоджена, використовувати пристрій не можна.
- Перед використанням перевіряйте всі компоненти.
- Зберігайте в прохолодному, темному й сухому місці.
- Перед процедурою гемодинамічний стан пацієнта повинен бути стабільним. Певні умови можуть вимагати особливої уваги під час використання цього виробу. До таких ризиків зокрема належать:
  - Повернуте положення серця;
  - Розширений корінь аорти;
  - Виражене збільшення правого передсердя;
  - Сколіоз/кіфоз;
  - Аномальна геометрія лівого передсердя;
  - Вади розвитку серця;
  - Судинні мальформації;
  - Неможливість доступу до правого передсердя через нижню порожнисту вену.
- Цей пристрій має використовуватися лише лікарями, які пройшли спеціальну підготовку щодо виконання транссептальних процедур, у повністю обладнаній операційній електрофізіологічній (ЕФ) лабораторії.
- Щоб звести до мінімуму ризик ушкодження, перфорації або тампонади серця, катетер необхідно просувати під рентгеноскопічним контролем. Також можна використовувати сумісні системи навігації та візуалізації в реальному часі.
- Під час введення зверніть увагу на наявність надмірного опору, коли наконечник голки просувається через вигини оболонки й розширювача у зборі. Якщо під час просування голки відчувається опір, втягніть голку та оцініть стан компонентів.
- Під час введення будьте обережні, щоб не створювати надмірних вигинів у цьому пристрої. Це може перешкоджати просуванню голки та спричинити ненавмисний прокол голкою розширювача й оболонки в зборі.
- Під час введення завжди використовуйте стилет, щоб полегшити проходження голки через розширювач й оболонку в зборі. Невикористання стилета може загальмувати просування голки та спричинити ненавмисний прокол голкою розширювача й оболонки в зборі або стирання матеріалу на внутрішній поверхні розширювача.
- Якщо відбувається входження в перикард або аорту, не просувайте розширювач поверх голки. Якщо голка потрапила в перикард або аорту, її необхідно витягти. Уважно стежте за життєвими ознаками організму.
- Існує ризик проникнення повітря під час вилучення предметів із гемостатичного клапана оболонки. Вживайте запобіжних заходів, щоб запобігти проникненню повітря. Для цього повільно виймайте предмети, щоб не допустити утворення вакууму в оболонці, та під рентгеноскопічним контролем відстежуйте наявність повітря в оболонці під час подальшого введення пристрою.
- Після використання пристрій, приладдя до нього та упаковку необхідно належним чином розподілити на категорії для утилізації, наприклад біологічно небезпечні матеріали, гострі предмети, нешкідливі відходи тощо, та обережно утилізувати згідно з процедурами закладу та відповідними законами й розпорядженнями.
- Один або кілька компонентів цього виробу можуть містити зазначену нижче речовину, визначену як CMR 1B у концентрації понад 0,1 % масової частки: кобальт: Chemical Abstracts Service (CAS) № 7440-48-4; ЕС № 231-158-0. Сучасні наукові дані підтверджують, що медичні пристрої, виготовлені з кобальтових сплавів та сплавів нержавіючої сталі, що містять кобальт, не спричиняють підвищеного ризику розвитку раку або небажаних ефектів для репродуктивної функції.

  Один або кілька компонентів цього виробу можуть містити зазначену нижче речовину, визначену як CMR 1A в концентрації понад 0,1 % масової частки: свинець: Chemical Abstracts Service (CAS) № 7439-92-1; ЕС № 231-100-4. Сучасні наукові дані підтверджують, що медичні вироби, виготовлені зі свинцю, не спричиняють підвищення ризику розвитку раку або небажані ефекти для репродуктивної функції.

Можливі небажані явища

Категорія небажаного явища	**Підкатегорія небажаного явища**
Кровотеча	Крововилив/кровотеча
	Гематома
Церебральна травма	Безсимптомна церебральна емболія
	Інсульт / гостре порушення мозкового кровообігу
	Транзиторна ішемічна атака (TIA)
Емболія	Повітряна емболія
	Емболія чужорідним тілом
	Легенева емболія
	Тромбоемболія
	Тромбоз/тромб
Перфорація серця	Тампонада серця
	Перикардіальний випіт
Серцево-судинна травма	Пошкодження клапанів серця
	Пункція кореня аорти
	Перфорація передсердь
Порушення провідної системи серця	Блокада вузла СА, вузла АВ або системи Гіса-Пуркіньє
	Серцеві аритмії
Імунологічна реакція	Анафілаксія
Інфекція	Перикардит
	Ендокардит
	Пневмонія
	Сепсис
Біль/дискомфорт	Біль у паху, грудній клітці (загальний біль у грудях, не пов’язаний з інфарктом міокарда)
Пошкодження периферичних судин	розшарування
	Розрив

Категорія небажаного явища	Підкатегорія небажаного явища
	Утворення артеріовенозної фістули
	Утворення псевдоаневризми
Гіпотензія	н/з
Травмування поверхневих тканин	н/з

Інструкції

Підготуйте та змонтуйте обладнання

1. Вийміть вміст з упаковки.

   ПРИМІТКА. Не з'єднуйте оболонку та розширювач.

2. Промийте розширювач та оболонку гепаринізованим фізіологічним розчином.
3. Закрийте запірний кран оболонки.
4. Зніміть стилет із голки та промийте голку гепаринізованим фізіологічним розчином.
5. Вставте стилет у голку та зафіксуйте його на втулці.
6. Повністю вставте розширювач у транссептальну оболонку.

Просуньте оболонку й розширювач у зборі у верхню порожнисту вену

1. Отримайте доступ до стегнової вени (бажано до правої стегнової вени).

   ДОДАТКОВО. Більшу (на ≥2,5 французького калібру більшу за розмір транссептальної оболонки) від стандартної довжини оболонку можна використовувати, щоб отримати й зберігати доступ до вени з метою заміни пристрою та підтримки гемостазу.

2. Введіть провідник діаметром 0,032 дюйма, 150–180 см, з наконечником 3 мм «J» у верхню порожнисту вену (ВПВ).

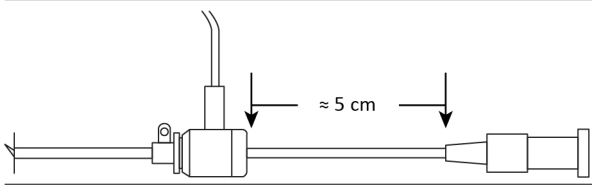
   ПРИМІТКА. 0,032 дюйма — максимальний діаметр провідника, який можна використовувати з розширювачем.

3. Введіть оболонку й розширювач у вену поверх провідника, доки наконечник оболонки не опиниться у ВПВ. Розташуйте наконечник розширювача медіально.

Розміщення голки й стилета в зборі всередині оболонки й розширювача в зборі

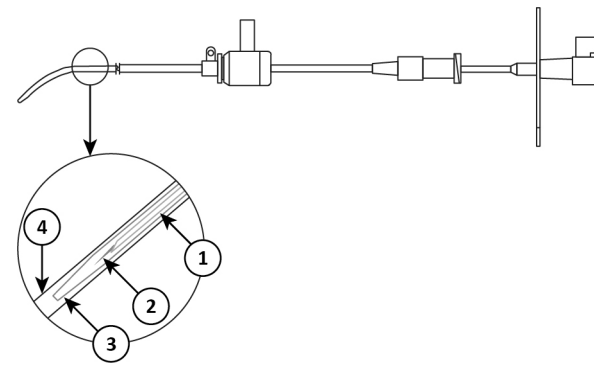
1. Витягніть провідник із розширювача.
2. Виконайте повну аспірацію, а потім промийте розширювач гепаринізованим фізіологічним розчином.
3. Витягніть розширювач приблизно на 5 см (див. рис. нижче), щоб полегшити проходження вигнутої частини голки через цупкі втулки розширювача та оболонки.

Рисунок 1. Виймання розширювача



4. Зафіксуйте стилет на втулці.
5. Вставте голку зі стилетом у розширювач. Просувайте голку зі стилетом під рентгеноскопічним контролем на відстань приблизно 2 см від наконечника розширювача всередині оболонки (див. рис. нижче).

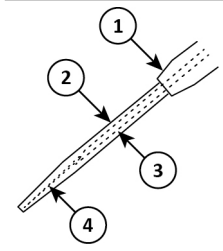
Рисунок 2. Вставлення голки зі стилетом у розширювач



1. Голка
2. Стилет
3. Наконечник розширювача
4. Оболонка

6. Щоб знову з'єднати оболонку та розширювач, одночасно просуньте розширювач і голку зі стилетом у оболонку під рентгеноскопічним контролем. Переконайтеся, що положення голки в розширювачі не змінюється, коли обидва компоненти просуваються разом. Зберігайте положення наконечника оболонки у ВПВ.
7. Просувайте голку зі стилетом під рентгеноскопічним контролем, доки стилет не розташується точно проксимально до наконечника розширювача (див. рис. нижче).

Рисунок 3. Просування голки зі стилетом



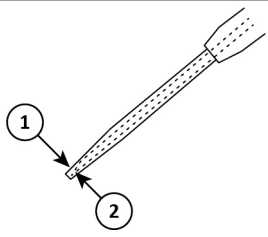
1. Наконечник оболонки
2. Розширювач
3. Голка
4. Стилет

8. Вийміть стилет, не утилізуйте його.
9. Виконуйте аспірацію голки, поки не спостерігатиметься повернення крові. Утилізуйте шприц.

   ПРИМІТКА. Використання шприца з наконечником для нанизування (не від Luer-Lok‡) може перешкоджати аспірації повітря.

10. Промийте голку гепаринізованим фізіологічним розчином. Закрийте запірний кран.
11. Просувайте голку під рентгеноскопічним контролем, доки наконечник голки не розташується точно проксимально до наконечника розширювача (див. рис. нижче).

Рисунок 4. Просування наконечника голки



1. Наконечник розширювача
2. Наконечник голки

ДОДАТКОВО. Прикріпіть 3-ходовий обертальний запірний кран до втулки голки.

ДОДАТКОВО. Прикріпіть шприц із рентгеноконтрастною речовиною до запірного крана. Виконайте аспірацію голки. Потім завантажте голку з контрастною речовиною під рентгеноскопічним контролем.

ДОДАТКОВО. Під'єднайте лінію контролю тиску до запірного крана.

ДОДАТКОВО. Використовуйте стандартну 3-портову колекторну установку для під'єднання ліній контрасту, тиску й промивання.

Вхід в овальне вікно

1. Візуалізуйте та визначте анатомічні орієнтири.
2. Установіть рентгеноскопічний блок під кутом паралельно площині мітрального клапана та ортогонально площині перегородки. Зазвичай у лівій передній косій (ЛПК), приблизно від 30 до 40 градусів.

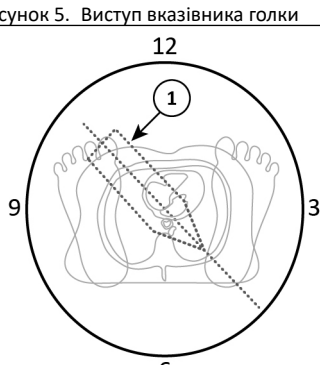
   ДОДАТКОВО. Під час ЕФ-процедур положення катетера в коронарному синусі та пучку Гіса можуть служити корисними анатомічними орієнтирами. У відповідній лівій передній косій (ЛПК) проєкції катетер для коронарного синуса видно в профіль. У відповідній правій передній косій (ППК) проєкції катетер для пучка Гіса видно в профіль. Овальне вікно на рівні або трохи нижче рівня катетера для пучка Гіса та зверху-ззаду від гирла коронарного синуса.

   ДОДАТКОВО. Розміщення катетера для моніторингу ангіографії або гемодинаміки типу пігтейл у некоронарній стулці аортального клапана може служити корисним анатомічним орієнтиром.

   ДОДАТКОВО. Спостерігайте за формою сигналу тиску, яка записується через транссептальну голку BRK™.

3. Відрегулюйте виступ вказівника так, щоб голка була перпендикулярна овальному вікну (зазвичай у діапазоні між 3:00 і 5:00 годинами, якщо дивитися на пацієнта з боку його ступень). (Див. рис. нижче.)

Рисунок 5. Виступ вказівника голки

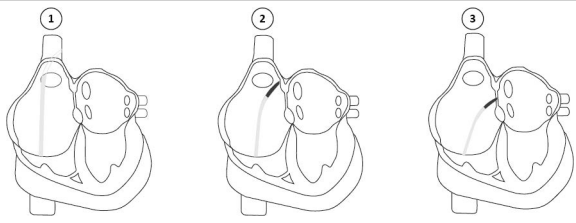


1. Виступ вказівника голки

4. За допомогою рентгеноскопії переконайтеся, що наконечник голки перебуває всередині розширювача.
5. Переконавшись, що наконечник голки перебуває всередині розширювача, повільно перетягніть разом оболонку, розширювач і голку в зборі. Уникайте будь-яких переміщень частин у зборі відносно одна одної. Дуже важливо зберегти попередню орієнтацію виступу вказівника під час перетягування частин у зборі.
6. На проєкції ЛПК (ортогонально до міжпередсердної перегородки) спостерігайте за наконечником розширювача під час перетягування до різкого медіального (або правоспрямованого) руху, що вказуватиме на вхід наконечника в овальне вікно. (Див. рис. нижче.)

   ПРИМІТКА. Якщо овальне вікно відкрите для зондування, то наконечник розширювача легко переміщується в ліве передсердя.

Рисунок 6. Вхід в овальне вікно



1. Вихідне положення у ВПВ
2. Початковий медіальний рух у правому передсерді
3. Різкий медіальний рух в овальне вікно

ПРИМІТКА. Якщо моніторинг тиску здійснюється за допомогою голки, то в такому випадку тиск через голку неточний, оскільки її наконечник розташовується навпроти овального вікна.

Пункція овального вікна транссептальною голкою BRK™

1. Перед просуванням голки переконайтеся, що оболонка, розширювач і голка в зборі займають правильне положення на овальному вікні.
2. Коли правильне положення підтверджено, розправте голку так, щоб вона повністю увійшла в оболонку й розширювач у зборі, і проведіть голку через міжпередсердну перегородку.

   ДОДАТКОВО. Під час моніторингу тиску підтвердженням входу в ліве передсердя слугує форма сигналу на кривій тиску в лівому передсерді.

   ДОДАТКОВО. Доступ до лівого передсердя можна підтвердити під рентгеноскопічним контролем за допомогою введення контрастної речовини.

3. Якщо під час просування голки відчувається опір, втягніть голку та повторно оцініть анатомічні орієнтири.

   ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо відбувається входження в перикард або аорту, не просувайте розширювач поверх голки. Якщо голка потрапила в перикард або аорту, її необхідно витягти. Уважно стежте за життєвими ознаками організму.

Просування оболонки й розширювача в зборі в ліве передсердя

Утримуючи фіксоване положення голки в лівому передсерді, повністю просуньте оболонку й розширювач у зборі поверх голки в порожнину лівого передсердя.

Просування оболонки поверх зафіксованих розширювача та голки в ліве передсердя

1. Зберігайте положення голки та розширювача поперек перегородки.
2. Утримуючи розширювач у заданому місці, повністю просуньте оболонку поверх розширювача в порожнину лівого передсердя.

Виймання транссептальної голки BRK™ та розширювача

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Існує ризик проникнення повітря під час вилучення предметів із гемостатичного клапана оболонки. Вживайте запобіжних заходів, щоб запобігти проникненню повітря. Для цього повільно виймайте предмети, щоб не допустити утворення вакууму в оболонці, та під рентгеноскопічним контролем відстежуйте наявність повітря в оболонці під час подальшого введення пристрою.

1. Поверніть запірний кран голки у вимкнене положення та від'єднайте всі насадки від втулки голки.
2. Видаліть транссептальну голку BRK™ із розширювача. Голку можна очистити та відкласти для повторного використання в цій процедурі. В іншому випадку утилізуйте голку тими засобами, які застосовуються для забруднених гострих предметів.
3. Одразу приєднайте шприц до розширювача та виконайте аспірацію. Продовжуйте аспірацію крові, поки тримаєте оболонку на місці та виймаєте розширювач. Кров має бути артеріальною.
4. Після видалення розширювача виконайте аспірацію крові через бічне відведення оболонки. Обережно промийте бічне відведення оболонки гепаринізованим фізіологічним розчином, щоб уникати повітряних бульбашок.
5. Тепер оболонка на місці в лівому передсерді.

Упаковка й термін придатності

Транссептальна голка BRK™ поставляється стерильною. Голку пакують зі вставленим стилетом. Голка й стилет поміщаються в первинну упаковку. Первинну упаковку кладуть усередину пакета Mylar‡ і Tyvek‡, який пройшов теплову герметизацію. Потім пакет і цю інструкцію з використання поміщають у коробку, яка запечатана з обох кінців. Маркування на пакеті та коробці містить інформацію про продукт, включно з терміном придатності. Строк придатності продукції, зазначений на маркуванні, — три роки.

Короткий огляд клінічних даних

Для країн Європейського Союзу: резюме з безпеки та клінічної ефективності (SSCP) для цих пристроїв буде опубліковано за посиланням https://ec.europa.eu/tools/eudamed нотифікованими органами відповідно до вимог EU MDR 2017/745 та пов'язаних із ними часових інтервалів. Шукайте пристрій за допомогою UDI-DI (Unique Device Identification — Device Identifier — унікальна ідентифікація пристрою — унікальний ідентифікатор пристрою), зазначеного на зовнішній упаковці пристрою. UDI-DI — це 14-значне число в першій парі круглих дужок. Щоб отримати додаткову інформацію про пошук та використання UDI-DI, перегляньте документ «Запитання й відповіді» за посиланням medical.abbott/manuals.

Повідомлення про інциденти

Якщо під час використання цього пристрою у вас є підстави вважати, що стався серйозний інцидент, повідомте про це виробника. Для споживачів у Європейському Союзі: повідомте про серйозний інцидент національний уповноважений орган, а також виробника.

Обмежена гарантія

Компанія Abbott Medical гарантує відсутність у своїй продукції недоліків, пов'язаних з використаними матеріалами і технологією виробництва, за умови дотримання правил її застосування. Ця гарантія є дійсною до закінчення терміну «придатності», указаного на маркуванні виробу. Дозволений спосіб і затверджені методи використання кожного нашого виробу зазначаються у відповідній «Інструкції з використання», яка входить у комплект кожного виробу. Компанія Abbott Medical заперечує будь-яку відповідальність за використання своїх виробів у порядку, що суперечить дозволеному або затвердженому. Відповідальність компанії Abbott Medical в рамках цієї гарантії обмежується заміною виробів. Вищевказана гарантія виключає і замінює собою всі інші прямі та непрямі гарантії, зокрема, але не виключно, будь-які непрямі гарантії товарної якості або придатності до будь-якого конкретного застосування. Компанія Abbott Medical відмовляється від будь-якої відповідальності за будь-які супутні або наслідкові збитки, шкоду чи видатки, які безпосередньо або опосередковано пов'язані з використанням цього виробу, за винятком відповідальності, передбаченої конкретним законодавством. Компанія Abbott Medical не бере на себе зобов'язання, а також не дає іншій особі повноваження брати на себе зобов'язання щодо збитків, шкоди або витрат, які виникли в результаті використання цього виробу. Докладнішу інформацію можна отримати з повної гарантійної політики компанії Abbott Medical, яку можна отримати в компанії Abbott Medical або з інформації на звороті рахунка-фактури компанії Abbott Medical.

Символи

Нижченаведені символи та стандартизовані символи можуть міститися на виробі або етикетці виробу. Стандартизовані символи див. у Universal Symbols Glossary (Глосарії універсальних символів) на сторінці medical.abbott/manuals.

Символ	Визначення
Series	Серія
Contents	Зміст
Transseptal Needle	Транссептальна голка
	Система одиночного стерильного бар'єра
	Довжина
	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Відповідно до федерального законодавства США продаж цього пристрою дозволено лише лікарям або за їхнім призначенням.
	Conformité Européenne (Європейська відповідність). Маркування нанесено відповідно до Директиви Європейської Ради 2017/745/ЕЕС. Цим компанія Abbott Medical заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням цієї директиви.
	Імпортер

Символ	Визначення
UK CA 0086	Отримано оцінку відповідності згідно з вимогами Сполученого Королівства
UKRP	Відповідальна особа в Сполученому Королівстві
UA.TR.101	Українське маркування відповідності технічним регламентам, де 101 — код сертифікуючого органу.
MD	Медичний пристрій
UDI	Унікальна ідентифікація виробу
medical.abbott/manuals	Дотримуйтесь інструкції з використання, доступної на цьому вебсайті
(7440-48-4) (7439-92-1)	Містить небезпечні речовини. (Кобальт, CAS № 7440-48-4) (Свинець, CAS № 7439-92-1)

VI: Tiếng Việt

BRK™ Kim Xuyên vách

Hướng dẫn sử dụng

Mô tả

Kim Xuyên vách BRK™ bao gồm một kim bằng thép không gỉ, có nòng và dùi bằng thép không gỉ, cứng. Phần đầu xa của kim được uốn cong để dễ dàng định vị trong tim khi được sử dụng cùng với bộ ống bao xuyên vách của Abbott Medical. Ở phần cong này, có một nấc chuyển đột ngột xuống ở đường kính bên ngoài của kim để kết hợp với đường kính bên trong của ống nong thuộc bộ ống bao xuyên vách của Abbott Medical. Đầu xa của kim được tạo vát giúp thực hiện thủ thuật chọc dễ dàng. Đầu gần của kim được đặt cấu hình với gờ gắn kim (biểu thị hướng phần cong đầu xa) và được lắp khóa 2 ngã giúp tiếp cận nòng kim để hút, tiêm/truyền dịch, lấy mẫu máu, theo dõi áp lực và đút dùi và/hoặc đút dây dẫn (đường kính dây dẫn tối đa 0,014 inch cho kim 18 gauge; đường kính dây dẫn tối đa 0,012 inch cho kim 19 gauge). Dùi thẳng và có đường kính đều nhau dọc suốt chiều dài. Đầu gần của dùi được lắp kẹp cong để khóa vào đốc kim đầu gần khi đút vào trong nòng kim. Dùi được thiết kế để giúp đẩy kim vào trong ống nong dễ dàng. Kim hiện có sẵn với nhiều cấu hình phần cong đầu xa và chiều dài khả dụng khác nhau.

Mục đích Dự kiến

Kim Xuyên vách BRK™ được thiết kế dùng để chọc vách liên nhĩ nhằm tiếp cận tim trái.

Chỉ định Sử dụng

Kim Xuyên vách BRK™ được dùng để chọc vách liên nhĩ trong thủ thuật đặt ống thông xuyên vách nhằm tiếp cận tim trái.

Nhóm Bệnh nhân Mục tiêu

Kim Xuyên vách BRK™ được thiết kế để dùng ở những bệnh nhân có huyết động ổn định cần tiếp cận ống thông tim trái. Cần xem xét đặc biệt việc sử dụng Kim Xuyên vách BRK™ ở những bệnh nhân mắc các bệnh sau:

- Tim xoay
- Phình động mạch chủ
- Phì đại tâm nhĩ phải thấy rõ
- Chứng vẹo cột sống/gù
- Hình dạng tâm nhĩ trái bất thường
- Dị dạng bẩm sinh
- Dị dạng mạch
- Không thể tiếp cận tâm nhĩ phải qua tĩnh mạch chủ dưới

Người dùng Chỉ định

Chỉ các bác sĩ được đào tạo đặc biệt về thủ thuật xuyên vách, thực hiện trong phòng thí nghiệm điện sinh lý vận hành được trang bị đầy đủ mới được sử dụng thiết bị này.

Các lợi ích Lâm sàng

Lợi ích lâm sàng dự kiến của Kim Xuyên vách BRK™ là chọc vách liên nhĩ trong thủ thuật đặt ống thông xuyên vách nhằm tiếp cận tim trái để cho phép các thiết bị cần tiếp cận nội tâm mạc bên trái của tim đạt được lợi ích lâm sàng dự kiến như ống thông cắt bỏ. Chọc thành công vách liên nhĩ chính là thước đo lợi ích lâm sàng của thiết bị này.

Chống chỉ định

- Trước đây đã có miếng vá vách liên nhĩ hoặc thiết bị giả đóng lỗ thông liên nhĩ.
- Trước đây đã gặp bất kỳ biến cố thuyên tắc mạch nào.
- U niêm nhĩ trái đã biết hoặc nghi ngờ.
- Tình trạng nhồi máu cơ tim đã biết hoặc nghi ngờ trong vòng hai tuần trở lại đây.
- Đau thắt ngực không ổn định.
- Vừa mới bị tai biến mạch máu não (CVA).
- Bệnh nhân không dung nạp liệu pháp chống đông máu.
- Bệnh nhân đang bị nhiễm trùng.

Cảnh báo

- Không thay đổi thiết bị này dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thiết bị này được thiết kế để chỉ sử dụng một lần; không tái xử lý hoặc tái sử dụng thiết bị. Lưu ý về "Hạn sử dụng" của sản phẩm trên bao bì. Mọi nỗ lực tái tiệt trùng và tái sử dụng hệ thống này có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống. Các tác dụng bất lợi của việc sử dụng các thành phần không vô trùng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  - Nhiễm trùng hoặc phản ứng cục bộ và toàn thân
  - Hư hỏng thiết bị
  - Chức năng hoạt động không chính xác
- Các chất liệu được xác định dưới đây cho mỗi sản phẩm có thể gây ra phản ứng dị ứng hoặc quá mẫn. Bệnh nhân dị ứng với những chất này có thể gặp phản ứng dị ứng với sản phẩm này. Trước khi sử dụng cho bệnh nhân, nên tư vấn cho bệnh nhân về các chất liệu có trong thiết bị và phải thảo luận kỹ về tiền sử dị ứng:
  - Thép không gỉ
  - Keo epoxy
  - Đồng thau mạ crôm niken
  - Mỡ chân không silicon cao (Dupont)
  - Chất kết dính Master Bond
- Lạm dụng thiết bị này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.
- Đối với cả bệnh nhân và nhân viên phòng xét nghiệm, các thủ thuật thông tim tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm tia-X đáng kể có thể dẫn đến tổn thương cấp tính do bức xạ, cũng như tăng rủi ro bị ảnh hưởng tới cơ thể và gen do cường độ của luồng tia-X và thời gian chụp huỳnh quang. Cân nhắc kỹ việc sử dụng thiết bị này ở phụ nữ mang thai.

Thận trọng

- Luật liên bang (Hoa Kỳ) quy định rằng thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo chỉ định của bác sĩ.
- Đọc chỉ dẫn trước khi sử dụng.
- Kiểm tra bao bì trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị mở hoặc hư hỏng.
- Kiểm tra tất cả các thành phần trước khi sử dụng.
- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa ánh sáng mặt trời.
- Trước khi tiến hành thủ thuật, bệnh nhân phải ổn định huyết động học. Có thể cần xem xét đặc biệt đối với một số tình trạng nhất định khi sử dụng sản phẩm này. Những tình trạng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  - Tim xoay
  - Phình động mạch chủ
  - Phì đại tâm nhĩ phải thấy rõ
  - Chứng vẹo cột sống/gù
  - Hình dạng tâm nhĩ trái bất thường
  - Dị dạng bẩm sinh
  - Dị dạng mạch
  - Không thể tiếp cận tâm nhĩ phải qua tĩnh mạch chủ dưới
- Chỉ các bác sĩ được đào tạo đặc biệt về thủ thuật xuyên vách, thực hiện trong phòng thí nghiệm điện sinh lý (EP) vận hành được trang bị đầy đủ mới được sử dụng thiết bị này.
- Khi đưa ống thông vào, cần thực hiện theo hướng dẫn soi huỳnh quang để giảm thiểu nguy cơ gây tổn thương, thủng hay chèn ép tim. Cũng có thể xem xét hệ thống điều hướng và trực quan hóa thời gian thực tương thích.
- Trong khi đưa kim vào, hãy kiểm tra xem có gặp lực cản quá mức ở đầu kim khi đẩy kim qua độ cong của bộ ống bao/ống nong hay không. Nếu gặp bất kỳ lực cản nào khi đẩy kim, hãy rút kim ra, rồi đánh giá các thành phần.
- Trong khi đưa kim vào, hãy cẩn thận để không tạo ra quá nhiều chỗ cong trong thiết bị này. Tạo ra nhiều chỗ cong có thể cản trở việc đẩy kim vào và vô tình làm cho kim đâm thủng bộ ống nong/ống bao.
- Trong khi đưa kim vào, luôn sử dụng dùi để giúp tạo đường đi dễ dàng cho kim qua bộ ống nong/ống bao. Việc không sử dụng dùi có thể cản trở đẩy kim vào và vô tình làm cho kim đâm thủng bộ ống nong/ống bao hoặc bào mòn vật liệu khỏi mặt trong của ống nong.
- Nếu đầu vào là màng ngoài tim hoặc động mạch chủ, thì không đẩy ống nong trên kim. Nếu kim đã đâm vào màng ngoài tim hoặc động mạch chủ, thì phải rút kim ra. Kiểm tra kỹ các dấu hiệu sinh tồn.
- Có nguy cơ thâm nhiễm không khí khi rút các vật dụng ra khỏi van cầm máu của ống bao. Thận trọng tránh thâm nhiễm không khí bằng cách rút từ từ các vật dụng ra để tránh làm tích tụ chân không trong ống bao và kiểm tra ống bao bằng huỳnh quang trong khi đưa thiết bị tiếp theo vào khi có không khí.
- Sau khi sử dụng, nên phân loại phù hợp thiết bị này, các phụ kiện và bao bì của thiết bị để xử lý, ví dụ: chất thải nguy hiểm sinh học, vật sắc nhọn, chất thải không nguy hiểm, v.v và thải bỏ một cách cẩn thận theo các quy trình ở cơ sở, luật pháp và quy định hiện hành.
- Một hoặc nhiều thành phần của thiết bị này có thể chứa chất sau được xác định là CMR 1B với nồng độ trên 0,1% trọng lượng: Coban: Mã số CAS (Chemical Abstracts Service) 7440-48-4; Mã số EC 231-158-0. Các bằng chứng khoa học hiện tại cho thấy các thiết bị y tế được sản xuất từ hợp kim coban và hợp kim thép không gỉ có chứa coban không làm tăng nguy cơ mắc ung thư hoặc ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sinh sản.

  Một hoặc nhiều thành phần của thiết bị này có thể chứa chất sau được xác định là CMR 1A với nồng độ trên 0,1% trọng lượng: Chì: Mã số CAS (Chemical Abstracts Service) 7439-92-1; Mã số EC 231-100-4. Bằng chứng khoa học hiện tại cho thấy các thiết bị y tế được sản xuất từ chì không làm tăng nguy cơ mắc ung thư hoặc ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sinh sản.

Các biến cố bất lợi tiềm ẩn

Danh mục Biến cố Bất lợi	Danh mục phụ Biến cố Bất lợi
Chảy máu	Chảy máu/Xuất huyết
	Khối tụ máu
Chấn thương não	Nghẽn mạch não không triệu chứng
	Đột quỵ/tai biến mạch máu não
	Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA)
Nghẽn mạch	Tắc mạch khí
	Thuyên tắc do vật thể lạ
	Tắc mạch phổi
	Thuyên tắc huyết khối
	Nghẽn mạch/huyết khối
Thủng tim	Ép tim
	Tràn dịch màng ngoài tim
Chấn thương tim mạch	Tổn thương van tim
	Thủng gốc động mạch chủ
	Thủng nhĩ
Rối loạn hệ thống dẫn truyền	Block nút SA, AV hoặc hệ thống His-Purkinje
	Rối loạn nhịp tim
Phản ứng miễn dịch	Sốc phản vệ
Nhiễm trùng	Viêm ngoại tâm mạc
	Viêm nội mạc tim
	Viêm phổi
	Nhiễm trùng máu
Đau/khó chịu	Đau, háng, ngực (đau ngực nói chung không liên quan đến MI)
Tổn thương mạch máu ngoại vi	Đứt mạch
	Vết rách
	Hình thành lỗ rò động tĩnh mạch
	Hình thành giả phình mạch
Huyết áp thấp	Không áp dụng
Tổn thương mô bề ngoài	Không áp dụng

Chỉ dẫn

Chuẩn bị và Lắp ráp Thiết bị

1. Lấy các thành phần ra khỏi bao bì.

   LƯU Ý: Không lắp ráp ống bao và ống nong.

2. Sục rửa ống nong và ống bao bằng nước muối sinh lý có heparin.
3. Đóng khóa ống bao lại.
4. Rút dùi ra khỏi kim, rồi sục rửa kim bằng nước muối sinh lý có heparin.
5. Đút dùi vào kim, rồi khóa vào đốc.
6. Đút hết ống nong vào trong ống bao xuyên vách.

Đẩy Bộ Ống bao/Ống nong vào Tĩnh mạch Chủ Trên

1. Tạo chỗ tiếp cận tĩnh mạch đùi (ưu tiên tĩnh mạch đùi phải).

   TÙY CHỌN: Có thể sử dụng ống bao có chiều dài tiêu chuẩn lớn hơn (kích thước ≥2,5 French so với ống bao xuyên vách) để tạo và duy trì chỗ tiếp cận tĩnh mạch nhằm trao đổi thiết bị và cầm máu.

2. Đưa dây dẫn có đường kính 0,032 inch, 150 - 180 cm, đầu chữ "J," 3 mm vào tĩnh mạch chủ trên (SVC).

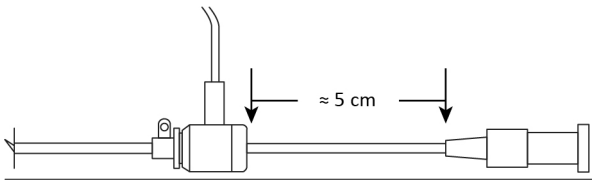
   LƯU Ý: Có thể sử dụng dây dẫn có đường kính tối đa 0,032 inch cùng với ống nong.

3. Đưa ống bao/ống nong vào tĩnh mạch qua dây dẫn cho đến khi đầu ống bao nằm trong SVC. Định hướng đầu ống nong về trung thất.

Đưa Bộ Kim/Dùi vào trong Bộ Ống bao/Ống nong

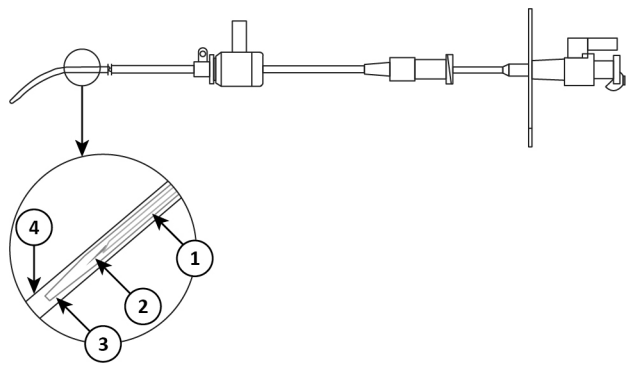
1. Rút dây dẫn ra khỏi ống nong.
2. Hút hết, rồi sau đó sục rửa ống nong bằng nước muối sinh lý có chứa heparin.
3. Rút ống nong ra khoảng 5 cm (xem hình bên dưới) để giúp đường cong của kim dễ dàng đi qua đốc cứng của ống nong và ống bao.

Hình 1. Rút Ống nong



4. Khóa dùi vào đốc.
5. Đưa kim/dùi vào trong ống nong. Đẩy kim/dùi bằng cách soi huỳnh quang cho đến khi vào được khoảng 2 cm tính từ đầu ống nong bên trong ống bao (xem hình bên dưới).

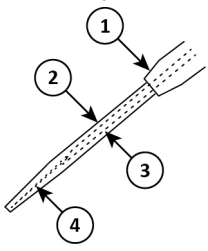
Hình 2. Đưa Kim/Dùi vào trong Ống nong



1. Kim
2. Dùi
3. Đầu ống nong
4. Ống bao

6. Để nối lại ống bao và ống nong, đẩy ống nong và kim/dùi cùng lúc vào trong ống bao bằng cách soi huỳnh quang. Đảm bảo vị trí của kim trong ống nong không thay đổi vì cả hai thành phần được đẩy vào cùng lúc. Giữ nguyên vị trí đầu ống bao trong SVC.
7. Bằng cách soi huỳnh quang, đẩy kim/dùi vào cho đến khi dùi được đặt vào ngay đầu gần của đầu ống nong (xem hình bên dưới).

Hình 3. Đẩy Kim/Dùi vào



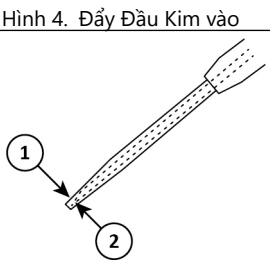
1. Đầu ống bao
2. Ống nong
3. Kim
4. Dùi

8. Rút dùi ra, không thải bỏ.
9. Dùng kim hút cho đến khi thấy có máu. Thải bỏ ống tiêm.

   LƯU Ý: Sử dụng ống tiêm có đầu kim slip-tip (không phải Luer-Lok‡) có thể tránh bị hút không khí vào.

10. Sục rửa kim bằng nước muối sinh lý có heparin. Đóng khóa lại.
11. Đẩy kim vào bằng cách soi huỳnh quang cho đến khi đầu kim ở ngay đầu gần của đầu ống nong (xem hình bên dưới).

Hình 4. Đẩy Đầu Kim vào



1. Đầu ống nong
2. Đầu kim

TÙY CHỌN: Gắn khóa xoay 3 ngã vào đốc kim.

TÙY CHỌN: Gắn ống tiêm có chất cản quang chắn xạ vào khóa. Hút kim. Sau đó, nạp chất cản quang vào kim theo hướng dẫn của huỳnh quang.

TÙY CHỌN: Nối dây kiểm tra áp lực vào khóa.

TÙY CHỌN: Sử dụng bộ cài đặt nhiều lớp, 3 cổng, tiêu chuẩn để kết nối dây chất cản quang, dây kiểm tra áp lực và dây sục rửa.

Gắn vào Hố Bầu dục

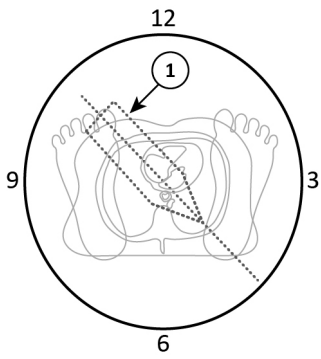
1. Làm hiện rõ và nhận diện những mốc giải phẫu học.
2. Đặt máy soi huỳnh quang ở góc song song với mặt phẳng van hai lá và vuông góc với mặt phẳng vách tim. Thường là chếch về phía trước bên trái (LAO), khoảng 30-40 độ.

   TÙY CHỌN: Trong khi tiến hành thủ thuật EP, có thể dùng các vị trí ống thông bó His và xoang vành làm mốc giải phẫu học hữu ích. Khi nhìn ở góc LAO thích hợp, ống thông xoang vành sẽ xuất hiện ở mặt nghiêng. Khi nhìn ở góc chếch về phía trước bên phải (RAO) thích hợp, ống thông bó His sẽ xuất hiện ở mặt nghiêng. Hố bầu dục nằm ngang hoặc hơi chếch xuống bên dưới, ống thông bó His, phía trên và sau lỗ xoang vành.

   TÙY CHỌN: Có thể đặt một ống thông kiểm tra mạch đồ/huyết động đuôi lợn trong đỉnh không phải mạch vành của van động mạch chủ để làm mốc giải phẫu học hữu ích.

   TÙY CHỌN: Quan sát dạng sóng áp lực được ghi lại qua Kim Xuyên vách BRK™.
3. Điều chỉnh gờ gắn kim sao cho kim vuông góc với hố bầu dục (thường là hướng từ 3 đến 5 giờ, nhìn từ chân bệnh nhân). (Xem hình bên dưới.)

Hình 5. Gờ Gắn Kim

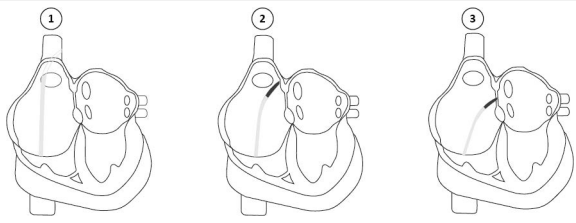


1. Gờ gắn kim

4. Sử dụng phương pháp soi huỳnh quang để xác nhận rằng đầu kim nằm bên trong ống nong.
5. Sau khi xác nhận đầu kim nằm bên trong ống nong, kéo rê từ từ toàn bộ bộ ống bao/ống nong/kim. Tránh làm lệch các bộ phận có liên quan đến nhau trong bộ này. Khi kéo rê bộ này, cần phải duy trì hướng trước đó của gờ gắn kim.
6. Khi nhìn ở góc LAO (vuông góc với vách liên nhĩ), hãy quan sát đầu ống nong trong khi kéo rê cho chuyển động trung thất đột ngột (hoặc sang phải), cho thấy đầu đã gắn vào hố bầu dục. (Xem các hình bên dưới.)

   LƯU Ý: Nếu hố bầu dục vừa khớp với que thăm, lúc này đầu ống nong sẽ di chuyển dễ dàng vào tâm nhĩ trái.

Hình 6. Gắn vào Hố Bầu dục



1. Vị trí ban đầu trong SVC
2. Chuyển động trung thất ban đầu trong RA
3. Chuyển động trung thất đột ngột vào hố bầu dục

LƯU Ý: Nếu kiểm tra áp lực qua kim, hãy lưu ý rằng áp lực qua kim sẽ không chính xác tại thời điểm này, vì đầu kim tựa vào hố bầu dục.

Chọc Hố Bầu dục bằng Kim Xuyên vách BRK™

1. Xác nhận đúng vị trí của bộ ống bao/ống nong/kim trên hố bầu dục rồi mới đẩy kim tới.
2. Sau khi xác nhận đúng vị trí, hãy kéo dài kim ra để gắn hoàn toàn vào bộ ống bao/ống nong, rồi đẩy kim ngang qua vách liên nhĩ.

   TÙY CHỌN: Trong khi kiểm tra áp lực, đầu vào tâm nhĩ trái được xác nhận khi dấu vết áp lực cho thấy dạng sóng áp lực tâm nhĩ trái.

   TÙY CHỌN: Có thể xác nhận đầu vào tâm nhĩ trái bằng phương pháp soi huỳnh quang có tiêm chất cản quang.
3. Nếu gặp bất kỳ lực cản nào khi đẩy kim, hãy kéo lùi kim lại, rồi đánh giá lại các mốc giải phẫu học.

   THẬN TRỌNG: Nếu đầu vào là màng ngoài tim hoặc động mạch chủ, thì không đẩy ống nong trên kim. Nếu kim đã đâm vào màng ngoài tim hoặc động mạch chủ, thì phải rút kim ra. Kiểm tra kỹ các dấu hiệu sinh tồn.

Đẩy Bộ Ống bao/Ống nong vào Tâm nhĩ Trái

Trong khi duy trì vị trí kim cố định bên trong tâm nhĩ trái, hãy đẩy hoàn toàn bộ ống bao/ống nong trên kim vào khoang tâm nhĩ trái.

Đẩy Ống bao trên Ống nong và Kim Cố định vào Tâm nhĩ Trái

1. Giữ nguyên vị trí kim và ống nong ngang qua vách ngăn.
2. Trong khi duy trì ống nong ở vị trí cố định, hãy đẩy hoàn toàn ống bao trên ống nong vào khoang tâm nhĩ trái.

Rút Kim Xuyên vách BRK™ và Ống nong ra

THẬN TRỌNG: Có nguy cơ thâm nhiễm không khí khi rút các vật dụng ra khỏi van cầm máu của ống bao. Thận trọng tránh thâm nhiễm không khí bằng cách rút từ từ các vật dụng ra để tránh làm tích tụ chân không trong ống bao và kiểm tra ống bao bằng huỳnh quang trong khi đưa thiết bị tiếp theo vào khi có không khí.

1. Xoay khóa kim tới vị trí tắt, rồi ngắt kết nối mọi phần đã gắn với đốc kim.
2. Rút Kim Xuyên vách BRK™ ra khỏi ống nong. Có thể vệ sinh kim rồi đặt sang một bên để dùng lại trong thủ thuật này. Mặt khác, thải bỏ kim phù hợp với quy định thải bỏ các vật sắc nhọn đã nhiễm bẩn.
3. Gắn ngay bơm tiêm vào ống nong rồi hút. Tiếp tục hút máu, đồng thời giữ cố định ống bao rồi rút ống nong ra. Nên lấy máu động mạch.
4. Sau khi rút ống nong ra, hút máu qua nhánh bên của ống bao. Cẩn thận sục rửa nhánh bên của ống bao bằng nước muối sinh lý có heparin để tránh tạo bọt khí.
5. Lúc này, ống bao sẽ nằm trong tâm nhĩ trái.

Bao bì và thời hạn sử dụng

Kim Xuyên vách BRK™ được cung cấp ở dạng vô trùng. Kim được đóng gói có lắp dùi. Kim và dùi được đặt trong bao bì chính. Bao bì chính được đặt bên trong túi nhựa Mylar‡ và Tyvek‡, có hàn nhiệt. Túi và Hướng dẫn sử dụng này sau đó được đặt trong một hộp, được niêm phong ở cả hai đầu. Cả túi và hộp đều có nhãn chứa thông tin sản phẩm, gồm cả ngày hết hạn. Sản phẩm được dán nhãn cho biết thời hạn sử dụng là ba năm.

Tóm tắt Dữ liệu Lâm sàng

Đối với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu: Bản tóm tắt về độ an toàn và hiệu suất lâm sàng (SSCP) cho các thiết bị này sẽ được Cơ quan Chứng nhận công bố tại https://ec.europa.eu/tools/eudamed, theo các yêu cầu của EU MDR 2017/745 và các mốc thời gian liên quan. Tìm kiếm thiết bị bằng UDI-DI được in trên bao bì bên ngoài của thiết bị. UDI-DI là số có 14 chữ số nằm giữa hai bộ dấu ngoặc đơn đầu tiên. Để biết thêm thông tin về cách tìm và sử dụng UDI-DI, hãy tham khảo tài liệu Câu hỏi Thường Gặp hiện có tại medical.abbott/manuals.

Báo cáo Sự cố

Nếu trong quá trình sử dụng thiết bị này, bạn có lý do để cho rằng đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, vui lòng báo cho nhà sản xuất biết. Đối với khách hàng ở Liên minh Châu Âu, hãy báo cáo sự cố nghiêm trọng cho cơ quan chức trách quốc gia cũng như cho nhà sản xuất.

Bảo hành Hữu hạn

Abbott Medical đảm bảo rằng các sản phẩm của mình không bị lỗi về mặt vật liệu và kết cấu khi sử dụng trong điều kiện bình thường. Bảo hành này không áp dụng quá ngày "Hết hạn" ghi trên bất kỳ nhãn sản phẩm nào. Mục đích sử dụng được cho phép và các phương pháp sử dụng được chấp thuận cho từng sản phẩm của chúng tôi được nêu trong "Hướng dẫn Sử dụng" có liên quan đi kèm với từng sản phẩm. Abbott Medical từ chối bất kỳ trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của công ty theo cách không được cho phép hoặc phê duyệt. Theo bảo hành này, trách nhiệm pháp lý của Abbott Medical chỉ giới hạn trong việc thay thế các sản phẩm của công ty. Bảo hành trên loại trừ và thay cho tất cả các bảo hành khác, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo hành ngụ ý nào về tính có thể bán được hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Abbott Medical từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các mất mát, hỏng hóc hoặc chi phí do vô tình hoặc là hệ quả thứ phát, trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra từ việc sử dụng sản phẩm này, trừ các tình huống được quy định cụ thể bởi pháp luật. Abbott Medical cũng không chịu trách nhiệm hoặc cho phép bất kỳ người nào khác chịu trách nhiệm về điều này hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý bổ sung nào cho việc mất mát, hỏng hóc hoặc chi phí liên quan đến sản phẩm này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách bảo hành đầy đủ của Abbott Medical hiện có tại Abbott Medical hoặc ở mặt sau của hóa đơn Abbott Medical.

Biểu tượng

Các biểu tượng dưới đây và biểu tượng hài hòa có thể xuất hiện trên sản phẩm hoặc nhãn sản phẩm. Đối với các biểu tượng hài hòa, tham khảo Chú giải Biểu tượng Chung tại medical.abbott/manuals.

Biểu tượng	Định nghĩa
Series	Sê-ri
Contents	Thành phần
Transseptal Needle	Kim Xuyên vách
	Hệ thống rào chắn vô trùng đơn
	Chiều dài
Rx ONLY	THẬN TRỌNG: Luật liên bang (Hoa Kỳ) quy định rằng thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo chỉ định của bác sĩ.
CE 2797	Conformité Européenne (Tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu). Được đóng dấu tuân theo Quy định của Hội Đồng Châu Âu số 2017/745. Bằng tài liệu này, Abbott Medical tuyên bố thiết bị này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và những điều khoản thích hợp khác của quy định này.
	Nhà nhập khẩu
UK CA 0086	Được đánh giá Sự phù hợp ở Vương quốc Anh
UKRP	Người Chịu trách nhiệm ở Vương quốc Anh
UA.TR.101	Dấu của Ucraina về tuân thủ các quy định kỹ thuật, trong đó 101 là cơ quan đánh giá.
MD	Thiết bị Y tế
UDI	Định danh Duy nhất của Thiết bị
medical.abbott/manuals	Làm theo hướng dẫn sử dụng trên trang web này
(7440-48-4) (7439-92-1)	Chứa các chất độc hại. (Số Coban CAS 7440-48-4) (Mã số CAS của Chì 7439-92-1)

Abbott Medical
14901 DeVeau Place
Minnetonka, MN 55345-2126 USA
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833

EC REP
Abbott Medical
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem
Belgium
+32 2 774 68 11

UKRP
Abbott Medical UK Limited
Elder House
Central Boulevard
Blythe Valley Business Park
Solihull B90 8AJ
United Kingdom

CR
Abbott Medical Costa Rica Limitada
Edificio #44
Calle 0, Ave.2
Zona Franca Coyol
El Coyol, Alajuela Costa Rica

CE
2797

UK
CA
0086

2023-03
ARTMT600239457 A

600239457

Abbott